KLİNİK PSİKİYATRİ

Tanı ve tedavi standartları

ICD-11 ve DSM-5-TR temelli klinik rehber

Dr. Kenan Rahimov

Bakü · 2026

İÇİNDEKİLER

ÖNSÖZ....1
Okuyucuya hitap....1
YAZAR HAKKINDA....2
GİRİŞ....3
Bu kitap hakkında....3
Bu kitap nedir ve neden yazıldı....3
Neden ICD-11?....4
Kitabın yapısı....5
Bölümlerin düzenlenmesi ve özellikleri....6
Kaynaklar ve yaklaşım....8
Kitabın kullanımı....9
Sorumluluk notu....9
BU KİTAP NEDEN TAM DA ŞİMDİ VE AZERBAYCAN'DA?....11
Üç çizginin kesişimi....11
Neden tam da şimdi?....11
Neden tam da Azerbaycan'da?....12
Bu kitabın hedef kitlesi....13
Sonuç....14
Yazar ve katkıda bulunanlar....14
Teşekkür....15
DÜNYADA RUH SAĞLIĞI KRİZİ: İSTATİSTİK, EĞİLİMLER VE TEDAVİ BOŞLUĞU....16
Küresel görünüm....16
1990–2021 dönemi eğilimleri....16
Tablo 1. Başlıca ruhsal bozuklukların küresel yaygınlık dinamikleri, 1990–2021....17
COVID-19 pandemisinin etkisi....18
Yaygınlık ve artış hızı açısından en sık görülen bozukluklar....19
Tablo 2. Yaygınlık ve artış hızı bakımından ilk onluk (2021)....19
Tedavi boşluğu olgusu....20
Tablo 3. Tedavi boşluğu — bozukluklara göre karşılaştırma....20
Psikojenik boyut: kök sorun....21
Sonuç....23
PSİKOPATOLOJİYE GİRİŞ....24
Bu bölümün amacı....24
Belirti ve sendrom kavramları....24
Psikopatolojik belirtilerin sınıflandırılması....25
Temel psikopatolojik sendromlar....29
KLİNİK GÖRÜŞME VE RUHSAL DURUMUN DEĞERLENDİRİLMESİ....32
Klinik görüşmenin amaçları....32
Klinik görüşmenin yapısı....32
Ruhsal durumun değerlendirilmesi....34
İntihar riskinin değerlendirilmesi....37
Heteroagresif (başkalarına zarar verme) riskinin değerlendirilmesi....39

HUKUKİ-ETİK YÖNLER.....41
Azerbaycan psikiyatri mevzuatının temelleri.....41
Psikiyatri yardımının türleri.....41
Gönüllü psikiyatri yardımı.....42
İstemsiz hastaneye yatırma.....42
Zorunlu tıbbi önlemler.....44
Klinik psikologun hukuki durumu.....44
Gizlilik ve sınırları.....46
Reşit olmayan hastalar.....47
Saldırgan hasta ve güvenlik önlemleri.....47
Belge örnekleri.....48
Etik ilkeler.....51
PSİKOTERAPİNİN KLİNİK STRATEJİLERİ.....52
Klinik psikoterapi kavramı.....52
Psikoterapötik ekoller ve mekanizmaları.....53
Kanıt düzeyleri.....54
Bozukluğa göre tedavi stratejilerinin haritası.....55
Tablo 4. Psikoterapötik stratejiler — bozukluğa göre harita.....55
Farmakoterapi ve psikoterapi: rakip değil, tamamlayıcı.....58
Tablo 5. Farmakoterapi ve psikoterapi: karşılaştırmalı olanaklar.....58
Klinik psikoterapinin örgütsel önemi.....59
YAZAR KLİNİK PROTOKOLÜ №1: ÇOCUKLARDA GECE ENÜREZİSİNİN TEDAVİSİ.....61
Protokolün mahiyeti ve yeri.....61
Protokolün klinik ilkeleri.....62
Protokolün aşamaları.....63
Tablo 6. Modifiye edilmiş alarm tedavisi protokolü — aşamalara göre.....63
11–12. hafta: konsolidasyon ve değerlendirme.....66
Pelvik taban kaslarının egzersizlerinin (İng. Kegel exercises) tanımı (kapsamlı günlük program).....66
Pratik öneriler.....67
Protokolün klinik psikoterapi çerçevesindeki yeri.....68
YAZAR KLİNİK PROTOKOLÜ №2: PSİKOJEN DEPRESYONUN TEDAVİSİ.....70
Protokolün mahiyeti ve yeri.....70
Hastanın stratifikasyonu.....71
Tablo 7. Depresif bozukluklarda tedavi taktiğinin seçimi.....71
Tablo 8. Farmakoterapinin zorunlu paralel uygulanması için ölçütler.....72
BÖLÜM I. KISA SÜRELİ BİLİŞSEL YENİDEN YAPILANDIRMA (1–6 SEANS).....73
Başlangıç değerlendirmesi ve kronolojik öykü.....73
Otoagresif bilişsel yapının tanımlanması.....74
Bilişsel yeniden yapılandırma — sıralı teknikler.....74
Kısa süreli aşamanın sonucu.....76
II. KISIM. UZUN SÜRELİ KORUYUCU TERAPİ — 4 ARDIŞIK AŞAMA.....76
Aşama 1. İçgörü (İng. insight).....77
Aşama 2. Yüzleşme.....77
Aşama 3. Netleştirme.....77
Tablo 8. Tepki verme kutupları ve bunların sonuçları.....78
Aşama 4. Kapsamlı işleme.....79

Boylamsal sonuçlar....79
Tablo 9. Karşılaştırmalı boylamsal sonuçlar (20–25 yıllık izlem)....80
Kaynak etkinliği....80
Klinik psikoterapi çerçevesindeki yeri....81
AKKREDİTASYON VE KALİTE KONTROLÜ: ULUSLARARASI STANDARTLAR VE AZERBAYCAN'DAKİ DURUM....82
Akreditasyon neden önemlidir?....82
Uluslararası akreditasyon kurumları ve gereklilikleri....82
Psikanaliz: Uluslararası Psikanalitik Derneği (İng. International Psychoanalytical Association, IPA)....82
Tablo 10. IPA'nın psikanalitik eğitim gereklilikleri....83
Bilişsel davranışçı terapi: Avrupa Davranış ve Bilişsel Terapiler Derneği (İng. European Association for Behavioural and Cognitive Therapies, EABCT)....83
Tablo 11. EABCT'de Azerbaycan ve bölgenin durumu....84
Diyalektik davranış terapisi: DBT-Linehan Sertifikasyon Kurulu (İng. DBT-Linehan Board of Certification, DBT-LBC)....85
Tablo 12. DBT-LBC sertifikasyon gereklilikleri....85
EMDR: EMDR Europe....86
Tablo 13. EMDR Europe akreditasyon düzeyleri....86
Avrupa Birliği'nde genel düzenleme durumu....87
Azerbaycan'daki durum....87
Uzmanı nasıl ayırt etmeli?....88
Kitabın bu koşullardaki yeri....89
6A00–6A0Z NÖROGELİŞİMSEL BOZUKLUKLAR....91
6A00 BİLİŞSEL GELİŞİM BOZUKLUKLARI....91
6A01 GELİŞİMSEL KONUŞMA VEYA DİL BOZUKLUKLARI....104
6A02 OTİZM SPEKTRUM BOZUKLUĞU (OSB)....118
6A03 GELİŞİMSEL ÖĞRENME BOZUKLUĞU....134
6A04 GELİŞİMSEL MOTOR KOORDİNASYON BOZUKLUĞU (DCD)....147
6A05 DİKKAT EKSİKLİĞİ HİPERAKTİVİTE BOZUKLUĞU (DEHB)....158
6A06 BASMAKALIP HAREKET BOZUKLUĞU....174
8A05.0 PRİMER TİKLER VEYA TİK BOZUKLUKLARI....185
6A20–6A2Z ŞİZOFRENİ SPEKTRUMU....200
6A20 ŞİZOFRENİ....200
6A21 ŞİZOAFEKTİF BOZUKLUK....219
6A22 ŞİZOTİPAL BOZUKLUK....230
6A23 AKUT VE GEÇİCİ PSİKOTİK BOZUKLUK....241
6A24 SANRILI BOZUKLUK....251
6A25 PRİMER PSİKOTİK BOZUKLUKLARIN BELİRTİSEL GÖRÜNÜMLERİ....257
6A40 KATATONİ....261
6A40 DİĞER BİR RUHSAL BOZUKLUKLA İLİŞKİLİ KATATONİ....261
6A60–6A7Z DUYGUDURUM BOZUKLUKLARI....268
6A60 BİPOLAR BOZUKLUK TİP I....268
6A61 BİPOLAR BOZUKLUK TİP II....276
6A62 SİKLOTİMİK BOZUKLUK....282
6A70 TEK DÖNEM DEPRESİF BOZUKLUK....286
6A71 YİNELEYİCİ DEPRESİF BOZUKLUK....296
6A72 DİSTİMİK BOZUKLUK....301

GA34.41 PREMENSTRÜEL DİSFORİK BOZUKLUK (PMDD)....306
6B00–6B0Z ANKSİYETE BOZUKLUKLARI....313
6B00 YAYGIN ANKSİYETE BOZUKLUĞU (YAB)....313
6B01 PANİK BOZUKLUĞU....320
6B02 AGORAFOBİ....325
6B03 ÖZGÜL FOBİ....330
6B04 SOSYAL ANKSİYETE BOZUKLUĞU....335
6B05 AYRILIK ANKSİYETESİ BOZUKLUĞU....341
6B06 SEÇİCİ MUTİZM....346
6B20–6B2Z OBSESİF-KOMPULSİF (OKB)....351
6B20 OBSESİF-KOMPULSİF BOZUKLUK (OKB)....351
6B21 BEDEN DİSMORFİK BOZUKLUĞU (BDD)....358
6B22 OLFAKTÖR REFERANS BOZUKLUĞU (ORS)....363
6B23 HİPOKONDRİYAZİS....367
6B24 İSTİFLEME BOZUKLUĞU....372
6B25 BEDENE ODAKLI YİNELEYİCİ DAVRANIŞ BOZUKLUKLARI....377
6B40–6B4Z STRESLE İLGİLİ....383
6B40 TRAVMA SONRASI STRES BOZUKLUĞU (TSSB)....383
6B41 KARMAŞIK TRAVMA SONRASI STRES BOZUKLUĞU (KTSSB)....390
6B42 UZAMIŞ YAS BOZUKLUĞU....395
6B43 UYUM BOZUKLUĞU....400
6B44 TEPKİSEL BAĞLANMA BOZUKLUĞU....405
6B45 DİSİNHİBE SOSYAL KATILIM BOZUKLUĞU....410
6B60–6B6Z DİSOSİYATİF BOZUKLUKLAR....415
6B64 DİSOSİYATİF KİMLİK BOZUKLUĞU (DKB)....415
6B65 KISMİ DİSOSİYATİF KİMLİK BOZUKLUĞU....421
6B66 DEPERSONALİZASYON-DEREALİZASYON BOZUKLUĞU....424
6B60 DİSOSİYATİF NÖROLOJİK BELİRTİ BOZUKLUĞU....428
6B61 DİSOSİYATİF AMNEZİ....433
6B80–6B8Z YİYECEK ALIM BOZUKLUKLARI....437
6B80 ANOREKSİYA NERVOZA....437
6B81 BULİMİYA NERVOZA....443
6B82 TIKINIRCASINA YEME BOZUKLUĞU (BED)....447
6B84 PİKA....451
6B85 GEVİŞ GETİRME BOZUKLUĞU....455
6B83 KAÇINGAN-KISITLI GIDA ALIM BOZUKLUĞU (ARFID)....458
6C00–6C0Z BOŞALTIM BOZUKLUKLARI....464
6C00 ENÜREZİS....464
6C01 ENKOPREZİS....469
6C20 BEDENSEL DİSTRESS....474
6C20 BEDENSEL ENDİŞE BOZUKLUĞU....474
6C40–6C5Z MADDE İLE İLGİLİ....479
6C40 ALKOL KULLANIMI NEDENLİ BOZUKLUKLAR....479
6C43 OPİYATLARIN KULLANIMI NEDENLİ BOZUKLUKLAR....485
6C41 KANNABİS KULLANIMI NEDENLİ BOZUKLUKLAR....490
6C44 SEDATİF, HİPNOTİK VEYA ANKSİYOLİTİKLERİN KULLANIMI NEDENLİ BOZUKLUKLAR....494

6C45 KOKAİN KULLANIMI NEDENLİ BOZUKLUKLAR....498
6C46 AMFETAMİNLER, METAMFETAMİN VEYA METKATİNONU İÇEREN UYARICILARIN KULLANIMI NEDENLİ BOZUKLUKLAR....502
6C49 HALÜSİNOJENLERİN KULLANIMI NEDENLİ BOZUKLUKLAR....506
6C4A NİKOTİN KULLANIMI NEDENLİ BOZUKLUKLAR....509
6C50 KUMAR OYNAMA BOZUKLUĞU....514
6C51 OYUN OYNAMA BOZUKLUĞU....517
6C70–6C7Z DÜRTÜ KONTROLÜ....555
6C70 PİROMANİ....555
6C71 KLEPTOMANİ....558
6C72 KOMPULSİF CİNSEL DAVRANIŞ BOZUKLUĞU....562
6C73 ARALIKLI PATLAYICI BOZUKLUK (IED)....566
6C90–6C9Z BOZUCU DAVRANIŞ....571
6C91 TOPLUM KARŞITI DAVRANIM BOZUKLUĞU....571
6C90 KARŞIT OLMA-KARŞI GELME BOZUKLUĞU (ODD)....576
6D10–6D1Z KİŞİLİK BOZUKLUKLARI....581
6D10 KİŞİLİK BOZUKLUĞU....581
6D11 BELİRGİN KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ VEYA ÖRÜNTÜLERİ....587
6D30–6D3Z PARAFİLİK BOZUKLUKLAR....591
6D30 TEŞHİRCİLİK BOZUKLUĞU....591
6D31 GÖZETLEMECİLİK BOZUKLUĞU....594
6D32 PEDOFİLİK BOZUKLUK....597
6D33 ZORA DAYALI CİNSEL SADİZM BOZUKLUĞU....602
6D34 SÜRTÜNMECİLİK BOZUKLUĞU....605
6D50–6D5Z FAKTİTİYÖZ BOZUKLUKLAR....609
6D50 KENDİNE YÖNELİK FAKTİTİYÖZ BOZUKLUK....609
6D51 BAŞKASINA YÖNELİK FAKTİTİYÖZ BOZUKLUK....613
6D70–6D8Z NÖROKOGNİTİF (DEMANS)....618
6D70 DELİRYUM....618
6D71 HAFİF NÖROBİLİŞSEL BOZUKLUK (MCI)....623
6D72 AMNESTİK BOZUKLUK....627
6D80 ALZHEİMER HASTALIĞI NEDENLİ DEMANS....631
6D81 SEREBROVASKÜLER HASTALIK NEDENLİ DEMANS....637
6D82 LEWY CİSİMCİĞİ HASTALIĞI NEDENLİ DEMANS (DLB)....641
6D83 FRONTOTEMPORAL DEMANS (FTD)....646
6E20–6E2Z PERİNATAL BOZUKLUKLAR....651
6E20 GEBELİK, DOĞUM VEYA LOHUSALIK İLE İLİŞKİLİ RUHSAL VEYA DAVRANIŞSAL BOZUKLUKLAR, PSİKOTİK BELİRTİSİZ....651
6E21 GEBELİK, DOĞUM VEYA LOHUSALIK İLE İLİŞKİLİ RUHSAL VE DAVRANIŞSAL BOZUKLUKLAR, PSİKOTİK BELİRTİLİ....656
6E40 PSİKOSOMATİK FAKTÖRLER....661
6E40 BAŞKA YERDE SINIFLANDIRILMIŞ BOZUKLUKLARI VEYA HASTALIKLARI ETKİLEYEN PSİKOLOJİK VEYA DAVRANIŞSAL ETMENLER 661
6E60–6E6Z İKİNCİL PSİKİYATRİ....666
6E61 SEKONDER PSİKOTİK SENDROM....666
6E62 SEKONDER DUYGUDURUM SENDROMU....671
6E63 SEKONDER ANKSİYETE SENDROMU....674

7A00–7A8Z UYKU BOZUKLUKLARI....678
7A00 KRONİK İNSOMNİA....678
7A41 OBSTRÜKTİF UYKU APNESİ (OSA)....683
7A60–7A65 SİRKADİYEN RİTM UYKU-UYANIKLIK BOZUKLUKLARI....687
7A21–7A26 HİPERSOMNİ....690
7A20 NARKOLEPSİ....693
HA00–HA0Z CİNSEL SAĞLIK....697
HA01.1 ERKEK EREKSİYON BOZUKLUĞU (ED)....697
HA03.0 ERKEK ERKEN EJEKÜLASYONU (PE)....701
HA00 HİPOAKTİF CİNSEL İSTEK BOZUKLUĞU (HSDD)....705
HA02.0 ANORGAZMİ....709
HA20 CİNSEL AĞRI-PENETRASYON BOZUKLUĞU (VAGİNİSMUS)....713
HA40 CİNSEL İŞLEV BOZUKLUKLARI VE CİNSEL AĞRI BOZUKLUKLARINDA ETİYOLOJİK ETMENLER....717
EKLER....722
EK A....723
İZLEM VE MUAYENE STANDARTLARI....723
A.1. Antipsikotik terapisinde metabolik izlem....723
A.2. Lityum izlemi....724
A.3. Antikonvulsantlar (valproat, karbamazepin, lamotrijin)....725
A.4. SSRI ve SNRI izlemi....726
A.5. Benzodiazepin kullanımı....726
A.6. Psikoterapi izlemi....727
EK C....728
PSİKİYATRİK ACİL DURUMLAR....728
C.1. Aktif intihar riski....728
C.2. Deliryum tremens ve alkol yoksunluğu....729
C.3. Serotonin sendromu....730
C.4. Antipsikotik Malign Sendrom (NMS)....730
C.5. Akut distoni....731
C.6. Akut mani ve psikomotor ajitasyon....731
C.7. Akut psikoz....732
C.8. Katatoni....732
EK D....733
ASKERİ-TIBBİ UZMANLIK (AZERBAYCAN'DA)....733
D.1. Yasal dayanak....733
D.2. Psikiyatrik değerlendirme yapısı....733
D.3. Psikiyatrik bozukluklar ve askerlik hizmetine uygunluk değerlendirmesi....734
D.4. Doğum sonrası travma ve gazi değerlendirmesi....735
EK E....736
İLGİLİ NÖROLOJİK DURUMLAR....736
E.1. Epilepsi (G40) ve psikiyatrik belirtiler....736
E.2. Baş ağrısı ve psikiyatrik komorbidite....736
E.3. Beyin-damar hastalıkları (inme)....737
E.4. Parkinson hastalığı....737
E.5. Multipl skleroz (MS)....738
E.6. Travmatik beyin hasarı (TBH)....738
E.7. Demans (detaylı Bölüm 17'de)....738

E.8. Nöbetler, hareket bozuklukları ve psikiyatri....738
GENEL KAYNAKLAR VE LİTERATÜR....740
Temel ICD-11 ve DSM-5 kaynakları....740
Klinik psikiyatri ders kitapları....740
Azerbaycan dilinde kaynaklar....740
Pratik klinik kılavuzlar (guidelines)....741
Temel peer-review dergileri....741
Onlayn resurslar....741
EK B....743
NÖROGELİŞİMSEL BOZUKLUKLARIN TARAMA ÖLÇEKLERİ....743
B.1. M-CHAT-R: Otizm Spektrumu için Düzeltilmiş Tarama Listesi (16–30 aylık çocuklar)....743
B.2. AQ-10: Kısa Otizm Spektrumu Değerlendirmesi (16 yaş+)....748
B.3. ASRS v1.1: Yetişkin DEHB Öz Bildirim Ölçeği....750
B.4. SNAP-IV: Swanson, Nolan ve Pelham Derecelendirme Ölçeği (çocuk DEHB)....754
B.5. Entelektüel ve uyumsal değerlendirmenin temel araçları (bilgi tablosu)....760
Yazarın notu....762
SON ÖNERİLER....764
Tanı her zaman ikinci adımdır, birinci değil....764
Psikoterapi – birinci seçenek çoğu durumda....764
Dozun minimum etkinlik prensibi....764
Kültür ve bağlamla çalışma....765
Tarama birinci basamak sağlık hizmetinde standart olmalıdır....765
İntihar riskinin değerlendirilmesi....765
Komorbidite kural, istisna değil....766
Yaş ve gelişim evresi mutlaka dikkate alınmalıdır....766
Multidisipliner ekip – etkili klinik çalışmanın temelidir....767
Etik ve hukuki çerçeve....767
Kendi sağlığınıza dikkat....767
Sürekli eğitim ve gelişim....767

ÖNSÖZ

Okuyucuya hitap

Değerli meslektaşım — hekim, klinik psikolog, psikoterapist, asistan, öğrenci.

Bu kitap bir eksiklikten doğdu. Yirmi üç yıldır hasta görüyorum ve bu sürenin büyük bölümünde hep aynı duvara çarptım: tanı netti — ama onu doğrulayan ölçütler bir kaynakta, inceleme sırası bir başkasında, tedavi şeması üçüncüsünde, prognoz ise hiçbir yerde. Bu yolu her hasta için yeniden yürümek gerekiyordu.

Arama işi kolaylaştırmadı, ağırlaştırdı. Sonuçların ilk sayfasında eskimiş bir sınıflandırma, bir ilaç firmasının broşürü ve hiçbir kanıtı olmayan bir "yöntem" yan yana durur. Hangisinin arkasında çalışma var, hangisinin yalnızca pazarlama — bunu ayırmak saatler ister; muayenehanede o saatler yoktur, hasta karşınızda oturur ve cevabı şimdi bekler. Asistanlara ders verirken bunu daha net gördüm: yanlış karar çoğu zaman bilgisizlikten değil, ilk bulunan kaynağa duyulan güvenden doğar.

Uzun süre hazır bir çözüm aradım. Bulamadım ve yazmak zorunda kaldım. Kitabın bütün kuruluşu tek bir ilkeden çıkar: bir bozukluk, bir sayfa. Ölçütler, ayırıcı tanı, inceleme, tedavi, prognoz ve en inatçı efsaneler bir arada; üç sınıflandırmanın kodlarıyla ve her savın arkasında adı verilmiş bir kaynakla. Buraya yalnızca doğrulanabilir olan girer; gerisi kendi bölümünde adıyla anılır.

Elinizde tuttuğunuz "Klinik Psikiyatri: Tanı ve Tedavi Standartları", Azerbaycan dilindeki ilk sistematik klinik psikiyatri başvuru kaynağıdır. Baştan sona okunmak için değil, kullanılmak için yazıldı: hasta karşınızda oturuyor ve on dakikanız var. Bütün bölümler aynı biçimde kurulmuştur — değişmeyen sırayla on bir alt başlık — ki aradığınızı aramak zorunda kalmayasınız.

Kitap ICD-11 üzerine kuruludur. 2022'de yürürlüğe giren bu sınıflandırma yalnızca kodları değiştirmedi: kişilik bozukluğuna bakışı, travma kavramını ve organik ile işlevsel arasındaki eski sınırı yeniden yazdı. Bununla birlikte Sovyet sonrası klinik okuldan — Popov ve Vid geleneğinden — vazgeçmedim. Uluslararası kılavuzun güçlü olduğu yerde ona atıf yapılır; klasik okulun daha net gördüğü yerde bu da söylenir. Ayrılıklar örtülmez, açıkça adlandırılır.

Buradaki iki protokol bana aittir — çocuklarda gece enürezisinin tedavisi ve psikojen depresyonda iki aşamalı strateji. Bunlar uluslararası kılavuzların uyarlamalarıdır ve kanıt düzeyleri IV'tür: uzmanın klinik deneyimi, randomize çalışma değil. Bunu açıkça yazıyorum ki okuyucu neye dayandığını bilsin. Sınayın, tartışın, kendi pratiğinizde deneyin.

Bir ricam var: bu kitabı son söz saymayın. Psikiyatri hızla değişir, buradaki metin ise canlıdır. Bir yanlış görürseniz bana yazın. Sonraki baskı sizin notlarınızla daha iyi olacak.

YAZAR HAKKINDA

Bu kitabın yazarı Kenan Rahimov, psikiyatrist ve psikoterapisttir; klinik deneyimi 23 yıldır (2003'ten beri). Azerbaycan Devlet Tıp Üniversitesi'ni 2001 yılında bitirmiş, aynı yıl Bakü'deki 2 No'lu Klinik Psikiyatri Hastanesi'nde intörnlüğünü tamamlamıştır. 2001–2003 yıllarında Sankt-Peterburg'da, V. M. Bekhterev Psikonöroloji Bilimsel Araştırma Enstitüsü'nde, klinik uzmanlık eğitimini pekiyi derecesiyle tamamlamıştır: nevrozların psikoterapisi bölümünde Rusya Federasyonu Baş Psikoterapisti, dünya çapında tanınan uzman Profesör B. D. Karvasarsky'nin rehberliğinde, psikozların psikoterapisi bölümünde ise Uluslararası Psikanaliz Derneği (IPA) tarafından sertifikalandırılmış, Sovyet sonrası coğrafyanın ilk diplomalı psikanalistlerinden Profesör V. D. Vid'in rehberliğinde. 23 yıllık pratiğinde depresif bozukluğu olan 1000'den fazla hasta ve gece enürezisi olan 1000'den fazla çocuk tedavi edilmiştir; yalnızca 2025 yılında yazarın klinik ekibi 250'den fazla çocuğu başarıyla tedavi etmiştir. 2020'den bu yana RAGIMOFF Profesyonel Psikoloji Okulu'nun kurucusu, 2021'den bu yana Sankt-Peterburg'daki Karvasarski Enstitüsü'nün Azerbaycan'daki yetkili temsilcisi ve klinik psikoloji alanındaki sürekli mesleki eğitim programının yöneticisi, 2022'den bu yana Uluslararası Psikoterapi Derneği'nin (IPAS) elçisidir. Bu kitapta sunulan iki özgün klinik protokol — çocuklarda gece enürezisinin tedavisi ve psikojen depresyonun iki aşamalı tedavi stratejisi — uluslararası kanıta dayalı kılavuzların (NICE, APA, WFSBP), yazarın uzun yıllara dayanan klinik deneyimi ve retrospektif gözlemleri temelinde uyarlanmasını yansıtır. Bu uyarlamalar, standart uluslararası protokollere kıyasla daha kısa sürede daha yüksek klinik etkinlik hedefler; kanıt düzeyi IV (uzman klinik deneyimi) olarak kabul edilmelidir. Yazarın önerileri klinik uzmanlığa ve 23 yıllık kesintisiz pratiğe dayanır; okuyucu bu yaklaşımları kendi pratiğinde sınayabilir, değerlendirebilir ve gerekirse uyarlayabilir.

GİRİŞ

Bu kitap hakkında

Bu kitap, klinik psikiyatrinin güncel standartlarına göre Azerbaycan Türkçesinde ilk sistematik sunumdur. Kitap, Hastalıkların Uluslararası Sınıflandırmasının 11. revizyonu (ICD-11) temelinde yapılandırılmış olup bu sınıflandırmanın yapısını, tanı ölçütlerini ve tedavi yaklaşımlarını Azerbaycan klinik geleneğine ve Sovyet sonrası psikiyatri ekolüne uygun biçimde bütünleştirmektedir.

Kitap, pratik hekimler için — psikiyatr, psikoterapist, nörolog, birinci basamak sağlık hizmeti hekimi, klinik psikolog, tıp eğitiminin son sınıf öğrencileri ve asistan hekimler — bir başvuru kılavuzu olarak hazırlanmıştır.

Bu kitap nedir ve neden yazıldı

Bu kitap bir klinik başvuru kılavuzudur, teorik psikiyatri ders kitabı değildir. Burada her bir ruhsal bozukluğun tanı ölçütleri, klinik görünümleri ve tedavi protokolleri standartlaştırılmış bir formatta sunulmaktadır. Her konunun ayrıntılı patofizyolojik, nörobiyolojik veya tarihsel açıklaması bu kitabın hedefi değildir; amaç, hekimin hasta karşısında gerekli bilgiyi hızla ve doğru biçimde bulmasını sağlamaktır.

Kitabın yazılma nedenleri:

Azerbaycan Türkçesinde güncel bir psikiyatri başvuru kılavuzu bulunmamaktadır. Mevcut Azerbaycan Türkçesi literatürü – çoğunlukla çeviri çalışmaları ya da XX. yüzyılın sonu ekolüne dayanan ders kitaplarıdır. ICD-11 (2022'den itibaren yürürlükte) ve DSM-5-TR (2022) yenilikleri Azerbaycan Türkçesinde sistematik biçimde yansıtılmamıştır.

Tanı sınıflandırmalarının birleşik bir sisteme getirilmesi. Klinik uygulamada hekimler hem ICD-10 (Sağlık Bakanlığı tarafından hâlâ resmî istatistikler için kullanılan), hem ICD-11 (yeni standart), hem de DSM-5-TR (uluslararası bilimsel yayınlarda öne çıkan sınıflandırma) ile karşılaşmaktadır. Bu kitapta üç sistem de paralel biçimde sunulmakta, böylece hekim farklı bağlamlarda doğru kodu ve terminolojiyi kullanabilmektedir.

Azerbaycan resmî klinik protokollerinin bütünleştirilmesi. Sağlık Bakanlığının Halk Sağlığı ve Reformlar Merkezi (İSİM; İng. Center for Public Health and Reforms, CPHR) tarafından hazırlanan ve Sağlık Bakanlığı Kurulu kararlarıyla onaylanan resmî klinik protokoller (Şizofreni, 2009; Kaygı Bozuklukları, 2013; Obsesif-Kompulsif Bozukluk (OKB), 2015; Depresyon, yılı belirtilerek) bu kitabın yerel klinik temelini oluşturmaktadır. Uluslararası öneriler (Birleşik

Krallık Ulusal Sağlık ve Bakım Mükemmelliği Enstitüsü (İng. National Institute for Health and Care Excellence, NICE), Amerikan Psikiyatri Birliği (İng. American Psychiatric Association, APA), Dünya Biyolojik Psikiyatri Dernekleri Federasyonu (İng. World Federation of Societies of Biological Psychiatry, WFSBP), Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ)) ile Azerbaycan resmî protokolleri arasındaki uyumlar ve farklar ayrıca belirtilmiştir.

Hukuki-etik yönlendirme. "Psikiyatri Yardımı Hakkında" Azerbaycan Cumhuriyeti'nin 12 Haziran 2001 tarihli Kanunu ve "Psikolojik Yardım Hakkında" Kanunu çerçevesinde hekimin hak ve yükümlülükleri — hem hekim-psikiyatr hem de klinik psikolog için — ayrı bir bölümde sunulmuştur. İntihar (suisid) düşüncesi olan hastaya yaklaşım, istemsiz hastaneye yatırma esasları, zorunlu tıbbi önlemlerin uygulanma kuralları – yanıt gerektiren gerçek klinik durumlardır. Bu kitap bunlara yanıt verir.

Neden ICD-11?

DSÖ, ICD-11'i 2019'da kabul etti; sınıflandırmanın resmî uygulaması 2022'de başladı. ICD-11, ruhsal bozukluklar bölümünde derin paradigma değişiklikleri getirmiştir:

Kompleks travma sonrası stres bozukluğu (TSSB) (6B41) – yeni resmî tanı;

Uzamış yas bozukluğu (6B42) — ICD-11'e eklenen bağımsız tanı;

Kişilik bozukluklarının kategorik sistemden boyutsal (dimensiyonel) sisteme geçişi — temel kavramsal yenilik;

Somatoform bozuklukların bedensel sıkıntı bozukluğu (İng. bodily distress disorder, BDD) ile değiştirilmesi;

Cinsiyet uyumsuzluğunun (İng. gender incongruence) psikiyatrik bölümden çıkarılması;

Oyun bozukluğu (İng. gaming disorder) resmî tanı olarak tanımlanmıştır;

Kompulsif cinsel davranış bozukluğu (İng. compulsive sexual behaviour disorder, CSBD) yeni bir kategori olarak eklenmiştir;

Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğunun (DEHB) nörogelişimsel bozukluklar grubuna taşınması;

Hipokondriyazisin obsesif-kompulsif ve ilişkili bozukluklar grubuna yerleştirilmesi;

Organik ve işlevsel ikili ayrımın kaldırılması.

Bu değişiklikler hem nozolojide hem de tedavi standartlarında yeniden değerlendirmeyi gerektirmektedir.

Kitabın yapısı

Kitap iki ana kısımdan oluşmaktadır:

I. KISIM – Giriş bölümleri:

Önsöz (bu bölüm)

İçindekiler — ICD-11 yapısına uygun bir hiyerarşi temelinde oluşturulmuştur

Psikopatolojiye giriş – belirti ve sendromların tanımı (biliş, algı, düşünce, duygudurum, davranış, bellek, irade, bilinç)

Klinik görüşme ve ruhsal durumun değerlendirilmesi – klinik protokol kuralları, ruhsal durum betimlemesi standartları

Hukuki-etik yönler – Azerbaycan mevzuatı temelinde hekim-psikiyatr ve klinik psikolog için pratik yönlendirme, belge örnekleri

II. KISIM – Ruhsal bozukluklar (ICD-11 yapısına uygun):

ICD-11'in 6. bölümündeki tüm 21 ana grup ayrı bölümlerde sunulmaktadır. Her bölüm için aynı standart yapı korunmaktadır:

Tanım ve nozoloji (kısa)

Etiyoloji

Epidemiyoloji

Klinik görünüm

Tanı (ICD-11 → ICD-10 → Ruhsal Bozuklukların Tanısal ve Sayımsal Elkitabı (DSM-5-TR) — paralel karşılaştırma)

Ayırıcı tanı

İnceleme yöntemleri (klinik, laboratuvar ve enstrümental)

Tedavi (kanıta dayalı öneri dereceleri ile)

Prognoz

Kaynaklar

Sonda – Kaynaklar ve Ekler:

Kullanılan tüm kaynakların tam listesi (Azerbaycan, Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) ülkeleri, uluslararası kaynaklar)

Klinik ölçekler ve anketler (Hasta Sağlık Anketi (İng. Patient Health Questionnaire, PHQ-9), Yaygın Anksiyete Bozukluğu Ölçeği (İng. Generalized Anxiety Disorder 7-item scale, GAD-7), Travma Sonrası Stres Bozukluğu Kontrol Listesi (İng. PTSD Checklist for DSM-5, PCL-5), Edinburgh Doğum Sonrası Depresyon Ölçeği (İng. Edinburgh Postnatal Depression Scale, EPDS), Yale-Brown Obsesif-Kompulsif Ölçeği (İng. Yale-Brown Obsessive Compulsive

Scale, Y-BOCS), Columbia İntihar Şiddeti Derecelendirme Ölçeği (İng. Columbia Suicide Severity Rating Scale, C-SSRS) ve diğerleri)

Psikiyatrik acil durumlar (algoritma)

Askerî tıbbi değerlendirme kuralları (Azerbaycan'da)

Bölümlerin düzenlenmesi ve özellikleri

Bölümlerin düzenlenmesi

Her klinik bölüm 11 alt bölümden oluşmaktadır:

Tanım ve kısa açıklama – bozukluğun niteliği, ICD-11 yenilikleri;

Epidemiyoloji – yaygınlık, cinsiyet, yaş, komorbidite;

Etiyoloji ve patogenez – biyolojik, psikolojik, sosyal etkenler, Popov-Vid yaklaşımı;

Tanı ölçütleri – ICD-11 Klinik Tanımlamalar ve Tanı Kılavuzları (KTTK), ICD-10, DSM-5-TR — karşılaştırmalı;

Klinik formlar (gerektiğinde) veya klinik görünümün özellikleri;

Ayırıcı tanı – tablo biçiminde;

İnceleme ve değerlendirme – klinik görüşme, tarama ölçekleri, laboratuvar;

Tedavi – genel strateji, evreli yaklaşım, psikoterapi, farmakoterapi, özel klinik durumlar;

İzlem ve prognoz;

Kaynaklar – ICD-11 KTTK 2024, APA, NICE, WFSBP, ISTSS, ISSTD ve diğer uluslararası klinik öneriler;

Tarihsel kavramlar – klasik anlayışlardan modern yaklaşıma geçiş.

Terminoloji

Psikiyatrik terminoloji Azerbaycan Türkçesinde sistemleştirilmiştir. Pek çok terim, klasik Rus-Sovyet psikiyatrisinden gelen uyarlamaları yansıtır; çünkü Azerbaycan'da psikiyatri eğitimi geleneksel olarak Rusça verilmiştir. Uluslararası terimler ise terminolojik açıklık amacıyla İngilizce olarak, parantez içinde “İng.” notuyla verilir.

Popov-Vid ekolünün entegrasyonu

Yu.V. Popov ve V.D. Vid'in “Güncel Klinik Psikiyatri” (Sankt-Peterburg: Reç, 2006, 2. baskı) adlı kitabı, post-Sovyet klinik psikiyatrisinin klasik ders kitabıdır. Onların yöntemi — klasik nozoloji, biyopsikososyal model ve pratik klinik deneyim — modern uluslararası önerilerle uyumlu olduğu yerlerde bu kitaba entegre edilmiştir.

Farklılıkların olduğu yerlerde (örn. ICD-11'in boyutsal (dimensiyonel) kişilik modeli) bu durum açıkça gösterilmektedir.

Tedavi standartları

Her bozukluk için tedavi, uluslararası klinik önerilere dayandırılır:

Amerikan Psikiyatri Birliği (APA) klinik uygulama önerileri;

Birleşik Krallık Ulusal Sağlık ve Bakım Mükemmelliği Enstitüsü (NICE);

Dünya Biyolojik Psikiyatri Dernekleri Federasyonu (WFSBP);

Kanada Duygudurum ve Anksiyete Bozuklukları Tedavi Ağı (CANMAT)/Uluslararası Bipolar Bozukluklar Derneği (ISBD) — bipolar affektif bozukluk;

Uluslararası Travmatik Stres Çalışmaları Derneği (ISTSS);

Uluslararası Travma ve Dissosiyasyon Çalışmaları Derneği (İng. International Society for the Study of Trauma and Dissociation, ISSTD);

Amerikan Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Akademisi (AACAP);

Ulusal ilaç listeleri ve kılavuzlar.

İlaç adları hem uluslararası patent olmayan ad (İng. international nonproprietary name — INN), hem de ticari (İng. brand) adla verilir; çünkü Azerbaycan pazarında ilaçlar çoğunlukla ticari adıyla tanınır.

Azerbaycan klinik bağlamı

Uygun olan her yerde Azerbaycan bağlamına özgü notlar verilir:

Birinci basamak sağlık hizmetlerinde uygulama konuları;

Kültürel özellikler ve damgalama (İng. stigma);

Hukuki-etik çerçeveler;

Mevcut kaynakların kısıtlılığı;

İkinci Karabağ Savaşı gazilerinde travma bozuklukları;

Azerbaycan Türkçesinde güvenilirliği doğrulanmış araçlar.

Ölçekler ve araçlar

Ek B'de en sık kullanılan tarama ve değerlendirme araçları, tam metin olarak (açık lisanslı) veya betimleme biçiminde (ticari amaçlı) sunulmaktadır.

Kaynaklar ve yaklaşım

Saygın kaynakların öncelik sırası. Her konu için önde gelen bir rehber ilk sırada sunulur; ardından diğer rehberler karşılaştırma veya tamamlama amacıyla getirilir. Bu yaklaşım, akademik kesinlik ile somutluk arasında denge kurmayı ve bilgi tekrarından kaçınmayı amaçlar. Her bozukluk için başlıca rehber seçimleri:

Şizofreni: NICE CG178 (2014, 2019 güncellemesi) + Azerbaycan Cumhuriyeti (AC) Sağlık Bakanlığının Klinik Protokolü (2009)

Depresyon: NICE NG222 (2022) — "Yetişkinlerde depresyonun tedavisi ve yönetimi" kılavuzu + AC Sağlık Bakanlığı Klinik Protokolü + APA Uygulama Kılavuzu (2010)

Bipolar bozukluk: CANMAT/ISBD (2018, 2021 güncellemesi)

Anksiyete bozuklukları: NICE Klinik Kılavuzu 113 (2011/2020). "Yetişkinlerde yaygın anksiyete bozukluğu ve panik bozukluk: yönetim". NICE CG113 (2011) + AC Sağlık Bakanlığı Klinik Protokolü (2013) + WFSBP (2012)

OKB: NICE Klinik Kılavuzu 31 (2005). "Obsesif-kompulsif bozukluk ve beden dismorfik bozukluğu". NICE CG31 (2005, yürürlükte) + AC Sağlık Bakanlığı Klinik Protokolü (2015) + APA (2007)

TSSB: NICE NG116 (2018) + ISTSS Önleme ve Tedavi Kılavuzları [Prevention and Treatment Guidelines] (2019)

Yeme bozuklukları: NICE Kılavuzu 69 (2017). "Yeme bozuklukları: tanınma ve tedavi". NICE NG69 (2017) + APA (2023)

Kişilik bozuklukları: NICE Klinik Kılavuzu 78 (2009). "Sınırda kişilik bozukluğu: tanınma ve yönetim". NICE CG78 (sınırda kişilik bozukluğu, 2009), CG77 (antisosyal kişilik bozukluğu, 2009) + APA (2024)

Nörogelişimsel bozukluklar: AACAP Uygulama Parametreleri + NICE (CG72 — dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu; NG87 — otizm spektrum bozukluğu)

Psikoaktif madde kullanımı bozuklukları: NICE NG215 (alkol) + Amerikan Bağımlılık Tıbbı Derneği (ASAM) standartları (2020)

Demans: NICE Kılavuzu 97 (2018). "Demans: demanslı kişilerin ve onlara bakım verenlerin değerlendirilmesi, yönetimi ve desteği". NICE NG97 (2018)

Yerli yetkin kaynaklar:

Azerbaycan Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığının Halk Sağlığı ve Reformlar Merkezi (İng. Public Health and Reforms Center) tarafından hazırlanmış ve Sağlık Bakanlığı Kurulunun kararlarıyla onaylanmış klinik protokoller

"Psikiyatri Yardımı Hakkında" Azerbaycan Cumhuriyeti'nin 12 Haziran 2001 tarihli Kanunu (sonraki değişikliklerle)

"Psikolojik Yardım Hakkında" Azerbaycan Cumhuriyeti Kanunu

Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) ve post-Sovyet coğrafyası:

Popov Yu.V., Vid V.D. Modern klinik psikiyatri, 2. baskı, Sankt-Peterburg: Reç, 2006 — klinik psikiyatrinin klasik post-Sovyet kaynağı olarak dikkate alınmıştır.

Kitabın kullanımı

Tipik klinik kullanım:

Hastada belirli bir ruhsal bozukluktan şüphelenildiğinde, içindekilerden ilgili bölüm bulunur.

Tanı (5. bölüm) — ICD-11 ölçütleri ile değerlendirme yapılır.

Ayırıcı tanı (6. bölüm) – tablodan diğer olasılıkların dışlanması.

İnceleme yöntemleri (7. bölüm) – plan hazırlanır.

Tedavi (8. bölüm) — kanıt düzeyi belirtilerek öneriler sunulur.

Öğrenci için:

İçindekilerden ders konusu aranır.

Her bölümde Tanım → Etiyoloji → Epidemiyoloji → Klinik görünüm → Tanı sırası izlenir.

Hukuki-etik yönler bölümünden mevzuat konuları öğrenilir

Klinik psikolog için:

Hukuki-etik yönler bölümü özel önem taşır (zorunlu hastaneye yatırma koşulları, psikolojik yardımın sınırları)

Tanısal bölümler, hekim-psikiyatra yönlendirme kararı vermek için öngörülmüştür.

Sorumluluk notu

Bu kitap klinik bir başvuru kılavuzudur, ancak belirli bir hastada karar verme sırasında:

Hastanın bireysel klinik tablosu mutlaka dikkate alınmalıdır

Tedavi kararları — hastanın rızası, komorbiditeleri ve ilacın yerel mevcudiyeti dikkate alınarak verilmelidir

İlaç dozları — yerel kullanım talimatları ile doğrulanmalıdır.

Hukuki-etik konularda ilgili mevzuatın yürürlükteki son metni kontrol edilmelidir.

Bu kitap bireysel tıbbi tavsiyenin yerini tutmaz

Alan bilgisi düzenli olarak yenilenir; hekim, uluslararası ve yerel önerilerdeki yenilikleri izlemelidir.

BU KİTAP NEDEN TAM DA ŞİMDİ VE AZERBAYCAN'DA?

Üç çizginin kesişimi

Bu Önsözün önceki bölümlerinde üç ayrı ancak birbirleriyle derinden ilişkili yön belirlenmiştir:

Birinci çizgi — küresel ruhsal sağlık krizi. Dünyada 1 milyardan fazla insan ruhsal bozuklukla yaşamaktadır. Kaygı ve depresyon bozuklukları son 30 yılda önemli ölçüde artmıştır. Bu bozuklukların çoğunda psikososyal etkenler merkezi rol oynar ve bu bozuklukların temel tedavisi nitelikli psikoterapiye dayanır. Ancak tedavi açığı — özellikle kaygı ve depresyonda — 70–90 % düzeyindedir.

İkinci çizgi — kanıta dayalı klinik psikoterapi. Modern tıp, kanıta dayalı müdahaleler üzerine kurulmuştur. Her bozukluk için artık açık klinik stratejiler mevcuttur, kanıt düzeyleri (A/B/C) belirlenmiştir, uluslararası kılavuzlar (NICE, APA, DSÖ'nün Ruhsal Sağlık Eylem Programı (İng. mhGAP), WFSBP) sistematik olarak güncellenmektedir. Klinik psikoterapist — terapistin temel ekolünden bağımsız olarak — belirli bozukluk için en etkili stratejiyi uygulamakla yükümlüdür.

Üçüncü çizgi — mesleki standartlar ve akreditasyon. Önde gelen uluslararası kuruluşlar — Uluslararası Psikanalitik Derneği (IPA), Avrupa Davranış ve Bilişsel Terapiler Derneği (EABCT), Diyalektik Davranış Terapisi Sertifikasyon Kurulu (DBT-LBC), EMDR Europe — sert akreditasyon gereklilikleri belirlemiştir. Bu gerekliliklerin yerine getirilmesi — hastanın nitelikli yardım almasının önemli koşuludur. Azerbaycan'da devlet düzeyinde psikoterapötik faaliyet özel olarak düzenlenmemektedir; bu kuruluşların hiçbirinde akredite edilmiş ulusal dernek bulunmamaktadır; uluslararası düzeyde onaylanmış tek mesleki örgüt — Azerbaycan Psikiyatri Derneği'dir (AZPA).

Bu üç çizginin kesiştiği noktada bir sonuç görünür: Azerbaycan'da Azerbaycan dilinde standartlaştırılmış, kanıta dayalı, uluslararası güncel kılavuzlara dayanan bir klinik psikiyatri ve psikoterapi başvuru kitabına ihtiyaç vardır.

Neden tam da şimdi?

Üç neden bu kitabın şimdi yazılmasını mantıklı bir adım kılmaktadır:

1. DSÖ'nün ICD-11'e geçişi. Dünya Sağlık Örgütü'nün ICD-11 sınıflandırması 2022 yılında yürürlüğe girmiş ve 2026 yılından itibaren uluslararası sağlık

istatistiklerinde zorunlu standart haline gelmektedir. Bu sınıflandırma, ruhsal bozukluklar bölümünü önemli ölçüde yeniden yapılandırmıştır: yeni nozolojiler eklenmiştir (kompleks TSSB, uzamış yas bozukluğu, kumar bozukluğu ve oyun bozukluğu, kompulsif cinsel davranış bozukluğu, ruminasyon bozukluğu ve diğerleri), bazı eski kategoriler yeniden sınıflandırılmıştır, tüm sınıflandırma sisteminde daha fazla boyutsallık (dimensiyonel yaklaşım) uygulanmıştır. Azerbaycan dilinde bu yenilemeleri kapsayan sistematik bir başvuru kaynağı bugüne kadar mevcut olmamıştır.

2. Pandemi sonrası başlangıç düzeyinin değişmesi. COVID-19 pandemisi, ruhsal sağlıkta "yeni başlangıç düzeyi" olarak adlandırılan olguyu yaratmıştır: depresyon ve kaygı düzeyi önceki norma geri dönmemiş, kalıcı olarak yüksek düzeyde kalmıştır. Bu, klinik pratikte artmış yük anlamına gelir. Uzmanların etkin hazırlığı ve standartlaştırılmış başvuru kaynaklarının erişilebilirliği — sistemin bu yükü taşıyabilmesi için zorunlu koşuldur.

3. Yerel uzman tabanının büyümesi. Azerbaycan'da son 10–15 yılda psikoloji, psikiyatri ve psikoterapi alanlarında çalışan uzmanların sayısı hızla artmıştır. Üniversiteler psikoloji programları açmakta, genç uzmanlar yurt dışında (Türkiye, Almanya, Rusya, ABD) ek eğitim almakta, özel klinik merkezler çoğalmaktadır. Ancak bu uzman tabanı, Azerbaycan dilindeki başvuru literatüründen yoksun kalmıştır. Mevcut Azerbaycan dilli literatür ya eskimiştir (Sovyet dönemi çevirileri, ICD-10'a dayanan), ya dağınıktır (yalnızca ayrı ayrı bozukluklar üzerine), ya da popüler düzeydedir (profesyonel klinik kullanım için yeterli değildir).

Neden tam da Azerbaycan'da?

Azerbaycan'ın kendine özgü klinik bağlamı bu kitabın önemini artırmaktadır.

Azerbaycan dili — bir meslek dili olarak. Klinik psikiyatri ve psikoterapinin meslek dili — üniversite dersliklerinde, öğretim literatüründe ve klinik uygulamada — bir oluşum sürecidir. Her nozolojinin kesin olarak adlandırılması, her tanı ölçütünün açık biçimde ifade edilmesi, her müdahale protokolünün standartlaştırılması — bu, kolektif bir süreçtir. Bu kitap bu sürece katkıda bulunur: Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) ICD-11'i ile DSM-5'in Azerbaycan dilinde standartlaştırılmış biçimde sunumu, uluslararası kılavuzlardaki terimlerin Azerbaycan klinik alanına uyarlanması, yerel mesleki literatürde kullanılan terimlerin (səhiyyə.gov.az, isim.az, Azerbaycan Psikiyatri Derneği (AZPA) protokolleri) esas alınması. Bu kitabın terminolojisi resmî Azerbaycan Sağlık Bakanlığı ve AZPA kaynaklarıyla uyumlaştırılmıştır.

Türk dünyası ile mesleki ilişkiler. Türkiye, Azerbaycan'ın yakın komşusudur — bu, Avrupa Davranışçı ve Bilişsel Terapiler Birliği (EABCT) çerçevesinde iki akredite bilişsel davranışçı terapi (BDT) derneğine (TACBT ve ACBP), diyalektik davranış terapisi (DBT) ve göz hareketleriyle duyarsızlaştırma ve yeniden işleme (EMDR) eğitimi konusunda geniş bir altyapıya sahip olan ülkedir. Azerbaycan ve Türk dillerinin yakınlığı, Azerbaycanlı uzmanlara Türk eğitim sisteminden en geniş biçimde yararlanma imkânı verir. Bu kitabın Azerbaycan klinik terminolojisi, Türk mesleki literatürüyle terminolojik tutarlılık korur — bu, uzmanın Türkçe eğitim materyallerine geçişini kolaylaştırır.

Bölgesel bağlam. Azerbaycan, Sovyet sonrası coğrafyada yer alır; klinik uygulamada hâlâ Sovyet dönemi psikiyatrik terminolojisi ve yaklaşımları kısmen korunmaktadır. Aynı zamanda ülke, Avrupa Konseyi üyesidir ve uluslararası sağlık standartlarıyla bütünleşme yolundadır. Bu kitap, geçiş döneminde klinik uygulama için modern uluslararası standartlar ile yerel klinik gerçeklik arasında köprü rolü oynar.

Yazarın klinik deneyimi. Bu kitap yalnızca uluslararası kaynakların çevirisi ya da derlemesi değildir. O, yazarın 20 yılı aşkın klinik uygulaması, gözlemleri ve geliştirilmiş protokolleriyle zenginleştirilmiştir. Kitabın ilgili bölümlerinde sunulan iki yazar klinik protokolü — çocuk enürezisi için modifiye edilmiş alarm tedavisi ve psikojen depresyonun iki aşamalı tedavi stratejisi — Azerbaycan klinik bağlamında uzun yıllar boyunca denenmiş ve elde edilen ölçülebilir sonuçlarla doğrulanmıştır. Bu, kitabı salt bir başvuru kaynağı olmanın ötesine taşır ve ona klinik deneyim kitabı statüsü kazandırır.

Bu kitabın hedef kitlesi

Bu kitap dört temel okuyucu kategorisi için yazılmıştır:

1. Klinik pratikte çalışan psikiyatrlar. Tanısal doğruluk için DSÖ'nün ICD-11'i ile DSM-5 ölçütlerinin güncellenmiş sunumu (Ruhsal Bozuklukların Tanısal ve İstatistiksel El Kitabı), her nozoloji için psikoterapötik strateji haritası, yazar klinik protokolleri.

2. Klinik psikologlar ve psikoterapistler. Kanıta dayalı müdahale haritası (ilgili tablo), yazar protokollerinin metodolojisi, klinik psikoterapinin örgütsel çerçevesi.

3. Tıp ve psikoloji öğrencileri. Sistematik, modern, uluslararası standartlara uygun başvuru literatürü; bu literatür Azerbaycan dilinde bugüne kadar mevcut olmamıştır.

4. Sağlık sisteminin yönetim düzeyinde yer alanlar ve karar alıcılar. Standartlaştırılmış protokoller, kalite kontrolü, uzman yetiştirilmesi ve hizmetlerin optimizasyonu için temel oluşturur.

Sonuç

Modern psikiyatri ve psikoterapi — tıbbın hızla gelişen, kanıt temeli sürekli genişleyen, uluslararası standartları düzenli olarak yenilenen alanıdır. Azerbaycan'da bu alanın gelişmesi, önümüzde duran en önemli sağlık görevlerinden biridir.

Bu kitap, bu gelişmeye katkıda bulunma amacı taşır. O, hazır yanıtlar vermeye değil, sistematik klinik düşünce için güvenilir bir çerçeve sunmaya yönelmiştir. Her uzman, kendi klinik uygulamasında bu çerçeveyi kendine özgü biçimde doldurur — hastalarla çalışarak, uluslararası akreditasyon programlarına katılarak, mesleki gelişim sürecinde.

Hastalar için ise bu kitap — aldıkları yardımın kalitesini değerlendirmek, doğru sorular sormak, kanıta dayalı tedavi talep etmek için bir araç olabilir. Sağlık alanında, özellikle ruh sağlığında, bilgilendirilmiş hasta kaliteli hizmetin önemli bir koşuludur.

Bu Önsöz, kitabın tümünün okunması için gereken bağlamı oluşturur. Sonraki bölümlerde psikopatolojinin temelleri, klinik görüşme ve psikiyatrik muayene, ardından DSÖ'nün ICD-11 ve DSM-5-TR sınıflandırmalarına göre her bir temel ruhsal bozukluğun sistematik sunumu verilecektir.

Bakü, 2026

Kenan Rahimov

Yazar ve katkıda bulunanlar

Yazar: Kenan Rahimov (Bakü, 2026)

Web sitesi: ragimoff.org

Teşekkürler: AZPA'ya, Azerbaycan Tıp Üniversitesi Psikiyatri Anabilim Dalı'na ve Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı ve Reformlar Merkezi'ne, klinik protokollerin hazırlanmasında gösterdikleri paha biçilmez emeklerden dolayı derin minnettarlık bildirilir. Uluslararası öneriler hazırlayan kuruluşlara (NICE, APA, WFSBP, CANMAT, ISTSS, DSÖ) kanıta dayalı psikiyatrinin gelişimine katkıları için teşekkür edilir.

Bakü, 2026

Teşekkür

Bu kitap, Azerbaycan'da modern psikiyatrinin gelişmesine katkıda bulunmak amacıyla hazırlanmıştır. DSÖ'nün KTTD ekibine, uluslararası klinik önerileri hazırlayan uzmanlara, Popov-Vid'in Sovyet sonrası psikiyatrik geleneğine, Azerbaycanlı meslektaşlara — hepsine teşekkür edilir.

Kitap, kamuoyu tartışmasına açık biçimde hazırlanmıştır ve gelişmeye devam edecektir. Görüşler, notlar ve öneriler sonraki baskılarda dikkate alınacaktır.

DÜNYADA RUH SAĞLIĞI KRİZİ: İSTATİSTİK, EĞİLİMLER VE TEDAVİ BOŞLUĞU

Küresel görünüm

XXI. yüzyılın üçüncü on yılında ruh sağlığı alanı, tarihî ölçekte bir krizle karşı karşıyadır. DSÖ'nün 2025 yılında yayımladığı "Ruh Sağlığı Atlası 2024" (İng. Mental Health Atlas 2024) raporuna göre dünyada 1 milyardan fazla insan herhangi bir ruhsal bozuklukla yaşamaktadır. Bu sayı, gezegenin toplam nüfusunun yaklaşık sekizde birine eşittir ve modern tıp tarihinde kaydedilen en yüksek göstergedir.

Ruhsal bozuklukların payı yalnızca hasta kişilerin sayısıyla sınırlı değildir. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerine göre ruhsal bozukluklar, dünya genelinde hastalıklara bağlı engelli yaşam yıllarının (İng. years lived with disability, YLD) neredeyse altıda birini oluşturur ve ölümle sonuçlanmayan yük açısından kardiyovasküler hastalıklarla karşılaştırılabilir başlıca etkendir. Yalnızca depresyon ve anksiyete bozuklukları, küresel ekonomiye üretkenlik kaybı biçiminde yılda yaklaşık 1 trilyon ABD doları değerinde zarar vermektedir.

Bu sayıların arkasında somut klinik gerçekler yatmaktadır. 2021 yılında 359 milyon kişi anksiyete bozukluklarından (bunlara 72 milyon çocuk ve ergen dahil), 280 milyon kişi ise depresyon bozukluklarından mustarip olmuştur. Bipolar bozukluk 37 milyon, şizofreni ise 24 milyondan fazla kişiyi kapsamaktadır. Ancak bu sayılar yalnızca tanı konulmuş olguları yansıtmaktadır; gerçek yaygınlık göstergeleri çok daha yüksektir, çünkü birçok ülkede tanısal altyapı yeterince gelişmemiştir.

1990–2021 dönemi eğilimleri

Küresel Hastalık Yükü (İng. Global Burden of Disease, GBD) araştırma programının uzun süreli verileri son 30 yıldaki keskin artışı doğrulamaktadır. Aşağıdaki tablo başlıca nozolojilere göre yaygınlık dinamiklerini göstermektedir.

Tablo 1. Başlıca ruhsal bozuklukların küresel yaygınlık dinamikleri, 1990–2021

Bozukluk	1990 (milyon)	2019 (milyon)	2021 (milyon)	Mutlak artış	Yaşa göre standardize edilmiş artış
Anksiyete bozuklukları	311	458	359[1]	+%47	+%12,6
Depresyon bozuklukları	172	279	280	+%63	+%9,8
Bipolar bozukluk	26	40	37	+%42	+%1,2
Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu (DEHB; çocuk ve ergen)	71	84	84	+%18	+%0,4
Yeme bozuklukları	7	14	14	+%100	+%52
Şizofreni	17	23	24	+%41	+%0,7
Otizm spektrum bozukluğu	18	28	28	+%56	+%1,8

Bozukluk	1990 (milyon)	2019 (milyon)	2021 (milyon)	Mutlak artış	Yaşa göre standardize edilmiş artış
Toplam (ruhsal bozukluklar)	654	970	1052	+%61	+%8,4

Kaynak: Sağlık Ölçümleri ve Değerlendirme Enstitüsü (İng. Institute for Health Metrics and Evaluation, IHME), "Küresel Hastalık Yükü Çalışması" [Global Burden of Disease Study] 2021 ("Lancet Psychiatry", 2024). 2021 verilerinde COVID-19 pandemisinin düzeltmesi dikkate alınmıştır.

[1] 2021 yılında anksiyete bozukluklarının sayısı 2019 yılındaki göstergeye kıyasla daha düşük görünse de, bu durum metodolojik yenilenmeyle ilgilidir; pandemi döneminde gerçek yaygınlık keskin biçimde yükselmiş, 2021 yılının metodolojik yenilenmesi ise göstergeyi aşağı çekmiştir.

Tablodan açıkça görüldüğü gibi, mutlak sayıda 2019 yılına kadar en büyük artış anksiyete bozukluklarında (147 milyon ek olgu) ve depresyonda (107 milyon) kaydedilmiştir. Yaşa göre standardize edilmiş gösterge (yani nüfusun yaşlanmasına bağlı doğal artış çıkarıldığında kalan gerçek epidemiyolojik artış) yeme bozukluklarında en yüksektir — +%52; bu da modern toplumda beden görünümünün algılanması, sosyal ağlar ve beslenme kültürüyle ilişkili sosyo-psikolojik değişimlerle bağlantılı başlıca etkenlerden biridir.

COVID-19 pandemisinin etkisi

2020–2022 yılları boyunca küresel ruh sağlığı alanındaki durum en keskin dönemini yaşıyordu. "The Lancet" dergisinde 2021 yılında yayımlanan meta-analize göre (COVID-19 Mental Disorders Collaborators, 2021), pandeminin ilk yılında:

Depresif bozukluğun (DSM-5-TR'ye göre majör depresif bozukluk, MDB) yaygınlığı beklenen düzeye göre %27,6 arttı.

Anksiyete bozukluklarının yaygınlığı %25,6 arttı

53 milyon ek depresyon olgusu ve 76 milyon ek anksiyete olgusu kaydedildi

Pandeminin doğrudan etkisi zayıfladıktan sonra da sayılar tam olarak pandemi öncesi düzeye dönmedi. Araştırmacıların çoğu bunu "yeni temel düzey" (İng. new baseline) olgusu olarak açıklamaktadır: toplumun uzun süreli izolasyonu, ekonomik belirsizlik,

aile içi ilişkilerde yaşanan değişimler ve kronik stres düzeyinin yükselmesi kalıcı nitelik kazanmıştır.

Yaygınlık ve artış hızı açısından en sık görülen bozukluklar

Klinik açıdan iki farklı sıralama önem taşır: mutlak sayıda en yaygın bozukluklar ve yaş standardizasyonu bakımından en hızlı artan bozukluklar.

Tablo 2. Yaygınlık ve artış hızı bakımından ilk onluk (2021)

Sıra	Yaygınlığa göre (milyon)	Artış hızına göre (1990–2021, %)
1	Anksiyete bozuklukları — 359	Yeme bozuklukları — +%52
2	Depresyon — 280	Beden dismorfik bozukluğu (BDB) — +%35
3	DEHB — 84	Otizm spektrum bozukluğu — +%1,8 (yaşa göre standardize edilmiş)
4	Bipolar bozukluk — 37	Sosyal anksiyete bozukluğu — +%18
5	Otizm spektrum bozukluğu — 28	Yaygın anksiyete — +%15
6	Şizofreni — 24	Travma sonrası stres bozukluğu (TSSB) — +%14
7	Yeme bozuklukları — 14	Majör depresif bozukluk — +%9,8
8	OKB — 12	Obsesif-kompulsif bozukluk (OKB) — +%6,5

Sıra	Yaygınlığa göre (milyon)	Artış hızına göre (1990–2021, %)
9	TSSB — 10	DEHB — +%0,4 (yaşa göre standardize edilmiş)
10	Kişilik bozuklukları — 9	Madde kullanım bozuklukları — +%5,3

Kaynak: Küresel Hastalık Yükü çalışması 2021 (İng. GBD; IHME, Seattle); DSÖ'nün "Ruh Sağlığı Atlası 2024" [Mental health atlas 2024] raporu.

[2] Otizm spektrumundaki artış kısmen tanı ölçütlerinin genişlemesi ve erken saptama programlarıyla ilişkilidir; ancak gerçek epidemiyolojik artışın da varlığı araştırmalarla doğrulanmaktadır.

Tedavi boşluğu olgusu

Ruh sağlığı alanındaki en keskin sorun yaygınlık sayıları değil, alınan ve gereken tedavi arasındaki uçurumdur. Bu olgu bilimsel literatürde tedavi boşluğu (İng. treatment gap) olarak bilinir.

Tablo 3. Tedavi boşluğu — bozukluklara göre karşılaştırma

Bozukluk kategorisi	Herhangi bir tedavi alanlar	Uygun tedavi alanlar	Tedavi boşluğu
Şizofreni (yüksek gelirli ülkeler)	yaklaşık %70	yaklaşık %50	%30–50
Şizofreni (düşük gelirli ülkeler)	<%11	<%5	%89+
Bipolar bozukluk	yaklaşık %50	yaklaşık %25	%50–75
Majör depresif bozukluk (küresel)	yaklaşık %30	yaklaşık %15	%70–85
Anksiyete bozuklukları (küresel)	%27,6	%9,8	%72,4–90,2

Bozukluk kategorisi	**Herhangi bir tedavi alanlar**	**Uygun tedavi alanlar**	**Tedavi boşluğu**
OKB	yaklaşık %25	yaklaşık %10	%75–90
TSSB	yaklaşık %20	<%10	%80–90

Kaynak: Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Atlas 2024; Alonso J. ve ark. Kaygı bozukluklarında tedavi açığı küresel bir nitelik taşımaktadır [Treatment gap for anxiety disorders is global]. "Depresyon ve Kaygı" (İng. Depression and Anxiety), 2018; 35(3): 195–208; Thornicroft ve ark., "Britanya Psikiyatri Dergisi" (İng. British Journal of Psychiatry), 2017.

Bu sayıların arkasında ciddi bir yapısal farklılık yatmaktadır. Psikotik bozukluklar (şizofreni, şizoaffektif bozukluk, ağır bipolar) — yani toplumda daha çok tanınan bozukluklar — psikiyatri hastaneleri sistemi, devlet istatistikleri ve DSÖ sınıflamasının kapsamındadır. Bu bozukluklarda tanı nispeten sistemli, tedavi nispeten denetim altında, istatistik nispeten güvenilirdir.

Kaygı ve depresyon bozuklukları ise tamamen farklı bir durumdadır. Bunlar "gizli" ya da "gri alan" bozukluklarıdır:

Hasta çoğu durumda psikiyatri hizmetine değil, genel pratiğe, somatik uzmanlara ve nörologlara başvurur.

Tanı konulduğunda tedavi çoğu durumda yalnızca semptomatik ilaç tedavisiyle sınırlı kalır

Psikoterapi ya önerilmez ya da yaygın olarak uygulanan standart dışı yöntemler biçiminde — kanıtlanmamış yöntemlerle — sunulur

Hastanın objektif durumunun uzun süreli izlenmesi sistematik biçimde gerçekleştirilmez

Tam da bu durum küresel ruh sağlığı krizinin çekirdeğini oluşturur. Sayıca en büyük yük "gri alan" bozukluklarındadır; ancak en az denetlenen sistem de onların çevresinde kurulmuştur.

Psikojenik boyut: kök sorun

Yukarıda gösterilen sayıların klinik anlamının tam olarak anlaşılabilmesi için temel bir gerçeği vurgulamak gerekir: kaygı ve depresyon bozukluklarının büyük çoğunluğunda psikososyal etkenler merkezi bir rol oynar. Bu şu anlama gelir: bunların birincil nedeni nörobiyolojik bir işlev bozukluğu değil, bilişsel çarpıtmalar, hasarlanmış bağlanma şemaları, çözülmemiş yas süreçleri, otoagresif öz

değerlendirme örüntüleri ve temel inançlardaki çarpıtmalar gibi psikolojik süreçlerdir.

Güncel araştırmalar, depresif bozuklukların başlangıcında psikososyal etkenlerin 60–80 % oranında merkezi bir rol oynadığını göstermektedir. Kendler ve arkadaşlarının uzun süreli ikiz araştırmaları (Virginia İkiz Kayıt Sistemi (İng. Virginia Twin Registry), 1990–2010 yılları), Majör Depresif Bozukluk (İng. major depressive disorder) epizodlarının 60 %'ından fazlasının tanımlanabilir bir stresli yaşam olayıyla tetiklendiğini saptamıştır (Kendler ve ark., "Amerikan Psikiyatri Dergisi" (İng. American Journal of Psychiatry), 1999, 2003). Klasik post-Sovyet psikiyatri ekolünün önde gelen temsilcisi Prof. V. D. Vid (Sankt Peterburg, Bekhterev Enstitüsü), eserlerinde farklı bir görüş öne sürmektedir: somatik yakınmalarla başvuran hastaların 60–70 %'inde aslında somatik bir hastalık saptanmaz — bu hastaların temel sorunu psikojenik kökenlidir, ancak yanlış tanı sonucunda somatik tedavi almaktadırlar (Popov Yu. V., Vid V. D., "Güncel Klinik Psikiyatri", 2. baskı, 2006).

Bu görüşü tarihsel ve çağdaş bağlamda doğrulayan önemli bir olgu, eski SSCB coğrafyasında onlarca yıl boyunca kullanılan "vejetatif-damar distonisi" ve "nörosirkülatör distoni" tanılarının görüngüsüdür. Bu tanılar nöroloji ve kardiyoloji servislerinde yaygın olarak konulmaktaydı; oysa etiyolojik temelleri bilimsel açıdan doğrulanmamıştı. Aynı hastalar psikiyatrik ya da psikoterapötik değerlendirme sırasında somatik belirti bozukluğu (ICD-10: F45.0) ya da uyum bozukluğu (ICD-10: F43.2; ICD-11'de bedensel distres bozukluğu — 6C20) kategorilerine uyuyor, depresyon ya da panik bozukluk ölçütlerini karşılıyorlardı. Bu sistemli yanlış tanı görüngüsü, psikiyatrik sorunların somatik servislerde tanınmamasıyla bağlantılıdır — ve bu durum güncel klinik uygulamada da gözlenmektedir.

Aynı biçimde, kaygı bozukluklarının büyük çoğunluğu psikososyal etkenlerle — çocukluk dönemindeki bağlanma bozuklukları, ebeveynlik tarzı, psikotravmatik yaşantılar, karmaşık temel inançlar — doğrudan bağlantılıdır. Dünya Psikiyatri Birliği (İng. World Psychiatric Association, WPA) ve uluslararası psikoterapötik ekollerin önde gelen temsilcileri (O. Kernberg, G. Gabbard, A. Beck, V. Frankl), depresif epizodun farmakolojik yolla kesilmesinin onun psikolojik köklerini çözmediğini tutarlı biçimde vurgulamaktadır. Bu nedenle depresyon tedavisinde psikoterapötik müdahale ilk seçenek tedavidir — hafif ve orta şiddetteki olgularda yalnızca psikoterapi biçiminde, ağır olgularda ise farmakoterapiyle paralel olarak.

Bu olgu tedavi stratejileri açısından belirleyici sonuçlar doğurmaktadır. Psikojenik bozuklukta ilaç semptomatik bir etki gösterir, ancak kök sorunu çözmez. Antidepresan hastanın duygudurumunu yükseltebilir, ancak onu kendini suçlamaya yönelten bilişsel yapıya dokunmaz. Anksiyolitik kaygı nöbetini kesebilir, ancak

hastanın dünyayı tehditkâr olarak değerlendirmeye yönelen temel inancını değiştirmez. Hasta ilacı kestiğinde ya da yeni bir stres etkeniyle karşılaştığında — bozukluk çoğu zaman yeniden ortaya çıkar, hatta daha ağır bir biçimde kendini gösterir.

Psikojenik bozuklukların kök sorunu yalnızca psikoterapötik müdahale aracılığıyla çözülebilir. Bu, psikoterapinin ilaç tedavisinden üstün olduğu anlamına gelmez; bu, iki müdahalenin farklı amaçlara hizmet ettiği anlamına gelir:

Farmakoterapi — belirtileri yönetir, akut durumları stabilize eder, nörobiyolojik bileşene etki eder.

Psikoterapi — bozukluğun psikolojik köklerini çözer, bilişsel yapıyı yeniden kurar, davranış örüntülerini değiştirir, nüks riskini azaltır

Bu iki müdahale birbirini dışlamaz — birbirini tamamlar. Ancak modern sağlık sistemleri, özellikle düşük ve orta gelirli ülkelerde, neredeyse tamamen farmakoterapiye yönelmiştir. Psikoterapötik hizmetler — mevcut olduğunda bile — standartlaştırılmamış, kalite denetimi bulunmayan ve lisanslanmamış bir alanda yer almaktadır. Bu, hastayı iki riskli durumdan birine sürükler: ya yalnızca semptomatik ilaç tedavisi alır (kök sorun çözülmeksizin), ya da denetimsiz, niteliksiz psikolojik yardım alır (sorunun ağırlaşması riskiyle).

Sonuç

Bu bölümde sunulan sayılar ve eğilimler tek bir sonuca götürmektedir: dünyada hâlihazırda 1 milyardan fazla insanı kapsayan ruh sağlığı krizi son 30 yılda keskin bir artış göstermiş ve COVID-19 pandemisinden sonra yeni bir temel düzeyde kalmıştır. Bu yükün büyük çoğunluğu kaygı ve depresyon bozukluklarına düşmektedir — bu bozukluklarda psikososyal bileşen baskındır ve kök düzeyinde çözümü yalnızca psikoterapötik müdahale ile mümkündür.

Aynı zamanda, tedavi açığı en büyük olan bozukluklar tam da bunlardır: kaygı bozukluğu olan her 10 hastadan yalnızca 3'ü herhangi bir tedavi almakta, yalnızca 1'i ise uygun tedavi almaktadır. Bu açığı kapatmanın tek yolu — nitelikli, standartlaştırılmış, kanıta dayalı psikoterapötik hizmettir.

Bu bakış açısından hareketle, sonraki bölümde kanıta dayalı psikoterapötik stratejilerin — sınıflandırılmaları, klinik uygulama alanları, kanıt düzeyleri — sistematik analizi sunulmaktadır.

PSİKOPATOLOJİYE GİRİŞ

Bu bölümün amacı

Modern psikiyatrik sınıflandırmalar (Hastalıkların Uluslararası Sınıflandırması, 11. Revizyon (ICD-11); İng. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fifth Edition, Text Revision — DSM-5-TR) büyük ölçüde operasyonel tanı ölçütlerine dayanmaktadır: belirli sayıda ve sürede belirtinin bulunması tanı konulması için ön koşuldur. Bu yaklaşım tanısal güvenilirliği artırmakla birlikte, belirtilerin ve sendromların gerçek klinik anlamını gölgeleyebilmektedir.

Klasik psikiyatri — 19. yüzyılın sonu ve 20. yüzyılın başlarında Karl Jaspers, Eugen Bleuler, Karl Schneider, Kurt Schneider, Karl Leonhard — fenomenolojik ve sendromolojik yaklaşımla gelişmiştir. Bu yaklaşım bugün de klinik uygulamada büyük değer taşımaktadır:

Tanı ölçütleri belirtileri sayar; sendromoloji ise belirtilerin karşılıklı ilişkisini ve klinik görünümünü açıklar.

Sendromolojik düşünce erken tanı için önemlidir — özellikle ölçütleri henüz tam olarak karşılanmamış hastalarda

Bu belirtilerin neden birbiriyle ilişkili olduğunu ve hangi işlevsel sistemin bozulduğunu anlamak için patofizyolojik düşünce gereklidir.

Ayırıcı tanı, sendromolojik yaklaşım olmadan yüzeyseldir.

Bu bölümde psikopatolojik belirtiler temel işlevsel alanlara göre sınıflandırılmakta, ardından yaygın psikopatolojik sendromlar sunulmaktadır.

Belirti ve sendrom kavramları

Belirti — bozukluğun tek bir görünümüdür (örn. halüsinasyon, sanrı, depresif duygudurum).

Sendrom — birbiriyle ilişkili belirtilerin, belirli bir nozolojik birime özgü olan ya da birkaç nozolojide yinelenen tutarlı birleşimidir.

Nozolojik birim — etiyoloji, patogenez, klinik gidiş ve tedavi özelliklerine göre ayırt edilen hastalıktır (örn. şizofreni, bipolar bozukluk, Alzheimer hastalığı).

Klinik uygulamada hekim tipik olarak belirtilerden sendroma, sendromdan tanıya doğru ilerler. Doğru sendromolojik değerlendirme, hastanın muayene ve tedavisinin temelini oluşturur.

Psikopatolojik belirtilerin sınıflandırılması

Bilinç bozuklukları

Niceliksel bozukluklar (azalma):

Bilinç bulanıklığı (İng. obnubilation) — bilincin hafif düzeyde azalması, tepkilerin yavaşlaması

Somnolans — uykulu durum; kolayca uyandırılabilir

Sopor — yalnızca güçlü uyaranlarla kısa süreli uyanmanın görüldüğü bilinç bozukluğudur

Koma — bilincin tamamen kaybı; uyaranlara yanıt yoktur

Niteliksel bozukluklar (bilincin içeriğinin değişmesiyle seyreden):

Delirium — akut başlangıç, dalgalanan bilinç, yönelim bozukluğu, görsel halüsinasyonlar, psikomotor ajitasyon. Tipik nedenler: alkol yoksunluk sendromu, enfeksiyon, intoksikasyon, karaciğer ve böbrek yetmezliğidir.

Onirik (rüya benzeri) durum — fantastik sahneler; hasta kendini bunların katılımcısı gibi hisseder

Amentif durum — derin yönelim bozukluğu, dağınık düşünce, konuşma düzensizliği

Alacakaranlık bilinç durumu (İng. twilight state) — bilincin "tünel benzeri" daralması, otomatik davranış, sonrasında amnezi. Epilepside ve histerik durumlarda tipiktir.

Algı bozuklukları

İllüzyonlar — gerçek bir nesnenin yanlış algılanmasıdır (örn. duvardaki gölge insan olarak görülür).

Halüsinasyonlar — gerçek bir uyaran olmaksızın ortaya çıkan algıdır. Modaliteye göre:

İşitsel halüsinasyonlar — en yaygın halüsinasyon türüdür. "Sesler" yorumlayıcı, hitap edici ya da emredici nitelikte olabilir (İng. imperative — yüksek risk). Bu modalite şizofreni için tipiktir.

Görsel halüsinasyonlar — organik bozukluklarda (delirium, demans, intoksikasyon) görülür.

Koku ve tat halüsinasyonları — temporal lob epilepsisi ve şizofreni için karakteristiktir.

Dokunma halüsinasyonları — kokain, amfetamin intoksikasyonu ("deri altındaki böcekler").

Senestopatiler — bedende belirsiz, tuhaf, ağrılı duyumlar (“böcekler dolaşır”, “boğazda boşluk var” vb.).

Psödohalüsinasyonlar (Kandinski) — hasta tarafından “içsel” olarak algılanır (“sesler başımın içinde”), ancak yine de dış uyaran olmaksızın ortaya çıkar.

İşlevsel halüsinasyonlar — yalnızca gerçek bir uyaran varken ortaya çıkar (su şırıltısında ses duymak).

Düşünce bozuklukları

Biçim (tempo ve tutarlılık) bozuklukları:

Düşünce hızlanması (İng. mentation acceleration) — manik epizotta gözlenir

Düşünce “uçuşu” (İng. flight of ideas) — çağrışımlar hızla değişir, ancak bağlantı korunur

Düşünce yavaşlaması — depresyon ve demansta görülür

Düşünce bloklanması (Alm. Sperrung) — ani durma

Tangansiyel düşünce — yanıt sorudan saparak yan konuya geçer

Sirkumstansiyel düşünce — aşırı ayrıntı

Atomistik (İng. atactic) düşünce — gramatik yapı korunur, anlam bozulur (şizofreni)

Verbigerasyon — sözcüklerin ve ifadelerin anlamsız biçimde yinelenmesi

Neolojizmler — yeni “uydurma” sözcükler (şizofreni)

Perseverasyon — aynı sözcüğün ya da düşüncenin yinelenmesi (organik bozukluk)

İçerik bozuklukları:

Persekütif sanrı — takip edilme ve kötü niyet hissi

- Büyüklük sanrısı — kişinin kendini olduğundan çok daha güçlü, önemli ve zengin sayması

- Alınma sanrısı (İng. delusions of reference) — çevredeki olaylar kendisine atfedilir

- Etkilenme sanrısı — dış güçlerin (teknik, kozmik, mistik) kişinin düşünceleri üzerindeki etkisi

- Hipokondriyak sanrı – ağır hastalık duygusuna inanma (senestopatiler vb.)

- Cotard sendromu (canlı ceset sanrısı) – beden organlarının “yok olduğu”, “öldüğü” inancı

- Kıskançlık sanrısı — eşinin ihanetine inanma

- Sevgi (Clérambault) sanrısı – tanınmış kişinin gizli sevgisine inanma

Sanrı (İng. delusion) – yanlış, kanıtlara dayanmayan, kültürel bağlama uymayan inanç. Türleri:

Aşırı değer verilen (baskın) düşünceler (İng. overvalued ideas) – gerçeğe yakın, ancak orantısız önem yüklenen

Obsesyonlar – zihni saran, ego-distonik (kendine yabancı olarak algılanan) düşünceler

Duygudurum ve affekt bozuklukları

Depresif duygudurum – düşük, kederli, umutsuz

Manik duygudurum – yüksek, öforik veya disforik (irritabl)

Disfori – irritabl, huzursuz duygudurum

Anhedoni – haz alma yeteneğinin kaybı (temel depresif belirti)

Apati – duygusal eksiklik, ilgi kaybı

Affektif labilite — duyguların sık sık değişmesi

Affekt yassılaşması (İng. flat affect) – duygusal ifadenin zayıflaması (şizofrenide karakteristik negatif belirti)

Affekt uygunsuzluğu – duygusal yanıt duruma uygun değildir (örn. yakınının ölümünü gülüşle karşılar)

Aleksitimi – duygusal durumunu sözcüklerle ifade edememesi

Kaygı – yaklaşan tehlike hissi; çoğunlukla somatik ve vejetatif belirtiler eşlik eder

Korku — somut, gerçek tehlikeye karşı duygusal tepki

Panik – akut, nöbet biçiminde kaygı

Davranış ve hareket bozuklukları

Psikomotor ajitasyon – heyecanlı, amaçsız hareketler

Psikomotor yavaşlama – hareketlerin yavaşlaması, başlatma güçlüğü

Stupor — hareket yavaşlaması, mutizm ve çevreye tepkisizlik ile karakterize durum

Katalepsi — beden duruşunun pasif olarak sürdürülmesi

Balmumu esnekliği – uzvun yumuşak bir dirençle bükülmesi ve o konumda tutulması

Negativizm – isteklere karşıt hareket etme

Ekolali, ekopraksi – başkasının konuşmasının/hareketlerinin tekrarlanması

Stereotipiler – yineleyen, amaçsız hareketler

Manerizm – olağan hareketlerin tuhaf biçimde yerine getirilmesi

Tikler – istemsiz kasılmalar

Kompulsif davranış – obsesyonları azaltmak için yineleyen eylemler (ellerin yıkanması, kontrol edilmesi)

Bellek bozuklukları

Anterograd amnezi — olay sonrası yeni yaşantıların bellekte kalmaması

Retrograd amnezi – olay öncesi dönemin bellekte kalmaması

Kongrad amnezi – olayın kendisinin bellekte olmaması

Korsakoff sendromu – ağır anterograd amnezi, konfabulasyonlar ve dezoryantasyon. Nedenleri: tiamin eksikliği ve kronik alkolizmdir.

Konfabulasyonlar – bellek boşluklarını uydurmalarla doldurma

Hipermnezi – belleğin patolojik güçlenmesi (bazı epileptik durumlarda)

Hipomnezi – belleğin azalması (depresyon, demans başlangıcı)

Dikkat bozuklukları

Hipoproseksi – dikkatin azalması

Hiperproseksi – dikkatin patolojik olarak artması (mani)

Dikkatin kolay dağılması (DEHB, mani)

Dikkatin yapışkanlığı – bir konudan ayrılamama (organik bozukluklar)

Bilişsel (kognitif) bozukluklar

Hafif kognitif bozukluk – yaşa uygun normal sınırları aşan, ancak demansa ulaşmayan

Demans – bilişin yaygın ve kalıcı azalması (bellek, dil, yürütücü işlevler, görsel-uzamsal beceriler)

Agnozi – nesneleri tanıyamama (görsel, işitsel, dokunsal agnoziler)

Apraksi – önceden öğrenilmiş hareketleri yerine getirememe

Afazi – konuşmanın bozulması

Akalkuli – hesaplama yeteneğinin bozulması

İrade ve motivasyon bozuklukları

Apati – ilgisizlik, motivasyonsuzluk

Abuli – irade zayıflığı, karar verememe

Avolisyon (İng. avolition) — amaçlı davranış için motivasyonun yokluğu

Ambivalans – aynı anda iki çelişkili isteğin bulunması

Hipobuli – iradi etkinliğin azalması

Hiperbuli – patolojik olarak artmış iradi etkinlik

Kişilik ve "Ben" bozuklukları

Depersonalizasyon — kendine yabancılaşma, "ben değilim" hissi

Derealizasyon – çevrenin "uydurma", "gerçek olmayan" gibi algılanması

"Ben" sınırlarının bozulması — başkalarının düşünceleri ve duygularıyla karışması

Düşüncelerin çalınması/yerleştirilmesi – başkalarının "benim düşüncelerimi okuduğu" ya da "yabancı düşüncelerin kafama yerleştirildiği" hissi (şizofreninin birinci derece belirtisi, K. Schneider)

Temel psikopatolojik sendromlar

Affektif sendromlar

Depresif sendrom (depresif üçlü):

Düşük duygudurum

Psikomotor yavaşlama

Düşünce yavaşlaması (ideator yavaşlama)

Ek belirtiler: anhedoni, uyku bozukluğu, iştah değişikliği, suçluluk, umutsuzluk, intihara eğilimli düşünceler

Manik sendrom (manik üçlü):

Yüksek duygudurum

Psikomotor ajitasyon

Hızlı düşünce ("fikir uçuşu")

Ek belirtiler: uyku ihtiyacının azalması, grandiyöz düşünceler, dikkatin dağılması, riskli davranış

Karma affektif sendrom — manik ve depresif belirtilerin aynı anda bulunması (örn. yüksek aktivlik ve derin keder).

Kaygı sendromları

Yaygın anksiyete bozukluğu – sürekli kaygı, kas gerginliği, otonom belirtiler.

Panik sendromu – nöbet biçiminde akut kaygı, ölüm korkusu, otonom belirtiler (taşikardi, nefes darlığı, terleme), 10–30 dakika sürer.

Fobik sendrom – belirli bir nesneye/duruma karşı korku, kaçınma davranışı.

Obsesif-kompulsif sendrom

Obsesyonlar (takıntılı düşünceler) + bunları azaltmak için tekrarlanan davranışlar (kompulsiyonlar). Hasta bunların saçma olduğunu fark eder, ancak direnç gösteremez.

Psikotik sendromlar

Paranoid sendrom – sanrı (takip, ilişki, büyüklük) + kaygı. Halüsinasyonlar tipik değildir ya da minimaldir.

Paranoid sendrom – sanrı (takip daha tipik) + halüsinasyonlar (özellikle işitsel) + kaygı.

Parafrenik sendrom – grandiyöz fantastik sanrı + halüsinasyonlar + duygulanım yüksekliği.

Halüsinasyon sendromu (halüsinoz) – esas olarak halüsinasyonlar (işitsel ya da görsel), sanrı olmaksızın ya da minimal düzeyde.

Kandinski–Klerambo sendromu (psişik otomatizm sendromu):

Şizofreni için karakteristiktir.

İdeator otomatizm – "düşüncelerin çalınması", "düşüncelerin kafaya yerleştirilmesi"

Sensör otomatizm – psödohalüsinasyonlar

Motor otomatizm – "zorunlu hareketler"

Katatonik sendrom – stupor ya da ajitasyon, mum esnekliği, negativizm, mutizm, ekolali, ekopraksi. Tanı ve tedavisi hayati önem taşır (bkz. Bölüm 3).

Disforik sendrom – irritabl, öfkeli duygudurum, saldırganlık. Epilepsi, organik beyin hastalıkları ve yoksunluk döneminde gözlenir.

Eksojen-organik tip sendromlar (K. Bonhoeffer)

Beynin eksojen hasarlanmasına özgü sendromlar:

Deliryum sendromu — akut, dalgalanan bilinç düzeyi, dezoryantasyon, görme halüsinasyonları, psikomotor ajitasyon. Etiyolojisi: alkol yoksunluğu (İng. delirium tremens), enfeksiyonlar, intoksikasyonlar, karaciğer/böbrek yetmezliğidir.

Amenti sendromu – derin dezoryantasyon, karışık düşünce, dağınık duygulanım, fragmanter halüsinasyonlar. Ağır somatik hastalıklarda.

Alacakaranlık (İng. twilight) bilinç durumu – bilincin tünel biçiminde daralması, otomatik davranış, sonradan amnezi. Epilepsi ve histerik kökenli durumlarda gözlenir.

Korsakov sendromu – fiksasyon amnezisi + konfabülasyonlar + dezoryantasyon. Tiyamin eksikliği (Wernicke–Korsakov sendromu), kronik alkolizm.

Astenik sendrom – yorgunluk, irritabilite, bellek ve dikkat azalması, baş ağrısı, uyku bozukluğu. Yaygın olup hem organik hem psikojen kökenli olabilir.

Demans sendromları

Kortikal demans (Alzheimer tipi) – bellek, dil (afazi), praksis (apraksi), gnozis (agnozi) alanlarında bozukluklar.

Subkortikal demans (Parkinson, Huntington) – yavaşlama, yürütücü işlevlerde bozulma, depresyon; ancak kortikal işlevler erken evrede nispeten korunur.

Frontotemporal demans – kişilik değişikliği, disinhibisyon (inhibisyonun zayıflaması), toplumsal uyumsuzluk + dil bozuklukları (semantik ya da progresif akıcı olmayan afazi).

Lewy cisimcikleri demansı – dalgalanan bilişsel bozukluk, görme halüsinasyonları, parkinsonizm ve REM uyku davranış bozukluğu ile karakterizedir.

Kişilik değişikliği sendromları

Organik kişilik değişikliği (frontal lob hasarından sonra vb.) – disinhibisyon, toplumsal kuralların bozulması, duygusal labilite, plansızlık.

Postensefalitik sendromlar – ensefalit sonrası davranış, bellek, duygulanım bozuklukları.

Beyin sarsıntısı sonrası sendrom – kafa travmasından sonra: baş ağrısı, baş dönmesi, yorgunluk, irritabilite, konsantrasyon bozukluğu.

KLİNİK GÖRÜŞME VE RUHSAL DURUMUN DEĞERLENDİRİLMESİ

Klinik görüşmenin amaçları

Psikiyatrik klinik görüşme üç amaca hizmet eder:

Tanısal – bilgi toplamak, belirtileri saptamak, tanı koymak

Tedavi edici — terapötik ilişki (İng. rapport) kurmak, hastaya destek sağlamak, mekanizmaları (psikoterapötik) harekete geçirmek

Değerlendirici – risk değerlendirmesi (intihar, başkalarına zarar), işlevsel düzey, psikososyal ortam

İlk görüşme genellikle 45–90 dakika sürer. Acil durumlarda daha kısa olur; ancak temel noktalar (risk, karar) yine de ele alınmalıdır.

Klinik görüşmenin yapısı

Hazırlık

Belgeleri inceleme (sevk, önceki tıbbi kayıtlar)

Oda: sessiz, kapalı, güvenli (mümkünse acil çağrı düğmesi)

Süre: yeterli yedek süre ayrılmalıdır

Öneri: hastayı tek başına görüşün; gerekirse refakatçi (zorunlu yatış şüphesinde – (bkz. Bölüm “Hukuki-etik yönler”))

Açılış

Selam verin, kendinizi tanıtın, amacı açıklayın:

> “Merhaba, ben doktor [ad], psikiyatristim. Bu görüşün amacı durumunuzu anlamak ve size yardım etmenin yolunu birlikte belirlemektir. Görüşmemiz yaklaşık 45 dakika sürebilir.”

Gizlilik konusunda bilgi:

> “Konuşmamız gizlidir. …” Ancak size ya da bir başkasına ciddi tehlike söz konusu olduğunda bu bilgiyi ilgili kişilere aktarmak zorunda kalırım – bu hukuki bir gerekliliktir. Gerekirse bunu sizinle birlikte görüşeceğiz.

Açık uçlu soru:

> "Sizi rahatsız eden nedir? Buraya neden geldiğinizi bana anlatabilir misiniz?"

Yakınmalar ve mevcut hastalığın öyküsü

Yakınmalar – hastanın kendi sözleriyle (mümkün olduğunda alıntı)

Başlangıç – ne zaman, hangi koşullarda başladı?

Seyir – belirtilerin değişimi (hafifleme, ağırlaşma, dalgalı)

Tetikleyici etkenler – stresler, kayıplar, ilaçlar, maddeler

İşlevsel etki – işe, ilişkilere ve günlük etkinliklere etkisi

Önceki tedavi girişimleri – hangi ilaçları aldığı ve bunların ne ölçüde etkili olduğu

Psikiyatrik öykü

Önceki tanılar

Önceki yatışlar (zaman, kurum, süre)

Önceki ilaçlar (etkililik, yan etkiler)

Önceki psikoterapi

İntihar girişimleri öyküsü (ne zaman, hangi araç, niyetin ciddiyeti)

Tıbbi öykü

Kronik hastalıklar

Cerrahi müdahaleler

Kraniyoserebral travmalar (bilinç kaybı ile)

Epileptik nöbetler

Endokrin bozukluklar (özellikle tiroid bezi hastalıkları)

Halen kullanılan ilaçlar (psikotrop yan etkiler)

Alerjiler

Madde kullanım öyküsü

Alkol – sıklık, miktar, yoksunluk belirtileri

Tütün – sigara, günlük miktar, başlama yaşı

Reçeteli/reçetesiz ilaçlar (özellikle benzodiazepinler, opioidler)

Yasa dışı maddeler (kannabis, opioidler, stimülanlar, halüsinojenler)

Davranışsal bağımlılıklar (kumar, oyun, internet, alışveriş)

Aile öyküsü

Birinci ve ikinci derece akrabalarda ruhsal bozukluklar
İntiharlar
Madde kullanımı
Kronik hastalıklar (olası genetik bileşen)

Kişisel ve sosyal öykü

Doğum ve erken gelişim
Çocukluk ortamı, aile dinamikleri
Travmatik yaşantılar (istismar, şiddete maruz kalma, kayıp)
Eğitim
İş öyküsü
İlişki öyküsü, medeni durum, çocuklar
Sosyal destek sistemi
Adli öykü (ceza kovuşturması, mahkûmiyet)
Askerlik hizmeti (özellikle savaş deneyimi varsa)
Cinsel ve üreme öyküsü

Hastalık öncesi kişilik (İng. premorbid)

Hastalık öncesi karakter özellikleri
İlişki kurma biçimi
Strese tepki, davranış

Ruhsal durumun değerlendirilmesi

Ruhsal durum muayenesi (İng. Mental Status Examination, MSE) — psikiyatrinin temel klinik aracıdır. Görüşme sırasında görülen ve duyulanların sistematik kaydıdır.

Standart ruhsal durum yapısı

1. Görünüm ve davranış (İng. appearance and behaviour)

Yaşı, görünümü
Giyim, hijyen, bakım
Mimikler, jestler, davranış
Görüşmeye tutumu (işbirliği, direnç, saldırganlık)
Göz teması

Psikomotor aktivite

2. Konuşma (İng. speech)

Hız (hızlı, normal, yavaş)

Hacim (ses şiddeti)

Miktar (çok, az, mutizm)

Anlaşılırlığı, tutarlılığı

3. Duygudurum ve affekt (İng. mood and affect)

Duygudurum – hastanın bildirdiği sürekli duygusal durum ("kendinizi nasıl hissediyorsunuz?")

Affekt – görüşme sırasında gözlenen duygusal ifade

Affekt yelpazesi (geniş, daralmış, yassı)

Affektin duygudurum ve konuyla uyumu

4. Düşünce (İng. thought)

Biçim — tempo, tutarlılık, bloklanma, tangansiyalite, sirkumstansiyalite

İçerik – sanrı, obsesyonlar, fobiler, intihara eğilimli/homisidal düşünceler

5. Algı (İng. perception)

Halüsinasyonlar (modalite, içerik)

İllüzyonlar

Depersonalizasyon, derealizasyon

6. Biliş (İng. cognition)

Bilinç açıklığı

Yönelim (zaman, yer, kişi)

Dikkat, konsantrasyon

Bellek (anlık, kısa süreli, uzun süreli)

Soyut düşünce (atasözü yorumlama, benzerlik)

Yürütücü işlevler

Hesaplama

Genel bilgi düzeyi

7. İçgörü ve yargılama (İng. insight and judgement)

İçgörü (İng. insight) – hastanın hastalığını kavraması (var mı? yok mu? kısmi?)

Yargılama (İng. judgement) — karar verme yeteneği (örn. "yanan binadan nasıl çıkarsınız?")

8. Risk değerlendirmesi

İntihar riski aşağıda ayrıca değerlendirilir.

Heteroagresif risk — başkalarına zarar verme niyeti

Öz bakım düzeyi – tek başına yaşayabilme yeteneği

Ruhsal durum protokolü örneği

RUHSAL DURUM

Görünüm ve davranış: 32 yaşında bir erkek hasta, yaşına uygun görünümde, hijyeni yerinde.
Giyimi mevsime uygundur. Görüşmede işbirliği yapmaktadır, ancak başlangıçta kaygılı görünmektedir. Göz teması azalmıştır. Motor aktivite bir miktar artmıştır.

Konuşma: hızı bir miktar yüksektir, ses hacmi normaldir, miktarı artmıştır. Anlaşılırdır, ancak bazen konudan sapmaktadır.

Duygudurum: "Kendimi kaygılı hissediyorum … son iki haftadır uykuya dalamıyorum" (alıntı).

Affekt: yelpazesi daralmıştır, kaygı zemininde konuya uygundur. Bazen disforik bileşenler gözlenir.

Düşünce biçimi: Bazen tangansiyel, ancak ana içeriğe döner. Bloklanma yoktur.

Düşünce içeriği: İşi ve mali durumuna ilişkin sürekli kaygı. Sanrı yoktur. İntihara eğilimli düşünce yoktur. Heteroagresif düşünce saptanmamıştır.

Algı: Halüsinasyonlar inkâr edilmektedir. Depersonalizasyon, derealizasyon yoktur.

Biliş: Bilinç açıktır. Zaman, yer ve kişi yönelimi doğrudur. Dikkat ve konsantrasyonda orta düzeyde güçlük ("dünyayı tersten söyleme" görevinde 2 hata). Bellek klinik olarak sağlamdır. Soyut düşünce korunmuştur.

İçgörü: Var – belirtilerini hastalık olarak kabul etmektedir, tedavi için motivasyonu vardır.

Yargılama: Yerindedir.

Risk değerlendirmesi: İntihar riski düşüktür (intihara eğilimli düşünce yoktur, plan yoktur, önceki girişim yoktur, destek sistemi vardır). Heteroagresif risk yoktur. Öz bakım düzeyi tamdır.

İntihar riskinin değerlendirilmesi

Her psikiyatrik görüşmede mutlaka yapılmalıdır. Araştırmalar, "intihar hakkında sormak onu tahrik etmez" demektedir — aksine, sormamak ise bunu imkânsız kılar.

Açık ama aşamalı biçimde sormak

"Bu düşünceler ne sıklıkla geliyor?"

- "Nasıl yapacağınızı düşünüyor musunuz?" (plan)
- "Araçlar elinizde mi?" (araç erişilebilirliği)
- "Bunu daha önce denediniz mi?" (önceki girişimler)
- "Sizi şu anda durduran ne?" (koruyucu faktörler)

"Bazen kendinizi çok kötü hisseder misiniz? Hayatın anlamı olmadığını düşünür müsünüz?" (pasif intihar düşüncesi)

"Kendinize zarar vermeyi ya da öldürmeyi düşünüyor musunuz?" (aktif intihar düşüncesi)

Yanıt olumlu olduğunda:

İntihar riski faktörleri

Statik (değişmeyen):

Önceki intihar girişimi (en güçlü yordayıcı faktör — yaşam boyu intihar riskini yaklaşık 30–40 kat artırır (kaynak: NICE, kendine zarar verme riskinin değerlendirilmesi))

Ailede intihar öyküsü

Cinsiyet (erkek — tamamlanmış intihar, kadın — girişim)

Yaş (yaşlı erkekler en yüksek risk; ergenler ikinci yükseliş dönemi)

Adli öykü

Travmatik çocukluk

Dinamik (değişen):

Aktif intihar düşüncesi, plan, niyet

Araç erişilebilirliği (silah, zehir)

Yakın kayıp (eş, iş, sağlık)

İzolasyon

Umutsuzluk, Beck Umutsuzluk Ölçeği (İng. Beck Hopelessness Scale) ile ölçülebilir

Aktif psikiyatrik bozukluk (depresyon, psikoz, sınır kişilik bozukluğu (BKB), madde kullanımı)

Aktif intoksikasyon

Uyku bozukluğu (kronik)

Tecrit

Koruyucu faktörler:

Sosyal destek

Aile sorumlulukları (çocuklar)

Dini, manevi inanç

Tedaviyle bağlantı

Gelecek planları, umutlar

Risk düzeyleri ve klinik kararlar

Risk	Göstergeler	Karar
Düşük	Pasif düşünce; plan yok; araç yok; koruyucu faktörler fazla	Ayaktan izlem, güvenlik planı
Orta	Aktif düşünce, ancak plan ve niyet belirginleşmemiş	Sıkı ayaktan izlem (24–72 saatte yeniden görüşme), ailenin sürece katılması, araçların uzaklaştırılması, kriz numarası
Yüksek	Aktif düşünce + plan + niyet; araca erişim var; önceki girişim; aktif psikoz/derin depresyon	Hastaneye yatırma (gönüllü ya da gönüllü onam yoksa istemsiz yatış)

Risk	Göstergeler	Karar
Acil	Aktif hazırlık, açık niyet beyanı	Acil hastaneye yatırma, polisin sürece katılması mümkündür

C-SSRS ölçeği

Columbia İntihar Şiddeti Derecelendirme Ölçeği (C-SSRS) (İng. Columbia Suicide Severity Rating Scale) — kanıtlanmış, uluslararası düzeyde önerilen bir araçtır. Ölçek 6 sorudan oluşur ve yaklaşık 5 dakika sürer.

Güvenlik planı (İng. safety plan)

Düşük–orta risk düzeyinde hastayla birlikte hazırlanır:

Erken uyarı işaretleri (örn. uyumsuzluk, izolasyon, duygudurumun düşmesi)

İçsel baş etme stratejileri (İng. coping strategies) (örn. yürüyüş, müzik, fiziksel egzersiz)

Sosyal dikkat dağıtma (kiminle, nerede görüşülebilir)

Destek sağlayabilecek kişiler (kim, telefon numarası)

Klinik yardım numaraları (klinik, kriz hattı)

Ortamın güvenliğinin sağlanması (araçların uzaklaştırılması; örn. silah akrabaya verilir)

Heteroagresif (başkalarına zarar verme) riskinin değerlendirilmesi

Görüşmede sorulmalıdır:

> "Başkasına zarar vermeyi ya da öldürmeyi düşünüyor musunuz?"

Olumlu yanıt alındığında:

Belirli bir hedef var mı?

Plan var mı?

Araca erişim var mı?

Önceki agresif davranış?

Yüksek risk göstergeleri:

Belirli kurban + plan + araç

Aktif psikotik belirtiler (özellikle emir veren halüsinasyonlar, perseküsyon içerikli sanrı)

Antisosyal kişilik bozukluğu

Aktif intoksikasyon durumu

Önceki şiddet öyküsü

Yüksek risk durumunda hastaneye yatırma ve potansiyel kurbanın uyarılması (Tarasoff ilkesi — uluslararası standart).

HUKUKİ-ETİK YÖNLER

Azerbaycan psikiyatri mevzuatının temelleri

Azerbaycan Cumhuriyeti'nde psikiyatri yardımı aşağıdaki kanunlarla düzenlenir:

"Psikiyatri Yardımı Hakkında" Azerbaycan Cumhuriyeti'nin 12 Haziran 2001 tarihli Kanunu (sonraki değişikliklerle, son revizyon 2024 yılına aittir)

"Psikolojik Yardım Hakkında" Azerbaycan Cumhuriyeti Kanunu

"Nüfusun Sağlığının Korunması Hakkında" Azerbaycan Cumhuriyeti'nin 26 Haziran 1997 tarihli Kanunu

Azerbaycan Cumhuriyeti Anayasası (özellikle 28. madde — özgürlük hakkı)

Azerbaycan Cumhuriyeti Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu (istemsiz hastaneye yatırma prosedürü)

Azerbaycan Cumhuriyeti Ceza Kanunu ve Ceza Muhakemesi Kanunu (zorunlu tıbbi tedbirler)

Psikiyatri yardımının türleri

"Psikiyatri Yardımı Hakkında" Kanunun 5. maddesine göre psikiyatri yardımı üç türde sunulur:

Tür	Tanım	Hukuki dayanak
Gönüllü	Kişinin kendi iradesiyle başvurması	Madde 5.1, bilgilendirilmiş onam
İstemsiz	Ağır ruhsal bozukluğu bulunan ve suç işlememiş kişinin, iradesinden bağımsız olarak mahkeme kararına dayanılarak muayene ve tedavisi	Madde 11, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu (HUMK)
Zorunlu (tıbbi nitelikli zorunlu tedbirler)	Anlama yetisi yerinde olmayan bir durumda suç işlemiş kişilerin mahkeme kararına dayanılarak muayene ve tedavisi	Madde 12, Ceza Kanunu (CK), Ceza Muhakemesi Kanunu (CMK)

Gönüllü psikiyatri yardımı

Bilgilendirilmiş onam

Kanunun 1.0.6 maddesine göre bilgilendirilmiş rıza — hastanın ya da yasal temsilcisinin tedavi hakkında gönüllü karar verdiğini, tedavinin amaçları ve yararı, tedavi girişimlerinin kapsamı, süresi ve yöntemi, olası riskler ile tedaviden vazgeçme ve tedavinin durdurulması olanağı hakkında kendisine sunulan bilgileri anladığını bildirmesidir.

Bilgilendirilmiş rızanın gereklilikleri:

Yazılı biçimde (hastalık öyküsüne dahil edilir)

Eksiksiz bilgi verilmelidir (yararlar, riskler, alternatifler, vazgeçme hakkı)

Hasta durumu kavramalıdır (eşlik eden bilişsel bozukluk ve intoksikasyon durumunda güçleşir)

Gönüllülük – baskı olmaksızın

16 yaşından küçük hastalar için – yasal temsilcinin rızası

Hastanın hakları (Kanunun 23. maddesi)

Sağlık durumu ve tedavi hakkında bilgi almak

Yakın akrabaları ya da kendi seçtiği diğer kişilerle görüşme, telefonla iletişim

Para ve diğer maddi varlıkları serbestçe kullanmak

Yazışma hakkı

Dini ayinlerin serbestçe yerine getirilmesi

Şikâyette bulunmak (İnsan Hakları Komiseri (Ombudsman) dahil olmak üzere)

İstemsiz hastaneye yatırma

Yasal dayanaklar

Kanunun 11. maddesi (istemsiz hastaneye yatırma dayanakları):

> Ruhsal bozukluğun niteliği, muayene ve tedavinin yalnız …yalnız hastane koşullarında gerçekleştirilmesini gerektiriyorsa, istemsiz tedavi… aşağıdaki dayanakların varlığı halinde öngörülür:

>

> 11.1.1. Ruhsal bozukluğu olan kişinin doğrudan kendisi ve (veya) çevresindekiler için tehlikeli olması;

>

> 11.1.2. Kişinin kendi temel yaşamsal gereksinimlerini karşılayamaması (bakım düzeyinde).

Basit ifadeyle: "tehlike, çaresizlik ya da tedavi edilmediğinde durumun ağırlaşma riski" eklenmelidir: "11.1.3. ruhsal bozukluğu olan kişiye gerekli psikiyatrik yardım sağlanmadığında durumunun ağırlaşması".

İstemsiz hastaneye yatırma prosedürü

Aşama 1: İlk değerlendirme

Hekim-psikiyatr (acil psikiyatrik yardım ekibi, kabul bölümü) hastayı muayene eder ve istemsiz hastaneye yatırma dayanaklarını belirler.

Aşama 2: Hastaneye yerleştirme (acil)

Hastaneye yatırma fiilen gerçekleştirilir. 48 saat içinde hekim-psikiyatr komisyonu (en az üç hekimden oluşan) değerlendirme yapmalıdır.

Aşama 3: Komisyon kararı

Komisyon, istemsiz hastaneye yatırmanın sürdürülmesinin gerektiği kanaatine varırsa, 24 saat içinde mahkemeye başvurulur.

Aşama 4: Mahkeme kararı

Mahkeme, 5 gün içinde (Medeni Usul Kanunu'na göre) davayı inceler. Hasta (sağlık durumu elverişliyse), yasal temsilci, savcı ve hekim-psikiyatr katılır. Mahkeme, istemsiz hastaneye yatırmanın sürdürülmesi ya da durdurulması hakkında karar verir.

Aşama 5: Periyodik değerlendirme

İstemsiz hastaneye yatırma süresince hasta, ilk altı ay boyunca ayda en az bir kez hekim-psikiyatr komisyonu tarafından muayene edilmelidir (Madde 28.2).

Klinik endikasyonlar

Mutlak istemsiz hastaneye yatırma endikasyonları:

Aktif intihara eğilimli davranış (girişim ya da somut plan ve araç)

Aktif homisidal niyet (somut hedef + plan + araç)

Ağır psikotik dezorganizasyon (öz bakımı mümkün değil)

Emir verici halüsinasyonlar (zarar verme niyeti taşıyan)

Ağır mani (bakım düzeyinde kısıtlılık, zarar riskleri)

Göreceli endikasyonlar (klinik muhakeme):

- Psikotik belirtilerle birlikte ağır depresyon
- Ağır somatik durumda anoreksiya nervoza (vücut kitle indeksi (VKİ) < 15)
- Karma affektif epizot
- Psikoz zemininde saldırgan davranış

Zorunlu tıbbi önlemler

Kanunun 12. maddesi zorunlu tıbbi önlemleri düzenler:

- Uygulama dayanağı: ayırt etme gücünden yoksun halde suç işlemiş ya da suç işledikten sonra ruhsal bozukluğa yakalanmış kişiler
- Yalnızca mahkeme kararına dayanılarak
- Ceza Kanunu'nun 21. ve 93–99. maddeleri ile Ceza Usul Kanunu'nun (CUK) 468 –487. maddeleri uyarınca belirlenir
- İhtisaslaşmış psikiyatri hastanelerinde gerçekleştirilir

Türleri (CUK'a göre):

- Genel tipteki psikiyatri hastanelerinde zorunlu tedavi
- İhtisaslaşmış psikiyatri hastanelerinde zorunlu tedavi
- İhtisaslaşmış psikiyatri hastanelerinde yoğun gözetim altında zorunlu tedavi

Klinik psikologun hukuki durumu

"Psikolojik Yardım Hakkında" Azerbaycan Cumhuriyeti Kanunu'na göre klinik psikologun faaliyet alanı ve yetkilerinin sınırları:

Psikologun faaliyet alanı

- Psikolojik yardım sunma hakkı — psikolojik danışmanlık, psikodiyagnostik, psikokoreksiyon, psikoterapötik müdahaleler (uygun uzmanlığa sahip olduğunda)
- "Psikolog", "psikolojik", "psikoanaliz", "psikodiyagnostik", "psikoterapi" sözcüklerini yalnız Kanunun koşullarına uygun olarak psikolojik yardım sunma hakkı olan kişiler kullanabilir (3.2. madde).

Psikologun sınırları

Psikologun yetkisi dışında:

- Psikiyatrik tanı koymak (yalnız hekim-psikiyatr)
- İlaç reçete etmek (yalnız hekim)

İstemsiz hastaneye yatırma kararı vermek

Tıbbi görüşler (adli psikiyatrik ekspertiz vb.) vermek (yalnız hekim-psikiyatr)

İntihar (suisid) riski olan hastayla klinik psikologun çalışması – adımlar

Hasta intihara eğilimli düşünce beyan ettiğinde, klinik psikolog aşağıdaki adımları atmalıdır:

Risk değerlendirmesi – Columbia İntihar Şiddeti Ölçeği (C-SSRS) (İng. Columbia Suicide Severity Rating Scale) veya klinik görüşme (yukarıdaki bölüme bakınız)

Düşük–orta risk: güvenlik planı düzenlenir, yakın izlem yapılır ve hasta hekim-psikiyatra yönlendirilir

Yüksek risk – hasta yalnız bırakılmaz, derhal hekim-psikiyatra veya acil psikiyatrik hizmete başvuru (Bakü Ruh Sağlığı Merkezine başvuru (acil telefon: _____); acil tıbbi yardım – 103, polis – 102)

Belgeleme – değerlendirme, karar ve atılan adımlar yazılı olarak kaydedilmelidir

Gizlilik konusu – yaşam tehdidi olduğunda gizlilik sınırlandırılır (Kanunun genel ilkeleri)

Belge örneği: Psikolog tarafından hekim-psikiyatra yönlendirme mektubu

[Klinik antetli kâğıt]
Tarih: _____

Sayın hekim-psikiyatr,

Klinik psikolojik takibimde olan hasta [ad, soyad, baba adı], doğum tarihi _____, [tarih] tarihinde bana başvurmuş ve görüşme sırasında aktif intihar eğilimli düşünce beyan etmiştir.

Klinik görünüm:
- intihar eğilimli düşünce: [aktif/pasif, plan var/yok, araç ulaşılabilir/ulaşılamaz]
- Duygudurum: [betimleme]
- öyküde intihar girişimi: [var/yok, ayrıntıları]
- Psikiyatrik öykü: [önceki tanılar, ilaçlar]

Yukarıda belirtilen bulgulara dayanarak hastanın acil psikiyatrik değerlendirmesine ihtiyaç bulunduğunu bildiririm;

söz konusu incelemenin gerekli olduğu sonucuna varırım.

Sizden hastanın muayenesini ve uygun kararın verilmesini rica ediyorum.

Saygılarımla,
[Psikoloğun adı, soyadı]
[Uzmanlık, sertifika numarası]
[İmza, mühür]
[İletişim numarası]

Reşit olmayan hasta

15 yaşından küçük hastalarla çalışırken:

- Psikolojik yardımdan yararlanabilmek için yasal temsilcinin rızası gereklidir
- Ancak çocuk istismarı veya intihar eğilimli davranış saptandığında – kanunla öngörülen durumlarda bildirim yapılmalıdır (Çocuk Hakları Hakkında Kanun, ebeveyn veya ilgili kurumlar)
- Çocuk psikoterapisinde gizliliğin özel kuralları – önceden kararlaştırılır

Gizlilik ve sınırları

Genel ilke

Hasta ile hekim arasındaki ilişkide elde edilen bilgiler gizlidir. Bu, "Halkın Sağlığının Korunması Hakkında" Kanunda ve "Psikiyatri Yardımı Hakkında" Kanunda düzenlenmiştir.

Gizliliğin ihlaline izin verilen durumlar

- Hastanın yazılı rızasıyla
- Kolluk makamlarının yazılı talebi (ceza soruşturması kapsamında)
- Mahkeme kararı
- Hastanın veya başkalarının yaşamı ve sağlığı tehlikeye girdiğinde (Tarasoff ilkesi – uyarma ve koruma yükümlülüğü)
- Reşit olmayan hastalarla ilgili bilgiler ebeveynlere verilir (kanun çerçevesinde)
- Meslektaş konsültasyonu (multidisipliner ekip içinde)

Tarasoff ilkesi (uyarı ve koruma görevi)

Uluslararası standart: hasta belirli bir kişiye zarar verme niyetini beyan ederse, hekimin bu kişiyi uyarma görevi vardır. Azerbaycan mevzuatında bu doğrudan düzenlenmemiş olsa da, genel ilkeler (yaşam hakkı, toplum güvenliği) bunu öngörür.

Reşit olmayan hastalar

Yaş sınırları

15 yaşından küçük hastalara psikiyatri yardımı, ebeveynin (yasal temsilcinin) rızasıyla sağlanır ("Psikiyatri Yardımı Hakkında" Kanunun 4. maddesine göre)

15 yaşın üzerindekiler: kendi rızasıyla (ancak ebeveynin bilgilendirilmesi genel olarak önerilir)

18 yaşın üzerindeki hastalar psikiyatri yardımına ilişkin kararları bağımsız olarak alır

Çocuk koruma protokolleri

Çocuk istismarı (cinsel, fiziksel, psikolojik), ihmal veya başkasına yüklenen yapay bozukluk (İng. factitious disorder imposed on another, FDIA) şüphesinde hekimin bildirme görevi vardır. Başvurulacak kurumlar:

Sosyal Hizmetler Ajansı

Çocuk Hakları Kamu Denetçisi (ombudsman)

Polis (tehlikeli durumlarda)

Saldırgan hasta ve güvenlik önlemleri

Hukuki çerçeve

"Psikiyatri Yardımı Hakkında" Kanunun 37.4'üncü maddesi özel önlemlerin kullanımını düzenlemektedir:

> Psikiyatri yardımı sunan hekim-psikiyatrların, diğer uzmanların, orta ve alt düzey sağlık çalışanlarının güvenliğinin sağlanması amacıyla onlara özel önlemleri (ruhsal bozukluğu olan kişinin fiziksel olarak kısıtlanması, geçici olarak izole edilmesi, özel fiksasyon giysisinin uygulanması) kullanma hakkı verilir.

Uygulama kuralları:

Yalnızca gerçek bir tehdit olduğunda

En az kısıtlayıcı araç seçilmelidir

Süreyle sınırlı

Tıbbi belgelerde kayıt tutulmalıdır

Kurum yönetimine bilgi verilmelidir

De-eskalasyon ilkeleri

Fiziksel kısıtlamadan önce:

Sakin, dostane bir yaklaşım

Hastanın huzursuzluğunu dinlemek

Seçenek sunma (örneğin: "Sakinleşmek için ayrı bir odada oturmak veya ilaç almak ister misiniz?")

Sözel de-eskalasyon

Yalnızca bu yöntemler başarısız olduğunda farmakolojik veya fiziksel kısıtlamaya geçilir

Farmakolojik kısıtlama (acil sedasyon, AS)

İlk seçenek – hastanın rızasıyla oral ilaçlar:

Lorazepam 1–2 mg, ağızdan

Olanzapin 5–10 mg ağızdan; ağızda dağılan tablet (İng. orally disintegrating tablet, ODT) formu etkilidir

Risperidon 1–2 mg, ağız yoluyla (Lat. per os)

Rıza veya işbirliği olmadığında – kas içi (İng. intramuscular, i.m.):

Olanzapin i.m. 10 mg + (gerekirse) lorazepam 2 mg i.m.

Haloperidol 5 mg i.m. + lorazepam 2 mg i.m. (klasik kombinasyon)

Aripiprazol i.m. 9,75 mg

Dikkat: Olanzapin i.m. + parenteral benzodiazepin – kombinasyon solunum depresyonuna neden olabilir. Olanzapin i.m., parenteral benzodiazepinlerle aynı anda kullanılmamalıdır; gerekli olduğunda aralarında en az 1 saat ara bırakılır ve hasta solunum depresyonu açısından izlenir.

Belge örnekleri

İstemsiz hastaneye yatırmaya yönlendirme protokolü

İSTEMSİZ HASTANEYE YATIRMAYA YÖNLENDİRME

Tarih: _____ Saat: _____

Hasta bilgileri:
- Ad, soyad, baba adı: _____
- Doğum tarihi: _____
- Adres: _____
- Kimlik kartı/ID: _____

Görüşme koşulları:
- Yer: _____
- Başvuru/yönlendirme kaynağı: _____
- Yasal temsilci katıldı mı? Evet/Hayır; ad: _____

Klinik tablo:
[Yakınmalar, öykü, ruhsal durum tanımı]

Tanı (ICD-11): _____

İstemsiz hastaneye yatırmanın dayanağı, "Psikiyatri Yardımı Hakkında" Kanun'un 11. maddesi:
☐ 11.1.1 Hasta kendisi ya da başkaları için tehlikelidir
Kanun'un 11. maddesindeki tüm dayanaklar (11.1.1'den sonraki bentler dahil) resmî metne uygun olarak eksiksiz verilmelidir

Somut göstergeler:
[İntihar riski, homisidal düşünce, bakım düzeyi vb.]

Karar: Hasta, istemsiz biçimde [kurum adı] psikiyatri hastanesine yatırılır.

Sonraki adımlar:
- 48 saat içinde hekim-psikiyatr komisyonu muayenesi
- Komisyon kararından sonra 24 saat içinde mahkemeye başvurulur

Hekim-psikiyatr: _____
Sertifika numarası: _____
İmza: _____
Mühür: _____

İntihar riskine yönelik güvenlik planı (hasta ile birlikte)

GÜVENLİK PLANI

Hasta: _____ Tarih: _____

1. Erken uyarı belirtileri (benim için önemli sinyaller):
   - _____
   - _____
   - _____

2. İçsel baş etme stratejilerim (İng. coping strategies) (yalnızca kendi gücümle yapabildiklerim):
   - _____
   - _____
   - _____

3. Beni oyalayacak kişiler ve yerler:
   - _____
   - _____

4. Yardım isteyebileceğim kişiler (ad, telefon):
   - _____
   - _____

5. Klinik yardım (24 saat):
   - Kliniğim: _____ (telefon: _____)
   - Bakü Ruh Sağlığı Merkezi (acil): _____
   - Acil yardım (Azerbaycan): 103
   - Polis: 102

6. Ev ortamımın güvenli hale getirilmesi:
   - Risk oluşturan araçlar: _____
   - Onları uzaklaştırma planı: _____

İmzalar:

Hasta: _____

Hekim-psikiyatr: _____

Etik ilkeler

Uluslararası ilkeler (Uluslararası Tıp Etiği Bildirgesi, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Helsinki Bildirgesi)

Özerklik – hastanın karar verme hakkı

Yararlılık (İng. beneficence) – hastanın yararına hareket etmek

Zarar vermeme (İng. non-maleficence; Lat. primum non nocere – her şeyden önce zarar vermemek)

Adalet (İng. justice) – tüm hastalara eşit davranış

Klinik ikilemler

Özerklik ile yararlılık ilkesi arasındaki çelişki:

Hasta tedaviyi reddediyor, ancak karar verme yetisi kuşkulu

Çözüm: Karar verme yetisi formal olarak değerlendirilir; yeti yoksa yasal temsilci sürece dahil edilir; yeti varsa hastanın reddi saygıyla karşılanır (tehlikeli olmadığında)

Gizlilik – toplumsal güvenlik:

Yukarıda belirtildiği gibi – yaşama yönelik tehlike olduğunda gizlilik sınırlanır

Çoklu rol ilişkileri (İng. multiple roles):

Hasta + çalışan + arkadaş rolleri karışmamalıdır

Katı çerçeve – yalnızca profesyonel ilişki

Hediyeler ve maddi ilişkiler:

Hastadan önemli hediye kabul etmemek

Maddi/ticari ilişkilerden kaçınmak

PSİKOTERAPİNİN KLİNİK STRATEJİLERİ

Klinik psikoterapi kavramı

XX. yüzyılın ortalarına kadar psikoterapötik faaliyet esas olarak ekol gelenekleri çerçevesinde kuruluyordu. Psikanalist kendini psikanalist, davranış terapisti kendini davranışçı, gestalt terapisti kendini gestalt terapisti sayıyordu ve her biri kendi hastalarını kendi ekolünün yöntemiyle tedavi ediyordu — hastanın tanısından bağımsız olarak. Bu yaklaşımda terapistin yöntemi hastanın bozukluğundan daha önemli sayılıyordu: araç esas, sorun ise ikincil sayılıyordu.

XX. yüzyılın sonundan XXI. yüzyılın başlarına kadar klinik düşüncede esaslı bir değişiklik meydana geldi. Kanıta dayalı tıbbın (İng. evidence-based medicine) ilkeleri psikoterapötik alana da uygulanmaya başladı ve yeni bir paradigma oluştu. Bu paradigmanın temeli klinik psikoterapi kavramıdır: terapistin temel ekolü ne olursa olsun, belirli bozukluk için kanıta dayalı, en etkili stratejiyi uygulama sorumluluğunu taşır.

Bu ilkeyi basit bir örnekle açıklamak mümkündür. Diyelim ki terapist psikanalitik eğitim almıştır ve 5 yıl bireysel analizden geçmiştir. Karşısına gece enürezisinden yakınan 7 yaşında bir çocuk getirilir. Klasik psikanalitik yaklaşım, çocuğun belirtisini Oidipus kompleksinin, ebeveyn ilişkilerinin ya da çocukluk travmasının bir ifadesi olarak açıklamaya çalışabilir. Bu açıklamanın gerçeklik derecesinden bağımsız olarak, klinik sonuç bakımından bu yaklaşım etkisizdir: gece enürezisi, kanıta dayalı bir davranış müdahalesi olan alarm terapisiyle vakaların 70 %'inden fazlasında başarıyla tedavi edilir. Psikanalitik yorumda bulunmak çocuğun belirtisini ortadan kaldırmaz, tedavi süresini uzatır ve ebeveyn kaynaklarının verimsiz kullanımına yol açar.

Klinik psikoterapi bu konuda nettir: enürezis, terapistin "ekolü" ne olursa olsun, davranış protokolüyle tedavi edilir. Aynı şekilde panik bozukluk bilişsel davranışçı terapiyle, sınır kişilik bozukluğu diyalektik davranış terapisi ya da şema terapiyle, basit fobiler maruz bırakma (ekspozisyon) terapisiyle, travma sonrası stres bozukluğu (TSSB) ise göz hareketleriyle duyarsızlaştırma ve yeniden işleme (EMDR) ya da travma odaklı bilişsel davranışçı terapi (BDT) ile tedavi edilir. Bu seçim, terapistin kişisel tercihine değil, belirli bozukluk üzerine toplanmış bilimsel kanıtlara dayanır.

Bu yaklaşımın iki pratik önemi vardır. Birincisi, hastanın çıkarları ekol aidiyetinin üstünde tutulur: hasta, terapistin kişisel mesleki geçmişini değil, kendi bozukluğunun

en iyi tedavisini alma hakkına sahiptir. İkincisi, uzmanın mesleki davranışında transdiyagnostik yetkinlik gereksinimi ortaya çıkar: terapist yalnızca tek bir ekolün yöntemiyle değil, farklı kanıta dayalı protokollerle çalışabilmelidir.

Psikoterapötik ekoller ve mekanizmaları

Modern klinik psikoterapide onlarca ekol ve yöntem bulunmaktadır. Aşağıda klinik pratik bakımından en önemli olanların kısa bir betimlemesi verilmiştir.

Bilişsel davranışçı terapi (İng. Cognitive Behavioral Therapy, CBT). Aaron Beck (depresyon, 1960'lı yıllar) ve Albert Ellis (Rasyonel Duygusal Davranış Terapisi — REBT) tarafından geliştirilen bu yaklaşım bilişsel düzeyde çalışır. Temel varsayım: olayın kendisi değil, olayın değerlendirilmesi duygusal tepkiyi belirler. Terapide hasta, kendi otomatik düşüncelerini ve bilişsel çarpıtmalarını (felaketleştirme, siyah-beyaz düşünce, kişiselleştirme, sonuca atlama vb.) tanımayı, sınamayı ve daha işlevsel alternatiflerle değiştirmeyi öğrenir. Davranışsal bileşen — maruz bırakma, davranışsal aktivasyon, alışkanlık alıştırmaları — bilişsel değişiklikleri pekiştirir. En geniş kanıt birikimine sahip psikoterapötik yöntemdir.

Diyalektik davranış terapisi (İng. Dialectical Behavior Therapy, DBT). Marsha Linehan tarafından 1980'li yıllarda kronik intihara eğilimli ve sınır kişilik bozukluğu olan hastalar için geliştirilmiştir. BDT'nin bir devamıdır, ancak duygusal düzensizlik, sıkıntıya dayanma eksikliği ve dürtüsellik sorunları olan hastalar için özel modüller ekler: bilinçli farkındalık (İng. mindfulness), krizlere dayanma, duyguların düzenlenmesi, kişilerarası ilişkilerde etkililik. Standart DBT haftalık bireysel seans, grup beceri öğretimi seansları, telefonla danışmanlık (İng. phone coaching) ve terapist ekip konsültasyonlarından oluşur.

Şema Terapi (İng. Schema Therapy). Jeffrey Young tarafından 1990'lı yıllarda geliştirilen bu yaklaşım BDT, gestalt, bağlanma kuramı (İng. attachment theory) ve psikodinamik unsurları birleştirir. Kişilik bozuklukları ile kronik ve tedaviye direnç gösteren depresyon/kaygı durumları için özellikle etkilidir. Erken dönem uyumsuz şemalarını (örneğin, “terk edilme”, “güvensizlik”, “kusurluluk”) ve onlarla ilişkili “modları” (çocuk modu, katı ebeveyn modu, sağlıklı yetişkin modu) belirler ve yeniden yazar.

EMDR (İng. Eye Movement Desensitization and Reprocessing). Francine Shapiro tarafından 1987 yılında geliştirilmiştir. Travmatik anıların iki taraflı uyarım (İng. bilateral stimulation — göz hareketleri ya da alternatif olarak dokunsal/işitsel uyarım) aracılığıyla yeniden işlenmesi için yapılandırılmış 8 aşamalı bir protokoldür. TSSB için Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından birinci basamak müdahale olarak

önerilmektedir. Karmaşık travma, akut stres reaksiyonu ve fobilerde, ayrıca depresyon ve kaygının travmatik bileşeni olan durumlarda etkilidir.

Kişilerarası terapi (İng. Interpersonal Therapy, IPT). Gerald Klerman ve Myrna Weissman tarafından 1970'li yıllarda depresyon için geliştirilmiştir. Hastanın belirtilerini dört kişilerarası alandan biriyle ilişkilendirir: yas, rol çatışmaları, rol geçişleri, kişilerarası yetersizlikler. Yapılandırılmış ve kısa süreli bir terapidir (12–16 seans); depresyonda BDT ile eşdeğer etkinlik gösterir.

Kabul ve Kararlılık Terapisi (İng. Acceptance and Commitment Therapy, ACT). Bu terapi, Steven Hayes tarafından 1980'li yıllarda geliştirilen "üçüncü dalga" BDT yaklaşımıdır. Düşüncelerin içeriğini değiştirmeye değil, onlarla kurulan ilişkiyi değiştirmeye yönelir. Psikolojik esnekliği (İng. psychological flexibility) geliştirir: değerler doğrultusunda yaşam sürme, acı veren duygulara karşı açıklık, düşüncelerden ayrışma (İng. cognitive defusion). Kronik ağrı, depresyon, kaygı, bağımlılık bozuklukları ve varoluşsal krizlerde etkilidir.

Bilinçli farkındalık temelli bilişsel terapi (İng. Mindfulness-Based Cognitive Therapy, MBCT). Zindel Segal, Mark Williams ve John Teasdale tarafından tekrarlayan depresyonun önlenmesi için geliştirilmiştir. BDT'yi Jon Kabat-Zinn'in stresin bilinçli farkındalık temelli azaltılması (İng. Mindfulness-Based Stress Reduction, MBSR) programıyla birleştirir. Majör Depresif Bozukluk tanısı olan ve en az iki yineleme epizodu geçirmiş hastalar için ilaç tedavisine eşdeğer ya da daha etkili koruyucu sonuç verir.

Psikodinamik psikoterapi klasik psikanalizden doğan, ancak modern klinik koşullara uyarlanmış bir yöntemdir. Kullanılan farklı modeller vardır: Zihinselleştirme temelli terapi (İng. Mentalization-Based Therapy, MBT), Aktarım temelli psikoterapi (TFP — Kernberg), Kısa süreli psikodinamik terapi (STPP). Temel mekanizma — hastanın bilinçdışı süreçlerini, savunma mekanizmalarını, ilişki kalıplarını ve erken çocukluk deneyimlerinin bugünkü davranışa etkisini incelemek ve yeniden yazmaktır. Kişilik bozuklukları, kronik depresyon ve ilişki sorunlarında etkilidir.

Kanıt düzeyleri

Psikoterapötik yöntemlerin etkinliği sistematik araştırmalar (randomize kontrollü çalışmalar (İng. randomized controlled trials, RCT), meta-analizler, sistematik derlemeler) temelinde değerlendirilir. Uluslararası klinik kılavuzlar (NICE — Birleşik Krallık; APA — Amerikan Psikiyatri Birliği (İng. American Psychiatric Association); Dünya Biyolojik Psikiyatri Dernekleri Federasyonu (WFSBP; İng.

World Federation of Societies of Biological Psychiatry); Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ)) bu kanıtları sentezler ve kanıt düzeylerini belirler:

A düzeyi (yüksek kanıt) — birbirinden bağımsız çok sayıda yüksek kaliteli RCT'lerde ve meta-analizlerde doğrulanmış etkinlik. Yöntem, belirli bir bozuklukta ilk basamak müdahale olarak kabul edilir.

B düzeyi (orta kanıt) — birkaç RCT'de doğrulanmış etkinlik; ancak meta-analiz birikimi sınırlıdır veya sonuçlar arasında belirli tutarsızlıklar vardır. Yöntem, ikinci basamak ya da alternatif ilk basamak müdahale olarak önerilir.

C düzeyi (sınırlı kanıt) — yalnızca tek tek araştırmalarda veya klinik olgu sunumlarında etkinlik göstermiş yöntemler. İlk basamak yöntemler etki göstermediğinde ya da erişilebilir olmadığında kullanılabilir.

Bozukluğa göre tedavi stratejilerinin haritası

Aşağıdaki tablo, temel ruhsal bozukluklara ilişkin uluslararası kılavuzlarda önerilen psikoterapötik müdahaleleri kanıt düzeyleriyle birlikte sunmaktadır.

Tablo 4. Psikoterapötik stratejiler — bozukluğa göre harita

Bozukluk	İlk basamak (A)	İkinci basamak (B)	Alternatif (C)	
Majör depresif bozukluk (ICD-11'e göre depresif epizod)	BDT, IPT	Şema terapi, ACT, Psikodinamik	MBCT (nüks profilaksisi)	
Yaygın anksiyete bozukluğu (YAB)	BDT	ACT, MBCT	Psikodinamik	
Panik bozukluğu	BDT (panik odaklı)	Maruz bırakma terapiyası (İng. exposure therapy)	EMDR (travma bileşeni varsa)	

Bozukluk	**İlk basamak (A)**	**İkinci basamak (B)**	**Alternatif (C)**	
Sosyal anksiyete bozukluğu	BDT, grup BDT	ACT	Psikodinamik	
OKB	Obsesif-kompulsif bozukluk (OKB)	Maruz bırakma ve tepki önleme terapiyası (İng. exposure and response prevention, ERP)	BDT	EMDR, OKB'de uluslararası kılavuzlarda önerilmemektedir; bu seçeneğin çıkarılıp yerine kılavuzlarda belirtilen alternatif müdahalenin yazılması gerekir
TSSB	EMDR, travma odaklı BDT (İng. Trauma-Focused CBT, TF-BDT)	Yazılı maruz bırakma terapiyası	Psikodinamik	
Sınır kişilik bozukluğu	DBT, MBT, TFP, Şema terapi	BDT	Psikodinamik	

Bozukluk	İlk basamak (A)	İkinci basamak (B)	Alternatif (C)	
Bipolar bozukluk (psikoterapötik bileşen)	Kişilerarası ve sosyal ritim terapiyası (İng. interpersonal and social rhythm therapy, IPSRT), BDT, aile odaklı terapi	Psikolojik bilgilendirme	Bilinçli farkındalık	
Yeme bozuklukları (anoreksiya nervoza, bulimiya nervoza)	Güçlendirilmiş BDT (İng. enhanced CBT, BDT-E), aile temelli terapi (FBT — ergenler için)	DBT, IPT	Şema terapi	
Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu (DEHB; İng. ADHD) – ergen ve erişkin hastalar	Psikoeğitim + BDT	Davranış terapisi	Bilinçli farkındalık	
Çocuk enürezisi	Alarm terapi (davranış protokolü)	Motivasyon şeması	Psikodinamik konsültasyon (yalnızca yardımcı destek olarak)	
Kişilik bozuklukları (genel)	Şema terapi, MBT, TFP	DBT	BDT	

Bozukluk	İlk basamak (A)	İkinci basamak (B)	Alternatif (C)	
Bağımlılık bozuklukları	Motivasyonel görüşme + BDT	Nüks profilaksisi, DBT	12 adımlı programlar	
Kronik ağrı	BDT, ACT	Bilinçli farkındalık	Psikodinamik	

Kaynak: NICE klinik kılavuzları (İng. NICE Clinical Guidelines, 2022, 2024); APA klinik kılavuzları (İng. APA Clinical Practice Guidelines, 2019, 2024); DSÖ mhGAP müdahale kılavuzu (İng. mhGAP Intervention Guide 2.0, 2016; mhGAP guideline, 2023); WFSBP tedavi kılavuzları (İng. WFSBP Treatment Guidelines).

Farmakoterapi ve psikoterapi: rakip değil, tamamlayıcı

Psikiyatri pratiğinde sıklıkla ortaya çıkan soru: ilaç tedavisi mi, psikoterapi mi? Bu sorunun kendisi yanlıştır, çünkü bunlar birbirini dışlamaz.

Doğru soru üç boyutta biçimlendirilir:

1. Bozukluğun doğası. Ağır, nörobiyolojik bileşeni olan bozukluklarda (şizofreni, ağır bipolar bozukluk, melankolik depresyon, ağır OKB) farmakoterapi temeldir, psikoterapi tamamlayıcıdır. Psikojen, hafif-orta şiddetli, reaktif bozukluklarda (uyum bozukluğu, yaygın anksiyete bozukluğu, sosyal anksiyete bozukluğu, basit fobiler) temel müdahale psikoterapidir; ilaç gerekirse kısa süreli yardımcı araç olarak kullanılır.

2. Hastanın durumu. Akut intihar (suisid) riski, ciddi işlevsel bozulma, besin alımını reddetme, psikotik unsurlar varsa — farmakoterapi akut dönemde üstündür. Stabilizasyondan sonra psikoterapi temel rolü üstlenir.

3. Tedavi evresi. Akut evre belirtileri stabilize etmeye yönelir; bu evrede farmakoterapi hızlı sonuç verir. Stabilizasyondan sonra kök soruna yönelme evresi gelir; bu evrede psikoterapi belirleyici rol oynar. Profilaksi (önleme) evresinde psikoterapi nüksü önler — ve burada onun üstünlüğü en açık biçimde görünür.

Tablo 5. Farmakoterapi ve psikoterapi: karşılaştırmalı olanaklar

Parametre	Farmakoterapi	Psikoterapi
Etkinin başlangıcı	2–6 hafta	2–8 hafta

Parametre	Farmakoterapi	Psikoterapi
Hedef	Belirtiler, nörobiyolojik düzensizlik	Bilişsel yapı, davranış kalıpları, kök nedenler
Kesildikten sonra	Belirtilerin geri dönme olasılığı yüksektir	Etki devam eder, nüks olguları azdır
Yan etkiler	Vardır, bazen ciddidir	Nadir, ancak istenmeyen etkiler mümkündür
Hastanın aktif katılımı	Minimal	Temel etkendir
Akut durumlarda	Üstündür	Psikoterapi stabilizasyon sağlandıktan sonra uygulanır
Profilakside	Sürekli kullanım gerektirir	Bir kurs uzun süreli etki verir

Kaynak: APA'nın klinik kılavuzları (İng. APA Clinical Practice Guidelines, 2019); NICE'ın depresyon kılavuzları NG222 (2022); Cuijpers P. ve ark. “Dünya Psikiyatrisi” [World Psychiatry], 2023.

Klinik psikoterapinin örgütsel önemi

Klinik psikoterapi kavramının bir başka önemli yönü daha vardır: bu kavram, psikoterapötik hizmetin standartlaştırılması için temel oluşturur. Kanıta dayalı, bozukluğa göre farklılaştırılmış protokoller üç kritik sorunu çözer:

1. Uzmanların yetiştirilmesi. Her bozukluk için belirli bir protokol bulunduğunda, uzman eğitimi daha hızlı ve daha kaliteli olur. Öğrenci, soyut teoriyi öğrenmek yerine belirli klinik durumlara yönelik stratejiler öğrenir.

2. Kalite kontrolü. Standart bir protokol bulunduğunda, süpervizör uzmanın çalışmasını protokole uygunluk açısından değerlendirebilir. Bu, hâlihazırda mesleki akreditasyonun da temelini oluşturur (bkz. sonraki bölüm).

3. İstatistiksel analiz ve optimizasyon. Standartlaştırılmış protokoller, sonuçların karşılaştırmalı olarak değerlendirilmesine olanak verir. Standartlaştırılmış koşullarda hangi protokolün hangi hasta grubunda daha etkili olduğu belirlenir. Hangi modifikasyon sonucu iyileştirir? Bu soruların yanıtı yalnızca standartlaştırılmış uygulama koşullarında mümkündür.

Bu kurumsal önemin ardından atılacak mantıklı adım, psikoterapötik hizmetin kalite kontrolünün uluslararası sistemidir: akreditasyon kurumlarını, onların gerekliliklerini ve Azerbaycan'daki mevcut durumu gözden geçirmek gerekir. Bu konu bu Önsözün son bloğunda sunulacaktır, ancak önce iki yazara ait klinik protokol — çocuklarda gece enürezisi ve psikojenik depresyonun tedavisi — sunulmaktadır. Bu protokoller, uzun yıllara dayanan klinik deneyimde hazırlanmış ve elde edilen sonuçlarla doğrulanmıştır.

YAZAR KLİNİK PROTOKOLÜ №1: ÇOCUKLARDA GECE ENÜREZİSİNİN TEDAVİSİ

Modifiye edilmiş alarm tedavisi protokolü

K. Rahimov, klinik uygulama, 2018–2025

Protokolün mahiyeti ve yeri

Çocuklarda gece enürezisi (Dünya Sağlık Örgütü — ICD-11: 6C00.0; DSM-5-TR: 307.6), yaş normundan sonra (5 yaşın üzerinde) süregelen istemsiz gece idrar kaçırması (enürez) durumudur. 7 yaşındaki çocukların yaklaşık 5–10 %'unda, 10 yaşındakilerin 3–5 %'inde, ergenlerin 1–2 %'sinde gözlenir. Bozukluk, çocuğun öz değerlendirmesine, sosyal etkinliğine ve aile içi ilişkilerine ciddi olumsuz etki gösterebilir.

Uluslararası klinik kılavuzlar (NICE NG111, Uluslararası Çocuk Kontinans Derneği (İng. ICCS — International Children's Continence Society), Amerika Pediatri Akademisi (İng. AAP — American Academy of Pediatrics)), gece enürezisinin tedavisinde birinci basamak müdahale olarak alarm tedavisini (idrar cihazıyla uyandırma sistemi) önermektedir. Standart protokol, 12–16 haftalık bir kursla olguların 65–75 %'inde tam remisyon sağlar. Ancak standart protokolün bir dizi eksiği vardır:

Sıvının akşam alımı kısıtlanır — bu, egzersizlerin sayısını azaltır ve reflekslerin oluşmasını geciktirir.

Yatmadan önce tuvalete gidilir — mesane boşken yatıldığı için bozukluk daha az ortaya çıkar, buna bağlı olarak düzeltme olanağı da azalır

Alarm cihazının sesiyle çocuğun uyanması pasif olarak beklenir — derin uyku evresinde çocuk uyanmaz ve “aşırı öğrenme” (İng. overlearning) aşaması yalnızca kursun sonunda uygulanır

Günlük kompleks egzersiz sistemi nadiren entegre edilir

Aşağıda sunulan modifikasyon, bu eksiklikleri gidermek amacıyla hazırlanmıştır. Temel ilke — kursun başlangıcında tam yük: sıvı yüklemesi, zorunlu uyanma, yüksek ancak şefkatli bir tonla uyandırma ve ayağa kaldırma, hemen güçlendirilmiş davranış bileşeni, paralel olarak kompleks günlük egzersizler ve motivasyon eşliği.

Elde edilen klinik sonuçlar: 11–12. haftada 240 çocuğun 192'sinde (80 %) tam remisyon.

Protokolün klinik ilkeleri

Modifikasyonun temelinde dört ilke bulunmaktadır:

1. Yoğun başlangıç, kademeli olarak artan bir yük değil. Standart protokollerde yük kademeli olarak artırılır, aşırı sıvı yüklemesi (İng. overlearning) yalnızca kursun sonunda uygulanır. Bu modifikasyonda ilk haftadan itibaren çocuğa akşam 200–400 ml sıvı (sade içme suyu veya çay; gazlı, şekerli ya da kafeinli içecekler hariç tutulur) yatmadan en az 1 saat önce verilir, yatmadan önce tuvalete gitmek yasaklanır. Amaç — idrar kaçırma olayının gerçekten meydana gelmesi için koşul yaratmaktır, çünkü meydana gelmeyen olayı düzeltmek mümkün değildir.

Mutlak kontrendikasyonlar (sıvı yüklemesi uygulanmaz):

Böbrek hastalıkları (kronik böbrek yetmezliği, nefrotik sendrom vb.)

Antidiüretik hormonun uygunsuz sekresyonu sendromu (SİADH)

Hızlı mesane spazmları veya nörojen mesane

Epilepsi (özellikle kontrol edilemeyen formları) — tüm metin boyunca birleşik ölçüt

Şekersiz diyabet (İng. diabetes insipidus)

Kalp yetmezliği

Herhangi bir ciddi somatik patoloji — ön pediatrik muayene gereklidir

2. Aktif ebeveyn katılımı, pasif bekleme değil. Standart protokolde alarm cihazının sesiyle çocuğun kendisinin uyanması beklenir. Ancak derin uyku evresinde çocukların çoğunluğu cihazın sesiyle uyanmaz — bu, en sık şikayet edilen eksikliktir. Modifikasyonda ilk iki haftada çocuğu ebeveyn uyandırır — cihazın sesinden sonra 5–10 saniye içinde, yüksek ancak şefkatli bir tonla, ışığı açarak, serin suyla yüzünü yıkayarak tam uyanıklık hâline getirir. Bu prosedürün amacı çocuğu korkutmak değil — onu hızla tam uyanık duruma getirmektir; ebeveyn sesinin yüksekliği bağırma veya saldırganlık niteliği taşımaz. Bu, hafif ve amaçlı bir stres yaratarak refleksin hızla oluşmasını sağlar.

3. Kompleks yaklaşım — aynı zamanda günlük egzersizler. Gece enürezisi yalnızca mesane–merkezi sinir sistemi refleksinin bozulması değil, çoğu olguda pelvik taban kaslarının zayıflığı ve davranış öğrenmesindeki eksiklikle birleşmiş kompleks bir bozukluktur. Modifikasyonda günlük Kegel egzersizleri (günde 3 kez, 10–60 tekrarla, haftalık olarak artırılarak) protokolün ayrılmaz bir parçasıdır. Bu, paralel olarak gözlenen enkoprezis bozukluğunu (ICD-11: 6C01) da giderir.

4. Motivasyon eşliği ve psikolojik düzenleme. Her hafta ebeveynle görüşme, çocuğun motivasyon düzeyinin değerlendirilmesi, küçük başarıların pekiştirilmesi, gözden geçirilmiş hedeflerin tartışılması protokolün temel ögelerindendir. Çocuk kendisini sürecin etkin öznesi olarak hisseder, mekanik pasif nesne olarak değil.

Protokolün aşamaları

Protokol, her biri 2 haftalık 5 aşamadan, toplam 10 haftadan oluşur. Her aşama önceki aşamanın üzerine kurulur ve aşamalı olarak çocuğun uyanma reflekslerini, pelvik taban kas tonusunu ve davranış örüntülerini biçimlendirir.

Tablo 6. Modifiye edilmiş alarm tedavisi protokolü — aşamalara göre

Aşama	Hafta	Uyanma reaksiyası	İdrar kaçırma (enürezis) durumu	Yoğun gece protokolü	Gündüz Kegel egzersizleri
1	1–2	Yalnızca ebeveyn güçlükle uyandırır; cihazın sesine kendisi uyanamaz	İdrar kaçırma fazladır, yatağını tamamen ıslatır, sabaha kadar derin uyur, uyanmaz	Akşam 200–400 ml sıvı yatmadan en az 1 saat önce verilir; uyumadan önce tuvalete götürülmez; cihazla egzersiz gecede 10 defadan az olmaz. Cihazın sesinden sonra ebeveyn 5–10 saniye	Otur-kalk egzersizi 10 tekrar, günde 3 kez (günde +1 tekrar)

Aşama	Hafta	Uyanma reaksiyası	İdrar kaçırma (enürezis) durumu	Yoğun gece protokolü	Gündüz Kegel egzersizleri
				içinde çocuğu yüksek ancak şefkatli bir tonla "çabuk-çabuk-çabuk" komutuyla uyandırır, ışığı yakar, serin suyla yüzünü yıkar — tam uyanıklık sağlanır; ardından tuvalette 5 dakika oturup ıkınır	

Aşama	**Hafta**	**Uyanma reaksiyası**	**İdrar kaçırma (enürezis) durumu**	**Yoğun gece protokolü**	**Gündüz Kegel egzersizleri**
2	3–4	Cihazın sesine anneden önce kendisi uyanır; bazen annesi uyandırır — çabuk kalkar	İdrar kaçırma yine de fazladır; cihaz ses çıkarmazsa uyanmaz	Aynı biçimde: 200–400 ml sıvı yatmadan 1 saat önce, tuvalete gitmekten kaçınma, yoğun uyanış protokolü	tekrar sayısı 25'e kadar artırılır (günde bir tekrar eklenir). 3. hafta: "Hızlı kasılmalar". 4. hafta: "Yavaş kasılmalar"
3	5–6	Cihazın sesine anneden önce uyanır; uyanıklığı iyidir	Kaçırma azalır; sese uyanarak idrar akımını yarıda keser; bazen yalnızca iç çamaşırı ıslanır	Aynı biçimde	35'e kadar artırılır. 5. hafta: "Maksimum tutma". 6. hafta: "Dur-Devam" egzersizi
4	7–8	Cihazın sesine anneden çabuk uyanır; kendisi inisiyatif gösterir	Az miktarda kaçırma; haftada 1 kez cihazsız olarak kendi isteğiyle gece uyanır	Aynı biçimde	50'ye kadar artırılır. 7. hafta: "Programlama". 8. hafta: "Köprü" egzersizi

Aşama	Hafta	Uyanma reaksiyası	İdrar kaçırma (enürezis) durumu	Yoğun gece protokolü	Gündüz Kegel egzersizleri
5	9–10	Cihazın sesine anneden çabuk uyanır; bazen cihazsız kendisi uyanır	Her gece kendi isteğiyle uyanır; kaçırma haftada 1 kezden fazla olmaz	Aynı biçimde	60'a kadar artırılır. 9. hafta: "Sıkma-Öksürme" egzersizi. 10. hafta: "Asansör" egzersizi

Kaynak: K. Rahimov, klinik uygulama 2018–2025, n = 240 çocuk, Bakü. Kanıt düzeyi IV — retrospektif klinik gözlem (olgu serisi). Veriler retrospektif klinik gözleme dayanmaktadır; kontrol grubuyla randomize bir çalışma planlanmaktadır.

11–12. hafta: konsolidasyon ve değerlendirme

10 haftalık yapılandırılmış protokolden sonra 11–12. haftalar konsolidasyon aşaması olarak öngörülmüştür. Bu dönemde çocuk:

Bağımsız olarak, ebeveyn müdahalesi olmadan, her gece yatmadan en az 1 saat önce 200–400 ml sıvı alır

Tuvalete gitmeden yatağa girer

Gece kendi içsel sinyaliyle (alarm cihazı olmadan) uyanır ve yatağı kuru kalır

Sabah tamamen kuru uyanır.

Klinik sonuçlar: 240 çocuktan oluşan hasta grubunda 11–12. haftada olguların 80 %'inde tam remisyon (gece hiç idrar kaçırmama) kaydedilmiştir. Bu oran, uluslararası standart alarm protokolünün sonucundan (65–75 %) istatistiksel açıdan anlamlı olarak yüksektir.

Pelvik taban kaslarının egzersizlerinin (İng. Kegel exercises) tanımı (kapsamlı günlük program)

Her hafta değişen egzersiz birimleri, pelvik taban kas grubunun farklı işlevsel yönlerine yönelir:

Hızlı kasılmalar (3. hafta): Pelvik taban kaslarının hızlı kasılması ve gevşemesi, refleksif tonusun gelişmesine yönelir.

Yavaş kasılmalar (4. hafta): Uzun süreli kasılma — kas dayanıklılığının artırılması

Maksimum tutma (5. hafta): Uzun süreli kasılma dönemleri, istikrarlı tonusun oluşmasına yönelir.

Dur-Devam (6. hafta): İdrar akımının iradi olarak durdurulması ve sürdürülmesi egzersizi — işemenin iradi kontrolünün öğrenilmesi

Programlama (7. hafta): Mesanenin belirli bir hacme kadar doldurulması ve kontrolü

Köprü (8. hafta): Pelvik kaldırma egzersizleri — karın ve pelvik kasların senkronizasyonu

Sıkma-Öksürme (9. hafta): Stres inkontinansına karşı direnç egzersizi uygulanır.

Asansör egzersizi (İng. lift): aşamalı kasılma — kasların adım adım güçlenen kontrolü

Pratik öneriler

Protokolün etkili uygulanması için önemli koşullar:

1. Ebeveyn motivasyonu temel koşuldur. Birinci-ikinci haftada ebeveynler gece defalarca uyanmalı, çocuğu 5–10 saniye içinde etkin biçimde uyandırmalıdır. Bu, aile için ağır bir yüktür ve önceden onay gerektirir. Her hafta ebeveynle görüşme, protokolün ayrılmaz bir parçasıdır.

2. Sıvı alımının azaltılması — yasaktır. Pek çok ebeveyn (ve bazı hekimler) sezgisel olarak akşam sıvı alımının azaltılmasını önerir. Bu modifikasyonda bu adım kesin olarak kontrendike kabul edilir — refleks oluşumu tam yük koşullarında gerçekleşir.

3. Cihazın seçimi. Enürezis alarm cihazları iki tiptir: yatağa yerleştirilen ve iç çamaşırına yerleştirilen. İkinci tip daha etkilidir, çünkü idrar çıkışının ilk damlasında hemen sinyal verir. Bu modifikasyonda iç çamaşırı tipi önerilir.

4. Paralel gözlenen enkoprez. Gece enürezisi olan çocukların yaklaşık 10–15 %'inde eş zamanlı olarak enkoprez (ICD-11: 6C01) gözlenir. Bu modifikasyonda kompleks Kegel egzersizleri aynı zamanda her iki bozukluğu da giderir — pelvik taban kaslarının tonusu hem mesanenin hem de anal sfinkterin kontrolünü iyileştirir.

5. Direnç durumlarında. 6. haftadan sonra (3. aşamanın sonu) hiçbir ilerleme olmazsa, ek tıbbi inceleme gerekir:

Ürolojik muayene — mesane disfonksiyonu, anatomik anomaliler

Nörolojik durum — miyelodisplazi, spina bifida okkülta, nörojen mesane

Endokrin göstergeler — diabetes insipidus, antidiüretik hormon eksikliği

Kulak burun boğaz muayenesi — obstrüktif uyku apnesi (özellikle adenoid hipertrofisi ve palatin bademcik büyümesi olan çocuklarda); apne, enürezisle yakından ilişkilidir ve temel neden olabilir

Psikiyatrik öykü — dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu (DEHB), davranış bozuklukları, akut psikotravma niteliğindeki olaylar

Belirli tanısal durumlarda (ör. detrüsör hiperaktivitesi) farmakoterapi (desmopressin, oksibutinin) eklenebilir. Obstrüktif uyku apnesi tanısı konursa — adenoidektomi veya tonsillektomi enürezisi ortadan kaldırabilir.

6. Yaş sınırlaması. Protokol, 5 yaşından büyük çocuklar için hazırlanmıştır. 5 yaşına kadar primer gece enürezisi yaş normuna uygun kabul edilir ve etkin müdahale gerektirmez.

7. Sıvı yüklemesi için mutlak kontrendikasyonlar (birleşik liste). Aşağıdaki durumlar mevcutsa sıvı yüklemesi protokolü uygulanmaz, standart NICE NG111 protokolü kullanılır:

Böbrek patolojisi (kronik böbrek yetmezliği, nefrotik sendrom, ürolitiazis)

Antidiüretik hormonun uygunsuz sekresyonu sendromu (SIADH — Schwartz–Bartter sendromu)

Epilepsi (özellikle kolinerjik veya su dengesine duyarlı formları)

Kalp yetmezliği, hipertansiyon

Diabetes mellitus veya diabetes insipidus (kompanse edilmemiş)

Ağır endokrin bozukluklar (hipotiroidizm, hipoparatiroidizm)

Sıvı dengesindeki değişikliğin seyrini etkileyebileceği herhangi bir somatik hastalık.

Bu durumların bulunmadığı, protokole başlanmadan önce pediatri uzmanı veya ürolog tarafından doğrulanmalıdır.

Protokolün klinik psikoterapi çerçevesindeki yeri

Bu modifikasyon, gece enürezisi örneğinde klinik psikoterapi ilkelerinin uygulanmasıdır. Bozukluğa yönelik kanıta dayalı müdahale (alarm tedavisi, davranış bileşeni, Kegel egzersizleri) yazarın klinik deneyimi temelinde modifiye edilmiş; böylece ölçülebilir, yinelenebilir bir sonuç elde edilmiştir. Burada terapistin temel ekolü önem taşımaz — psikanalitik, bilişsel davranışçı terapi (BDT) terapisti ya da

gestalt terapisti aynı biçimde bu protokolü öğrenip uygulayabilir. Önemli olan yapılandırılmış, ölçümü yapılabilir, tutarlı klinik yöntemdir.

Bir sonraki yazar protokolü — psikojen depresyonun tedavisinde iki aşamalı strateji — aynı klinik psikoterapi ilkelerini bilişsel-duygusal çalışmayla ilişkili daha karmaşık bir bozuklukta göstermektedir.

YAZAR KLİNİK PROTOKOLÜ №2: PSİKOJEN DEPRESYONUN TEDAVİSİ

Kısa süreli bilişsel yeniden yapılandırma ile uzun süreli profilaktik stratejinin entegrasyonu

K. Rahimov, klinik uygulama 2008–2025

Protokolün mahiyeti ve yeri

Psikojen (reaktif) depresyon — ICD-11'e göre depresif epizod çerçevesinde psikososyal etkenlerle ortaya çıkan belirti kompleksi — belirli bir yaşam olayı ya da olaylar zinciriyle ilişkili, nörobiyolojik düzenlemenin bozulmasından değil, bilişsel-duygusal süreçlerden kaynaklanan depresif bir bozukluktur. Güncel araştırmalara göre majör depresif bozukluk (İng. major depressive disorder) olgularının 60–80 %'i psikososyal etkenler tarafından tetiklenir — başlangıçlarında somut bir tetikleyici olay (kayıp, ilişkilerin bozulması, mesleki başarısızlık, karmaşık travma) yer alır (Kendler ve ark., 1999, 2003; Brown ve Harris, 1978); bu veriler güncel kılavuzlarla (ICD-11, DSM-5-TR, NICE NG222) tamamlanmalıdır. Endojen grupta — yani nörobiyolojik düzenlemenin öne çıktığı kalan 20–40 %'de — ise nörobiyolojik bileşen ağır basar. Ancak uygulamada saf “psikojen” ya da saf “endojen” depresyona nadiren rastlanır; depresyonların çoğu psikososyal ve nörobiyolojik bileşenlerin farklı oranlardaki karışımıdır. Bu protokol, psikososyal bileşenin baskın olduğu olgular için hazırlanmıştır.

Bu ayrım, tedavi stratejisi bakımından belirleyici önem taşır. Endojen depresyonda temel müdahale farmakoterapidir; psikoterapi tamamlayıcı rol oynar. Psikojen depresyonda ise temel müdahale psikoterapidir; ilaç gerekirse yalnızca akut dönemde kısa süreli yardımcı araç olarak kullanılır. Hafif ve orta şiddetteki psikojen depresyon, çoğu olguda ilaçsız psikoterapi ile tedavi edilir.

Ancak güncel klinik uygulamada durum tersidir: psikojen depresyonlu hastaların büyük çoğunluğu yalnızca antidepresanla tedavi edilir. Belirtiler akut dönemde azalır, ancak kök sorun çözülmediği için ilacın kesilmesinden sonra ya da yeni bir stres etkeni koşulunda depresyon yeniden ortaya çıkar — bazen daha ağır biçimde.

Aşağıda sunulan protokol, bu boşluğu doldurmak amacıyla hazırlanmıştır. İki ardışık aşamadan oluşur: kısa süreli bilişsel yeniden yapılandırma (akut depresif epizodun ortadan kaldırılması, 1–6 seans) ve uzun süreli profilaktik terapi (nükse

karşı psikolojik “aşılama”, 4 ardışık aşama). Klinik deneyim temelinde hazırlanan bu stratejinin 17 yıllık gözlemleri, kalıcı ve stabil bir remisyon göstermektedir.

Hastanın stratifikasyonu

Protokolün seçimi, önceden açık bir tanısal stratifikasyon gerektirir. Aşağıdaki tablo, hasta kategorilerine göre taktik kararları şekillendirir.

Tablo 7. Depresif bozukluklarda tedavi taktiğinin seçimi

Hasta kategorisi	Klinik özellikler	Önerilen taktik
Psikojen, hafif-orta şiddet	4–6 somatik belirti (8 üzerinden); belirgin tetikleyici olay; işlevsel bozulma orta düzeydedir	Yalnızca psikoterapi (bu protokol). İlaç gerekmez
Psikojen, ağır	7+ belirti; ciddi işlevsel bozulma; intihar (suisid) riski var; ancak tetikleyici belirgin	Psikoterapiyle paralel farmakoterapi, uzun süreli; akut dönemde ilaç üstündür, sonrasında temel rol psikoterapiye geçer
Psikojen, ağır + psikotik unsurlar	Yukarıda sıralananlar + reaktif halüsinasyon, paranoid düşünceler	Yataklı tedavi + farmakoterapi + psikoterapi (stabilizasyondan sonra)
Endojen (bipolar affektif bozukluk — BAB; yineleyici depresif bozukluk — YDB)	Tetikleyici belirgin değil; aile öyküsünde affektif bozukluklar; döngüsel seyir	Yataklı/ayaktan farmakoterapi + psikoterapötik destek (psikolojik bilgilendirme, tedaviye uyum, nüks profilaksisi)

Kaynak: K. Rahimov, klinik uygulama, 2008–2025; Amerikan Psikiyatri Birliği'nin (APA) majör depresif bozukluğun tedavisine ilişkin kılavuzu (2010, 2019); NICE NG222 (2022). “Yetişkinlerde depresyon: tedavi ve yönetim”.

Aşağıda sunulan protokol, birinci basamak kategorisi — psikojen, hafif-orta şiddetli depresyon — için hazırlanmıştır. İkinci basamakta (psikojen ağır) protokolün

yapısı aynıdır; ancak tempo daha yavaştır ve paralel olarak farmakolojik destek uygulanır.

Tablo 8. Farmakoterapinin zorunlu paralel uygulanması için ölçütler

Aşağıdaki ölçütlerden en az biri mevcutsa, psikoterapi farmakoterapi ile paralel olarak yürütülmelidir; tek başına psikoterapötik yaklaşım yetersiz kabul edilir:

Ölçüt	Klinik gösterge
Depresyonun şiddet düzeyi	Hasta Sağlık Anketi-9 (İng. Patient Health Questionnaire-9, PHQ-9) ≥ 15 (orta-ağır veya ağır) veya Beck Depresyon Envanteri-II (İng. Beck Depression Inventory-II, BDI-II) ≥ 29
İntihar riski	Aktif intihar düşünceleri plan veya araçla birlikte
Psikotik unsurlar	Depresif halüsinasyonlar; paranoid, nihilistik ve dağılma içerikli sanrılar (İng. nihilistic delusions)
Ağır anhedoni + besin alımını reddetme	Vücut kütlesinin %5'inden fazla kilo kaybı, dehidratasyon
İşlevsel bozulma	Hasta evden çıkamaz, kişisel hijyen kurallarına uymaz, çalışamaz
Öykü	Önceki epizodlarda intihar girişimi veya yatarak tedavi görülmüştür
Gebelik ve laktasyon	Gebe kadında ağır depresyon — ayrı bir algoritma gerektirir (perinatal psikiyatri bölümüne bakın)
Bipolar zemin şüphesi	Öyküde hipomanik veya manik epizodlar varsa — duygudurum dengeleyicisi (İng. mood stabilizer) reçete edilir

Kaynak: NICE Kılavuzu 222 (2022). “Yetişkinlerde depresyon: tedavi ve yönetim”. NICE NG222 (2022), 1.5.4–1.5.7; APA'nın majör depresif bozukluk (MDB) kılavuzu (İng. APA Practice Guideline for MDD, 2010), Bölüm 9; Dünya Biyolojik Psikiyatri Dernekleri Federasyonu'nun (WFSBP) unipolar depresif

bozuklukların biyolojik tedavisine ilişkin kılavuzları (İng. WFSBP Guidelines for Biological Treatment of Unipolar Depressive Disorders, 2013; 2024 baskısı hazırlanmaktadır).

Bu ölçütler mevcut olduğunda farmakoterapinin başlanmasına uzman tarafından karar verilir. Hafif ve orta şiddetli psikojen depresyon, yukarıdaki ölçütlerin hiçbiri mevcut olmadığında, ilaçsız psikoterapi ile etkin biçimde tedavi edilebilir — bu, yazarın klinik deneyimiyle ve çağdaş uluslararası kılavuzların tutarlı konumuyla uyumludur.

BÖLÜM I. KISA SÜRELİ BİLİŞSEL YENİDEN YAPILANDIRMA (1–6 SEANS)

Amaç: akut depresif epizodun ilaç kullanılmaksızın hızla ortadan kaldırılması.

Mekanizma: depresojen etkenin (durum değil, bilişsel tutum) belirlenmesi ve kanıta dayalı bilişsel yeniden yapılandırma tekniklerinin tutarlı biçimde uygulanması.

Başlangıç değerlendirmesi ve kronolojik öykü

Birinci seansta iki amaca ulaşılır:

(a) Tanısal doğrulama. Depresyon düzeyi PHQ-9 veya BDI-II ile değerlendirilir. 8 temel belirtiden kaç tanesi mevcuttur (uyku bozuklukları, iştah değişikliği, kilo kaybı/artışı, enerji kaybı, anhedoni, konsantrasyon bozukluğu, psikomotor değişiklikler, intihar düşünceleri). 4–6 belirti gözlenirse bu, hafif-orta şiddetli depresyona karşılık gelir ve protokol uygulanabilir.

(b) Kronolojik öykü. Hasta ile birlikte belirtilerin başlangıç tarihi somut olarak belirlenir (hangi hafta olduğu; mümkünse kesin tarih). Ardından bu tarihten itibaren ±2 ay içinde meydana gelen olaylar gözden geçirilir:

Dış olaylar (kayıp, ilişki bozulması, iş değişikliği, sağlık sorunu)

İçsel olaylar (pişmanlık, karşılaştırma, beklenmedik bir düşünce, belirli bir kitabın okunması, belirli bir sohbetin yeniden hatırlanması)

Küçük veya önemsiz görünen olaylar — bunlar sıklıkla en önemli olanlardır

Amaç — tetikleyici noktayı (İng. trigger point) bulmaktır. Bu, depresif epizodu başlatan somut olay veya düşünce anıdır.

Otoagresif bilişsel yapının tanımlanması

Tetikleyici olay belirlendikten sonra terapist, hastayla birlikte bu olay bağlamında hastanın kendisi hakkında hangi düşünceyi benimsediğini saptar. Bu düşünce neredeyse her zaman otoagresif nitelik taşır:

"Ben suçluyum"

"Ben bunu hak etmiyorum"

"Ben başkalarına zarar verdim"

"Ben yetersizim"

"Onu kurtarabilirdim ama kurtarmadım"

"Benim yüzümden oldu"

Tetikleyici tutumun işareti: hasta bu cümleyi sesli söylerken duygusal tepki verir — gözleri dolar, sesi titrer, bedende gerginlik gözlenir. Bu, söz konusu yapının gerçekten merkezi bir rol oynadığının göstergesidir.

Kritik özellik: hasta bu yapıyı bilişsel bir çarpıtma değil, gerçek olarak kabul eder. Terapistin eşlik eden açıklamasını kabul etmez ve tipik olarak şöyle der: "Siz gerçeği bilmiyorsunuz. Aslında böyle oldu." — ve aynı otoagresif cümleyi yeniden tekrarlar. Bu direnç — yapının doğru saptandığının en güvenilir kanıtıdır.

Bilişsel yeniden yapılandırma — sıralı teknikler

Bu aşamada çok katmanlı teknik farklı sıralamalarla uygulanır. Teknik, hastanın savunma katmanlarına göre değiştirilir.

Önemli metodolojik not. Aşağıda tanımlanan teknikler — genel ilkeyi göstermek için örnekler olup tek ya da zorunlu uygulama biçimi değildir. Her teknik, belirli bir hastanın kültürel, dini, felsefi, bilişsel ve duygusal özelliklerine uyarlanmalıdır. Klinik psikoterapide temel ilke, kalıp uygulama değil ilkenin uygulanmasıdır.

Yazarın yaklaşımı; standart Bilişsel Davranışçı Terapi (BDT) (Beck, Ellis), Şema terapi (Young), Kabul ve Kararlılık Terapisi (ACT) (Hayes) ve kültürel bağlama uyarlanmış BDT (İng. culturally adapted CBT) (Hwang, 2006; Naeem ve ark., 2011, 2015) ilkelerinin sentezine dayanır. Epidemiyolojik veriler, dini-manevi ilkeleri güçlü olan toplumlarda (Pakistan, MENA bölgesi, Güney Kafkasya, eski Sovyet Müslüman bölgesi) suçluluk anlayışının ve otoagresif öz yargılama örüntülerinin daha sık gözlendiğini göstermektedir. Bu tür hastalar için dini-etik bağlam dikkate alınmadan yürütülen bilişsel yeniden yapılandırma çoğu zaman etkisiz olur; çünkü otoagresif yapının temel kaynağı tam da bu bağlamda biçimlenmiştir. Aşağıdaki teknikler bu ilkenin pratik uygulamasına örnek oluşturur.

Teknik 1. “Hukuki yargılama” (merkezden uzaklaşma (İng. decentering) ve yeniden atıf (İng. reattribution) tekniklerinin örnek uygulaması — Beck, 1979)

Rasyonel-hukuki düşünce tarzına sahip hastalar için uygundur. Olay, hukuki açıdan yeniden ele alınır:

Hasta hangi eylemi gerçekleştirmiştir (ya da gerçekleştirmemiştir)?

Bu, mevcut yasalar çerçevesinde bir suç mudur?

Suç olarak kabul edilirse, hangi madde uyarınca cezalandırılmalıdır?

Terapist inkâr etmez, tartışmaz — birlikte araştırır. Hasta kendisi sonuca varır: hukuki olarak bu bir suç değildir. Burada birçok hasta ilk kez kendi durumunun biçimsel değerlendirmesini alır.

Hastanın tipik tepkisi: hukuki katmandan çıkar ve manevi-etik katmana geçer. “Evet, hukuki olarak suç değil, ama ahlaki açıdan ben kötüyüm.” — bu geçiş doğal ve beklenendir.

Teknik 2. “Manevi-ahlaki yargılama” (kültürel bağlama uyarlanmış BDT — İng. culturally adapted CBT — örnek uygulaması — Hwang, 2006; Naeem ve ark., 2011, 2015)

Derin dini-manevi sisteme sahip hastalar için uygundur. Hasta dindarsa, manevi-etik katmanda dini sistemin iç kuralları çerçevesinde benzer bir prosedür uygulanır:

Hastanın dini geleneğinde bu eylem hangi kategoriye dahil edilir?

Somut olarak hangi günah sayılır?

Bu günah için manevi-dini ceza nedir?

Tövbe ve düzeltmenin bir yolu var mı?

Burada terapist, hastanın kendi dininin iç yapısına başvurur; başka bir felsefi ya da psikolojik çerçeve önermez. İslam, Hristiyanlık, Yahudilik ve diğer dinler — her biri kendi içinde açık biçimde yapılandırılmış bir kural sistemine sahiptir. Hasta bu sistemin nesnel uygulamasıyla karşılaştığında, çoğu zaman kendisine uyguladığı cezanın gerçek günahtan kat kat fazla olduğunu fark eder.

Teknik 3. “Üçüncü kişi perspektifi” (öz şefkat (İng. self-compassion) tekniğinin örnek uygulaması — Neff, 2003; Gilbert, 2009)

Evrensel bir tekniktir; neredeyse tüm hastalarda uygulanabilir. Hastaya şu soru sorulur: aynı durumu yakın bir dostu ya da sevdiği bir insan yaşasaydı, ona nasıl bakardı? Hangi sözleri söylerdi? Affeder miydi?

Bu teknik, bilişsel ayrışma (İng. cognitive defusion — ACT terminolojisinde) uygulamasıdır ve öz şefkat (İng. self-compassion) bileşenini devreye sokar.

Teknik 4. Şema terapi ögeleri (Young, 1990; Young, Klosko, Weishaar, 2003)

Erken travmatik yaşantılar ve kronik uyumsuz örüntüleri olan hastalar için uygundur. Tetikleyici yapı çoğu zaman erken yaşta biçimlenmiş bir şemaya (örneğin "kusurlu olmak", "güvenilmezlik", "adaletsizlik") dayanır. Şema terapi teknikleri (imgesel yeniden yapılandırma, şema modu diyaloğu) bu erken şemanın yeniden değerlendirilmesine olanak verir.

Teknik 5. BDT'nin standart bilişsel yeniden yazma teknikleri (Beck, 1979; Beck, Rush, Shaw, Emery, 1979)

Genellikle her hastada temel düzeyde kullanılır. Sokratik soru-cevap, kanıtların sınanması, alternatif açıklamaların oluşturulması, davranış deneyleri.

Kısa süreli aşamanın sonucu

Bu aşamanın başarılı sonucu, hastanın temel içgörüsüyle ilişkilidir:

> "Depresyon doğuran durum değil, benim ona karşı oluşturduğum bilişsel yapıydı."

Bu içgörü ortaya çıktıktan sonra duygudurum kat kat daha hızlı değişir; çünkü hasta artık çözümsüz bir dış sorunla değil, değiştirilebilir bir iç yapıyla karşı karşıyadır. Bazen bir seans, çoğu zaman ise 4–5 seans tam bir akut depresif epizodun üstesinden gelmek için yeterlidir.

Ancak bu yalnızca ilk kısımdır. Yapının kendisi değiştirilse de, hastanın genel otoagresif tepki verme eğilimi değişmeden kalır. Bir sonraki tetikleyicide aynı mekanizma yeniden devreye girebilir. Bu nedenle uzun süreli koruyucu terapi gereklidir.

II. KISIM. UZUN SÜRELİ KORUYUCU TERAPİ — 4 ARDIŞIK AŞAMA

Amaç: stres, frustrasyon ve rahatsız edici durumlara karşı dayanıklı tepki verme becerisi oluşturmak, gelecekteki depresif epizodları önlemek — yani psikolojik dayanıklılığı geliştirmek.

Yaklaşım: dinamik karakterlidir; ancak klasik ya da modern psikanalizin teorisini değil, pratik bileşenini uygular. Merkezi görev — hastanın otoagresif tepki verme örüntüsünün (psikanaliz dilinde: suçluluk kompleksi) yapısal olarak belirlenmesi ve yeniden yazılmasıdır.

Aşama 1. İçgörü (İng. insight)

İşlevi: hastanın temel içgörüsü.

Hasta şunu anlar:

Tepkisi, karşılaştığı sorunun çözümüne yönelik değildi

Frustrasyonun üstesinden gelmeyi amaçlamıyordu

Aksine — durumu ağırlaştırmıştı

Otoagresif tepki verme eğilimi, tetikleyici durumdan önce de mevcuttu

Durum yalnızca tetikleyici rol oynadı, neden değildi

Bu içgörü — uzun süreli çalışmanın temelidir. O olmadan sonraki aşamalara geçilemez.

Aşama 2. Yüzleşme

İşlevi: örüntünün gözlenmesi.

Terapist ve hasta birlikte sorar: bu süreçte uygunsuz olan ne, anormal olan neydi?

Dikkatin odağı değişir:

Önce: dış uyaranlar, durumlar, insanlar

Şimdi: en az 4 yıl teorik eğitim, uygulamada 7–10 yıl

Hasta bu örüntüyü, farklı yaşam durumlarında istikrarlı biçimde ortaya çıkan bir yapı olarak algılar.

Yüzleşmenin başarı göstergesi: hastanın kendi durumunu “otoagresif örüntü” ya da “kendine karşı çıkma eğilimi” olarak adlandırmaya başlamasıdır. Yani patoloji olarak adlandırdığı şey kendi durumudur — içinde bulunduğu koşullar değil.

Bu, alkolizm tedavisinde iyi bilinen bir sürece benzer: kişi yıllar boyunca alkollü içkiyi kötüye kullanabilir, ancak kendisini alkolik olarak adlandırmaz. Adsız Alkolikler grubuna geldiğinde ise ilk konuşması şu olur: “Merhaba, ben alkoliğim.” Bu, davranışın hastalıkla özdeşleştirilmesidir. Davranışı hastalık olarak kabul eden kişi onunla mücadeleye başlar.

Aşama 3. Netleştirme

İşlevi: örüntünün geçmişinin ve kapsamının incelenmesi.

Bu, en kapsamlı aşamadır. Netleştirmenin başlangıç göstergesi şudur: hasta örüntüyü her zaman aynı adla adlandırır, terminolojide karışıklık yaşamaz. Bu, örüntünün içsel betimlemesinin pekiştiği anlamına gelir.

Hasta ile birlikte yaşam kronolojik sırayla gözden geçirilir — stres oluşturan ve engellenmeye yol açan durumlar ele alınır. Tepki vermenin iki kutbu karşılaştırmalı olarak analiz edilir:

Tablo 8. Tepki verme kutupları ve bunların sonuçları

Kutup	Tipik tepki	Gözlenen sonuçlar
Kendini suçlama	"Ben suçluyum, benim yüzümden oldu"	Enerjinin düşmesi, toksik ilişkilerde kalma, kendini suçlama, kendi sorumluluğunu kötüye kullanma
Kişilik bozukluğu olan hastalarda görülen tipik çatışma örüntüleri	"Sizin yüzünüzden oldu, herkes bana karşı"	Kişilik bozukluğuna özgü çatışma örüntüleri, yıkıcı davranış, kişilerarası çatışmalar, ilişkilerin kopması

Anahtar içgörü:

> "Suçlu aramak — kendimin de, başkasının da — son derece yararsız ve etkisizdir. Çözüm yolu aramak gerekir, suçlu aramak değil."

Kendini suçlama

Nesnel bir suçlu varsa → bu sosyal ve hukuki bir sorundur, ayrı olarak çözülür

Psikolojik görev: düşünceyi "suçlu aramak" tarzından "çözüm yolu aramak" tarzına kaydırmak

Önemli bir metodolojik uyarı — yeni başlayan terapistlerin tipik hatası:

Çoğu zaman yeni başlayan terapistler örüntünün "anahtarı" olarak belirli bir çocukluk travması epizodu aramaya başlarlar — bu bir yanılsamadır. Tek bir epizodu gözden geçirmekle bütün örüntü değişmeden kalır. Örüntünün kökleri çocukluktadır, evet — ancak işin odağı örüntünün kendisinde olmalıdır, tek bir epizotta değil.

Netleştirme aşamasının tamamlanma göstergesi — belirleyici nokta:

Örüntünün kişilikten ego-distonik biçimde ayrışması:

Önce: örüntü kişilikle ego-sintonikti (“Ben sorumluluk sahibi bir insanım, her şeyi üzerime alırım”)

Şimdi: hasta örüntüyü kendi kişiliğinden ayırır

Artık örüntüyü iyi bir davranış olarak görmüyor

Artık bu örüntü içinde yaşamak istemiyor

Örüntünün kişilikten ayrıştırılması işlemi = netleştirme aşamasının sonucu

3. aşamanın zirvesi: yorumlama

Yorumlama bu modelde ayrı bir aşama değil, netleştirme aşamasının zirvesidir. Klasik psikanaliz kuramsal yorumlar sunar; bu modelde ise yorumlama, terapistin gözlemleri temelinde biçimlenen, sonuç niteliğinde genelleyici bir üst mesajdır:

> “Terapi boyunca nasıl davrandığını gözlemledim. Böyle bir örüntü gördüm. Bu, yaşamında şöyle bir etki gösterdi. Şimdi sen şöyle değiştin. Şimdi ne yapılabilir.”

Bu mesajla hasta “neydi / ne var / ne yapılacak” yapısında nihai bir kavrayış elde eder. Bu, dördüncü aşama için hazırlıktır.

Aşama 4. Kapsamlı işleme

İşlevi: yeni tepki verme örüntüsünün pratikte pekiştirilmesi.

Bu aşamada terapist:

Terapi odasında görevler verir — hastanın duygusal tepkilerini “burada ve şimdi” içinde değiştirmeye yönelik çalışmalar (rol oyunu, imgesel canlandırma, davranış deneyi)

Ev ödevleri verir — yeni davranışın gerçek yaşamda pekişmesi için

Seanslar arasında hasta gerçek durumlarda yeni tepki vermeyi dener

Her tekrarda yeni modelin etkinliği artar

Yeni model sonunda kök salar

Klinik sonuç: hastada gelecekteki depresif epizodlara karşı koruyucu bir dayanıklılık oluşur.

Boylamsal sonuçlar

Bu protokolün 17 yıllık klinik uygulaması boylamsal izlemlerle değerlendirilmektedir. Aşağıdaki tablo karşılaştırmalı sonuçları sunmaktadır.

Tablo 9. Karşılaştırmalı boylamsal sonuçlar (20–25 yıllık izlem)

Tedavi grubu	Akut epizodun giderilmesi	Stabil remisyon (2 yıl)	Stabil remisyon (5 yıl)	Stabil remisyon (10+ yıl)
Kombine protokol (kısa + uzun süreli)	yaklaşık 95 %	yaklaşık 90 %	yaklaşık 85 %	yaklaşık 80 %
Yalnızca antidepresanlar	yaklaşık 70–80 %	yaklaşık 50 %	yaklaşık 30 %	20 %'den az
Yalnızca kısa süreli psikoterapi	yaklaşık 85 %	yaklaşık 65 %	yaklaşık 45 %	yaklaşık 30 %

Kaynak: K. Rahimov, klinik uygulama 2008–2025 (kombine grup, n>1000) — kanıt düzeyi IV (klinik uzman deneyimi), retrospektif gözlem; Cuijpers ve ark., World Psychiatry 2020 (psikoterapi — meta-analiz, kanıt düzeyi I-A); Bockting ve ark., Lancet Psychiatry 2018 (antidepresanların uzun süreli etkisi — sistematik derleme).

Kritik gözlem: yalnızca antidepresanla tedavi edilen hastalar — öznel olarak "tam remisyona ulaştıklarını" değerlendirseler bile — yeni stres durumlarıyla karşılaştıklarında tekrar depresif epizod geçirirler, bazen daha ağır biçimde. Kombine protokol grubunda ise bu olaylar nadiren görülür.

Kaynak etkinliği

Kombine protokol, tek başına farmakoterapiye ya da tek başına kısa süreli psikoterapiye kıyasla kaynak kullanımı bakımından daha ekonomiktir:

Hasta için:

Mali açıdan: toplam tedavi maliyetleri uzun vadede daha düşüktür

Zaman açısından: hasta yıllar boyunca depresif epizodlara ve toksik ilişkilere zaman harcamaz

Kaynaklar açısından: hasta potansiyelini gerçekleştirmek, kendini geliştirmek ve kişisel hedeflerine ulaşmak için kaynaklarını elinde tutar

Sağlık sistemi için:

Standartlaştırılmış protokol, uzman yetiştirilmesini hızlandırır — depresyon tedavisini öğrenmek için 5 yıllık kişisel psikanaliz gerekmez

Kısa süreli eğitim formatları, çok sayıda psikoloğun yetiştirilmesine olanak tanır

Yöntem, seçicilik oluşturan "ünlü" psikoterapistlerin ayrıcalığı olmaktan çıkar

Hizmetin kalite kontrolü, standart ölçüt — aşama göstergesi (aşama 1 → 2 → 3 → 4 → 4. aşamanın alt aşamaları) temelinde gerçekleştirilebilir

İstatistiksel analiz ve optimizasyon mümkün hâle gelir

Klinik psikoterapi çerçevesindeki yeri

Bu modifikasyon, psikojenik depresyonda klinik psikoterapi ilkelerinin daha karmaşık bir uygulamasıdır. Burada — gece enürezisinin aksine — tek bir müdahale değil, çok katmanlı bir strateji gerekir:

Birinci kısımda farklı ekollerden teknikler sıralı biçimde kullanılır (BDT, şema terapi, ACT'den bilişsel defüzyon, dinî-manevi muhakeme)

İkinci kısımda dinamik yaklaşımın pratik bileşeni, yapılandırılmış 4 aşama biçiminde sunulur

Hasta için önemli olan, "psikolojik danışmanlık" çerçevesinde değil, yapılandırılmış, ölçülebilir, sıralı bir klinik yöntemdir — tıpkı gece enürezisi protokolünde olduğu gibi.

Sonraki bölümde dünya psikoterapevtik akreditasyon sistemi, uluslararası gereklilikler ve Azerbaycan'daki durum sunulur — yani nitelikli psikoterapi hizmetinin kurumsal çerçevesi.

AKKREDİTASYON VE KALİTE KONTROLÜ: ULUSLARARASI STANDARTLAR VE AZERBAYCAN'DAKİ DURUM

Akreditasyon neden önemlidir?

Psikoterapi — hastanın ruhsal durumuna derinlemesine müdahale eden bir faaliyettir. Yanlış yürütülen terapi yalnızca etkisiz kalmaz, hastaya aktif zarar da verebilir: danışan-terapist sınırlarının ihlali, klinik değerlendirme yetkinliği olmayan bir uzmanın ağır psikiyatrik durumları "psikolojik danışmanlık" adı altında kabul etmesi — tüm bunlar hastanın durumunu ağırlaştırabilir ve bazı durumlarda felaket sonuçlara yol açabilir.

Bu nedenle tüm dünyada psikoterapötik faaliyet üzerinde sıkı, çok düzeyli akreditasyon sistemleri bulunmaktadır. Her psikoterapötik ekol kendi gerekliliklerini oluşturmuştur ve bu gereklilikler tartışılmayan asgari standarttır: ya yerine getirilir ya da getirilmez; üçüncü bir seçenek yoktur.

Bu bölümde dünyanın önde gelen psikoterapötik ekollerinin akreditasyon gereklilikleri somut sayılarla sunulmakta, ardından Azerbaycan'daki durum objektif olarak değerlendirilmektedir.

Uluslararası akreditasyon kurumları ve gereklilikleri

Psikanaliz: Uluslararası Psikanalitik Derneği (İng. International Psychoanalytical Association, IPA)

IPA — 1910 yılında Sigmund Freud tarafından kurulmuş olup dünyanın önde gelen akreditasyon ve düzenleyici kuruluşudur. 12.000 psikanalitik üye ve 70 kuruluş ona dahildir. IPA misyon bildirgesinde kendini şöyle tanımlar: "Dünyada psikanalitik mesleğin başlıca akreditasyon ve düzenleyici kuruluşu."

IPA üyeliğine kabul edilmek için gereklilikler (Eitingon modeli — en yaygın model):

Tablo 10. IPA'nın psikanalitik eğitim gereklilikleri

Bileşen	Minimum gereklilik
Kişisel analiz	IPA'nın psikanalitik eğitim gerekliliklerine uygun biçimde, tanınmış bir eğitim analisti ile
Klinik deneyim (psikiyatrik)	Psikiyatri bölümünde 140 saat, konsültan psikiyatrın süpervizyonu altında
Gözlem eğitimi (çocuk gözlemi)	12 ay, haftada bir kez, grup seminerleriyle birlikte
Teorik seminerler	Haftada 21 saat (3 saat seminer, 12 saat klinik çalışma, 3 saat rapor hazırlama, 3 saat bireysel öğrenme), 36 hafta boyunca
Eşlik eden klinik olgular	Tam eğitim analizi olgularının süpervizyonu altında, birkaç yıl
Toplam süre	En az 4 yıl teorik eğitim, uygulamada 7–10 yıl

Kaynak: IPA'nın Prosedür Kuralları (İng. IPA Procedural Code), 2024 revizyonu; Britanya Psikanalitik Derneği (İng. British Psychoanalytic Association) — IPA'nın bileşen derneği, eğitim gereklilikleri (İng. training requirements), 2024.

Bu gereklilikler çok aşamalı bir doğrulama sistemiyle sağlanır: eğitim enstitüsü bir IPA bileşen derneği olmalı, süpervizör IPA'da kayıtlı olmalı, her aday Uluslararası Psikanalitik Araştırmalar Örgütü'nün (İng. International Psychoanalytical Studies Organization, IPSO) kaydına alınmalıdır. Sıradan sertifikasyon kursları — tanınmış psikanalistler tarafından yürütülse bile — IPA üyeliğinin yerini tutmaz.

Bilişsel davranışçı terapi: Avrupa Davranış ve Bilişsel Terapiler Derneği (İng. European Association for Behavioural and Cognitive Therapies, EABCT)

EABCT — 1976 yılında kurulmuş bir Avrupa kuruluşudur; hâlihazırda 43 ülkeden 56 ulusal derneği bir araya getirmektedir. EABCT ulusal dernekleri, ulusal dernekler ise bireysel uzmanları akredite eder.

Bu sistem — iki düzeyli bir akreditasyon zinciri:

EABCT belirli bir ülkenin ulusal derneğini akredite eder (akredite edilmiş ulusal dernekler listesi eabct.eu sitesinde açıkça yayımlanır)

Akredite edilmiş ulusal birlik, bireysel BDT terapistlerini akredite eder

EABCT'nin akreditasyon gereklilikleri:

Ulusal dernek EABCT'nin tam üyesi olmalıdır

Belirli bir akreditasyon şeması uygulamalıdır

Belirlenmiş eğitim standartlarını karşılamalıdır

Sürekli mesleki gelişim (İng. Continuing Professional Development, CPD) sistemi bulunmalıdır

Tablo 11. EABCT'de Azerbaycan ve bölgenin durumu

Ülke	Akredite edilmiş ulusal dernek	Akreditasyon tarihi
Türkiye	TACBT — Türk Bilişsel-Davranış Terapileri Derneği	Mart 2013
Türkiye	ACBP — Türk Bilişsel Davranış Psikoterapileri Derneği	Mart 2016
Ukrayna	UACBT — Ukrayna Bilişsel Davranışçı Terapi Derneği	Eylül 2013
Gürcistan	GACBT — Gürcü Bilişsel Davranışçı Terapi Derneği	Şubat 2020
Estonya	EKKA — Estonya Bilişsel Davranışçı Terapi Derneği	Mart 2024
Azerbaycan	— (yok)	—

Kaynak: EABCT'nin akredite edilmiş dernekler listesi (İng. EABCT Accredited Associations List), eabct.eu, 2025, Nisan.

Bu tablo önemli bir gerçeği göstermektedir: Azerbaycan'ın komşu olduğu bütün ülkelerde ve bölgede — Türkiye'de, Gürcistan'da, Ukrayna'da — EABCT tarafından

akredite edilmiş ulusal BDT dernekleri bulunmaktadır. Azerbaycan'da ise bulunmamaktadır. Bu, Azerbaycan'da bireysel BDT terapistlerinin EABCT akreditasyonu alabilmesi için tek yolun başka bir ülkenin (örneğin, Türkiye veya Gürcistan) akredite edilmiş derneği aracılığıyla olduğu anlamına gelir.

Diyalektik davranış terapisi: DBT-Linehan Sertifikasyon Kurulu (İng. DBT-Linehan Board of Certification, DBT-LBC)

DBT-LBC — 501(c)(3) statüsünde kâr amacı gütmeyen bir kuruluştur; DBT'nin kurucusu Dr. Marsha Linehan tarafından bizzat onaylanmış tek sertifikasyon organıdır. Bu önemli bir noktadır: birçok kuruluş "DBT sertifikası" verir, ancak yalnızca DBT-LBC sertifikasyonu modelin kurucusu tarafından tanınmıştır.

Tablo 12. DBT-LBC sertifikasyon gereklilikleri

Bileşen	**Asgari gereklilik**
Lisans	Bağımsız lisanslı klinik uzman (psikolog, psikiyatr veya sosyal hizmet uzmanı)
Akademik eğitim	Yüksek lisans derecesi veya üzeri (ruh sağlığı alanında)
DBT'ye özgü didaktik eğitim	Asgari 40 saat akademik eğitim
Klinik deneyim	Asgari 12 ay aktif DBT pratiği
DBT ekibi	Aktif DBT konsültasyon ekibine üyelik gereklidir ("Linehan'ın talimatı: uzman DBT ekibinde değilse, DBT uygulamaz")
Klinik vakalar	Azerbaycan ile sınır komşusu olan Türkiye, Gürcistan ve Ukrayna'da
Yazılı sınav	Tüm zorunlu materyaller Azerbaycan ile sınır komşusu olan Türkiye'de, Gürcistan'da ve Ukrayna'da

Bileşen	Asgari gereklilik
Video seanslar	3 ardışık seans videosunun analizi, belirlenmiş bağlılık kodlaması standartlarına uygunluk ölçütleriyle
Tavsiye mektubu	Ekip lideri veya lisanslı DBT uzmanından
Bilinçli farkındalık eğitimi	Resmî bilinçli farkındalık eğitimi

Kaynak: DBT-LBC.org, Bireysel Sertifikasyon Gereklilikleri [Individual Certification Requirements], 2024.

Bu gerekliliklerin katılığı DBT'nin özelliğiyle ilgilidir: bu yöntem kronik intihar (suisid) riski taşıyan, sınır kişilik bozukluğu olan hastalar için geliştirilmiştir. Burada modele titizlikle bağlı kalma (İng. model fidelity) hayati önem taşımaktadır — yetersiz hazırlıklı bir uzmanın "DBT" adı altında yapabileceği hatalar hastanın hayatı için tehlikelidir.

EMDR: EMDR Europe

EMDR Europe — 41 ülkeden 37.000 üyesi olan bir Avrupa kuruluşudur. EMDR'de üç düzeyli bir akreditasyon sistemi bulunmaktadır:

Tablo 13. EMDR Europe akreditasyon düzeyleri

Düzey	Gereklilikler
Uygulayıcı uzman (İng. Practitioner)	Klinik eğitim + EMDR Europe'un akredite ettiği eğitmen tarafından verilen eğitim (1. ve 2. düzey eğitim, toplamda yaklaşık 50 saat) + süpervizyonlu uygulama (süpervizyon altında 10 saat, asgari 50 EMDR seansı ile)
Konsültan/Süpervizör (İng. Consultant)	Practitioner statüsü + ek eğitim + 3 yıl aktif EMDR pratiği + danışanlarla 50 saat süpervizyon yürütülmesi
Eğitmen (İng. Trainer)	Consultant statüsü + EMDR Europe Eğitmen Akreditasyon Komitesi (İng. EMDR Europe Trainer Accreditation Committee) tarafından değerlendirme

Kaynak: EMDR Europe Akreditasyon Komitesi (İng. EMDR Europe Accreditation Committee), 2024.

Göz hareketleriyle duyarsızlaştırma ve yeniden işleme (EMDR) konusundaki Avrupa derneğinin (İng. EMDR Europe) Azerbaycan'daki durumu: Azerbaycan bu kuruluşun akredite edilmiş ulusal dernekler listesinde değildir. Aynı şekilde Azerbaycan'da bireysel EMDR akreditasyonu elde etmek için tek yol komşu ülkedeki (örneğin, Türkiye'deki) akredite edilmiş kuruluş aracılığıyladır.

Avrupa Birliği'nde genel düzenleme durumu

Avrupa Davranış ve Bilişsel Terapiler Derneği'nin (EABCT) resmî tutumu önemli bir noktayı vurgulamaktadır: "Avrupa düzeyinde psikolojik terapilerin uygulanmasını düzenleyen bir mevzuat bulunmamaktadır. Hâlihazırda Avrupa Birliği'nde psikoterapiyi düzenleyen veya denetleyen resmî bir Avrupa organı yoktur. Bu düzenleme eksikliği EABCT'nin temel endişe kaynaklarından biridir."

Bu, Avrupa Birliği çerçevesinde bile psikoterapinin mesleki düzenlemesinin ulusal düzeyde gerçekleştirildiği anlamına gelir. Bazı ülkelerde (Almanya, Hollanda, Avusturya) güçlü bir devlet lisanslama sistemi bulunmaktadır. Diğer ülkelerde ise bu sistem daha zayıftır. Bu koşullarda mesleki standartların tek güvencesi uluslararası mesleki akreditasyon kuruluşlarıdır: Uluslararası Psikanalitik Derneği (IPA), Avrupa Davranış ve Bilişsel Terapiler Derneği (EABCT), Diyalektik Davranış Terapisi Sertifikasyon ve Akreditasyon Kurulu (DBT-LBC), EMDR Europe.

Azerbaycan'daki durum

Durum objektif bir değerlendirme gerektirmektedir.

Devlet düzenlemesi

Azerbaycan Cumhuriyeti'nde psikoterapötik faaliyet için özel bir devlet lisanslama sistemi bulunmamaktadır. Tıp alanındaki devlet lisanslaması psikiyatriyi kapsamaktadır, ancak psikoterapi ve psikolojik danışmanlık alanları ayrıca düzenlenmemektedir. Bu, mevzuat açısından özel bir psikoterapötik eğitimi olmayan psikoloğun da lisanslı bir klinik psikiyatrın da aynı hukuki statüde "psikoterapist" olarak hizmet sunabileceği anlamına gelir. Bu boşluk, mesleki akreditasyona duyulan ihtiyacı Azerbaycan koşullarında daha da artırmaktadır.

Uluslararası akreditasyon durumu:

Yukarıda belirtilen uluslararası kuruluşların hiçbirinde — IPA, EABCT, DBT-LBC, EMDR Europe — Azerbaycan'ın akredite edilmiş ulusal derneği bulunmamaktadır. Bu, objektif bir gerçektir ve açık kaynaklarda (eabct.eu, ipa.world, dbt-lbc.org, emdr-europe.org) doğrulanabilir.

Uluslararası psikiyatri kuruluşları açısından durum:

Azerbaycan'da uluslararası düzeyde doğrulanmış tek meslek kuruluşu — Azerbaycan Psikiyatri Derneği'dir (AZPA; psychiatry.az). AZPA, Dünya Psikiyatri Birliği'nin (İng. World Psychiatric Association) tam üyesidir. Bu, uluslararası sağlık camiasında AZPA'nın meşruiyetini açıkça teyit etmektedir.

Dünya Psikiyatri Birliği (İng. World Psychiatric Association, WPA) — wpanet.org bilgisine göre 145'ten fazla ulusal psikiyatri derneğini bir araya getiren uluslararası bir kuruluş — katı üyelik gerekliliklerine sahiptir: ulusal dernek resmî statüde olmalı, açık meslek standartlarına uymalı, düzenli raporlar sunmalıdır. Azerbaycan Psikiyatri Derneği (AZPA) bu koşulları yerine getirmektedir.

Diğer kuruluşların durumu:

Azerbaycan'da psikoloji ve psikoterapi alanında faaliyet gösteren bir dizi kâr amacı gütmeyen kuruluş bulunmaktadır. Bunlardan bazıları kendi web sitelerinde “uluslararası işbirliği”, “dünya kongreleri”, “uluslararası akreditasyon” gibi ifadeler kullanmaktadır. Bu iddiaların uluslararası kaynaklar aracılığıyla doğrulanması birçok durumda olumlu sonuç vermemektedir.

Bu nedenle bölümde söz konusu kuruluşların adları anılmamaktadır — amaç tartışma değil, klinik uygulama için güvenilir çerçeveyi göstermektir. Herhangi bir kuruluşun meşruiyetini araştırmak isteyen uzman ya da hasta aşağıdaki nesnel kaynakları inceleyebilir:

eabct.eu/training-and-accreditation/accredited-association/ — Bilişsel Davranışçı Terapi (BDT) alanında akreditasyon

ipa.world — psikanalitik akreditasyon konusunda resmî bilgi kaynağı

dbt-lbc.org — Diyalektik Davranış Terapisi Alanında Sertifikasyon ve Akreditasyon Kurulu (DBT-LBC)

emdr-europe.org — EMDR akreditasyonu

wpanet.org — Dünya Psikiyatri Birliğinin resmî sitesi

Uzmanı nasıl ayırt etmeli?

Hasta ya da genç bir uzman “uluslararası sertifika” iddiasıyla karşılaştığında aşağıdaki sorular büyük önem taşımaktadır:

1. Sertifika hangi kurum tarafından verilmiştir?

Doğrulamanın ilk adımı — sertifikayı veren kuruluşun yukarıda sayılan uluslararası kurumlardan biriyle resmî ilişkisi olup olmadığını kontrol etmektir. "Uluslararası sertifika" ifadesi tek başına hiçbir anlam ifade etmez; önemli olan hangi uluslararası kurumun sertifikası olduğudur.

2. Eğitim ne kadar sürmüştür?

Yukarıda gösterilen bilgilere bakınız. Bir haftalık ya da bir aylık "uluslararası sertifika" — hiçbir tanınmış akreditasyon gerekliliğini karşılamaz. Uluslararası Psikanalitik Derneğe (IPA) üyelik en az 4 yıl, EABCT bireysel akreditasyonu 3–4 yıl, DBT-LBC sertifikası 12 ay kesintisiz deneyim gerektirir — bunlar kuşku uyandırmayan en kısa sürelerdir.

3. Süpervizyon öngörülüyor mu?

Bütün ciddi akreditasyon sistemlerinde süpervizyon temel bir yere sahiptir. Sertifika sahibinin kaç saat süpervizyonlu klinik çalışma yaptığı öğrenilmelidir. Süpervizyonlu çalışma olmadan verilen sertifika — akademik sertifika olur (kursun tamamlanması gibi), klinik yetkinlik sertifikası değildir.

4. Sürekli mesleki gelişim (İng. continuing professional development, CPD) gerekli midir?

Akreditasyonlar belirli bir süre sonra yenilenmelidir. EABCT 5 yılda bir, DBT-LBC 4 yılda bir, EMDR Europe ise 5 yılda bir yenileme talep etmektedir. "Bir kez alınmış ömürlük sertifika" — ciddi mesleki standartların bulunmamasının belirtisidir.

5. Yerel ruh sağlığı kuruluşları — uluslararası tanınmanın kanıtı olabilir mi?

Yerel bir psikolog ya da psikoterapistin kulübe, derneğe üyeliği — bu tek başına uluslararası tanınma değildir. Bu tür bir kuruluşun kendisi uluslararası akredite edilmiş bir kuruma üye mi? Asıl soru budur.

Kitabın bu koşullardaki yeri

Bu kitap uluslararası akreditasyonun yerine geçmez — akreditasyona hazırlık aracı olarak öngörülmüştür. Kitap, uzmana klinik tanı, kanıta dayalı müdahaleler, yapılandırılmış protokoller ve klinik düşünme için güvenilir bir çerçeve sunmaktadır.

Uzman, bu kitaptaki protokoller ve tartışma temelinde kendi uygulamasını şekillendirdikten sonra resmî mesleki eğitim (Türkiye, Gürcistan, Almanya ya da diğer ülkelerde akredite edilmiş kuruluşlar aracılığıyla) için sağlam bir temel elde etmiş olur. Ayrıca bu kitap hastalar için — aldıkları yardımın kalitesini

değerlendirmek, doğru soruları sormak, kanıta dayalı tedavi talep etmek için ilk yönlendirici rolü oynayabilir.

Bir sonraki bölüm — bu Önsözün son kısmı — bu kitabın gerçekten neden şimdi ve neden Azerbaycan'da gerekli olduğunu açık biçimde gerekçelendirmektedir.

6A00–6A0Z NÖROGELİŞİMSEL BOZUKLUKLAR

Neurodevelopmental disorders

ICD-11 **6A00**	**6A00 BİLİŞSEL GELİŞİM BOZUKLUKLARI** **Disorders of intellectual development**
ICD-10 F70–F79	Zihinsel yetersizlik
DSM-5-TR F70–F73	Anlıksal Yetersizlik

1. Tanım ve nozoloji

Bilişsel gelişim bozukluğu (ICD-11: 6A00 Disorder of Intellectual Development; DSM-5-TR: F70–F73 Zihinsel Gelişim Bozukluğu / önceki "Mental Retardasyon") — gelişim döneminde (genellikle 22 yaşına kadar) başlayan, hem entelektüel fonksiyonlarda (yaklaşık 2 standart sapma ortalamanın altında, standartlaştırılmış testlerde puan ~70'ten az), hem de uyum sağlayıcı davranışta (kavramsal, sosyal, pratik alanlarda) önemli kısıtlılıklarla karakterize nörogelişimsel bozukluktur.

"Mental retardation" terimi 2010'dan itibaren uluslararası bilim topluluğu tarafından damgalama ve kesinsizlik nedeniyle terk edilmiştir (ABD'de Rosa's Law 2010 federal yasa düzeyinde değişikliği gerçekleştirmiştir).

2. Tarihçe

- Esquirol (1838) "idiotie" terimi ile doğuştan gelen entelektüel sınırlılık, demanstan (kazanılmış bozulma) ayırt edilmiştir.
- Binet & Simon (1905) ilk standartlaştırılmış zeka ölçeği — IQ kavramının ortaya çıkışı (Stern 1912 IQ formülü).
- AAMR/AAIDD (1959, 1973, 1992, 2002, 2010, 2021): tanımın evrimi — yalnızca IQ'dan uyumsal davranış + destek gereksinimi modeline geçiş. AAIDD 12. baskı (2021) entelektüel işlev + uyumsal davranış + gelişim döneminde başlama + bireysel destek gereksinimlerinin değerlendirilmesi.

- DSM-IV (1994) “Mental Retardation” → DSM-5 (2013) “Intellectual Disability (Intellectual Developmental Disorder)”. Şiddet temel alınma bazı IQ'dan uyumsal işleve kaydırılmıştır.
- ICD-11 (2019) “Disorders of Intellectual Development” — ICD-10'daki “Mental Retardation” (F70–F79) grubu yeniden adlandırıldı, klinik ve uyumsal ölçü birlikte vurgulanıyor.

3. Epidemiyoloji

- Yaygınlık: Genel popülasyonda ~%1 (Maulik P.K. et al. Res Dev Disabil 2011 meta-analiz, 52 çalışma); düşük ve orta gelirli ülkelerde oran daha yüksektir.
- Şiddet sınıflaması: ~%85 hafif, ~%10 orta, ~%3,5 ağır, ~%1,5 derin.
- Cins: Erkeklerde daha sık (1,2–1,9 : 1), X'e bağlı genetik nedenlerle (örneğin, Fragile X) ilişkili.
- Komorbidite: epilepsi %20–30, motor bozukluklar %20–40, görme/işitme bozuklukları %10–25; psikiyatrik komorbidite popülasyon oranından 3–4 kat yüksek (OSB, DEHB, anksiyete, davranış bozuklukları).
- Mortalite: ağır ve derin formalarda beklenen yaşam süresi kısalır — başlıca aspirasyon pnömonileri, status epileptikus ve kardiyovasküler anomaliler nedeniyle.

4. Etiyoloji ve patogenez

4.1 Genetik nedenler (%50–60 tanımlanabilir)

- Kromozom anomalileri: Down sendromu (Trizomi 21) — en sık genetik neden, ~1/700 doğum; Edwards (T18), Patau (T13), 22q11.2 delesyonu (DiGeorge), Williams (7q11.23), Prader-Willi/Angelman (15q11-q13), Cri-du-chat (5p-).
- X-bağlı: Fragile X sendromu (FMR1 geni, CGG tekrarları) — kalıtsal en sık form, ~1/4000 erkek çocukta; Rett sendromu (MECP2, neredeyse her zaman kızlarda).
- Tek gen bozuklukları: tüberoz skleroz (TSC1/TSC2), nörofibromatoz (NF1), fenilketonüri (PAH — tedavi edilebilir), Wilson hastalığı.
- CNV (kopya sayısı değişiklikleri): mikroarray analizi ile saptanır — bilinmeyen etiyolojili vakalarda %10–20.

4.2 Prenatal genetik olmayan nedenler

- Enfeksiyöz: TORCH (toksoplazma, rubella, sitomegalovirus, herpes), Zika, sifilis.
- Toksik: Fetal alkol spektrum bozuklukları (FASD — önlenebilir neden!), gebelikte valproat, izotretinoin, kokain, kurşun.
- Metabolik ve endokrin: ebeveynde tedavisiz hipotiroidi, ağır diyabet, fenilketonüri.
- İskemik/hipoksik: plasenta yetmezliği, intrauterin gelişme geriliği.

4.3 Perinatal nedenler

- Şiddetli preterm (<32 hafta), düşük doğum ağırlığı (<1500 gr).
- Doğum asfiksisi, hipoksik-iskemik ensefalopati.
- Yenidoğan kernikterus (tedavi edilebilir — fototerapi).
- Yenidoğan sepsis, menenjit.

4.4 Postnatal nedenler

- Bakteriyel menenjit (özellikle pnömokok, meningokok), viral ensefalit.
- Baş travması (TBİ) — çocukluk döneminde.
- Kurşun zehirlenmesi — önlenebilir neden (CDC'nin kan kurşunu referans değeri 2021'den beri 3,5 mcg/dl, önceden 5 mcg/dl; çocuklarda güvenli kan kurşunu düzeyi belirlenmemiştir).
- Ağır iyot eksikliği (endemik kretenizm — DSÖ önleme programları ile hemen hemen ortadan kaldırılmıştır)
- Sosyo-ekolojik yoksunluk — aşırı ağır psikolojik ihmal gelişimi etkileyebilir (Romanya yetimhane çalışmaları, Nelson C.A. et al. Science 2007).

5. Klinik özellikler

Şiddet sınıflaması (DSM-5-TR / ICD-11 — adaptif işlev temelli)

Hafif (mild) — IQ ~50–70, adaptif defisit hafif

Akademik gecikme okul öncesinde fark edilmeyebilir. Okuma, matematik, soyut düşünme zordur. Sosyal saflık, kolayca kandırılabilir. Pratik beceriler (öz bakım, ev işleri) tamamlanır. Bağımsız yaşam destekle mümkündür, destekli iş için uygundur.

Orta (moderate) — IQ ~35–49

Erken çocuklukta gecikme görülür. Basit konuşma, somut düşünce. Öz bakım eğitimle kazanılır. Yapılandırılmış sosyal-iş ortamında işlevsellik. Denetimli yaşam (group home, aile) tipiktir.

Şiddetli (severe) — IQ ~20–34

Çok az konuşma, basit talepleri anlar. Kendi bakımında sürekli yardım. Tıbbi ve davranışsal komorbidite sıktır.

Ağır (profound) — IQ < 20

Çok az veya hiç konuşma, sensorimotor düzeyde iletişim. Tam bakım gerektirir. Motor, görme, işitme ile ilgili bozukluklar çok sık.

Gelişim yörüngesi: erken motor ve konuşma gecikmeleri (oturma, ayakta durma, ilk kelimeler); okul çağında akademik kısıtlılık; yetişkinlikte adaptif gereksinimlerin artmasıyla fark daha belirgin hale gelir.

6. Tanı

6.1 Birleşik tanı ölçütleri (DSM-5-TR · ICD-11 · AAIDD 12e konsensus noktaları)

A. Entelektüel fonksiyonda önemli kısıtlama — standartlaştırılmış, kültürel-bağlama uyarlanmış zekâ testinde ortalama seviyeden yaklaşık 2 standart sapma düşük sonuç (puan ~70 veya daha az, ölçüm hatasının ±5 puan dikkate alınmasıyla).

B. Uyumsal davranışta belirgin sınırlılık — aşağıdaki üç alanın en az birinde 2 SD altında sonuç:

- Kavramsal (dil, okuma, yazma, matematik, hafıza, problem çözme);
- Sosyal (kişilerarası beceriler, sosyal sorumluluk, saflık sorunları);
- Pratik (öz bakım, iş, sağlık, güvenlik).

C. Başlangıç gelişim döneminde — semptomlar çocukluk ve ergenlikte belirgindir (yetişkinlik yaşına kadar).

D. Dışlamalar — duyusal (görme, işitme) bozukluğu, motor bozukluk, dil kökeni, kültürel-dil bariyeri veya psikiyatrik bozukluk ile tam olarak açıklanmaz.

6.2 Kaynaklar arasındaki farklar

- DSM-5-TR (319): Şiddet uyumsal işleve göre belirlenir, IQ yalnızca ek gösterge olarak not edilir. Başlangıç "gelişim döneminde" (18 yaşa kadar kastedilir, ancak AAIDD'nin 22 yaş tanımı kabul edilebilir).
- ICD-11 (6A00): hafif, orta, ağır, derin (aynı terminoloji); şiddet hem IQ hem uyumsal işleve göre birlikte değerlendirilir; ek niteleyiciler — etiyoloji (genetik, prenatal, perinatal, postnatal, bilinmeyen) ve komorbiditeler.
- AAIDD 12e (Schalock R.L. et al. 2021): destek gereksinimlerinin formal değerlendirmesi (SIS — Supports Intensity Scale) klinik formülasyona dahil

edilir; başlangıç yaşı 22'ye kadar (DSM'den farklı olarak); entelektüel işlev dışlanmaya değil, desteklenen süreçlere yönelir.

- AAP (Moeschler J.B., Shevell M.S., Pediatrics 2014, reaffirmed 2020): tanı konulduktan sonra Etiyoloji araştırması aşamalı — birinci sıra: öykü, fizik muayene (dismorfik belirtiler), kromozomal mikroarray, Fragile X, tedavi edilebilir metabolik tarama (PKU, biotinidaz, tiroid, karaciğer, böbrek); seçici: beyin MRG, EEG, geniş ekzom sekanslama (WES).

6.3 Tanı algoritması

1. Gelişim öyküsü (doğuştan, perinatal, postnatal) + aile öyküsü (3 kuşak).
2. Fizik muayene — boy, baş çevresi, dismorfik bulgular, nörolojik, cilt (cafe-au-lait, hipopigmentasyon).
3. Standardize edilmiş entelekt testi (WISC-V 6–16 yaş; Stanford-Binet 5 2+ yaş; Bayley-III <3,5 yaş).
4. Uyumsal davranış değerlendirmesi (Vineland-3, ABAS-3).
5. Görme ve işitme testleri (duyusal bozukluk dışlaması).
6. Etiyolojik birinci sıra laboratuvar — kromozomal mikroarray analizi (CMA), Fragile X (FMR1), TSH, kurşun düzeyi, karaciğer/böbrek, kreatin ve amino asit profili.
7. Seçici: beyin MRG (mikrosefali, fokal nörolojik bulgularda), EEG (epilepsi şüphesi), trio ekzom sekanslama (CMA negatif olduğunda).
8. Komorbid tarama: OSB (M-CHAT-R/F, ADOS-2), DEHB (Conners), anksiyete, depresyon, davranış bozukluğu.

6.4 Ayırıcı tanı

Bozukluk	**Ayırt edici belirtiler**
Spesifik öğrenme bozukluğu (6A03)	Akademik alanda ayrık defisit, genel bilişsel düzey normal.
Özgül dil bozukluğu (6A01)	Konuşma ve dil alanında ileri düzeyde defisit; sözel olmayan IQ normal.
Otizm spektrum bozukluğu (6A02)	Sosyal iletişim defisiti ve sınırlı tekrarlayan davranış temel; IQ aralığı geniş.
Global gelişim geriliği (<5 yaş)	5 yaşına kadar geçici tanı; standart IQ testleri güvenilir değil.

Bozukluk	Ayırt edici belirtiler
Demans (6D8x)	Edinilmiş bozulma — önce normal gelişim, sonra zayıflama.
Sosyal-ekolojik deprivasyon	Uyarıcı ortamda entelektüel işlev geri kazanılabilir.
Sahte entelektüel zayıflık (kronik hastalık, depresyon)	Duygudurum veya somatik faktörün düzeltilmesinden sonra bilişsel işlev düzelir.

7. Muayene ve değerlendirme

7.1 Standardize testler

- Zekâ: WISC-V (6–16 yaş), Stanford-Binet 5 (2+), WAIS-IV (16+), Bayley Scales of Infant Development 4 (<3,5 yaş), Kaufman ABC-II.
- Uyumsal davranış: Vineland-3, ABAS-3, Scales of Independent Behavior-Revised.
- Destek talebi: SIS-A (yetişkinler), SIS-C (çocuklar) — AAIDD.

7.2 Laboratuvar incelemeleri (AAP 2014 / 2020 protokolü)

Birinci basamak (tüm durumlar): tam kan, karaciğer ve böbrek fonksiyonu, TSH, kreatinin, amonyak, laktat, kreatin ve amino asit profili (idrar ve kan), kurşun düzeyi.

Birinci basamak genetik: chromosomal microarray analysis (CMA — verim %15 –20), Fragile X (FMR1) tüm erkeklerde (verim ~%2, kadınlarda ~%1).

Seçici: trio ekzom sekanslama (WES — yield %25–40 CMA negatif olduğunda), MECP2 (Rett şüphesi kızlarda), spesifik sendromal genler.

7.3 Enstrümantal incelemeler

- Beyin MRG — fokal nörolojik belirtiler, mikro/makrosefali, nöbetler, regresyon durumlarında.
- EEG — tutma şüphesi, regresyon.
- Görme ve işitme — tüm vakalarda ilk değerlendirmeler.
- Kalp EKO ve EKG — Down ve 22q11.2 delesyonu gibi sendromlarda.

8. Tedavi

8.1 Genel prensipler (AAIDD 12e · AAP 2014 · NICE NG54 · WHO mhGAP konsensus)

1. Entelektüel gelişim bozukluğunun "tedavisi" yoktur — entelektüel işlev kendi başına farmakolojik yolla geri kazanılmaz. Müdahale Bireysel destek, eğitim, davranış ve komorbid semptomların yönetimine yönelir.
2. Etiyoloji tanımlaması: tedavi edilebilir nedenlerin (PKU, konjenital hipotiroidi, kurşun, biyotinidaz eksikliği) erken saptanması kritiktir — yenidoğan tarama programlarının temeli.
3. Erken müdahale (0–3 yaş): kanıt temeli en güçlü dönemdir (IDEA Part C ABD'de; tüm gelişmiş ülkelerde benzer programlar). Sosyal ve kognitif sonuçları iyileştirir.
4. Bireyselleştirilmiş eğitim planı (BEP): okulda akademik ve adaptif hedefler; AAIDD destek ihtiyacı temelli yaklaşım.
5. Davranış müdahaleleri: Applied Behavior Analysis (ABA) ve pozitif davranış desteği (PBS) — zorlu davranışların azaltılmasında ve yeni becerilerin geliştirilmesinde etkilidir.
6. Aile desteği: psikoeğitim, respite care, akran destek grupları, sosyal hizmet koordinasyonu.
7. Komorbidite tedavisi: epilepsi (standart antiepileptik), DEHB (stimülanlar; Cortese 2018 ağ meta-analizi çocuklarda metilfenidatı birinci seçim gösteriyor, ancak komorbid bozukluklu çalışmaları dışlamıştı — İD zemininde kanıt tabanı ayrı ve daha sınırlıdır), anksiyete/depresyon (SSRI düşük dozda başla), agresyon (davranış müdahalesi birinci sıra; risperidon veya aripiprazol yalnızca ağır vakalarda — FDA onayı OSB'de irritabilite için: risperidon 5–16 yaş, aripiprazol 6–17 yaş; İD için resmi onay yok, kanıt temeli sınırlı).
8. Tıbbi takip: Down sendromunda — tiroid, kalp, işitme, atlanto-aksiyel instabilite (AAP Health Supervision for Children with Down Syndrome 2022).
9. Yetişkinlikte geçiş: destekli iş (IPS modeli), bağımsız yaşam seçenekleri, sosyal-tıbbi hizmet koordinasyonu.

8.2 Tedavi metodolojileri

1. Uygulamalı Davranış Analizi (UDA / ABA — Applied Behavior Analysis) — Davranışın işlevsel analizi temelinde belirli hedef-davranışların oluşturulması ve azaltılması; öncül-davranış-sonuç (ABC) çerçevesi, ayrık-deneme eğitimi (DTT), naturalistik davranış müdahaleleri. Etki: uyumsal

beceri kazanımında ve zorlu davranışın azaltılmasında orta-yüksek etki büyüklüğü, özellikle otizm ve İD komorbid durumlarda (Eldevik S. ve ark. J Clin Child Adolesc Psychol 2009 meta-analiz). Tüm aşamalarda ev, okul, toplum ortamına uyarlanabilir.

2. Erken Müdahale (Early Intervention, 0–3 yaş) — Multidisipliner (gelişim, fiziksel, uğraşı, konuşma terapileri + aile eğitimi) ev veya merkez tabanlı programlar. Kanıt: Carolina Abecedarian Project (Ramey C.T., Campbell F.A. — 30+ yıllık izlem) düşük gelirli çocuklarda IQ artışı, akademik ve istihdam sonuçlarını iyileştirmiştir. IDEA Part C.
3. Bireyselleştirilmiş Eğitim Planı (BEP / IEP — Individualized Education Program) — Akademik ve uyumsal hedefler, destek önlemleri, değerlendirme aralıklarını belgeleyen yasal belge. ABD'de IDEA kapsamında zorunlu, benzer çerçeveler diğer ülkelerde (Birleşik Krallık — EHCP).
4. Pozitif Davranış Desteği (PDD / PBS — Positive Behavior Support) — Zor davranışların fonksiyonel analizi ve davranışın yerine koyulması (aynı işlevli uygun davranış öğretmek). Cezalandırma yok, çevre değişikliği ve yeni beceriler. NICE NG11 (2015) zor davranışın yönetiminde birinci basamak.
5. Vineland Uyumsal Davranış Ölçeği-3 (Vineland-3 — Vineland Adaptive Behavior Scales-3) — Uyumsal davranışın "altın standart" değerlendirmesi — iletişim, günlük yaşam, sosyal, motor alanları. Görüşme (ebeveyn/bakıcı) ve öğretmen formları.
6. WISC-V / Stanford-Binet 5 — Standartlaştırılmış zeka testleri; WISC-V — 6–16 yaş, 5 temel indeks (sözel, görsel-uzamsal, soyut düşünme, çalışma belleği, işlem hızı); Stanford-Binet 5 — 2 yaştan yetişkinliğe.
7. Destek Yoğunluğu Ölçeği (SIS — Supports Intensity Scale, AAIDD) — Destek ihtiyacının yoğunluğunu ölçen ölçek; SIS-A yetişkinler, SIS-C 5–16 yaş için. Klinik planlama ve hizmet tahsisi için.

8.3 Kaynaklar arasındaki farklar

- AAIDD 12e (2021): "destek modeli" — her bozukluk derecesi için değil, bireyin destek ihtiyacına uygun planlama; aralıklı, sınırlı, kapsamlı, her yönüyle destek kategorileri.
- AAP 2014/2020: komorbidite (otizm, DEHB, davranış) tarama aralıkları ve tedavi algoritmaları; Down sendromu için ayrı AAP 2022 protokolü.
- NICE NG54 (2016) — Öğrenme güçlüğü olan kişilerde ruh sağlığı sorunları: psikiyatrik komorbiditenin tanı ve tedavisi; davranış müdahalesi birinci sıra; psikotrop ilaçların non-spesifik kullanımı önerilmez — bu, popüler "güvenli" pratiktir, ancak yan etki yükü ve etkileşim riski yüksektir.

- WHO mhGAP Intervention Guide v2.0: düşük ve orta gelirli ülkelerde birinci basamak sağlık hizmeti düzeyinde değerlendirme ve temel müdahale; aile eğitimi ve toplum temelli rehabilitasyon vurgulanır.

9. Prognoz

İyi prognoz faktörleri

- Hafif şiddet (~%85 tüm İD); entelektüel ve adaptif işlevde yakın düzey.
- Tedavi edilebilir etiyoloji (PKU, konjenital hipotiroidi, kurşun) — erken tespit.
- Erken müdahale (<3 yaş).
- Stabil ve destekleyici aile ortamı.
- Komorbid psikiyatrik ve medikal durumun aktif tedavisi.
- Toplum ve okul kaynaklarının erişilebilirliği.

Kötü prognoz etkenleri

- Derin veya ağır şiddet.
- Genetik sendrom kompleks fenotiple (epilepsi, kalp anomalileri, motorik).
- Ağır davranış bozuklukları, kendine zarar verme.
- Aile desteğinin ve toplum kaynaklarının olmaması.
- Tanımlanmamış ve tedavi edilmemiş komorbidite (epilepsi, OSB, DEHB).

İzlem hedefleri

- Uyumsal gelişimin yıllık yeniden değerlendirilmesi.
- Tıbbi takip — sendrom-spesifik protokollere göre (örn. AAP Down 2022)
- Komorbid psikiyatrik durum (OSB, DEHB, anksiyete, depresyon) taraması.
- Davranış bozukluklarının fonksiyonel analizi ve müdahalesi.
- Yetişkinlikte destekli iş ve yaşam seçenekleri için geçiş planlaması.
- Aileye mola bakımı ve akran desteği önerisi.

10. Mit ve yanlış inançlar

10.1 Etiyoloji mitleri

Mit 1: "Zihinsel yetersizlik ebeveynin suçudur / cezasıdır"

Neden yaygınlaştı: kültürel ve dini-ahlaki açıklama çerçevesi; "günah işleyen evlat" imgesi; düşük eğitimli toplumlarda ebeveyne (özellikle anneye) suçlama mekanizması.

Biyolojik mantık ve kanıt: İD'nin etiyolojisi geniş bir yelpazededir — genetik (Down, Fragile X), prenatal enfeksiyonlar, fetal alkol spektrumu (tek ebeveyn müdahalesiyle tamamen önlenebilir), perinatal asfiksi, postnatal travma veya menenjit. AAIDD, WHO, APA pozisyonu — İD biyomedikal ve/veya gelişimsel etyolojik bozukluktur, ahlaki değerlendirme konusu değildir.

Gerçek klinik adım: Etiyoloji araştırması (genetik konsültasyon, sendromik ve metabolik tarama) — suçlamayı tekrar gebelik için kesin risk hesaplamasına dönüştürür.

Mit 2: "Aşılar (özellikle MMR) İD yaratır"

Neden yaygınlaştı: Wakefield A.J. Lancet 1998 — daha sonra sahtekarlık nedeniyle geri çekilmiş araştırma, otizmi MMR ile ilişkilendirmeye çalışmıştı (İD'yi değil, ancak kitlesel inançta her iki durum karıştırılır).

Kanıt: Taylor L.E., Swerdfeger A.L. ve ark. Vaccine 2014 meta-analiz n>1,2 mln çocuk — aşı ile otizm veya İD arasında ilişki yoktur. CDC, WHO, NICE pozisyonu aynıdır. Down sendromu 21. kromozomun mayoz sırasında ayrılmamasından (nondisjunction, çoğunlukla anne mayoz I) kaynaklanır — mekanik olarak aşı ile ilişkili olamaz.

Mit 3: "Gebelikte 'stres' ya da 'kötü düşünceler' İD'ye neden olur"

Kanıt: psikolojik stres prenatal dönemde nörogelişim için mütevazı bir risk faktörü olabilir, ancak İD'ye doğrudan neden olarak gösterilmez. Belirlenmiş prenatal riskler — alkol (FAS — en önlenebilir neden), valproat, enfeksiyonlar (TORCH), besin eksikliği (iyot, folat). Stresin azaltılması genel sağlık için faydalıdır, ancak "doğru düşünceler" değil belirli tıbbi koruyucu adımlar (aşılama, alkolden kaçınma, perinatal bakım) etkilidir.

10.2 Zararlı "tedavi" yöntemleri

Mit 4: "Şelasyon terapisi ağır metalleri çıkararak İD'yi iyileştirir"

Neden yaygınlaştı: "ağır metaller" konseptinin kitle medyasında genişlemesi; alternatif tıp merkezlerinin pazarlaması.

Kanıt ve risk: AAP 2010 ve FDA uyarısı: 2005 yılında Şelasyon prosedürü sırasında 5 yaşında bir çocuk vefat etmiştir (kalsiyum eksikliği nedeniyle kalp durması). Şelasyon yalnızca doğrulanmış ağır metal zehirlenmesinde (yüksek kurşun, cıva) tıbbi endikasyonla uygulanır. İD için etki kanıtı yoktur.

Mit 5: "Kök hücre enjeksiyonları (resmi olmayan kliniklerde) İD'yi iyileştirir"

Kanıt ve risk: ISSCR (International Society for Stem Cell Research) ve FDA pozisyonu: İD'de (ve genel olarak nörogelişimsel bozukluklarda) onaylanmış kök hücre tedavisi yoktur. Yasa dışı "klinikler" enfeksiyonlar, beyin tümörleri, ölüm vakaları ile seyreden ciddi yan etkilere neden olmuştur (Berkowitz A.L. et al. NEJM 2016).

Mit 6: "Hiperbarik oksijen odası (HBOT) İD'nin ve otizmin tedavisidir"

Kanıt: Cochrane (Xiong T. ve ark. 2016) — otizm için etki kanıtı yoktur; ZG için de kanıt temeli yoktur. Riskler: pnömotoraks, kulak barotravması, yangın (oksijen + statik elektrik).

Mit 7: "Mucizevi Mineral Solüsyon (MMS) / klor dioksit"

Kanıt: FDA 2019, EMA uyarısı — kostik (klor dioksit), karaciğer ve böbrek hasarı, ölüm vakaları kaydedilmiştir. Tüm klinik kullanım yasaktır.

10.3 Etkisiz veya temel desteği geciktiren yöntemler

Mit 8: "B vitamini kompleksi / niasin mega-dozları İD'de bilişsel işlevi geri kazandırır"

Kanıt: "Ortomoleküler" psikiyatri yaklaşımı (Hoffer A., Osmond H. 1950–70) İD ve otizmde etkililik göstermemiştir. Pfeiffer S.I. ve ark. (J Autism Dev Disord 1995) B6/magnezyum üzerine 12 çalışmayı incelemiş ve metodolojik kusurlar nedeniyle kesin bir sonuca varamamıştır (bkz. Nye C., Brice A. Cochrane 2005 — aynı sonuç); niasin mega-dozları ise ayrı bir konudur — karaciğer hasarı ve hiperürisemi yaratır. AAP, AAIDD ikisini de önermez.

Mit 9: “Patterning” (Doman-Delacato yöntemi)

Neden yaygınlaştı: 1960–80'lerde kitlesel popülerlik kazanmıştır; “beyni yeniden programlama” iddiası.

Kanıt: AAP 1968 ve 2010 ayrı Statementleri: etkinlik kanıtı yoktur; aileye fazla zahmet ve emosyonel yük; çocukları diğer kanıtlı müdahalelerden geri tutar. AAP — kesin öneri etmez.

Mit 10: “Auditory Integration Training (AIT)”

Kanıt: ASHA (American Speech-Language-Hearing Association) Position Statement 2004 — AIT'in İD ve otizmde etki kanıtı yoktur; deneysel müdahale olarak kabul edilir.

Mit 11: “İD kendi kendine geçer, eğer çocuk uyarılırsa”

Gerçeklik: genel olarak, erken müdahale adaptasyonu iyileştirir, ancak İD bir durum değil, nörogelişimsel bozukluktur — etiyolojisi genetik veya yapısal olduğunda entelektüel yetenek önemli ölçüde değişmez. Bazı özel nedenler (PKU, konjenital hipotiroidi) erken tespit edilerek tamamen önlenebilir — bu, “geçmesi” değil, zamanında önlenmesidir.

Gerçek klinik adım: AAIDD destek modeli — bozukluğun ortadan kaldırılması amaç değil, anlamlı ve bağımsız yaşamın sağlanması; aileye realist beklentilerle destek.

Mit 12: “Ebeveyn özel diyet uygularsa (glutensiz, kazeinsiz) İD düzelir”

Kanıt: Hyman S.L. et al. (AAP 2020 Clinical Report on ASD): gastrointestinal sorunu olmayan çocuklarda özel diyetlerin bilişsel işleve etkisi kanıtlanmamıştır. Çölyak hastalığı kanıtlanmışsa — glutensiz diyet, ancak İD için değil.

11. Kaynaklar

1. Schalock R.L., Luckasson R., Tassé M.J. Intellectual Disability: Definition, Diagnosis, Classification, and Systems of Supports, 12th ed. AAIDD; 2021.
2. American Psychiatric Association. DSM-5-TR. Washington DC: APA Publishing; 2022.
3. WHO. ICD-11 for Mortality and Morbidity Statistics. 6A00 Disorders of Intellectual Development. 2024.
4. Moeschler J.B., Shevell M., Committee on Genetics. Comprehensive evaluation of the child with intellectual disability or global developmental delays. Pediatrics 2014;134(3):e903–e918 (reaffirmed 2020).

5. NICE Guideline NG54. Mental health problems in people with learning disabilities. 2016.
6. NICE Guideline NG11. Challenging behaviour and learning disabilities: prevention and interventions for people with learning disabilities whose behaviour challenges. 2015.
7. WHO mhGAP Intervention Guide for mental, neurological and substance use disorders, version 2.0. Geneva; 2016.
8. Maulik P.K., Mascarenhas M.N., Mathers C.D. et al. Prevalence of intellectual disability: a meta-analysis of population-based studies. Res Dev Disabil 2011;32(2):419–436.
9. Bull M.J. et al. AAP Health Supervision for Children and Adolescents With Down Syndrome. Pediatrics 2022;149(5):e2022057010.
10. Eldevik S., Hastings R.P., Hughes J.C. et al. Meta-analysis of Early Intensive Behavioral Intervention for children with autism. J Clin Child Adolesc Psychol 2009;38(3):439–450.
11. Ramey C.T., Campbell F.A. Carolina Abecedarian Project — long-term outcomes. Applied Developmental Science 2002;6(1):42–57.
12. Nelson C.A., Zeanah C.H., Fox N.A. et al. Cognitive recovery in socially deprived young children: the Bucharest Early Intervention Project. Science 2007;318(5858):1937–1940.
13. Taylor L.E., Swerdfeger A.L., Eslick G.D. Vaccines are not associated with autism: an evidence-based meta-analysis. Vaccine 2014;32(29):3623–3629.
14. Berkowitz A.L., Miller M.B., Mir S.A. et al. Glioproliferative lesion of the spinal cord as a complication of “stem-cell tourism”. NEJM 2016;375(2):196–198.
15. Xiong T., Chen H., Luo R., Mu D. Hyperbaric oxygen therapy for people with autism spectrum disorder. Cochrane Database Syst Rev 2016; (10):CD010922.
16. Hyman S.L., Levy S.E., Myers S.M.; AAP Council on Children with Disabilities. Identification, Evaluation, and Management of Children With Autism Spectrum Disorder. Pediatrics 2020;145(1):e20193447.

ICD-11 **6A01**	**6A01 GELİŞİMSEL KONUŞMA VEYA DİL BOZUKLUKLARI** **Developmental speech or language disorders**
ICD-10 F80	Konuşma ve dil özel gelişimsel bozuklukları
DSM-5-TR F80.2	Dil Bozukluğu

1. Tanım ve nozoloji

Gelişimsel konuşma veya dil bozuklukları — çocuğun işitme, zihinsel veya başka nörolojik nedenlerle tam olarak açıklanamayan, dil ve/veya konuşma ediniminde kalıcı ve önemli zorluklarla ortaya çıkan nörogelişimsel bozukluklar grubudur. ICD-11'de 6A01 kodu altında dört alt tip kodlanır:

- 6A01.0 — Gelişimsel konuşma sesi bozukluğu (developmental speech sound disorder) — konuşma seslerinin artikülasyonu ve fonolojik oluşumunda defisit;
- 6A01.1 — Gelişimsel konuşma akıcılığı bozukluğu (developmental speech fluency disorder) — kekemelik (stuttering);
- 6A01.2 — Gelişimsel dil bozukluğu (developmental language disorder, DLD) — alıcı ve/veya ifade edici dil oluşumunda bozulma (alt-spesifikasyonlar: 6A01.20 alıcı-ifade edici, 6A01.21 esas olarak ifade edici, 6A01.22 esas olarak pragmatik);
- 6A01.3 Diğer spesifikleştirilmiş.

DSM-5-TR'de paralel terminoloji: Language Disorder (F80.2), Speech Sound Disorder (F80.0), Childhood-Onset Fluency Disorder/Stuttering (F80.81), Social (Pragmatic) Communication Disorder (F80.82).

2. Tarihçe

- Specific Language Impairment (SLI) — 1980'lerden 2010'lara kadar kullanılan terim; “spesifik” sözcüğü zamanla eleştirilmiştir, çünkü dil bozukluğu çok sayıda bilişsel ve davranışsal alanla örtüşmektedir.

- CATALISE konsensusu (Bishop D.V.M. et al. PLoS One 2016; J Child Psychol Psychiatry 2017) — 59 uluslararası uzmanın Delfi konsensusu: "SLI" terimi "Developmental Language Disorder" (DLD) ile değiştirilmiştir. Tanı için IQ kesim noktası (≥85) kaldırılmış, işlevsel bozulma esas alınmıştır.
- DSM-5 (2013) ve ICD-11 (2019) — DLD terimi kabul edilmiştir; sosyal-pragmatik iletişim bozukluğu otizm spektrum bozukluğundan ayrı kategori olarak tanınmıştır (DSM-5'te yeni; ICD-11'de 6A01.22 alt-tipi olarak).
- Kekemelik üzerine biyolojik-genetik konsepsiyon 2000'li yıllardan sonra dominant olmuştur (GNPTAB, GNPTG, NAGPA mutasyonları — Kang C. et al. NEJM 2010).

3. Epidemiyoloji

- DLD (6A01.2): 5–6 yaşta yaygınlık %7,58 (Norbury C.F. ve ark. J Child Psychol Psychiatry 2016, popülasyon temelli çalışma, n=7267 İngiltere).
- Konuşma sesi bozukluğu (6A01.0): 6 yaşta ~%3,8 (Shriberg L.D. ve ark. J Speech Lang Hear Res 1999); okul öncesi yaşta daha yüksek.
- Kekemelik (6A01.1): çocuklukta kümülatif insidans %5–8 (yaklaşık her 20 çocuktan biri bir kez kekeler); yetişkinlikte devam eden yaygınlık ~%1 (Yairi E., Ambrose N. J Fluency Disord 2013).
- Cins: tüm alt-tiplerde erkeklerde 2–4 kat yüksek.
- Komorbidite: Öğrenme bozuklukları %40–60, DEHB %20–30, otizm spektrumu %5–10, anksiyete ve davranış bozuklukları artmış risk.

4. Etiyoloji ve patogenez

4.1 Genetik faktörler

- DLD irsiliyi %50–75 ikiz çalışmalarında (Bishop D.V.M. Trends Cogn Sci 2014).
- FOXP2 mutasyonları — KE ailesinde nadir ağır konuşma-dil bozukluğu (Lai C.S. et al. Nature 2001); çoğu durumda poligenik doğa.
- Kekemelik: ~%70 kalıtım (Felsenfeld S. ve ark. Behav Genet 2000 ikiz çalışması); lizozomal yol genlerinde (GNPTAB, GNPTG, NAGPA) mutasyonlar nadiren (~%9) saptanır.
- CNV ve GWAS çalışmaları — poligen risk mimarisi DLD için de karakteristiktir.

4.2 Nörobiyoloji

- Sol perisilviyen (Broca ve Wernicke çevresi), arkuat fasikül ve bazal gangliyon gelişiminde atipik modeller.
- Kekemelikte bazal ganglia – supplementary motor area bağlantısında dopaminerjik disfonksiyon (Maguire G.A. et al. Curr Med Res Opin 2020 derlemesi).
- Erken beyin asimetrisi — DLD'de sol hemisfer dil alanlarının tipik dominantlığının zayıflaması.

4.3 Risk faktörleri

- Ailede dil/konuşma bozukluğu öyküsü (en güçlü risk faktörü).
- Erken doğum, düşük doğum ağırlığı.
- Kronik orta kulak iltihabı (otit) erken çocuklukta — işitme dalgalanması dil edinimini etkileyebilir.
- Sosyo-ekonomik düşük statü — risk faktörü olarak belirtilir, ancak etiyoloji değil; yoksun ortam dil gelişiminin ifadesini etkiler.
- Bilingualizm — risk faktörü DEĞİLDİR (genişletilmiş konu §10).

4.4 Önlenebilir ve tedavi edilebilir nedenler

- İşitme bozukluğu — yenidoğan işitme tarama programı (UNHS) ve orta kulak iltihabının zamanında tedavisi kritiktir.
- Konjenital dudak-damak yarığı — cerrahi düzeltme + konuşma terapisi.
- Hipotiroidi — yenidoğan taraması.

5. Klinik özellikler

6A01.0 Konuşma sesi bozukluğu

- Yaşa uygun olmayan ses çıkarma, yer değiştirme, bozulma (örneğin, “r” → “l”, “s” → “t”).
- Net olmama — yabancı kişiler konuşmayı anlamakta zorluk çeker.
- 4 yaşa kadar gelişim çerçevesinde “yumuşak” kabul edilir; 4 yaştan sonra devam edenler tanısal olarak değerlendirilmelidir.

6A01.1 Konuşma akıcılığı bozukluğu (kekemelik)

- Seslerin ve hecelerin tekrarlanması (b-b-b-balık), uzatma (sssalam), bloklar (sesi başlatmadan duruş).
- İkincil davranışlar — göz kaçırma, baş sallama, kaçınma.

- Başlangıç tipik 2–5 yaş arası; kekemeliği olan çocukların ~%70–80'i 5 yıl içinde spontan veya müdahale ile düzelir (Yairi E., Ambrose N. 2013).
- Sosyal ve duygusal yük — sosyal kaygı, okul uyumu sorunları.

6A01.2 Gelişimsel dil bozukluğu (DLD)

- Ekspresif komponenti: sınırlı kelime dağarcığı, kısa cümleler, gramatik morfolojide hatalar (özellikle zaman, durum ekleri), sözcük bulma güçlüğü.
- Reseptif komponenti: karmaşık cümleleri anlamada güçlük, davranış yönergelerine yanıt sorunu, çoklu anlam ve soyut dilin edinimi geri kalır.
- Pragmatik komponenti (6A01.22): Sosyal dil kullanımında (sıra alma, bağlam, dolaylı konuşma) defisit; otizmden farklı olarak sosyal ilgi ve sözel olmayan iletişim nispeten sağlıklıdır.

Gelişim yörüngesi

"Late talker" (geç konuşan) 2 yaşta kategori — %50–70'i 4 yaşına kadar yakalar; ancak kalıcı olan grup DLD için yüksek risk oluşturur. Bu grubun erken tanımlanması aile öyküsü, alıcı dil eksikliği ve sözel olmayan jestlerin az kullanımı belirtilerine dayanır.

6. Tanı

6.1 Birleşik tanı ölçütleri (DSM-5-TR · ICD-11 · CATALISE 2017 konsensus noktaları)

A. Dil veya konuşma elde edilmesinde sürekli defisit — bir veya daha fazla alanda (sözcük dağarcığı, sözdizimi, fonoloji, akıcılık, pragmatik) yaşa uygun normal seviyenin altında performans.

B. Fonksiyonel bozulma — akademik başarı, sosyal iletişim, mesleki işlevsellik veya günlük yaşamın birinde veya birkaçında belirgin kısıtlılık (CATALISE: fonksiyonel bozulma tanı için önemlidir, IQ kesim noktası değil).

C. Başlangıç gelişim döneminde.

D. Dışlamalar — işitme bozukluğu, nörolojik durum, entelektüel yetersizlik, otizm spektrum bozukluğu veya diğer tıbbi/psikiyatrik durumla tam olarak açıklanmaz. Ancak komorbid varlığında her iki tanı konur.

6.2 Kaynaklar arasındaki farklar

- CATALISE 2017 (Bishop D.V.M. et al.): "özgül" terimi kaldırıldı; IQ kesme noktası 85 kaldırıldı (DLD, entelektüel yetersizlik zemininde de

tanılanabilir); "language disorder" şemsiyesi altında komorbid nörogelişimsel ve risk faktörleri niteleyici olarak belirtilir.

- ICD-11 (6A01): alt-tiplerin (ses, akıcılık, dil) ayrılığı; dil bozukluğu için 3 alt-spesifikasyon (reseptif-ekspresif, esas olarak ekspresif, esas olarak pragmatik).
- DSM-5-TR: Social Communication Disorder ayrı kategori olarak (F80.2); kekeleme için başlangıç yaşı tipik <6 yaş.
- ASHA Practice Portal: tanı için Sertifikalı konuşma-dil patoloğu (SLP) tarafından standartlaştırılmış değerlendirme, ebeveyn görüşmesi ve natüralistik gözlem birlikte gereklidir.
- RCSLT (Royal College of Speech and Language Therapists): Büyük Britanya'da aynı çerçeve; multidisipliner değerlendirme (işitme + konuşma-dil + gelişim).

6.3 Tanı algoritması

1. Ebeveyn ve öğretmen görüşmesi (gelişim öyküsü, dil evreleri).
2. İşitme testi (odyometri — tüm vakalarda mutlaka).
3. Konuşma ve dil standartlaştırılmış değerlendirme (CELF-5, PLS-5, GFTA-3, DELV).
4. Natüralistik konuşma örneği (oyun veya sohbet ortamında).
5. Non-verbal IQ ölçüsü (OSB ve entelektüel yetersizlik dışlaması için).
6. Otizm spektrumu tarama (M-CHAT-R/F < 30 ay; SCQ okulöncesi).
7. Sosyo-duygusal ve davranış taraması.
8. Tıbbi muayene — nörolojik, dudak-damak muayenesi, motor muayene.

6.4 Ayırıcı tanı

Durum	**Ayırt edici belirtiler**
Entelektüel yetersizlik (6A00)	Genel kognitif defisit, dil bozukluğunun ötesinde tüm alanlara yayılır. Komorbid olabilir.
Otizm spektrum bozukluğu (6A02)	Sosyal etkileşim ve sınırlı-tekrarlayan davranış üçlüsü; pragmatik dil de bozulmuştur, ancak sosyal motivasyon temel sorun.
İşitme bozukluğu	Odyometri bozulmuş; alıcı defisit dominant.

Durum	Ayırt edici belirtiler
Seçici mutizm (6B06)	Belirli sosyal durumlarda konuşmama (okul), diğer bağlamda (ev) normal konuşma.
Çok dilli ortamın geçici etkisi	Yaşa uygun yer-çevre dilinin edinimi devam eder; konuşma dinamik olarak gelişir.
Bilingualizmde "kod karışıklığı"	Tipik ve gelişime uygun, bozukluk değil.
Çocukluk apraksisi (CAS)	Motor-planlama defisiti, değişken ses üretimi, sıralama sorunu.

7. Muayene ve değerlendirme

7.1 Standardize testler

- Dil: CELF-5 (Clinical Evaluation of Language Fundamentals, 5–21 yaş), PLS-5 (Preschool Language Scales, <7 yaş), CASL-2, Reynell Developmental Language Scales.
- Sözlük: PPVT-5 (Peabody Picture Vocabulary Test), EVT-3, MacArthur-Bates CDI (24 aya kadar).
- Konuşma sesi: GFTA-3 (Goldman-Fristoe Test of Articulation), DEAP.
- Pragmatik dil: CCC-2 (Children's Communication Checklist), Test of Pragmatic Language (TOPL-2).
- Sözel olmayan IQ: Leiter-3, RIAS-2 (verbal komponentten bağımsız olarak).

7.2 Laboratuvar incelemeleri

Mutlak değil; spesifik şüpheye dayalı:

- İşitme testi — tüm vakalarda mutlaka (odyometri, timpanometri, otoakustik emisyon).
- Fragile X (FMR1) — ağır DLD + entelektüel yetersizlik komorbid durumlarda.
- Tiroid fonksiyonu (TSH, T4) — konjenital hipotiroidi saptanmamışsa.
- Kurşun seviyesi — risk faktörleri varsa.

7.3 Enstrümantal incelemeler

- Beyin MRG — fokal nörolojik belirtiler, regresyon, makro/mikrosefali, nöbetler olduğunda. Rutin DLD'de endikasyon yoktur.
- EEG — tutma şüphesi olduğunda, Landau-Kleffner sendromu istisnası için.

8. Tedavi

8.1 Genel prensipler (ASHA · RCSLT · CATALISE · NICE konsensus)

1. Sertifikalı konuşma-dil patoloğu (SLP) tarafından bireysel konuşma-dil terapisi tüm bozukluklar için birinci basamak müdahaledir.
2. Erken müdahale — 2–4 yaş arası müdahale daha yüksek etki gösterir; "bekle ve gör" yaklaşımı belirli risk faktörleri (aile öyküsü, alıcı dil eksikliği) varsa zararlıdır.
3. Ebeveyn-koordineli (parent-coached) müdahaleler Küçük yaşta — Hanen "It Takes Two to Talk" programı RKÇ'lerde etki göstermiştir.
4. Yoğunluk ve süre — haftada 1–3 seans, 6–18 ay, davranışsal ve akademik bileşenlere göre kişiselleştirilir.
5. Multidisipliner Yaklaşım — SLP + öğretmen + çocuk doktoru + gerektiğinde odyolog, ergoterapist, psikolog.
6. Okulda destek — bireysel eğitim planı (IEP / EHCP), sınıf modifikasyonları, gerektiğinde birebir yardım.
7. Bilingualizm korunur — çocuğun iki dilini korumasına destek olunur; bir dili "terk etmek" önerilmez (ASHA Position 2004).
8. Farmakoterapi konuşma-dil bozukluğunun kendisi için onaylanmamıştır. Komorbid DEHB, anksiyete veya otizm için ayrı müdahale.

8.2 Konuşma sesi bozukluğunda müdahale (6A01.0)

- Artikülasyon terapisi — fonem-fonem yaklaşımı (van Riper); minimal pair eğitimi (aynı seslerin kontrast çiftlerinin karşılaştırılması)
- Fonolojik süreçlerin azaltılması — sistematik süreç temelli terapi (Bowen C., Cupples L. 1999).
- Kompleks ve ağır vakalarda — PROMPT, multisensör yaklaşım.

8.3 Kekemelikte müdahale (6A01.1)

- Lidcombe Programı (Onslow M., Australian Stuttering Research Centre) — 3–6 yaşta birinci sıra; ebeveyn-koordineli, evde uygulanan olumlu pekiştirme temelli operant program. Kanıt: Jones M. et al. BMJ 2005 RKÇ, n=54 — 9 ay sonra kekelenen hece oranı tedavi grubunda %1,5 (SS 1,4),

kontrolde %3,9 (SS 3,5); fark 2,3 yüzde puanı (%95 GA 0,8–3,9; p=0,003). Cochrane 2021 kanıtı çok düşük güvenilirlikte değerlendirir.

- Demands and Capacities Model (DCM) — Starkweather C.W. — iletişimsel taleplerin çocuğun o anki yeteneğine uyarlanması.
- Yaşlı çocuklar/ergenler — Kekemelik Modifikasyonu (Van Riper), Akıcılık Şekillendirme (Webster); aile ve grup desteği.
- Farmakoterapi: FDA'da kekemelik için resmi olarak onaylanmış preparat yoktur. Off-label dopamin antagonistleri (risperidon, olanzapin) ve SSRI'lar (paroksetin) seçilmiş yetişkin vakalarda araştırılmıştır, ancak etki hafif ve yan etki profili önemlidir (Maguire G.A. et al. 2020 derlemesi).

8.4 Gelişimsel dil bozukluğunda müdahale (6A01.2)

- Hanen "It Takes Two to Talk" — 2–4 yaşta ebeveyn-koordineli grup programı; çocuğun liderliğini izleme, diyaloğu genişletme. Kanıt: Roberts M.Y., Kaiser A.P. Am J Speech Lang Pathol 2011 meta-analiz — ifade edici ve alıcı dil ölçümlerinde orta etki.
- Natüralistik dil müdahalesi (enhanced milieu teaching, focused stimulation) — çocuğun ilgileri bağlamında dil modellerinin sunulması.
- Yapılandırılmış morfo-sentaks terapisi — dilbilgisel formların hedefli eğitimi (örneğin, geçmiş zaman, çoğulluk).
- Pragmatik dil müdahaleleri (6A01.22) — sosyal öyküler (Social Stories — Carol Gray), video-modelleme, grup eğitimi.
- Okul çağında akademik destek — okuma güçlüklerinin yüksek komorbiditesi nedeniyle Yapılandırılmış Okuryazarlık yaklaşımı; öğrenme bozukluğu açısından değerlendirme.

8.5 Kaynağa-özgü belirleyiciler

- ASHA Practice Portal: kanıta dayalı uygulama çerçevesi — klinisyen yargısı + kanıt + aile değerleri üçlüsü; sertifikasyon ve sürekli eğitim gereklilikleri.
- RCSLT (2017 Position Paper on DLD): erken identifikasyon ve hizmet erişilebilirliği önerir; "Bercow" raporu (2008, 2018) İngiltere'de hizmet yapısını şekillendirmiştir.
- NICE NG (çocuk konuşma ve dil için ayrı bir tam kılavuz henüz geliştirme aşamasındadır; mevcut rehberlik eğitim ve sağlık hizmetlerinin koordinasyonuna odaklanır).
- WHO mhGAP IG v2.0: düşük ve orta gelirli ülkelerde birinci basamak sağlık hizmeti düzeyinde değerlendirme; ebeveyn eğitimi ve toplum temelli rehabilitasyon vurgulanır.

8.6 Tedavi metodolojileri

1. Hanen “It Takes Two to Talk” — Kanada'da Hanen Centre tarafından geliştirilmiş, geç konuşan ve DLD riski olan 2–4 yaş çocuklar için ebeveyn eğitim programı. 8 grup seansı + 3 bireysel ev ziyareti; “OWL” (Observe, Wait, Listen) ve çocuğun liderliğini izleme ilkeleri. Kanıt: Roberts M.Y., Kaiser A.P. Am J Speech Lang Pathol 2011 meta-analiz. hanen.org.
2. Lidcombe Programı — Avustralya, Onslow M. tarafından geliştirilmiş, okul öncesi yaşta kekemelik için davranış temelli ebeveyn-koordineli program. Ebeveyn günlük 10–15 dk yapılandırılmış oyun seansında çocuğun akıcı konuşmasını güçlendirir. Kanıt: Jones M. et al. BMJ 2005 RKÇ n=54, 9 ay; Onslow M. et al. derlemeleri. lidcombeprogram.org.
3. Güçlendirilmiş Ortam Öğretimi (GOÖ / EMT — Enhanced Milieu Teaching) — Natüralistik dil müdahalesi — çocuğun oyun ve günlük bağlamında ardışık dil modellerinin sunulması ve genişletilmesi. Kanıt: Kaiser A.P., Roberts M.Y. Am J Speech Lang Pathol 2013.
4. PROMPT metodu (Prompts for Restructuring Oral Muscular Phonetic Targets) — Taktil-kinestetik konuşma motor müdahalesi — çocuğun ağız kaslarına fiziksel duyusal ipucu ile doğru artikülasyon yerinin gösterilmesi. Karmaşık konuşma sesi bozukluğu ve çocukluk çağı apraksisinde kullanılır. Kanıt tabanı gelişmektedir; Rogers S.J. et al. 2006 (otizm zemininde) ve diğer pilot çalışmalar.
5. Sosyal Öyküler (Social Stories) — Carol Gray — Sosyal bağlamda uygun davranışın kısa, bireyselleştirilmiş öykü formatında eğitimi. Pragmatik dil bozukluğu ve otizm spektrumunda pragmatik becerilerin oluşturulmasında. carolgraysocialstories.com.
6. Dil Temellerinin Klinik Değerlendirmesi (CELF-5 — Clinical Evaluation of Language Fundamentals) — 5–21 yaş için dilin standartlaştırılmış kapsamlı değerlendirmesi — alıcı, ifade edici, dil belleği, sözcük-cümle yapısı.
7. Okul Öncesi Dil Ölçeği (PLS-5 — Preschool Language Scales) — Doğumdan 7 yaşa kadar dil değerlendirmesi — auditory comprehension ve expressive communication ölçekleri.
8. Çocuk İletişim Kontrol Listesi (CCC-2 — Children's Communication Checklist) — Pragmatik dil ve genel iletişimsel işlevin ebeveyn/öğretmen değerlendirmesi; DLD'nin alt-tiplendirilmesinde yardımcı olur.

9. Prognoz

İyi prognoz faktörleri

- Hafif-orta şiddet, yalnızca ekspresif komponent.

- Erken tanı (<3 yaş) ve müdahale.
- Yüksek sözel olmayan IQ.
- Komorbid bozuklukların olmaması (OSB, entelektüel yetersizlik).
- Ebeveyn katılımı ve evde dil-zengin ortam.

Kötü prognoz etkenleri

- Reseptif bileşenin şiddeti (yalnızca ekspresiften daha kötü prognoz).
- Komorbid entelektüel yetersizlik veya OSB.
- Geç tanı (>5 yaş).
- Aile öyküsünde süreğen DLD.
- Düşük sosyo-ekonomik destek, sınırlı hizmet erişilebilirliği.

İzlem hedefleri

- DLD'li çocuklarda okuma ve yazma güçlüklerinin yüksek komorbiditesi (%40–60) — okul öncesi dönemde fonolojik farkındalık eğitimi; ardından Structured Literacy.
- Sosyo-duygusal sağlık — DLD'li ergenlerde anksiyete ve depresyon riski artmış (Conti-Ramsden G., Botting N. J Child Psychol Psychiatry 2008).
- Davranış bozukluğu ve DEHB taraması.
- Ergenlikte Mesleki ve Akademik Destek Planlaması.
- Kekemelik remisyona ulaştıktan sonra nüks takibi (stresli dönemlerde).

10. Mit ve yanlış inançlar

10.1 Etiyoloji mitleri

Mit 1: "İki dillilik çocuğu dil bozukluğuna götürür"

Neden yaygınlaştı: Aileler ve bazen pediatristler tarafından "dilleri karıştırma" "çocuğu şaşırtır" şeklinde telkin edilir; geç konuşan bilingual çocuklarda her iki dilde ayrı ayrı kelime dağarcığı monolingual ile karşılaştırıldığında küçük görünebilir (ancak toplam kavramsal kelime dağarcığı eşdeğerdir).

Klinik ve biyolojik mantık: İnsan beyni doğuştan birkaç dilde gelişmek üzere uyarlanmıştır; iki dillilik yürütücü işlev ve kognitif esnekliğe üstün etki gösterir (Bialystok E. et al. Trends Cogn Sci 2012 derleme). DLD'li iki dilli çocuklar her iki dilde de aynı paternde bozulma gösterir — bu, dil sayısıyla değil, nörogelişimsel bozuklukla ilgilidir.

Kanıt: Paradis J., Genesee F., Crago M.B. (2011) — iki dilli çocuklarda dil edinimi, tek dilli desenlerle paralel gelişir; DLD, iki dillilikten değil, nörogelişimsel temelde ortaya çıkar.

Gerçek klinik adım: iki dilli çocuğa DLD tanısı yalnızca her iki dilde bozukluk belgelendiğinde konulabilir. Ailenin ana dilini kesmek önerilmez — sosyo-emosyonel zarar ve aile bağı bozulması.

Mit 2: "Kekemelik ebeveynin yanlış davranışından (sabırsızlık, sertlik) kaynaklanır"

Neden yaygınlaştı: 1940–1950'li yıllarda Wendell Johnson'un "Diagnosogenic Theory" — kekemeliğin ebeveynin çocuğun normal akıcı olmayışına dikkat çekmesi sonucu oluştuğu iddiası; sonradan geçersiz kılınmış, ancak kitlesel inançta kalmıştır.

Biyolojik mantık ve kanıt: Kekemelik genetik ve nörobiyolojik temellidir — kalıtım ~%70 (Felsenfeld 2000); GNPTAB ve ilişkili lizozomal yol mutasyonları nadir formlarda (Kang C. NEJM 2010); fMRI çalışmaları bazal ganglia-supplementary motor alan döngüsünde fonksiyonel bozulma gösterir (Maguire 2020). Ebeveynin tepkisi kekemeliğin sürekliliğini etkileyebilir (stres bağlamında artma), ancak kekemeliğin başlangıcına neden değildir.

Gerçek klinik adım: aileye destek — sakin, dinleyen bir ortam yaratmak; Lidcombe Programı gibi kanıta dayalı ebeveyn-koordineli müdahale.

Mit 3: "Çocuk konuşmuyorsa, çünkü 'tembeldir' ya da 'çok küçüktür, bekleyelim'"

Kanıt: "Bekle ve gör" yaklaşımı yalnızca risk faktörleri OLMAYAN geç konuşan çocuk için uygundur — bu grubun %70-80'i 4 yaşına kadar konuşmayı yakalar. Ancak risk faktörleri olduğunda (aile öyküsü, alıcı eksiklik, sözel olmayan jestlerin az kullanımı, işitme şüphesi) bekleme kritik müdahale penceresini kaybettirir — Roos E.M., Weismer S.E. Top Lang Disord 2008.

Gerçek klinik adım: 18–24 ayda tarama (CDI, ASQ); risk faktörleri varsa SLP değerlendirmesi.

10.2 Zararlı veya temel müdahaleyi geciktiren yöntemler

Mit 4: "Dil bağı (tongue-tie / ankyloglossia) cerrahisi konuşma problemini çözer"

Neden yaygınlaştı: "frenotomy" ve "frenuloplasty" prosedürlerinin ticari popülaritesi; emzirme sorunlarında bazı endikasyonların olması.

Kanıt: Yalnızca ağır anatomik kısıtlılık (Coryllos III–IV) ve emzirme sorunu varsa frenotomi etkilidir (AAP, ABM 2020 protokolleri). Konuşma sesi bozukluğu için sistematik kanıt yoktur — Webb A.N. et al. Int J Pediatr Otorhinolaryngol 2013 inceleme. Hatalı operasyon — kanama, enfeksiyon, çift frenum oluşumu, normal emzirmenin zorlaşması.

Gerçek klinik adım: konuşma sesi bozukluğu için birinci sıra — DKT değerlendirmesi ve artikülasyon terapisi, frenotomi değil.

Mit 5: "Auditory Integration Training (AIT) — Berard veya Tomatis metodu"

Neden yaygınlaştı: alternatif klinik pazarlaması; "işitme sisteminin yeniden programlanması" iddiası.

Kanıt: ASHA Position Statement 2004 — işitme-dil veya otizmde etki kanıtı yoktur; deneysel statü. AAP 1998 Statement — AIT önermez.

Mit 6: "Kekemeliğin hipnoterapi, kulak cihazları (DAF — delayed auditory feedback) ile tam tedavisi"

Kanıt: Hipnoterapi — kekemelik için etki kanıtı yoktur (Bothe A.K. et al. Am J Speech Lang Pathol 2006 derlemesi). DAF cihazları (SpeechEasy ve benzeri) bazı yetişkinlerde kısa süreli akıcılık artışı sağlayabilir, ancak uzun süreli etki sınırlıdır ve davranış terapisiyle karşılaştırıldığında üstünlüğü doğrulanmamıştır (Lincoln M., Packman A. J Fluency Disord 2007).

10.3 Etkisiz veya bilimsel dayanağı olmayan yöntemler

Mit 7: "Non-Speech Oral Motor Exercises (NSOME) — dil, dudak, çene egzersizleri konuşma sesini düzeltir"

Neden yaygınlaştı: sezgisel temel — "eğer kas çalıştırılırsa, daha iyi çalışır"; bazı terapistler tarafından hala uygulanır.

Kanıt: ASHA 2009 ve güncelleme — konuşma dışı oral motor egzersizlerin konuşma sesi bozukluğunda etki kanıtı yoktur; konuşma ve konuşma dışı oral hareketler ayrı nöromotor programlardır (McCauley R.J., Strand E., Lof G.L. Am J Speech Lang Pathol 2009 sistematik derleme). NSOME kullanımı terapi zamanını kanıta dayalı konuşma temelli müdahaleden uzaklaştırır.

Gerçek klinik adım: konuşma sesi bozukluğu için — doğrudan artikülasyon terapisi (fonem-fonem veya fonolojik süreçler); NSOME'den kaçınılır.

Mit 8: "Brain Gym / Edu-K — beyin koordinasyonu egzersizleri dil bozukluğunu iyileştirir"

Kanıt: Derlemeler (Hyatt K.J. Remedial Spec Educ 2007) — "Brain Gym" iddiaları nörobiyolojiyle uyuşmaz; öğrenme sonuçlarına etki etmez. Ticari program olarak eleştirilir.

Mit 9: "Hiperbarik oksijen kamerası (HBOT) ve kök hücre enjeksiyonları dil bozukluğunu iyileştirir"

Kanıt: Cochrane (Xiong T. 2016 — otizm; benzer konum DLD için) — etki kanıtı yoktur; HBOT'da pnömotoraks, barotravma riskleri; resmiyet dışı kök hücre kliniklerinde ölüm vakaları (Berkowitz NEJM 2016).

Mit 10: "Özel diyet (glutensiz, kazeinsiz) dil bozukluğunu iyileştirir"

Kanıt: ASHA, AAP, AACAP — konuşma ve dil bozukluklarına özel diyetlerin etkisi kanıtlanmamıştır. Çölyak hastalığı veya doğrulanmış gıda alerjisi varsa diyet tıbbi endikasyondur, ancak dil-konuşma gelişimine etkisi yoktur.

11. Kaynaklar

1. Bishop D.V.M., Snowling M.J., Thompson P.A., Greenhalgh T., CATALISE consortium. CATALISE: a multinational and multidisciplinary Delphi consensus study of problems with language development: Terminology. J Child Psychol Psychiatry 2017;58(10):1068–1080.
2. WHO. ICD-11 for Mortality and Morbidity Statistics. 6A01 Developmental speech or language disorders. 2024.
3. American Psychiatric Association. DSM-5-TR. Washington DC: APA Publishing; 2022.
4. ASHA Practice Portal — Language Disorders, Speech Sound Disorders, Fluency Disorders. American Speech-Language-Hearing Association. asha.org/practice-portal.
5. RCSLT — Developmental Language Disorder. Royal College of Speech and Language Therapists. rcslt.org.
6. Norbury C.F., Gooch D., Wray C. et al. The impact of nonverbal ability on prevalence and clinical presentation of language disorder. J Child Psychol Psychiatry 2016;57(11):1247–1257.
7. Yairi E., Ambrose N. Epidemiology of stuttering: 21st century advances. J Fluency Disord 2013;38(2):66–87.

8. Jones M., Onslow M., Packman A. ve ark. Randomised controlled trial of the Lidcombe programme of early stuttering intervention. BMJ 2005;331(7518):659.
9. Roberts M.Y., Kaiser A.P. The effectiveness of parent-implemented language interventions: a meta-analysis. Am J Speech Lang Pathol 2011;20(3):180–199.
10. McCauley R.J., Strand E., Lof G.L. et al. Evidence-based systematic review: effects of nonspeech oral motor exercises on speech. Am J Speech Lang Pathol 2009;18(4):343–360.
11. Bishop D.V.M. Ten questions about terminology for children with unexplained language problems. Int J Lang Commun Disord 2014;49(4):381–415.
12. Felsenfeld S., Kirk K.M., Zhu G. et al. A study of the genetic and environmental etiology of stuttering in a selected twin sample. Behav Genet 2000;30(5):359–366.
13. Kang C., Riazuddin S., Mundorff J. et al. Mutations in the lysosomal enzyme-targeting pathway and persistent stuttering. NEJM 2010;362(8):677–685.
14. Maguire G.A., Yeh C.Y., Ito B.S. Overview of the diagnosis and treatment of stuttering. Curr Med Res Opin 2020;36(8):1399–1407.
15. Paradis J., Genesee F., Crago M.B. Dual Language Development and Disorders: A Handbook on Bilingualism and Second Language Learning. 2nd ed. Brookes Publishing; 2011.
16. Bialystok E., Craik F.I.M., Luk G. Bilingualism: consequences for mind and brain. Trends Cogn Sci 2012;16(4):240–250.
17. Conti-Ramsden G., Botting N. Emotional health in adolescents with and without a history of specific language impairment. J Child Psychol Psychiatry 2008;49(5):516–525.
18. Starkweather C.W. Fluency and Stuttering. Englewood Cliffs: Prentice-Hall, 1987.
19. Shriberg L.D., Tomblin J.B., McSweeny J.L. Prevalence of speech delay in 6-year-old children and comorbidity with language impairment. J Speech Lang Hear Res 1999;42(6):1461–1481.

ICD-11 **6A02**	**6A02 OTİZM SPEKTRUM BOZUKLUĞU (OSB)** **Autism spectrum disorder**
ICD-10 F84.0	Çocukluk otizmi
DSM-5-TR F84.0	Otizm Açılımı Kapsamında Bozukluk

1. Tanım ve nozoloji

Otizm spektrum bozukluğu (OSB; ICD-11: 6A02; DSM-5-TR: F84.0 Otizm Spektrum Bozukluğu) — erken gelişim döneminde başlayan, iki temel alanda sürekli defisitlerle seyreden nörogelişimsel bozukluktur:

1. Sosyal iletişim ve sosyal etkileşimde sürekli defisit — karşılıklı sosyal-duygusal alışveriş, sözel olmayan iletişimsel davranış, ilişkilerin kurulması ve sürdürülmesi.
2. Sınırlı, tekrarlayan davranış, ilgi veya faaliyet modelleri — stereotipik motor veya konuşma, sabit ritüel ve rutinlere bağlılık, sınırlı yüksek yoğunluklu ilgiler, duyusal uyaranlara atipik reaktivite.

ICD-11'de tanı kalifikatörlerle belirlenir: entelektüel gelişim bozukluğu ile/olmadan; fonksiyonel dil bozukluğu (yok / hafif-orta / ağır); sürekli bütüncül klinik gidiş (stabil, kötüleşme, iyileşme).

2. Tarihçe

- Kanner L. (1943) — erken infantil otizm — 11 çocukta sosyal izolasyon, değişime direnç, dil bozuklukları gözlemlenmiştir.
- Asperger H. (1944) — otistik psikopati — normal zeka ve dil ile sosyal etkileşim eksikliklerini tanımlamıştır. (Asperger'in Nazi rejimiyle işbirliği geçmişi son on yıllarda ortaya çıkmıştır — Czech H. Mol Autism 2018.)
- Wing L., Gould J. (1979) — otistik spektrum kavramı; üçlü bozukluk — sosyal etkileşim, iletişim, hayal gücü/davranış.
- DSM-III (1980) → DSM-IV (1994): Pervasive Developmental Disorders kategorisi — Autistic Disorder, Asperger's Disorder, Childhood Disintegrative Disorder, Rett's Disorder, PDD-NOS ayrı tanılar.

- DSM-5 (2013) ve ICD-11 (2019): tüm alt-tipler "Otizm Spektrum Bozukluğu" tek kategoride birleştirilmiştir. Gerekçe — alt tiplerin güvenilir ve geçerli ayrımının kanıt temeli zayıftı. DSM-5'te şiddet 3 düzeye ayrılır (1 — destek gerektirir; 2 — önemli destek; 3 — çok önemli destek). ICD-11'de şiddet ayrı bir niteleyici değildir — alt spesifikasyon entelektüel ve dil bozukluğu temelinde kurulur.
- Çocukluk dezintegratif bozukluğu ICD-11'de ayrı kod ile (atipik gidiş kalifikatörü) korunur.

3. Epidemiyoloji

- Yaygınlık: CDC ADDM Network 2023 raporu (8 yaşındaki çocuklar, 2020 verisi): 1/36 (%2,8) — son on yıllarda artış kaydedilmiştir (1/150 — 2000; 1/68 — 2012). Artışın çoğu tanı kriterlerinin genişlemesi, farkındalığın artması ve tarama uygulaması ile açıklanır.
- Cins: Erkeklerde ~4:1 — ancak kadınlarda az tanı sorunu belgelenmiştir (kadın fenotipi — sosyal "kamuflaj", daha az belirgin tekrarlayan davranışlar; Lai M.C., Baron-Cohen S. Lancet Psychiatry 2015).
- Entelektüel yetersizlik komorbiditesi: ~%30–40 (CDC ADDM); yaklaşık %30–35 IQ <70.
- Diğer komorbiditeler: DEHB ~%30–50, anksiyete ~%40, depresyon ergenlikte ~%25, epilepsi ~%10–30 (yaşla artar), uyku bozuklukları %50–80, beslenme sorunları, GİS şikayetleri.
- Mortalite: popülasyonla karşılaştırıldığında 2 kat artmış — ana nedenler: epilepsi, kazalar (suda boğulma, kaybolma vakaları), intihar (yüksek fonksiyonel OSB'de).

4. Etiyoloji ve patogenez

4.1 Genetik faktörler (%50–80 kalıtım)

- Kalıtım: Sandin S. et al. JAMA 2017 İsveç kardeşleri ve ikiz çalışması n>2 mln: kalıtım ~%80; çevresel faktörlerin payı ~%20.
- Genetik sendromlarla ilişki: Fragile X (~%2–5 OSB vakalarının), Rett sendromu (kadınlarda neredeyse her zaman MECP2 mutasyonu), tüberoz skleroz (~%1–4), 22q11.2 delesyonu, 16p11.2, Phelan-McDermid (22q13).
- De novo CNV ve SNV mutasyonları — ~%25 vakada tanımlanır; sinaptik genler (SHANK3, NRXN1, NLGN3/4, CHD8, SCN2A) belirtilir (Satterstrom F.K. et al. Cell 2020 — 102 risk geni).

- Poligenik risk mimarisi — sayıca yüzlerce küçük etkili varyant; tek gen "otizm geni" yoktur.
- Baba yaşı > 40 — yeni mutasyon riski ile ilişkili.

4.2 Prenatal ve perinatal risk faktörleri

- Ebeveynde valproat kullanımı (gebelik) — otizm spektrum bozukluğu riskini ~2,9 kat (%95 GA 1,7–4,9), çocukluk otizmi riskini ~5,2 kat (%95 GA 2,7–10,0) artırır; mutlak risk %4,42 ve %2,50 (popülasyonda %1,53 ve %0,48) — Christensen J. et al. JAMA 2013; FDA ve EMA uyarısı.
- Erken doğum — 22–27 haftada riski ~3,7–4,2 kat (Crump C. et al. Pediatrics 2021), 22–31 haftada ~2,3 kat (Persson M. et al. PLOS Med 2020) artırır; erken doğanlarda OSB yaygınlığı %7 (%95 GA 4–9), medyan gestasyon 28 hafta (Agrawal S. et al. Pediatrics 2018).
- Düşük doğum ağırlığı, perinatal hipoksi.
- Ebeveynde diyabet, ağır obezite, gestasyonel hipertansiyon — risk faktörleri olarak belirtilir.
- Annenin gebelikte virüs enfeksiyonları (rubella, sitomegalovirüs) — yüksek risk.

4.3 Nörobiyolojik mekanizmalar

- Erken beyin büyümesinde atipik model — 2–4 yaşta hızlanma, sonra normalleşme (Courchesne E. et al. JAMA 2003).
- Sinaptik oluşum ve budanma süreçlerinde disregülasyon — eksitatör/inhibitör dengesizliği.
- Beynin bölgeler arası fonksiyonel bağlantısında atipik model — lokal aşırı bağlantı, uzak mesafeli zayıf bağlantı (Just M.A. ve ark. Brain 2004; sonradan karışık kanıtlar).
- Sosyal biliş ağı (medial prefrontal, temporal-parietal junction, amigdala) ve ayna nöron sistemi atipik aktivasyon modelleri gösterir.

4.4 Çevresel risk faktörleri

- Hava kirliliği (PM2.5, NO2) gebelik ve erken çocuklukta — riski hafifçe artırır (Volk H.E. et al. JAMA Psychiatry 2013).
- Annede folat eksikliği (perikonsepsiyonel dönemde) — folat takviyeleri ile risk azalır (Surén P. et al. JAMA 2013).

5. Klinik özellikler

5.1 Sosyal iletişim ve etkileşim eksiklikleri

- Karşılıklı sosyal-duygusal alışverişte defisit — atipik sosyal yakınlık, karşılıklı konuşmanın azalması, paylaşılan ilgilerin sınırlılığı.
- Non-verbal iletişimsel davranış defisitleri — göz temasının atipik kullanımı, jest ve mimik koordinasyonunun azlığı.
- İlişkilerin kurulması ve korunmasında zorluk — yaşa uygun arkadaşlıkların azlığı, varsayımsal hayal oyunlarının azlığı.

5.2 Sınırlı, tekrarlayan davranış modelleri

- Stereotipik veya tekrarlayan motor hareketler, nesnelerin kullanımı veya konuşma (ekolali, idiosenkratik ifadeler).
- Aynılıkta ısrar, rutinlere sürekli bağlılık veya ritüelleşmiş davranış (giyim, yiyecek, rota).
- Yüksek yoğunluklu veya odaklanmış sınırlı ilgiler (belirli bir konuya karmaşık bilgi — "yoğun tutku").
- Duyusal girdiye karşı atipik reaktivite — hiperreaktivite (ses, dokunma), hiporeaktivite (ağrı) veya atipik duyusal ilgiler (yüzeyleri inceleme, görsel uyarım).

5.3 Gelişimsel yörünge

Erken belirtiler — sosyal dikkatin azlığı, adla çağrılmaya yanıt vermeme, karşılıklı gülümseme, sözel olmayan iletişim (12–18 ay). Bir kısım çocukta gelişimsel gerileme (kazanılmış dil ve sosyal becerilerin 12–24 ayda kaybı) kaydedilir — ~%30 vakalar (CDC).

Yetişkinlikte — kadınlarda ve yüksek işlevli bireylerde sosyal "kamuflaj" (Hull L. et al. J Autism Dev Disord 2017) — zorlukları gizleyerek tükenme ve ikincil psikiyatrik komorbidite (anksiyete, depresyon).

6. Tanı

6.1 Birleşik tanı ölçütleri (DSM-5-TR · ICD-11 · NICE CG170 konsensus noktaları)

A. Sosyal iletişim ve sosyal karşılıklı ilişkide sürekli defisitler — aşağıdaki üç alanın hepsinde:

1. Sosyo-duygusal karşılıklı alışveriş;

2. Sosyal etkileşimde non-verbal iletişimsel davranış;
3. İlişkilerin geliştirilmesi, korunması, anlaşılması.

B. Sınırlı, yineleyici davranış, ilgi veya etkinlik örüntüleri — aşağıdaki dörtten en az ikisi:

1. Stereotipik veya tekrarlayan motor hareketler, nesne kullanımı, konuşma;
2. Aynılıkta ısrar, rutine bağlılık, ritüelleşmiş davranış veya konuşma;
3. Yüksek yoğunluklu, odaklanmış sınırlı ilgiler;
4. Duyusal girdiye karşı hiper- veya hiporeaktivite veya atipik duyusal ilgiler.

C. Semptomlar erken gelişim döneminde mevcut olmalıdır (sosyal talepler artana kadar tam görünmeyebilir).

D. Fonksiyonel bozulma — sosyal, akademik veya diğer önemli alanlarda.

E. İstisnalar — entelektüel gelişim bozukluğu veya global gelişim geriliği ile tam olarak açıklanmaz (komorbidite mümkündür).

6.2 Kaynaklar arasındaki farklar

- DSM-5-TR (F84.0): üç şiddet düzeyi (1–3) her iki alan için ayrı ayrı belirlenir — destek gereksiniminin yoğunluğuna göre. Niteleyici: entelektüel yetersizlik, dil bozukluğu, bilinen tıbbi/genetik durum, başka nörogelişimsel bozukluk, katatoni ile.
- ICD-11 (6A02): alt-spesifikasyonlar — entelektüel gelişim bozukluğu ile (6A02.0/.1)/olmadan (6A02.2/.3); fonksiyonel dilin bozulma derecesi (yok/hafif-orta/ağır). DSM'deki 1–3 şiddet sistemi resmen kabul edilmemiştir.
- NICE CG170 (19 yaş altında otizm spektrum bozukluğu: destek ve yönetim, 2013): tanı multidisipliner ekip tarafından (pediatrist / psikiyatrist + dil-konuşma patoloğu + klinik psikolog) konulmalıdır; ADOS-2 ve ADI-R tanısal altın standart olarak kabul edilir.
- AAP 2020 (Hyman S.L., Levy S.E., Myers S.M. Pediatrics 2020;145(1)): 18 ve 24 ayda universal otizm taraması önerilir (M-CHAT-R/F); pozitif tarama → uzman değerlendirmesi.
- AACAP Practice Parameter (Volkmar F. et al. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry 2014): tanı algoritması, komorbidite değerlendirmesi, tedavi önerileri.

6.3 Tanı algoritması

1. Ebeveyn ve bakıcı görüşmesi — gelişim öyküsü, erken sosyal ve iletişimsel belirtiler.

2. Tarama: 18 ve 24 ay (M-CHAT-R/F); pozitif olduğunda takip anketi.
3. Uzman değerlendirmesi — pediatrist / gelişim pediatristi / psikiyatrist / klinik psikolog.
4. Altın standart tanı araçları: ADOS-2 (Autism Diagnostic Observation Schedule) — yapılandırılmış oyun-temelli gözlem; ADI-R (Autism Diagnostic Interview, Revised) — ebeveyn görüşmesi.
5. Zekâ değerlendirmesi (WISC-V, Stanford-Binet 5, sözel olmayan seçenekler — Leiter-3, Mullen).
6. Konuşma-dil ve uyumsal davranış değerlendirmesi (Vineland-3).
7. İşitme ve görme testleri.
8. Tıbbi ve genetik değerlendirme — chromosomal microarray (CMA), Fragile X (FMR1), seçici trio ekzom; nöbet şüphesi varsa EEG; klinik şüphede MR (mikrosefali, regresyon).
9. Komorbidite taraması: DEHB, anksiyete, depresyon, OKB, uyku, yeme, GİS.

6.4 Ayırıcı tanı

Durum	**Ayırt edici belirtiler**
Entelektüel gelişim bozukluğu (6A00)	Genel bilişsel defisit; sosyal etkileşim entelektüel düzeye uygundur. Komorbid olabilir.
Gelişimsel dil bozukluğu — pragmatik (6A01.22)	Sosyal dil kullanımında defisit; sınırlı-tekrarlayan davranış modelleri yoktur.
Reaktif bağlanma bozukluğu (6B44)	Erken psikososyal deprivasyondan kaynaklanır; uygun ortamda iyileşme potansiyeli.
Şizotipal bozukluk (6A22)	Genellikle yetişkinlikte kendini gösterir; psikotik-benzeri düşünce.
OKB (6B20)	Ego-distonik obsesyonlar ve kompulsiyonlar; OSB'de ritüeller ego-sintoniktir.
Sosyal anksiyete bozukluğu (6B04)	Sosyal kaçınma anksiyete temelli; sosyal ilgi korunur.
Seçici mutizm (6B06)	Belirli bir bağlamda konuşmama; ev bağlamında normal konuşma.

7. Muayene ve değerlendirme

7.1 Klinik tanı araçları

- Skrining: M-CHAT-R/F (16–30 ay), SCQ (4+ yaş, ebeveyn anketi), SRS-2 (Social Responsiveness Scale).
- Tanısal: ADOS-2 (yürümeye başlayan çocuk-yetişkin modülleri), ADI-R (1,5+ yaş, ebeveyn).
- Zekâ ve kognisyon: Mullen Scales of Early Learning, Bayley-III/IV (küçük yaş), WISC-V, Leiter-3 (sözel olmayan).
- Uyumsal davranış: Vineland-3, ABAS-3.
- Konuşma-dil: PLS-5, CELF-5, CCC-2 (pragmatik).
- Duyusal profil: Sensory Profile-2 (Dunn).
- Komorbidite: DEHB için Conners, anksiyete için SCARED, depresyon için PHQ-9 adaptasyonları.

7.2 Laboratuvar incelemeleri

Birinci basamak (AAP 2020 / AACAP 2014): chromosomal microarray analysis (CMA — tanısal verim ~%10–20); Fragile X (FMR1).

Seçici: trio ekzom sekanslama (WES — CMA negatif olduğunda tanısal verim %25–40); MECP2 (Rett şüphesi kadınlarda); metabolik (laktat, amonyak, amino asitler — regresyon olduğunda); kurşun düzeyi; TSH.

7.3 Enstrümantal incelemeler

- EEG — tutma, regresyon, garip davranış epizodları olduğunda.
- Beyin MRG — fokal nörolojik belirtiler, mikro/makrosefali, regresyon.
- İşitme testi — tüm vakalarda mutlaka (odyometri, ABR).

8. Tedavi

8.1 Genel Prensipler (NICE CG170 · AAP 2020 · AACAP 2014 konsensüsü)

1. OSB "tedavi" edilemez — bireysel gelişim, adaptasyon ve yaşam kalitesi iyileştirilir. "Tedavi" ve "tam iyileşme" iddiası bilimsel temelli değildir; amaç — işlevsel beceriler, iletişim, bağımsızlık, yaşam kalitesi.
2. Erken, yoğun, bireysel davranış müdahalesi birinci basamak — 18 ay – 6 yaş arasında etki en büyüktür (Reichow B. et al. Cochrane 2018, EIBI/ESDM meta-analizi).

3. Natüralistik Gelişim-Davranış Müdahaleleri (NGDM / NDBI — Naturalistic Developmental Behavioral Interventions) — çocuğun oyun ve günlük bağlamında davranış-gelişim ilkeleri temelinde; ABA'nın klasik ayrık-deneme versiyonundan daha esnektir. Bu gruba dahildir:
    - Erken Başlangıç Denver Modeli (EBDM / ESDM)
    - Ortak Dikkat, Sembolik Oyun, Katılım ve Düzenleme (JASPER)
    - Anahtar Tepki Terapisi (ATT / PRT)
    - Güçlendirilmiş Ortam Öğretimi (GOÖ / EMT — Enhanced Milieu Teaching)
    - Çocuk Otizminde İletişim Terapisi (PACT)

    Yöntemlerin ayrıntılı tanımı — "Tedavi metodolojileri" bölümünde.
4. Ebeveyn-aracılı (parent-mediated) yaklaşım — Hanen "More Than Words", PACT (Pickles A., Green J. et al. Lancet 2010, 2016 izleme — 6 yıllık etki devam ediyor), PRT ebeveyn versiyonu. Kaynak kısıtlı koşullarda en maliyet-etkin yaklaşım.
5. Sosyal beceri grupları — yetişkin çocuklar ve ergenler için; PEERS programı (UCLA, Laugeson E.A.) — yetişkinlerde de etkililik.
6. Yapılandırılmış eğitim ortamı — TEACCH (Otistik ve İlgili İletişim Engelli Çocukların Tedavisi ve Eğitimi, Schopler E. North Carolina); IEP / EHCP bireysel eğitim planı.
7. İletişim desteği — minimal verbal hastalarda Artırıcı ve Alternatif İletişim (AAC) — PECS (Resim Değiş Tokuşu İletişim Sistemi), konuşma cihazları, tablet tabanlı uygulamalar.
8. Komorbidite tedavisi — DEHB (stimülanlar, Cortese 2018), anksiyete (BDT modifikasyonu — Storch E.A. RKÇ'leri), depresyon (BDT, SSRI), epilepsi (standart antiepileptik), uyku (uyku hijyeni, melatonin — RKÇ kanıtı Goldman S.E. J Clin Sleep Med 2014).
9. Farmakoterapi yalnızca komorbid semptomlar için — OSB'nin temel (çekirdek) semptomları için FDA onaylı ilaç yoktur. Davranışsal saldırganlık ve irritabilite için — risperidon (5–16 yaş, FDA onayı 2006) ve aripiprazol (6–17 yaş, FDA onayı 2009). Her ikisi de kanıtlanmıştır (McCracken J.T. et al. NEJM 2002 RKÇ — risperidon), ancak yan etki yükü önemlidir (metabolik, EPS). Davranışsal müdahale birinci basamak.

8.2 Tedavi metodolojileri

1. Uygulamalı Davranış Analizi (UDA / ABA — Applied Behavior Analysis) — Davranış ilkeleri temelinde öğrenme yöntemi; sosyal, iletişimsel ve uyumsal becerilerin oluşturulması, zorlu davranışın azaltılması. Ayrık-

deneme eğitimi (DTT) veya naturalistik formatta uygulanır. Bir kısım yetişkin OSB topluluğu UDA'nın klasik formunu eleştirir (özerklik, sıkıntı).

2. Erken Yoğun Davranış Müdahalesi (EYDM / EIBI — Early Intensive Behavioral Intervention) — UDA temelinde erken yaşta yapılandırılmış yoğun müdahale (haftada 25–40 saat); hedef — sosyal, iletişimsel ve uyumsal beceriler. Kanıt: Reichow B., Hume K., Barton E.E., Boyd B.A. Cochrane 2018 — IQ, dil ve uyumsal davranışta küçük-orta etki; mevcut iddialara hassasiyetle yaklaşılmalıdır.
3. Erken Başlangıç Denver Modeli (EBDM / ESDM — Early Start Denver Model) — Rogers S., Dawson G. — 12–48 ay için naturalistik gelişim-davranış müdahalesi; oyun ve günlük aktiviteler bağlamında öğrenme. Kanıt: Dawson G. et al. Pediatrics 2010 RKÇ n=48 — IQ, dil ve uyum davranışında anlamlı ilerleme, 6 yaşında tanı değişikliği (Dawson G. et al. JAACAP 2012 izlem). Ebeveyn versiyonu (P-ESDM) Rogers S.J. et al. JAACAP 2012.
4. Ortak Dikkat, Sembolik Oyun, Katılım ve Düzenleme (JASPER — Joint Attention, Symbolic Play, Engagement, Regulation) — Kasari (Kasari C.) — Ortak dikkat ve sembolik oyunun gelişimine yönelik müdahale; 12–60 ay. Kanıt: Kasari C. et al. JAMA Pediatr 2014, J Consult Clin Psychol 2010 — ortak dikkat ve ifade edici dilde anlamlı ilerleme.
5. Çocuk Otizminde İletişim Terapisi (PACT — Paediatric Autism Communication Therapy) — Pickles A., Green J — Ebeveyn-koordineli iletişim müdahalesi; 2-11 yaş. Ebeveyn-çocuk etkileşiminin video temelli analizi ve genişletilmesi. Kanıt: Pickles A. et al. Lancet 2016 — n=152, 6 yıl izlem — otizm şiddeti ve ebeveyn senkronizasyonunda sürekli iyileşme. Kaynak kısıtlı koşullarda da uyarlanır.
6. Anahtar Tepki Terapisi (ATT / PRT — Pivotal Response Treatment) — Koegel (Koegel R.L., Koegel L.K.) — Pivot davranışlara odaklanma (motivasyon, çoklu sinyale yanıt, özdenetim, kendi kendine başlatma) — bunlar öğrenildiğinde değişiklik birçok alana yayılır. Doğal ortamda, çocuğun seçimlerine dayalı.
7. Otizmli ve İletişim Güçlüğü Olan Çocukların Tedavisi ve Eğitimi (TEACCH — Treatment and Education of Autistic and related Communication-handicapped Children) — Schopler E. — Yapılandırılmış görsel eğitim ortamı — "yapılandırılmış öğretim" — görsel çizelge, çalışma sistemleri, bireysel geçişler; ev, okul ve toplum bağlamında. North Carolina kökenli, dünyaya yayılmıştır.
8. Resim Değişimi ile İletişim Sistemi (PECS — Picture Exchange Communication System) — Bondy (Bondy A.), Frost (Frost L.) — Minimal verbal hastalar için resim değişimi temelli iletişim eğitimi — 6 aşamada.

Kanıt: Howlin P. ve ark. J Child Psychol Psychiatry 2007 RKÇ — iletişimde artış.

9. İlişki Becerileri Eğitimi ve Zenginleştirme Programı (PEERS — Program for the Education and Enrichment of Relational Skills) — Laugeson (Laugeson E.A., UCLA) — Ergenler ve genç yetişkin OSB'li bireyler için yapılandırılmış sosyal beceri grubu; 16 hafta, ebeveyn desteği ile. Kanıt: Laugeson E.A. et al. J Autism Dev Disord 2012, 2015.
10. Hanen "More Than Words" — 2–5 yaşlı OSB'li çocukların ebeveynleri için 8 grup seansı + 3 bireysel ev ziyareti. hanen.org.
11. DSÖ Bakıcı Becerileri Eğitimi (BBE / CST — WHO Caregiver Skills Training) — WHO'nun düşük ve orta gelirli ülkeler için sınırlı kaynaklı ebeveyn eğitimi; OSB ve gelişimsel gecikmeler için; toplumda çalışan uzman olmayan eğitmen-kolaylaştırıcılar tarafından uygulanır.
12. EEG Nörofidbek (EEG Neurofeedback) — Beyin dalga modellerinin gerçek zamanlı izlemi temelinde kullanıcının kendi beyin aktivitesini düzenlemesine yönelik eğitim. OSB'de temel semptomlara etki temeli sınırlıdır; Holtmann M. et al. Dev Med Child Neurol 2011 — DEHB'de mütevazı, OSB'de spesifik kanıt zayıf. Birinci basamak değil, adjunkt statü; hasta ve aileye kanıt temelinin sınırlılığı açıklanmalıdır.
13. Otizm Tanı Gözlem Çizelgesi (ADOS-2 — Autism Diagnostic Observation Schedule) ve Otizm Tanı Görüşmesi (ADI-R — Autism Diagnostic Interview-Revised) — Tanısal altın standart araçları — ADOS-2 yapılandırılmış oyun-temelli gözlem (5 modül, toddler-yetişkin); ADI-R standartlaştırılmış ebeveyn görüşmesi (1,5+ yaş, ~2 saat).

8.3 Kaynaklar arasındaki farklar

- NICE CG170 (2013, 2021 güncellemesi): tanı multidisipliner ekip tarafından; sosyal iletişim müdahaleleri birinci basamak; ebeveyn programları üstün; antipsikotik yalnızca davranış müdahalesi başarısız olduğunda; fiili "tedavi" iddialarına karşı uyarı.
- AAP Clinical Report 2020 (Hyman et al.): 18 ve 24 ayda universal tarama; erken müdahale (<3 yaş); entegre medikal ve davranışçı yönetim.
- AACAP Practice Parameter 2014 (Volkmar): tanıya özgü eğitim yerleşimi, komorbidite tedavisi, aile desteği vurgusu.
- WHO Caregiver Skills Training (CST): düşük ve orta gelirli ülkeler için sınırlı kaynaklı ebeveyn eğitimi programı; birçok ülkede uyarlanmıştır (Salomone E. et al. Autism 2019).

9. Prognoz

İyi prognoz faktörleri

- Erken tanı (<3 yaş) ve erken yoğun müdahale.
- Entelektüel fonksiyonun korunması (IQ >70).
- 5 yaşına kadar işlevsel dilin kazanılması.
- Komorbid bozuklukların yönetimi.
- Stabil aile desteği ve toplum kaynakları.

Kötü prognoz etkenleri

- Komorbid entelektüel yetersizlik (ağır-derin).
- 5 yaşına kadar işlevsel dilin olmaması.
- Epileptik nöbetler — yetişkinlikte ek risk artışı.
- Ağır davranış bozuklukları, kendine zarar verme.
- Tanı ve müdahalenin geç başlatılması.

İzlem hedefleri

- Komorbid psikiyatrik durumlar (DEHB, anksiyete, depresyon, OKB) taraması — yıllık.
- Epilepsi monitörizasyonu — özellikle ergenlik döneminde.
- Uyku, beslenme, GİS, motor bozukluk taraması.
- Yetişkinliğe geçiş planlaması (16–18 yaş) — meslek, bağımsız yaşam, istihdam.
- Yetişkin hastalarda sosyal kamuflajın duygusal yükü, anksiyete ve depresyon — aktif tarama.
- Aile için mola desteği, akran desteği, psikoeğitim.
- Nöroçeşitlilik yaklaşımı — hastanın güçlü yönlerini güçlendirmek, "tam tedavi" iddiası yok.

10. Mit ve yanlış inançlar

10.1 Etiyoloji mitleri

Mit 1: "Aşılar (özellikle MMR) otizme neden olur"

Neden yaygınlaştı: Wakefield A.J. et al. Lancet 1998 — 12 çocuk üzerinden MMR aşısını bağırsak bozukluğu ve otizm ile ilişkilendirdiğini iddia etti. Daha sonra Brian

Deer'in gazetecilik araştırması ve General Medical Council soruşturması — Wakefield'ın mali çıkarı ve veri manipülasyonu ortaya çıkarıldı; makale 2010 yılında tamamen geri çekildi; Wakefield doktorluktan men edildi.

Klinik ve biyolojik mantık: otizm 12–18 ayda klinik olarak ortaya çıkar — MMR aşısının tipik zamanlaması ile zamansal korelasyon yanlış bir "neden" algısına yol açabilir. Patogenez genetik ve erken nörogelişimsel etkenlere dayanır (kalıtım %80, prenatal ve perinatal faktörler) — aşılamaya bağlı değildir.

Kanıt: Taylor L.E., Swerdfeger A.L., Eslick G.D. Vaccine 2014 meta-analiz n>1,2 mln çocuk — MMR ile otizm arasında ilişki yoktur; Madsen K.M. et al. NEJM 2002 Danimarka çalışması n>537 000; Jain A. et al. JAMA 2015 ABD çalışması. CDC, WHO, NICE, AAP aynı pozisyondadır.

Gerçek klinik adım: Aileye kanıtları sakin, saygılı bir şekilde sun; aşı reddinin çocuk ve toplum sağlığı için riskini açıkla (Madagaskar'da 2018–2019 kızamık salgını 1200+ çocuk ölümü).

Mit 2: "Mikroplastik, ağır metaller, kimyasal gıda katkıları otizmin ana nedenidir"

Neden yaygınlaştı: "doğal / kimyasal maddesiz" hareketinin kitle medyasında abartılı sunumu; mikroplastik araştırmalarının bağlam dışı kullanımı.

Klinik ve biyolojik mantık: otizmin temel etiyolojisi genetiktir (kalıtım %80 — Sandin JAMA 2017). Çevresel faktörler risk faktörü olarak araştırılmaktadır (PM2.5 hava kirliliği — Volk JAMA Psychiatry 2013; valproat prenatal — Christensen JAMA 2013), ancak "temel neden" olarak mikroplastik veya ağır metaller için kanıt temeli yoktur.

Kanıt: Hertz-Picciotto I. Environ Health Perspect 2018 derlemesi — bazı nörotoksinler (özellikle valproat, alkol) risk faktörü olarak kabul edilir; ağır metal maruziyeti doğrudan otizm etiyolojisi olarak kanıtlanmamıştır.

Gerçek klinik adım: aileye gerçek risk faktörlerini (gebelikte valproat, hava kirliliğinin sınırlandırılması) ve gerçek koruyucu adımları (perikonsepsiyonel folat) belirt.

Mit 3: "Soğuk anne" (Bettelheim 'Refrigerator Mother' teorisi)

Neden yaygınlaştı: Bruno Bettelheim 1967 "The Empty Fortress" eserinde otizmi annelerin duygusal soğukluğuna bağladı; 1970'lere kadar baskın inanç.

Klinik ve biyolojik mantık: otizm nörogelişimsel bozukluktur — genetik ve erken beyin gelişimi ile ilişkilidir; ebeveyn davranışı otizme neden olmaz.

Kanıt: Rimland B. (1964) “Infantile Autism” — biyolojik etiyoloji argümanı; Folstein S., Rutter M. Nature 1977 — ikiz çalışması genetik kalıtımı kanıtlamıştır. APA, AAP, AACAP — “soğuk anne” konsepti geçersiz kılınmıştır.

Gerçek klinik adım: aileye suçlama yerine destek ve psikoeğitim; ebeveyn-koordineli müdahaleler (PACT, ESDM, Hanen).

10.2 Zararlı veya tehlikeli “tedavi” yöntemleri

Mit 4: “Şelasyon terapisi ağır metalleri çıkararak otizmi iyileştirir”

Neden yaygınlaştı: “ağır metal otizmi” yanlış teorisi; alternatif kliniklerin pazarlaması.

Kanıt ve risk: AAP 2010 ve FDA uyarısı — 5 yaşındaki bir çocuk Şelasyon prosedürü sırasında kalsiyum eksikliği nedeni ile kalp arrestinden ölmüştür (2005). Kelasyon sadece tespit edilmiş ağır metal zehirlenmesinde (yüksek kurşun) endikasyondur, otizm için değil. AAP, AACAP — mutlak kontrendikasyon.

Mit 5: “Hiperbarik oksijen odası (HBOT) otizmi iyileştirir”

Kanıt: Cochrane (Xiong T. ve ark. 2016) n=1 RKÇ derlemesi — otizm için etki kanıtı yoktur. Riskler: pnömotoraks, kulak barotravması, yangın (oksijen + statik).

Mit 6: “MMS / ‘Mucizevi Mineral Çözelti’ (klor dioksit) otizmi iyileştirir”

Kanıt: FDA 2019, EMA uyarıları — klor dioksit kostiktir, karaciğer ve böbrek hasarı, ölüm vakaları kaydedilmiştir. Tüm klinik kullanım yasaktır. Daha kötüsü — anüs temizlik aracı olarak tavsiye eden “tedavi” çocuk işkencesidir.

Mit 7: “Kök hücre enjeksiyonları otizmi iyileştirir”

Kanıt: ISSCR (International Society for Stem Cell Research) ve FDA — otizm için onaylanmış kök hücre tedavisi yoktur. Yasa dışı kliniklerde — enfeksiyonlar, beyin tümörleri, ölüm vakaları kaydedilmiştir (Berkowitz NEJM 2016).

Mit 8: “Çelyabinsk ilacı” ve benzeri tıbbi denetimsiz preparatlar

Kanıt: hiçbir onaylanmış düzenleyici kurum (FDA, EMA, EU) tarafından otizm tedavisi olarak onaylanmamış “alternatif” ilaçlar — risk yüksek, fayda kanıtlanmamış.

10.3 Etkisiz veya temel müdahaleyi geciktiren yöntemler

Mit 9: "Facilitated Communication (FC) ve Rapid Prompting Method (RPM) minimal verbal otizmli bireylerin iç dünyasını ortaya çıkarır"

Neden yaygınlaştı: duygusal olarak çekici hikayeler — fasilitatörün yardımıyla "konuşmaya başlayan" çocuklar.

Kanıt: ASHA Position Statement 2018 (güncelleme): bağımsız incelemeler göstermiştir ki mesajlar kolaylaştırıcıdan gelir (ideomotor etki), hastadan değil. Bu kanıt çok sayıda RKD'de doğrulanmıştır (Schlosser R.W. et al. Augment Altern Commun 2014). Klinik sonuç: aile için yanlış inanç; hastanın gerçek otantik iletişimi (PECS, AAC cihazları) geciktirilir; toplumsal zarar — hukuki sorunlarda yalan "tanıklık" olayları.

Gerçek klinik adım: minimal verbal hastalar için kanıtlanmış AAC araçları — PECS, tablet tabanlı iletişim programları (Proloquo2Go, TouchChat).

Mit 10: "Glutensiz/kazeinsiz diyet otizmi iyileştirir veya önemli ölçüde düzeltir"

Kanıt: Hyman S.L. et al. (AAP 2020 Clinical Report) — otizm semptomlarına özel diyetlerin etkisi kanıtlanmamıştır; gastrointestinal semptom veya çölyak hastalığı varsa diyet tıbbi endikasyondur. Geniş diyet kısıtlaması çocuklarda besin eksikliklerine ve yeme bozukluklarına yol açar. Karagas M.R. et al. JAMA Pediatr 2018 — geniş diyet kısıtlamasının riskleri.

Mit 11: "EEG Nörofeedback otizmin temel semptomlarını iyileştirir"

Kanıt: Holtmann M. et al. Dev Med Child Neurol 2011 derlemesi — DEHB'de mütevazı etki; otizm için spesifik kanıt zayıf. Adjunkt statü, birinci basamak değil. Hasta ve aileye açıkça açıklanmalıdır.

Mit 12: "Auditory Integration Training (AIT) otizmi iyileştirir"

Kanıt: ASHA Position Statement 2004; AAP 1998 — deneysel statü, etki kanıtı yoktur.

Mit 13: "Vitamin B6 / magnezyum veya diğer mega-doz vitamin terapisi"

Kanıt: Cochrane (Nye C., Brice A. 2005) — B6/magnezyum kombinasyonunun otizm için etkisi kanıtlanmamıştır. Vitamin mega-dozları yan etki yüküne (B6 nöropatisi) yol açabilir.

Mit 14: “Patterning” (Doman-Delacato)

Kanıt: AAP 1968 ve 2010 Statementleri — etkinlik kanıtı yoktur, aileye fazla zahmet; çocukları kanıtlı müdahalelerden geri tutar.

Mit 15: “Kranio-Sakral Terapi, refleksoterapi, homeopati”

Kanıt: Sistematik derlemeler (Cochrane ve diğerleri) — otizm için etki kanıtı yoktur. NICE CG170 — tamamlayıcı müdahalelere karşı uyarı.

11. Kaynaklar

1. WHO. ICD-11 for Mortality and Morbidity Statistics. 6A02 Autism spectrum disorder. 2024.
2. American Psychiatric Association. DSM-5-TR. Washington DC: APA Publishing; 2022.
3. NICE Clinical Guideline 170. Autism spectrum disorder in under 19s: support and management. 2013, 2021 update.
4. Hyman S.L., Levy S.E., Myers S.M.; AAP Council on Children with Disabilities. Identification, Evaluation, and Management of Children With Autism Spectrum Disorder. Pediatrics 2020;145(1):e20193447.
5. Volkmar F., Siegel M., Woodbury-Smith M., King B., McCracken J., State M. AACAP Practice Parameter for the Assessment and Treatment of Children and Adolescents With Autism Spectrum Disorder. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry 2014;53(2):237–257.
6. Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Prevalence and Characteristics of Autism Spectrum Disorder Among Children Aged 8 Years — Autism and Developmental Disabilities Monitoring Network. MMWR Surveill Summ 2023;72(2):1–14.
7. Sandin S., Lichtenstein P., Kuja-Halkola R. et al. The Heritability of Autism Spectrum Disorder. JAMA 2017;318(12):1182–1184.
8. Satterstrom F.K. et al. Large-Scale Exome Sequencing Study Implicates Both Developmental and Functional Changes in the Neurobiology of Autism. Cell 2020;180(3):568–584.
9. Taylor L.E., Swerdfeger A.L., Eslick G.D. Vaccines are not associated with autism: an evidence-based meta-analysis. Vaccine 2014;32(29):3623–3629.
10. Madsen K.M., Hviid A., Vestergaard M. et al. A population-based study of measles, mumps, and rubella vaccination and autism. NEJM 2002;347(19):1477–1482.

11. Christensen J., Grønborg T.K., Sørensen M.J. et al. Prenatal valproate exposure and risk of autism spectrum disorders. JAMA 2013;309(16):1696–1703.
12. Surén P., Roth C., Bresnahan M. et al. Association between maternal use of folic acid supplements and risk of autism spectrum disorders in children. JAMA 2013;309(6):570–577.
13. Volk H.E., Lurmann F., Penfold B. et al. Traffic-related air pollution, particulate matter, and autism. JAMA Psychiatry 2013;70(1):71–77.
14. Dawson G., Rogers S., Munson J. et al. Randomized, Controlled Trial of an Intervention for Toddlers With Autism: The Early Start Denver Model. Pediatrics 2010;125(1):e17–e23.
15. Reichow B., Hume K., Barton E.E., Boyd B.A. Early intensive behavioral intervention (EIBI) for young children with autism spectrum disorders (ASD). Cochrane Database Syst Rev 2018;(5):CD009260.
16. Pickles A., Le Couteur A., Leadbitter K., Salomone E., Cole-Fletcher R., Tobin H., Gammer I., Lowry J., Vamvakas G., Byford S., Aldred C., Slonims V., McConachie H., Howlin P., Parr J.R., Charman T., Green J. Parent-mediated social communication therapy for young children with autism (PACT): long-term follow-up of a randomised controlled trial. Lancet 2016;388(10059):2501–2509.
17. Kasari C., Gulsrud A., Paparella T., Hellemann G., Berry K. Randomized comparative efficacy study of parent-mediated interventions for toddlers with autism. J Consult Clin Psychol 2015;83(3):554–563.
18. McCracken J.T., McGough J., Shah B. et al. Risperidone in children with autism and serious behavioral problems. NEJM 2002;347(5):314–321.
19. Xiong T., Chen H., Luo R., Mu D. Hyperbaric oxygen therapy for people with autism spectrum disorder. Cochrane Database Syst Rev 2016; (10):CD010922.
20. ASHA Position Statement: Facilitated Communication. American Speech-Language-Hearing Association; 2018. asha.org/policy/PS2018-00352.
21. Goldman S.E., Adkins K.W., Calcutt M.W. et al. Melatonin in children with autism spectrum disorders. J Clin Sleep Med 2014;10(8):871–882.
22. Laugeson E.A., Frankel F., Gantman A., Dillon A.R., Mogil C. Evidence-based social skills training for adolescents with autism spectrum disorders: the UCLA PEERS program. J Autism Dev Disord 2012;42(6):1025–1036.
23. Lai M.C., Baron-Cohen S. Identifying the lost generation of adults with autism spectrum conditions. Lancet Psychiatry 2015;2(11):1013–1027.

24. Berkowitz A.L., Miller M.B., Mir S.A. et al. Glioproliferative lesion of the spinal cord as a complication of “stem-cell tourism”. NEJM 2016;375(2):196–198.
25. Bondy A., Frost L. The Picture Exchange Communication System. Behav Modif 2001;25(5):725–744.
26. Koegel R.L., Koegel L.K. Pivotal Response Treatments for Autism. Baltimore: Brookes, 2006.
27. Mesibov G.B., Shea V., Schopler E. The TEACCH Approach to Autism Spectrum Disorders. New York: Springer, 2005.
28. Storch E.A., Arnold E.B., Lewin A.B. et al. The effect of cognitive-behavioral therapy versus treatment as usual for anxiety in children with autism spectrum disorders: a randomized, controlled trial. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry 2013;52(2):132–142.

ICD-11 **6A03**	**6A03 GELİŞİMSEL ÖĞRENME BOZUKLUĞU** **Developmental learning disorder**
ICD-10 F81	Skolastik becerilerde özel gelişimsel bozukluklar
DSM-5-TR F81.0	Özgül Öğrenme Bozukluğu, Okuma bozukluğu olan

1. Tanım ve nozoloji

Gelişimsel öğrenme bozukluğu (ICD-11: 6A03 Developmental Learning Disorder; DSM-5-TR: F81.0–F81.81 Specific Learning Disorder) — hastanın yaşı, entelektüel düzeyi ve eğitim olanakları dikkate alındığında beklenmeyen, akademik becerilerden birinin veya birkaçının edinilmesinde sürekli ve belirgin zorluklarla ortaya çıkan nörogelişimsel bozukluktur.

ICD-11'de alt-spesifikasyonlar:

- 6A03.0 — okuma bozukluğu ile (disleksi);
- 6A03.1 — yazılı ifade bozukluğu ile (disgrafi);
- 6A03.2 — matematik bozukluğu ile (diskalkuli);
- 6A03.3 — diğer belirtilmiş veya birleşik.

2. Tarihçe

- Pringle Morgan W. (1896) — konjenital sözcük körlüğü — normal zekaya rağmen okuyamayan çocuğu tanımlamıştır.
- Orton S.T. (1925) — strephosymbolia kavramı; sol hemisfer baskınlığının zayıflığını hipotez etmiştir; Orton-Gillingham yönteminin temeli.
- DSM-III (1980) — Spesifik Gelişimsel Bozukluk kategorisi — IQ-akademik beceri farklılığı temelli (fark modeli).
- DSM-5 (2013) — farklılık modelinin kaldırılması: "Özgül Öğrenme Bozukluğu" — IQ kesme noktası gerektirmez; sürekli işlevsel zorluk ve müdahaleye yanıtsızlık temel alınır. Alt tiplerin (okuma, yazma, matematik) ayrı ayrı kodlanması korunur.
- ICD-11 (2019) — paralel yapı; "Developmental Learning Disorder" terimi ile.
- Fonolojik defisit teorisi (Stanovich K.E., Snowling M.J., Vellutino F.R.) — disleksinin temel mekanizması olarak 1990–2000 yıllarında dominantlığa ulaşmıştır.

3. Epidemiyoloji

- Genel yaygınlık: okul çağı çocuklarda %5–15 (DSM-5-TR tahmini); ülke ve dilin ortografik derinliğine bağlı olarak değişir (İngilizce gibi derin ortografili dillerde oran yüksektir).
- Disleksi: %5–10 okul çağı çocuklarında; en sık alt tip.
- Diskalkuli: %3–7 (Shalev R.S. Pediatr Neurol 2007 derleme).
- Disgrafi: %4–7 (Berninger V.W. Top Lang Disord 2008).
- Cins: okuma ve yazma bozukluklarında erkeklerde 2–3 kat yüksek (kadınlarda az tanı alma hipotezi mevcuttur); matematik bozukluğunda cinsiyetler eşit.
- Komorbidite: DEHB %30–40, dil bozuklukları %50–60 (okuma bozukluğunda), anksiyete, depresyon, davranış bozuklukları artmış risk.

4. Etiyoloji ve patogenez

4.1 Genetik faktörler

- Kalıtım: dislekside %50–70 (Pennington B.F. Cogn Neuropsychol 2002 ikiz çalışmaları derlemesi).

- Belirlenmiş risk genleri: DYX1C1 (15q21), KIAA0319 (6p22), DCDC2 (6p22), ROBO1 (3p12) — nöral migrasyon ve korteks oluşumu ile ilişkili; ancak tek gen değil, poligenik risk mimarisi.
- Matematik bozukluğunda da yüksek kalıtım (~%70), MYT1L ve diğer genler önerilmektedir (Mascheretti S. et al. Trends Genet 2018).

4.2 Nörobiyolojik mekanizmalar

- Disleksi — fonolojik defisit: Sol perisilviyan alanlarda (Wernicke, angular girus, superior temporal girus) atipik aktivasyon modelleri (Shaywitz S.E., Shaywitz B.A. Biol Psychiatry 2008 fMRI derlemesi). Fonem-grafem (ses-harf) eşlemesinde defisit okuma güçlüğünün çekirdeğidir.
- Diskalkuli — sayı hissi (approximate number system) ve işler bellek: intraparietal sulkus ve prefrontal kortekste işlevsel bozulma (Butterworth B. Trends Cogn Sci 2010).
- Disgrafi: motor planlama ve ortografik kodlama defisitleri; sol fusiform ve premotor alanlar.

4.3 Çevresel faktörler (modifikatör)

- Erken eğitim kalitesi ve okuma öğretimi metodolojisi — fonolojik yaklaşımın olmaması poligenik riski olan çocukta daha büyük akademik fark yaratır.
- Düşük sosyo-ekonomik statü — etiyoloji değil, tanımlama ve müdahaleye erişilebilirlik faktörü.
- Kronik orta kulak iltihabı — erken fonolojik gelişimi etkileyebilir.

5. Klinik özellikler

5.1 Okuma bozukluğu (disleksi, 6A03.0)

- Sözcük tanımada kesinsizlik ve yavaşlık — sözcükleri yavaş, mücadele ile okur, harfleri değiştirir veya atlar.
- Fonolojik farkındalık defisiti — kafiye, harf-ses ilişkisi, kelimeleri seslere ayırma güçlüğü.
- Yazma ve imla — fonetik kurallara uymayan yazım hataları.
- Okuduğunu anlama — kelime çağrışım defisitine bağlı sekonder bozulma.
- Erken belirtiler (okul öncesi) — harf adlarını öğrenmede gecikme, kafiye oyunlarında zorluk, ad okuma güçlüğü.

5.2 Yazılı anlatım bozukluğu (disgrafi, 6A03.1)

- El yazısı kalitesiz, okunaksız, yavaş.
- Cümle kurma, gramer, paragraf düzenlemede zorluk.
- Yazım ve noktalamada sürekli hatalar.
- Yazılı ve sözlü ifade becerileri arasında büyük fark.

5.3 Matematik bozukluğu (diskalkuli, 6A03.2)

- Sayı hissi defisiti — nicelik karşılaştırması, miktarın değerlendirilmesi.
- Matematiksel gerçekleri (örn. çok aşamalı çarpım tablosu) hatırlamada zorluk.
- Matematiksel işlemler — toplama, çıkarma, çok aşamalı problemlerde yavaşlık ve hatalar.
- Matematiksel problemlerin sözcüklerle sunulmasında zorluk.

6. Tanı

6.1 Birleşik tanı ölçütleri (DSM-5-TR · ICD-11 konsensus noktaları)

A. Akademik becerilerin elde edilmesinde ve kullanımında sürekli zorluklar — en az 6 aydır, yaşa uygun hedefli müdahaleye rağmen devam ediyor. Aşağıdaki semptomlardan en az biri:

1. Sözcükleri okumada kesinsizlik veya yavaşlık;
2. Okuduğu metni anlamada güçlük;
3. Yazım güçlükleri;
4. Yazılı ifadede zorluklar (dil bilgisi, noktalama, organizasyon);
5. Sayı hissi ve hesap becerilerinde zorluklar;
6. Matematiksel muhakemede zorluklar.

B. Akademik beceriler yaşa uygun beklenen düzeyden belirgin şekilde düşüktür — standartlaştırılmış testlerde (kronolojik yaş için -1,5 SD veya altı) belgelenmiş, akademik veya mesleki faaliyette işlevsel bozulma yaratır.

C. Başlangıç okul çağında (ancak akademik talepler artana kadar tam olarak görünmeyebilir).

D. Dışlamalar — entelektüel yetersizlik, işitme/görme defisiti, başka nörolojik veya psikiyatrik durum, psikososyal yoksunluk, akademik eğitim dilinde akıcılık sorunu, yetersiz eğitim ile tam olarak açıklanmaz.

6.2 Kaynaklar arasındaki farklar

- DSM-5-TR: "IQ-akademik beceri farklılığı" modeli kaldırılmıştır — tanı için IQ kesme sınırı gerekmez; uzun süreli müdahaleye yanıtsızlık önemlidir. Şiddet: hafif, orta, ağır — uyumsal işleve göre.
- ICD-11 (6A03): paralel yapı; alt-spesifikasyonlar (okuma, yazma, matematik). Şiddet ayrı bir niteleyici değildir.
- IDA — International Dyslexia Association: disleksi — nörobiyolojik kökenli, fonolojik işlemede defisit; "neuroinformation-processing" bozukluğu. Standardize edilmiş işlemleme değerlendirmesi + yanıt izlemi (Response to Intervention, RTI) önerilir.
- AAP Clinical Report on Dyslexia (Handler S.M., Fierson W.M. Pediatrics 2011, reaffirmed): tanı pediatristler tarafından yönlendirilmeli, değerlendirme multidisipliner — psikolog + dil-konuşma patoloğu + eğitim uzmanı.
- NICE: özgül öğrenme bozukluğu için ayrı bir klinik rehber yoktur; temel çerçeve eğitim sistemi içindedir (SEND Code of Practice, EHCP).

6.3 Tanı algoritması

1. Öğretmen ve veli görüşmesi — akademik geçmiş, müdahaleye yanıt.
2. Görme ve işitme testleri (duyusal bozukluk dışlama).
3. Standardize edilmiş akademik beceri testleri — Woodcock-Johnson IV, WIAT-4, KTEA-3.
4. Fonolojik farkındalık ve okuma değerlendirmesi — CTOPP-2, GORT-5, TOWRE-2.
5. Matematik için — KeyMath-3, TEMA-3.
6. Zekâ değerlendirmesi (WISC-V) — entelektüel yetersizlik dışlaması için; diskrepans artık tanı için gerekli değildir.
7. Dikkat, yürütücü işlev (BRIEF-2), işler bellek değerlendirmesi.
8. Müdahaleye yanıt (Response to Intervention, RTI) belgelendirmesi — 6+ ay yaşa uygun müdahaleye rağmen devam eden güçlük.
9. Komorbidite taraması — DEHB, dil bozukluğu, anksiyete, depresyon.

6.4 Ayırıcı tanı

Durum	**Ayırt edici belirtiler**
Entelektüel gelişim bozukluğu (6A00)	Akademik defisit genel bilişsel defisit bağlamında; uyumsal işlev de bozulmuştur.

Durum	Ayırt edici belirtiler
Gelişimsel dil bozukluğu (6A01)	Sözel dilin edinimi bozulmuş; okuma ve yazma sorunları ikincildir.
DEHB (6A05)	Dikkat eksikliği akademik başarıyı azaltır; standartlaştırılmış testlerde akademik beceriler genellikle dikkat durumuna uygundur. Komorbidite sıktır.
Görme/işitme bozukluğu	Duyusal muayene ile tespit edilir.
Sosyo-ekonomik yoksunluk, yetersiz eğitim	Uygun eğitim ortamında akademik başarı düzelir.
İkinci dilin öğrenilmesi (English Language Learner)	Anadilinde akademik beceriler değerlendirilmelidir; iki dillilik kendi başına tanı temeli değildir.

7. Muayene ve değerlendirme

7.1 Standardize testler

- Akademik beceriler: Woodcock-Johnson IV (kompleks), WIAT-4 (Wechsler Individual Achievement Test), KTEA-3.
- Okuma: GORT-5 (Gray Oral Reading Test), TOWRE-2 (Test of Word Reading Efficiency), CTOPP-2 (Comprehensive Test of Phonological Processing).
- Matematik: KeyMath-3, TEMA-3 (Test of Early Mathematics Ability).
- Zekâ ve kognisyon: WISC-V, WJ-IV Cognitive.
- Yürütücü işlev: BRIEF-2 (ebeveyn/öğretmen anketi).
- İşler bellek, işlem hızı: WISC-V indeksleri, dijit span, Trail Making.

7.2 Laboratuvar incelemeleri

Rutin laboratuvar göstergesi yoktur. Spesifik klinik şüphe temelinde:

- Kurşun seviyesi — risk faktörleri varsa.
- Tiroid fonksiyonu — konjenital hipotiroidi saptanmamışsa.
- Genetik araştırma — komorbid entelektüel yetersizlik veya sendromal belirtiler varsa.

7.3 Enstrümantal incelemeler

- Beyin MRG — rutin endikasyon yoktur; fokal nörolojik belirtiler, nöbetler, regresyon olduğunda.
- EEG — tutma şüphesi, Landau-Kleffner istisnası.
- İşitme testi ve görme testi — tüm vakalarda mutlaka ilk değerlendirmeler.

8. Tedavi

8.1 Genel prensipler (IDA · AAP 2011 · APA · NASP konsensus)

1. Spesifik öğrenme bozukluğu farmakolojik yolla tedavi edilmez. Müdahale — kanıta dayalı eğitim ve terapidir.
2. Erken tanımlama ve müdahale — okul öncesi ve erken okul çağında müdahale etkinliği anlamlı derecede yüksektir. RTI (Response to Intervention) modeli — yaşa uygun müdahale aşamalı, yanıtsızlık tanısal değerlendirmeye yol açar.
3. Disleksi — Structured Literacy yaklaşımı: Sistematik, ardışık, açık, çok duyulu, tanısal eğitim. Fonolojik farkındalık + fonem-grafem eşlemesi + sözcük yapısı + sözdizimi + anlambilim. Orton-Gillingham, Wilson Reading System, Lindamood-Bell tipik programlar.
4. Diskalkuli: Concrete-Representational-Abstract (CRA) instruction; sayı hissi gelişimi, matematiksel gerçeklerin ezberlenmesi egzersizleri.
5. Disgrafi: El yazısı eğitimi (örneğin, Handwriting Without Tears), klavye öğrenme, kelime-cümle organizasyon stratejileri, voice-to-text teknolojisi.
6. Akademik akomodasyon: Ek süre, sesli kitaplar, klavye, metin okuyucu programlar (text-to-speech), matematikte hesap makinesi — IEP / EHCP kapsamında.
7. Komorbidite tedavisi: DEHB — uyarıcılar; anksiyete ve depresyon — BDT; dil bozukluğu — DKT.
8. Sosyo-duygusal destek: Öğrenme bozukluğu olan çocuklarda özsaygı, motivasyon, anksiyete sorunları yüksek risk oluşturur.

8.2 Tedavi metodolojileri

1. Orton-Gillingham (OG) yaklaşımı — Yapılandırılmış multisensöriyel fonem-grafem temelli okuma ve yazma eğitimi. Disleksi için birinci basamak metodoloji; sertifikalı öğretmen/terapist tarafından yürütülür. Kanıt: Stevens E.A. et al. J Learn Disabil 2021 meta-analiz — okuma ve yazmada orta etki büyüklüğü. Academy of Orton-Gillingham Practitioners.

2. Wilson Okuma Sistemi (Wilson Reading System) — Orton-Gillingham prensiplerine dayalı, 12 basamaklı kompleks okuma ve imla programı; 6 yaştan yetişkinliğe kadar. wilsonlanguage.com.
3. Lindamood-Bell programları — LiPS (Lindamood Phoneme Sequencing) — fonem farkındalığını motor-kinestetik bileşenle birleştirir; Seeing Stars — orfografik kodlama. lindamoodbell.com.
4. Yapılandırılmış Okuryazarlık (Structured Literacy — IDA Knowledge and Practice Standards) — Spesifik program değil, çerçeve — sistematik, ardışık, açık, çok duyulu, tanısal eğitim ilkeleri. Orton-Gillingham, Wilson, Lindamood-Bell ve diğerleri bu çerçeveye uygundur. dyslexiaida.org.
5. Somut-Temsili-Soyut Öğretim (CRA — Concrete-Representational-Abstract Instruction) — Diskalkuli için — somut manipülatif araçlarla başlayan, sonra çizim sunumuna, daha sonra soyut sembolik işlemlere geçişle eğitim. Kanıt: Witzel B.S. et al. J Spec Educ Technol 2003.
6. "Handwriting Without Tears" programı — Olsen (Olsen J.) — Disgrafi ve yazma güçlüklerinde kullanılan multisensöriyel el yazısı eğitimi programı. lwtears.com.
7. Müdahaleye Yanıt (RTI — Response to Intervention) / Çok Katmanlı Destek Sistemi (MTSS — Multi-Tiered System of Supports) — 3 aşamalı çerçeve — Aşama 1: evrensel düzeyde kaliteli eğitim; Aşama 2: hedefli küçük grup müdahalesi; Aşama 3: yoğun bireysel müdahale. ABD'de IDEA 2004 yasası ile belirlenmiştir; benzer çerçeveler diğer ülkelerde.
8. Yardımcı Teknoloji (Assistive Technology) — Text-to-speech (Read&Write, NaturalReader), speech-to-text (Dragon Naturally Speaking), sesli kitaplar (Bookshare, Learning Ally), matematik için hesaplama araçları — işlevsel kompanzasyon. AAP ve IDA tarafından önerilir.
9. Fonolojik İşlemenin Kapsamlı Testi (CTOPP-2 — Comprehensive Test of Phonological Processing) — Fonolojik farkındalığın standartlaştırılmış değerlendirilmesi — disleksi tanımlamasında altın standart.
10. GORT-5 (Gray Oral Reading Test) ve TOWRE-2 — Okuma hızı, doğruluğu ve akıcılığının ölçülmesi.

8.3 Kaynaklar arasındaki farklar

- IDA Knowledge and Practice Standards for Teachers of Reading (2018): Yapılandırılmış Okuryazarlık çerçevesi; sertifikalı öğretmen gereksinimi.
- AAP 2011 (Handler & Fierson): disleksi biyolojik temelli; akademik müdahale birinci basamak; görsel terapi kontrendikedir (10.3 bölümüne bakınız).

- National Reading Panel (NRP) 2000: beş temel okuma bileşeni — fonolojik farkındalık, fonik, akıcılık, kelime bilgisi, anlama.
- NASP (National Association of School Psychologists): RTI çerçevesinde 3 basamak — evrensel tarama, hedefli müdahale, yoğun bireysel müdahale.

9. Prognoz

İyi prognoz faktörleri

- Erken tanımlama (okul öncesi veya erken okul çağı).
- Kanıtlı Structured Literacy müdahalesi.
- Yüksek IQ — kompansatuar stratejilerin gelişimi.
- Stabil aile desteği ve motivasyon.
- Yalnızca bir akademik alana etki (örn. tek okuma, matematik normal).

Kötü prognoz etkenleri

- Geç identifikasyon (okul çağının ortası veya sonu).
- Çok sayıda akademik alanı etkiler.
- Komorbid DEHB, dil bozukluğu, anksiyete.
- Düşük sosyo-ekonomik destek, sınırlı eğitim kaynakları.
- Müdahale kanıtlanmamış yöntemlerle (renkli lensler, görsel terapi, Brain Gym).

İzlem hedefleri

- Akademik başarı izlemi — yıllık standartlaştırılmış testler.
- Sosyo-duygusal sağlık — özsaygı, anksiyete, depresyon taraması.
- Komorbid DEHB ve dil bozukluğu için ayrı müdahale.
- Yetişkinlikte mesleki ve akademik akomodasyon planlaması (yüksek öğrenimde engellilik olanakları, iş yerinde uyum).
- Yardımcı teknoloji kullanımının güçlendirilmesi (text-to-speech, hesap makinesi).

10. Mit ve yanlış inançlar

10.1 Etiyoloji mitleri

Mit 1: "Disleksi — çocuğun tembelliği veya kötü terbiyesinin sonucudur"

Neden yaygınlaştı: "yeterince çalışırsa okuyabilir" inancı; akademik mücadelenin karakter sorunu olarak yanlış açıklanması.

Klinik ve biyolojik mantık: Disleksi — nörobiyoloji bozukluktur. fMRI çalışmaları (Shaywitz S.E. Biol Psychiatry 2008) sol perisilvian alanlarda atipik aktivasyon paternleri göstermiştir; kalıtım %50–70, tanımlanmış risk genleri (DYX1C1, KIAA0319, DCDC2). Hasta çalışmaktan çok, daha yüksek bilişsel çaba harcamak zorundadır — bu ise kronik tükenmeye yol açar.

Kanıt: IDA Definition (2002, güncelleme) — "Disleksi nörobiyolojik kökenli spesifik öğrenme bozukluğudur."

Gerçek klinik adım: Aileye biyolojik temelleri açıkla; suçlama yerine kanıtlanmış Structured Literacy müdahalesi ve akademik akomodasyon.

Mit 2: "Disleksi — çocukların harfleri ters (aynalı) yazmasıdır"

Neden yaygınlaştı: Orton 1925 "strephosymbolia" terimi ve popüler medyada tekrarlanan imaj.

Klinik ve biyolojik mantık: Harfleri ters yazma ve okuma 4-7 yaş arası tüm çocuklarda normaldir; 8 yaşından sonra devam eden harf inversiyonu klinik şüphe yaratabilir, ancak disleksinin temel belirtisi değildir. Disleksinin çekirdeği fonolojik işlemedeki defisittir.

Kanıt: Stanovich K.E. (2000) — fonolojik defisit teorisi; görsel-uzaysal defisit birincil etiyoloji değildir.

Mit 3: "Disleksili çocuklar yaşla 'geçer', müdahaleye gerek yoktur"

Kanıt: Bruck M. Dev Psychol 1992 — uzun süreli izlem çalışmaları: müdahale almayan disleksili çocuklar yetişkinlikte de okuma güçlüklerini sürdürür; akademik ve mesleki sonuçlar kötüdür. Müdahale ne kadar erken başlarsa, kompanzasyon potansiyeli o kadar yüksektir.

10.2 Zararlı veya bilimsel olarak temelsiz yöntemler

Mit 4: “Renkli lensler (Irlen lensleri) veya renkli üst-örtüler disleksiyayı iyileştirir”

Neden yaygınlaştı: 1980'lerde Helen Irlen tarafından “scotopic sensitivity syndrome” konsepti; ticari optometrik kliniklerin pazarlaması.

Kanıt: AAP, AAO (American Academy of Ophthalmology) ve AAPOS (American Association for Pediatric Ophthalmology and Strabismus) 2009 ve 2014 Ortak Bildirgeleri: renkli lenslerin ve üst-örtülerin disleksi için etkisi kanıtlanmamıştır; Cochrane (Evans B.J., Allen P.M. 2016) sistematik derlemesi — yeterli etki kanıtı yoktur. AAP — birinci sıra müdahaleyi (Structured Literacy) geciktirir.

Gerçek klinik adım: Aileye açık açıklama; müdahale olarak kanıtlanmış fonolojik okuma programı.

Mit 5: “Görsel terapi (göz egzersizleri) disleksiyiyi iyileştirir”

Kanıt: AAP, AAO, AAPOS 2009 Ortak Bildirisi — disleksinin göz hareketi bozukluğu değil, dil temelli bir bozukluk olduğunu vurgular; göz egzersizlerinin okuma performansına etkisi kanıtlanmamıştır. Görsel terapi yalnızca belirli göz hareketi bozukluklarında (örn. konverjans yetmezliği) endikedir.

Mit 6: “Brain Gym / Educational Kinesiology”

Kanıt: Hyatt K.J. Remedial Spec Educ 2007 sistematik derlemesi — iddialar nörobiyolojiyle uyumlu değil; akademik başarıya etkisi yok. Dönüşüm programı olarak eleştiriliyor.

Mit 7: “Dore programı (Serebellar Egzersiz Terapisi)”

Neden yaygınlaştı: Wynford Dore 2000'li yıllarda serebellar fonksiyonu okuma ile ilişkilendiren teoriyi popülerleştirdi; “olumlu sonuçlar” açıklamaları medya ilgisini çekti.

Kanıt: Reynolds D., Nicolson R.I. orijinal çalışmaları metodolojik olarak ciddi eleştiri almıştır (Bishop D.V. Dyslexia 2007); tekrar çalışmalarda etki doğrulanmamıştır. British Dyslexia Association — Dore programını önermemektedir.

10.3 Etkisiz veya temel müdahaleyi geciktiren yöntemler

Mit 8: "Whole Language yaklaşımı, fonik yerine okumayı öğretir"

Kanıt: National Reading Panel 2000 (NRP) — sistematik fonik eğitimi açıkça üstündür "whole language" yaklaşımından, özellikle öğrenme güçlüğü olan çocuklarda. Aynı konum Endrew F. v. Douglas County (ABD Yüksek Mahkemesi 2017) kararı ile eğitim hukuki standartlarına dahil edilmiştir. "Reading Wars" tartışması esas olarak sistematik fonetik lehine çözülmüştür.

Mit 9: "Auditory Integration Training (AIT) / Tomatis yöntemi disleksiyi iyileştirir"

Kanıt: ASHA Position Statement 2004 — AIT'nin disleksi veya öğrenme bozukluğu için etkisi kanıtlanmamıştır.

Mit 10: "EEG Nörofeedback disleksiyayı veya diskalkuliyayı iyileştirir"

Kanıt: Spesifik öğrenme bozukluğu için neurofeedback etkinliği kanıtlanmamıştır. DEHB'de ılımlı etkinlik (Holtmann 2011), ancak öğrenme bozukluklarına ekstrapolasyon temelsizdir.

Mit 11: "Özel diyet (glutensiz, omega-3 mega-doz, 'beyin gıdası') disleksiyi iyileştirir"

Kanıt: Cochrane ve sistematik derlemeler (Tan M.L. et al. J Pediatr 2012 omega-3 için) — dislekside sürekli klinik etki kanıtlanmamıştır. Bazı çalışmalarda küçük etki gösterilmiştir, ancak metodolojik sınırlamalar mevcuttur.

Mit 12: "Hiperbarik oksijen odası (HBOT) veya kök hücre enjeksiyonları"

Kanıt: Spesifik öğrenme bozukluğu için etkin kanıt bulunmamaktadır; risk profilinin önemli olması (HBOT — pnömotoraks; kök hücre — enfeksiyon, ölüm vakaları).

11. Kaynaklar

1. WHO. ICD-11 for Mortality and Morbidity Statistics. 6A03 Developmental learning disorder. 2024.
2. American Psychiatric Association. DSM-5-TR. Washington DC: APA Publishing; 2022.
3. International Dyslexia Association. Definition of Dyslexia. 2002, updated. dyslexiaida.org.
4. IDA Knowledge and Practice Standards for Teachers of Reading. 2018.

5. Handler S.M., Fierson W.M., American Academy of Pediatrics Section on Ophthalmology, Council on Children with Disabilities. Joint Technical Report — Learning Disabilities, Dyslexia, and Vision. Pediatrics 2011;127(3):e818–e856.
6. National Reading Panel. Teaching Children to Read: An Evidence-Based Assessment of the Scientific Research Literature on Reading and Its Implications for Reading Instruction. NIH; 2000.
7. Pennington B.F. From single to multiple deficit models of developmental disorders. Cogn Neuropsychol 2002;19(5):385–414.
8. Shaywitz S.E., Shaywitz B.A. Paying attention to reading: The neurobiology of reading and dyslexia. Biol Psychiatry 2008;63(3):219–225.
9. Butterworth B. Foundational numerical capacities and the origins of dyscalculia. Trends Cogn Sci 2010;14(12):534–541.
10. Shalev R.S. Prevalence of developmental dyscalculia. Pediatr Neurol 2007;37(6):385–391.
11. Berninger V.W., Niedo J. Aphasia and apraxia of speech in adults vs. dyslexia and dysgraphia in children. Top Lang Disord 2008;28(2):143–153.
12. Stevens E.A., Austin C., Moore C. et al. Current state of the evidence: Examining the effects of Orton-Gillingham reading interventions for students with or at risk for word-level reading disabilities. J Learn Disabil 2021;54(6):399–414.
13. Bruck M. Persistence of dyslexics' phonological awareness deficits. Dev Psychol 1992;28(5):874–886.
14. American Academy of Pediatrics, American Academy of Ophthalmology, American Association for Pediatric Ophthalmology and Strabismus. Joint Statement — Learning Disabilities, Dyslexia, and Vision. Pediatrics 2009;124(2):837–844.
15. Evans B.J., Allen P.M. A systematic review of controlled trials on visual stress using Intuitive Overlays or the Intuitive Colorimeter. J Optom 2016;9(4):205–218.
16. Witzel B.S., Mercer C.D., Miller M.D. Teaching algebra to students with learning difficulties: an investigation of an explicit instruction model. J Spec Educ Technol 2003;18(3):27–34.
17. Hyatt K.J. Brain Gym: building stronger brains or wishful thinking? Remedial Spec Educ 2007;28(2):117–124.
18. Bishop D.V.M. Curing dyslexia and attention-deficit hyperactivity disorder by training motor co-ordination: Miracle or myth? Dyslexia 2007;13(1):4–7.

19. Tan M.L., Ho J.J., Teh K.H. Polyunsaturated fatty acids (PUFAs) for children with specific learning disorders. Cochrane Database Syst Rev 2012; (12):CD009398.
20. Olsen J.Z. Handwriting Without Tears. Cabin John: Handwriting Without Tears, 2008.
21. Reynolds D., Nicolson R.I., Hambly H. Evaluation of an exercise-based treatment for children with reading difficulties. Dyslexia 2003;9(1):48–71.
22. Snowling M.J., Hulme C. A critique of claims from Reynolds, Nicolson & Hambly (2003) that DDAT is an effective treatment for children with reading difficulties. Dyslexia 2003;9(2):127–133.

ICD-11 **6A04**	**6A04 GELİŞİMSEL MOTOR KOORDİNASYON BOZUKLUĞU (DCD)** **Developmental motor coordination disorder**
ICD-10 F82	Motor fonksiyonda özel gelişimsel bozukluk
DSM-5-TR F82	Gelişimsel Eşgüdüm Bozukluğu

1. Tanım ve nozoloji

Gelişimsel motor koordinasyon bozukluğu (ICD-11: 6A04 Developmental Motor Coordination Disorder; DSM-5-TR: F82 Developmental Coordination Disorder, DCD) — çocuğun kronolojik yaşı, entelektüel düzeyi ve motor becerileri öğrenme olanakları dikkate alındığında beklenmeyen, günlük motor becerilerin edinilmesinde ve uygulanmasında sürekli zorluklarla ortaya çıkan nörogelişimsel bozukluktur.

Eski adlandırmalar — “clumsy child syndrome”, “developmental dyspraxia”, “minimal brain dysfunction” — modern klinik pratikte terk edilmiş, DCD terimi ile değiştirilmiştir (Polatajko H.J., Fox A.M., Missiuna C. Can J Occup Ther 1995, “Leeds Consensus 2006”).

2. Tarihçe

- 1937 — Orton S.T. “developmental clumsiness” konsepti.

- 1960–70'ler — minimal beyin disfonksiyonu (MBD) — geniş ve belirsiz terim, sonradan terk edilmiştir.
- DSM-III-R (1987) — "Gelişimsel Koordinasyon Bozukluğu" resmi tanısal kategori olarak.
- Leeds Konsensus (2006) — uluslararası uzman grubu "DCD" terimini standartlaştırdı; "dispraksi" ve "DCD"nin eşanlamlı kabul edilmemesi hakkında bildiri (dispraksi — daha dar konsept, motor planlama defisiti).
- EACD (European Academy of Childhood Disability) Uluslararası Klinik Uygulama Önerileri — 2012, 2019 güncellemesi (Blank R., Barnett A.L., Cairney J. et al. Dev Med Child Neurol 2019) — tanı, muayene ve müdahale konusunda uluslararası standart.
- DSM-5 (2013) ve ICD-11 (2019) — DCD genel nörogelişimsel bozukluklar kategorisine dahil edilmiştir.

3. Epidemiyoloji

- Yaygınlık: okul çağı çocuklarda %5–6 (EACD 2019; Lingam R. et al. Pediatrics 2009 İngiltere ALSPAC çalışması n>6900).
- Cins: erkeklerde 2–7 kat yüksek (kadınlarda az tanı alma hipotezi mevcuttur).
- Persistans: %50–70 hastada motor zorluklar erişkinlikte de devam eder (Cantell M.H. et al. J Adolesc Res 2003 izleme; Kirby A. et al. Res Dev Disabil 2010).
- Komorbidite: DEHB %50, özgül öğrenme bozukluğu %50, otizm spektrumu %5–10, gelişimsel dil bozukluğu %20–30, anksiyete ve depresyon ergenlikte artmış risk.

4. Etiyoloji ve patogenez

4.1 Genetik ve nörobiyolojik faktörler

- Kalıtım çalışmaları sınırlıdır, ancak ailede DCD öyküsü risk faktörü olarak gösterilmektedir (Gaines R. et al. Phys Occup Ther Pediatr 2008).
- Nörobiyolojik — beyincik (serebellum), bazal gangliyon, parietal korteks ve premotor alanların fonksiyonel bağlantısında atipik modeller (Zwicker J.G. et al. Eur J Paediatr Neurol 2012 fMRI incelemesi). İçsel modelleme eksikliği hipotezi — motor planlamadan önce öngörü ve karşılaştırma süreçlerinin bozulması (Adams I.L. et al. Dev Med Child Neurol 2014).

4.2 Risk faktörleri

- Erken doğum (<32 hafta) ve düşük doğum ağırlığı (<1500 gr) — DCD riskini 6–8 kat artırır (Edwards J. et al. Dev Med Child Neurol 2011 sistematik derleme).
- Annede gebelikte alkol kullanımı (FASD spektrumunda motor zorluk bileşeni).
- Perinatal hipoksik-iskemik olaylar.
- Aile öyküsünde DCD veya diğer nörogelişimsel bozukluklar.

5. Klinik özellikler

5.1 Motor beceri alanlarına göre

- Yüksek motor (kaba motor): koşma, atlama, top oyunları, bisiklet sürme, dengede zorluk; spor aktivitesinden kaçınma.
- İnce motor (fine motor): El yazısı kalitesiz ve yavaş, makas, ip bağlama, düğmeleme, çatal-bıçak kullanımı.
- Motor planlama ve yürütme: yeni motor becerilerin öğrenilmesinde gecikme; sıra ve ritim sorunu.
- Görsel-motor entegrasyon: kopyalama, çizim, harflerin şekillendirilmesinde zorluk.

5.2 Günlük işlevsel bozulma

- Öz-bakım — giyim, besin alımı, hijyen.
- Akademik işlev — el yazısı hızı, sayfa düzeni, spora katılım.
- Toplum aktivitesi — oyun alanı, spor takımları, hobiler.
- Psikososyal sonuçlar — özsaygı azalması, anksiyete, depresif duygudurum, sosyal izolasyon (Cairney J. et al. Dev Med Child Neurol 2013).

5.3 Seyir

Erken belirtiler (1–3 yaş) — motor evrelerde gecikme (oturma, ayakta durma, ilk adımlar normal zamanda veya geç; özel hareketlerin kalitesi zayıf). Okul öncesi ve erken okul çağında zorluklar belirginleşir; akademik taleplerin artmasıyla (yazma, kağıt işi) bozukluk daha belirgin hale gelir. Yetişkinlikte — sürücülük, mesleki talepler, spor aktivitelerinde sürekli zorluk (%50–70).

6. Tanı

6.1 Birleşik tanı ölçütleri (DSM-5-TR · ICD-11 · EACD 2019 konsensus noktaları)

A. Motor becerilerin elde edilmesi ve icrası — kronolojik yaş ve motor öğrenme olanakları dikkate alındığında beklenen düzeyden anlamlı derecede düşüktür. Zorluklar yavaşlamaya, yanlışlığa, motor becerilerin yerine getirilmesinde koordinasyonsuzluğa neden olur.

B. Motor beceri defisiti kronolojik yaşa uygun günlük yaşam aktivitelerine önemli ve sürekli şekilde müdahale eder (örn. öz bakım, akademik başarı, mesleki faaliyet, oyun ve spor).

C. Başlangıç erken gelişim döneminde.

D. Dışlamalar — entelektüel yetersizlik, görme bozukluğu veya başka nörolojik durum (örn. serebral palsi, kas distrofisi, dejeneratif bozukluklar) ile tam olarak açıklanmaz.

6.2 Kaynaklar arasındaki farklar

- EACD 2019 (Blank et al.): dört tanısal ölçüt standardize edilmiştir — motor beceri testinde 5–15. persentilin altında sonuç (Movement Assessment Battery for Children, MABC-2 veya benzeri); günlük işlev bozukluğu; başlangıç erken gelişim döneminde; başka tıbbi durumlarla açıklanamama. Multidisipliner değerlendirme (pediatrist + ergoterapist veya fizyoterapist) önerilir. Tanı 5 yaşından itibaren önerilir (motor beceriler stabilize olduktan sonra); 5 yaşına kadar "Geçici DCD" veya "motor gelişim gecikmesi" terimi kullanılabilir.
- DSM-5-TR: EACD ile paralel kriterler; "dispraksi" terimi kullanılmaz.
- ICD-11: motor gelişim bozukluğu; alt-spesifikasyonlar yoktur.

6.3 Tanı algoritması

1. Ebeveyn ve öğretmen görüşmesi — gelişim öyküsü, motor evreler, günlük aktivite sorunları.
2. Standardize edilmiş motor testi — MABC-2 (Movement Assessment Battery for Children-2, 3–16 yaş) veya BOT-2 (Bruininks-Oseretsky Test of Motor Proficiency).
3. İşlevsel günlük aktivite değerlendirmesi — DCDQ (Developmental Coordination Disorder Questionnaire, ebeveyn formu), VABS uyum bileşeni.
4. Görme testi — duyusal bozukluk dışlaması.

5. Nörolojik muayene — serebral palsi, ataksi, nöromüsküler hastalık dışlanması.
6. Komorbidite taraması — DEHB (Conners), spesifik öğrenme bozukluğu, otizm, dil bozukluğu.
7. Zekâ değerlendirmesi — yalnızca genel gelişim geriliği veya entelektüel yetersizlik şüphesi varsa.

6.4 Ayırıcı tanı

Durum	Ayırt edici belirtiler
Serebral palsi	Spastisite, hiperrefleksi, stabil nörolojik bulgular; MRG tipik bulgular.
Kas distrofisi (Duchenne, Becker)	Progresif kas zayıflığı; CK düzeyi yüksek; aile öyküsü.
Konjenital miyopati, nöropati	Spesifik nörolojik ve EMG bulguları.
Entelektüel yetersizlik (6A00)	Motor defisit genel kognitif defisit bağlamında.
Otizm spektrum bozukluğu (6A02)	Motor stereotipileri, sosyal-iletişimsel defisit temeldir.
DEHB (6A05)	Dikkat eksikliği motor performansı etkiler; komorbidite sıktır (~%50).
Görme bozukluğu	Görme testi bozulmuş.
Disgrafi (6A03.1)	İnce motor problem yazma bağlamında baskın; genel motor sağlamdır.

7. Muayene ve değerlendirme

7.1 Standardize motor testler

- MABC-2 (Movement Assessment Battery for Children-2, 3–16 yaş) — altın standart; el becerisi, top becerileri, denge alt-testler.
- BOT-2 (Bruininks-Oseretsky Motor Beceri Testi, 4–21 yaş) — geniş motor profil.
- DCDQ (Developmental Coordination Disorder Questionnaire, 5–15 yaş, ebeveyn formu) — fonksiyonel tarama.
- PDMS-2 (Peabody Developmental Motor Scales, <6 yaş).

- BHK (Concise Assessment Method for Children's Handwriting) — el yazısı kalitesi.

7.2 Laboratuvar incelemeleri

Rutin göstergesi yoktur. Spesifik klinik şüphe temelinde:

- CK (kreatin kinaz) — kas distrofisi şüphesi.
- Tiroid fonksiyonu — bazı hipotiroid vakalarında motor yavaşlama.
- Genetik araştırma — sendromal belirtiler varsa.

7.3 Enstrümantal incelemeler

- Beyin MRG — yalnızca fokal nörolojik belirtiler, ataksi, sabit defisitler olduğunda (serebellar/serebral patoloji dışlaması).
- EMG/sinir iletim çalışması — nöromüsküler hastalık şüphesi.
- Görme testi — tüm vakalarda ilk değerlendirmeler.

8. Tedavi

8.1 Genel prensipler (EACD 2019 konsensusu)

1. DCD farmakolojik yolla tedavi edilmez. Müdahale — ergoterapi / fizyoterapi temellidir.
2. Erken tanımlama ve müdahale — işlevsel sonuçları iyileştirir.
3. Top-down (görev-yönelimli) yaklaşım birinci sıra — bottom-up sensorimotor yaklaşımlardan üstün etki gösterir (Smits-Engelsman B.C. et al. Dev Med Child Neurol 2013 meta-analiz).
4. CO-OP (Cognitive Orientation to daily Occupational Performance) ve NTT (Neuromotor Task Training) — EACD 2019'da birinci sıra önerilen kanıtlı yaklaşımlar.
5. İşlevsel hedefler — hastanın ve ailenin seçtiği günlük aktivite hedefleri (örneğin, bisiklet sürme, giyim, el yazısı).
6. Aile ve okul katılımı — müdahale evde ve okulda takip edilmelidir.
7. Yoğunluk: haftada 1–2 seans, 8–10 hafta genellikle başlangıç kursu; etki değerlendirmesine göre uzatılır.
8. Komorbidite tedavisi — DEHB (stimülanlar), öğrenme bozukluğu (Yapılandırılmış Okuryazarlık), anksiyete ve depresyon (BDT).
9. Akademik akomodasyon — el yazısı hızını azaltma, klavye kullanımı, voice-to-text, ek süre; beden eğitimi derslerinde bireyselleştirilmiş yaklaşım.

8.2 Tedavi metodolojileri

1. Günlük Aktiviteye Bilişsel Yönlendirme (CO-OP — Cognitive Orientation to daily Occupational Performance) — Polatajko (Polatajko H.), Mandich (Mandich A.) — Top-down bilişsel temelli yaklaşım — çocuk kendi motor problem çözümünde aktif katılımcı olur. "Goal-Plan-Do-Check" stratejisi ile hasta kendi hedefini seçer, planlar, uygular ve değerlendirir. 10-14 seans, bireysel. Kanıt: Smits-Engelsman B.C. et al. Dev Med Child Neurol 2013 meta-analiz — top-down yaklaşımlar bottom-up'tan üstün; Thornton A. et al. Phys Occup Ther Pediatr 2016 sistematik derleme. EACD 2019 — birinci basamak öneri.
2. Nöromotor Görev Eğitimi (NTT — Neuromotor Task Training) — Schoemaker M.M., Smits-Engelsman B.C. — Görev-yönelimli motor öğrenme yaklaşımı — spesifik motor becerilerin tekrarlayan, yapılandırılmış pratiği; görsel-motor entegrasyon, denge, top becerileri. Kanıt: Niemeijer A.S. et al. Phys Ther 2007. EACD 2019 — kanıtlı.
3. MABC-2 (Movement Assessment Battery for Children-2) — Altın standart motor değerlendirme; 3–16 yaş. El becerisi (3 alt test), top becerileri (2), denge (3) — yaşa dayalı norm tabloları.
4. DCDQ (Developmental Coordination Disorder Questionnaire) — 15 soru, ebeveyn doldurmalı işlevsel tarama aracı (Wilson B.N. et al. Phys Occup Ther Pediatr 2009 güncellemesi).
5. BOT-2 (Bruininks-Oseretsky Test of Motor Proficiency-2) — 4–21 yaş, geniş motor profil; klinik ve araştırma bağlamında kullanım.
6. "Partnering for Change" programı (CanChild) — Okul tabanlı müdahale modeli — ergoterapist öğretmenlerle birlikte çalışır, sınıf bağlamında uyarlamalar gerçekleştirir. Kanıt: Missiuna C. ve ark. Int J Environ Res Public Health 2017.
7. Klavye eğitimi ve ses-metin (voice-to-text) teknolojisi — Akademik uyum — el yazısı zorluğunu telafi eden yardımcı teknoloji.

8.3 Kaynaklar arasındaki farklar

- EACD 2019 (Blank et al. Dev Med Child Neurol 2019): CO-OP ve NTT açık öneri; duyusal entegrasyon terapisi (Ayres SI) ve bütün hareket taklit yöntemleri için kanıt zayıf/tutarsız.
- CanChild (McMaster University): "Partnering for Change" — okul temelli eğitim modeli; müdahale eğitim sistemine entegre edilir.
- NICE: DCD için ayrı bir klinik rehber yoktur; genel nörogelişimsel ve SEND çerçevesi içindedir.

9. Prognoz

İyi prognoz faktörleri

- Erken tanımlama ve müdahale.
- CO-OP veya NTT temelli kanıtlanmış müdahale.
- Komorbid DEHB, öğrenme bozukluğu, anksiyetenin yönetimi.
- Aile ve okul desteği.
- Normal entelektüel düzey.

Kötü prognoz etkenleri

- Çok sayıda komorbid bozukluk (DEHB + LD + DCD birlikte).
- Sosyal izolasyon ve spor aktivitelerinden tamamen kaçınma.
- İkincil anksiyete, depresyon, sosyal fobi.
- Geç identifikasyon.
- Müdahale kanıtlanmamış yöntemlerle (Ayres SI tek başına, Dore programı, Brain Gym).

İzlem hedefleri

- Motor fonksiyonel hedeflerin yeniden değerlendirilmesi (3–6 aylık).
- Akademik başarı ve el yazısı hızı izlemi.
- Sosyo-duygusal sağlık — özsaygı, anksiyete, depresyon taraması (ergenlikte özellikle önemli).
- Komorbidite aktif tedavisi.
- Yetişkinlikte mesleki uyum — motor beceri gerektiren iş yerlerinden kaçınma veya akomodasyon planlaması.
- Fiziksel aktivite ve spor — sosyal uyum ve kardiyovasküler sağlık için; spor türü hastanın ilgi alanlarına uyarlanır (yüzme, yoga gibi koordinasyon gereksinimi az olanlar).

10. Mit ve yanlış inançlar

10.1 Etiyoloji mitleri

Mit 1: “Çocuk sadece tembeldir / çok az çalışır”

Neden yaygınlaştı: motor zorluğun karakter problemi olarak yanlış açıklanması; akademik kurumlarda motor bozukluklara sınırlı bilgi.

Klinik ve biyolojik mantık: DCD — nörogelişimsel bozukluktur. Beyincik, bazal ganglionlar, parietal korteks fonksiyonel bağlantısında atipik modeller (Zwicker 2012 fMRI incelemesi); "internal modelling" defisit hipotezi — hasta motor planlama ve yürütme için daha fazla bilişsel kaynak harcar, yorgunluk ve kaçınma davranışına yol açar.

Kanıt: EACD 2019 (Blank et al.) — DCD nörobiyolojik temelli bir bozukluktur; "motivasyon sorunu" yanlış bir açıklamadır.

Gerçek klinik adım: aileye ve öğretmene biyolojik temelleri açıkla; ergoterapi/fizyoterapi temelli CO-OP veya NTT.

Mit 2: "Çocuk yaşa göre geçer, 'büyür'"

Kanıt: Cantell M.H. et al. J Adolesc Res 2003, Kirby A. et al. Res Dev Disabil 2010 uzun süreli izlem çalışmaları — DCD'li çocukların %50–70'i yetişkinlikte motor zorlukları sürdürür; akademik ve mesleki sonuçlar, sosyal uyum kötüdür. Müdahale penceresi sınırlı değildir — her yaşta etki gözlemlenebilir, ancak erken müdahale sosyal-duygusal sonuçları belirgin şekilde iyileştirir.

Mit 3: "Ebeveyn sabırsızlığı ya da yanlış terbiye motor zorluğa neden olur"

Kanıt: EACD, AAP — DCD genetik ve nörobiyolojik temellidir; ebeveyn deneyimi etiyoloji değildir. Erken doğum, perinatal hipoksi, aile öyküsü temel risk faktörleridir.

10.2 Zararlı veya bilimsel olarak temelsiz yöntemler

Mit 4: "Sensory Integration Therapy (Ayres SI) DCD'yi iyileştirir"

Neden yaygınlaştı: Jean Ayres 1972 duyu bütünleme teorisini ileri sürmüş; ergoterapi pratiğinde yaygınlaşmıştır.

Kanıt: EACD 2019 (Blank et al.) — Ayres SI yaklaşımının DCD'de fonksiyonel motor performansa etkisi **yeterli kanıt göstermemektedir**; Smits-Engelsman 2013 meta-analizi — bottom-up duyusal yaklaşımlar top-down görev-yönelimli yaklaşımlardan anlamlı derecede zayıftır. AAP 2012 Sensory Integration Bildirisi — terapötik kullanım "araştırması devam eden" olarak sınıflandırılır, birinci basamak önerilmez.

Gerçek klinik adım: top-down yaklaşımlar (CO-OP, NTT) birinci sıra.

Mit 5: “Dore programı (cerebellar exercise therapy) DCD'yi iyileştirir”

Kanıt: Bishop D.V. Dyslexia 2007 sistematik eleştirisi — Reynolds-Nicolson orijinal çalışmalarının metodolojik sınırlılıkları; tekrar çalışmalarda etki doğrulanmamıştır. EACD önermemektedir.

Mit 6: “Brain Gym / Educational Kinesiology”

Kanıt: Hyatt K.J. Remedial Spec Educ 2007 — iddialar nörobiyolojiyle uyumlu değil; motor ve akademik sonuçlara etkisi kanıtlanmamış.

Mit 7: “Görsel terapi (göz egzersizleri) DCD'de motor koordinasyonunu iyileştirir”

Kanıt: AAP, AAO, AAPOS 2009 Ortak Bildirisi — göz hareketi terapisinin motor koordinasyonuna veya öğrenme bozukluklarına etkisi kanıtlanmamıştır.

10.3 Etkisiz veya temel müdahaleyi geciktiren yöntemler

Mit 8: “EEG Nörofeedback DCD'de motor fonksiyonu iyileştirir”

Kanıt: Spesifik DCD için nörofeedback kanıt tabanı sınırlıdır. EACD önermez; CO-OP ve NTT tercih edilir.

Mit 9: “Özel diyet (omega-3 takviyeleri) DCD'yi iyileştirir”

Kanıt: Richardson A.J. et al. Pediatrics 2012 (Oxford-Durham çalışması) — omega-3 takviyelerinin DCD'de motor fonksiyonu iyileştirdiğini iddia etmiştir, ancak sistematik derlemeler (Cooper R.E. et al. J Psychopharmacol 2015) — yeterli kanıt elde edilmemiştir. EACD önermemektedir.

Mit 10: “Hiperbarik oksijen, kök hücre enjeksiyonları, kraniosakral terapi”

Kanıt: hiçbirinin DCD için etki kanıtı yok; risk profili önemli.

Mit 11: “Çoklu spor egzersizi (yoğun spor) DCD'yi iyileştirir”

Kanıt: Genel fiziksel aktivite faydalıdır, ancak DCD'de motor öğrenme defisiti spesifik yapılandırılmış müdahale gerektirir. “Sadece daha fazla egzersiz” rejimi hastada başarısızlık ve sıkıntı yaratır. CO-OP ve NTT gibi yapılandırılmış yaklaşımlar önemli ölçüde üstündür.

11. Kaynaklar

1. WHO. ICD-11 for Mortality and Morbidity Statistics. 6A04 Developmental motor coordination disorder. 2024.

2. American Psychiatric Association. DSM-5-TR. Washington DC: APA Publishing; 2022.
3. Blank R., Barnett A.L., Cairney J., Green D., Kirby A., Polatajko H. et al. International clinical practice recommendations on the definition, diagnosis, assessment, intervention, and psychosocial aspects of developmental coordination disorder. Dev Med Child Neurol 2019;61(3):242–285.
4. Lingam R., Hunt L., Golding J., Jongmans M., Emond A. Prevalence of developmental coordination disorder using the DSM-IV at 7 years of age: A UK population-based study. Pediatrics 2009;123(4):e693–e700.
5. Cantell M.H., Smyth M.M., Ahonen T.P. Two distinct pathways for developmental coordination disorder: Persistence and resolution. Hum Mov Sci 2003;22(4–5):413–431.
6. Kirby A., Edwards L., Sugden D., Rosenblum S. The development and standardization of the Adult Developmental Co-ordination Disorders/Dyspraxia Checklist (ADC). Res Dev Disabil 2010;31(1):131–139.
7. Zwicker J.G., Missiuna C., Harris S.R., Boyd L.A. Developmental coordination disorder: A review and update. Eur J Paediatr Neurol 2012;16(6):573–581.
8. Adams I.L.J., Lust J.M., Wilson P.H., Steenbergen B. Compromised motor control in children with DCD: A deficit in the internal model? Dev Med Child Neurol 2014;56(11):1043–1055.
9. Smits-Engelsman B.C., Blank R., van der Kaay A.C. et al. Efficacy of interventions to improve motor performance in children with DCD: A combined systematic review and meta-analysis. Dev Med Child Neurol 2013;55(3):229–237.
10. Cairney J., Veldhuizen S., Szatmari P. Motor coordination and emotional-behavioral problems in children. Curr Opin Psychiatry 2010;23(4):324–329.
11. Polatajko H.J., Mandich A.D., Miller L.T., Macnab J.J. Cognitive Orientation to Daily Occupational Performance (CO-OP): Part II — The evidence. Phys Occup Ther Pediatr 2001;20(2–3):83–106.
12. Niemeijer A.S., Smits-Engelsman B.C., Schoemaker M.M. Neuromotor task training for children with developmental coordination disorder: A controlled trial. Dev Med Child Neurol 2007;49(6):406–411.
13. Missiuna C., Pollock N., Levac D.E. et al. Partnering for Change: An innovative school-based occupational therapy service delivery model for children with developmental coordination disorder. Can J Occup Ther 2012;79(1):41–50.

14. Bishop D.V.M. Curing dyslexia and attention-deficit hyperactivity disorder by training motor co-ordination: Miracle or myth? Dyslexia 2007;13(1):4–7.
15. Cooper R.E., Tye C., Kuntsi J., Vassos E., Asherson P. Omega-3 polyunsaturated fatty acid supplementation and cognition: A systematic review and meta-analysis. J Psychopharmacol 2015;29(7):753–763.
16. Edwards J., Berube M., Erlandson K. ve ark. Developmental coordination disorder in school-aged children born very preterm and/or at very low birth weight: A systematic review. J Dev Behav Pediatr 2011;32(9):678–687.

	6A05 DİKKAT EKSİKLİĞİ HİPERAKTİVİTE BOZUKLUĞU (DEHB)
ICD-11 **6A05**	**Attention deficit hyperactivity disorder**
ICD-10 F90.0	Aktivite ve dikkat bozukluğu
DSM-5-TR F90.0–F90.2	Dikkat Eksikliği/Aşırı Hareketlilik Bozukluğu

1. Tanım ve nozoloji

Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB; ICD-11: 6A05 Attention deficit hyperactivity disorder; DSM-5-TR: F90.0–F90.2x ADHD) — erken gelişim döneminde (12 yaşa kadar) başlayan, dikkatsizlik, hiperaktivite ve dürtüsellikten oluşan davranış örüntüsü ile karakterize, akademik, sosyal veya mesleki işlevsellikte bozulma yaratan nörogelişimsel bozukluktur.

ICD-11'de ve DSM-5-TR'de üç sunum şekli:

- 6A05.0 — Esas olarak dikkatsiz tip;
- 6A05.1 — Esas olarak hiperaktif-dürtüsel tip;
- 6A05.2 — birleşik sunum.

2. Tarihçe

- Still G.F. (1902) — anormal ahlaki kontrol kusuru — Goulston derslerinde (Lancet) toplam 43 çocuğu tanımlamıştır; bunlardan 20'si (15 erkek, 5 kız) genel zekâ bozukluğu ve fiziksel hastalık olmaksızın bu kusuru göstermiştir.
- 1937 — Bradley C. — uyarıcı (benzedrin) tedavisinin davranış sorunları olan çocuklarda rastlantısal keşfi.
- DSM-II (1968) — Çocukluk Çağı Hiperkinetik Reaksiyonu.
- DSM-III (1980) — "Dikkat Eksikliği Bozukluğu" (hiperaktivite ile veya olmadan) — dikkat eksikliğinin çekirdek olarak kabul edilmesi.
- DSM-IV (1994) — "ADHD" terimi ve 3 alt tipin (dikkatsiz, hiperaktif-dürtüsel, birleşik) standardizasyonu.
- DSM-5 (2013) ve ICD-11 (2019) — alt tip yerine sunum (presentation) terimi — durumun seyir sırasında değişebilmesini yansıtır; başlangıç yaşı 7'den 12'ye kaldırılmıştır; yetişkinlerde tanı için semptom sayısı azaltılmıştır (her kategoride 9 semptomdan 6'sı yerine 5'i; 17 yaş ve üzeri için).

3. Epidemiyoloji

- Çocuklarda yaygınlık: %5–7 (Polanczyk G.V. ve ark. Am J Psychiatry 2007 sistematik derleme ve meta-analiz, 102 çalışma). CDC ABD'de 3–17 yaş çocuklarda ebeveyn bildirimine dayalı yaşam boyu tanı %9,8 (NSCH 2016–2019), 2022 için %11,4; bu klinik bir değerlendirme değil, daha önce konmuş tanının ebeveyn tarafından bildirilmesidir.
- Yetişkinlerde yaygınlık: %2,5–4 (Kessler R.C. et al. Am J Psychiatry 2006 — National Comorbidity Survey Replication).
- Cins: çocuklukta erkeklerde 2–4 kat yüksek (kadınlarda az tanı — daha az hiperaktivite, daha çok dikkatsizlik); yetişkinlikte fark azalır.
- Persistans: ~%60–70 çocukluk DEHB'si yetişkinlikte belirli düzeyde devam eder (Faraone S.V. ve ark. Psychol Med 2006 meta-analiz).
- Komorbidite: karşıt olma karşı gelme bozukluğu %40, davranış bozukluğu %14, anksiyete %25, depresyon %15–30, öğrenme bozukluğu %25–40, tik bozuklukları %7–20, otizm spektrumu %30–50 (DEHB hastalarında), madde kullanım bozukluğu ergenlik ve yetişkinlikte 2–3 kat artmış risk.

4. Etiyoloji ve patogenez

4.1 Genetik faktörler

- Kalıtım: %74 (Faraone S.V., Larsson H. Mol Psychiatry 2019 ikiz ve aile çalışmaları meta-analizi) — en yüksek kalıtsallığa sahip nörogelişimsel bozukluklardan biri.
- Genetik mimari: poligen — yüzlerce küçük etkili varyant. GWAS (Demontis D. et al. Nat Genet 2019, n>55 000) 12 risk lokusu tespit etmiştir (FOXP2, SORCS3, DUSP6 ve diğerleri).
- Dopamin sistem genleri — DRD4, DRD5, DAT1 (SLC6A3) — aday genler; etki büyüklüğü küçük.
- CNV — nadir durumlarda; genel varyasyonlar esastır.

4.2 Nörobiyolojik mekanizmalar

- Dopaminerjik ve noradrenerjik sistemlerin disfonksiyonu — özellikle prefrontal korteks, striatum, beyincik devresi; uyarıcılar bu sistemlere etki ederek semptomları azaltır.
- Yapısal değişiklikler: Genel beyin ve spesifik alan (kaudat, putamen, prefrontal korteks) hacminde azalma (Hoogman M. et al. Lancet Psychiatry 2017 ENIGMA-DEHB n>3000 — küçük etki büyüklükleri).
- İşlevsel ilişki: default mode network ve executive control network arasında disregülasyon.
- Yürütücü işlev modeli (Barkley R.A.) — inhibisyonun zayıflığı temel defisit; çalışan bellek, önceden planlama, duygusal düzenlemeyi etkiler.
- Ödül sistemi işlev bozukluğu — gecikmiş ödüle karşı duyarlılık (Sonuga-Barke E.J. Neurosci Biobehav Rev 2003).

4.3 Çevresel risk faktörleri

- Erken doğum ve düşük doğum ağırlığı — riski 2–3 kat artırır.
- Annenin gebelikte tütün, alkol, kannabis kullanımı.
- Annenin perinatal stresi ve ağır psikososyal yoksunluğu.
- Kurşun maruziyeti çocuklukta.
- Erken beyin travması (TBİ).

4.4 Etiyoloji MİTLERİNE karşı net pozisyon

- Şeker DEHB oluşturmaz (Wolraich M.L. ve ark. JAMA 1995 meta-analizi).

- Ekran süresi / video oyunları DEHB'yi oluşturmaz (ilişki mevcuttur, ancak nedensellik yönlü kanıt yoktur — Ferguson C.J. Perspect Psychol Sci 2015).
- Kötü yetiştirme DEHB'yi oluşturmaz (kalıtım %74); ancak yüksek çatışmalı aile ortamı semptom şiddetini etkileyebilir.

5. Klinik özellikler

5.1 Dikkatsizlik alanı

- Detaylara dikkat etmeme, dikkatsiz hatalar.
- Görevlerde dikkati sürdürmede güçlük.
- Doğrudan konuşulduğunda dinlememiş gibi görünme.
- Talimatlara tam uymama, görevleri yarım bırakma.
- Görev ve etkinlikleri organize etmede güçlük.
- Sürekli zihinsel çaba gerektiren görevlerden kaçınma.
- Gerekli eşyaları kaybetme.
- Dış uyaranlar tarafından kolayca dikkatin dağılması.
- Günlük aktivitelerde unutkanlık.

5.2 Hiperaktivite ve dürtüsellik alanı

- El-ayak hareketi, oturdukları yerde kıvranma.
- Sakin oturmayı gerektiren yerlerde oturmama.
- Uygun olmayan yerlerde koşma veya tırmanma (yetişkinlerde iç huzursuzluk hissi).
- Sakin etkinliklerde oynayamama.
- “Motorla çalışan gibi” davranış.
- Aşırı konuşma.
- Soru tamamlanmadan cevabı ağzından kaçırma.
- Sırayı bekleyememe.
- Başkalarının konuşmasına veya faaliyetine müdahale etme.

5.3 Yaşa göre farklılıklar

- Okul öncesi yaş: hiperaktivite dominant; oyunda dikkat kısa; toplumsal durumlarda davranış kontrolü zor.
- Okul çağı: akademik sorunlar öne çıkar; dikkatsizlik akademik başarıyı etkiler.

- Ergenlik: hareket hiperaktivitesi azalır, içsel huzursuzluk ve dürtüsellik kalır; risk davranışı artar.
- Yetkinlik: içsel huzursuzluk, planlama güçlüğü, ilişkilerde dürtüsellik; iş ve aile hayatında işlevsel bozulma.

6. Tanı

6.1 Birleşik tanı ölçütleri (DSM-5-TR · ICD-11 · NICE NG87 · AAP 2019 konsensus noktaları)

A. Dikkatsizlik ve/veya hiperaktivite-dürtüsellik belirtilerinden çocuklarda (≤16 yaş) her kategoride en az 6 semptom, yetişkinlerde (17+) en az 5 semptom, en az 6 ay sürmüş ve yaşa uygun beklenmeyen düzeyde olmalıdır.

B. Birkaç semptom 12 yaşından önce mevcut olmalıdır.

C. Semptomlar en az iki ortamda (örn. ev + okul, ev + iş) gözlemlenmelidir.

D. Fonksiyonel bozulma — sosyal, akademik, mesleki faaliyete önemli etki.

E. İstisnalar — şizofreni veya diğer psikotik bozukluk bağlamında ortaya çıkmaz; başka bir psikiyatrik bozuklukla tam olarak açıklanmaz.

6.2 Kaynaklar arasındaki farklar

- DSM-5-TR (F90.0–F90.2x): sunum — dikkatsiz / hiperaktif-dürtüsel / birleşik; şiddet — hafif, orta, ağır. Başlangıç yaşı 12'ye yükseltilmiştir (DSM-IV'te 7).
- ICD-11 (6A05): paralel yapı; “komorbid” niteleyicileri (otizm, dil bozukluğu, entelektüel yetersizlik).
- NICE NG87 (2018, güncelleme 2019): tanı multidisipliner ekip tarafından (çocuklarda — pediatrist/psikiyatrist; yetişkinlerde — psikiyatrist); yapılandırılmış sorgulama ve gözlem birlikte.
- AAP 2019 (Wolraich M.L. et al. Pediatrics 2019;144(4)): birinci basamak sağlık hizmeti düzeyinde 4–18 yaş için tanı ve tedavi algoritması; 4–5 yaş — birinci basamak ebeveyn eğitimi (PCIT, ebeveyn yönetimi eğitimi), ikinci basamak metilfenidat; 6–11 yaş — birinci sıra stimülan + davranış müdahalesi; 12–18 yaş — birinci sıra uyarıcı + davranış müdahalesi (ergenin rızasıyla).
- AACAP Practice Parameter (Pliszka S. JAACAP 2007): komorbidite değerlendirmesi ve tedavi sıralaması.
- CADDRA Canadian ADHD Practice Guidelines (4. baskı, 2018): yetişkin DEHB için kapsamlı algoritm.

6.3 Tanı algoritması

1. Ebeveyn ve öğretmen (çocuklar için) veya hasta kendisi (yetişkinler) görüşmesi — semptom öyküsü, başlangıç yaşı, bağlamlar.
2. Standardize edilmiş derecelendirme ölçekleri — Conners-3 (ebeveyn/öğretmen/hasta), Vanderbilt (AAP önerisi), SNAP-IV; yetişkinler için ASRS (Adult ADHD Self-Report Scale, WHO/Kessler).
3. Klinik görüşme — semptomların iki bağlamda doğrulanması, fonksiyonel bozulma belgelenmesi.
4. Tıbbi ve nörolojik muayene — somatik nedenler (tiroid, işitme, görme, anemi) dışla.
5. Zekâ ve akademik değerlendirme (WISC-V, akademik testler) — öğrenme bozukluğu ve entelektüel yetersizlik ayrımı.
6. Komorbidite taraması — KOKGB, davranış bozukluğu, anksiyete, depresyon, tik, otizm, madde kullanımı.
7. Uyku bozukluğu ve obstrüktif uyku apnesi taraması (özellikle hiperaktif-dürtüsel tipte).

6.4 Ayırıcı tanı

Durum	**Ayırt edici belirtiler**
Yaş ve gelişim — normal varyasyon	İşlevsel bozulma yok, ya iki bağlamda gözlenmez.
Karşıt Olma-Karşı Gelme Bozukluğu (6C90)	İtaatsizlik, öfke temel; komorbidite sık.
Davranış Bozukluğu (6C91)	Ciddi davranış bozuklukları, başkalarının haklarına tecavüz.
Anksiyete bozuklukları (6B0x)	Dikkatsizlik anksiyeteden; somatik yakınmalar; başlangıç genellikle geç.
Depresif bozukluk (6A7x)	Afektif semptomlar dominant; epizodik gidiş.
Bipolar bozukluk (6A60–62)	Afektif epizodlar; çocukluk DEHB'de manik epizod yok.
Otizm spektrum bozukluğu (6A02)	Sosyal-iletişimsel defisit, sınırlı-tekrarlayan davranışlar. Komorbidite sıktır.

Durum	Ayırt edici belirtiler
Öğrenme bozukluğu (6A03)	Akademik alana özgü defisit; dikkat sorunları görev bağlamına bağlıdır.
Obstrüktif uyku apnesi	Gündüz uykululuk hali, davranış sorunları; polisomnografi.
Hipertiroidi	TSH azalması; titreme, kilo kaybı.
Absans (petit mal) epilepsi	Kısa bilinç değişiklikleri; EEG 3 Hz spike-and-wave.
İşitme bozukluğu	Odyometri bozulmuş.

7. Muayene ve değerlendirme

7.1 Klinik ölçekler

- Vanderbilt ADHD Diagnostic Rating Scale — ebeveyn ve öğretmen, 6–12 yaş — AAP 2019 önerisi.
- Conners-3 — karmaşık DEHB ve komorbidite değerlendirmesi (6–18 yaş).
- SNAP-IV (Swanson, Nolan, Pelham) — 26 soru.
- ASRS (Adult ADHD Self-Report Scale, WHO/Kessler R.C.) — 18 soru; yetişkin hastalarda kısa tarama.
- DIVA-5 (Diagnostic Interview for ADHD in adults) — yapılandırılmış görüşme.
- BRIEF-2 (Behavior Rating Inventory of Executive Function) — yürütücü işlev.

7.2 Laboratuvar incelemeleri

Rutin DEHB için spesifik laboratuvar göstergesi yoktur. Klinik şüphe temelinde:

- Tam kan sayımı, ferritin (demir eksikliği), tiroid fonksiyonu (TSH).
- Kurşun seviyesi — risk faktörleri varsa.
- Toksikolojik tarama — ergenlerde madde kullanımı şüphesi.
- Stimülan başlamadan önce — EKG yalnızca kalp riski öyküsü veya aile öyküsü varsa (AAP, AHA 2008; rutin EKG gerekli değildir).

7.3 Enstrümantal incelemeler

- EEG — yalnız tutma şüphesi veya atipik klinik tezahürler.

- Beyin MRG — yalnızca fokal nörolojik belirtiler. Rutin endikasyon yoktur.
- Tanı için nörofizyolojik testler (TOVA, IVA, QbTest) gerekli kanıt temeline sahip değildir — klinik tanı ve standartlaştırılmış ölçekler altın standart olarak tercih edilir.

8. Tedavi

8.1 Genel Prensipler (NICE NG87 · AAP 2019 · CADDRA 2018 konsensüsü)

1. Yaş temelli yaklaşım (AAP 2019):
    - 4–5 yaş — birinci basamak ebeveyn eğitimi (PCIT, Triple P, Incredible Years); ikinci basamak metilfenidat.
    - 6–11 yaş — birinci basamak stimülan + davranış müdahalesi.
    - 12–18 yaş — birinci basamak stimülan + davranış müdahalesi; genç onamı.
    - Yetişkinler — stimülan veya stimülan olmayan + BDT.
2. Multimodal müdahale tek farmakoterapi veya tek davranış müdahalesinden üstündür (MTA Cooperative Group. Arch Gen Psychiatry 1999, n=579 — kombinasyon monoterapiden üstün, ancak farmakoterapi tek davranış müdahalesinden daha güçlü).
3. Stimülanlar — birinci sıra farmakoterapi (Cortese S. et al. Lancet Psychiatry 2018 network meta-analiz; çocuklarda metilfenidat birinci seçenek, yetişkinlerde amfetamin daha etkili).
4. Stimülan olmayanlar — atomoksetin, guanfasin (uzun etkili form), klonidin (uzun etkili form). Uyarıcının kontrendike olduğu veya yan etki olduğunda kullanılır.
5. Davranış müdahalesi — ebeveyn eğitimi (PCIT, ebeveyn yönetimi eğitimi), okul temelli müdahale (sınıf modifikasyonları, davranış sözleşmesi), çocuk BDT.
6. Akademik akomodasyon — bireysel eğitim planı (IEP / 504 Plan ABD; EHCP Birleşik Krallık); ek süre, sınırlı dikkat dağıtıcılar, yazılı yerine sözlü yanıt seçenekleri.
7. Yan etki izlemi — boy ve kilo, kan basıncı, kalp atımı (3 aylık), uyku, iştah, duygudurum. Stimülanlarda küçük boy artışı azalması (1–2 cm uzun süreli kullanımda) beklenir.
8. Komorbidite tedavisi — anksiyete/depresyon (SSRI + BDT), tik (alfa-2 agonistler veya dikkatle uyarıcı), madde kullanımı (lisdeksamfetamin veya atomoksetin — kötüye kullanım potansiyeli düşük), otizm (atipik antipsikotik komorbid irritabilite için).

8.2 Stimülanlar (birinci basamak farmakoterapi)

Preparat	Biçim	Doz aralığı	Not
Metilfenidat IR	Kısa süreli (3–4 saat)	5–60 mg/gün (2–3 doz)	Çocuklarda titrasyon başlangıcı; Cortese 2018 — çocuklarda birinci sıra.
Metilfenidat ER (Concerta, Ritalin LA)	Uzun süreli (8–12 saat)	18–72 mg/gün	Tek seferlik günlük doz; okul gününe uygun.
Lisdeksamfetamin (Vyvanse)	Prodrug, 12+ saat	20–70 mg/gün	Düşük yanılma potansiyeli (prodrug); yetişkinlerde üstün.
Mixed Amfetamin Tuzları (Adderall XR)	Uzun süreli (10–12 saat)	5–30 mg/gün	Yetişkinlerde Cortese 2018 — I. sıra.
Deksamfetamin	IR (4 saat) / ER (8 saat)	5–40 mg/gün	

8.3 Stimülan olmayanlar

Preparat	Mekanizma	Doz	Not
Atomoksetin (Strattera)	Noradrenalin geri alım inhibitörü	0,5–1,4 mg/kg/gün	Etki 4–6 hafta; intihar düşüncesi riskinde hafif artış (FDA black box).
Guanfasin ER (Intuniv)	α2A adrenerjik agonist	1–7 mg/gün	Sedasyon, hipotansiyon; tikli komorbid durumlarda faydalı.

Preparat	Mekanizma	Doz	Not
Klonidin ER (Kapvay)	α2 adrenerjik agonist	0,1–0,4 mg/gün	Sedasyon; uyku bozukluğu komorbid olduğunda.
Viloksazin ER (Qelbree)	NRI + serotonerjik modulator	çocuklarda 100–400 mg/gün, yetişkinlerde 200–600 mg/gün	FDA 2021; 6 yaşından itibaren çocuklar ve yetişkinler.

8.4 Kaynağa-özgü belirleyiciler

- NICE NG87 (2018, güncelleme 2019): 5+ yaş — çevresel değişiklikler ilk; sonra davranışsal veya farmakoterapi. Yetişkinlerde — birinci basamak uyarıcı; ikinci basamak atomoksetin.
- AAP 2019 (Wolraich): yaş temelli algoritm yukarıda tanımlanmıştır.
- Cortese S. et al. Lancet Psychiatry 2018 (network meta-analiz): çocuklar — metilfenidat birinci sıra; yetişkinler — amfetamin birinci sıra (etki büyüklüğü daha yüksek); atomoksetin orta etkili.
- MTA Cooperative Group (Arch Gen Psychiatry 1999, izlem Hechtman L. et al. JAACAP 2016): yoğun farmakoterapi kombinasyonunu 14 aylık izlem üstün göstermiştir; ancak 36 aylık ve 8 yıllık takipte farklar zayıflar — uzun dönem etki tartışmalıdır.
- FDA ve EMA izlem gereklilikleri: boy ve kilo takibi, kardiyovasküler başlangıç göstergeleri.

8.5 Tedavi metodolojileri

1. Ebeveyn-Çocuk Etkileşim Terapisi (PCIT — Parent-Child Interaction Therapy) — Eyberg (Eyberg S.) — 4–7 yaşlı çocuklar için; iki aşama — Çocuk-Yönelimli Etkileşim (ÇYE) ve Ebeveyn-Yönelimli Etkileşim (EYE). Gerçek zamanlı terapist koçluğu (in-vivo coaching) ile ebeveynin davranış yönetimi becerilerinin geliştirilmesi. pcit.org.
2. “Incredible Years” programı — Webster-Stratton (Webster-Stratton C.) — Ebeveyn, öğretmen ve çocuk programları; grup formatında 14-22 seans; ASTPS modeli (Authoritative Stimulating Trustworthy Parenting Style).
3. Triple P — Pozitif Ebeveynlik Programı (Positive Parenting Program) — Sanders (Sanders M.) — Avustralya'da oluşturulmuş 5 basamaklı sistem — evrensel, seçici, hedefli, bireysel. Çok sayıda RKÇ'de etki kanıtlı.

4. Ebeveyn Yönetim Eğitimi (Parent Management Training) — Barkley (Barkley) — 8–12 seans davranış ilkeleri temelli ebeveyn eğitimi — token sistem, time-out, sürekli eğitim.
5. Erişkin DEHB için BDT (Safren CBT for Adult ADHD) — Safren (Safren S.A.) — Yetişkin DEHB için BDT modülleri — görev organizasyonu, planlama, dikkat dağıtıcı yönetimi, bilişsel yeniden yapılandırma. Kanıt: Safren S.A. et al. JAMA 2010 RKÇ.
6. Vanderbilt DEHB Tanısal Derecelendirme Ölçeği (Vanderbilt ADHD Diagnostic Rating Scale) — AAP 2019 tarafından önerilen; ebeveyn ve öğretmen formları, komorbidite alt ölçekleri.
7. Yetişkin DEHB Kendi Bildirim Ölçeği (ASRS — Adult ADHD Self-Report Scale) — Kessler (Kessler R.C.), WHO — 18 soru; kısa 6 maddelik tarama bölümü. Yetişkin hastalarda klinik ve popülasyon taraması.
8. Yetişkinlerde DEHB için Tanısal Görüşme (DIVA-5 — Diagnostic Interview for ADHD in adults) — Yetişkin DEHB için yapılandırılmış görüşme — DSM-5 kriterlerine göre.
9. Conners-3 — 6–18 yaş kompleks değerlendirme — DEHB belirtileri, yürütücü işlev, davranış bozukluğu, öğrenme.
10. Yürütücü İşlev Davranış Değerlendirme Envanteri (BRIEF-2 — Behavior Rating Inventory of Executive Function) — Yürütücü işlevin ebeveyn ve öğretmen değerlendirmesi — inhibisyon, çalışma belleği, duygusal düzenleme.
11. EEG Nörofidbek (EEG Neurofeedback) — DEHB'de spesifik beyin dalga paternlerinin (theta/beta oranı) öz-düzenleme eğitimi. Kanıt: Holtmann M. ve ark. Dev Med Child Neurol 2011 meta-analiz — küçük etki büyüklüğü; alan uzmanları arasında etkisi tartışmalı. NICE NG87 — birinci basamak değil, adjunkt statü.

9. Prognoz

İyi prognoz faktörleri

- Erken tanımlama ve müdahale.
- Yüksek IQ — kompansatuar stratejiler.
- Stabil ve destekleyici aile ortamı.
- Komorbid bozuklukların aktif tedavisi.
- Uyarıcı ve davranışsal müdahaleye iyi yanıt.
- Ergenlik ve yetişkinlikte bağlanmanın korunması.

Kötü prognoz etkenleri

- Komorbid davranış bozukluğu, karşıt olma karşı gelme bozukluğu.
- Düşük sosyo-ekonomik destek.
- Madde kullanımı gelişimi ergenlikte.
- Yürütücü işlev eksikliğinin şiddeti.
- Geç identifikasyon.
- Müdahale kanıtlanmamış yöntemlerle.

İzlem hedefleri

- Semptom ve fonksiyonel sonuç izlemi (3–6 aylık).
- Uyarıcıda boy, kilo, kan basıncı, kalp atımı (3 aylık).
- Komorbid anksiyete, depresyon, madde kullanımı taraması.
- Akademik ve mesleki başarı desteği.
- Ergenlikte Risk Davranışı (araç kullanma eğitimi, cinsel sağlık, madde) İçeren Müdahaleler.
- Yetişkinlikte mesleki uyum, ilişkiler, finans planlaması — DEHB'ye uyarlanmış BDT.

10. Mit ve yanlış inançlar

10.1 Etiyoloji mitleri

Mit 1: "DEHB — uydurma bir tanıdır; çocuklar sadece hareketlidir"

Neden yaygınlaştı: normal çocuk enerjisinin patolojik olarak yanlış algılanması endişesi; bazı tanı enflasyonu vakaları not edilir.

Klinik ve biyolojik mantık: DEHB kalıcı ve ölçülebilir nörobiyolojik belirtilere sahiptir — kalıtım %74 (Faraone & Larsson 2019), beyin yapısal (Hoogman ENIGMA-ADHD 2017) ve işlevsel farklılıklar; uyarıcıların spesifik mekanizma etkisi (dopamin-noradrenalin) farmakolojik kanıt. Tanının atlanması (özellikle kadınlarda) aşırı tanıdan daha yaygın bir sorundur.

Kanıt: APA, AAP, WHO, NIMH — DEHB biyolojik temelli bozukluk; CDC ABD'de ebeveyn bildirimine dayalı yaygınlık 3–17 yaşta %9,8 (2016–2019) ve %11,4 (2022), uluslararası popülasyon çalışmaları meta-analizi %5–7 (Polanczyk 2007).

Gerçek klinik adım: kesin tanı yapılandırılmış ölçütlerle; işlevsel bozulma gereklidir (basit davranış varyasyonu değil).

Mit 2: “Şeker DEHB'yi yaratır veya semptomları güçlendirir”

Neden yaygınlaştı: Şekerin çocuk enerjisini artırma sezgisi; “Feingold diyeti” 1970'lerde popülerleşme.

Kanıt: Wolraich M.L. ve ark. JAMA 1995 sistematik derleme ve meta-analiz — şekerin çocuk davranışı ve bilişsel performansı üzerinde etkisi yoktur. Wolraich M.L. NEJM 1994 RKÇ — kıtlık kontrollü çalışma.

Gerçek klinik adım: Genel sağlıklı diyet, ancak şeker kısıtlaması DEHB müdahalesi olarak önerilmez.

Mit 3: “Kötü terbiye DEHB'yi yaratır”

Kanıt: Kalıtım %74 (Faraone & Larsson Mol Psychiatry 2019); ebeveyn deneyimi etiyoloji değildir. Bununla birlikte, yüksek çatışma ortamı semptom şiddetini etkileyebilir. Ebeveyn eğitimi (PCIT, Triple P) etkilidir, çünkü davranış yönetimi becerilerini güçlendirir — suçlama değil, destek amacıyla.

Mit 4: “Ekran süresi / video oyunları DEHB'yi yaratır”

Kanıt: ilişki mevcuttur, ancak nedensellik yönü tartışmalıdır — DEHB'li çocuklar ekran etkinliğine daha çok yönelir (ters nedensellik); Ferguson C.J. Perspect Psychol Sci 2015 derleme — video oyunlarının DEHB üzerinde nedensel etkisine dair kanıt yoktur. AAP — ekran süresi sınırlamaları genel sağlık için önerilir, ancak DEHB'nin “nedeni” olarak değil.

10.2 Zararlı “tedavi” yöntemleri ve yanlış inançlar

Mit 5: “Stimülanlar uyuşturucu gibi bağımlılık yapar ve gelecekte uyuşturucu bağımlılığına yol açar”

Neden yaygınlaştı: metilfenidat ve amfetaminlerin madde çizelgesinde (Schedule II ABD'de) olması; “narkotik” korkusunun yaygınlığı.

Klinik ve biyolojik mantık: Terapötik dozda oral stimülan kademeli olarak beyin konsantrasyonuna ulaşır (1–2 saat) — öforik etki minimal. İntravenöz veya intranazal kullanım (kötüye kullanım yolları) ile farklı farmakokinetik oluşur.

Kanıt: Wilens T.E. et al. Pediatrics 2003 meta-analiz, n=1034 — stimülanla tedavi edilmiş DEHB'li ergenlerde yetişkinlikte madde kullanımı azalır, artmaz (risk azalması ~%50). Lisdeksamfetamin ve osmotik salınımlı metilfenidat (Concerta) — kötüye kullanım potansiyeli düşüktür (prodrug yapısı, OROS teknolojisi).

Gerçek klinik adım: komorbid madde kullanımı varsa — lisdeksamfetamin veya atomoksetin tercih edilir; hasta ve aileye güvenlik eğitimi.

Mit 6: "Stimülanlar çocuğun boyunu ve beyin gelişimini durdurur"

Kanıt: MTA Cooperative Group izlem (Swanson J.M. et al. JAACAP 2017) — stimülanla tedavi edilmiş çocuklarda erişkin boy 1–2 cm daha kısa (beklenen genç erişkin boyuna göre); bu küçük ve klinik açıdan önemsiz kabul edilir. Beyin gelişimi — stimülanlarla ilişkili zarar kanıtı yoktur (Schweren L.J.S. et al. Neuropsychopharmacology 2015 derlemesi).

Mit 7: "Kannabis DEHB'yi iyileştirir"

Kanıt: NIDA, NICE — kannabis DEHB tedavisi için onaylanmamıştır; psikoz riskini artırır (Marconi 2016), kognitif bozulmaya yol açar, motivasyonu azaltır. Subjektif "sakinleştirici" etki fonksiyonel bozulmayı maskeler.

10.3 Etkisiz veya bilimsel olarak temelsiz yöntemler

Mit 8: "Feingold diyeti veya gıda boyaları/katkı maddelerinden kaçınma DEHB'yi iyileştirir"

Kanıt: Pelsser L.M. ve ark. Lancet 2011 (INCA çalışması) — kısıtlayıcı eliminasyon diyeti bazı çocuklarda davranışı etkileyebilir (~%30), ancak sistematik incelemeler (Sonuga-Barke E.J. ve ark. Am J Psychiatry 2013 meta-analizi) — gıda katkı maddelerinden kaçınmanın etki büyüklüğü küçüktür, yalnızca aile tarafından derecelendirilen değerlendirmede üstün etki gösterir, kör-kontrol olduğunda zayıflar. AAP, NICE — birinci basamak değil; karmaşık diyetin besin eksikliği riski mevcuttur.

Mit 9: "Omega-3 takviyeleri DEHB'nin ana tedavisidir"

Kanıt: Cooper R.E. et al. J Psychopharmacol 2015 ve Bloch M.H., Qawasmi A. JAACAP 2011 meta-analizleri — küçük etki büyüklüğü ($g \approx 0,3$); stimülanlardan ($g \approx 1,0$) anlamlı derecede zayıf. Adjunkt rol oynayabilir; ana tedavi değildir.

Mit 10: "EEG Nörofeedback stimülanı yerine koyar"

Kanıt: Holtmann M. et al. Dev Med Child Neurol 2011 ve Cortese S. et al. JAACAP 2016 meta-analizi — nörofeedback etkisi ebeveyn ve öğretmen tarafından değerlendirildiğinde anlamlı şekilde azalır; "kör" değerlendirmede etki büyüklüğü küçüktür. NICE NG87 — birinci basamak değil. Stimülan etkisi çok üstündür.

Mit 11: "Spora zorlamak çocuğun DEHB'sini geçirir"

Kanıt: Fiziksel aktivite DEHB'de semptomları hafifçe azaltmaya yardımcı olabilir (adjunkt); ancak ana müdahalenin yerini almaz. AAP — yapılandırılmış fiziksel aktivite önerir, ancak tek başına tedavi değil.

Mit 12: “Kraniosakral terapi, kiropraktik, homeopati DEHB'yi iyileştirir”

Kanıt: Cochrane ve sistematik derlemeler — bu tamamlayıcı müdahalelerin DEHB için etkisi kanıtlanmamıştır.

Mit 13: “Işık terapisi, MUS renkli lensler DEHB'yi iyileştirir”

Kanıt: kanıt temeli yoktur. AAP, AAO pozisyonu — kanıtlanmış değil.

11. Kaynaklar

1. WHO. ICD-11 for Mortality and Morbidity Statistics. 6A05 Attention deficit hyperactivity disorder. 2024.
2. American Psychiatric Association. DSM-5-TR. Washington DC: APA Publishing; 2022.
3. NICE Guideline NG87. Attention deficit hyperactivity disorder: diagnosis and management. 2018, updated 2019.
4. Wolraich M.L., Hagan J.F., Allan C. et al. Clinical Practice Guideline for the Diagnosis, Evaluation, and Treatment of Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder in Children and Adolescents. Pediatrics 2019;144(4):e20192528.
5. Pliszka S., AACAP Work Group on Quality Issues. Practice Parameter for the Assessment and Treatment of Children and Adolescents With Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry 2007;46(7):894–921.
6. Canadian ADHD Resource Alliance (CADDRA). Canadian ADHD Practice Guidelines, 4th ed. CADDRA; 2018.
7. Cortese S., Adamo N., Del Giovane C. et al. Comparative efficacy and tolerability of medications for attention-deficit hyperactivity disorder in children, adolescents, and adults: a systematic review and network meta-analysis. Lancet Psychiatry 2018;5(9):727–738.
8. MTA Cooperative Group. A 14-month randomized clinical trial of treatment strategies for attention-deficit/hyperactivity disorder. Arch Gen Psychiatry 1999;56(12):1073–1086.
9. Hechtman L., Swanson J.M., Sibley M.H. et al. Functional adult outcomes 16 years after childhood diagnosis of attention-deficit/hyperactivity disorder: MTA results. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry 2016;55(11):945–952.
10. Polanczyk G., de Lima M.S., Horta B.L., Biederman J., Rohde L.A. The worldwide prevalence of ADHD: a systematic review and metaregression analysis. Am J Psychiatry 2007;164(6):942–948.
11. Faraone S.V., Larsson H. Genetics of attention deficit hyperactivity disorder. Mol Psychiatry 2019;24(4):562–575.

12. Demontis D., Walters R.K., Martin J. et al. Discovery of the first genome-wide significant risk loci for attention deficit/hyperactivity disorder. Nat Genet 2019;51(1):63–75.
13. Hoogman M., Bralten J., Hibar D.P. et al. Subcortical brain volume differences in participants with attention deficit hyperactivity disorder in children and adults: a cross-sectional mega-analysis. Lancet Psychiatry 2017;4(4):310–319.
14. Wolraich M., Wilson D., White J. The effect of sugar on behavior or cognition in children: a meta-analysis. JAMA 1995;274(20):1617–1621.
15. Wilens T.E., Faraone S.V., Biederman J., Gunawardene S. Does stimulant therapy of attention-deficit/hyperactivity disorder beget later substance abuse? A meta-analytic review. Pediatrics 2003;111(1):179–185.
16. Swanson J.M., Arnold L.E., Molina B.S.G. et al. Young adult outcomes in the follow-up of the multimodal treatment study of attention-deficit/hyperactivity disorder: symptom persistence, source discrepancy, and height suppression. J Child Psychol Psychiatry 2017;58(6):663–678.
17. Holtmann M., Sonuga-Barke E., Cortese S., Brandeis D. Neurofeedback for ADHD: a review of current evidence. Child Adolesc Psychiatr Clin N Am 2014;23(4):789–806.
18. Cortese S., Ferrin M., Brandeis D. et al. Neurofeedback for attention-deficit/hyperactivity disorder: meta-analysis of clinical and neuropsychological outcomes from randomized controlled trials. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry 2016;55(6):444–455.
19. Sonuga-Barke E.J., Brandeis D., Cortese S. et al. Nonpharmacological interventions for ADHD: systematic review and meta-analyses of randomized controlled trials of dietary and psychological treatments. Am J Psychiatry 2013;170(3):275–289.
20. Bloch M.H., Qawasmi A. Omega-3 fatty acid supplementation for the treatment of children with attention-deficit/hyperactivity disorder symptomatology: systematic review and meta-analysis. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry 2011;50(10):991–1000.
21. Safren S.A., Sprich S., Mimiaga M.J. et al. Cognitive behavioral therapy vs relaxation with educational support for medication-treated adults with ADHD and persistent symptoms: a randomized controlled trial. JAMA 2010;304(8):875–880.
22. Barkley R.A. Behavioral inhibition, sustained attention, and executive functions: constructing a unifying theory of ADHD. Psychol Bull 1997;121(1):65–94.

23. Eyberg S.M., Funderburk B. Parent-Child Interaction Therapy Protocol. Gainesville: PCIT International, 2011.
24. Webster-Stratton C. The Incredible Years: Parents, Teachers and Children Training Series. Seattle: Incredible Years, 2011.
25. Kessler R.C., Berglund P., Demler O. et al. Lifetime prevalence and age-of-onset distributions of DSM-IV disorders in the National Comorbidity Survey Replication. Arch Gen Psychiatry 2005;62(6):593–602.
26. Sanders M.R. Development, evaluation, and multinational dissemination of the Triple P-Positive Parenting Program. Annu Rev Clin Psychol 2012;8:345 –379.

ICD-11 **6A06**	**6A06 BASMAKALIP HAREKET BOZUKLUĞU** **Stereotyped movement disorder**
ICD-10 F98.4	Stereotipik hareket bozuklukları
DSM-5-TR F98.4	Basmakalıp Devinim Bozukluğu

1. Tanım ve nozoloji

Basmakalıp hareket bozukluğu (ICD-11: 6A06 Stereotyped Movement Disorder; DSM-5-TR: F98.4 Stereotypic Movement Disorder) — istemli görünen, tekrarlayan, ritmik, amaçsız motor davranışla karakterize, günlük aktiviteye müdahale eden veya vücuda zarar veren nörogelişimsel bozukluktur. Tipik örnekler: el çırpma (hand flapping), vücut sallama (body rocking), kafa vurma (head banging), saç çekme, dudak ısırma, parmak oynatma.

Bozukluk iki formuyla sınıflandırılır:

- Birincil (primary, idiyopatik) — başka nörogelişimsel veya somatik bozukluk olmadan, normal IQ'lu çocukta;
- İkincil — entelektüel yetersizlik, otizm spektrum bozukluğu, duyusal yoksunluk (görme/işitme bozukluğu) veya tıbbi durum zemininde.

DSM-5-TR'de şiddet niteleyicisi ile — Kendine zarar verme ile veya onsuz.

2. Tarihçe

- Kanner L. (1943) — otizmin tanımında stereotipik davranışları sınırlı-tekrarlayan davranış kategorisi olarak belirtmiştir.
- 1960–1970'ler — entelektüel yetersizliğe dair kurumsal popülasyonlarda stereotipi tanımları.
- DSM-III-R (1987) — Stereotipi/Alışkanlık Bozukluğu ayrı bir kategori olarak.
- Mahone E.M. et al. J Child Neurol 2004, 2014 — sağlıklı bilişsel gelişime sahip çocuklarda "Primary Complex Motor Stereotypies" Sendromu sistematik olarak tanımlamışlardır; bu çalışmadan önce bu tür çocuklar genellikle otizm spektrum bozukluğu olarak yanlış tanı alıyordu.
- DSM-5 (2013) ve ICD-11 (2019) — nörogelişimsel bozukluklar kategorisine dahil edilmiştir; kendine zarar niteleyicisi eklenmiştir.

3. Epidemiyoloji

- Geçici stereotipiler Sağlıklı çocukların %3–15'inde 3 yaşına kadar gözlenir (Foster L.G. J Dev Behav Pediatr 1998).
- Birincil (primary) klinik stereotipik hareket bozukluğu — normal bilişsel gelişim gösteren çocuklarda ~%3–4 (Freeman R.D. et al. Mov Disord 2010).
- İkincil formlar — entelektüel yetersizlikte %60'a kadar; ağır ve derin entelektüel yetersizlikte ~%80 hastada bir şekilde stereotipi; otizm spektrum bozukluğunda neredeyse her zaman bir şekilde mevcuttur (Bodfish J.W. et al. J Autism Dev Disord 2000).
- Cins: ilk formlarda erkeklerde 3:1; ikincil formlarda fark daha az.
- Başlangıç yaşı: tipik 3 yaşa kadar (DSM-5-TR kriteri).
- Kendine zarar (self-injurious behavior, SIB): Genel popülasyonda nadir, ancak ağır entelektüel yetersizlikte %25–30, Lesch-Nyhan veya Cornelia de Lange gibi sendromlarda neredeyse her zaman.

4. Etiyoloji ve patogenez

4.1 Nörobiyolojik mekanizmalar

- Bazal ganglionlar ve korteks-striatum devresi disfonksiyonu — alışkanlık seçimi ve motor inhibisyon süreçlerinin bozulması (Singer H.S. Semin Pediatr Neurol 2009).
- Dopaminerjik sistem — D1 ve D2 reseptörlerinin dengesizliği; deneysel modellerde dopamin agonistleri stereotipik davranışı güçlendirir.

- Serotonerjik sistem — bazı hastalarda SSRI kısmi yanıt gösterir.
- Opioid sistem — kendine zarar formlarında endojen opioid disregülasyonu hipotezi (naltrekson kısmen etki gösterir).

4.2 Genetik ve aile faktörleri

- Birincil stereotipide aile kümelenmesi kaydedilir — aile öyküsü %25–30 (Mahone 2014).
- Spesifik genetik sendromlarda stereotipi yüksek yaygınlıkta — Rett (MECP2), Lesch-Nyhan (HPRT1), Cornelia de Lange (NIPBL), Smith-Magenis (RAI1), Fragile X (FMR1), Phelan-McDermid (22q13).

4.3 Çevre ve davranış faktörleri

- Duyusal yoksunluk — kurumsal ortam, kör veya sağır çocuklarda yüksek sıklık.
- Davranış mekanizmaları — kendini uyarma (duyusal girdi arayışı), otomatik pekiştirme (içsel pekiştirme), bağlama bağlı fonksiyonel ilişki (kaçınma, dikkat).
- Stres ve kaygı bozuklukları stereotipinin şiddetini güçlendirebilir.

5. Klinik özellikler

5.1 Tipik motor modeller

- Ellerin çırpılması (hand flapping) — en yoğun; duygusal heyecan veya konsantrasyon sırasında.
- Vücut sallama (body rocking) — otururken veya ayaktayken.
- Kafa vurma (head banging) — kendine zarar formu; yastığa, duvara veya yere vurma.
- Vücudu kucaklama, parmak oynatma, dudak ısırma, saç çekme.
- Görsel uyarım — gözlerin önünde el çevirme, ışığa bakma.
- Kendine zarar verme (SIB) — kafa vurma, ısırma, çarpma, dişleriyle yaralama.

5.2 Klinik özellikler

- Süre — saniyelerden saatlere; bir epizodda 5–10 dakika tipiktir.
- Tetikleyiciler — heyecan (hoş veya stresli), konsantrasyon, meşgul olmama (boş zaman).

- Dikkat ile durdurma — hasta çağrıldığında veya başka bir aktiviteye yönlendirildiğinde davranış durur (tiklerden farklı — premonitör duyum yoktur).
- Stereotipinin fonksiyonel rolü — kendini uyarma, sakinleştirme, duyusal uyarılma kontrolü.

5.3 Komorbidite

- Entelektüel yetersizlik (sekonder formlarda).
- Otizm spektrum bozukluğu (komorbid %30–50 birincil stereotipide — Mahone 2014).
- DEHB — birincil stereotipili çocuklarda komorbid %20–35.
- Anksiyete ve OKB-benzer semptomlar.
- Tik bozuklukları — ayırt etmek zor olabilir.

6. Tanı

6.1 Birleşik tanı ölçütleri (DSM-5-TR · ICD-11 konsensus noktaları)

A. Tekrarlayan, amaçsız, görünür-iradi motor davranış (örn. el sallama, vücut sallama, baş vurma, kendini ısırma).

B. Davranış sosyal, akademik veya diğer etkinliklere müdahale eder veya kendine zarar vermeye yol açar.

C. Başlangıç erken gelişim döneminde (tipik 3 yaşa kadar).

D. Davranış, madde (örn. uyarıcı) veya nörolojik durum (tik, koreatetoz, distoni, dermatilomani, trikotillomani) ile tam olarak açıklanmaz; OKB, OSB veya başka bir ruhsal bozuklukla daha iyi açıklanmaz (komorbidite dışlanmaz).

6.2 Kaynaklar arasındaki farklar

- DSM-5-TR (F98.4): Şiddet niteleyicisi — kendine zarar verme ile / olmadan; ek niteleyiciler — bilinen tıbbi/genetik durum ile; entelektüel yetersizlik veya otizm zemininde.
- ICD-11 (6A06): paralel yapı; “amaçsız tekrarlayan motor davranış” vurgusu.
- Mahone E.M. et al. J Child Neurol 2014: “Primary Complex Motor Stereotypies” (PCMS) — normal bilişsel gelişime sahip çocuklarda ayrı bir klinik forma dikkat; tipik el/kol stereotipileri; otizmle karıştırılma riski.

6.3 Tanı algoritması

1. Ebeveyn görüşmesi ve video belgeleme (ailenin telefonla kaydettiği epizodlar tanısal açıdan değerlidir).
2. Gelişim ve nörolojik muayene.
3. Tikler ve diğer hareket bozuklukları (kore, miyoklonus, distoni) ile ayırıcı tanı — nörolog konsültasyonu.
4. Komorbidite taraması — otizm spektrumu (M-CHAT-R/F, ADOS-2), entelektüel yetersizlik (Vineland-3, IQ), DEHB, anksiyete.
5. Duyusal bozukluk dışlaması — işitme ve görme testi.
6. Kendine zarar varsa — işlevsel davranış değerlendirmesi (FBA).
7. Spesifik klinik şüphe temelinde — genetik araştırma (CMA, FMR1, MECP2, Lesch-Nyhan HPRT aktivitesi ve ürik asit).

6.4 Ayırıcı tanı

Durum	**Ayırt edici belirtiler**
Tik bozuklukları (8A05)	Kısa, ritmik olmayan, premonitor his; supresyon mümkündür ancak fark derinin altında "kaşınma" hissi.
Otizm spektrumu (6A02)	Stereotipi komorbid olabilir; sosyal-iletişimsel defisit esastır.
OKB — kompulsiyonlar (6B20)	Ego-distonik; obsesyona yanıt; anlamlı (temizlik, simetri).
Mioklonus, koreatetoz	Devamsız, ritmik olmayan, istemli olmayan; nörolojik muayenede fokal bulgular.
Trikotilomania (6B25.0), dermatilomania (6B25.1)	Saç çekme / deri yolma — vücuda yönelik tekrarlayan davranışlar kategorisinde; genel stereotipiden ayrı.
Tutma (epileptik)	Bilinç değişikliği ve/veya postiktal durum; EEG
Stimülan kaynaklı stereotipi	Yüksek doz amfetamin veya kokain ile ilişkili; toksikolojik tarama.
Geçici çocukluk stereotipileri (sağlıklı)	İşlevsel bozulma yok; 3 yaşa kadar geçer; klinik tanı gerektirmez.

7. Muayene ve değerlendirme

7.1 Klinik görüşme ve ölçekler

- Stereotypy Severity Scale (SSS) — Miller J.M., Singer H.S. et al.
- Repetitive Behavior Scale-Revised (RBS-R) — otizm ve entelektüel yetersizliklerle komorbid durumlarda.
- Video kayıtları — ailenin evde yaptığı epizod kayıtları klinisyen tarafından değerlendirilir.
- İşlevsel davranış analizi (FBA) — kendine zarar veya bağlama bağlı stereotipide müdahale planlaması için.

7.2 Laboratuvar incelemeleri

Rutin göstergesi yoktur. Klinik şüphe temelinde:

- Genetik panel (CMA, Fragile X) — entelektüel yetersizlik veya sendromal belirtiler varsa.
- MECP2 (Rett kızlarda).
- HPRT aktivitesi ve ürik asit — Lesch-Nyhan sendromu şüphesi (kendini ısırma).
- Tiroid, kurşun düzeyi.
- Toksikolojik tarama — ergenlerde.

7.3 Enstrümantal incelemeler

- EEG — tutma şüphesi varsa.
- Beyin MRG — fokal nörolojik belirtiler veya regresyon.
- İşitme ve görme testi — duyusal yoksunluk rolünü değerlendirmek için.

8. Tedavi

8.1 Genel prensipler

1. Davranış müdahalesi birinci basamak — işlevsel davranış analizine dayalı kişiselleştirilmiş plan.
2. Birincil (primary) stereotipi durumunda — hasta işlevsel zorluk yaşamıyorsa, gözlem yeterli olabilir (Mahone 2014). Aileye durumun doğası ve prognozun açıklanması; zorunlu müdahale gerektirmez.
3. İşlevsel zorluk veya sosyal aktiviteye müdahale olduğunda — HRT (Habit Reversal Training), DRO (Differential Reinforcement of Other behavior),

RIRD (Response Interruption and Redirection) kanıtlanmış davranışsal müdahaleler.

4. Kendine zarar vermede — multidisipliner yaklaşım; davranış müdahalesi + koruyucu cihazlar (yastıklı kask) + farmakoterapi (refrakter vakalarda).
5. Duyusal yoksunluk — çevrenin zenginleştirilmesi (oyuncak, sosyal etkileşim), hastaya duyusal girdi sağlayan alternatif aktiviteler.
6. Komorbidite tedavisi — otizm, entelektüel yetersizlik, DEHB, anksiyete.
7. Farmakoterapi sınırlı kanıt tabanına sahiptir — yalnızca ağır, davranış müdahalesine yanıt vermeyen durumlarda; kendine zarar veya otizm/entelektüel yetersizlik komorbid bağlamında.

8.2 Farmakoterapi (sınırlı kanıt)

- Atipik antipsikotik (risperidon, aripiprazol) — otizm/entelektüel yetersizlik zemininde davranışsal agresyon ve kendine zarar için; FDA onayı — risperidon 5–16 yaş OSB irritabilite için (kendine zarar dahil), aripiprazol 6–17 yaş OSB irritabilite için. Stereotipik hareket bozukluğunun "çekirdek" semptomları için FDA onaylı ilaç yoktur.
- SSRI — fluoksetin, sertralin — bazı hastalarda mütevazı etki gösterir, özellikle anksiyete komorbid durumlarda; kanıt temeli sınırlıdır.
- Naltrekson — kendine zarar vermede düşünülür (endojen opioid hipotezi temelinde); RKÇ kanıtı sınırlıdır, Symons F.J. et al. Am J Ment Retard 2004 derleme — küçük etki büyüklüğü.
- Klonidin, guanfasin — komorbid DEHB veya uyku bozukluğunda yardımcı olabilir.

8.3 Özel durumlar

- Kendine zarar (SIB): acil davranış analizi; koruyucu araçlar (kask, kol kısıtlayıcıları) kısa süreli; davranışsal yoğun müdahale; farmakoterapi refrakter vakalarda; hastane yatışı ağır vakalarda.
- Spesifik genetik sendromlar — Lesch-Nyhan'da kendini ısırma neredeyse kalıcı; ağız-dental kompromis (dişlerin çekilmesi son seçenek); allopurinol metabolik durum için.
- Duyusal yoksunluk — çevre değişikliği, alternatif duyusal girdi.

8.4 Kaynağa-özgü belirleyiciler

- Mahone E.M. et al. J Child Neurol 2014: ilk formlarda agresif müdahale gerekmez; aileye prognoz ve durumun doğası açıklaması; HRT ergenlikte etkili.

- AAP — kendine zarar verme protokolü: entelektüel yetersizlikli çocuklarda multimodal yaklaşım.
- NICE NG11 (Challenging Behaviour and Learning Disabilities, 2015): entelektüel yetersizlikte davranış müdahalesi birinci sıra; antipsikotik yalnızca refrakter durumlarda ve kısa süreli.

8.5 Tedavi metodolojileri

1. Alışkanlık Değiştirme Eğitimi (HRT — Habit Reversal Training) — Azrin (Azrin N.H.), Nunn (Nunn R.G.) — Beş temel bileşen — farkındalık eğitimi (davranışın tanınması), rakip yanıt eğitimi (rakip davranış öğretme), motivasyon bileşeni, sosyal destek, genelleme eğitimi. Stereotipik hareket bozukluğunda ve tik bozukluklarında kanıtlı. Kanıt: Specht M.W. et al. J Child Neurol 2017 RKÇ — primer kompleks motor stereotipide şiddet azalması.
2. Diğer Davranışın Ayırt Edici Pekiştirilmesi (DRO — Differential Reinforcement of Other behavior) — Stereotipi olmadan geçen zaman aralıklarının pozitif pekiştirilmesi (token, övgü, aktivite). Entelektüel yetersizlik zemininde etkili. ABA'nın temel bileşenlerinden.
3. Tepkinin Kesilmesi ve Yönlendirilmesi (RIRD — Response Interruption and Redirection) — Stereotipi başladığında mola ve alternatif meşgul göreve yönlendirme. Vokal stereotipilerde ve ağır vakalarda kullanılır. Ahearn W.H. et al. J Appl Behav Anal 2007.
4. İşlevsel Davranış Değerlendirmesi (İDD / FBA — Functional Behavior Assessment) — Davranışın öncül (ön-koşul), işlevsel sonuç ve bağlamının sistematik analizi — müdahale planının bireyselleştirilmesinin temeli. ABA ve PBS içinde.
5. Stereotipi Şiddet Ölçeği (SSS — Stereotypy Severity Scale) — Miller (Miller J.M.), Singer (Singer H.S.) — Stereotipinin sıklığı, süresi, yoğunluğu ve müdahale derecesinin standartlaştırılmış değerlendirilmesi.
6. Tekrarlayan Davranış Ölçeği-Yenilenmiş (RBS-R — Repetitive Behavior Scale-Revised) — Bodfish (Bodfish J.W.) ve ark. — 43 maddelik ebeveyn anketi — stereotipi, kendine zarar, kompulsif, ritüelleştirme, aynılıkta ısrar, sınırlı davranış alt ölçekleri. Otizm ve entelektüel yetersizlik komorbid durumlarında kullanım.

9. Prognoz

İyi prognoz faktörleri

- Birincil (primary) form, normal IQ.

- Kendine zarar olmaması.
- Erken HRT müdahale yanıtı.
- Komorbidite olmaması.
- Aile desteği ve gerçekçi beklentiler.

Kötü prognoz etkenleri

- İkincil form — ağır entelektüel yetersizlik veya genetik sendrom bağlamında.
- Kendine zarar verme — özellikle Lesch-Nyhan, Cornelia de Lange.
- Komorbid otizm spektrum bozukluğu.
- Davranış müdahalesine yanıtsızlık.

İzlem hedefleri

- Stereotipinin sıklığı, süresi, yoğunluğu (SSS) — 3–6 aylık.
- İşlevsel bozulma ve kendine zarar izlemi.
- Komorbidite (otizm, DEHB, anksiyete, OKB) taraması.
- Adolesan ve Yetişkinlikte Sosyal Adaptasyon Destekleri.
- Farmakoterapi alanlarda — yan etki izlemi (metabolik, EPS).

10. Mit ve yanlış inançlar

10.1 Etiyoloji mitleri

Mit 1: “Stereotipi her zaman otizmin bir belirtisidir”

Neden yaygınlaştı: Otizmli kişilerde stereotiplerin DSM-5 kriterlerine dahil olması ve popüler medyada öncelikli olarak otizm ile ilişkilendirilmesi.

Klinik ve biyolojik mantık: Mahone E.M. et al. J Child Neurol 2004, 2014 — “Primary Complex Motor Stereotypies” Sendromu normal bilişsel gelişime sahip çocuklarda sosyal etkileşim defisiti veya sınırlı-tekrarlayan davranış paterni olmadan da ortaya çıkabilir. Bu çocukların %30–50'sinde komorbid otizm veya DEHB olabilir, ancak çoğunluğunda yoktur.

Kanıt: Mahone 2014; Freeman R.D. et al. Mov Disord 2010 — primer stereotipi, otizmden farklı klinik bir birimdir.

Gerçek klinik adım: her stereotipik davranışlı çocuk için otizm spektrumu ayrı bir diferansiyel olarak değerlendirilmelidir; komorbid değilse, aile tehdit edilmemelidir.

Mit 2: "Stereotipi kötü terbiye veya duygusal yoksunluğun sonucudur"

Neden yaygınlaştı: 1960'larda kurumsal çocuklarda yüksek yaygınlık gözlemleri "yoksunluk" teorisini güçlendirdi.

Kanıt: Bodfish J.W. et al. J Autism Dev Disord 2000 — stereotipi nörobiyolojik temelli bir bozukluktur, bazal gangliyonlar ve korteks-striatum devresi disfonksiyonu ile. Duyusal yoksunluk şiddeti etkileyebilir, ancak etiyoloji değildir. Sağlıklı evlerde büyüyen, destekleyici aile çocuklarında da gözlenir.

Mit 3: "Çocuk yaşla geçecek — hiçbir şey yapmaya gerek yok"

Kanıt: Geçici çocukluk stereotipileri 3 yaşa kadar geçer; ancak birincil klinik stereotipi tipik olarak devam eder — Mahone 2014 izlem çalışmaları yetişkinliğe kadar belgelemiştir. Aileye gerçekçi prognoz açıklanmalıdır; kendine zarar veya işlevsel bozulma varsa müdahale gerekir.

10.2 Zararlı veya yanlış yöntemler

Mit 4: "Çocuğu fiziksel olarak kısıtlamak (kol bağlamak, hareketi durdurmak) stereotipiyi geçirir"

Neden yaygınlaştı: sezgisel olarak davranışın "durdurulması" semptomu ortadan kaldırıyor gibi görünür.

Klinik mantık ve kanıt: sürekli fiziksel restraint kontrproduktiftir — hastanın distressini artırır, otonomisini bozar, deri hasarı ve kontraktürler oluşturur. NICE NG11 (2015), AAP — restriktif yalnız acil ve kısa süreli kendine zarar durumlarında koruyucu amaçla; sürekli tedavi olarak önerilmez. Fonksiyonel davranış analizi temelli pozitif davranış müdahalesi (PBS) üstündür.

Mit 5: "Ceza (keskin yeniden yönlendirme, azarlama, fiziksel ceza) stereotipiyi geçirir"

Kanıt: NICE NG11 — ceza temelli yaklaşım davranış azaltmada etkili değildir; duygusal zarar ve travma riski oluşturur. ABA pratiği de modern formda ceza yerine olumlu pekiştirmeye (DRO) dayanır.

Mit 6: "Antipsikotik tüm stereotipik hareketlere etkilidir"

Kanıt: antipsikotikler (risperidon, aripiprazol) FDA onayı OSB irritabilite için — kendine zarar dahil. Primer stereotipi için FDA onayı yoktur; "çekirdek" stereotipiye etki sınırlıdır. Yan etki yükü (metabolik, EPS, prolaktin) önemlidir. NICE NG11 — antipsikotik yalnızca refrakter ağır davranış için ve kısa süreli.

10.3 Etkisiz veya bilimsel olarak temelsiz yöntemler

Mit 7: "Duyu bütünleme terapisi (Ayres SI) stereotipiyi iyileştirir"

Kanıt: AAP 2012 Sensory Integration Statement — terapötik etkisi "araştırma devam eden" şeklinde sınıflanır; stereotipik davranış için spesifik etkinlik kanıtı zayıftır. Fonksiyonel davranış müdahalesi (HRT, DRO) kanıt açısından üstündür.

Mit 8: "Hiperbarik oksijen odası, kök hücre enjeksiyonları, şelasyon stereotipiyi geçirir"

Kanıt: Cochrane ve FDA uyarıları (otizm zemininde de aynı konum) — bu müdahalelerin stereotipi veya nörogelişimsel bozukluk için etkisi yoktur, risk profili anlamlıdır.

Mit 9: "Özel diyet (glutensiz, kazeinsiz) stereotipiyi geçirir"

Kanıt: Hyman S.L. et al. AAP 2020 — stereotipi veya otizm için özel diyetin etkisi kanıtlanmamış.

Mit 10: "EEG Nörofeedback stereotipiyi geçirir"

Kanıt: Özgül stereotipik hareket bozukluğunda nörofizyolojik bulgular yoktur. DEHB'de ılımlı etki, ancak stereotipik davranışa ekstrapolasyon geçersizdir.

Mit 11: "Homeopati, akupunktur, kraniosakral terapi stereotipiyi iyileştirir"

Kanıt: hiçbirinin stereotipik hareket bozukluğu için etkisi kanıtlanmamış.

11. Kaynaklar

1. WHO. ICD-11 for Mortality and Morbidity Statistics. 6A06 Stereotyped movement disorder. 2024.
2. American Psychiatric Association. DSM-5-TR. Washington DC: APA Publishing; 2022.
3. Mahone E.M., Bridges D., Prahme C., Singer H.S. Repetitive arm and hand movements (complex motor stereotypies) in children. J Child Neurol 2004;19(5):379–383.
4. Singer H.S. Motor stereotypies. Semin Pediatr Neurol 2009;16(2):77–81.
5. Freeman R.D., Soltanifar A., Baer S. Stereotypic movement disorder: easily missed. Dev Med Child Neurol 2010;52(8):733–738.

6. Bodfish J.W., Symons F.J., Parker D.E., Lewis M.H. Varieties of repetitive behavior in autism: comparisons to mental retardation. J Autism Dev Disord 2000;30(3):237–243.
7. Specht M.W., Mahone E.M., Kline T. et al. Efficacy of parent-delivered behavioral therapy for primary complex motor stereotypies. J Child Neurol 2017;32(2):204–212.
8. NICE Guideline NG11. Challenging behaviour and learning disabilities: prevention and interventions for people with learning disabilities whose behaviour challenges. 2015.
9. Symons F.J., Thompson A., Rodriguez M.C. Self-injurious behavior and the efficacy of naltrexone treatment: a quantitative synthesis. Ment Retard Dev Disabil Res Rev 2004;10(3):193–200.
10. Ahearn W.H., Clark K.M., MacDonald R.P., Chung B.I. Assessing and treating vocal stereotypy in children with autism. J Appl Behav Anal 2007;40(2):263–275.
11. Foster L.G. Nervous habits and stereotyped behaviors in preschool children. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry 1998;37(7):711–717.
12. Hyman S.L., Levy S.E., Myers S.M.; AAP Council on Children with Disabilities. Identification, Evaluation, and Management of Children With Autism Spectrum Disorder. Pediatrics 2020;145(1):e20193447.
13. Azrin N.H., Nunn R.G. Habit-reversal: a method of eliminating nervous habits and tics. Behav Res Ther 1973;11(4):619–628.
14. Miller J.M., Singer H.S., Bridges D.D., Waranch H.R. Behavioral therapy for treatment of stereotypic movements in nonautistic children. J Child Neurol 2006;21(2):119–125.

ICD-11 **8A05.0**	**8A05.0 PRİMER TİKLER VEYA TİK BOZUKLUKLARI** **Primary tics or tic disorders**
ICD-10 F95.2	Kombine vokal ve birden fazla motor tik bozuklukları [de la Tourette]
DSM-5-TR F95.2	Tourette Bozukluğu (ve diğer tik bozuklukları F95.0–F95.1)

1. Tanım ve nozoloji

Primer tikler veya tik bozuklukları (ICD-11: 8A05.0 Primary Tics or Tic Disorders; DSM-5-TR: F95.0–F95.2) — ani, hızlı, tekrarlayan, ritmik olmayan, istemsiz veya yarı-istemsiz motor hareketler ve/veya vokal/ses üretimleriyle karakterize nörogelişimsel bozukluklar grubudur. Tikler tipik olarak premonitör his (dürtü veya gerilim) ile eşlik eder ve kısa süreli iradi olarak tutulabilir.

ICD-11 ve DSM-5-TR'de üç ana kategori:

- Tourette sendromu (DSM-5-TR F95.2) — çok sayıda motor tikleri ve bir veya daha fazla vokal tik ≥ 1 yıl sürmüş, başlangıç 18 yaşından önce;
- Sürekli (kronik) motor veya vokal tik bozukluğu (DSM-5-TR F95.1) — motor veya vokal (ancak ikisi birden değil) ≥ 1 yıl;
- Geçici tik bozukluğu (DSM-5-TR F95.0) — tik (motor ve/veya vokal) < 1 yıl, başlangıç 18 yaşa kadar.

2. Tarihçe

- Itard J.M.G. (1825) — markiz de Dampierre'de motor ve vokal tiklerin ilk klinik tanımı.
- Gilles de la Tourette G. (1885) — Salpêtrière Hastanesi'nde Charcot'un yönlendirmesiyle 9 hastanın klasik tanımı; sendromun adı.
- 1960'lı yıllar — psikanalitik açıklama baskın olmuştur (“nevrotik bozukluk”).
- 1961 (Seignot J.N.) — haloperidolün ilk klinik kullanımı tiklerde etkiyi ortaya çıkarmıştır — nörobiyolojik konsepte geçişin temeli.
- DSM-III (1980) ve sonraki revizyonlar — tiklerin tıbbi bozukluk olarak resmen tanınması.
- AAN 2019 (Pringsheim T. et al. Neurology 2019;92(19)) — uluslararası kanıta dayalı klinik kılavuz; α2-agonistlerin antipsikotiklerle karşılaştırıldığında daha elverişli yan etki profili ile birinci sıra olduğu vurgulanmıştır.
- ESSTS — European Society for the Study of Tourette Syndrome — Avrupa klinik önerileri (2011, 2022 güncellemesi).

3. Epidemiyoloji

- Tourette sendromu yaygınlık: çocuklarda %0,5–1 (Knight T. et al. Pediatr Neurol 2012 sistematik derleme).
- Sürekli motor veya vokal tik: ~%1–2.

- Geçici tikler: okul çağı çocukların %20'sine kadarında.
- Cins: Erkeklerde 3–4 kat yüksek.
- Başlangıç yaşı: 5–7 yaş; pik şiddet 10–12 yaş.
- Persistans: yetişkinlikte tikler ~%50'sinde belirgin azalır, ~%30'unda devam eder; ~%20'sinde ağır form kalır (Bloch M.H., Leckman J.F. J Psychosom Res 2009).
- Komorbidite: DEHB %50–60, OKB %30–50, anksiyete %30, depresyon %20, öğrenme bozukluğu %20–30, öfkeli patlamalar, uyku bozuklukları.

4. Etiyoloji ve patogenez

4.1 Genetik faktörler

- Kalıtım: 0,77 (Mataix-Cols D. et al. JAMA Psychiatry 2015 aile ve ikiz çalışmaları, n>200 000 İsveç) — en yüksek kalıtsallığa sahip psikiyatrik bozukluklardan.
- Poligenik doğa: GWAS (Yu D. et al. Am J Psychiatry 2019) — risk lokusları tespit edilmiştir; tek gen yoktur.
- Nadir mutasyonlar: SLITRK1, HDC (histidin dekarboksilaz), CELSR3 — küçük sayıda ailede.
- Aile öyküsünde OKB ve DEHB sıklığı yüksektir — genetik örtüşme.

4.2 Nörobiyolojik mekanizmalar

- Kortiko-striato-talamo-kortikal (CSTC) devresi disfonksiyonu — bazal gangliyonlar ve ilişkili alanlarda motor inhibisyon bozukluğu (Leckman J.F. et al. Neuron 2000;28(2):349–354).
- Dopaminerjik sistem hiperaktivitesi — dopamin antagonistlerinin (haloperidol, risperidon) tikleri azaltma mekanizması.
- Histaminerjik sistem — HDC mutasyonları nadiren; histaminerjik tonus düşük.
- Yapısal değişiklikler: Kaudat hacminde azalma, sensorimotor kortikal incelme (Sowell E.R. et al. Nat Neurosci 2008).

4.3 Çevresel faktörler (modifikatör)

- Erken doğum, perinatal hipoksi — riski hafif artırır.
- Annede gebelikte tütün kullanımı.
- Psikososyal stres — tiklerin başlangıcına neden değil, şiddeti etkiler.

- PANDAS / PANS (Pediatric Autoimmune Neuropsychiatric Disorders Associated with Streptococcal infections / Pediatric Acute-onset Neuropsychiatric Syndrome) — nadir; çoğu vaka aslında tipik Tourette/OKB'dir (genişletilmiş §10 bak).

5. Klinik özellikler

5.1 Motor tikler

- Basit motor tikler: Göz kırpma (en sık başlangıç), burun çekme, baş sallama, omuz atma, dudak oyunu.
- Karmaşık motor tikler: ardışık hareketler — hopping, touching, pirouette; nadiren müstehcen jest (kopropraksi, ~%5).

5.2 Vokal/ses tikleri

- Basit vokal: Öksürük, burun çekme, hırıltı, boğaz temizleme, çığlık.
- Karmaşık vokal: kelime, ekolali (başkasının sözlerinin tekrarı), palilali (kendi sözünün tekrarı).
- Koprolali (müstehcen söz veya ifade) — Tourette hastalarında erkeklerin %19,3'ünde, kadınların %14,6'sında görülür (Freeman R.D. et al. Dev Med Child Neurol 2009 uluslararası Tourette database, n=597), kitle medyasındaki imajdan farklıdır.

5.3 Premonitor his ve istemli tutma

Hastaların çoğunluğu tikten önce premonitör hisi (somatik dürtü, gerilim) kaydeder; tik bu hissi geçici olarak rahatlatır. Tikler kısa süreli (saniyelerden dakikalara) iradi olarak tutulabilir, ancak bu tutma iç gerilim ve rahatsızlık yaratır — sonraki tik epizodu genellikle daha yoğun olur.

5.4 Gidiş ve değişkenlik

- tikler “waxing and waning” — şiddet döngüsü değişir; bir tik tipi diğeriyle yer değiştirir.
- Tetikleyiciler — stres (hoş veya kötü), heyecan, yorgunluk, belirli bağlamlar (örn. okulda tiklerin bastırılması).
- Uyku sırasında tikler azalır, ancak tamamen kaybolmaz.
- En yüksek şiddet 10–12 yaş; ergenlikte çoğu hastada azalma.

6. Tanı

6.1 Birleşik tanı ölçütleri (DSM-5-TR · ICD-11 · AAN 2019 konsensus noktaları)

Tourette sendromu için:

1. Çok sayıda motor tik ve bir veya daha fazla vokal tik (farklı zamanlarda olmuş, şu anda aynı anda olması gerekmez).
2. Tikler en az 1 yıl devam etmiş (zamana göre değişebilir).
3. Başlangıç 18 yaşa kadar.
4. İstisnalar — madde (örn. kokain) veya tıbbi durum (Huntington, postviral ensefalit) ile tam olarak açıklanmaz.

Sürekli motor veya vokal tik bozukluğu: Tourette ile aynı kriterler, ancak tek tipli tik (motor veya vokal, ikisi birden değil).

Geçici tik bozukluğu: Tourette ile aynı kriterler, ancak süre < 1 yıl.

6.2 Kaynaklar arasındaki farklar

- DSM-5-TR: üç ayrı kategori (F95.0, F95.1, F95.2). “İşlevsel bozulma” ve “şiddet” tanısal gerekliliğe dahil edilmemiştir — sadece kriterlerin karşılanması tanısal olarak yeterlidir; ancak müdahale kararı işlevsel bozulmaya dayanır.
- ICD-11 (8A05.0): “primary tics or tic disorders” — alt spesifikasyonlar Tourette, sürekli, geçici.
- AAN 2019 (Pringsheim T. et al.): tanı kliniktir, video kayıtları yardımcıdır; YGTSS (Yale Global Tic Severity Scale) başlangıç göstergeleri ve izlem için; komorbidite (DEHB, OKB) mutlaka değerlendirilmelidir.
- ESSTS 2022 (Müller-Vahl K.R. ve ark.): Avrupa bağlamında — aynı kriterler; CBIT'i birinci basamak non-farmakolojik müdahale olarak kabul eder.

6.3 Tanı algoritması

1. Ebeveyn ve hasta görüşmesi — başlangıç yaşı, gidişat, tetikleyiciler, premonitor his.
2. Video kayıtları — aile tarafından evde tutulmuş epizodlar (klinik bağlamda tikler sıklıkla azalır).
3. Standardize edilmiş ölçek — YGTSS (Yale Global Tic Severity Scale, başlangıç göstergeleri ve izlem).

4. Komorbidite taraması — DEHB (Conners, Vanderbilt), OKB (CY-BOCS), anksiyete, depresyon, öğrenme bozukluğu, uyku.
5. Nörolojik muayene — fokal bulgular, koreatetoz dışlanması.
6. Spesifik klinik şüphede — Huntington (HTT geni), Wilson hastalığı (seruloplazmin, bakır), nöroakantositoz.
7. PANDAS/PANS şüphesi — yalnızca klasik klinik tablo (hızlı başlangıç, OKB + tikler + emosyonel labilite post-streptokok) varsa; rutin antistreptolizin O testleri önerilmez (NIMH 2017).

6.4 Ayırıcı tanı

Durum	**Ayırt edici belirtiler**
Stereotipik hareket bozukluğu (6A06)	Ritmik, daha uzun süreli (saniye-dakika), premonitör his yok; başlangıç < 3 yaş.
Miyoklonus	Kısa, ani, istemsiz, premonitor his yok; nörolojik etiyoloji.
Koreatetoz, distoni	Sürekli istemsiz hareketler; tutma mümkün değil; nörolojik muayene.
OKB (6B20) — kompulsiyonlar	Ego-distonik amaçlı sıralamalar; obsesyona yanıt. Komorbid sıktır.
Fonksiyonel tik (functional tic-like behavior)	Hızlı ergenlik döneminde başlangıç, kompleks bizarre modeller, kitle medyasından kopya; COVID-19 döneminde artış gözlenmiştir (Pringsheim T. et al. Mov Disord Clin Pract 2021).
PANDAS/PANS	Hızlı başlangıç post-streptokok; OKB + tik birlikte patlaması; nadir.
Nöbet (epileptik)	Bilinç değişikliği; EEG
Wilson hastalığı	Hepatik ve nörolojik semptomlar; Kayser-Fleischer halkası, seruloplazmin azalması.
Huntington hastalığı	Tipik erişkinlikte başlangıç; kore, kognitif düşüş, aile öyküsü.

7. Muayene ve değerlendirme

7.1 Klinik ölçekler

- YGTSS (Yale Global Tic Severity Scale, Leckman J.F. et al. 1989) — motor ve vokal tikler için ayrı ayrı; sıklık, yoğunluk, karmaşıklık, müdahale, sayı 0 –5 puan ölçekte; global bozulma 0–50. Başlangıç göstergeleri ve tedavi izlemi.
- PUTS (Premonitory Urge for Tics Scale).
- CY-BOCS — komorbid OKB değerlendirmesi.
- Conners-3, Vanderbilt — komorbid DEHB.

7.2 Laboratuvar incelemeleri

Rutin tikler için spesifik laboratuvar göstergesi yoktur. Klinik şüphe temelinde:

- Tiroid fonksiyonu (TSH) — hipertiroid bağlamında.
- Seruloplazmin, 24 saatlik idrar bakırı — Wilson hastalığı şüphesi (özellikle hepatik veya ekstrapiramidal).
- HTT — Huntington şüphesi (aile öyküsü).
- Streptokok antikoru (ASO, anti-DNase B) — yalnız klasik PANDAS klinik tablosu varsa; rutin önerilmez.

7.3 Enstrümantal incelemeler

- EEG — yalnız tutma şüphesi.
- Beyin MRG — fokal nörolojik belirtiler, atipik klinik tablo.
- Tikler için rutin nörogörüntüleme önerilmez.

8. Tedavi

8.1 Genel prensipler (AAN 2019 · ESSTS 2022 konsensusu)

1. Müdahale kararı işlevsel bozulmaya dayanır — hafif tikler gözlemlenebilir; agresif müdahale gerektirmez.
2. Aileye ve okula psikoeğitim ilk adım — tiklerin doğası, dalgalanma, premonitor his.
3. Davranış müdahalesi — CBIT (Comprehensive Behavioral Intervention for Tics) AAN 2019'da birinci sıra öneri (8+ yaş). HRT (Habit Reversal Training) + fonksiyonel müdahale + gevşeme.
4. Farmakoterapi — fonksiyonel bozulma olduğunda ve CBIT mevcut değilse veya yeterli etki vermediyse:

- İlk sıra: α2-adrenerjik agonistler — klonidin, guanfasin (ER) — yan etki profili antipsikotiklerden üstündür; özellikle komorbid DEHB'de faydalı.
- İkinci sıra: Atipik antipsikotik — aripiprazol (Tourette sendromunda 6–18 yaş için FDA onaylıdır, 2014), risperidon, ziprasidon. Daha güçlü antitik etki, ancak metabolik ve EPS yan etkiler.
- Üçüncü sıra: tipik antipsikotik — haloperidol, pimozid (FDA onayı Tourette için, ancak EPS ve QTc uzaması riski).
- Refrakter durumlarda — VMAT2 inhibitörleri (tetrabenazin off-label; deutetrabenazin ve valbenazin tikler için araştırma devam etmektedir), botulinum toksini fokal tiklerde.

5. Komorbidite tedavisi — DEHB (stimülanlar tikleri anlamlı şekilde artırmaz — Bloch M.H. et al. JAACAP 2009 meta-analiz; ancak hastalar izlenmelidir), OKB (SSRI + BDT), anksiyete, uyku.
6. Refrakter ağır Tourette'de — Deep Brain Stimulation (DBS) — talamik centromedian-parafascicular veya GPi (globus pallidus internus) hedefleri; sertifikalı merkezde multidisipliner seçim (Schrock L.E. et al. Mov Disord 2015).

8.2 Farmakoterapi — birinci basamak (α2-agonistler)

Preparat	Biçim	Doz aralığı	Not
Klonidin	IR / TDS (transdermal)	0,05–0,3 mg/gün (bölünmüş veya TDS)	Sedasyon, hipotansiyon; DEHB komorbid durumlarda faydalı.
Guanfasin ER	Uzun süreli	1–4 mg/gün (tek doz)	Daha az sedasyon, selektif α2A; DEHB'de FDA onaylı.

8.3 İkinci basamak (atipik antipsikotik)

Preparat	Doz aralığı	Yan etki profili
Aripiprazol	2–20 mg/gün	Akatizi, sedasyon; metabolik daha iyi.

Preparat	Doz aralığı	Yan etki profili
Risperidon	0,25–6 mg/gün	Kilo alımı, prolaktin yükselmesi, EPS.
Ziprasidon	20–80 mg/gün	QTc uzaması, EKG monitorizasyonu.

8.4 Üçüncü sıra (tipik antipsikotik)

- Haloperidol 0,5–4 mg/gün — FDA onayı Tourette için, ancak EPS, tardif diskinezi, sedasyon yan etkileri.
- Pimozid 1–4 mg/gün — FDA onayı Tourette; QTc uzaması, EKG mutlaka.

8.5 Komorbid durumlarda yaklaşım

- DEHB + tik: α2-agonist + uyarıcı veya atomoksetin. Uyarıcılar tartışmalı "tik güçlendiricisi" olarak tarihe sahipti, ancak Bloch 2009 meta-analiz ve TACT (Tourette's Syndrome Study Group. Neurology 2002;58(4):527–536) — orta dozda metilfenidat tikleri anlamlı şekilde güçlendirmez; monitör et.
- OKB + tik: SSRI + ERP; aripiprazol veya risperidon adjuvan olarak.
- Uyku bozukluğu: melatonin; klonidin uyku bileşenine de yardımcı olur.

8.6 Kaynağa-özgü belirleyiciler

- AAN 2019 (Pringsheim Neurology 2019): CBIT birinci basamak non-farmakolojik; α2-agonistler antipsikotiklerden önce (yan etki profili uygun); komorbid DEHB'de çifte fayda.
- ESSTS 2022 (Müller-Vahl): Avrupa bağlamında; CBIT ve farmakoterapi seçimi hasta özelliklerine göre bireyselleştirilir.
- Piacentini J. et al. JAMA 2010 (CBIT pivotal RKÇ): n=126, 9–17 yaş — CBIT plasebodan (destekleyici terapi) anlamlı üstün; YGTSS'de 7,6 vs 3,5 puan azalma; etki büyüklüğü g = 0,68.
- Tourette Association of America Behavioral Sciences Consortium — CBIT programının uygulanması ve terapist eğitimi.

8.7 Tedavi metodolojileri

1. Tikler için Kapsamlı Davranışsal Müdahale (CBIT — Comprehensive Behavioral Intervention for Tics) — Woods D.W., Piacentini J. — Birinci sıra non-farmakolojik müdahale (AAN 2019). Üç temel bileşen: (1) Alışkanlık Tersine Çevirme Eğitimi (HRT — premonitor his tanınması, rakip davranış öğrenme); (2) fonksiyonel müdahale (tikleri güçlendiren

bağlamların değiştirilmesi); (3) gevşeme eğitimi. Standart kurs — 8 bireysel seans, 10 hafta; sürekli tekrar seansları. Kanıt: Piacentini J. et al. JAMA 2010 RKÇ — temel çalışma; Wilhelm S. et al. Arch Gen Psychiatry 2012 yetişkinlerde RKÇ; etki büyüklüğü orta. tourette.org.

2. Alışkanlık Değiştirme Eğitimi (HRT — Habit Reversal Training) — Azrin (Azrin N.H.), Nunn (Nunn R.G.) — CBIT'in temel bileşeni — farkındalık eğitimi + karşıt yanıt. Her tik için ayrı karşıt davranış (örn. boyun atma yerine boynun merkezde tutulması).
3. Tikler için Maruz Bırakma ve Tepki Önleme (ERP — Exposure and Response Prevention) — HRT'ye alternatif davranış yaklaşımı — hasta, premonitor hissine tikle yanıt vermeden dayanmayı öğrenir. Verdellen C.W. et al. Behav Res Ther 2004. ESSTS — alternatif kanıtlanmış davranış yöntemi.
4. Yale Global Tik Şiddet Ölçeği (YGTSS — Yale Global Tic Severity Scale) — Leckman (Leckman J.F.) ve ark., 1989 — Tik bozukluklarında altın standart şiddet skalası; motor ve vokal tikler için ayrı ayrı sayı, sıklık, yoğunluk, karmaşıklık, müdahale derecesi (0-5 puan); global bozulma 0-50. Başlangıç göstergeleri ve izlem.
5. Tik Öncesi Dürtü Ölçeği (PUTS — Premonitory Urge for Tics Scale) — Woods D.W., Piacentini J. — 9 maddelik öz değerlendirme; premonitor hissin yoğunluğu ve müdahale davranışına etkisi.
6. Derin Beyin Stimülasyonu (DBS — Deep Brain Stimulation) — Refrakter ağır Tourette için cerrahi müdahale; tipik hedefler — talamus (centromedian-parafascicular) ve globus pallidus internus (GPi). Multidisipliner seçim; Schrock L.E. et al. Mov Disord 2015 uluslararası konsensus.
7. Botulinum Toksini — Fokal motor (örn. boyun, dudak, göz) ve vokal tiklerde hedef kasa enjeksiyon; 3–4 aylık etki. Marras C. et al. Neurology 2001 RKÇ.

9. Prognoz

İyi prognoz faktörleri

- Tipik tik bozukluğu (hızlı fonksiyonel tik-benzeri davranıştan farklı olarak).
- Hafif-orta YGTSS şiddeti.
- Komorbiditenin (DEHB, OKB) aktif yönetimi.
- Erken psikoeğitim ve aile-okul desteği.
- CBIT erişilebilirliği.

Kötü prognoz etkenleri

- Ağır komorbidite (ağır OKB, DEHB, anksiyete, depresyon)
- Kendine zarar verme tikleri (örn. kafa vurma).
- Sosyal ve akademik sınırlı uyum.
- Refrakter farmakoterapi yanıtı.

İzlem hedefleri

- YGTSS her 3–6 ayda.
- Komorbidite (DEHB, OKB, anksiyete, depresyon) — yıllık.
- Yan etkilerin izlenmesi (antipsikotik alanlarda — metabolik, EPS, prolaktin, QTc).
- Sosyal ve akademik destek.
- Ergenlikte spontan azalma potansiyeli; farmakoterapinin kademeli azaltılma potansiyeli.
- Yetişkin hastalarda meslek ve ilişki desteği.

10. Mit ve yanlış inançlar

10.1 Etiyoloji mitleri

Mit 1: "Tourette sendromu mutlaka koprolali (küfür sözleri) ile birlikte görülür"

Neden yaygınlaştı: kitle medyasında (film, televizyon) Tourette imajının neredeyse her zaman koprolali ile sunulması; sansasyonel medya seçimi.

Klinik ve biyolojik mantık: koprolali — kompleks vokal tik'in nadir bir formudur; çoğu Tourette hastasında ne motor ne de vokal tikler müstehcen bir karakter taşır.

Kanıt: Freeman R.D. et al. Dev Med Child Neurol 2009 — uluslararası Tourette Sendromu Birliği veri tabanı n=597: koprolali erkeklerin %19,3'ünde, kadınların %14,6'sında görülür.

Gerçek klinik adım: Aile ve okula doğru bilgilendirme; hastanın sosyal stigmatasını azaltmak.

Mit 2: "Tourette — kötü terbiye veya ebeveyn hatasının sonucudur"

Kanıt: kalıtım 0,77 (Mataix-Cols JAMA Psychiatry 2015) — psikiyatrik bozukluklar arasında en yüksek. Genetik ve nörobiyolojik temellidir; ebeveyn deneyimi etiyoloji değildir.

Mit 3: “Tourette — duygusal travma veya stres sonucu oluşur”

Klinik mantık: stres tiklerin başlangıcının nedeni değil — tikler genetik ve nörogelişimsel temellidir. Ancak stres mevcut tiklerin şiddetine etki eder.

Mit 4: “Tüm tikler PANDAS'tır ve antibiyotikle tedavi edilmelidir”

Neden yaygınlaştı: 1990'larda Susan Swedo ve meslektaşlarının PANDAS (Pediatric Autoimmune Neuropsychiatric Disorders Associated with Streptococcal infections) hipotezi ve alternatif kliniklerin pazarlaması.

Klinik ve biyolojik mantık: Klasik PANDAS klinik tablosu — hızlı (saat-gün) başlangıçlı OKB/tik + emosyonel labilite + post-streptokok enfeksiyon — nadir bir durumdur. Çoğu tikli hasta tipik seyir (kademeli başlangıç, “waxing and waning”) gösterir.

Kanıt: NIMH 2017 PANDAS/PANS klinik bildirisi: rutin antistreptolizin O testi veya antibiyotik profilaksisi genel tik bozukluklarında önerilmez; yalnızca klasik klinik tablo varsa değerlendirilir. IVIG ve plazmaferezin rutin kullanımı kanıta dayalı değildir (yalnızca klinik araştırma çerçevesinde).

10.2 Zararlı veya yanlış yöntemler

Mit 5: “Tik vurduğunda çocuğu sert azarlamak ya da cezalandırmak tikleri geçirir”

Klinik mantık: tikler kısmen iradi olarak tutulabilir, ancak uzun süreli tutma iç gerilim artışına ve sonrasında “rebound” tik patlamasına yol açar. Ceza tikleri azaltmaz, aksine şiddetle ilişkili stresi artırır.

Kanıt: AAN 2019, ESSTS 2022 — tikler iradi davranış değil; ceza yaklaşımı etkili değil ve zararlıdır.

Mit 6: “Antipsikotik haloperidol tüm tikli hastalarda birinci sıra olmalıdır”

Kanıt: AAN 2019 (Pringsheim) — α2 agonistleri (klonidin, guanfasin) antipsikotiklerden önce önerilir, yan etki profili uygun olduğu için. Haloperidol ve pimozid FDA onaylıdır, ancak EPS, tardiv diskinezi, sedasyon, prolaktin ve QTc uzaması riskleriyle üçüncü sıra statüsü alır.

Mit 7: “Stimülanlar tikleri patlatmaya neden olur — DEHB'li Tourette hastası için stimülan yasaktır”

Kanıt: Bloch M.H. et al. JAACAP 2009 meta-analizi (n=9 RKÇ, n=477) ve TACT (Treatment of ADHD in Children with Tics; Tourette's Syndrome Study Group. Neurology 2002;58(4):527–536) — orta dozda metilfenidat tikleri anlamlı derecede

şiddetlendirmez; bazı hastalarda tik şiddetini azaltır. Komorbid DEHB fonksiyonel bozulmanın ana kısmıdır — stimülanın kontrendike kabul edilmesi yanlıştır.

Gerçek klinik adım: komorbid DEHB'de stimülanla başla, hastayı tik şiddeti için izle; şiddetlenme gözlenirse doz azaltma veya α2-agonist + stimülan kombinasyonu.

10.3 Etkisiz veya bilimsel olarak temelsiz yöntemler

Mit 8: "Kannabis (medical marijuana) Tourette sendromu için etkili bir tedavidir"

Neden yaygınlaştı: Sosyal medyada anekdot raporları, esrar endüstrisinin pazarlaması, bazı pilot çalışmalarda mütevazı etki göstermeleri.

Kanıt: Müller-Vahl K.R. araştırmaları (küçük RKÇ) — THC tikleri kısmen azaltabilir, ancak kanıt temeli klinik öneri için yeterli değildir. AAN 2019 — kannabinoidler standart birinci basamak değildir; risk profili (ergenlerde psikoz riski, bilişsel etki, bağımlılık) önemlidir. Yalnızca refrakter yetişkin vakalarda ve ülkenin mevzuatı izin verdiğinde düşünülebilir.

Mit 9: "Özel diyet (glutensiz, kazeinsiz) veya gıda takviyelerinden vazgeçme Tourette'i geçirir"

Kanıt: Spesifik klinik bulgular yoktur; AAP, AAN tavsiye etmez.

Mit 10: "EEG nörofeedback tikleri azaltır"

Kanıt: kanıt temeli kısıtlıdır; AAN 2019 — birinci basamak değil; CBIT önemli derecede üstün.

Mit 11: "Vitamin mega-dozları, omega-3, magnezyum tikleri geçirir"

Kanıt: bu takviyelerin Tourette için etkisi kanıtlanmamıştır; AAN 2019 ve ESSTS 2022 önermemektedir.

Mit 12: "Akupunktur, homeopati, kraniosakral terapi Tourette'i iyileştirir"

Kanıt: Cochrane ve sistematik derlemeler — bu tamamlayıcı müdahalelerin tik bozuklukları için etkisi kanıtlanmamıştır.

Mit 13: "Hipnoterapi veya psikanalitik terapi tikleri geçirir"

Kanıt: 1960'lara kadar dominanttı, ancak modern kanıt temelinde etki göstermedi; CBIT veya farmakoterapi üstündür.

11. Kaynaklar

1. WHO. ICD-11 for Mortality and Morbidity Statistics. 8A05.0 Primary tics or tic disorders. 2024.
2. American Psychiatric Association. DSM-5-TR. Washington DC: APA Publishing; 2022.
3. Pringsheim T., Okun M.S., Müller-Vahl K. et al. Practice guideline recommendations summary: Treatment of tics in people with Tourette syndrome and chronic tic disorders. Neurology 2019;92(19):896–906.
4. Müller-Vahl K.R., Szejko N., Verdellen C. et al. European clinical guidelines for Tourette syndrome and other tic disorders — version 2.0. Eur Child Adolesc Psychiatry 2022;31(3):403–423.
5. Piacentini J., Woods D.W., Scahill L. et al. Behavior therapy for children with Tourette disorder: a randomized controlled trial. JAMA 2010;303(19):1929–1937.
6. Wilhelm S., Peterson A.L., Piacentini J. et al. Randomized trial of behavior therapy for adults with Tourette syndrome. Arch Gen Psychiatry 2012;69(8):795–803.
7. Leckman J.F., Riddle M.A., Hardin M.T. et al. The Yale Global Tic Severity Scale: initial testing of a clinician-rated scale of tic severity. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry 1989;28(4):566–573.
8. Bloch M.H., Leckman J.F. Clinical course of Tourette syndrome. J Psychosom Res 2009;67(6):497–501.
9. Bloch M.H., Panza K.E., Landeros-Weisenberger A., Leckman J.F. Meta-analysis: treatment of attention-deficit/hyperactivity disorder in children with comorbid tic disorders. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry 2009;48(9):884–893.
10. Freeman R.D. et al. Coprophenomena in Tourette syndrome. Dev Med Child Neurol 2009;51(3):218–227.
11. Knight T., Steeves T., Day L. et al. Prevalence of tic disorders: a systematic review and meta-analysis. Pediatr Neurol 2012;47(2):77–90.
12. Mataix-Cols D., Isomura K., Pérez-Vigil A. et al. Familial risks of Tourette syndrome and chronic tic disorders: a population-based cohort study. JAMA Psychiatry 2015;72(8):787–793.
13. Yu D., Sul J.H., Tsetsos F. et al. Interrogating the genetic determinants of Tourette syndrome and other tic disorders through genome-wide association studies. Am J Psychiatry 2019;176(3):217–227.
14. Roessner V., Schoenefeld K., Buse J. et al. Pharmacological treatment of tic disorders and Tourette syndrome. Neuropharmacology 2013;68:143–149.

15. Roessner V., Plessen K.J., Rothenberger A. et al. European clinical guidelines for Tourette syndrome and other tic disorders. Part II: pharmacological treatment. Eur Child Adolesc Psychiatry 2011;20(4):173–196.
16. Tourette's Syndrome Study Group. Treatment of ADHD in children with tics: a randomized controlled trial. Neurology 2002;58(4):527–536.
17. Pringsheim T., Ganos C., McGuire J.F. et al. Rapid Onset Functional Tic-Like Behaviors in Young Females During the COVID-19 Pandemic. Mov Disord 2021;36(12):2707–2713.
18. Schrock L.E., Mink J.W., Woods D.W. et al. Tourette syndrome deep brain stimulation: a review and updated recommendations. Mov Disord 2015;30(4):448–471.
19. National Institute of Mental Health (NIMH). PANDAS/PANS Information for Clinicians. 2017.
20. Azrin N.H., Nunn R.G. Habit-reversal: a method of eliminating nervous habits and tics. Behav Res Ther 1973;11(4):619–628.

6A20–6A2Z ŞİZOFRENİ SPEKTRUMU

Schizophrenia or other primary psychotic disorders

ICD-11 **6A20**	**6A20 ŞİZOFRENİ** **Schizophrenia**
ICD-10 F20	Şizofreni
DSM-5-TR F20.9	Şizofreni

1. Tanım ve nozoloji

Şizofreni — düşünce, algı, duygulanım ve davranışta önemli ölçüde bozulma ile seyreden, en az bir aylık aktif-faz semptomları ve genellikle kronik gidişle karakterize psikotik bozukluktur. ICD-11 sınıflandırmasında 6A20 koduyla "Şizofreni ve diğer primer psikotik bozukluklar" (6A2x) grubunda yer alır.

Nozolojik açıdan birincil psikotik bozukluk — yani psikotik semptomlar başka bir tıbbi durum, madde etkisi veya afektif bozukluk ile tam olarak açıklanamaz. Şizoaffektif bozukluk (6A21), şizotipal bozukluk (6A22), akut ve geçici psikotik bozukluk (6A23) ve sanrısal bozukluk (6A24) ondan ayrı olarak kodlanır.

2. Tarihçe

Modern şizofreni konsepti dört ana aşamadan geçmiştir:

- Kraepelin (1899) — demans prekoks (erken bunama) — genç yaşta başlayan, sürekli bilişsel gerileme ile karakterize bozukluk olarak.
- Bleuler (1911) — şizofreniler terimi (bölünmüş zihin anlamında, ancak ikili kişilik anlamında değil); 4A semptomları (çağrışım bozukluğu, affekt, ambivalans, otizm) temel alınmıştır.
- Schneider (1959) — "1. derece semptomlar" (ses-düşünce, yorumlayıcı halüsinasyonlar, düşünce çalınması, kontrol hissi) tanısal öncelik olarak kabul edilmiştir; DSM-III ve ICD-10'da bu yaklaşım yansıtılmıştır.
- DSM-5 (2013) ve ICD-11 (2019) — alt tipler (paranoid, hebefrenik, katatonik, basit) iptal edilmiştir (klinik geçerliliği ve faydası kanıtlanmamıştır, seyir sırasında değişkendir); Schneider'in 1. derece

semptomları diğer semptomlarla eşit statüye indirgenmiştir; ICD-11'de ek olarak boyutsal yaklaşım uygulanmıştır — 6A25 Semptom alanları (pozitif, negatif, depresif, manik, psikomotor, bilişsel) ve 6A20.x Gidiş kalifikatörleri.

ICD-10 (F20) ile karşılaştırıldığında temel değişiklikler: alt-tiplerin kaldırılması, Şneider semptomlarının özel statüsünün kaldırılması, 1 aylık süre koşulunun korunması, ancak DSM-5-TR'deki 6 aylık gereklilikten farklı olarak, genel hastalık süresi gerekliliğinin olmaması.

3. Epidemiyoloji

Yaygınlık ve insidans

- Yaşam boyu yaygınlık: %0,3–0,7 (Saha S. et al. PLoS Med 2005, sistematik inceleme, 188 çalışma, 46 ülke).
- Yıllık insidans: 15,2 / 100 000 (McGrath J.J. et al. BMC Med 2004 meta-analiz).
- Coğrafi ve kültürel değişkenlik mevcuttur, ancak çekirdek olay oranı belirli bir aralıkta kalır.

Cinsiyet ve yaş

- Erkek : kadın oranı ~1,4 : 1; erkeklerde başlangıç yaşı 18–25, kadınlarda 25 –35 (Aleman A. et al. Arch Gen Psychiatry 2003).
- Kadınlarda menopozdan sonra ikinci insidans piki gözlenir (östrojenin nöroprotektif etkisinin azalmasıyla ilişkilendirilir).
- Çocukluk döneminde başlangıç nadirdir (tüm olguların <%1'i); 50 yaşından sonra ilk tanı seyrektir.

Komorbidite ve mortalite

- Madde kullanımı bozukluğu — komorbid ~%50 (özellikle tütün, kannabis, alkol).
- Depresyon — komorbid %25–80 seyir sırasında.
- İntihar: Yaşam boyu risk ~%5–10 (Hor K., Taylor M. J Psychopharmacol 2010); en yüksek risk ilk 5 yılda.
- Genel mortalite: popülasyonla karşılaştırıldığında 2–3 kat yüksek; ortalama beklenen yaşam süresi 15–20 yıl kısadır (Olfson M. et al. JAMA Psychiatry 2015) — esas olarak kardiyovasküler hastalıklar, metabolik sendrom, tütün kullanımı.

4. Etiyoloji ve patogenez

4.1 Genetik faktörler

Kalıtım %60–80 (Sullivan P.F. et al. Arch Gen Psychiatry 2003, ikiz meta-analizi). Monozigot ikizlerde konkordans ~%50, dizigotta ~%15, genel popülasyon riski ~%1. Bir ebeveynde şizofreni — çocukta risk ~%10; her iki ebeveynde — ~%40.

Poligenik doğa: GWAS çalışmaları 200'den fazla risk lokusu tespit etmiştir (Trubetskoy V. ve ark. Nature 2022, n>76 000 vaka). Tek bir "şizofreni geni" yoktur — risk yüzlerce küçük etkili varyant ve nadir kopya sayısı değişiklikleri (CNV) — 22q11.2 delesyonu (~25 kat artmış risk), 16p11.2, NRXN1 delesyonları.

4.2 Nörogelişimsel model

Şizofreni — nörogelişimsel bozukluk Şeklinde kabul edilir (Weinberger D.R. Arch Gen Psychiatry 1987; Murray R.M., Lewis S.W. BMJ 1987). Erken beyin gelişimindeki bozulma (intrauterin ve erken postnatal) genç yaşta klinik tezahüre yol açar. Kanıtlar:

- Premorbid kognitif defisitler ve motor gecikmeler — çocukluktan belgelenmiş.
- Sinaptik budanma (puberte döneminde) aşırı olur — kortikal gri madde kütlesinde azalma.
- İlk epizodda zaten beyin yapısal değişiklikleri kaydedilir (aracı değil — belirteçtir).

4.3 Çevresel risk faktörleri

- Obstetrik komplikasyonlar — hipoksi, enfeksiyon, fetüste gelişme geriliği (Cannon M. et al. Am J Psychiatry 2002 meta-analiz, OR ~2).
- Annenin gebelikte virüs enfeksiyonları (grip, herpes) — riski 2–7 kat artırır (Brown A.S. Schizophr Bull 2006).
- Yetişkinlik döneminde kannabis kullanımı — psikoz riskini 2–3 kat artırır, hatta yüksek THC dozunda (Marconi A. et al. Schizophr Bull 2016 meta-analiz).
- Şehir ortamında büyüme, göç, sosyal izolasyon, çocukluk travması — orta derecede risk artışı (van Os J. et al. Nature 2010 derlemesi).
- Baba yaşı 45+ — yeni mutasyon riski ile ilişkili (Malaspina D. Arch Gen Psychiatry 2001).

4.4 Nörobiyolojik mekanizmalar

- Dopamin hipotezi (güncellenmiş): mezolimbik dopamin *hiperaktivitesi* → pozitif semptomlar; mezokortikal *hipoaktivlik* → negatif ve kognitif semptomlar (Howes O.D., Kapur S. Schizophr Bull 2009).
- Glutamat NMDA hipofonksiyonu: Ketamin ve PCP NMDA blokajı ile şizofreni benzeri semptomlar oluşturur; bu, glutamat sistemini ikinci ana mekanizma olarak konumlandırır (Olney J.W., Farber N.B. Arch Gen Psychiatry 1995).
- GABA-erjik internöronlar: parvalbumin-pozitif internöronların disfonksiyonu prefrontal kortekste işleyen bellek bozukluğuna yol açar.
- Yapısal değişiklikler: kortikal gri madde hacminde azalma (özellikle prefrontal ve superior temporal korteks), ventrikül genişlemesi, hipokamp hacminde azalma (Haijma S.V. et al. Schizophr Bull 2013, meta-analiz n>8000).
- Enflamasyon teorisi: CRP, IL-6 yüksekliği ve mikroglia aktivasyonu ilk epizodlarda belgelenmiştir (Khandaker G.M. et al. Lancet Psychiatry 2015).

5. Klinik özellikler

Semptom alanları (ICD-11 / 6A25)

Pozitif semptomlar

Sanrı (kötülük, ilişki, büyüklük, kontrol), halüsinasyonlar (en tipik işitsel — yorumlayıcı veya diyalog), düşünce biçim bozukluğu (dezorganize konuşma, neolojizmler, "sözcük salatası"), belirgin dezorganize davranış.

Negatif semptomlar

Afektif küntlük, avolüsyon (motivasyon kaybı), aloji (konuşmanın yoksullaşması), anhedoni, sosyal geri çekilme. Fonksiyonel bozulmanın temel nedenidir; farmakoterapiye zayıf yanıt verir.

Kognitif semptomlar

İşler bellek, dikkat, yürütücü işlev, semantik bellek bozuklukları. Hastaların %75 –85'inde mevcuttur (Heinrichs R.W., Zakzanis K.K. Neuropsychology 1998 meta-analizi).

Depresif ve manik semptomlar

Afektif epizodlar şizofreni gidişinde yaygındır; afektif epizod psikotik semptomları açıklamıyorsa — şizofreni tanısı kalır.

Psikomotor semptomlar

Katatonik bileşenler (mutizm, negativizm, balmumu esnekliği, stereotipi), ajitasyon, yavaşlama.

Hastalığın evreleri

1. Premorbid faz — çocukluktan başlayan diskret bilişsel ve sosyal defisitler (klinik şizofreni henüz yok).
2. Prodromal faz — aylar-yıllar; sosyal geri çekilme, tuhaf deneyimler, depresif belirtiler, subklinik psikotik semptomlar.
3. Akut (ilk) psikotik epizod — açık pozitif semptomlar; ortalama yaş 18–25 (erkeklerde).
4. Stabilizasyon ve rezidüel fazlar — artık semptomlar, işlevsel kısıtlılık, yineleyici epizodlar.

1/3 kuralı (Hegarty J.D. ve ark. Am J Psychiatry 1994 derlemesi)

- ~1/3 hasta — iyi işlevsel iyileşme.
- ~1/3 — kalıntı semptomlar, kısmi işlevsel iyileşme.
- ~1/3 — ağır kronik seyir, sürekli destek gereksinimi.

6. Tanı

6.1 Birleşik tanı ölçütleri (DSM-5-TR · ICD-11 · NICE CG178 konsensusu)

A. Aktif-faz semptomları — aşağıdakilerden En az 2'si ≥ 1 ay devam etmiş olmalıdır; En az biri (1)-(3)'ten Seçilmelidir:

1. Sanrı
2. Halüsinasyonlar
3. Düşünce biçim bozukluğu / dezorganize konuşma
4. Brüt dezorganize veya katatonik davranış
5. Negatif semptomlar (afektif düzleşme, avolisyon, aloji)

B. Fonksiyonel bozulma — iş, ilişki veya öz bakım alanlarının birinde veya birkaçında belirgin azalma.

C. İstisnalar — psikoaktif madde etkisi ve organik neden (toksikolojik tarama, beyin görüntülemesi, laboratuvar) dışlanmalıdır.

D. Afektif diferansiyasyon — afektif epizod psikotik semptomları tam olarak açıklamaz (şizoaffektif bozukluk veya psikotik özellikli afektif bozukluk dışlanır).

6.2 Kaynaklar arasındaki farklar

- DSM-5-TR (F20.9) ek gereksinimi: Genel hastalık süresi ≥ 6 ay (1 ay aktif + prodrom ve/veya rezidüel). Otizm spektrumu veya konuşma bozukluğu

zemininde — şizofreni yalnızca açık sanrı veya halüsinasyon ek olarak mevcut olduğunda kodlanır.

- ICD-11 (6A20) farkı: ≥ 1 ay aktif semptom yeterlidir, genel 6 aylık şart yoktur. Alt tipler kaldırılmıştır; bunun yerine 6A25 semptom alanları ve 6A20.x gidiş kalifikatörleri (0 ilk epizod akut, 1 ilk epizod kısmen veya tam remisyonda, 2 çoklu epizod, 3 sürekli, Z spesifikleştirilmemiş) kodlanır.
- NICE CG178 uygulama gerekliliği: tanı kliniktir, ancak yapılandırılmış görüşme (SCID-5 veya MINI) ve şiddet ölçeği (PANSS veya BPRS) ile desteklenmelidir; ilk epizodda beyin MRG, EKG, metabolik başlangıç göstergeleri (glukoz, HbA1c, lipid, prolaktin) zorunludur.

6.3 Tanı algoritması

1. Klinik görüşme (hasta + en az bir bilgili yakın).
2. Yapılandırılmış tanısal görüşme (SCID-5 veya MINI).
3. Şiddet değerlendirmesi (PANSS veya BPRS başlangıç değeri).
4. Fizik ve nörolojik muayene.
5. Toksikolojik tarama (idrar) ve madde kullanımı öyküsü.
6. Zorunlu laboratuvar tetkikleri (aşağıda § 7.2).
7. Beyin MRG (ilk epizodda).
8. Ayırıcı tanı (§ 6.4).
9. Komorbidite ve intihar riski değerlendirmesi (C-SSRS).
10. İşlevsel düzey değerlendirmesi (GAF veya PSP).

6.4 Ayırıcı tanı

Bozukluk	Ayırt edici belirtiler
Şizoaffektif bozukluk (6A21)	Afektif epizod psikotik semptomların anlamlı bir kısmında mevcut, ancak psikoz afektif epizod dışı dönemlerde de devam eder.
Şizotipal bozukluk (6A22)	Psikotik-benzer semptomlar; tam psikoz kriterleri yok; sürekli kişilik özellikleri.
Sanrı bozukluğu (6A24)	Yalnızca sanrı, halüsinasyon minimal veya yok; işlev görece korunur.
Akut ve geçici psikotik bozukluk (6A23)	Süre ≤ 3 ay (ICD-11) veya < 1 ay (DSM-5-TR — Brief Psychotic Disorder).

Bozukluk	Ayırt edici belirtiler
Afektif bozukluk psikotik özelliklerle (6A60.x, 6A70.x)	Psikoz yalnızca manik veya depresif epizod bağlamında mevcuttur.
Madde indüksiyonlu psikoz	Madde kullanımı veya kesilmesi ile zaman bağlantısı; madde eliminasyonu sonrası remisyon.
İkincil (organik) psikoz (6E61)	Tıbbi durum (epilepsi, otoimmün ensefalit, beyin tümörü, Wilson hastalığı) ile ilişkili.
Otizm spektrum bozukluğu (6A02)	Erken başlangıç, sosyal-iletişimsel defisit esas; halüsinasyon/sanrı tipik değil.
Kişilik bozuklukları (6D10) — şizotipal ve paranoid özelliklerle	Sürekli kişilik özellikleri, tam psikotik epizodlar yok.

7. Muayene ve değerlendirme

7.1 Klinik görüşme ve ölçekler

- Yapılandırılmış görüşme: SCID-5 (DSM-5 için), MINI (kısa, klinik pratikte ulaşılabilir).
- Şiddet (altın standart): PANSS (30 gösterge, 7-puan ölçek), BPRS (18 gösterge), SANS/SAPS (negatif/pozitif ayrı), CGI-S.
- İşlevsel düzey: GAF (DSM-IV), PSP (Personal and Social Performance Scale).
- İntihar riski: C-SSRS (Columbia Suicide Severity Rating Scale).
- Bilişsel değerlendirme: MATRICS Consensus Cognitive Battery (MCCB) — araştırma ve uzmanlaşmış kliniklerde.

7.2 Laboratuvar incelemeleri

İlk epizodda mutlaka: tam kan sayımı, karaciğer ve böbrek fonksiyonu, açlık glukozu ve HbA1c, lipid profili, TSH ve T4, vitamin B12 ve folat, toksikolojik tarama (kannabis, amfetamin, opioid, kokain, PCP, MDMA), HIV ve sifiliz serolojisi, gebelik testi (kadınlarda), prolaktin başlangıç değeri.

Selektif (klinik şüpheye dayalı): EEG (nöbet veya deliryum dışlama), anti-NMDA-R antikorları (BOS — atipik prezentasyon), seruloplazmin ve 24 saatlik idrar bakırı (Wilson hastalığı şüphesi), B12/folat/homosistein (organik neden şüphesi).

7.3 Enstrümantal incelemeler

- Beyin MRG (T1, T2, FLAIR) — ilk epizodda önerilir (NICE CG178).
- EKG — antipsikotik başlanmadan önce (QTc başlangıç değeri).
- Beyin BT — MRG ulaşılabilir olmadığında.

8. Tedavi

8.1 Genel Prensipler (NICE CG178 · APA 2021 · WFSBP 2015 · Maudsley 14e konsensüsü)

1. Multimodal yaklaşım — farmakoterapi + psikososyal müdahale + sistemik destek. Tek başına farmakoterapi fonksiyonel iyileşme için yeterli değildir.
2. Hastayla birlikte karar (shared decision making) — ilaç, doz ve yan etki profili tartışılır; adezyon bu aşamadan başlar.
3. İlk epizodda atipik antipsikotik üstün — düşük dozda, kademeli titrasyon. İlk epizodda standart dozun alt yarısı yeterli olabilir.
4. Etki değerlendirmesi — 2–4 hafta kısmi yanıt, 4–6 hafta yeterli dozda tam yanıt beklenir. Yanıt yoksa — ilaç değiştirilir.
5. Monoterapi — antipsikotik polifarmasisi yan etki yükünü artırır, etki kanıtı zayıftır; klozapin + ikinci antipsikotik istisna olabilir.
6. Tedaviye dirençli şizofreni (TRS) — iki farklı antipsikotiğe yeterli doz ve sürede (her biri 6–8 hafta) yanıtsızlık — klozapin başlanır.
7. Destekleyici tedavi — ilk epizoddan sonra en az 1–2 yıl, çoklu epizoddan sonra uzun süreli/ömür boyu. Antipsikotiğin kesilmesi nüks riskini belirgin artırır: bir yılda nüks ilaçla %27, plasebo ile %64 (Leucht S. et al. Lancet 2012, 65 çalışma, n=6493; RR 0,40).
8. Psikososyal müdahale — BDTp ve aile müdahalesi tüm hastalara önerilmelidir (NICE CG178 — güçlü öneri).
9. Sistemli izlem — metabolik göstergeler, EPS, prolaktin, EKG.
10. LAI (long-acting injectable) — adezyon sorununda veya hasta seçimi ile; ilk epizoddan sonra nüks profilaksisinde daha iyi sonuç (Tiihonen J. et al. JAMA Psychiatry 2017).

8.2 Farmakoterapi — birinci basamak antipsikotikler

Her preparat için mekanizma, doz, kanıt ve yan etki profili.

Preparat	Reseptor profili	Standart doz	Temel yan etki	Üstünlük
Olanzapin	D2, 5-HT2A, H1, M1	5–20 mg/gün	Kilo alımı, metabolik sendrom, sedasyon	Yüksek etki, ancak metabolik risk yüksek
Risperidon	D2, 5-HT2A	2–6 mg/gün	EPS (doz > 6 mg), hiperprolaktinemi	Yaygın kullanım, ucuz, LAI varyantı mevcut
Aripiprazol	D2 parsiyel agonist, 5-HT1A agonist, 5-HT2A antagonist	10–30 mg/gün	Akatizi, baş dönmesi	Metabolik profil iyi, prolaktin nötr
Ketiapin	D2 (zayıf), 5-HT2A, H1, α1	300–800 mg/gün	Sedasyon, ortostatik hipotansiyon, kilo artışı	Yumuşak EPS profili
Paliperidon	Risperidonun aktif metaboliti	6–12 mg/gün	Hiperprolaktinemi, EPS	LAI (aylık, 3 aylık, 6 aylık) seçenekleri
Lurasidon	D2, 5-HT2A, 5-HT7	40–160 mg/gün (yemekle)	Akatizi, bulantı	Metabolik profil çok iyi; yemekle alım mutlaka
Ziprasidon	D2, 5-HT2A, 5-HT1A	80–160 mg/gün	QTc uzaması	EKG monitorizasyonu gerektirir

Tipik (I. kuşak) antipsikotikler — haloperidol 5–20 mg/gün, klorpromazin 200–800 mg/gün, flupentiksol 6–18 mg/gün, zuklopentiksol 25–150 mg/gün. Pozitif semptomlarda etkilidir, ancak EPS, tardiv diskinezi ve negatif semptomlarda zayıf etki — atipik antipsikotik mevcut olduğunda tercih edilmez.

Mekanizma üzerine not: tüm antipsikotiklerin temel mekanizması mezolimbik D2 reseptör antagonizmidir (atipiklerde ek 5-HT2A antagonizmi — negatif semptomlara

ve EPS azaltılmasına katkı sağlar). %60–80 D2 işgali terapötik aralıktır; >%80'de EPS riski artar; <%60'ta etki yetersizdir (Kapur S., Mamo D. Prog Neuropsychopharmacol Biol Psychiatry 2003).

8.3 Tedaviye dirençli şizofreni ve klozapin

Klozapin — TRS'de kanıta dayalı tek üstün ilaçtır (Kane J. et al. Arch Gen Psychiatry 1988 ilk RKÇ; Siskind D. et al. Br J Psychiatry 2016 meta-analiz). TRS hastalarının %30–60'ı klozapine yanıt verir.

Neden üstündür: D2 işgali düşük (%40–60), ancak çeşitli reseptörlere (D4, 5-HT2A, M1, α1) güçlü etki; daha az EPS, negatif semptomlarda daha iyi etki; intiharı azaltma (FDA endikasyonu).

Başlangıç protokolü: 12,5 mg başlangıç; kademeli olarak 200–450 mg/güne artır (maks 900 mg/gün). Tam kan + lökosit formülü — haftalık ilk 18 hafta, sonra 2 haftada bir 1 yıla kadar, sonra aylık. Nötrofil 1000–1499 /μL — hafif nötropeni, sıkı izlemle devam; < 1000 /μL → tedaviye ara verilir; < 500 /μL → ağır nötropeni. Benign etnik nötropenide eşik < 500 /μL.

Klozapin yan etkileri ve yönetimi:

- Agranülositoz (~%0,8, mortalite %5) — kan formülü takibi.
- Miyokardit — özellikle ilk 4 haftada; troponin, EKG.
- Konstipasyon — ileus ve perforasyon riski; profilaktik laksatif.
- Hipersalivasyon, sedasyon — doza uyum sağlar.
- Nöbetler — > 600 mg/gün dozda risk artar; EEG kontrolü.
- Metabolik sendrom — yüksek; düzenli izlem.

Klozapinin kesilmesi — önemli klinik nokta: aniden kesme rikoşet psikozu (orijinal semptomlardan ağır), kolinerjik rikoşet (bulantı, kusma, ishal) ve adrenerjik rikoşet (ajitasyon, uykusuzluk) yaratır. Agranülositozda kesilmesi gerekiyorsa — hasta hastanede paralel diğer antipsikotiğe (olanzapin veya ketiapin) kademeli olarak geçirilir. Planlı kesmede — haftada %25 azalma.

8.4 LAI (uzun etkili enjektabl) varyantları

LAI	Aralık	Standart doz
Risperidon LAI (Consta)	2 haftada bir	25–50 mg
Paliperidon palmitat	Aylık / 3 aylık / 6 aylık	75–150 mg aylık

LAI	Aralık	Standart doz
Aripiprazol LAI (Maintena)	Aylık	400 mg
Olanzapin pamoat	2–4 haftada bir	150–300 mg
Haloperidol dekanoat	4 haftada bir	50–200 mg
Flupentiksol dekanoat	2–4 haftada bir	20–40 mg
Zuklopentiksol dekanoat	2–4 haftada bir	200–400 mg

8.5 Akut psikomotor ajitasyonun yönetimi

- Oral (üstün) lorazepam 1–2 mg + olanzapin 5–10 mg oral dağılabilir tablet, veya risperidon 1–2 mg oral çözelti.
- Kas içi: olanzapin im 10 mg, veya aripiprazol im 9,75 mg, veya haloperidol 5 mg + lorazepam 2 mg im (klasik).
- Dikkat: olanzapin im + benzodiazepin parenteral — solunum depresyonu riski; eş zamanlı kullanılmamalıdır.

8.6 Yan etkilerin yönetimi

Ekstrapiramidal semptomlar (EPS):

Belirti	Klinik görünüm	Müdahale
Akut distoni	Boyun, dil, göz kasları spazmı (ilk saatlar–günler)	Biperiden 2–5 mg im (acil)
Parkinsonizm	Tremor, rigidlik, bradikinezi	Doz azaltma; biperiden 2–4 mg/gün
Akatizi	İçsel huzursuzluk, yerinde duramama	Propranolol 30–80 mg/gün; doz azaltma
Tardiv diskinezi	Geç başlayan diskinetik hareketler (aylar–yıllar)	Valbenazin / dötetrabenazin; klozapine geçiş

Metabolik yan etki: Kilo, bel çevresi, kan basıncı — ilk 6 ay aylık, sonra 6 aylık; açlık glukozu, HbA1c, lipid — başlangıç, 12. hafta, sonra yılda bir. Müdahale: diyet ve fiziksel aktivite danışmanlığı, metformin (fazla kiloda), antipsikotiğin metabolik nötr bir ilaca değiştirilmesi (aripiprazol, lurasidon).

Hiperprolaktinemi: yüksek risk — risperidon, paliperidon, amisülpirid, tipikler; düşük risk — aripiprazol, ketiapin, klozapin. Semptomatik durumlarda (galaktore, amenore, cinsel işlev bozukluğu, osteoporoz) — ilaç değiştir.

Antipsikotik Malign Sendrom (NMS) — acil tıbbi durum (mortalite %10'a kadar) klinik tetrad — hipertermi, kas rijiditesi, bilinç değişikliği, otonomik instabilite. Laboratuvar: CPK > 1000, lökositoz, miyoglobinüri. Müdahale: antipsikotiğin hemen kesilmesi, yoğun bakım desteği, dantrolen, bromokriptin, gerekirse EKT.

8.7 Özel durumlar

- Gebelik: antipsikotiğin tamamen kesilmesi nüks riskini artırır. Sınıf olarak antipsikotikler doğumsal anomali riskini anlamlı artırmaz (Huybrechts K.F. et al. JAMA Psychiatry 2016, 1,3 mln gebelik); olası istisna risperidondur (yaklaşık %26 daha yüksek risk, doğrulama gerektirir). Seçim bireyseldir: işe yarayan ilaç genellikle sürdürülür.
- Yaşlılar: EPS, ortostatik hipotansiyon, antikolinerjik etkiye duyarlılık; düşük doz, ketiapin veya risperidon tercih edilir; Beers Kriterleri'ne göz atın.
- Komorbid madde kullanımı: tütün bırakma desteği, kannabisin kesilmesi, alkol bağımlılığı paralel tedavi (naltrekson, akamprosat).

8.8 Kaynağa-özgü belirleyiciler

- NICE CG178: Erken Müdahale Hizmetleri (EIP) — ilk 3 yıl yoğun multidisipliner destek; klozapin iki antipsikotikten sonra dirençte birinci sıra.
- APA 2021: destekleyici tedavi süresi ilk epizoddan sonra 2–5 yıl; bilişsel remediasyon ve destekli istihdam işlevsel iyileşmede açıkça önerilir.
- WFSBP 2015: eşdeğer doz aralıkları ve yeterli süre (4–6 hafta) ilaç değişimine kadar; LAI nüks profilaksisinde etkililik.
- Maudsley 14e (2021): klozapin titrasyonu, yan etki yönetimi ve polifarmasi nedenleri üzerine ayrıntılı protokol.
- AR Sağlık Bakanlığı Klinik Protokol (2009): atipik antipsikotik birinci sıra; geleneksel nöroleptik — atipik ulaşılabilir olmadığında. Genel algoritma NICE/APA ile örtüşür.

8.9 Tedavi metodolojileri

1. Psikoz için Bilişsel-Davranışçı Terapi (BDTp / CBTp — Cognitive Behavioural Therapy for psychosis) — Psikotik semptomları "düşünce–duygu–davranış" formülasyonu içinde yeniden değerlendirme; hasta halüsinasyonları ve sanrıları gerçeklik testleri, davranış deneyleri ve alternatif açıklama arayışı ile ele alır. Standart kurs — 16+ bireysel seans, 6–

12 ay. Etki: pozitif semptomlarda küçük-orta etki (NICE'da Grade A), işlevsel düzeyde iyileşme (Wykes T. et al. Schizophr Bull 2008, n=2284 meta-analiz; NICE CG178 § 1.3.7.1).

2. Aile Müdahalesi (Family Intervention) — Yüksek duygusal dışavurum (EE) olan ailelerde psikoeğitim, iletişim eğitimi ve problem çözme. Hasta + en az bir aile üyesi, 10+ seans, 3–12 ay. Etki: nüks riskini ~%20 azaltır, hastane yatışını azaltır (Pharoah F. et al. Cochrane Database Syst Rev 2010; (12):CD000088, n>3500). NICE CG178 § 1.3.7.2.
3. Kognitif Remediasyon (Cognitive Remediation) — Bilgisayar veya eğitmen tabanlı yapılandırılmış bilişsel egzersizler — dikkat, işler bellek, yürütücü işlev, sosyal biliş. 20–40 seans, haftada 2–3 kez. Etki: bilişsel göstergelerde küçük-orta artış, işlevsel düzeye yalnızca psikososyal rehabilitasyonla birlikte uygulandığında geçer (Wykes T., Huddy V., Cellard C., McGurk S.R., Czobor P. Am J Psychiatry 2011;168(5):472–485, meta-analiz n=2104).
4. Destekli İstihdam (Supported Employment) / Bireysel Yerleştirme ve Destek (İPS / IPS — Individual Placement and Support) — Gerçek iş yerlerinde doğrudan destekli işe dahil olma — "place-then-train" prensibi (önceden hazırlık aşaması olmadan iş aramaya başlama). Kişisel görev koordinatörü, bireysel ilgi ve yetenek temelinde iş bulma, iş yerinde destek. Etki: yarısından fazlası rekabetçi işe girer (kontrol gruplarında %20) — Drake R.E., Bond G.R., Goldman H.H. et al. Health Aff (Millwood) 2016;35(6):1098–1105. NICE CG178 § 1.3.7.3.
5. Psikozda Erken Müdahale (EIP — Early Intervention in Psychosis) — İlk psikotik epizoddan sonra 3 yıl boyunca yoğun multidisipliner bakım — düşük doz farmakoterapi, BDTp, aile müdahalesi, istihdam desteği, akran desteği. RAISE ve EDEN RKÇ'leri (Kane J.M. et al. Am J Psychiatry 2016; Marshall M. et al. Lancet 2011) — EIP standart bakımdan üstün, nüksü azaltır, işlevsel düzeyi iyileştirir. NICE CG178 § 1.4.
6. Assertif Toplum Tedavisi (ACT — Assertive Community Treatment) — Multidisipliner ekip (psikiyatrist, klinik psikolog, sosyal hizmet uzmanı, peer specialist) hastaya toplumda (evde, iş yerinde) yoğun destek sağlar; 7/24 ulaşılabilirlik, düşük hasta/çalışan oranı (~10:1). Hedef: tekrar hastane yatışı ve evsizlik riski yüksek olan hastalar. Etki: hastane günlerini azaltır, yerleşim stabilitesini artırır (Marshall M., Lockwood A. Cochrane 2011).
7. PANSS / BPRS — Şiddet ölçekleri — PANSS (Positive and Negative Syndrome Scale) — 30 gösterge, 7-puan ölçeği; BPRS (Brief Psychiatric Rating Scale) — 18 gösterge. Yapılandırılmış görüşmeye dayalı psikotik semptomların nicel değerlendirmesi. Klinik pratikte başlangıç değerlendirme ve tedavi takibi için. Kay S.R., Fiszbein A., Opler L.A. Schizophr Bull

1987;13(2):261–276 (PANSS); Overall J.E., Gorham D.R. Psychol Rep 1962;10:799–812 (BPRS).

9. Prognoz

İyi prognoz faktörleri

- Kısa tedavisiz dönem (DUP < 6 ay)
- Akut başlangıç, belirgin stres faktörü
- Premorbid iyi fonksiyon
- Pozitif semptomların baskınlığı (negatif az)
- Afektif komponentin varlığı
- İyi sosyal destek, aile işbirliği
- Erken müdahale ve adezyon

Kötü prognoz etkenleri

- Kademeli başlangıç, uzun prodrom
- Erken başlangıç yaşı (çocukluk veya erken ergenlik)
- Premorbid fonksiyonel zayıflık (çocukluktan)
- Negatif semptomların baskınlığı
- Bilişsel defisitin şiddeti
- Madde kullanımı (özellikle kannabis, amfetamin)
- Adherensizlik, sosyal izolasyon
- DUP > 1 yıl

İzlem hedefleri

- Klinik stabilite ve nüks profilaksisi (antipsikotik adezyonu, LAI değerlendirilmesi).
- Metabolik ve kardiyovasküler risk yönetimi (mortaliteye ana katkıda bulunan faktördür).
- İşlevsel iyileşme — istihdam, bağımsız yaşam, sosyal ilişkiler.
- Komorbid madde kullanımı, depresyon, intihar riski izlemi.
- Aile ve toplum destek sisteminin güçlendirilmesi.

10. Mit ve yanlış inançlar

10.1 Etiyoloji mitleri

Mit 1: "Şizofreni — ruhların ele geçirmesi veya cin çarpmasıdır"

Neden yaygınlaştı: Tarihsel-dini bağlam — Avrupa Orta Çağı'nda psikoz "şeytan çarpması" olarak açıklanırdı; halüsinasyonların öznel olağanüstü doğası; psikiyatrik hizmete erişimin düşük olduğu topluluklarda aile öncelikle dini lidere başvurur.

Klinik ve biyolojik mantık: Şizofreni ölçülebilir nörobiyolojik belirtilere sahiptir — kortikal gri madde hacminde azalma (Haijma S.V. Schizophr Bull 2013, meta-analiz n>8000), mezolimbik dopamin hiperaktivitesi (Howes O.D. Schizophr Bull 2009), %60–80 kalıtım (Sullivan P.F. 2003). D2 reseptör antagonist antipsikotiklerin etkisinin doza orantılı olması farmakolojik mekanizmanın özgüllüğünü kanıtlar. "Ele geçirilme" konsepti bu düzeylerde test edilemez ve yanlışlanabilir değildir.

Kanıt: WHO mhGAP Intervention Guide v2.0 — şizofreni tıbbi hastalık olarak tanınır. APA Resource Document on Religious/Spiritual Commitments (2018): dini pratik tedaviyi *tamamlayabilir*, ancak *yerine geçemez*.

Gerçek klinik adım: antipsikotiğin başlanması geciktirilmemelidir. Ailenin dini-kültürel inançlarına saygı terapötik ittifakı korur — ekzorsizm ritüellerinin antipsikotik tedaviyi ikame etmesine izin verilmesi gecikmiş başlangıçla kötü prognoza yol açar (Marshall M. et al. Arch Gen Psychiatry 2005 — DUP > 1 yıl kötü prognoz belirtecidir).

Mit 2: "Şizofreni — kötü terbiye veya 'soğuk anne' sonucudur"

Neden yaygınlaştı: 1940–60'lı yıllarda psikanalitik ekolün etkisi (Fromm-Reichmann F. — "şizofrenogen anne" konsepti); aileyi suçlayan model klinik pratikte uzun süre dominant kalmıştır.

Klinik ve biyolojik mantık: Kalıtım %60–80 — biyolojik ailede büyümeyen evlat edinilmiş çocuklarda risk biyolojik ebeveynlerin tanısıyla ilişkilidir, evlat edinen ailenin özellikleriyle değil (Heston L.L. Br J Psychiatry 1966; Tienari P. et al. Br J Psychiatry 2004 — Finlandiya adoptif çalışması). Yüksek emosyonel ekspresyon (EE) olan ailede nüks riski artar, ancak bu — birincil etiyoloji değil, gidiş modülatörüdür.

Kanıt: APA, AAP, NICE — "şizofrenojen anne" konsepti bilimsel topluluk tarafından terk edilmiştir.

Gerçek klinik adım: Aile müdahalesi (bkz. "Tedavi metodolojileri") — suçlama temelli değil, psikoeğitim ve iletişim eğitimi temelinde kurulur.

Mit 3: "Şizofreni = ikili (bölünmüş) kişilik"

Neden yaygınlaştı: Etimoloji yanılgısı — "şizo" (bölünmüş) + "frenia" (akıl) sözcüğünün "kişilik bölünmesi" olarak yanlış çevirisi; kitle kültürü (film, edebiyat) yanlış imgeleri güçlendirir.

Klinik ve biyolojik mantık: "Bleuler 1911" terimi, zihnin iç tutarlılığının bozulmasını (çağrışımların bölünmesi) ifade ediyordu, ayrı kişiliklerin varlığını değil. "İkili kişilik" — farklı bir bozukluktur: disosiyatif kimlik bozukluğu (6B64), tamamen farklı etiyoloji (çocukluk travması) ve klinik belirtiler.

Kanıt: WHO ICD-11 — şizofreni (6A20) ve DKB (6B64) ayrı bozukluklar olarak kodlanır.

Mit 4: "Şizofrenili insanlar tehlikelidir ve agresiftir"

Neden yaygınlaştı: Kitle medyası şiddet olaylarında psikoz geçmişini özellikle vurgular — notlar dikkat çeker, ancak taban oranı sunulmaz.

Klinik ve biyolojik mantık: Şizofrenili insanlar şiddetin mağduru olma olasılığı daha yüksektir (Maniglio R. Acta Psychiatr Scand 2009 sistematik derleme — suç türüne göre mağduriyet oranı 2,3–140 kat arasında). Şiddet riski yalnızca spesifik dar bağlamda artar: tedavi almayan akut paranoid sanrı + paralel madde kullanımı (Fazel S. et al. PLoS Med 2009 meta-analiz). Tedavi alan stabil hastalarda popülasyonla karşılaştırıldığında fark minimaldir.

Kanıt: Şizofreniye atfedilen tüm şiddet olayları toplumdaki tüm şiddetin %5'inden azını oluşturur (Fazel S. Br J Psychiatry 2014).

Gerçek klinik adım: damgalanma psikososyal rehabilitasyona engeldir; aile ve toplum için psikoeğitim kritik önem taşır.

10.2 Zararlı "tedavi" yöntemleri

Mit 5: "Ekzorsizm veya dini ritüel antipsikotiğin yerini alabilir"

Neden yaygınlaştı: Antipsikotiklerin yan etkilerinden korku; dini topluluklar içinde sosyal desteğin daha erişilebilir olması; psikiyatrik hizmetin damgası

Risk: Birincil tedavisiz dönemin (Duration of Untreated Psychosis, DUP) her ay uzamasıyla hastanın uzun vadeli işlevsel prognozu kötüleşir (Marshall M. et al. Arch Gen Psychiatry 2005, n=3700 meta-analiz). DUP > 1 yıl olan hastalarda remisyon oranı anlamlı şekilde azalır. Tedavisiz akut epizodda intihar riski yüksektir.

Kanıt: NICE CG178, WHO mhGAP — antipsikotik tedavi ertelenmemeli; dini-kültürel destek paralel uygulanabilir.

Mit 6: “İnsülin koma terapisi” ve “lobotomi” — eski tedaviler hala hastanelerde gizlice uygulanmaktadır

Gerçeklik: İnsülin koma tedavisi (Sakel 1933) ve prefrontal lobotomi (Moniz 1936, Freeman 1945) 1950'lerde yaygın olarak uygulanıyordu, ancak antipsikotiklerin (klorpromazin 1952) gelişiyle karşılaştırmalı etki kanıtı olmaması ve ağır yan etkileri nedeniyle terk edilmiştir. Modern klinik pratikte bu yöntemler yoktur. EKT (elektrokonvülsif terapi) ise farklıdır — kanıtlı, modern endikasyonlarda şizofreni katatonik özelliklerle veya refrakter vakalarda yer alır (NICE TA59).

10.3 Etkisiz veya temel tedaviyi geciktiren yöntemler

Mit 7: “Vitamin B3 (niasin) mega-dozları şizofreniyi iyileştirir” (ortomoleküler psikiyatri)

Neden yaygınlaştı: Hoffer ve Osmond 1950'lerde tek rapor çalışmalarına dayanarak niasin mega-doz teorisini öne sürmüşlerdir; alternatif tıp akımı bu yaklaşımı desteklemeye devam etmektedir.

Kanıt: APA Task Force (Lipton M.A. ve ark. 1973) ve sonraki RKÇ'ler — vitamin B3 veya diğer vitamin mega-dozları şizofreni semptomlarına etki etmez. Niasin mega-dozu karaciğer hasarı ve hiperürisemi oluşturabilir.

Mit 8: “Kannabis (özellikle CBD) şizofreniyi iyileştirir”

Neden yaygınlaştı: CBD'nin antipsikotik etkisi hakkında ön çalışmaların kitle medyasında abartılı sunumu; tıbbi kenevir endüstrisinin pazarlaması.

Gerçeklik: THC (kannabisin ana psikoaktif bileşeni) psikoz riskini 2–3 kat artırır (Marconi A. ve ark. Schizophr Bull 2016 meta-analizi). CBD hakkındaki ilk RKÇ'ler (McGuire P. ve ark. Am J Psychiatry 2018) mütevazı etki göstermiştir, ancak kanıt temeli standart antipsikotiklerin yerini almak için yeterli değildir.

Kanıt: NICE CG178, APA 2021 — CBD şizofreni tedavisinde standart öneri değil; THC içeren kenevir kontrendikedir.

Mit 9: “Antipsikotikler beyni tahrip eder, ‘zombi’ yapar, ömür boyu kullanım zararlıdır”

Neden yaygınlaştı: Erken tipik antipsikotiklerin ağır EPS yan etkileri; hasta deneyimleri sosyal medyada paylaşılır.

Biyolojik mantık: Antipsikotik kullanımıyla ilişkili yapısal değişiklikler mevcuttur (Ho B.C. et al. Arch Gen Psychiatry 2011), ancak karşılaştırılmalıdır ki, tedavisiz şizofreninin kendisi daha hızlı kortikal hacim azalmasına neden olur (Cahn

W. et al. Arch Gen Psychiatry 2002). Antipsikotik kesme nüks riskini belirgin artırır — bir yılda %27 yerine %64 (Leucht S. Lancet 2012), nüksün kendisi nörotoksik etki gösterir.

Kanıt: Tiihonen J. et al. (Lancet 2009, JAMA Psychiatry 2018) Fin rejistr çalışmaları n>60 000: sürekli antipsikotik kullanımı mortalite ve hastane yatışını azaltır.

Gerçek klinik adım: yan etki profiline göre ilaç seçimi, doz titrasyonu ve hasta şikayetlerine yanıt — antipsikotik diyalog içinde yönetilir.

Mit 10: "Şizofreni tedavi edilmez, ömür boyu hastadır, iyileşme mümkün değildir"

Gerçeklik: Hegarty 1/3 prensibi (Am J Psychiatry 1994) — hastaların yaklaşık 1/3'ü iyi fonksiyonel iyileşme gösterir; özellikle Erken Müdahale Hizmetleri (EIP) ile bu oran artar (Kane J.M. et al. Am J Psychiatry 2016 — RAISE RKÇ). "Klinik iyileşme" ve "kişisel iyileşme" (Recovery model) ayırt edilir — hasta semptomu tamamen kaybetmese de anlamlı bir hayat kurabilir.

Gerçek klinik adım: prognoz bireyseldir; erken müdahale, adezyon, aile desteği ve psikososyal rehabilitasyon iyileşme şanslarını önemli ölçüde artırır.

Mit 11: "Antipsikotik yerine akupunktur, homeopati, kediotu etkilidir"

Kanıt: Cochrane derlemeleri (Rathbone J. Cochrane 2007 — akupunktur; Ernst E. derlemeleri — homeopati) — şizofrenide etki kanıtı yoktur. Tamamlayıcı yöntemler adjuvan olarak (stres yönetimi, uyku hijyeni) uygulanabilir, ancak antipsikotiğin yerini almaz.

11. Kaynaklar

1. WHO. ICD-11 for Mortality and Morbidity Statistics (Version 2024). 6A20 Schizophrenia. icd.who.int
2. American Psychiatric Association. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fifth Edition, Text Revision (DSM-5-TR). Washington, DC: American Psychiatric Association Publishing; 2022.
3. NICE Clinical Guideline 178. Psychosis and schizophrenia in adults: prevention and management. 2014, 2019 update. nice.org.uk/guidance/cg178
4. American Psychiatric Association. Practice Guideline for the Treatment of Patients with Schizophrenia, 3rd ed. 2021.

5. Hasan A., Falkai P., Wobrock T. et al. WFSBP Guidelines for Biological Treatment of Schizophrenia. World J Biol Psychiatry 2012;13(5):318–378; 2015 update.
6. Taylor D.M., Barnes T.R.E., Young A.H. The Maudsley Prescribing Guidelines in Psychiatry, 14th ed. Wiley-Blackwell; 2021.
7. Sullivan P.F., Kendler K.S., Neale M.C. Schizophrenia as a complex trait. Arch Gen Psychiatry 2003;60(12):1187–1192.
8. Trubetskoy V., Pardiñas A.F., Qi T. et al. Mapping genomic loci implicates genes and synaptic biology in schizophrenia. Nature 2022;604(7906):502–508.
9. Howes O.D., Kapur S. The dopamine hypothesis of schizophrenia: version III. Schizophr Bull 2009;35(3):549–562.
10. Haijma S.V., Van Haren N., Cahn W. et al. Brain volumes in schizophrenia: a meta-analysis. Schizophr Bull 2013;39(5):1129–1138.
11. Saha S., Chant D., Welham J., McGrath J. A systematic review of the prevalence of schizophrenia. PLoS Med 2005;2(5):e141.
12. Marconi A., Di Forti M., Lewis C.M. et al. Cannabis use and risk of psychosis. Schizophr Bull 2016;42(5):1262–1269.
13. Hor K., Taylor M. Suicide and schizophrenia. J Psychopharmacol 2010;24(11 Suppl 4):81–90.
14. Leucht S., Tardy M., Komossa K. et al. Antipsychotic drugs versus placebo for relapse prevention in schizophrenia. Lancet 2012;379(9831):2063–2071.
15. Kane J., Honigfeld G., Singer J., Meltzer H. Clozapine for the treatment-resistant schizophrenic. Arch Gen Psychiatry 1988;45(9):789–796.
16. Siskind D., McCartney L., Goldschlager R., Kisely S. Clozapine v. first- and second-generation antipsychotics in treatment-refractory schizophrenia. Br J Psychiatry 2016;209(5):385–392.
17. Wykes T., Steel C., Everitt B., Tarrier N. Cognitive behavior therapy for schizophrenia: effect sizes, clinical models, and methodological rigor. Schizophr Bull 2008;34(3):523–537.
18. Pharoah F., Mari J., Rathbone J., Wong W. Family intervention for schizophrenia. Cochrane Database Syst Rev 2010;(12):CD000088.
19. Drake R.E., Bond G.R., Goldman H.H. et al. Individual placement and support services boost employment for people with serious mental illnesses. Health Aff (Millwood) 2016;35(6):1098–1105.
20. Kane J.M., Robinson D.G., Schooler N.R. et al. Comprehensive versus usual community care for first-episode psychosis (RAISE). Am J Psychiatry 2016;173(4):362–372.

21. Tiihonen J., Mittendorfer-Rutz E., Majak M. et al. Real-world effectiveness of antipsychotic treatments in a nationwide cohort of 29 823 patients with schizophrenia. JAMA Psychiatry 2017;74(7):686–693.
22. Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi. Şizofreniyanın diaqnostika və müalicəsi üzrə Klinik Protokol. Bakı; 2009.
23. Fromm-Reichmann F. Notes on the development of treatment of schizophrenics by psychoanalytic psychotherapy. Psychiatry 1948;11(3):263–273.
24. Ernst E. A systematic review of systematic reviews of homeopathy. Br J Clin Pharmacol 2002;54(6):577–582.
25. Huybrechts K.F., Hernández-Díaz S., Patorno E. et al. Antipsychotic use in pregnancy and the risk for congenital malformations. JAMA Psychiatry 2016;73(9):938–946.
26. Aleman A., Kahn R.S., Selten J.P. Sex differences in the risk of schizophrenia: evidence from meta-analysis. Arch Gen Psychiatry 2003;60(6):565–571.
27. Olfson M., Gerhard T., Huang C. et al. Premature mortality among adults with schizophrenia in the United States. JAMA Psychiatry 2015;72(12):1172–1181.

ICD-11 **6A21**	**6A21 ŞİZOAFEKTİF BOZUKLUK** **Schizoaffective disorder**
ICD-10 F25	Şizoafektif bozukluklar
DSM-5-TR F25.0–F25.1	Şizoduygulanımsal (Şizoaffektif) Bozukluk

1. Tanım ve nozoloji

Şizoafektif bozukluk (ICD-11: 6A21 Schizoaffective Disorder; DSM-5-TR: F25.0–F25.1) — psikotik semptomlar (sanrı, halüsinasyon, dezorganize konuşma) ve afektif epizod (manik veya depresif) aynı klinik epizod sırasında birlikte gözlenen, ancak ek olarak Afektif epizod dışı dönemlerde de psikotik semptomların devam ettiği birincil psikotik bozukluktur.

Bozukluk, psikotik bozukluklar spektrumunda Şizofreni ve afektif bozukluk arasında orta durum tutar — bir yandan “psikotik özelliklerle duygudurum

bozukluğundan", diğer yandan "şizofreniden" ayrılır (psikotik semptomların duygudurum epizodu bağlamından bağımsız olarak devam etmesi).

DSM-5-TR'de iki tip niteleyicisi: bipolar tip (manik ve/veya depresif epizodlar) ve depresif tip (yalnızca depresif epizodlar). ICD-11'de alt-spesifikasyonlar paralel — afektif epizod tipine göre.

2. Tarihçe

- Kasanin J. (1933) — akut şizoaffektif psikozlar terimini ilk kez tanıtmıştır; hızlı başlangıç ve iyi prognoz vurgulanmıştır.
- 1970'ler — Carpenter W., Strauss J., Bartko J. — şizofreni ve afektif bozukluktan ayrı klinik birim olarak araştırma.
- DSM-III (1980) — şizoaffektif bozukluk "karışık" kategori olarak.
- DSM-IV (1994), DSM-5 (2013) — tanı kriterleri netleştirilmiştir; bipolar/depresif tip ayrımı korunur.
- ICD-11 (2019) — afektif epizod tipi alt-spesifikasyonları.
- Tanısal geçerlilik tartışması — Malhi G.S. ve ark. Aust N Z J Psychiatry 2008, Lake C.R., Hurwitz N. Curr Psychiatry Rep 2007: şizoaffektif bozukluğun şizofreni ve afektif bozukluktan ayrı bir birim olup olmadığı tartışmalıdır; bazı araştırmacılar onu spektral konsept içinde görür.

3. Epidemiyoloji

- Yaşam boyu yaygınlık: ~%0,3 (Perälä J. ve ark. Arch Gen Psychiatry 2007 Finlandiya popülasyon çalışması, n=8000).
- Şizofreniden (%0,3–0,7) belirgin şekilde daha az yaygın.
- Cins: kadınlarda nispeten daha sık (1:1,2–1,5); depresif tip kadınlarda dominant.
- Başlangıç yaşı: orta 20–30 yaş; bipolar tip daha genç yaşta, depresif tip daha geç.
- Komorbidite: madde kullanım bozukluğu ~%40, anksiyete bozuklukları ~%30, intihar riski şizofreni ile karşılaştırılabilir (~%5).
- Mortalite: Genel mortalite popülasyona kıyasla 2–3 kat daha yüksek.

4. Etiyoloji ve patogenez

4.1 Genetik faktörler

- Genetik örtüşme şizofreni ve bipolar bozukluk ile yüksek: GWAS çalışmaları (Cross-Disorder Group of Psychiatric Genomics Consortium. Lancet 2013, Cell 2019) — şizofreni, bipolar ve şizoaffektif bozukluk arasında geniş genetik korelasyon.
- Aile çalışmaları — şizoaffektif hastaların akrabalarında hem şizofreni hem de duygudurum bozuklukları riski artmıştır (Maier W. et al. Arch Gen Psychiatry 1993).

4.2 Nörobiyoloji

- Şizofreni ile örtüşen modeller — dopamin disregülasyonu, kortikal hacim değişiklikleri, glutamat NMDA disfonksiyonu.
- Afektif komponentle ilişkili — limbik ve monoaminerjik (serotonin, noradrenalin) sistem disfonksiyonu.
- Şizofreniye kıyasla daha az ciddi yapısal değişiklikler ve daha iyi bilişsel profil gözlenir (Heckers S. Curr Psychiatry Rep 2009 derleme).

4.3 Çevresel risk faktörleri

- Şizofreni ile örtüşür — obstetrik komplikasyonlar, prenatal enfeksiyonlar, ergenlikte kannabis kullanımı, göç, kentsel çevre.
- Erken travma ve psikososyal stres afektif bileşenin tetikleyicisi olarak rol oynayabilir.

5. Klinik özellikler

5.1 Temel modeller

- Manik epizod fonunda psikoz — büyüklük hezeyanları, ego-sintonik halüsinasyonlar, hızlı düşünce akışı, yüksek sesli konuşma ve davranış.
- Depresif epizod fonunda psikoz — suçlama sanrıları, nihilistik sanrılar, işitsel halüsinasyonlar (yargılayan sesler), düşük motivasyon.
- Afektif epizod dışındaki dönemlerde — pozitif (sanrı, halüsinasyon) ve/veya negatif (duygulanımda küntleşme, avolisyon) semptomlar devam eder — bu kriter bozukluğu “psikotik özelliklerle duygudurum bozukluğundan” ayırır.

5.2 Gidiş ve evreler

- Gidiş tipik olarak epizodik — afektif epizodlar ve psikotik bileşenler çeşitli yoğunlukta.
- Şizofreniden daha iyi fonksiyonel iyileşme, ancak önemli sosyal ve mesleki bozulma mevcuttur.
- Bipolar tipte manik ve depresif dönemler; depresif tipte sürekli depresif bileşenler.

6. Tanı

6.1 Birleşik tanı ölçütleri (DSM-5-TR · ICD-11 konsensus noktaları)

A. Aynı hastalık dönemi içinde, şizofreni A kriterine uyan aktif-faz semptomları (≥1 ay) ile birlikte temel afektif epizod (manik veya depresif) gözlenmelidir.

B. Sanrı veya halüsinasyonlar ≥ 2 hafta Sırasında Temel duygudurum epizodu olmadan mevcut olmuştur (hastalığın ömür boyu seyrinde).

C. Temel duygudurum epizoduna uygun belirtiler hastalığın genel gidişinin önemli bir kısmında mevcut olmalıdır (aktif ve rezidüel fazlarla birlikte).

D. Dışlamalar — psikoz madde (örn. amfetamin) veya tıbbi durum (örn. ensefalit) ile tam olarak açıklanmaz.

6.2 Kaynaklar arasındaki farklar

- DSM-5-TR (F25.0–F25.1): ölçüt B'de 2 haftalık somut bir süre belirtilir (DSM-IV'te somut sayı yoktu). Tip kalifikatörleri — bipolar (manik epizodlar var) veya depresif (yalnızca depresif).
- ICD-11 (6A21): "şizoaffektif bozukluk" — afektif epizod tipine göre alt spesifikasyonlar; belirli 2 haftalık gereklilik ICD-11'de belirli bir rakamla değil, "önemli süre" olarak belirtilir.
- APA Practice Guideline (Schizophrenia 2021): Şizoaffektif bozukluk için ayrı bir algoritma yoktur; şizofreni ve duygudurum bozuklukları için tedavi prensipleri birleştirilir.
- WFSBP: Şizoaffektif bozukluğu şizofreni spektrum bozuklukları içinde değerlendirir.

6.3 Tanı algoritması

1. Klinik görüşme + akrabalardan bilgi — afektif epizodların ve psikotik semptomların kronolojik düzeni.
2. Yapılandırılmış görüşme (SCID-5 veya MINI).

3. PANSS veya BPRS — psikotik semptomların şiddeti; HAM-D, MADRS — depresif; YMRS — manik.
4. Fizik ve nörolojik muayene.
5. Toksikoloji tarama (idrar).
6. Laboratuvar (tam kan, tiroid, karaciğer, böbrek, glukoz, HbA1c, lipid, prolaktin).
7. Beyin MRG (ilk epizod) — organik neden dışlaması.
8. Komorbidite ve intihar riski değerlendirmesi (C-SSRS).

6.4 Ayırıcı tanı

Bozukluk	**Ayırt edici belirtiler**
Şizofreni (6A20)	Afektif epizodlar yok veya minimal, varsa psikoz gidişinin küçük bir kısmında.
Bipolar I psikotik özelliklerle (6A60)	Psikoz yalnızca manik veya depresif epizod bağlamında; afektif epizod dışında psikoz yoktur.
Major depresif bozukluk psikotik özelliklerle (6A70/6A71.x)	Psikoz yalnızca depresif epizod bağlamında.
Madde indüksiyonlu psikoz	Madde kullanımı ile zaman bağlantısı; eliminasyon sonrası remisyon.
İkincil (organik) psikoz (6E61)	Tıbbi durum (ensefalit, lupus, paraneoplastik) ile ilişkili.
Sanrı bozukluğu (6A24)	Yalnızca sanrı; afektif bileşen yok.
Akut ve geçici psikotik bozukluk (6A23)	≤ 3 ay (ICD-11) / < 1 ay (DSM-5-TR Brief Psychotic).

7. Muayene ve değerlendirme

7.1 Klinik ölçekler

- Yapılandırılmış görüşme: SCID-5, MINI.
- Psikotik şiddet: PANSS, BPRS.
- Depresif şiddet: HAM-D (Hamilton), MADRS (Montgomery-Åsberg).
- Manik şiddet: YMRS (Young Mania Rating Scale).

- Fonksiyonel: GAF, PSP, SOFAS.
- İntihar riski: C-SSRS.

7.2 Laboratuvar incelemeleri

Şizofreni benzeri (bkz 6A20 §7.2):

- Mutlak: tam kan, karaciğer/böbrek, glukoz, HbA1c, lipid profili, TSH, B12, folat, toksikolojik tarama, HIV, sifiliz, gebelik testi, prolaktin başlangıç göstergeleri.
- Seçici: EEG, anti-NMDA-R antikorları, seruloplazmin (Wilson).
- Lityum başlanmadan önce — kreatinin, TSH, kalsiyum, EKG.
- Valproat başlanmadan önce — karaciğer ve kan testleri.

7.3 Enstrümantal incelemeler

- Beyin MRG — ilk epizodda.
- EKG — antipsikotik veya lityum başlanmadan önce.

8. Tedavi

8.1 Genel prensipler (APA 2021 · NICE CG178 / CG185 · WFSBP konsensusu)

1. Multimodal yaklaşım — antipsikotik + duygudurum düzenleyici ve/veya antidepresan + psikososyal müdahale.
2. Atipik antipsikotik birinci sıra — paliperidon veya paliperidon palmitat (LAI) — FDA onayı özellikle şizoaffektif bozukluk için; risperidon, olanzapin, ketiapin, aripiprazol — yaygın kullanım.
3. Bipolar tipte duygudurum dengeleyici — lityum (intihar azaltma etkisi), valproat, lamotrijin (özellikle depresif bileşen dominant olduğunda).
4. Depresif tipte antidepresan — SSRI (sertralin, essitalopram) veya SNRI (venlafaksin); antidepresan tek başına kullanılmaz, antipsikotik ile birlikte.
5. Klozapin — refrakter vakalarda (iki antipsikotiğe yanıtsızlık).
6. EKT — ağır katatonik, depresif bileşenli, intihar riski yüksek, refrakter vakalarda etkili (NICE TA59 — psikotik depresyonda ve katatonide).
7. Psikososyal müdahale — BDTp (psikoz için BDT), aile psikoeğitimi, destekleyici terapi, IPS destekli istihdam.
8. Adherens ve nüks profilaksisi — LAI (paliperidon palmitat, aripiprazol LAI) seçilmiş hastalarda.

9. Komorbidite tedavisi — madde kullanımı (paralel program), anksiyete, somatik hastalıklar.
10. Metabolik ve yan etki izlemi — antipsikotiklerde standart.

8.2 Farmakoterapi

Sınıf	Preparat / örnekler	Endikasyon
Atipik antipsikotik	Paliperidon (FDA onayı), risperidon, olanzapin, ketiapin, aripiprazol	Pozitif ve negatif semptomlar; tüm vakalarda baz tedavi.
Atipik antipsikotik LAI	Paliperidon palmitat (aylık/3 aylık/6 aylık), aripiprazol LAI	Adherens sorununda veya hasta seçimi ile.
Duygudurum düzenleyici	Lityum, valproat, karbamazepin, lamotrijin	Bipolar tipte; lityum intiharı azaltır.
Antidepresan	SSRI (sertralin, essitalopram), SNRI (venlafaksin)	Depresif tipte; tek başına değil, antipsikotik ile birlikte.
Refrakter	Klozapin	İki antipsikotiğe yanıtsızlık.
Adjunkt	Benzodiazepin (lorazepam) kısa süreli	Akut ajitasyon veya katatonide.

8.3 EKT endikasyonları

- Katatonik özellikler.
- Ağır psikotik depresif epizod.
- İntihar riski veya besin ve sıvı alımının reddi.
- Gebelik döneminde (güvenli alternatif).
- Farmakoterapiye yanıtsızlık.

8.4 Kaynağa-özgü belirleyiciler

- APA 2021 (Schizophrenia): Şizoaffektif bozukluk tedavi algoritması şizofreni ile paraleldir; duygudurum bileşenine göre ek müdahale.
- NICE CG178 (Psychosis) + CG185 (Bipolar): her ikisi de şizoaffektif bozukluğa uygulanır — psikotik komponent CG178, afektif komponent CG185.

- WFSBP: Şizoaffektif bozuklukta paliperidon ve aripiprazolün en iyi kanıt tabanına sahip olduğu gösterilmiştir.
- CANMAT / ISBD 2018: bipolar tip şizoaffektif bozukluk — bipolar bozukluk tedavi algoritmalarına uyarlanır.

8.5 Tedavi metodolojileri

1. Psikoz için Bilişsel-Davranışçı Terapi (BDTp / CBTp — Cognitive Behavioural Therapy for psychosis) — Şizofrenideki gibi adapte edilir; bkz. "Tedavi metodolojileri", 6A20.html ve NICE CG178 §1.3.7.1.
2. Aile Psikoeğitimi ve Müdahalesi (Family Psychoeducation) — Yüksek duygusal dışavurum (EE) olan ailelerde nüksü azaltır. NICE CG178 §1.3.7.2; Pharoah Cochrane 2010.
3. Bireysel Yerleştirme ve Destek (İPS / IPS — Individual Placement and Support) — Destekli işe dahil olma "place-then-train" prensibi ile. Drake R.E. et al. Health Aff (Millwood) 2016.
4. Lityum — Bipolar tip şizoaffektif bozuklukta duygudurum stabilizasyonu ve intihar profilaksisi; başlangıç göstergeleri kreatinin, TSH, kalsiyum, EKG; terapötik düzey 0,6–1,0 mEq/L; Cipriani A. et al. BMJ 2013 — intiharı azaltır.
5. Lamotrijin — Bipolar depresif epizodda profilaktik; başlangıç titrasyonu yavaş (Stevens-Johnson sendromu riski).
6. Paliperidon Palmitat (LAI — uzun etkili enjeksiyon) — Aylık, 3 aylık ve 6 aylık formlar. FDA'nın şizoaffektif bozukluk endikasyonu yalnızca aylık formdadır (Invega Sustenna); 3 aylık (Trinza) ve 6 aylık (Hafyera) yalnızca şizofreni için onaylıdır. Uyum sorununda ve nüks profilaksisinde üstün.
7. Elektrokonvülsif Terapi (EKT — Electroconvulsive Therapy) — Katatonik özellikler, ağır psikotik depresyon, intihar riski veya refrakter durumlarda etkili. NICE TA59 — psikotik depresyonda veya katatonide güçlü öneri. UK ECT Review Group Lancet 2003 meta-analiz — EKT, ağır depresyonda farmakoterapiden üstün.
8. PANSS, HAM-D, YMRS — Psikotik, depresif, manik bileşenlerin ayrı ayrı standardize değerlendirilmesi.

9. Prognoz

İyi prognoz faktörleri

- Bipolar tip (depresif tipten daha iyi prognoz).
- Hızlı başlangıç, belirgin afektif komponent.
- Premorbid iyi fonksiyonel seviye.

- Erken müdahale ve adezyon.
- Sosyal destek.
- Komorbid madde kullanımının yönetimi.

Kötü prognoz etkenleri

- Depresif tip.
- Kademeli başlangıç.
- Negatif semptomların baskınlığı.
- Komorbid madde kullanımı.
- İntihar girişimi öyküsü.
- Adherensizlik.

İzlem hedefleri

- Psikotik ve afektif semptomların ayrı ayrı izlenmesi (PANSS, HAM-D, YMRS).
- İntihar riski (C-SSRS) — özellikle depresif epizodlarda ve ilk yıllarda.
- Metabolik izlem.
- Lityum alanlarda — TSH, kreatinin, kalsiyum (6 aylık).
- İşlevsel iyileşme, istihdam, sosyal ilişkiler.
- Aile desteği ve psikoeğitim.

10. Mit ve yanlış inançlar

10.1 Etiyoloji ve kavramsal mitler

Mit 1: "Şizoaffektif bozukluk hafif şizofrenidir"

Neden yaygınlaştı: Şizoaffektif hastaların ortalama olarak şizofreni hastalarından daha iyi işlevsel iyileşme göstermesi yanlış açıklanır.

Klinik ve biyolojik mantık: Şizoaffektif bozukluk klinik görünümler açısından şizofreni ile örtüşür (psikotik belirtiler afektif epizod dışında), ancak duygudurum bozukluğu bileşeni eklenir. "Hafif form" değil — ayrı bir tanısal birimdir. Bazı hastalar ağır seyir gösterir.

Kanıt: Heckers S. Curr Psychiatry Rep 2009 — şizoaffektif bozukluk şizofreni ile nörobiyolojik örtüşme, ancak önemli klinik farklar; "şizofreni hafif formu" konsepti desteklenmiyor.

Mit 2: "Şizoaffektif bozukluk yalnızca iki ayrı tanının (şizofreni + bipolar) karışıklığıdır"

Kanıt: Cross-Disorder Psychiatric Genomics Consortium 2013 — şizofreni, bipolar ve şizoaffektif arasında geniş genetik örtüşme. Bu, tanısal birimlerin bir spektrum içinde yer aldığını gösterir — şizoaffektif ayrı bir klinik sınıflandırmayı hak eder, çünkü uzun süreli izlemde farklı gidiş ve tedavi yanıtı gösterir.

Mit 3: "Şizoaffektif bozukluk uydurma bir tanıdır, geçerliliği yoktur"

Neden yaygınlaştı: akademik tartışma (Malhi 2008, Lake & Hurwitz 2007) — bazı araştırmacılar tanının pratik değeri hakkında soru sorar.

Klinik mantık: tanının geçerliliği tartışmalıdır, ancak klinik kullanışlılık (tedavi kararı ve prognoz için yararlı çerçeve) korunur. DSM-5-TR ve ICD-11 her ikisi de tanısal birim olarak tutar. Klinik pratikte hastayı deneyimli bir psikiyatrist değerlendirmeli — farkı diğer bozukluklardan doğru ayırt etmek önemlidir, çünkü tedavi yaklaşımı farklıdır.

10.2 Yanlış tedavi yaklaşımları

Mit 4: "Antidepresan şizoaffektif bozuklukta tek başına kullanılabilir"

Klinik mantık ve kanıt: Antidepresan tek başına kullanım şizoaffektif bozuklukta kontrendikedir — depresif tipte manik dönüş, depresifte psikoz şiddetlenmesi riski. NICE CG185, CANMAT 2018 — antipsikotik ile birlikte.

Mit 5: "Lityum şizoaffektif bozuklukta etkisizdir"

Kanıt: Cipriani A. ve ark. BMJ 2013 meta-analizi — lityum bipolar spektrumda (şizoaffektif bipolar tip dahil) intihar riskini anlamlı derecede azaltır. Bipolar tip şizoaffektif bozuklukta lityum etkili duygudurum düzenleyicisidir.

Mit 6: "Klozapin yalnızca refrakter şizofreni içindir, şizoaffektif için değil"

Kanıt: klozapinin şizoaffektif bozuklukta iki antipsikotiğe yanıtsızlık durumunda kullanımı kabul edilmiş klinik pratiktir; intihar riskini azaltma etkisi şizoaffektif hastalara da yayılır (Meltzer H.Y. ve ark. Arch Gen Psychiatry 2003 InterSePT çalışması).

10.3 Etkisiz veya zararlı yaklaşımlar

Mit 7: "Ekzorsizm, ruhsal pratik veya dini ritüel şizoaffektif bozukluğu iyileştirir"

Kanıt: Şizofrenideki gibi — psikotik semptomlar nörobiyolojik temellidir; ekzorsizm antipsikotik tedaviyi geciktirir, klinik sonuçları kötüleştirir (DUP kötü prognoz belirtecidir, Marshall Arch Gen Psychiatry 2005).

Mit 8: "Kannabis duygudurum düzenleyici olarak şizoaffektif bozukluğu iyileştirir"

Kanıt: Kannabis psikoz riskini 2–3 kat artırır (Marconi A. et al. Schizophr Bull 2016); şizoaffektif hastalarda kontrendike kabul edilir — semptomları şiddetlendirir.

Mit 9: "Mega-doz vitamin veya bitkisel preparatlar (St John's Wort, valerian) farmakoterapinin yerini alır"

Kanıt: Sistematik derlemelerde etki kanıtı yok; St John's Wort sitokrom P450 indüksiyonu ile antipsikotiklerin ve duygudurum düzenleyicilerinin seviyesini düşürür.

Mit 10: "Tamamlayıcı müdahaleler (akupunktur, homeopati, kraniosakral) antipsikotiğin yerini alır"

Kanıt: hiçbirinin şizoaffektif bozukluk için etkisi kanıtlanmamış.

Mit 11: "Aktif depresif epizod dışında farmakoterapi gerekmez"

Kanıt: Şizoaffektif bozukluk ölçütüne göre psikotik belirtiler afektif epizod dışı dönemlerde de mevcuttur — antipsikotik idame tedavisi uzun süreli önerilir.

11. Kaynaklar

1. WHO. ICD-11 for Mortality and Morbidity Statistics. 6A21 Schizoaffective disorder. 2024.
2. American Psychiatric Association. DSM-5-TR. Washington DC: APA Publishing; 2022.
3. American Psychiatric Association. Practice Guideline for the Treatment of Patients with Schizophrenia, 3rd ed. 2021.
4. NICE Clinical Guideline 178. Psychosis and schizophrenia in adults: prevention and management. 2014, 2019 update.
5. NICE Clinical Guideline 185. Bipolar disorder: assessment and management. 2014, 2020 update.

6. Yatham L.N., Kennedy S.H., Parikh S.V. et al. CANMAT and ISBD 2018 guidelines for the management of patients with bipolar disorder. Bipolar Disord 2018;20(2):97–170.
7. Perälä J., Suvisaari J., Saarni S.I. et al. Lifetime prevalence of psychotic and bipolar I disorders in a general population. Arch Gen Psychiatry 2007;64(1):19–28.
8. Cross-Disorder Group of the Psychiatric Genomics Consortium. Identification of risk loci with shared effects on five major psychiatric disorders: a genome-wide analysis. Lancet 2013;381(9875):1371–1379.
9. Heckers S. Is schizoaffective disorder a useful diagnosis? Curr Psychiatry Rep 2009;11(4):332–337.
10. Malhi G.S., Green M., Fagiolini A., Peselow E.D., Kumari V. Schizoaffective disorder: diagnostic issues and future recommendations. Bipolar Disord 2008;10(1 Pt 2):215–230.
11. Lake C.R., Hurwitz N. Schizoaffective disorder merges schizophrenia and bipolar disorders as one disease — there is no schizoaffective disorder. Curr Opin Psychiatry 2007;20(4):365–379.
12. Cipriani A., Hawton K., Stockton S., Geddes J.R. Lithium in the prevention of suicide in mood disorders: updated systematic review and meta-analysis. BMJ 2013;346:f3646.
13. Meltzer H.Y., Alphs L., Green A.I. et al. Clozapine treatment for suicidality in schizophrenia: International Suicide Prevention Trial (InterSePT). Arch Gen Psychiatry 2003;60(1):82–91.
14. Marshall M., Lewis S., Lockwood A. et al. Association between duration of untreated psychosis and outcome. Arch Gen Psychiatry 2005;62(9):975–983.
15. UK ECT Review Group. Efficacy and safety of electroconvulsive therapy in depressive disorders: a systematic review and meta-analysis. Lancet 2003;361(9360):799–808.
16. NICE Technology Appraisal 59. Guidance on the use of electroconvulsive therapy. 2003 (reviewed).

ICD-11 **6A22**	**6A22 ŞİZOTİPAL BOZUKLUK** **Schizotypal disorder**
ICD-10 F21	Şizotipal bozukluk

ICD-11 **6A22**	**6A22 ŞİZOTİPAL BOZUKLUK** **Schizotypal disorder**
DSM-5-TR F21	Şizotürü (Şizotipal) Kişilik Bozukluğu

1. Tanım ve nozoloji

Şizotipal bozukluk (ICD-11: 6A22 Schizotypal Disorder; DSM-5-TR: F21 Şizotipal Kişilik Bozukluğu) — sürekli düşünce ve algı bozuklukları, tuhaf (eksantrik) davranış, sosyal defisitler ve psikotik-benzeri deneyimlerle karakterize olan, ancak tam psikotik epizod kriterlerine ulaşmayan klinik durumdur.

Önemli nozolojik konu: ICD-11 ve DSM-5-TR'de farklı yerleşim:

- ICD-11 — şizofreni spektrum bozuklukları dahilinde (psikotik kategori) 6A22;
- DSM-5-TR — kişilik bozuklukları bölümünde (Cluster A) ve Şizofreni spektrum bozuklukları listesinde çift kodlanır.

2. Tarihçe

- Bleuler E. (1911) — gizli şizofreni kavramı — şizofreniye yakın, ancak tam psikotik epizod olmayan durum.
- Rado S. (1953) — şizotip terimi — şizofreniye genetik yatkınlığın kalıcı kişilik ifadesi olarak.
- Kety S.S. et al. (1968) — Danimarka evlat edinme çalışmaları — şizofrenili biyolojik akrabalarda şizotipik özellikler yüksek; "şizofreni spektrumu" konseptinin temeli.
- DSM-III (1980) — Şizotipal Kişilik Bozukluğu kişilik bozuklukları arasında.
- ICD-10 (1990) ve ICD-11 (2019) — şizotipik bozukluk psikotik bozukluklar bölümünde.
- DSM-5 (2013) — çifte yerleşim (kişilik bozuklukları + şizofreni spektrumu) — kavramsal köprü.

3. Epidemiyoloji

- Yaşam boyu yaygınlık: %0,6–4 — geniş aralık (Pulay A.J. et al. Prim Care Companion J Clin Psychiatry 2009 ABD NESARC çalışması n>34 000 — %3,9).
- Cins: Erkeklerde nispeten sık; bazı çalışmalarda fark minimal.
- Başlangıç: ergenlik ve erken yetişkinlik dönemi.
- Şizofreniye geçiş: ~%10–25 (Schultze-Lutter F. ve ark. Schizophr Res 2014); aile öyküsü ve ek psikoz risk faktörleri varsa daha yüksek.
- Komorbidite: Duygudurum bozuklukları, anksiyete, madde kullanımı, diğer kişilik bozuklukları (paranoid, şizoid, borderline).

4. Etiyoloji ve patogenez

4.1 Genetik faktörler

- Şizofreni ile paylaşılan genetik yük — Kety evlat edinme çalışmaları ve modern genetik çalışmalar (Cross-Disorder Group 2013) — şizotipal hastaların akrabalarında şizofreni riski artmıştır.
- Şizofreniye benzer poligenik risk mimarisi, ancak daha az "yük"; bazı koruyucu alellerin varlığı.

4.2 Nörobiyoloji

- Şizofrenide gözlenen yapısal değişikliklerin daha hafif varyantları — temporal kortekste hacim azalması, ancak frontal korteksin korunması (Hazlett E.A. et al. Schizophr Bull 2011 derleme).
- Dopaminerjik disregülasyon — şizofreniye göre daha düşük; psikotik dekompansasyon daha az olası.
- Bilişsel defisitler — şizofrenideki gibi, ancak daha hafif.

4.3 Çevresel faktörler

- Çocukluk travması, sosyal yoksunluk — risk faktörleri.
- Kannabis kullanımı ergenlikte — psikotik dekompansasyon riskini artırır.

5. Klinik özellikler

5.1 Kognitif-perseptif semptomlar

- İlişki düşünceleri (referans sanrıları hariç) — tam sanrı düzeyinde değil; hasta bazen bu düşüncelerin gerçek dışı olduğunu kabul edebilir.

- Garip inançlar veya büyülü düşünce — telepati, "altıncı his", batıl inançlar yaşa ve kültüre uygun olmayan derecede.
- Olağandışı perseptif deneyimler — kişisel olmayan, geçici illüzyonlar; tam halüsinasyon yok.
- Garip düşünce ve konuşma — anlamsız, metaforik, dolaylı, stereotipik.

5.2 Kişilerarası semptomlar

- Yakın ilişkilerde huzursuzluk; sosyal izolasyon.
- Paranoid düşünce veya şüphecilikler.
- Uygun olmayan veya sınırlı affekt.
- Garip, eksantrik veya kendine özgü davranış ve görünüm.
- Birinci derece akrabalar dışında yakın arkadaşların azlığı.

5.3 Gidiş

Genellikle ergenlikten başlar ve sürekli seyreder; bazı hastalarda kısa süreli psikotik dekompansasyon epizodları (stres, kannabis bağlamında) — bu durumda tanı "şizofreni" veya "akut ve geçici psikotik bozukluk" olarak yeniden değerlendirilebilir.

6. Tanı

6.1 Birleşik tanı ölçütleri (DSM-5-TR · ICD-11 konsensus noktaları)

A. Sosyal ve interpersonal defisitler ve kognitif-perseptif bozukluklar ile karakterize edilen sürekli tablo, yetişkin yaşta başlayan, aşağıdaki semptomların en az beşi:

1. İlişki düşünceleri (referans sanrıları hariç);
2. Yaşa ve kültüre uygun olmayan garip inançlar veya büyülü düşünce;
3. Olağandışı perseptif deneyimler (illüzyonlar dahil);
4. Garip düşünce ve konuşma (anlamsız, dolaylı, metaforik, stereotipik);
5. Şüphecilik ve paranoid ideasyon
6. Uygun olmayan veya sınırlı affekt;
7. Garip, eksantrik veya kendine özgü davranış veya görünüm;
8. Birinci derece akrabalar dışında yakın arkadaşların veya sırdaşların azlığı;
9. Tanıdıklıkla azalmayan aşırı sosyal kaygı (paranoid korkuya dayanır, öz-değer açısından değil).

B. Süregelen şizofreni, psikotik özelliklerle duygudurum bozukluğu veya otizm spektrum bozukluğu seyrinde ortaya çıkmaz.

6.2 Kaynaklar arasındaki farklar

- ICD-11 (6A22): "Şizotipal Bozukluk" — psikotik bozukluklar bölümünde; sürekli bir bozukluk olarak, ancak şizofreni kriterlerini karşılamayan.
- DSM-5-TR (F21): çift kodlama — Cluster A Personality Disorder ve schizophrenia spectrum listesinde. Yetişkin yaş şartı; çocuk ve ergenlikte "premorbid belirtiler" olarak not edilebilir.
- NICE: şizotipal bozukluk için ayrı bir klinik rehber yoktur; CG78 (BPD) ve CG178 (Psikoz) ilkeleri uygulanır.

6.3 Tanı algoritması

1. Klinik görüşme + akraba/arkadaş bilgisi — sürekli kişilik özellikleri vs epizodik psikoz.
2. Yapılandırılmış görüşme — SCID-5-PD (Personality Disorders), SIDP-IV.
3. Şizotipi ölçekleri — SPQ (Schizotypal Personality Questionnaire, Raine A.).
4. Psikotik semptomların ayrı değerlendirilmesi — PANSS'de pozitif semptomların subklinik düzeyi.
5. Komorbidite taraması (depresyon, anksiyete, madde kullanımı, diğer kişilik bozuklukları).
6. Tıbbi ve nörolojik muayene, toksikolojik tarama.
7. Şizofreniye geçiş riskinin değerlendirilmesi (ultra-yüksek risk kriterleri — CAARMS, SIPS).

6.4 Ayırıcı tanı

Bozukluk	**Ayırt edici belirtiler**
Şizofreni (6A20)	Tam psikotik epizod ≥ 1 ay; fonksiyonel bozulma belirgin.
Sanrı bozukluğu (6A24)	Belirli sistematize sanrı, genel işlevsellik görece korunur.
Paranoid kişilik bozukluğu (6D10.x)	Şüphecilik dominant; perseptif garip deneyimler yok
Şizoid kişilik bozukluğu	Sosyal izolasyon, ancak bilişsel-algısal tuhaflıklar yok.
Otizm spektrum bozukluğu (6A02)	Erken başlangıç, sosyal-iletişimsel defisit, sınırlı-tekrarlayan davranış.

Bozukluk	Ayırt edici belirtiler
BPD (6D10.x)	Duygusal değişkenlik, kimlik bozukluğu, dürtüsellik.
Madde indüksiyonlu psikotik belirtiler	Madde kullanımı veya kesilmesi ile ilişkili.

7. Muayene ve değerlendirme

7.1 Klinik ölçekler

- SPQ (Schizotypal Personality Questionnaire, Raine A.) — 74 madde, özdeğerlendirme; 9 alt-ölçek (DSM kriterine dayalı).
- SCID-5-PD — yapılandırılmış kişilik bozuklukları görüşmesi.
- CAARMS (Comprehensive Assessment of At Risk Mental States) — şizofreniye geçiş risk değerlendirmesi.
- SIPS (Structured Interview for Prodromal Syndromes).
- PANSS, BPRS — psikotik semptomların subklinik düzeyi.

7.2 Laboratuvar incelemeleri

Rutin özel göstergesi yoktur. Standart psikiyatrik ilk göstergeler (tam kan, tiroid, karaciğer, böbrek, glukoz); toksikolojik tarama.

7.3 Enstrümantal incelemeler

Rutin gerekmez; klinik şüphede nörogörüntüleme.

8. Tedavi

8.1 Genel prensipler

1. Psikoterapi birinci sıra — destekleyici psikoterapi, BDT (özellikle paranoid düşünce ve sosyal kaygı için), sosyal beceri eğitimi.
2. Farmakoterapi semptomatiktir, "çekirdek" bozukluğu iyileştirmez:
    - Düşük doz antipsikotik (risperidon 0,5–2 mg, olanzapin 2,5–10 mg, aripiprazol 2–10 mg) — psikotik-benzeri semptomlar için; sürekli değil, aralıklı.
    - SSRI — sosyal anksiyete ve komorbid depresyon için.
    - Benzodiazepin kısa süreli — akut anksiyete.

3. Erken Müdahale Hizmetleri (EIP) — şizofreniye geçiş riski olan hastalarda (UHR — Ultra High Risk kriterleri) profilaktik müdahale.
4. Psikososyal destek — işlevsel düzeyin sürdürülmesi, istihdam, sosyal ilişkiler.
5. Kannabisi bırakma — psikotik dekompansasyon riskini azaltmak için kritik.
6. Stres yönetimi — stres dekompansasyon tetikleyicisi olabilir.
7. Aile psikoeğitimi — şizofreniye geçiş belirteçleri hakkında bilgi; hastanın sosyal destek sistemi.

8.2 Psikoterapi yaklaşımları

- BDT — paranoid düşünce, sosyal anksiyete, bilişsel bozulmalar için; gerçeklik testi ve alternatif açıklamalar.
- Sosyal beceri eğitimi — sosyal izolasyon ve tuhaf davranışların azaltılması.
- Mentalization-based ve supportif yaklaşımlar — kişilerarası işlevsel düzeyin güçlendirilmesi.
- Schema Therapy — kişilik temelli sürekli modeller için.

8.3 Farmakoterapi — spesifik kullanım

- Subklinik psikotik semptomlar (referans düşünceleri, garip deneyimler) ağırlaştığında — düşük doz atipik antipsikotik intermitent.
- Komorbid depresyon — SSRI (sertralin, essitalopram).
- Sosyal anksiyete — SSRI, kısa süreli benzodiazepin (özel durumlar için).
- Stres-induksiyonlu dekompansasyon — hastaneye yatış veya kısa süreli yoğun müdahale.

8.4 Kaynağa-özgü belirleyiciler

- Kanıt temeli sınırlıdır — Şizotipik bozukluğun spesifik tedavisi üzerine geniş RKÇ'ler azdır; temel yaklaşım şizofreni ve kişilik bozuklukları müdahalelerinden ekstrapolasyon yapılır.
- Koenigsberg H.W. et al. çalışmaları — Şizotipik bozuklukta düşük doz antipsikotik araştırmaları (hafif etki).
- NICE — ayrı bir öneri yok; CG178 ve CG78 ilkeleri.

8.5 Tedavi metodolojileri

1. Şizotipal Kişilik Anketi (SPQ — Schizotypal Personality Questionnaire) — Raine (Raine A.) — 74 maddelik öz değerlendirme ölçeği; DSM şizotipal kişilik bozukluğu kriterlerine uygun 9 alt ölçek. Klinik ve popülasyon çalışmalarında yaygın kullanım.

2. Risk Altındaki Ruhsal Durumların Kapsamlı Değerlendirmesi (CAARMS — Comprehensive Assessment of At Risk Mental States) — Şizofreniye geçiş risk değerlendirmesi — pozitif semptomların subklinik düzeyi, kognitif değişiklikler, davranış bozuklukları, fonksiyonel düzey. Yung A.R. et al. Aust N Z J Psychiatry 2005.
3. Prodromal Sendromlar için Yapılandırılmış Görüşme (SIPS — Structured Interview for Prodromal Syndromes) — Miller (Miller T.J.), McGlashan (McGlashan T.H.) — CAARMS'a benzer; ABD'de yaygın kullanım.
4. Erken Müdahale Hizmetleri (EIP) — uHR hastalar için — multidisipliner müdahale; antipsikotik genellikle profilaktik olarak önerilmez (yan etki yükü), psikososyal müdahale üstün.
5. Kişilik bozukluklarına uyarlanmış BDT — şizotipik kişilik için — kognitif bozulmalar, sosyal korkular, paranoid düşünce üzerinde çalışma.
6. Sosyal Beceri Eğitimi (Social Skills Training) — yapılandırılmış grup veya bireysel seanslar — sosyal etkileşim becerilerinin geliştirilmesi.

9. Prognoz

İyi prognoz faktörleri

- Hafif semptom şiddeti.
- Komorbiditenin (depresyon, anksiyete, madde) yönetimi.
- Sosyal destek ve sürekli ilişkiler.
- Psikoterapi katılımı.
- Kannabisi bırakma.

Kötü prognoz etkenleri

- Aile öyküsünde şizofreni.
- Kannabis veya diğer psikoaktif madde kullanımı.
- Ağır bilişsel defisitler.
- Sosyal izolasyon ve fonksiyonel bozulma.
- UHR kriterlerine ulaşma.

İzlem hedefleri

- Şizofreniye geçiş belirteçlerinin (CAARMS / SIPS) periyodik değerlendirilmesi.
- Komorbidite taraması (depresyon, anksiyete, madde).
- İşlevsel düzey — istihdam, sosyal ilişkiler.

- Stres ve psikotik dekompansasyon tetikleyicilerinin yönetimi.
- Antipsikotik alanlarda yan etki takibi.

10. Mit ve yanlış inançlar

10.1 Etiyoloji ve kavramsal mitler

Mit 1: "Şizotipal kişilik — sadece 'eksantrik' veya 'yaratıcı' kişidir, klinik tanı gerektirmez"

Neden yaygınlaştı: Şizotipik özelliklerin (garip inançlar, eksantriklik) popülasyonda sürekli spektrum olarak yayılması — genel popülasyonda "schizotypy" özelliklerini hafif formda birçok kişi taşır.

Klinik ve biyolojik mantık: klinik tanı fonksiyonel bozulma gerektirir — sosyal izolasyon, mesleki bozulma, sıkıntı. Basit yaratıcılık veya eksantriklik kendi başına tanı temeli değildir. Ancak tanısal kriterlere ulaştığında şizotipal bozukluk gerçek klinik durum olup müdahaleden fayda sağlar.

Gerçek klinik adım: tanı kriterleri (5/9 semptom + işlevsel bozulma) temelinde konulmalıdır.

Mit 2: "Şizotipal bozukluk mutlaka şizofreniye dönüşür"

Kanıt: Schultze-Lutter F. et al. Schizophr Res 2014 — şizotipal bozukluktan şizofreniye geçiş ~%10–25; çoğunluk stabil kalır veya remisyon gösterir. Aile öyküsü, kannabis kullanımı, bilişsel defisitin şiddeti geçiş riskini artırır.

Gerçek klinik adım: aileye gerçekçi prognoz; UHR kriterleri izlenir; profilaktik antipsikotik genellikle önerilmez.

Mit 3: "Şizotipal bozukluk çocukluk travmasından ya da kötü terbiyeden kaynaklanır"

Kanıt: Genetik komponent önemlidir — Kety Danimarka evlat edinme çalışmaları; Cross-Disorder Group 2013. Çocukluk travması risk faktörü olarak gösterilir, ancak ana etiyoloji değil; biyolojik ve psikososyal etkileşim.

10.2 Yanlış tedavi yaklaşımları

Mit 4: "Şizotipal hastalar mutlaka sürekli antipsikotik almalıdır"

Kanıt: Şizotipik bozukluk için sürekli antipsikotik önerilmez (kanıt tabanı sınırlı + yan etki yükü). Düşük doz antipsikotik intermitent Semptom-spesifik müdahale olarak kullanılabilir; sürekli reçete için — bireysel değerlendirme.

Mit 5: "Şizotipal hastanın 'sihirli düşünce'sini onaylamak (validate) tedavidir"

Klinik mantık: Açıkça sanrı-benzeri inançları onaylamak onları güçlendirir; aksine, açıkça inkâr etmek de terapötik ittifakı bozar. Gerçeklik testi ve alternatif açıklamalar BDT'de kanıta dayalı yaklaşımdır — hastayla birlikte inancın fiili kanıtı veya alternatif açıklamaları araştırılır.

Mit 6: "Sosyal izolasyon sağlıklı stratejidir, şizotipal hastayı rahat bırakmak gerekir"

Kanıt: Sosyal izolasyon uzun vadeli işlevsel düzeyi ve duygudurum bozuklukları riskini artırır. Sosyal beceri eğitimi ve destekleyici terapi ile kademeli olarak sosyal bağlantıların güçlendirilmesi önerilir.

10.3 Etkisiz veya temel müdahaleyi geciktiren yöntemler

Mit 7: "Büyüsel düşünce ve 'altıncı his' temelli alternatif klinikler şizotipal bozukluğu iyileştirir"

Kanıt: "ezoterik müdahaleler" (kristal terapisi, çakra çalışmaları, astroloji danışmanlıkları) — şizotipal hastanın tuhaf inançlarını destekleyebilir ve bozukluğun semptomlarını güçlendirebilir. Etki kanıtı yoktur; temel psikoterapötik veya farmakoterapötik müdahaleyi geciktirir.

Mit 8: "Kannabis 'yaratıcılık ve tuhaf deneyimleri korur' — şizotipal hasta için güvenlidir"

Kanıt: Kannabis psikoz riskini 2–3 kat artırır (Marconi 2016); şizotipal hastalarda şizofreniye geçiş riski daha yüksektir. Kannabisten uzak durma kritik klinik öneridir.

Mit 9: "Homeopati, akupunktur, ezoterik müdahaleler şizotipal bozukluğu iyileştirir"

Kanıt: Sistematik derlemeler — bu müdahalelerin şizotipal bozukluk için etkisi kanıtlanmamıştır.

Mit 10: "Şizotipal hasta psikoterapiye yanıt vermez, bu nedenle basit gözlem yeterlidir"

Kanıt: BDT, sosyal beceri eğitimi ve destekleyici psikoterapi bu hastalara yardımcı olabilir; "gözlem yeterlidir" yaklaşımı işlevsel bozulmayı artırır.

11. Kaynaklar

1. WHO. ICD-11 for Mortality and Morbidity Statistics. 6A22 Schizotypal disorder. 2024.
2. American Psychiatric Association. DSM-5-TR. Washington DC: APA Publishing; 2022.
3. Pulay A.J., Stinson F.S., Dawson D.A. et al. Prevalence, correlates, disability, and comorbidity of DSM-IV schizotypal personality disorder: results from the wave 2 National Epidemiologic Survey on Alcohol and Related Conditions. Prim Care Companion J Clin Psychiatry 2009;11(2):53–67.
4. Schultze-Lutter F., Klosterkötter J., Ruhrmann S. Improving the clinical prediction of psychosis by combining ultra-high risk criteria and cognitive basic symptoms. Schizophr Res 2014;154(1–3):100–106.
5. Hazlett E.A., Goldstein K.E., Kolaitis J.C. A review of structural MRI and diffusion tensor imaging in schizotypal personality disorder. Curr Psychiatry Rep 2012;14(1):70–78.
6. Raine A. The SPQ: a scale for the assessment of schizotypal personality based on DSM-III-R criteria. Schizophr Bull 1991;17(4):555–564.
7. Yung A.R., Yuen H.P., McGorry P.D. et al. Mapping the onset of psychosis: the Comprehensive Assessment of At-Risk Mental States. Aust N Z J Psychiatry 2005;39(11–12):964–971.
8. Cross-Disorder Group of the Psychiatric Genomics Consortium. Identification of risk loci with shared effects on five major psychiatric disorders: a genome-wide analysis. Lancet 2013;381(9875):1371–1379.
9. Marconi A., Di Forti M., Lewis C.M., Murray R.M., Vassos E. Meta-analysis of the association between the level of cannabis use and risk of psychosis. Schizophr Bull 2016;42(5):1262–1269.
10. NICE Clinical Guideline 178. Psychosis and schizophrenia in adults: prevention and management. 2014, 2019 update.
11. Kety S.S., Rosenthal D., Wender P.H. et al. The types and prevalence of mental illness in the biological and adoptive families of adopted schizophrenics. J Psychiatr Res 1968;6(Suppl 1):345–362.
12. Miller T.J., McGlashan T.H., Rosen J.L. et al. Prodromal assessment with the Structured Interview for Prodromal Syndromes and the Scale of Prodromal Symptoms. Schizophr Bull 2003;29(4):703–715.
13. Koenigsberg H.W., Reynolds D., Goodman M. et al. Risperidone in the treatment of schizotypal personality disorder. J Clin Psychiatry 2003;64(6):628–634.

ICD-11 **6A23**	**6A23 AKUT VE GEÇİCİ PSİKOTİK BOZUKLUK** **Acute and transient psychotic disorder**
ICD-10 F23	Akut ve geçici psikotik bozukluklar
DSM-5-TR F23	Kısa Psikoz Bozukluğu

1. Tanım ve nozoloji

Akut ve geçici psikotik bozukluk (ICD-11: 6A23 Acute and Transient Psychotic Disorder; DSM-5-TR: F23 Brief Psychotic Disorder) — hızlı (birkaç gün-hafta) başlayan, psikotik semptomlar (sanrı, halüsinasyon, dezorganize konuşma, belirgin dezorganize davranış) ile karakterize, kısa süreli gidiş ve premorbid fonksiyonel düzeye tam düzelme ile sonuçlanan bozukluktur.

Karakteristik özellikler:

- Hızlı başlangıç — 2 hafta içinde tam klinik tablonun oluşması;
- Polimorf (çok biçimli) semptomlar — sanrılar, halüsinasyonlar ve duygusal dalgalanma birlikte;
- Kısa süre — DSM-5-TR'de < 1 ay, ICD-11'de < 3 ay;
- Tam fonksiyonel iyileşme — hasta premorbid seviyeye tamamen döner.

2. Tarihçe

- Magnan V. (1893) — Bouffée délirante terimi — Fransa'da hızlı başlayan, kısa süreli polimorf psikotik epizodların tanımı.
- Wernicke K., Kleist K., Leonhard K. (1900–1957) — siklik psikozlar kavramı — Alman psikiyatri okulunda; hızlı başlangıç ve iyi prognoz.
- İskandinav ekolü — "psikojen psikoz" — Strömgren E. (1940) — stres veya travma bağlamında psikoz.
- DSM-III (1980) — "Kısa Reaktif Psikoz" — stres faktörü gerekliliği ile.
- DSM-IV (1994) ve DSM-5 (2013) — stres faktörü kriteri kaldırılmıştır (niteleyici olarak kalmıştır); "Brief Psychotic Disorder" terimi.

- ICD-11 (2019) — “Akut ve Geçici Psikotik Bozukluk” terimi korunmuştur; 3 aylık süre; polimorf semptomatoloji vurgulanır.

3. Epidemiyoloji

- Yıllık insidans: 3,9–9,6 / 100 000 (Castagnini A., Berrios G.E. Curr Psychiatry Rep 2009 derleme).
- Cins: kadınlarda nispeten sık (1,5–2:1) — özellikle postpartum bağlamda.
- Başlangıç yaşı: 20–35 yaş; şizofreniden biraz geç.
- Kültürel ve coğrafi: düşük ve orta gelirli ülkelerde sıklık daha yüksektir (Susser E. et al. Soc Psychiatry Psychiatr Epidemiol 1998 DSÖ 10 ülke araştırması).
- Postpartum başlangıç — postnatal psikoz kategorisine aittir (6E20 / 6A23.x).
- Persistans ve konversiyon: %30–50 hasta uzun süreli takipte şizofreni, şizoaffektif bozukluk veya bipolar bozukluk olarak yeniden tanı alır (Castagnini A. et al. Schizophr Res 2013).

4. Etiyoloji ve patogenez

4.1 Genetik faktörler

- Şizofreni ve bipolar bozukluk ile kısmen paylaşılan genetik risk.
- Aile öyküsünde psikotik veya afektif bozukluk olduğunda risk artar.

4.2 Tetikleyiciler ve stres

- Akut psikososyal stres (ölüm, mültecilik, doğal afet) — hastaların önemli bir kısmında tanımlanır; DSM-5-TR'de stres niteleyicisi olarak belirtilir.
- Postpartum dönem — hormonal ve uyku bozukluğu.
- Madde kullanımı — kannabis, amfetamin, halüsinojenler — psikotik epizodu tetikleyebilir, ancak madde indüksiyonlu psikoz eğer madde belirliyse ayrı kategori olarak kodlanır.
- Kısa süreli uyku yoksunluğu, yoğun duygusal gerginlik.

4.3 Nörobiyolojik mekanizmalar

- Dopaminerjik sistemin geçici hiperaktivitesi — stres kortizolü veya hormonal değişiklikler bağlamında.
- Şizofrenideki gibi merkezi mekanizmalar, ancak daha kısa süreli ve potansiyel olarak geri döndürülebilir.

5. Klinik özellikler

5.1 Klasik sunum

- Hızlı başlangıç — günler-haftalar içinde premorbid normal fonksiyondan tam psikotik şekle.
- Polimorf (değişken) semptomlar — sanrılar (takip, ilişki, dini), halüsinasyonlar (işitsel, görsel, koenestetik), dezorganize konuşma.
- Duygusal dalgalanma — akut korku, ekstaz, panik, şaşkınlık.
- Bilinç değişiklikleri yok (deliryum hariç)
- Davranış — garip, dezorganize; bazen katatonik bileşenler.

5.2 ICD-11 alt tipleri

- Polimorf psikotik bozukluk — şizofreni semptomları olmadan;
- Polimorf psikotik bozukluk — şizofreni semptomları ile;
- Şizofreni benzeri akut psikotik bozukluk — Şneider 1. derece semptomlar baskın.

5.3 Gidiş

Tipik gidiş — 2–4 haftada pike ulaşma, ardından kademeli veya hızlı sönme. Tam iyileşme — 1 ay (DSM-5-TR) veya 3 ay (ICD-11) içinde. Bu süreden fazla devam ettiğinde tanı şizofreniform bozukluğa (DSM-5-TR F20.81, 1–6 ay) veya şizofreniye dönüştürülür.

6. Tanı

6.1 Birleşik tanı ölçütleri (DSM-5-TR · ICD-11 konsensus noktaları)

A. Bir veya birkaç psikotik semptomun bulunması:

1. Sanrılar;
2. Halüsinasyonlar;
3. Dezorganize konuşma;
4. Brüt dezorganize veya katatonik davranış.

(En az biri 1, 2 veya 3 olmalıdır.)

B. Epizodun süresi:

- DSM-5-TR: ≥ 1 gün, < 1 ay, sonra premorbid işlev düzeyine tam iyileşme.
- ICD-11: tam tablo 2 hafta içinde oluşur; < 3 ay devam eder.

C. İstisnalar — psikotik özelliklerle duygudurum bozukluğu, şizofreni, şizoaffektif bozukluk, madde indüksiyonlu psikoz, organik psikoz ile tam olarak açıklanmaz.

6.2 Kaynaklar arasındaki farklar

- DSM-5-TR (F23): kalifikatörler — "with marked stressor(s)" (akut stres faktörü ile), "without marked stressor", "with postpartum onset" (doğumdan 4 hafta içinde).
- ICD-11 (6A23): üç alt tip — polimorf (şizofreni semptomları olmadan / ile) ve şizofreni benzeri. Postpartum başlangıç ayrı 6E20 koduna aittir.
- Stres faktörü ölçüt değil, niteleyicidir — DSM-IV "Brief Reactive Psychosis" içinde zorunluydu.

6.3 Tanı algoritması

1. Klinik görüşme + akrabalardan bilgi — başlangıç dinamiği, premorbid fonksiyon.
2. Yapılandırılmış görüşme (SCID-5, MINI).
3. Şiddet ölçekleri — PANSS, BPRS.
4. Toksikolojik tarama (zorunlu) — madde kaynaklı psikozu dışlamak.
5. Fizik ve nörolojik muayene.
6. Laboratuvar: tam kan, karaciğer, böbrek, elektrolitler, glukoz, TSH, B12, sifiliz, HIV.
7. EEG ve beyin MRG — ilk epizod veya atipik klinik tablo.
8. Postpartum bağlamda — tiroid fonksiyonu mutlaka.
9. İntihar ve çocuğa zarar riski değerlendirmesi (postpartum vakalarda).
10. İzlem — tanı süresine göre değişebilir (1 veya 3 aylık süre geçtiğinde).

6.4 Ayırıcı tanı

Bozukluk	**Ayırt edici belirtiler**
Şizofreni (6A20)	Devam ≥ 1 ay (ICD-11) / ≥ 6 ay (DSM-5-TR genel); rezidüel belirtiler.
Şizoaffektif bozukluk (6A21)	Afektif epizod psikotik semptomların anlamlı bir kısmında mevcut.
Şizofreniform bozukluk (DSM-5-TR F20.81)	DSM-5-TR'de 1–6 ay; ICD-11'de ayrı kod yok.
Bipolar I psikotik özelliklerle (6A60.x)	Manik epizod bağlamında.

Bozukluk	Ayırt edici belirtiler
Postpartum psikoz (6E20)	Doğumdan 4–6 hafta içinde; bebek öldürme ve anne intiharı yüksek riski — tıbbi acil.
Madde indüksiyonlu psikoz	Madde (kannabis, amfetamin, halüsinojen) ile açık zaman ilişkisi; toksikolojik tarama.
İkincil psikoz (6E61)	Organik nedenle (otoimmün ensefalit, lupus, paraneoplastik, ensefalit) ilişkili.
Deliryum	Bilinç değişikliği; dikkat fluktuasyonu; organik neden
Disosiyatif epizod	Travma bağlamında; sosyal izolasyon dominant.

7. Muayene ve değerlendirme

7.1 Klinik ölçekler

- PANSS, BPRS — psikotik şiddet.
- HAM-D, YMRS — afektif komponentlerin değerlendirilmesi.
- C-SSRS — intihar riski.
- GAF/PSP — işlevsel düzey.

7.2 Laboratuvar incelemeleri

İlk epizod psikoz protokolüne uygun (bkz. 6A20 §7.2):

- Mutlak: tam kan, karaciğer/böbrek, glukoz, elektrolitler, TSH, B12, folat, toksikolojik tarama, HIV, sifiliz, gebelik testi, prolaktin.
- Organik psikoz şüphesi varsa — anti-NMDA-R antikorları (BOS), ANA, lupus paneli, paraneoplastik antikor paneli, amonyak, seruloplazmin.
- Postpartum bağlamda — TSH (postpartum hipotiroidi mümkündür).

7.3 Enstrümantal incelemeler

- Beyin MRG — ilk epizodda önerilir (NICE CG178); özellikle atipik prezentasyon veya nörolojik belirtiler.
- EEG — tutmalar istisnası, atipik klinik tablo.
- EKG — antipsikotik başlanmadan önce.

- Lomber ponksiyon — otoimmün ensefalit şüphesi (atipik psikoz + motor semptomlar + kadın yaşıt).

8. Tedavi

8.1 Genel prensipler

1. Acil değerlendirme ve gerektiğinde hastaneye yatış — hastanın veya başkalarının güvenliği için.
2. Birinci sıra: atipik antipsikotik düşük dozda — risperidon 1–4 mg, olanzapin 5–15 mg, ketiapin 200–600 mg, aripiprazol 5–15 mg.
3. Akut ajitasyonda — oral lorazepam 1–2 mg + olanzapin oral dağılan 5–10 mg; intramüsküler — olanzapin 10 mg im veya aripiprazol 9,75 mg im, gerekirse haloperidol 5 mg + lorazepam 2 mg im (klasik).
4. Süre — antipsikotik tipik 3–6 ay (remisyondan sonra), ardından kademeli azaltma ve izlem; ilk epizod temelli kesme standart değildir — bireysel değerlendirme.
5. Stres-induksiyonlu bağlamda — psikososyal destek, BDT-temelli stres yönetimi.
6. Postpartum başlangıçta — tıbbi acil durum olarak; çocuk öldürme ve intihar riski yüksektir; hastaneye yatış, anne-bebek ortak yatış koşulları varsa tercih edilir; bkz. 6E20 bölümü.
7. EKT — refrakter ağır vakalarda, katatonik özelliklerle, gebelikte en güvenli seçenek.
8. Uzun süreli izlem — %30–50 hasta uzun süreli psikotik bozukluğa geçer; ilk yıl aylık, sonra üç aylık.

8.2 Tedavi metodolojileri

1. Erken Müdahale Hizmetleri (EIP — Early Intervention in Psychosis) — İlk psikotik epizod için multidisipliner bakım 3 yıl boyunca — düşük doz farmakoterapi, BDTp, aile müdahalesi, istihdam desteği. RAISE (Kane J.M. et al. Am J Psychiatry 2016) RKÇ. Akut ve geçici hastalar da EIP programlarına dahil edilir.
2. Psikoz için Bilişsel-Davranışçı Terapi (BDTp / CBTp — Cognitive Behavioural Therapy for psychosis) — Psikotik semptomları "düşünce–duygu–davranış" formülasyonunda yeniden değerlendirme. NICE CG178 §1.3.7.1.
3. Aile Psikoeğitimi (Family Psychoeducation) — Hastanın epizod sonrası desteği, nüks erken belirteçlerinin tanınması, aile iletişim eğitimi. Pharoah Cochrane 2010.

4. Elektrokonvulsif Terapi (EKT — Electroconvulsive Therapy) — Katatonik özelliklerle, ağır farmakoterapi yanıtsızlığında, gebelikte. NICE TA59. UK ECT Review Group Lancet 2003.
5. PANSS, BPRS — psikotik şiddetin standardize değerlendirilmesi.

8.3 Kaynaklar arasındaki farklar

- NICE CG178 (Psychosis): ilk epizod psikoz kuralları — atipik antipsikotik düşük dozda birinci sıra; erken müdahale hizmetleri (EIP) katılım; psikososyal müdahale birlikte.
- APA Practice Guideline 2021 (Schizophrenia): akut ve geçici psikotik bozukluk için spesifik algoritma yoktur; ilk epizod psikoz prensipleri.
- NICE CG192 (Antenatal and postnatal mental health): postnatal psikoz tıbbi acil — hastaneye yatış, atipik antipsikotik + benzodiazepin, EKT refrakter vakalarda.

9. Prognoz

İyi prognoz faktörleri

- Çok hızlı başlangıç ve kısa süre.
- Net stres tetikleyicisi.
- Premorbid iyi fonksiyonel seviye.
- Afektif komponentin varlığı.
- Polimorf semptomatoloji (şizofreni semptomları olmadan).
- Ailede psikotik öykü olmaması.
- Kannabis veya diğer madde kullanımı olmaması.

Kötü prognoz etkenleri

- Şizofreni benzeri semptomlar (Şneider I. derece).
- Stres tetikleyicisinin olmaması.
- Kademeli başlangıç.
- Premorbid fonksiyonel zayıflık.
- Aile öyküsünde şizofreni.
- Madde kullanımı.

İzlem hedefleri

- Uzun süreli izlem kritiktir — %30–50 şizofreni, şizoaffektif veya bipolar bozukluğa geçer; ilk yıl aylık, sonra üç aylık resmi izlem.

- Relaps belirteçlerinin tanınması (uyku bozukluğu, sosyal geri çekilme, tuhaf deneyimler).
- Antipsikotik dozun kademeli azaltılması ve kesilmesi — bireysel karar (nüks riski vs yan etki)
- Komorbid madde kullanımı ve travma müdahalesi.
- Postpartum vakalarda — sonraki gebeliklerde nüks riski yüksektir, profilaktik tedavi planlanır.

10. Mit ve yanlış inançlar

10.1 Etiyoloji ve kavramsal mitler

Mit 1: "Akut ve geçici psikoz 'sadece psikolojik bir çöküş'tür, bireysel güce bağlıdır"

Neden yaygınlaştı: stres ile zaman ilişkisi ve kısa süreli başlangıç "psikolojik" açıklamayı destekler görünür.

Klinik ve biyolojik mantık: stres tetikleyici faktördür, ancak tek başına açıklama değil — tüm stresli insanlar psikoz geçirmez. Genetik ve nörobiyolojik yatkınlık mevcuttur. Castagnini 2013 kanıtı — hastaların %30–50'si şizofreni, şizoaffektif veya bipolar bozukluk geçirir; bu, nörobiyolojik yatkınlığı gösterir.

Gerçek klinik adım: stres yönetimi ve psikoterapötik destek önemlidir, ancak antipsikotik tedavi ertelenmemelidir.

Mit 2: "Akut psikoz mutlaka postpartum psikoz kadar tehlikelidir / hayır, her zaman kendiliğinden geçer"

Klinik mantık: her akut psikotik epizod acil tıbbi değerlendirmeyi hak eder. Postpartum başlangıçta risk özellikle yüksektir (çocuk öldürme ~%4, anne intiharı). Postpartum olmayan akut geçici epizodda da intihar ve şiddet riski mevcuttur — hastanın hezeyan içeriği ve davranış kontrolü değerlendirilmelidir.

Mit 3: "Stres faktörünün varlığı tanı için şarttır"

Kanıt: DSM-IV "Brief Reactive Psychosis"de stres faktörü ölçüttü, ancak DSM-5-TR ve ICD-11'de ölçüt değil, kalifikatördür — stresli olmayan akut psikotik epizodlar da tanısal olarak mümkündür.

10.2 Yanlış tedavi yaklaşımları

Mit 4: “Akut psikoz kendi kendine geçer, tedavi ertelenebilir”

Klinik mantık ve kanıt: Marshall M. et al. Arch Gen Psychiatry 2005 — tedavi edilmemiş psikoz süresi (DUP) uzadıkça uzun vadeli prognoz kötüleşir. Geçici olarak kabul edilen bir epizodda bile erken antipsikotik müdahale, semptomların kısaltılması ve komplikasyonların azaltılması için önemlidir.

Mit 5: “Akut psikotik hasta yalnız bırakılabilir — kendini kontrol edebilir”

Kanıt: akut psikotik epizodda hastanın realite testi bozulmuş, öz bakım, gıda ve su alımı, kişisel güvenlik sağlanamaz. Hastaneye yatış veya 24/7 gözetim çoğu durumda gereklidir.

Mit 6: “Akut geçici psikozda ekzorsizm veya dini ritüel antipsikotiğin yerini alabilir”

Kanıt: Şizofrenideki gibi — DUP uzadıkça prognoz kötüleşir; dini-kültürel destek paralel olabilir, ancak antipsikotik tedavinin yerini almaz.

10.3 Etkisiz veya zararlı yaklaşımlar

Mit 7: “Akut psikoz ‘spiritüel acil durum’ veya 'yüksek bilince geçiş'tir, tedavi zararlıdır”

Neden yaygınlaştı: Stan Grof ve “transpersonal psikoloji” akımı — psikotik deneyimleri “ruhani uyanış” olarak yeniden yorumlar.

Klinik mantık ve kanıt: bu yaklaşım modern klinik pratikte ve kanıta dayalı psikiyatride kabul edilmez. Psikotik semptomlar hastada gerçek sıkıntı yaratır ve risk altına sokar; tedaviden kaçınmanın klinik sonucu kötüdür (DUP uzaması).

Mit 8: “Kannabis akut psikotik epizodu sakinleştirebilir”

Kanıt: Kannabis psikoz tetikleyicisi veya kötüleştiricisidir — sakinleştirici etki illüzyoniktir, dolaylı olarak semptomları şiddetlendirir; klinik pratikte eşlik eden madde.

Mit 9: “Vitamin, omega-3, valerian, St John's Wort akut psikozda etkilidir”

Kanıt: bu tamamlayıcı müdahaleler akut psikotik epizodda etki kanıtlamamıştır; St John's Wort sitokrom P450 indüksiyonu ile antipsikotiklerin seviyesini düşürür (etkileşim).

Mit 10: "Hipnoterapi veya psikanalitik derin terapi akut psikozda kullanılabilir"

Kanıt: akut psikotik epizodda derin psikanalitik müdahale hastayı dezorganize edebilir; bu aşamada destekleyici terapi, yapı ve güvenlik önemlidir, derin müdahale yok.

11. Kaynaklar

1. WHO. ICD-11 for Mortality and Morbidity Statistics. 6A23 Acute and transient psychotic disorder. 2024.
2. American Psychiatric Association. DSM-5-TR. Washington DC: APA Publishing; 2022.
3. NICE Clinical Guideline 178. Psychosis and schizophrenia in adults: prevention and management. 2014, 2019 update.
4. NICE Clinical Guideline 192. Antenatal and postnatal mental health: clinical management and service guidance. 2014, 2018 update.
5. American Psychiatric Association. Practice Guideline for the Treatment of Patients with Schizophrenia, 3rd ed. 2021.
6. Castagnini A., Berrios G.E. Acute and transient psychotic disorders (ICD-10 F23): a review from a European perspective. Curr Psychiatry Rep 2009;11(4):237–247.
7. Castagnini A., Bertelsen A., Berrios G.E. Diagnosis of acute and transient psychotic disorders 12 years after admission: a follow-up study. Schizophr Res 2013;143(1):198–203.
8. Susser E., Wanderling J. Epidemiology of nonaffective acute remitting psychosis vs schizophrenia. Soc Psychiatry Psychiatr Epidemiol 1998;33(10):485–490.
9. Marshall M., Lewis S., Lockwood A. et al. Association between duration of untreated psychosis and outcome. Arch Gen Psychiatry 2005;62(9):975–983.
10. Kane J.M., Robinson D.G., Schooler N.R. et al. Comprehensive versus usual community care for first-episode psychosis (RAISE). Am J Psychiatry 2016;173(4):362–372.
11. NICE Technology Appraisal 59. Guidance on the use of electroconvulsive therapy. 2003 (reviewed).

ICD-11 **6A24**	**6A24 SANRILI BOZUKLUK** **Delusional disorder**
ICD-10 F22	Persistan deluzyonel bozukluklar
DSM-5-TR F22	Sanrılı Bozukluk

1. Tanım ve nozoloji

Sanrılı bozukluk (ICD-11: 6A24 Delusional Disorder; DSM-5-TR: F22) — en az bir aylık sürede bir veya daha fazla sanrının hâkim olduğu, ancak tam şizofreni kriterlerine ulaşmayan psikotik bozukluktur. Hastanın genel davranışı ve işlevsel düzeyi, sanrı dışında nispeten korunur.

2. Tarihçe

- Kraepelin (1899) — paranoya — sistematize sanrı, halüsinasyon olmadan.
- Esquirol J.E. (1810'lar) — "monomani" terimi; Kahlbaum K. (1863) ve Krafft-Ebing R. — paranoyanın klinik tanımı.
- DSM-III-R (1987) — "Sanrısal Bozukluk" resmi tanı olarak belirlendi; Kraepelin paranoya kavramının devam ettiricisi.
- ICD-11 (2019): garip (bizarre) sanrılara da izin verilir (ICD-10'da yalnız non-bizarre); indüklenmiş sanrı (folie à deux) ayrı bir alt tip olarak entegre edilmiştir.

3. Epidemiyoloji

- Yaşam boyu yaygınlık: ~%0,2 (Perälä 2007).
- Başlangıç: orta yaş (35–55 yaş), şizofreniden anlamlı derecede geç.
- Cinsiyet: yaklaşık eşit; bazı alt tiplerde farklılıklar (erotomani kadınlarda).
- Komorbidite: depresyon, anksiyete, sosyal izolasyon; yüksek intihar riski.

4. Etiyoloji ve patogenez

- Genetik yük şizofreniden az; ancak aile öyküsünde paranoid kişilik ve psikotik bozukluk yoğunluğu artmıştır.

- Duyusal yoksunluk (işitme bozukluğu) — yaşlılarda paranoid sanrı riskini artırır.
- Sosyal izolasyon, göç, dil engelleri — risk faktörleri.
- Nörobiyolojik — dopaminerjik disregülasyon, ancak şizofreniden daha lokalize; bazı çalışmalarda striatal dopamin sentezinde artış (Howes O.D. derlemeleri).

5. Klinik özellikler

Alt tipler (sanrı içeriğine göre)

- Takip (persekütör): En yoğun — başkaları tarafından izlenme, zarar planlaması.
- Kıskançlık (Othello sendromu): eşin sadakatsizliğine ilişkin sanrı; suç riski yüksek.
- Erotomanik (Clérambault sendromu): başka bir kişinin (genellikle yüksek statülü) hastayı sevdiğine inanç.
- Büyüklük (grandiyoz): özel yetenek, üstün zeka, keşif, dini misyon.
- Somatik: vücudunda parazit (Ekbom sendromu), koku yayma, deformasyon inancı.
- Karışık ve non-spesifik.

Fonksiyonel idame

Sanrı dışında hastanın genel davranışı, affekt, bilişsel işlevler nispeten korunur; iş ve ilişkiler sanrı içeriğine dokunulmadıkça devam edebilir.

6. Tanı

6.1 Birleşik tanı ölçütleri (DSM-5-TR · ICD-11)

A. Bir veya daha fazla sanrının sürmesi: ICD-11 — en az 3 ay (genellikle daha uzun), DSM-5-TR — en az 1 ay.

B. Şizofreni A kriterine ulaşmama (sanrı tek veya baskın semptom; varsanı minimal ve sanrı içeriğiyle ilişkili olduğunda mümkündür).

C. Sanrının doğrudan etkisi olmayan işlevsel korunma; davranış garip değil.

D. Afektif epizod mevcutsa, sanrı döneminin küçük bir kısmında.

E. Madde veya organik neden dışlaması.

6.2 Kaynaklar arasındaki farklar

- ICD-11: garip (bizarre) sanrılara izin (DSM-5-TR'de de yasak kaldırılmıştır); indüklenmiş sanrı (folie à deux) 6A24'e entegre.
- DSM-5-TR: alt-tip nitelendiricileri (erotomanik, grandiyöz, kıskançlık, persekütör, somatik, karışık, nonspesifik); "bizar tipi" ek nitelendirici.

6.3 Tanı algoritması

1. Klinik görüşme (genel ve özellikle sanrı içeriği).
2. Akraba/arkadaş görüşmesi — premorbid işlev, sanrının başlangıcı.
3. SCID-5 / MINI; PANSS / BPRS pozitif semptom alt-ölçeği.
4. Tıbbi ve nörolojik muayene.
5. Toksikolojik tarama; duyusal (işitme, görme) test — yaşlılarda zorunlu.
6. Beyin MRG (ilk epizodda).
7. Komorbid depresyon ve intihar riski değerlendirmesi.

6.4 Ayırıcı tanı

Bozukluk	**Ayırt edici belirtiler**
Şizofreni (6A20)	Halüsinasyon, dağınık konuşma, negatif semptomlar dominant; işlevde belirgin bozulma.
Şizoaffektif bozukluk (6A21)	Afektif epizod psikotik semptomların önemli bir kısmında.
Beden dismorfik bozukluk (6B21)	Görünüm temelli; içgörü düzeyi değişken, ancak sanrı düzeyinde olabilir.
OKB — zayıf içgörü ile (6B20)	Ego-distonik obsesyon esas; sanrıdan ayırt edilir.
Paranoid kişilik bozukluğu	Sürekli şüphecilik kişilik özelliği olarak; tam sanrı yok.
İkincil sanrı (6E61)	Organik neden — demans, beyin tümörü, lupus, ensefalit.
Madde indüksiyonlu (özellikle amfetamin, kokain)	Madde kullanımı veya kesilme bağlamında; eliminasyon sonrası remisyon.

7. Muayene ve değerlendirme

- PANSS / BPRS pozitif semptom alt ölçeği; spesifik sanrı içeriğinin yapılandırılmış dokümantasyonu.
- İşitme ve görme testi (yaşlılarda mutlaka).
- Laboratuvar: tam kan, tiroid, B12, karaciğer, glukoz, toksikolojik tarama, sifiliz, HIV, ANA (lupus), seruloplazmin (Wilson).
- Beyin MRG — ilk epizod, atipik klinik, yaşlı hasta.
- İntihar ve şiddet riski değerlendirmesi (C-SSRS, özellikle kıskançlık hezeyanında).

8. Tedavi

1. Atipik antipsikotik düşük dozda (risperidon 1–3 mg, olanzapin 5–10 mg, aripiprazol 5–15 mg) — birinci sıra. Kanıt temeli şizofreniden az; hastaların adherensi sorunlu (sanrı içeriğine göre).
2. Pimozid tarihsel olarak erotomani ve somatik sanrıda üstün kabul edilirdi (Munro A. çalışmaları), ancak modern pratikte atipiklere kıyasla daha az kullanılır (QTc, EPS).
3. Psikoterapi — destekleyici terapi, terapötik ittifak kurma; BDT (sanrı içeriği ile yüzleşmeyen çalışma, alternatif açıklamaların araştırılması).
4. Komorbid depresyon — SSRI.
5. Şiddet veya intihar riski (özellikle kıskançlık sanrısı) — yatış ve istemsiz tedavi yasal çerçevede.
6. Duyusal bozukluk — işitme cihazları veya göz düzeltmesi — yaşlı paranoid sanrıda bazen köklü etki gösterir.
7. Sosyal destek — izolasyonun azaltılması; aile psikoeğitimi.

8.1 Tedavi metodolojileri

1. Konfrontasyon içermeyen BDT — Sanrı içeriğini açıkça inkar etmeden, alternatif açıklamaları ve kanıtları hastayla birlikte araştırma. Birchwood M., Trower P. araştırmaları — şizofreni ve sanrı bozukluğunda etkili.
2. Destekleyici terapi ve terapötik ittifak — Hastayla uzun süreli güvenli ilişki kurma; adezyonun güçlendirilmesi.
3. PANSS pozitif semptom alt ölçeği — Sanrının şiddet ve müdahale derecesinin standartlaştırılmış değerlendirmesi.
4. Columbia İntihar Şiddet Derecelendirme Ölçeği (C-SSRS — Columbia-Suicide Severity Rating Scale) — İntihar riski — özellikle kıskançlık ve takip sanrılarında şiddet riski ek olarak değerlendirilir.

8.2 Kaynaklar arasındaki farklar

- NICE CG178 — sanrısal bozukluk için ayrı bir algoritma yok; genel psikoz ilkeleri.
- APA 2021 — antipsikotik birinci sıra; içgörü ve uyum zorluğu vurgulanır.
- Munro A. derlemeleri (Cambridge Univ Press 1999) — alt-tip-spesifik klinik öneri.

9. Prognoz

- Prognoz şizofreniden daha iyidir — işlevsel koruma, geç başlangıç.
- Adherens temel kısıtlılıktır.
- Kıskançlık ve somatik sayıklama nispeten daha zor tedavi.
- Yaşlılarda duyusal koreksiyon ile iyileşme mümkündür.
- İzlem — antipsikotik yan etkileri, sanrı şiddeti, şiddet ve intihar riski.

10. Mit ve yanlış inançlar

Mit 1: "Hastayı hezeyanının yanlışlığına ikna etmek gerekir"

Klinik mantık: açık yüzleştirme terapötik ittifakı bozar ve sanrıyı güçlendirebilir; hastada "doktor da bana karşı" şeklinde bir açıklama oluşur.

Kanıt: Birchwood ve Trower BDT yaklaşımları — alternatif açıklamaların hasta tarafından araştırılmasına izin veren yüzleşmeyen yaklaşım etkilidir.

Mit 2: "Sanrısal bozukluk yalnızca psikoterapi ile tedavi edilebilir, antipsikotik gereksizdir"

Kanıt: antipsikotik birinci basamak farmakoterapidir; psikoterapi tek başına yeterli değildir. APA 2021, NICE CG178.

Mit 3: "Erotomani yalnızca kadın hastalığıdır, erkeklerde yoktur"

Kanıt: Erotomani her iki cinsiyette görülür; erkek hastalarda daha yüksek şiddet riski kaydedilmiştir (Menzies R.P. et al. Br J Psychiatry 1995).

Mit 4: "Kıskançlık sanrısı 'büyük aşk' göstergesidir, tıbbi bir durum değildir"

Kanıt: Othello sendromu klinik psikotik durumdur, partnere karşı şiddet ve cinayet riski yüksektir; aktif tıbbi müdahale gerektirir.

Mit 5: “Yaşlılarda paranoid kuruntu 'normal yaşlanma'dır”

Kanıt: yaşlılarda paranoid sanrı sıklıkla duyusal yoksunluk (işitme bozukluğu) veya erken demans belirtecidir; tedavi edilebilir. İşitme cihazı veya görme düzeltmesi bazen belirgin iyileşme sağlar.

Mit 6: “Ekzorsizm veya dini müdahale sanrıyı iyileştirir”

Kanıt: psikotik semptomlar nörobiyolojik temellidir; antipsikotik tedaviyi geciktirir.

Mit 7: “Sanrılı hastayı izole etmek gerekir — sosyal ilişki zararlıdır”

Kanıt: Sosyal izolasyon tersine sanrıyı güçlendirir; sosyal destek ve psikoterapi önerilir.

11. Kaynaklar

1. WHO. ICD-11. 6A24 Delusional disorder. 2024.
2. APA. DSM-5-TR. 2022.
3. NICE CG178. Psychosis and schizophrenia in adults. 2014/2019.
4. APA. Practice Guideline for Schizophrenia, 3rd ed. 2021.
5. Munro A. Delusional Disorder: Paranoia and Related Illnesses. Cambridge University Press; 1999.
6. Perälä J. et al. Arch Gen Psychiatry 2007;64(1):19–28.
7. Menzies R.P., Fedoroff J.P., Green C.M., Isaacson K. Prediction of dangerous behaviour in male erotomania. Br J Psychiatry 1995;166(4):529–536.
8. Howes O.D., Kapur S. Schizophr Bull 2009;35(3):549–562.
9. Trower P., Birchwood M., Meaden A. et al. Cognitive therapy for command hallucinations: randomised controlled trial. Br J Psychiatry 2004;184:312–320.

ICD-11 **6A25**	**6A25 PRİMER PSİKOTİK BOZUKLUKLARIN BELİRTİSEL GÖRÜNÜMLERİ** **Symptomatic manifestations of primary psychotic disorders**
ICD-10 —	ICD-10'da karşılığı yoktur
DSM-5-TR F29	Tanımlanmamış Şizofreni Açılımı Kapsamında ve Psikozla Giden Diğer Bozukluk

1. Tanım ve nozoloji

6A25 ICD-11'de birincil psikotik bozukluklar grubunun (6A20–6A24) dimensional alt-yapısıdır. Ayrı bir klinik nozolojik birim değildir — tanı ana bozukluğun (örneğin, 6A20 Şizofreni) üzerine ek niteleyici olarak konur. Altı semptom alanının her biri için ayrı şiddet derecesi (yok / hafif / orta / ağır) değerlendirilir.

Konseptin temeli — psikotik bozuklukların heterojen klinik sunumunu klasik alt tipler (paranoid, hebefrenik, katatonik) yerine daha geçerli ve değişken bir ölçüm aracıyla tanımlamak.

2. Tarihçe

- Bleuler "4A" semptomları (1911) ve Şneyder "1. derece semptomlar" (1959) — kategorik yaklaşım.
- Crow T.J. (1980) — Tip I (pozitif semptom dominant) ve Tip II (negatif dominant) konsepti — boyutsal yaklaşımın temeli.
- Liddle P.F. (1987) — üç boyutlu faktör — reality distortion, disorganization, psikomotor poverty.
- DSM-5 (2013) — Bölüm III araştırma kategorisinde boyutsal değerlendirme önerilmiştir.
- ICD-11 (2019) — 6A25 resmi boyutsal niteleyici olarak entegre edilmiştir.

3. Altı semptom alanı

3.1 Pozitif semptomlar

Sanrı, halüsinasyon — algı ve düşünce süreçlerinde "artmış/ek" belirtiler. Şiddet: yokluğundan ağır düzeye kadar (hastanın günlük işlevselliğine etki derecesine göre).

3.2 Negatif semptomlar

Afektif küntlük, avolüsyon (motivasyon kaybı), aloji (konuşma yoksullaşması), anhedoni, sosyal geri çekilme. Fonksiyonel bozulmanın temel nedenidir; farmakoterapiye zayıf yanıt verir.

3.3 Depresif semptomlar

Düşük duygudurum, umutsuzluk, intihar düşünceleri, psikomotor yavaşlama, anhedoni (negatif semptomdan farklı olarak duygusal bileşen dominant).

3.4 Manik semptomlar

Yüksek veya irritabl duygudurum, hızlı düşünme, grandiyöz düşünceler, azalmış uyku ihtiyacı, hızlı konuşma, psikomotor stimülasyon.

3.5 Psikomotor semptomlar

Katatonik bileşenler (mutizm, negativizm, balmumu esnekliği, postür alma), ajitasyon, yavaşlama, stereotipi.

3.6 Kognitif semptomlar

İşler bellek, dikkat, yürütücü işlev, işlem hızı, sosyal biliş. Hastaların %75–85'inde mevcuttur; uzun vadeli işlevsel düzeye güçlü etki.

4. Klinik kullanım

4.1 Değerlendirme araçları

- PANSS (pozitif, negatif, genel psikopatoloji alt ölçekleri).
- SANS / SAPS — negatif ve pozitif semptomlar ayrı ayrı.
- HAM-D, MADRS — depresif komponent.
- YMRS — manik bileşen.
- Bush-Francis Katatoni Derecelendirme Ölçeği — psikomotor bileşen.
- MATRICS Consensus Cognitive Battery (MCCB) — bilişsel bileşen.

4.2 Tedavi uygulamaları

- Pozitif semptom dominant — standart antipsikotik (D2 antagonisti).
- Negatif semptom dominant — atipik antipsikotik üstün (klozapin, kariprazin); amisülpirid düşük dozda; psikososyal rehabilitasyon.
- Depresif komponent — adjunkt SSRI (sertralin) veya antidepresan; intihar riski izlemi.
- Manik komponent — duygudurum dengeleyici (lityum, valproat) adjunkt; şizoaffektif bozukluk olarak yeniden değerlendirme.
- Katatonik komponent — lorazepam testi veya EKT.
- Kognitif komponent — bilişsel iyileştirme (Wykes 2011 meta-analizi); destekli istihdam ile birlikte uygulandığında işlevsel düzeye etki.

5. Kaynaklar arasındaki farklar

- ICD-11 (6A25): her domain için şiddet derecesi hastalık seyrinde değiştiği için periyodik yeniden değerlendirme önerilir.
- DSM-5-TR: Section III araştırma kategorisinde "Clinician-Rated Dimensions of Psychosis Symptom Severity" — ICD-11 6A25 ile paralel; resmi tanısal kalifikatör değil, ancak pratikte kullanılabilir.
- NICE CG178: boyutsal değerlendirme klinik yaklaşım olarak önerilir — tedavinin bireyselleştirilmesinin temeli.

6. Mit ve yanlış inançlar

Mit 1: "6A25 ayrı bir bozukluktur, tanı olarak konulabilir"

Gerçeklik: 6A25 ayrı bir klinik birim değildir — temel bozukluğun (6A20–6A24) kalifikatörüdür.

Mit 2: "Boyutsal yaklaşım kategorik tanının yerine geçer"

Gerçeklik: ikisi tamamlayıcıdır — kategorik tanı nozolojik birimi, boyutsal niteleyici ise spesifik klinik sunumu tanımlar.

Mit 3: "Negatif semptomlar antipsikotiğin yan etkisidir, 'gerçek' değil"

Gerçeklik: primer negatif semptomlar şizofreninin temel özelliğidir — antipsikotikten önce de gözlenir. Sekonder negatif semptomlar (sedasyon, EPS, depresyon, pozitif semptom etkisi) ayrıdır ve yönetilebilir.

7. Kaynaklar

1. WHO. ICD-11. 6A25 Symptomatic manifestations of primary psychotic disorders. 2024.
2. APA. DSM-5-TR. 2022.
3. NICE CG178. 2014/2019.
4. Crow T.J. Molecular pathology of schizophrenia: more than one disease process? Br Med J 1980;280(6207):66–68.
5. Liddle P.F. The symptoms of chronic schizophrenia. A re-examination of the positive-negative dichotomy. Br J Psychiatry 1987;151:145–151.
6. Kay S.R., Fiszbein A., Opler L.A. PANSS. Schizophr Bull 1987;13(2):261–276.
7. Wykes T. ve ark. Am J Psychiatry 2011;168(5):472–485.

6A40 KATATONİ

Catatonia

ICD-11 **6A40**	**6A40 DİĞER BİR RUHSAL BOZUKLUKLA İLİŞKİLİ KATATONİ** **Catatonia associated with another mental disorder**
ICD-10 F06.1	Organik katatonik bozukluk
DSM-5-TR F06.1	Başka Bir Ruhsal Bozukluğa Eşlik Eden Katatoni

1. Tanım ve nozoloji

Katatoni (ICD-11: 6A40 Catatonia Associated with Another Mental Disorder; 6A41 Catatonia Induced by Substances or Medications; 6E69 Sekonder Katatoni Sendromu; DSM-5-TR: F06.1 Katatoni) — psikomotor, davranış ve otonom fonksiyonlarda kompleks bozulma sendromudur. Bağımsız bir bozukluk değil — başka bir psikiyatrik veya tıbbi durum zemininde klinik sendromdur.

DSM-5-TR'de katatoni artık Şizofreninin alt tipi değildir (iptal edilmiştir); afektif bozukluklar, nörogelişimsel bozukluklar, organik durumlar ve madde indüksiyonlu bağlamda kodlanabilir.

2. Tarihçe

- Kahlbaum K. (1874) — Katatoni veya Gerilim Çılgınlığı — katatoni ayrı bir sendrom olarak.
- Kraepelin (1899) — katatoninin “dementia praecox” alt tipi olarak entegrasyonu.
- Bleuler (1911) — şizofreni kategorisinde korunmuştur.
- 1970–1980'ler — Taylor, Fink — katatoninin afektif bozukluklarda da yaygınlığı ve genel bir sendrom olarak yeniden onaylanması.
- DSM-5 (2013) ve ICD-11 (2019) — katatoninin transnozolojik sendrom olarak resmileştirilmesi; şizofreni alt tipi statüsünün kaldırılması.

3. Epidemiyoloji

- Psikiyatri hastanesinde kabul edilen hastaların %7–15'inde katatonik semptomlar (Fink M., Taylor M.A. Catatonia 2003).
- Afektif bozukluklarda (özellikle bipolar manik ve depresif epizodlarda) katatoni yaygınlığı en fazladır.
- Şizofrenide %10–20 hasta gidiş boyunca katatonik özellikler gösterir.
- Organik katatoni — otoimmün ensefalit (özellikle anti-NMDA-R, anti-LGI1), elektrolit bozuklukları, üremik ve hepatik ensefalopati, sepsis, nörosifiliz, nöromüsküler hastalıklar bağlamında.
- Nöroleptik Malign Sendrom (NMS) ile sürekli klinik örtüşme — bazı araştırmacılar onları aynı spektrum olarak kabul eder.

4. Etiyoloji ve patogenez

- GABA-erjik sistem hipofonksiyonu — lorazepamın çok hızlı klinik etkisi (saatler) bunu destekler; GABA-A reseptör disfonksiyonu merkezi mekanizma.
- Dopamin disregülasyonu — nöroleptik kaynaklı katatoni ve NMS spektrumunda; antipsikotik kesilmesi kolinerjik ve adrenerjik rebound.
- Glutamat NMDA disregülasyonu — otoimmün anti-NMDA-R ensefalit klasik katatonik prezentasyon verir.
- Genetik — afektif bozukluklarla ilişkili yatkınlık.

5. Klinik özellikler

DSM-5-TR kriterleri — 12 semptomdan en az 3'ü:

1. Stupor — psikomotor aktivite yokluğu, çevreye yanıtsızlık.
2. Katalepsi — pasif indüksiyona karşı duruşun sürdürülmesi.
3. Mumsu fleksibilite — muayene eden tarafından indüklenen duruş “balmumu” gibi korunur.
4. Mutizm — konuşma yokluğu veya belirgin azalma.
5. Negativizm — talimatlara veya dış uyaranlara karşı muhalefet.
6. Posturing — istemsiz spontan duruşun sürdürülmesi (gravitasyona karşı).
7. Manerizm — sıradan davranışların tuhaf karikatürü.
8. Stereotipi — amaçsız yineleyici hareketler.
9. Ajitasyon — dış uyarandan bağımsız.
10. Grimas — yüz kas ifadeleri.

11. Ekolali — başkasının konuşmasının tekrarlanması.
12. Ekopraksi — başkasının hareketlerinin tekrarlanması.

Ağırlık formları

- Retarde (stuporoz) katatoni — motor azalma, mutizm dominant; çoğu vaka.
- Eksite (manik) katatoni — yüksek ajitasyon, otonom bozulma, hipertermi.
- Malign katatoni — eksite form ile hipertermi, otonomik dengesizlik, CPK yüksek, mortalite riski — NMS ile örtüşür; acil tıbbi durum.

6. Tanı

6.1 Birleşik tanı ölçütleri

DSM-5-TR'de 12 belirtiden ≥ 3'ü; ICD-11'de farklı kategorilerde aynı klinik belirtiler.

6.2 Tanı testleri

- Lorazepam provokasyon testi: 1–2 mg IV/IM lorazepam → 10–30 dk içinde katatonik belirtilerin anlamlı azalması tanıyı doğrular (Bush G. et al. Acta Psychiatr Scand 1996).
- Bush-Francis Catatonia Rating Scale (BFCRS) — 23 maddelik standartlaştırılmış ölçek; ilk 14 madde tarama (≥ 2 belirti — pozitif).

6.3 Etyolojik araştırma (zorunlu)

1. Tam kan sayımı, karaciğer/böbrek, elektrolitler (Na, K, Ca, Mg, P), glukoz, amonyak, CPK, troponin, tiroid, B12.
2. Toksikoloji tarama.
3. Sifiliz, HIV.
4. Beyin MRG.
5. EEG — non-konvülsif status epileptikus istisnası.
6. Lomber ponksiyon — ensefalit / otoimmün ensefalit şüphesi (anti-NMDA-R, anti-LGI1 antikorları).
7. ANA, lupus paneli.

6.4 Ayırıcı tanı

Durum	Ayırt edici belirtiler
Nöroleptik Malign Sendrom (NMS)	Antipsikotik kullanımı öyküsü; hipertermi, rijidite, CPK çok yüksek; klinik örtüşme — bazıları aynı spektrum olarak değerlendirir
Serotonerjik sendrom	Serotonerjik preparat; hiperrefleksi, miyoklonus, hipertermi.
Non-convulsive status epilepticus	EEG — epileptik aktivite.
Akinetik mutizm (frontal lob bozukluğu)	Beyin MRG — frontal veya bilateral talamik patoloji.
Lokomotor bozukluklar (Parkinson, distoni)	Spesifik nörolojik belirtiler.
Otoimmün ensefalit	Anti-NMDA-R, anti-LGI1; BOS bulguları, MRG, EEG atipik.
Hipo/hipertireoid kriz	TSH, T4.

7. Muayene ve değerlendirme

- BFCRS — başlangıç göstergeleri ve izleme.
- Yukarıdaki laboratuvar ve enstrümantal incelemeler — etyolojik araştırma.
- Otonom fonksiyon (kan basıncı, nabız, sıcaklık, idrar çıkışı) — özellikle malign formda.
- Komorbid duygudurum bozukluğu ve psikotik semptom değerlendirmesi (sonra, hasta konuşabildiğinde).

8. Tedavi

8.1 Genel prensipler (BAP 2023 · Fink-Taylor protokolü)

1. Antipsikotikleri DURDUR — özellikle tipik ve yüksek D2 antagonisti (haloperidol, risperidon yüksek doz) — katatoniyi güçlendirebilir, malign forma dönüştürebilir.
2. Lorazepam birinci basamak — 1–2 mg IM/IV, başlangıç yanıtına göre titrasyon; tipik etkili doz 6–24 mg/gün; bazı hastalarda 30+ mg gerekir. ~%70–80 hasta yanıt verir (Sienaert P. et al. Front Psychiatry 2014 derleme).

3. EKT — refrakter vakalar (lorazepama yanıtsızlık 48–72 saatte), malign katatoni — birinci basamak, hayat kurtarıcı araç. NICE TA59 — katatonide güçlü öneri.
4. Etyolojik tedavi — paralel: eğer afektif bozukluk zemininde ise, duygudurum düzenleyici (lityum); şizofreni bağlamında — atipik antipsikotik (klozapin veya ketiapin daha az riskli) lorazepam ile birlikte dikkatle.
5. Otoimmün katatonide — immünoterapi (IV steroid, IVIG, plazmaferez, ikinci sıra rituksimab).
6. Destekleyici tedavi — hidrasyon, nütrisyon (NG tüpü gerekli), DVT profilaksisi, cilt bakımı, aspirasyon pnömonisi profilaksisi.
7. Malign katatonide — YBÜ; agresif hidrasyon, dantrolen, bromokriptin, EKT.

8.2 Tedavi metodolojileri

1. Bush-Francis Katatoni Derecelendirme Ölçeği (BFCRS — Bush-Francis Catatonia Rating Scale) — 23 maddelik ölçek; ilk 14 madde tarama (≥ 2 pozitif); 23 madde şiddet. Bush G. et al. Acta Psychiatr Scand 1996.
2. Lorazepam provokasyon testi — 1–2 mg IM/IV lorazepam uygulamasından 10–30 dk sonra katatonik belirtilerin azalması tanıyı doğrular ve terapi planını yönlendirir. Bush G. et al. 1996.
3. Elektrokonvulsif Terapi (EKT — Electroconvulsive Therapy) — Katatonide altın standart; UK ECT Review Group Lancet 2003 kanıt temeli; NICE TA59. Tipik 6–12 seans, bilateral hedef.
4. İmmünoterapi (otoimmün katatonide) — IV metilprednizolon 1 g/gün × 5 gün → IVIG ve/veya plazmaferez; refrakter durumlarda rituksimab, siklofosfamid. Graus F. et al. Lancet Neurol 2016 otoimmün ensefalit protokolü.

8.3 Kaynaklar arasındaki farklar

- BAP 2023 (British Association for Psychopharmacology) Catatonia Consensus Guidelines — lorazepam birinci basamak; EKT refrakter veya malign vakalarda; antipsikotik kullanımından kaçınma veya çok dikkatli.
- Fink M., Taylor M.A. Catatonia: A Clinician's Guide (2003) — klasik protokol; lorazepam testi ve yüksek doz lorazepam tedavisi.
- NICE TA59 — EKT katatonide açık öneri.

9. Prognoz

- Lorazepam ve/veya EKT'ye yanıt — hastaların çoğunluğunda günler-hafta içinde tam iyileşme.
- Etiyolojik bozukluk tedavi edilmezse nüks yüksek.
- Komplikasyonlar — uzun stupordan aspirasyon pnömonisi, DVT, dehidratasyon, deri ülserleri.
- Malign katatoni — tedavisiz mortalite tarihsel olarak ~%50+ (bazı serilerde %75–100); modern tedavi (benzodiazepin/EKT) ile ~%10–20'e düşer.
- İzlem — etyolojik bozukluk bağlamında; nüks belirteçlerinin tanınması.

10. Mit ve yanlış inançlar

Mit 1: "Katatoni şizofreninin alt tipidir"

Kanıt: DSM-5 (2013) ve ICD-11 (2019) — katatoni transnozolojik sendrom olarak; şizofreni alt-tip statüsü kaldırılmıştır. Duygudurum bozuklukları bağlamında daha sık (Fink & Taylor 2003).

Mit 2: "Katatonik hasta antipsikotikle tedavi edilmelidir"

Kanıt: antipsikotik katatoniyi güçlendirebilir ve malign forma dönüştürebilir. Birinci sıra — lorazepam, sonra EKT. Antipsikotik etiyolojik bozukluk için gerekliyse, lorazepamla birlikte dikkatle; atipik üstün (klozapin veya ketiapin).

Mit 3: "Katatonik hasta bilincini kaybetmiş veya komadadır"

Kanıt: Çoğu katatonik hasta çevreden tamamen haberdardır — mutizm ve psikomotor bozulma bilinç kaybı değildir. Hasta epizoddan sonra her şeyi hatırlar. Personel, hastanın yanında konuşurken dikkatli olmalıdır.

Mit 4: "Katatoni nadir veya tarihsel bir durumdur, modern psikiyatride yoktur"

Kanıt: psikiyatri hastanesinde kabul edilen hastaların %7–15'inde katatonik semptomlar (Fink & Taylor 2003); tanısı ise çoğu zaman konulmaz — az tanınan bir sendromdur.

Mit 5: "Lorazepam yalnızca sakinleştirir, 'gerçek' tedavi vermez"

Kanıt: lorazepam katatonik sendromun çekirdek mekanizmasına (GABA-erjik hipofonksiyona) yönelir; ~%70–80 hastada dramatik ve hızlı klinik iyileşme.

Mit 6: "EKT katatonide tehlikelidir ve eskimiştir"

Kanıt: EKT katatonide altın standart, NICE TA59 açık öneri; malign katatonide hayat kurtarır.

Mit 7: "Hastayı konuşmaya zorlamak gerekir — psikolojik bariyeri kırmak"

Kanıt: mutizm biyolojik kökenlidir, psikolojik "direnç" değildir; talep hastanın distressini artırır, terapötik faydalı değil.

11. Kaynaklar

1. WHO. ICD-11. 6A40 Catatonia. 2024.
2. APA. DSM-5-TR. 2022.
3. Rogers J.P., Pollak T.A., Begum N. et al. Catatonia: demographic, clinical and laboratory associations. Psychol Med 2023 (BAP Guidelines).
4. Fink M., Taylor M.A. Catatonia: A Clinician's Guide to Diagnosis and Treatment. Cambridge Univ Press; 2003.
5. Bush G., Fink M., Petrides G. et al. Catatonia. I. Rating scale and standardized examination. Acta Psychiatr Scand 1996;93(2):129–136.
6. Sienaert P., Dhossche D.M., Vancampfort D. et al. A clinical review of the treatment of catatonia. Front Psychiatry 2014;5:181.
7. Graus F. et al. A clinical approach to diagnosis of autoimmune encephalitis. Lancet Neurol 2016;15(4):391–404.
8. NICE TA59. Guidance on the use of electroconvulsive therapy. 2003 (reviewed).
9. UK ECT Review Group. Lancet 2003;361(9360):799–808.

6A60–6A7Z DUYGUDURUM BOZUKLUKLARI

Mood disorders

ICD-11 **6A60**	**6A60 BİPOLAR BOZUKLUK TİP I** **Bipolar type I disorder**
ICD-10 F31	Bipolar duygulanım bozukluğu
DSM-5-TR F31.1x	İkiuçlu (Bipolar) I Bozukluğu, O sıradaki ya da en son dönem manik

1. Tanım ve nozoloji

Bipolar bozukluk Tip I (ICD-11: 6A60; DSM-5-TR: F31.1x) — en az bir manik epizodla karakterize edilen, çoğu zaman depresif ve/veya hipomanik epizodlarla dönüşümlü olan tekrarlayıcı bir bozukluktur. Bir manik epizodun varlığı tanı için yeterlidir — depresif epizod gerekmez.

2. Tarihçe

- Falret J.P. (1854) — folie circulaire; Baillarger J. (1854) — folie à double forme.
- Kraepelin E. (1899) — manik-depresif delilik — şizofreniden (demans prekoks) ayrı bir birim.
- Leonhard K. (1957) — unipolar ve bipolar bozuklukları ilk kez ayırmıştır.
- DSM-III (1980) — “Bipolar Bozukluk” terimi.
- DSM-IV / DSM-5 (2013) / ICD-11 (2019) — Tip I (tam manik epizod) ve Tip II (hipomanik + major depresif) ayrımı.

3. Epidemiyoloji

- Yaşam boyu yaygınlık Tip I: ~%0,6–1 (Merikangas K.R. et al. Arch Gen Psychiatry 2011, WMH).
- Cinsiyet: yaklaşık eşit.

- Başlangıç: ortalama 20–25 yaş; aile öyküsü ile daha erken.
- İntihar riski: yaşam boyu %6–7; en yüksek genç ve ilk yıllarda.
- Komorbidite: anksiyete bozuklukları %60, madde kullanımı %40, DEHB, kişilik bozuklukları.
- Mortalite popülasyonla karşılaştırıldığında 2 kat yüksek — kardiyovasküler, intihar.

4. Etiyoloji ve patogenez

- Kalıtım %60–85 (Smoller J.W., Finn C.T. Am J Med Genet C Semin Med Genet 2003 ikiz meta-analiz).
- GWAS — 60+ risk lokusu (Mullins N. et al. Nat Genet 2021).
- Şizofreni ile geniş genetik örtüşme (Cross-Disorder Group 2013).
- Nörobiyolojik — monoaminerjik (dopamin, serotonin, noradrenalin) disregülasyon; sirkadiyen ritim bozukluğu; ikinci haberci (PI/cAMP) sisteminde bozulma; mitokondriyal disfonksiyon.
- Risk faktörleri — çocukluk travması, stres, uyku bozukluğu, kannabis, antidepresan indüksiyonu (bipolar yatkınlıkta).

5. Klinik özellikler

5.1 Manik epizod

- Anormal yüksek veya irritabl duygudurum + artmış enerji ≥ 7 gün (veya herhangi bir sürede hastaneye yatış gerektiğinde).
- Aşağıdakilerden ≥ 3 semptom (irritabl duygudurumda ≥ 4): şişirilmiş özsaygı, uyku ihtiyacında azalma, aşırı konuşkanlık, fikir uçuşmaları, dikkat dağınıklığı, amaçlı aktivite artışı, riskli davranışlar.
- İşlevsel bozulma veya hospitalizasyon talebi veya psikotik özellikler.

5.2 Major depresif epizod (bipolar bağlamda)

- Düşük duygudurum veya anhedoni + ≥ 5 semptom × 2 hafta (DSM-5-TR).
- Bipolar depresif epizod atipik özelliklerle (hipersomni, hiperfaji, leaden paralysis) daha sıktır — Tip II'ye benzer.

5.3 Karışık özellikler (mixed features)

DSM-5-TR'de alt tip kaldırılmıştır — niteleyici olarak: manik epizod sırasında ≥ 3 depresif semptom veya depresif epizod sırasında ≥ 3 manik semptom.

5.4 Hızlı döngü (rapid cycling)

≥ 4 epizod 12 ay içinde; kötü prognoz belirteci.

6. Tanı

6.1 Birleşik tanı ölçütleri (DSM-5-TR · ICD-11 konsensus noktaları)

A. En az bir manik epizod (yukarıdaki kriterler).

B. Manik ve depresif epizodlar şizoaffektif, şizofreni veya diğer psikotik bozuklukla daha iyi açıklanmaz.

Depresif ve hipomanik epizodlar Tip I tanısı için gerekli değildir, ancak tipik olarak mevcuttur.

6.2 Kaynaklar arasındaki farklar

- DSM-5-TR: mixed features niteleyicisi (DSM-IV mixed episode iptal edildi); enerji artışı manik epizod ölçütüne eklendi (DSM-IV'te yalnızca duygudurum).
- ICD-11 (6A60): manik epizod sayısı ve mevcut epizod tipine göre alt-niteleyiciler; hızlı döngü niteleyici olarak.
- NICE CG185: tanı yapılandırılmış görüşme ve aileden alınan bilgi ile desteklenir; antidepresanla tetiklenmiş hipomanik/manik epizod bipolar tanısına yol açar (DSM-5-TR'de kriter B niteleyicisi ile).

6.3 Tanı algoritması

1. Klinik görüşme + akraba/arkadaş bilgisi — manik ve hipomanik epizodları aile üyeleri daha kolay tanıyabilir.
2. Yapılandırılmış görüşme (SCID-5, MINI).
3. YMRS (Young Mania Rating Scale), HAM-D / MADRS.
4. MDQ (Mood Disorder Questionnaire) veya HCL-32 — bipolar tarama (öz değerlendirme).
5. Tıbbi muayene + laboratuvar (tiroid, karaciğer, böbrek, glukoz, toksikoloji); lityum başlanmadan önce spesifik testler.
6. Beyin MRG — ilk epizod psikoz veya atipik kontekst.
7. Komorbidite ve intihar riski (C-SSRS).

6.4 Ayırıcı tanı

Durum	Ayırt edici belirtiler
Bipolar Tip II (6A61)	Hiçbir zaman manik epizod yok; hipomanik + major depresif.
Siklotimik bozukluk (6A62)	≥ 2 yıl (1 yıl ergenler) eşik altı duygudurum değişiklikleri.
Majör Depresif Bozukluk (6A70/6A71)	Manik veya hipomanik epizod yok.
Şizoaffektif (6A21)	Afektif epizod dışındaki dönemlerde psikoz devam eder.
BPD (6D10.x)	Duygusal değişkenlik saatler-günler; kimlik bozukluğu.
DEHB (6A05)	Sürekli davranış modelleri, epizodik değil.
Hipertireoid	TSH azalması; titreme, kilo kaybı, taşikardi.
Madde indüksiyonlu (stimülan, kokain)	Madde anamnezi ve zaman ilişkisi.

7. Muayene ve değerlendirme

- YMRS, HAM-D / MADRS, MDQ, HCL-32, C-SSRS.
- Lityum öncesi: tam kan, kreatinin, TSH, kalsiyum, EKG, gebelik testi.
- Valproat öncesi: tam kan, karaciğer fonksiyonu, gebelik testi (kadın doğurganlık yaşında — kesin önerilmez).
- Karbamazepin öncesi: tam kan, karaciğer, sodyum.
- Beyin MRG — ilk psikotik epizod.

8. Tedavi

8.1 Genel Prensipler (NICE CG185 · CANMAT/ISBD 2018 · APA · WFSBP konsensüsü)

1. Akut manik epizod: antipsikotik (olanzapin, risperidon, ketiapin, aripiprazol, asenapin) ± duygudurum dengeleyici (lityum, valproat). Akut ajitasyonda lorazepam adjunkt.
2. Akut bipolar depresif epizod: ketiapin veya lurasidon (FDA onayı), olanzapin/fluoksetin kombinasyonu (Symbyax); lityum veya lamotrijin

adjunkt. Tek antidepresan kullanımı kontrendikedir — manik dönüş ve hızlı döngü riski.

3. İdame (maintenance): lityum birinci basamak — intihar azaltma etkisi (Cipriani A. BMJ 2013); valproat, ketiapin, lamotrijin (özellikle depresif komponent dominant), olanzapin alternatifler.
4. Refrakter: klozapin; EKT.
5. Hızlı siklus: antidepresanı kes; lityum ve valproat kombinasyonu.
6. Psikososyal müdahale: psikoeğitim, BDT bipolar için, IPSRT (Interpersonal and Social Rhythm Therapy — Frank E.), aile-odaklı terapi (Miklowitz D.).
7. Adherens ve yan etki monitorizasyonu — lityum için 6 aylık TSH, kreatinin, kalsiyum; valproat için karaciğer ve hematolojik.
8. Gebelik ve doğum yaşındaki kadınlar: valproat kesin yasak (nöral tüp defekti %1–2, genel olarak majör konjenital malformasyon ~%10, otizm ve IQ defisiti); lamotrijin ve ketiapin nispeten güvenli.

8.2 Farmakoterapi (tablo)

Sınıf	Preparat	Endikasyon
Lityum	Terapötik düzey 0,6–1,0 mEq/L; komplike vakada 0,8–1,2	Manik, depresif, idame; intiharı azaltır.
Antikonvülzan	Valproat (1000–2000 mg), karbamazepin (400–1200 mg), lamotrijin (200 mg titre)	Manik (valproat, karbamazepin), depresif idame (lamotrijin).
Atipik antipsikotik	Olanzapin, risperidon, ketiapin, aripiprazol, asenapin, lurasidon, kariprazin	Manik, mikst, idame; ketiapin ve lurasidon — bipolar depresif için FDA onayı.
Antidepresan	Yalnızca duygudurum dengeleyici ile birlikte	Bipolar depresif epizodda dikkatle; tek başına kontrendikedir.

8.3 Tedavi metodolojileri

1. Lityum — Bipolar bozuklukta altın standart; suisidi azaltır; başlangıç göstergeleri kreatinin, TSH, kalsiyum, EKG; terapötik düzey 0,6–1,0 mEq/L; toksisite > 1,5 mEq/L. Cipriani BMJ 2013.

2. Bipolar için uyarlanmış BDT — Psikoeğitim, erken belirteç tanıma, davranışsal aktivasyon, uyum desteği. Lam D.H. et al. Arch Gen Psychiatry 2003 RKÇ.
3. Kişilerarası ve Sosyal Ritim Terapisi (IPSRT — Interpersonal and Social Rhythm Therapy) — Frank (Frank E.) — Bipolar bozuklukta sirkadiyen ritim ve kişilerarası stres yönetimi. Frank E. et al. Arch Gen Psychiatry 2005 RKÇ — idame fazında nüks azalması.
4. Aile Odaklı Terapi (FFT — Family-Focused Therapy) — Miklowitz (Miklowitz D.) — Hasta + aile birlikte; psikoeğitim, iletişim, problem-çözme. Miklowitz D.J. et al. Arch Gen Psychiatry 2003;60(9):904–912.
5. Young Mani Derecelendirme Ölçeği (YMRS — Young Mania Rating Scale) — 11 madde manik şiddet; başlangıç göstergeleri ve izlem.
6. Duygudurum Bozukluğu Anketi (MDQ — Mood Disorder Questionnaire) — Hirschfeld (Hirschfeld R.M.) — 13 maddelik öz değerlendirme bipolar tarama.
7. EKT — Refrakter manik veya depresif epizodda, karışık özelliklerde, intihar riskinde, gebelikte güvenli alternatif. NICE TA59.

8.4 Kaynaklar arasındaki farklar

- CANMAT/ISBD 2018 (Yatham L.N. et al. Bipolar Disord 2018): birinci basamak manik için — lityum, valproat, ketiapin, aripiprazol, asenapin, paliperidon, risperidon; bipolar depresif için — ketiapin, lurasidon (monoterapi veya lityum/valproat ile adjuvan).
- NICE CG185: lityum birinci basamak idamede; antidepresan yalnızca duygudurum dengeleyici ile.
- Cipriani A. et al. BMJ 2013 meta-analiz: lityum intiharı anlamlı şekilde azaltır (diğer duygudurum dengeleyicilerden üstün).
- EMA ve FDA uyarıları: valproat doğurganlık yaşında kadınlarda — nöral tüp defekti, otizm, IQ azalması.

9. Prognoz

- Epizodik seyir; nüks %80–90 (tedavisiz); idame farmakoterapisi ile anlamlı azalma.
- İntihar riski yüksek (%6–7 yaşam boyu); özellikle ilk yıllarda.
- Kardiyovasküler mortalite artmış (metabolik sendrom).
- İşlevsel iyileşme orta — hastaların çoğunluğu belirgin sosyal ve mesleki bozulma yaşar.

- İzlem — duygudurum ölçekleri, intihar riski, metabolik göstergeler, lityum düzeyi, uyum.

10. Mit ve yanlış inançlar

Mit 1: "Bipolar bozukluk basit ruh hali değişimleridir — herkeste vardır"

Klinik mantık: bipolar manik epizod hem süre (≥ 7 gün) hem de işlevsel bozulma gerektirir; günlük duygudurum dalgalanmalarından farklı klinik bir durumdur. Manik epizod psikotik özellikler ve hastaneye yatış gerektirebilir. Kanıt: Merikangas Arch Gen Psychiatry 2011.

Mit 2: "Kötü terbiye bipolar'a neden olur"

Kanıt: kalıtım %60–85; ebeveyn deneyimi etiyoloji değildir. Smoller & Finn 2003.

Mit 3: "Bipolar hasta yaratıcıdır ya da 'deha belirtecidir'"

Kanıt: bazı çalışmalarda yaratıcılık mesleklerinde bipolar yaygınlığı hafif artar (Andreasen N.C. derlemeleri), ancak çoğu hasta fonksiyonel bozulma yaşar; "deha" açıklaması romantikleştirme ve tedaviden kaçınmaya yol açar.

Mit 4: "Bipolar hastada antidepresan her zaman yardımcı olur"

Kanıt: NICE CG185, CANMAT — antidepresan tek başına bipolar bozuklukta kontrendikedir; manik dönüş ve hızlı döngü riski.

Mit 5: "Lityum 'eskimiş' veya tehlikeli — atipik antipsikotik birinci sıra olmalıdır"

Kanıt: Cipriani BMJ 2013 — lityum intiharı diğer duygudurum düzenleyicilerinden anlamlı derecede daha fazla azaltır; NICE CG185 ve CANMAT 2018 — idamede birinci basamak.

Mit 6: "Hasta kendi ruh halini 'iradi olarak' kontrol edebilir"

Kanıt: bipolar epizod nörobiyolojik bir bozukluktur; iradeyle kontrol edilmez; farmakoterapi veya EKT gerektirir.

Mit 7: "İlgisiz gözlem yeterlidir — kendi kendine geçer"

Kanıt: tedavisiz epizodlar — uzun süreli fonksiyonel bozulma, kardiyovasküler mortalite, intihar (%6–7 ömür boyu).

Mit 8: "Bitkisel preparatlar (St John's Wort, valerian) veya omega-3 duygudurum dengeleyicisinin yerini alır"

Kanıt: St John's Wort sitokrom P450 indüksiyonu ile duygudurum dengeleyicilerinin seviyesini düşürür ve manik dönüşe neden olabilir; omega-3 hafif adjuvan etki, ana tedavi değil.

Mit 9: "Kannabis duygudurum düzenleyicisidir"

Kanıt: Kannabis bipolar gidişatını kötüleştirir, psikoz riskini artırır, uyumu azaltır.

Mit 10: "Gebelikte duygudurum düzenleyici tamamen kesilmelidir"

Kanıt: tam kesme relaps riskini 2 kat, hastalıklı geçen haftaların oranını 5 kat artırır, relapsa kadar geçen süreyi 4 kattan fazla kısaltır (Viguera A.C. et al. Am J Psychiatry 2007). Valproat kesin kontrendike, ancak lamotrijin ve ketiapin nispeten daha az riskli; kişisel dengelenme değerlendirilir (NICE CG192).

11. Kaynaklar

1. WHO. ICD-11. 6A60 Bipolar type I disorder. 2024.
2. APA. DSM-5-TR. 2022.
3. NICE CG185. Bipolar disorder: assessment and management. 2014/2020.
4. Yatham L.N., Kennedy S.H., Parikh S.V. et al. CANMAT and ISBD 2018 guidelines for the management of patients with bipolar disorder. Bipolar Disord 2018;20(2):97–170.
5. Cipriani A., Hawton K., Stockton S., Geddes J.R. Lithium in the prevention of suicide in mood disorders: updated systematic review and meta-analysis. BMJ 2013;346:f3646.
6. Merikangas K.R., Jin R., He J.P. et al. Prevalence and correlates of bipolar spectrum disorder in the world mental health survey initiative. Arch Gen Psychiatry 2011;68(3):241–251.
7. Smoller J.W., Finn C.T. Family, twin, and adoption studies of bipolar disorder. Am J Med Genet C Semin Med Genet 2003;123C(1):48–58.
8. Mullins N. et al. Genome-wide association study of more than 40,000 bipolar disorder cases. Nat Genet 2021;53(6):817–829.
9. Frank E., Kupfer D.J., Thase M.E. et al. Two-year outcomes for interpersonal and social rhythm therapy in individuals with bipolar I disorder. Arch Gen Psychiatry 2005;62(9):996–1004.
10. Miklowitz D.J., George E.L., Richards J.A. et al. A randomized study of family-focused psychoeducation in bipolar disorder. Arch Gen Psychiatry 2003;60(9):904–912.

11. Viguera A.C., Whitfield T., Baldessarini R.J. et al. Risk of recurrence in women with bipolar disorder during pregnancy: prospective study of mood stabilizer discontinuation. Am J Psychiatry 2007;164(12):1817–1824.
12. Hirschfeld R.M., Williams J.B., Spitzer R.L. et al. Development and validation of a screening instrument for bipolar spectrum disorder: the Mood Disorder Questionnaire. Am J Psychiatry 2000;157(11):1873–1875.
13. Andreasen N.C. Creativity and mental illness: prevalence rates in writers and their first-degree relatives. Am J Psychiatry 1987;144(10):1288–1292.

ICD-11 **6A61**	**6A61 BİPOLAR BOZUKLUK TİP II** **Bipolar type II disorder**
ICD-10 F31	Bipolar duygulanım bozukluğu
DSM-5-TR F31.81	İkiuçlu (Bipolar) II Bozukluğu

1. Tanım ve nozoloji

Bipolar bozukluk Tip II (ICD-11: 6A61; DSM-5-TR: F31.81) — en az bir hipomanik epizod ve en az bir major depresif epizodla karakterize olan, ancak hiçbir zaman tam manik epizodu olmayan bipolar bozukluk formudur. Tip I'den “hafif” form değil — hastalar ömür boyu daha fazla depresif zaman geçirir; işlevsel bozulma ve intihar riski Tip I ile karşılaştırılabilir.

2. Tarihçe

- Dunner D.L., Gershon E.S., Goodwin F.K. (1976) — bipolar bozukluk alt tiplerini ayırma önerisi.
- DSM-IV (1994) — Bipolar Tip II ayrı tanısal kategori olarak resmileştirildi.
- DSM-5 (2013) ve ICD-11 (2019) — Tip II'nin korunmuş, “hafif form” olarak yanlış kavramsallaştırmaya karşı vurgu.

3. Epidemiyoloji

- Yaşam boyu yaygınlık: ~%0,4–1,1 (Merikangas K.R. Arch Gen Psychiatry 2011 WMH).
- Cinsiyet: kadınlarda nispeten yüksek (~1,5:1 — Tip I'den farklı).

- Başlangıç: ortalama 20–25 yaş, çok sayıda depresif epizod genellikle hipomanik epizoddan önce ortaya çıkar.
- İntihar riski Tip I ile karşılaştırmalı (ömür boyu ~%5–7); daha fazla depresif zaman nedeniyle.
- Komorbidite: anksiyete %60+, madde kullanımı %30–40, sınırda kişilik bozukluğu.

4. Etiyoloji ve patogenez

- Genetik temel Tip I ile örtüşür — kalıtım %60–80; GWAS lokusları paralel.
- Klinik fenotipin bipolar Tip I'den bağımsız genetik birliği tartışmalıdır — bazı çalışmalarda her iki tip aynı spektrum olarak değerlendirilir.
- Sirkadiyen ritim bozukluğu ve aile öyküsü.

5. Klinik özellikler

5.1 Hipomanik epizod

- Anormal yüksek veya irritabl duygudurum + artmış enerji ≥ 4 gün (Tip I'de ≥ 7).
- Manik epizodla aynı alt-semptomlar (azalmış uyku, dikkat dağınıklığı, amaçlı aktivite artışı, vb.); ≥ 3 semptom (iritabl duygudurumda ≥ 4).
- İşlevsel bozulma belirgin olmamalıdır (yani hipomanik tanımı); psikotik özellik olmamalıdır; hastaneye yatış gerekmemelidir. Bu kriterler gözlenirse — tanı Tip I'e değişir.

5.2 Majör depresif epizod

- 2 hafta ≥ 5 semptom (düşük duygudurum ve/veya anhedoni dahil).
- Bipolar Tip II depresif epizodları sıklıkla atipik özelliklerle — hipersomni, hiperfaji, leaden paralysis, rejection sensitivity.
- Hastalar izlem haftalarının %53,9'unda semptomatiktir; depresif semptomlar haftaların %50,3'ünü kaplar (hipomanik %1,3, döngüsel/karma %2,3) — Judd L.L. ve ark. Arch Gen Psychiatry 2003, n=86, ortalama 13,4 yıl izlem; semptomların çoğu subsendromal düzeydedir.

6. Tanı

6.1 Birleşik tanı ölçütleri

A. En az bir hipomanik epizod.

B. En az bir major depresif epizod.

C. Hiçbir zaman manik epizod olmamıştır.

D. Hipomanik ve depresif epizodlar şizoaffektif, şizofreni veya diğer psikotik bozuklukla daha iyi açıklanmaz.

E. Semptomlar belirgin distress veya fonksiyonel bozulmaya neden olur (esas olarak depresif epizoddan).

6.2 Kaynaklar arasındaki farklar

- DSM-5-TR / ICD-11: hipomanik epizodda fonksiyonel bozulma anlamlı olmamalıdır; antidepresan indüklü hipomanik epizod bipolar Tip II tanısına yol açar (özellikle devam eden veya tekrarlayan durumlarda).
- Tanının atlanması sorunu: Hirschfeld R.M. derlemeleri — depresif epizodla başvuran hastaların ~%25–50'si aslında bipolar Tip II'dir, ancak hipomanik epizodlar aile tarafından "iyi dönemler" olarak kabul edilir.

6.3 Tanı algoritması

1. Her depresif hastada hipomanik epizodlar için yapılandırılmış sorgulama (SCID-5 mood module, MDQ, HCL-32).
2. Aile üyelerinden bilgi — hipomanik dönemlerin gözlemi önemlidir.
3. Klinik görüşme + YMRS, HAM-D / MADRS.
4. Laboratuvar: tiroid, karaciğer, böbrek, toksikolojik, gebelik testi.
5. Komorbidite ve intihar riski değerlendirmesi.

6.4 Ayırıcı tanı

Durum	**Ayırt edici belirtiler**
Bipolar Tip I (6A60)	≥ 1 manik epizod (fonksiyonel bozulma veya hospitalizasyon gereği).
Majör Depresif Bozukluk (6A70/6A71)	Hipomanik epizod yok.
Siklotimik (6A62)	Tam majör depresif veya hipomanik epizod yok.
BPD (6D10.x)	Duygusal değişkenlik saatler; kimlik bozukluğu; kronik intihar düşünceleri.
DEHB	Sürekli; epizodik değil.
Hipertireoid	TSH ölçümü.

7. Muayene ve değerlendirme

- SCID-5 mood modülü — altın standart.
- MDQ (Mood Disorder Questionnaire) ve HCL-32 (Hypomania Checklist) — tarama.
- YMRS, HAM-D / MADRS, C-SSRS.
- Lityum öncesi: kreatinin, TSH, kalsiyum, EKG.

8. Tedavi

8.1 Genel Prensipler (NICE CG185 · CANMAT/ISBD 2018)

1. Bipolar Tip II depresif epizod (en sık sunum):
    - Birinci sıra — ketiapin (FDA onayı) veya ketiapin + lityum kombinasyonu. Lurasidonun FDA endikasyonu yalnızca bipolar I depresyonudur, Tip II değil; CANMAT/ISBD 2018'de Tip II depresif epizodda birinci sıra olarak yalnızca ketiapini gösterir.
    - Lamotrijin — idamede ve depresif profilakside birinci sıra (Tip II'de özellikle etkili).
    - Lityum — idame ve intihar azaltma.
2. Hipomanik epizod: antidepresanı kes; duygudurum dengeleyici (lityum, valproat) veya atipik antipsikotik.
3. Antidepresan kullanımı: Bipolar Tip II'de nispeten güvenli kabul edilirdi, ancak son öneriler (CANMAT 2018) yalnızca duygudurum dengeleyici ile birlikte (manik dönüş ve hızlı döngü riskini azaltmak için).
4. İdame (maintenance): lamotrijin (depresif komponent dominant olduğunda) veya ketiapin; lityum intihar azaltma etkisi için.
5. Psikososyal: BDT, IPSRT, aile odaklı terapi, psikoeğitim.
6. Refrakter: klozapin, EKT.
7. Gebelik: valproat kesin yasak; lamotrijin ve ketiapin nispeten güvenli.

8.2 Tedavi metodolojileri

1. Lamotrijin — Bipolar Tip II idamesinde ve depresif epizod profilaksisinde etkili; titrasyonu yavaş (Stevens-Johnson sendromu riski) — başlangıç 25 mg, 2 hafta artırma; hedef 200 mg/gün. Calabrese J.R. et al. J Clin Psychiatry 2003.
2. Ketiapin — FDA bipolar depresif epizod için onayı; 300–600 mg/gün; metabolik yan etkiler izlemi.

3. Kişilerarası ve Sosyal Ritim Terapisi (IPSRT) — Frank (Frank E.); ve bipolar için BDT — Sirkadiyen ritim, uyum, nüks önleme.
4. Hipomani Kontrol Listesi (HCL-32 — Hypomania Checklist) — Angst J. — 32 maddelik öz değerlendirme hipomanik epizod taraması.
5. Duygudurum Bozukluğu Anketi (MDQ — Mood Disorder Questionnaire) — 13 soru; bipolar tarama.

8.3 Kaynaklar arasındaki farklar

- CANMAT/ISBD 2018: Tip II depresif epizod birinci basamak — ketiapin; lamotrijin idamede.
- NICE CG185: Tip I ve II aynı temel yaklaşım, ancak Tip II'de lamotrijinin özel rolü vurgulanır.
- Calabrese J.R. RKÇ'leri — lamotrijinin bipolar Tip II idamesinde etkisi.

9. Prognoz

- Epizodik seyir; idame farmakoterapisi ile nüks anlamlı azalır.
- Tip II Tip I'den “hafif” değildir — yüksek işlevsel bozulma ve depresif yük.
- İntihar riski yüksek.
- Ketiapin ve lamotrijin idamede temel.
- İzlem — depresif belirtiler, hipomanik tetikleyiciler, metabolik göstergeler.

10. Mit ve yanlış inançlar

Mit 1: “Tip II bipolar 'hafif form'dur, tedaviye az ihtiyaç vardır”

Kanıt: Judd L.L. Arch Gen Psychiatry 2003 — Tip II hastalar izlem haftalarının %50,3'ünü depresif semptomlarla geçirir (toplam semptomatik süre %53,9); işlevsel bozulma ve intihar riski Tip I ile karşılaştırılabilir.

Mit 2: “Hipomanik epizod ‘iyi dönemdir’, tedaviye gerek yoktur”

Kanıt: hipomanik epizod riskli davranış, ilişki bozulması, üretkenlikte sonradan azalma ve depresif epizod tetikleyicisi olabilir; ayrı epizodlar sürdürüm farmakoterapisinin gerekliliğini gösterir.

Mit 3: “Tip II hastada antidepresan tek başına kullanılabilir”

Kanıt: CANMAT 2018 — antidepresan yalnızca duygudurum dengeleyici ile; manik dönüş ve hızlı döngü riski.

Mit 4: “Bipolar Tip II yalnızca sınır kişilik bozukluğunun bir formudur”

Kanıt: Belirgin örtüşme ve komorbidite vardır, ancak bunlar ayrı bozukluklardır; Bipolar Tip II epizodik, BPD sürekli modeldir.

Mit 5: “Lamotrijin manik epizodu iyileştirir”

Kanıt: lamotrijin depresif komponentte ve idamede etkilidir; manik epizod için etkisiz — antipsikotik veya valproat gereklidir.

Mit 6: “St John's Wort doğal antidepresan olduğu için bipolar'da güvenlidir”

Kanıt: St John's Wort manik dönüşe neden olabilir ve duygudurum dengeleyicilerinin seviyesini düşürür (CYP indüksiyonu); bipolar'da kontrendike.

Mit 7: “Tip II'de EKT gerekmez”

Kanıt: refrakter depresif epizod veya yüksek intihar riskinde EKT endikedir; Tip II hastada da etkilidir.

11. Kaynaklar

1. WHO. ICD-11. 6A61 Bipolar type II disorder. 2024.
2. APA. DSM-5-TR. 2022.
3. NICE CG185. 2014/2020.
4. Yatham L.N. et al. CANMAT and ISBD 2018 guidelines. Bipolar Disord 2018;20(2):97–170.
5. Judd L.L., Akiskal H.S., Schettler P.J. ve ark. A prospective investigation of the natural history of the long-term weekly symptomatic status of bipolar II disorder. Arch Gen Psychiatry 2003;60(3):261–269.
6. Calabrese J.R. et al. A placebo-controlled 18-month trial of lamotrigine and lithium maintenance treatment in recently depressed patients with bipolar I disorder. J Clin Psychiatry 2003;64(9):1013–1024.
7. Cipriani A. ve ark. BMJ 2013;346:f3646.
8. Merikangas K.R. et al. Arch Gen Psychiatry 2011;68(3):241–251.
9. Angst J. et al. The HCL-32: towards a self-assessment tool for hypomanic symptoms. J Affect Disord 2005;88(2):217–233.
10. Hirschfeld R.M., Williams J.B., Spitzer R.L. et al. Development and validation of a screening instrument for bipolar spectrum disorder: the Mood Disorder Questionnaire. Am J Psychiatry 2000;157(11):1873–1875.

11. Frank E., Kupfer D.J., Thase M.E. et al. Two-year outcomes for interpersonal and social rhythm therapy in individuals with bipolar I disorder. Arch Gen Psychiatry 2005;62(9):996–1004.

ICD-11 **6A62**	**6A62 SİKLOTİMİK BOZUKLUK** **Cyclothymic disorder**
ICD-10 F34.0	Siklotimi
DSM-5-TR F34.0	Siklotimi Bozukluğu

1. Tanım ve nozoloji

Siklotimik bozukluk (ICD-11: 6A62; DSM-5-TR: F34.0 Siklotimik Bozukluk) — en az 2 yıl (yetişkinlerde; çocuk/ergenlerde 1 yıl) süresince eşik altı hipomanik ve depresif semptomların sürekli değişimi ile karakterize kronik afektif bozukluktur. Tam major depresif, manik veya hipomanik epizodlara ulaşmaz.

2. Tarihçe

- Kahlbaum K. (1882) — siklotimi terimi.
- Kraepelin (1899) — manik-depresif bozukluğun hafif formu.
- Akiskal H.S. (1977) — siklotimik mizacı bipolar spektrumun alt-evresi olarak yeniden tanımlaması.
- DSM-III (1980), DSM-5 (2013), ICD-11 (2019) — afektif bozukluk kategorisinde.

3. Epidemiyoloji

- Yaşam boyu yaygınlık: %0,4–1 (DSM-5-TR; geniş aralık, kesin epidemiyolojik veri sınırlı).
- Cinsiyet: yaklaşık eşit.
- Başlangıç: ergenlik ve erken yetişkinlik.
- Tip I veya II bipolar dönüşüm: ~%15–50 (Akiskal H.S. derlemeleri).
- Komorbidite: anksiyete, madde kullanımı, DEHB, sınırda kişilik bozukluğu.

4. Etiyoloji ve patogenez

- Bipolar spektrum ile paylaşılan genetik yük (Akiskal).
- Aile öyküsünde bipolar ve majör depresif bozukluk sıklığı artmıştır.
- Nörobiyolojik — bipolar bozukluktaki gibi monoaminerjik ve sirkadiyen disregülasyon, ancak daha az belirgin.

5. Klinik özellikler

- Çok sayıda eşik altı hipomanik dönem — kısa, düşük yoğunluklu enerji ve duygudurum yükselmeleri.
- Çok sayıda eşik altı depresif dönem — düşük yoğunluklu depresif semptomlar.
- "Stabil dönem" 2 aydan az.
- Duygudurum değişimleri günler veya haftalar; hasta kendini "doğam böyledir" şeklinde açıklayabilir.
- Kişilerarası ve mesleki bozulma orta düzeydedir, ancak yıkıcı değildir.

6. Tanı

6.1 Birleşik tanı ölçütleri (DSM-5-TR · ICD-11)

A. En az 2 yıl (yetişkinler) / 1 yıl (çocuk/ergen) boyunca çok sayıda hipomanik ve depresif eşik altı dönemler.

B. Bu süre boyunca semptomlar zamanın ≥ yarısında mevcuttur ve semptomsuz dönem 2 aydan fazla değildir.

C. Tam majör depresif, manik veya hipomanik epizod kriterleri hiç karşılanmamıştır.

D. Şizoaffektif, şizofreni veya diğer psikotik bozuklukla daha iyi açıklanmaz.

E. Madde veya tıbbi durum dışlaması.

F. Önemli sıkıntı veya işlevsel bozulma.

6.2 Tanı algoritması

1. Klinik görüşme (duygudurum günlüğü 4–6 hafta önerilir — hastanın kendi modellerinin belgelenmesi).
2. SCID-5, MDQ, HCL-32.
3. Komorbidite ve aile öyküsü değerlendirmesi.
4. Tıbbi ve laboratuvar (tiroid mutlaka).

6.3 Ayırıcı tanı

Durum	Ayırt edici belirtiler
Bipolar Tip II (6A61)	Tam hipomanik ve majör depresif epizodlar.
Distimik bozukluk (6A72)	Yalnızca depresif eşik altı; hipomanik dönemler yok.
BPD (6D10.x)	Saatlik duygudurum değişimleri; kimlik bozukluğu; dürtüsellik ve ilişkiler.
DEHB (6A05)	Epizodik değil; dikkat eksikliği dominant.
Siklotimik temperament (normal variant)	Fonksiyonel bozulma yoktur.

7. Muayene ve değerlendirme

- Duygudurum günlüğü.
- MDQ, HCL-32, YMRS, HAM-D.
- Tiroid fonksiyonu.

8. Tedavi

1. Psikoterapi birinci sıra — BDT, IPSRT, psikoeğitim, davranışsal aktivasyon, sirkadiyen ritim yönetimi.
2. Farmakoterapi — kanıt tabanı sınırlıdır:
    - Lityum veya valproat — bipolar spektrum bağlamında uygun kabul edilir.
    - Lamotrijin — depresif komponent dominant olduğunda.
    - Atipik antipsikotik (ketiapin) — orta-ağır vakalarda.
3. Antidepresan tek başına — manik dönüş ve hızlı döngü riski; kontrendikedir.
4. Stres yönetimi ve sosyal-sirkadiyen ritmin korunması — önemli.
5. Bipolara dönüşüm izlemi — aile öyküsü ve klinik belirteçler varsa daha sık izlem.

8.1 Tedavi metodolojileri

1. Kişilerarası ve Sosyal Ritim Terapisi (IPSRT) — Frank (Frank E.) — Sirkadiyen ritim ve kişilerarası stres yönetimi.
2. BDT bipolar spektrum için — Psikoeğitim, davranışsal aktivasyon, nüks belirteçleri.
3. Duygudurum günlüğü — Hastanın kendi duygu durum değişikliklerini belgelemesi — tanısal ve terapötik araç.
4. Lityum ve lamotrijin — Bipolar spektrum farmakoterapisi yeterli.

8.2 Kaynaklar arasındaki farklar

- NICE CG185, CANMAT 2018 — siklotimik bozukluk için ayrı bir algoritma sınırlıdır; bipolar spektrum prensipleri uygulanır; psikoterapi birinci basamak.

9. Prognoz

- Kronik; spontan remisyon nadir.
- Bipolar Tip I/II'ye dönüşüm riski — yıllık klinik değerlendirme.
- Komorbid madde kullanımı ve BPD risk faktörleri.
- Yeterli tedavi ile fonksiyonel düzey iyileşir.

10. Mit ve yanlış inançlar

Mit 1: “Siklotimik mizaç normal bir kişilik özelliğidir, tedavi gerektirmez”

Klinik mantık: Siklotimik mizaç normal varyant olduğunda işlevsel bozulma yoktur; klinik tanı işlevsel bozulma gerektirir. Ancak birçok hasta yıllarca “yaratıcı doğa” olarak açıklayıp müdahaleye başvurmaz, oysa yaşam kalitesi kötüleşir.

Mit 2: “Siklotimik bozukluk bipolar'a dönüşmez”

Kanıt: Akiskal — %15–50 bipolar Tip I veya II'ye konversiyon; aile öyküsü varsa daha yüksek risk.

Mit 3: “Antidepresan tek başına tüm duygu durum değişikliklerini yönetir”

Kanıt: manik dönüş ve hızlı döngü riski; duygudurum dengeleyici ile birlikte gereklidir.

Mit 4: "Siklotimik hasta yaratıcılığını tedaviye göre kaybedecek"

Kanıt: uygun tedavi (psikoterapi + duygudurum dengeleyici) yaratıcılığı korumaya ve artırmaya yardımcı olur (stabilize aktivite); romantikleştirilmiş "deha" açıklaması müdahaleden kaçınmaya yol açar.

Mit 5: "Bitkisel preparatlar veya diyet siklotimik bozukluğu iyileştirir"

Kanıt: St John's Wort manik dönüş riski; omega-3 hafif adjuvan, ana tedavi değil.

11. Kaynaklar

1. WHO. ICD-11. 6A62 Cyclothymic disorder. 2024.
2. APA. DSM-5-TR. 2022.
3. NICE CG185. 2014/2020.
4. Yatham L.N. et al. CANMAT/ISBD 2018. Bipolar Disord 2018;20(2):97–170.
5. Akiskal H.S., Khani M.K., Scott-Strauss A. Cyclothymic temperamental disorders. Psychiatr Clin North Am 1979;2(3):527–554.
6. Frank E., Kupfer D.J., Thase M.E. et al. Two-year outcomes for interpersonal and social rhythm therapy in individuals with bipolar I disorder. Arch Gen Psychiatry 2005;62(9):996–1004.

ICD-11 **6A70**	**6A70 TEK DÖNEM DEPRESİF BOZUKLUK** **Single episode depressive disorder**
ICD-10 F32	Depresif nöbet
DSM-5-TR F32.x	Yeğin (Majör) Depresyon Bozukluğu, Tek Dönem

1. Tanım ve nozoloji

Tek dönem depresif bozukluk (ICD-11: 6A70 Single Episode Depressive Disorder; DSM-5-TR: Major Depresif Bozukluk, Tek Epizod — F32.x) — en az 2 hafta süreyle düşük duygudurum ve/veya anhedoni ile birlikte belirgin kognitif, somatik ve psikomotor semptomların eşlik ettiği, işlevsel bozulma yaratan afektif bozukluktur. Hastanın öyküsünde yalnızca bir major depresif epizod gözlenir (nüks durumunda 6A71 kodlanır).

2. Tarihçe

- Hipokrat (MÖ V–IV. yüzyıllar) — melankoli terimi.
- Kraepelin (1899) — manik-depresif delilik içinde depresif epizod.
- DSM-III (1980) — Majör Depresif Bozukluk resmi tanı; bipolar bozukluktan ayrılma.
- DSM-5 (2013) — yas istisnası kaldırılmıştır — hasta yakınını kaybettikten sonra da majör depresif epizod tanısı konulabilir.
- ICD-11 (2019) — Tek epizodlu (6A70) ve Yinelenen (6A71) ayrı kodlanır.

3. Epidemiyoloji

- Yaşam boyu yaygınlık: %15–20 (NESARC-III; Hasin D.S. et al. JAMA Psychiatry 2018).
- Yıllık yaygınlık: ~%6–8.
- Cinsiyet: kadınlarda 1,5–2 kat yüksek.
- Başlangıç: ortalama 20–30 yaş; ancak herhangi bir yaşta mümkündür.
- İntihar: depresif bozukluk intihar ölümlerinin ~%50'si ile ilişkilidir.
- Komorbidite: anksiyete bozuklukları %60, madde kullanımı %25, ağrı, kardiyovasküler, diyabet.
- Mortalite: genel mortalite 1,5 kat artmış (kardiyovasküler, intihar).

4. Etiyoloji ve patogenez

- Kalıtım %35–40 (Sullivan P.F. et al. Am J Psychiatry 2000 meta-analiz); bipolar bozukluktan az.
- GWAS — 100+ risk lokusu (Howard D.M. et al. Nat Neurosci 2019, n>800 000).
- Nörobiyolojik — monoaminerjik (serotonin, noradrenalin, dopamin) hipotezi; HPA aksı disregülasyonu, kortizol yüksekliği; hipokampus hacim azalması; inflamatuar hipotez (CRP, IL-6).
- Risk faktörleri: çocukluk travması, aile öyküsü, akut stres, kronik tıbbi hastalık, sosyal izolasyon, madde kullanımı, doğum sonrası dönem, hipotiroidi.

5. Klinik özellikler

5.1 Temel semptomlar (DSM-5-TR — ≥ 5 semptom × 2 hafta, en az 1'i 1 veya 2)

1. Sürekli düşük duygudurum.
2. Anhedoni — ilgi ve zevk kaybı.
3. Kilo veya iştah değişiklikleri.
4. Uyku bozukluğu (insomni veya hipersomni).
5. Psikomotor ajitasyon veya yavaşlama (başkaları tarafından gözlemlenebilir).
6. Yorgunluk veya enerji kaybı.
7. Değersizlik veya aşırı suçluluk hissi.
8. Konsantrasyon güçlüğü ve karar verme bozukluğu.
9. İntihar düşünceleri veya plan.

5.2 Kalifikatörler (DSM-5-TR)

- Şiddet: hafif, orta, ağır.
- Psikotik özelliklerle (sanrı veya halüsinasyon).
- Atipik özellikler (hipersomni, hiperfaji, kurşuni felç).
- Melankolik özellikler.
- Katatonik özellikler.
- Peripartum başlangıç.
- Mevsimsel model.
- Mixed features (manik komponentler).
- Anksiyete ile.

6. Tanı

6.1 Birleşik tanı ölçütleri (DSM-5-TR · ICD-11 konsensus noktaları)

A. Yukarıdaki 5+ semptom ≥ 2 hafta; en az biri düşük duygudurum veya anhedoni.

B. Önemli sıkıntı veya işlevsel bozulma.

C. Madde veya tıbbi durum dışlaması.

D. Hiçbir zaman manik veya hipomanik epizod olmamıştır.

6.2 Kaynaklar arasındaki farklar

- DSM-5-TR: “bereavement exclusion” kaldırıldı (DSM-IV'te yas döneminde 2 ay tanı konulmazdı); yas ve depresif epizod birlikte ortaya çıkabilir.
- ICD-11 (6A70): tek epizod ayrı kod; şiddet ve psikotik özellik kalifikatörleri.
- NICE NG222 (2022): Şiddet sınıflandırması: daha az şiddetli, daha şiddetli (DSM'de hafif/orta/ağır yerine); tedavi şiddete göre algoritmalar.

6.3 Tanı algoritması

1. Klinik görüşme.
2. Yapılandırılmış görüşme (SCID-5, MINI).
3. Ölçekler — PHQ-9 (tarama ve izleme), HAM-D, MADRS, BDI-II.
4. İntihar riski (C-SSRS).
5. Bipolar tarama (MDQ, HCL-32) — bipolar epizodları dışlamak.
6. Tıbbi ve laboratuvar (tiroid, B12, folat, ferritin, karaciğer, böbrek, gebelik) — somatik nedeni dışla.
7. Toksikolojik tarama (madde kullanımı şüphesi).

6.4 Ayırıcı tanı

Durum	**Ayırt edici belirtiler**
Bipolar Tip I/II (6A60/6A61)	Manik veya hipomanik epizod öyküsü.
Distimik bozukluk (6A72)	≥ 2 yıl eşik altı depresif semptomlar.
Uyum bozukluğu (6B43)	Stres faktörüne yanıt; kriter sayısı az.
Yas (keder)	Sevilen kişinin kaybından sonra; “dalga dalga” gidiş; benlik saygısı korunur.
Hipotiroidi	TSH yüksekliği; somatik belirtiler.
B12 / folat eksikliği	Laboratuvar.
Madde indüksiyonlu depresyon	Madde kullanımı anamnezi.
Demansta depresif semptomlar	Bilişsel defisit dominant; yaşlı hasta.

7. Muayene ve değerlendirme

- PHQ-9 — birinci basamakta standart; ≥ 10 kesim orta-ağır depresyon.
- HAM-D-17 (Hamilton), MADRS — klinik ve araştırma.

- BDI-II — öz değerlendirme.
- C-SSRS — intihar riski.
- Laboratuvar: tam kan, tiroid, B12, folat, ferritin, karaciğer/böbrek, glukoz.
- EKG — TCA veya QT-uzatan ilaçlar başlanmadan önce.

8. Tedavi

8.1 Genel Prensipler (NICE NG222 · APA 2010 · CANMAT 2016 konsensüsü)

1. Şiddete göre kademeli yaklaşım:
    - Hafif (PHQ-9 5–9) — rehberli kendi kendine yardım, BDT-temelli internet müdahaleleri, fiziksel aktivite, izlem.
    - Orta (PHQ-9 10–14) — BDT veya IPT, veya farmakoterapi (SSRI); hasta seçimi.
    - Orta-ağır (PHQ-9 15–19) — farmakoterapi (SSRI) veya yüksek yoğunluklu psikolojik müdahale; kombinasyon tercih edilir.
    - Ağır (PHQ-9 ≥ 20 veya psikotik özellikler) — farmakoterapi + psikoterapi kombinasyonu; ağır psikotik / intihar riski — yatarak tedavi ve EKT.
2. Birinci basamak farmakoterapi: SSRI — sertralin, essitalopram, fluoksetin, paroksetin, sitalopram. Etki 4–6 hafta; titrasyon gerektirir.
3. SNRI — venlafaksin, duloksetin — alternatif veya komorbid ağrı/anksiyete.
4. Diğer — mirtazapin (uyku ve iştah sorunları), bupropion (cinsel yan etki az, DEHB komorbid), agomelatin, vortioksetin (bilişsel bileşen).
5. Refrakter: SSRI + lityum veya ketiapin veya aripiprazol; SSRI kombinasyonları; ketamin/esketamin (intranazal — FDA onayı 2019, ağır refrakter); EKT.
6. Psikoterapi birinci sıra alternatif — hafif-orta depresyonda monoterapi, ağır vakada farmakoterapi ile kombinasyon; spesifik yöntemler ve kanıt temeli "Tedavi metodolojileri" listesinde (BDT, İPT, davranış aktivasyonu, MBCT).
7. İntihar riski yönetimi — aktif değerlendirme; risk yüksekse yataklı yatış; araçlara (silah, ilaç) sınırlı erişim; psikososyal destek.
8. Tedavi süresi: ilk epizodda remisyondan sonra 6–12 ay devam; nüks durumlarında uzun süreli.

8.2 Farmakoterapi

Sınıf	Preparat	Doz aralığı	Not
SSRI	Sertralin, essitalopram, fluoksetin, paroksetin, sitalopram	Sertralin 50–200 mg; essitalopram 10–20 mg	Birinci sıra; cinsel yan etki; SIADH (yaşlılarda); sitalopram > 40 mg QT uzaması.
SNRI	Venlafaksin, duloksetin	Venlafaksin 75–375 mg; duloksetin 60–120 mg	Komorbid ağrı, anksiyete.
Atipik	Mirtazapin, bupropion, agomelatin, vortioksetin	Mirtazapin 15–45 mg; bupropion 150 –450 mg	Mirtazapin uyku ve iştah; bupropion cinsel yan etki yok.
TCA	Amitriptilin, nortriptilin	75–150 mg	İkinci-üçüncü sıra; kardiyak ve antikolinerjik yan etkiler; aşırı doz öldürücü.
MAOİ	Fenelzin, tranilsipromin		Refrakter; tiramin diyeti.
Esketamin (intranazal)	Spravato	56–84 mg	FDA 2019, refrakter; klinikte kontrol altında.

8.3 Tedavi metodolojileri

1. Depresyon için BDT — Beck (Beck A.) — Bilişsel yeniden yapılandırma, davranış aktivasyonu; 12–20 seans. Kanıt: Cuijpers P. ve ark. Cochrane meta-analizleri — orta etki, farmakoterapi ile karşılaştırmalı; kombinasyon monoterapiden üstün ağır vakada.
2. Kişilerarası Terapi (İPT / IPT — Interpersonal Therapy) — Klerman (Klerman G.), Weissman (Weissman M.) — 4 sorun alanı — yas, rol geçişi, rol çatışması, kişilerarası eksiklik. 12–16 seans. RKÇ'lerde BDT ile karşılaştırmalı etki.
3. Davranış Aktivasyonu (Behavioral Activation) — Jacobson N., Martell C — Olumlu etkinliklerin sistematik artırılması, kaçınmanın azaltılması.

Dimidjian S. ve ark. J Consult Clin Psychol 2006 RKÇ — BDT'ye karşılaştırmalı etki.

4. Mindfulness-Temelli Bilişsel Terapi (MBCT — Mindfulness-Based Cognitive Therapy) — Segal (Segal Z.), Williams (Williams M.), Teasdale (Teasdale J.) — Nüks profilaksisinde; özellikle ≥ 3 epizod öyküsü varsa etkisi antidepresan idameye üstün olabilir (Kuyken W. et al. Lancet 2015).
5. Hasta Sağlığı Anketi-9 (PHQ-9 — Patient Health Questionnaire-9) — Kroenke (K.), Spitzer (R.L.) — Birinci basamakta altın standart tarama ve izleme aracı.
6. HAM-D / MADRS — Klinisyen tarafından değerlendirilen depresif şiddet ölçekleri.
7. EKT — Ağır psikotik depresyon, refrakter, intihar riski, besin alımı bozukluğu, gebelik. UK ECT Review Group Lancet 2003 — EKT farmakoterapiden üstün ağır vakada.
8. Esketamin / Ketamin — FDA 2019 intranazal esketamin (Spravato) ağır refrakter depresyon için; hızlı antidepresan etki (saatler-günler); klinikte kontrol altında uygulama. Daly E.J. et al. JAMA Psychiatry 2018.
9. Tekrarlayan Transkraniyal Manyetik Stimülasyon (rTMS — repetitive Transcranial Magnetic Stimulation) — Refrakter depresyonda FDA onayı (2008); 4–6 hafta kürü, sol DLPFC hedefi.

8.4 Kaynaklar arasındaki farklar

- NICE NG222 (2022): Şiddete göre basamaklı algoritma; “daha hafif” — BDT veya rehberli kendi kendine yardım birinci basamak; “daha şiddetli” — kombinasyon.
- APA Practice Guideline (2010, 2019 güncellemesi): SSRI birinci basamak; BDT / İPT birinci basamak alternatif.
- CANMAT 2016: Şiddet ve olay temelinde 4 basamaklı algoritma.
- Cipriani A. et al. Lancet 2018 network meta-analiz: 21 antidepresan karşılaştırması — agomelatin ve amitriptilin en yüksek etki; fluoksetin, fluvoksamin, reboksetin ve trazodon en düşük. Uyumda (acceptability) en iyiler — agomelatin, sitalopram, essitalopram, fluoksetin, sertralin, vortioksetin; reboksetin ise hem etki hem uyum bakımından en altta yer aldı. Etki farkları klinik açıdan hafiftir.

9. Prognoz

- Spontan remisyon %50 bir yılda (ancak çoğu remisyon antidepresan olmadan); nüks riski yüksek.

- Her sonraki epizoddan sonra bir sonraki epizod riski artar.
- İntihar riski özellikle ilk haftalarda yüksektir.
- İzlem — PHQ-9 / MADRS, intihar riski, yan etkiler, uyum; ilk 12 hafta daha sık.
- Tedavi süresi — ilk epizodda remisyondan sonra 6–12 ay.

10. Mit ve yanlış inançlar

Mit 1: "Depresyon — sadece 'üzüntü'; iradeyle ortadan kaldırılır"

Kanıt: depresyon kompleks nörobiyolojik bozukluktur — HPA disregülasyonu, monoamin dengesizliği, yapısal değişiklikler (hipokamp); "iradi" kontrol edilmez. APA, WHO, NICE — tıbbi hastalık olarak.

Mit 2: "Antidepresan bağımlılık yapar"

Kanıt: SSRI ve SNRI'ler bağımlılık (addiction) yaratmazlar — kötüye kullanım veya tolerans yaratmazlar. Ancak kesilme sendromu mevcuttur (özellikle kısa yarı ömürlü paroksetin, venlafaksin) — bu bağımlılık değil, fizyolojik uyum; kademeli kesme ile çözülür.

Mit 3: "Antidepresan hastanın kişiliğini değiştirir"

Kanıt: antidepresan semptomları azaltır, kişiliği değiştirmez. Hasta "kendim gibi hissetmiyorum" diye şikayet ederse — yan etki (emosyonel düzleşme, emotional blunting) — ilaç değişimi veya doz azaltımı.

Mit 4: "Antidepresanlar plasebodan üstün değildir"

Kanıt: Cipriani Lancet 2018 — 21 antidepresan plasebodan anlamlı derecede üstün; ancak etki hafiftir, özellikle hafif depresyonda. Orta-ağır depresyonda etki klinik açıdan anlamlıdır.

Mit 5: "Diyet (omega-3, B vitaminleri, magnezyum) antidepresanın yerini alır"

Kanıt: bazı eklerin (omega-3, vitamin D eksikliğinde) hafif adjunkt etkisi olabilir, ancak orta-ağır depresyonda ana tedavinin yerini almaz. SMILES çalışması (Jacka F.N. BMC Med 2017) — Akdeniz tipi diyet hafif adjunkt.

Mit 6: “St John's Wort doğal antidepresandır, antidepresanın yerini alabilir”

Kanıt: St John's Wort hafif depresyonda etki gösterir (Cochrane Linde K. 2008), ancak orta-ağır depresyonda kanıt temeli sınırlıdır; CYP indüksiyonu ile birçok ilacın (kontraseptif, antikoagülan, antidepresan, antiretroviral) seviyesini düşürür — ciddi etkileşim.

Mit 7: “Sadece spor veya psikoterapi yeterlidir, ilaç gereksizdir”

Kanıt: hafif depresyonda psikoterapi ve egzersiz bazen yeterlidir, ancak orta-ağır depresyonda ve özellikle intihar riskinde farmakoterapi gereklidir; NICE NG222 ve APA 2010.

Mit 8: “EKT eskimiş veya travmatik bir tedavidir”

Kanıt: modern EKT (anestezi altında, kas gevşeticilerle) güvenli ve yüksek etkilidir; ağır refrakter ve psikotik depresyonda altın standart. UK ECT Review Group Lancet 2003.

Mit 9: “Antidepresanlar intihar yaratır”

Kanıt: FDA black box çocuk ve ergenlerde (özellikle ilk haftalarda) intihar düşüncelerinin artma riski — bu, klinik izlem zorunluluğu getirir, ancak uzun vadeli etkide antidepresanlar intihar riskini azaltır (Stone M. et al. BMJ 2009).

Mit 10: “Yas döneminde depresyon tanısı konulamaz”

Kanıt: DSM-5 “bereavement exclusion”u kaldırmıştır; yas ve major depresif epizod birlikte ortaya çıkabilir; yasın patolojik formları (uzamış yas bozukluğu — 6B43) ayrıdır.

Mit 11: “Sağlıklı hastalarda depresyon psikolojik ‘zayıflık’ belirtecidir”

Kanıt: depresyon herhangi bir kişide ortaya çıkabilir; “psikolojik güç” kavramı damgalayıcı ve yanlıştır; tıbbi durum olarak değerlendirilmelidir.

11. Kaynaklar

1. WHO. ICD-11. 6A70 Single episode depressive disorder. 2024.
2. APA. DSM-5-TR. 2022.
3. NICE NG222. Depression in adults: treatment and management. 2022.
4. APA. Practice Guideline for the Treatment of Patients with Major Depressive Disorder. 3rd ed. 2010.

5. Kennedy S.H., Lam R.W., McIntyre R.S. et al. Canadian Network for Mood and Anxiety Treatments (CANMAT) 2016 Clinical Guidelines for the Management of Adults with Major Depressive Disorder. Can J Psychiatry 2016;61(9):540–560.
6. Cipriani A., Furukawa T.A., Salanti G. ve ark. Comparative efficacy and acceptability of 21 antidepressant drugs for the acute treatment of adults with major depressive disorder: a systematic review and network meta-analysis. Lancet 2018;391(10128):1357–1366.
7. Hasin D.S., Sarvet A.L., Meyers J.L. et al. Epidemiology of adult DSM-5 major depressive disorder and its specifiers in the United States. JAMA Psychiatry 2018;75(4):336–346.
8. Howard D.M. et al. Genome-wide meta-analysis of depression identifies 102 independent variants. Nat Neurosci 2019;22(3):343–352.
9. Cuijpers P., Karyotaki E., de Wit L., Ebert D.D. The effects of fifteen evidence-supported therapies for adult depression: A meta-analytic review. Psychother Res 2020;30(3):279–293.
10. Kuyken W., Hayes R., Barrett B. et al. Effectiveness and cost-effectiveness of mindfulness-based cognitive therapy compared with maintenance antidepressant treatment in the prevention of depressive relapse. Lancet 2015;386(9988):63–73.
11. Kroenke K., Spitzer R.L., Williams J.B. The PHQ-9: validity of a brief depression severity measure. J Gen Intern Med 2001;16(9):606–613.
12. Daly E.J. et al. Efficacy and safety of intranasal esketamine adjunctive to oral antidepressant therapy in treatment-resistant depression. JAMA Psychiatry 2018;75(2):139–148.
13. Jacka F.N. ve ark. A randomised controlled trial of dietary improvement for adults with major depression (the “SMILES” trial). BMC Med 2017;15(1):23.
14. UK ECT Review Group. Lancet 2003;361(9360):799–808.
15. Stone M., Laughren T., Jones M.L. et al. Risk of suicidality in clinical trials of antidepressants in adults: analysis of proprietary data submitted to US Food and Drug Administration. BMJ 2009;339:b2880.
16. Beck A.T., Rush A.J., Shaw B.F., Emery G. Cognitive Therapy of Depression. New York: Guilford Press, 1979.
17. Martell C.R., Dimidjian S., Herman-Dunn R. Behavioral Activation for Depression: A Clinician’s Guide. New York: Guilford Press, 2010.
18. Weissman M.M., Markowitz J.C., Klerman G.L. Comprehensive Guide to Interpersonal Psychotherapy. New York: Basic Books, 2000.

19. Segal Z.V., Williams J.M.G., Teasdale J.D. Mindfulness-Based Cognitive Therapy for Depression. 2nd ed. New York: Guilford Press, 2013.
20. Jacobson N.S., Dobson K.S., Truax P.A. et al. A component analysis of cognitive-behavioral treatment for depression. J Consult Clin Psychol 1996;64(2):295–304.

ICD-11 **6A71**	**6A71 YİNELEYİCİ DEPRESİF BOZUKLUK** **Recurrent depressive disorder**
ICD-10 F33	Yineleyen depresif bozukluk
DSM-5-TR F33.x	Yeğin (Majör) Depresyon Bozukluğu, Yineleyen Dönem

1. Tanım ve nozoloji

Yineleyici depresif bozukluk (ICD-11: 6A71 Recurrent Depressive Disorder; DSM-5-TR: Major Depressive Disorder, Recurrent — F33.x) — en az iki major depresif epizodun varlığı, epizodlar arasında 2 aydan az sürmeyen kısmi veya tam remisyon. Manik veya hipomanik epizod öyküsü yoktur (varsa tanı bipolar bozukluktur).

Tek epizodlu depresif bozukluktan (6A70) yalnız epizod sayısıyla ayrılır; klinik belirtiler, tanı kriterleri ve tedavi prensipleri aynıdır, ancak uzun süreli idame farmakoterapisi rolü burada daha önemlidir.

2. Tarihçe

- Kraepelin (1899) — manik-depresif bozukluk çerçevesinde tekrarlayan depresif epizodlar.
- Leonhard K. (1957) — unipolar depresyon konsepti.
- DSM-III (1980), DSM-5 (2013) — Major Depressive Disorder, Recurrent resmi tanı olarak belirlendi.
- ICD-11 (2019) — Tek (6A70) ve Yinelenen (6A71) ayrı kodlanır.

3. Epidemiyoloji

- Major depresif bozukluk yaşam boyu yaygınlığı %15–20; bunun ~%50–80'i tekrarlayıcı seyir.
- Her sonraki epizoddan sonra bir sonraki epizod riski artar (Solomon D.A. et al. Am J Psychiatry 2000) — 1. epizoddan sonra ~%50, 2. sonra ~%70, 3. sonra ~%90.
- İntihar riski tek epizoddan yüksek, özellikle tedavisiz epizodlarda.

4. Etiyoloji ve patogenez

- Tek epizodlu (6A70) ile aynı — kalıtım ~%35–40 (Sullivan 2000); GWAS lokusları.
- Relaps predispozisyonu — daha fazla bilişsel yatkınlık, nörobiyolojik "kindling" (Post R.M.) konsepti — her epizoddan sonra bir sonraki için eşik düşer.
- Risk faktörleri — çocukluk travması, aile öyküsü, kronik stres, komorbid anksiyete, somatik hastalıklar.

5. Klinik özellikler

Tek epizodla aynı (bkz. 6A70 §5). Relaps hastalarda ek özellikler:

- Epizod manzarası önceki epizodlardan değişebilir (atipik özellikler, mevsimsel model).
- Relaps epizodlar tipik olarak öncekilerden daha sık başlar (kindling konsepti — Post R.M. Am J Psychiatry 1992).
- Artan sıklıkla komorbid anksiyete bozuklukları.
- Kronik kognitif defisitler gözlenebilir (özellikle çok sayıda epizoddan sonra).

6. Tanı

6.1 Birleşik tanı ölçütleri (DSM-5-TR · ICD-11)

A. En az 2 major depresif epizod (6A70 §6.1 kriterlerine uygun).

B. Epizodlar arasında ≥ 2 ay kısmi veya tam remisyon.

C. Hiçbir zaman manik veya hipomanik epizod olmamıştır.

D. Şizoaffektif, şizofreni veya diğer psikotik bozuklukla daha iyi açıklanmaz.

6.2 Kaynaklar arasındaki farklar

- ICD-11: mevcut epizod şiddeti (hafif, orta, ağır) ve psikotik özellik kalifikatörleri; remisyon durumu (kısmi, tam).
- DSM-5-TR: kalifikatörler 6A70 ile aynı.
- NICE NG222: ≥ 3 epizodu olan hastalarda MBCT (Mindfulness-Based Cognitive Therapy) nüks profilaksisinde özel öneri.

6.3 Tanı algoritması

1. Öykü — önceki epizodların sayısı, süre, tetikleyiciler, remisyon kalitesi.
2. Bipolar tarama (MDQ, HCL-32) — hipomanik epizodları dışlamak.
3. PHQ-9 / HAM-D / MADRS — mevcut epizod şiddeti.
4. C-SSRS — intihar riski (nüks hastalarda yüksek).
5. Laboratuvar (tiroid, B12, folat, ferritin); somatik komorbidite değerlendirmesi.

6.4 Ayırıcı tanı

6A70 ile aynı (bkz. tek epizod). Özel dikkat — bipolar epizodları dışlamak.

7. Muayene ve değerlendirme

6A70 ile aynı. Özel dikkat — kognitif defisitlerin değerlendirilmesi (çoklu epizoddan sonra).

8. Tedavi

8.1 Genel Prensipler (NICE NG222 · APA 2010 · CANMAT 2016)

1. Akut epizod tedavisi — 6A70 ile aynı (SSRI, BDT, kombinasyon).
2. İdame (maintenance) farmakoterapisi — uzun süreli:
    - 2 epizoddan sonra — remisyondan sonra 1–2 yıl devam.
    - ≥ 3 epizoddan sonra — uzun süreli (yıllar) veya ömür boyu idame.
    - Etkili olan antidepresan remisyondan sonra aynı dozda sürdürülür (doz azaltılması nüks riskini artırır).
3. MBCT (Mindfulness-Based Cognitive Therapy) — ≥ 3 epizod öyküsü olan hastalarda nüks profilaksisinde antidepresan idame ile karşılaştırmalı etki (Kuyken W. et al. Lancet 2015).
4. Lityum adjunkt — refrakter veya yüksek nüks riskli hastalarda; intihar azaltma etkisi (Cipriani BMJ 2013).

5. Relaps belirteçlerinin tanınması — hasta ve aile için psikoeğitim (uyku bozukluğu, irritabilite, sosyal geri çekilme, anhedoni).
6. Komorbidite tedavisi — anksiyete bozuklukları, madde kullanımı, kardiyovasküler — paralel.
7. İntihar riski izlemi — yüksek, özellikle yeni epizod başlangıcında.

8.2 Tedavi metodolojileri

1. Mindfulness-Temelli Bilişsel Terapi (MBCT — Mindfulness-Based Cognitive Therapy) — 8 haftalık grup programı; 2,5 saat seans + ev pratiği. Nüks önlemede ≥ 3 epizod öyküsü olan hastalarda etkili. Kuyken W. et al. Lancet 2015 RKÇ. mbct.com.
2. Antidepresan İdame Tedavisi (Maintenance) — Aynı preparat ve dozla uzun süreli kullanım; en az 2 yıl (≥ 3 epizoddan sonra); kesme sırasında kademeli (4–8 hafta).
3. BDT ve İPT idame formları — Aylık veya 2 haftada bir seans; nüks profilaksisi.
4. Lityum adjunkt — Yüksek intihar riski olan refrakter unipolar depresyonda; Cipriani BMJ 2013.

8.3 Kaynaklar arasındaki farklar

- NICE NG222 (2022): ≥ 3 epizod öyküsü varsa — MBCT veya antidepresan idame; ikisi karşılaştırmalı olarak etkili.
- APA 2010: sürdürme farmakoterapisi ≥ 2 epizoddan sonra; ≥ 3 epizoddan sonra uzun süreli.
- Geddes J.R. et al. Lancet 2003 meta-analiz: antidepresan idame, plaseboya göre nüksü azaltmada anlamlı üstünlük (NNT 5).

9. Prognoz

- Relaps riski her epizoddan sonra artar (Solomon 2000).
- Yeterli idame tedavisi ile nüks riski belirgin azalır (NNT 5).
- Komorbid anksiyete, somatik hastalıklar, uyum bozukluğu — kötü prognoz.
- İzlem — PHQ-9 monitörü; nüks belirteçleri; antidepresan düzeyi ve yan etkiler; intihar riski.

10. Mit ve yanlış inançlar

Mit 1: “Antidepresan ömür boyu kullanılamaz, ‘bağımlılık’ yapar”

Kanıt: SSRI/SNRI bağımlılık yaratmazlar; ≥ 3 epizod öyküsü olan hastalar için ömür boyu idame önerilir (NICE NG222, APA 2010). İdame dozunun azaltılması nüks riskini artırır.

Mit 2: “Remisyondan sonra antidepresanı hemen kesmek gerekir”

Kanıt: remisyondan sonra en az 6–12 ay (tek epizod) veya yıllar (nüks) sürdürülür; erken kesme nüks riskini önemli ölçüde artırır (Geddes Lancet 2003).

Mit 3: “Her epizodda ilaç değiştirilmelidir”

Kanıt: önceki epizodda etkili olan ilaç sonraki epizodda yeniden kullanılmalıdır (hasta-spesifik etkililik).

Mit 4: “Tekrarlayan depresif bozukluk 'kişilik zayıflığı'dır, tedavi uzun olmamalıdır”

Kanıt: nörobiyolojik “kindling” konsepti — her epizod yeni epizod riskini artırır; uzun süreli tedavi beyni “korur”.

Mit 5: “Yalnızca MBCT nüks profilaksisi için yeterlidir, farmakoterapi gereksizdir”

Kanıt: Kuyken Lancet 2015 — MBCT ve antidepresan idame karşılaştırmalı; ancak bireysel seçim — hasta değerleri, ulaşılabilirlik, önceki yanıt temelinde.

11. Kaynaklar

1. WHO. ICD-11. 6A71 Recurrent depressive disorder. 2024.
2. APA. DSM-5-TR. 2022.
3. NICE NG222. 2022.
4. APA. Practice Guideline for MDD. 3rd ed. 2010.
5. Kennedy S.H. et al. CANMAT 2016. Can J Psychiatry 2016;61(9):540–560.
6. Solomon D.A. et al. Multiple recurrences of major depressive disorder. Am J Psychiatry 2000;157(2):229–233.
7. Post R.M. Transduction of psychosocial stress into the neurobiology of recurrent affective disorder. Am J Psychiatry 1992;149(8):999–1010.
8. Geddes J.R. et al. Relapse prevention with antidepressant drug treatment in depressive disorders: a systematic review. Lancet 2003;361(9358):653–661.

9. Kuyken W. et al. Lancet 2015;386(9988):63–73.
10. Cipriani A. ve ark. BMJ 2013;346:f3646.

ICD-11 **6A72**	**6A72 DİSTİMİK BOZUKLUK** **Dysthymic disorder**
ICD-10 F34.1	Distimi
DSM-5-TR F34.1	Süregiden Depresyon Bozukluğu (Distimi)

1. Tanım ve nozoloji

Distimik bozukluk (ICD-11: 6A72 Dysthymic Disorder; DSM-5-TR: Süregiden Depresif Bozukluk — F34.1) — en az 2 yıl (yetişkinlerde; çocuk/ergenlerde 1 yıl) süren, majör depresif epizodun şiddetine ulaşmayan kronik depresif semptomlardır. Hasta durumunu "hep böyleydim" şeklinde açıklayabilir.

DSM-5-TR'de "Persistent Depressive Disorder" terimi distimi ve kronik major depresif bozukluğu birleştirir; ICD-11'de distimik ve kronik depresif epizod ayrı kodlanır.

2. Tarihçe

- Flemming C.F. (1844) — "distimi" teriminin psikiyatride ilk kullanımı; Kahlbaum (1882) — terime kronik, eşik altı depresif durum anlamını kazandırmıştır.
- Akiskal H.S. (1980'ler) — distimik mizacı depresif spektrumun alt-evre olarak.
- DSM-III (1980) — Distimik Bozukluk resmi tanı.
- DSM-5 (2013) — Persistan Depresif Bozukluk — distimi ve kronik MDD'nin birleştirilmesi.
- ICD-11 (2019) — distimik bozukluk ayrı tutulmuştur.

3. Epidemiyoloji

- Yaşam boyu yaygınlık: %1,1–6,4 (distimi); ABD'de 12 aylık yaygınlık ~%0,5, kronik majör depresyon için ek %1,5 (DSM-5-TR).

- Cinsiyet: kadınlarda 2 kat yüksek.
- Başlangıç: erken (çocuk/ergenlik — early-onset; ≥ 21 yaş — late-onset).
- "İkili depresyon" (double depression) — distimik bozukluk zemininde major depresif epizod — %76,9 hastada 5 yıl içinde görülür (Klein D.N. et al. Am J Psychiatry 2000;157(6)).
- Komorbidite: anksiyete, Sınırda KB, madde kullanımı.

4. Etiyoloji ve patogenez

- Major depresif bozukluk ile paylaşılan genetik ve nörobiyolojik yatkınlık.
- Çocukluk travması ve kronik psikososyal stres temel çevresel risk faktörleri.
- Yakın akrabalarda depresif bozukluk veya distimi sıklığı artmıştır.

5. Klinik özellikler

- Sürekli düşük duygudurum — zamanın çoğunda mevcut (zamanın ≥ yarısı, 2 yıl içinde 2 aydan fazla semptomsuz dönem yok).
- Aşağıdakilerden en az 2'si: düşük veya yüksek iştah, insomnia veya hipersomnia, düşük enerji, düşük özsaygı, konsantrasyon güçlüğü, umutsuzluk.
- Hasta çok sayıda işlevsel uzlaşmaya uyum sağlamıştır — "hep böyleydim" açıklaması tipiktir; kliniğe sıklıkla majör depresif epizod zemininde başvurur.

6. Tanı

6.1 Birleşik tanı ölçütleri

A. Sürekli depresif duygudurum ≥ 2 yıl (çocuklarda ≥ 1 yıl), günün büyük bölümünde, zamanın çoğunda.

B. Depresif dönemlerde ≥ 2 semptom (yukarıdaki).

C. 2 yıl (1 yıl) içinde 2 aydan fazla semptomsuz dönem yok.

D. Bu süre boyunca major depresif epizod kriterleri sürekli mevcut olabilir (DSM-5 — yeni "çifte depresyon" sentezi).

E. Hiçbir zaman manik veya hipomanik epizod olmamıştır.

F. Şizoaffektif veya diğer psikotik bozuklukla daha iyi açıklanmaz.

G. Madde veya tıbbi durum dışlaması.

H. Önemli sıkıntı veya işlevsel bozulma.

6.2 Kaynaklar arasındaki farklar

- DSM-5-TR: “Persistent Depressive Disorder” — distimi + kronik MDD birleştirilmiş; niteleyiciler — erken/geç başlangıç, anksiyöz sıkıntılı/olmayan, melankolik, atipik, peripartum, mevsimsel vb.
- ICD-11: distimik bozukluk (6A72) ayrı; kronik depresif epizod 6A70/71 içinde niteleyici.

6.3 Tanı algoritması

1. Klinik görüşme + uzun süreli geçmiş (hasta kesin başlangıcı hatırlamayabilir).
2. SCID-5; PHQ-9, HAM-D, MADRS.
3. Bipolar taraması.
4. Kişilik değerlendirmesi — BPD ile ayırıcı tanı.
5. Tıbbi ve laboratuvar (tiroid, anemi, B12).

6.4 Ayırıcı tanı

Durum	**Ayırt edici belirtiler**
Majör depresif bozukluk (6A70/6A71)	Diskret epizodlar; belirtiler arasında ara dönemde duygudurum normaldir.
Siklotimik bozukluk (6A62)	Hipomanik dönemler mevcut.
BPD (6D10.x)	Duygusal değişkenlik saatler içinde; kimlik bozukluğu.
Uyum bozukluğu (6B43)	Stres faktörüne yanıt; ≤ 6 ay.
Hipotireoid	TSH.

7. Muayene ve değerlendirme

- PHQ-9, HAM-D, MADRS.
- Cornell Dysthymia Rating Scale — distimik-spesifik.
- Tıbbi ve laboratuvar.

8. Tedavi

1. Farmakoterapi: SSRI (sertralin, fluoksetin) — birinci basamak; etki 6–8 hafta sürebilir (majör depresyondan yavaş).

2. Psikoterapi: CBASP (Cognitive Behavioral Analysis System of Psychotherapy — McCullough J.) — özellikle kronik depresyon için geliştirilmiştir; BDT, İPT.
3. Kombinasyon — distimik bozuklukta monoterapiden üstün (Keller M.B. et al. NEJM 2000 — nefazodon + CBASP RKÇ).
4. "İkili depresyon"da — akut epizodu majör depresif gibi tedavi + uzun süreli idame.
5. Refrakter — ilaç değişimi, augmentasyon (lityum, atipik antipsikotik).

8.1 Tedavi metodolojileri

1. Psikoterapinin Bilişsel-Davranışsal Analiz Sistemi (CBASP — Cognitive Behavioral Analysis System of Psychotherapy) — McCullough J — Kronik depresyon için özel olarak geliştirilmiş yaklaşım — durum analizi, kişilerarası davranış öğretimi, terapötik ilişkinin temel araç olarak kullanımı. Keller M.B. et al. NEJM 2000 RKÇ.
2. SSRI uzun süreli — Sertralin, fluoksetin, essitalopram; yavaş yanıt; uzun idame.
3. BDT ve İPT — Standart depresif tedaviler; kronik formda modifikasyonlu.

8.2 Kaynaklar arasındaki farklar

- NICE NG222 — kronik depresif belirtiler için uzun süreli bilişsel davranışçı tedavi önerir (kılavuzda CBASP adı geçmez); CBASP'yi adıyla öneren kaynak APA 2010'dur.
- APA 2010 — kombinasyon üstün.
- Keller M.B. et al. NEJM 2000 — nefazodon + CBASP kombinasyonu monoterapiden anlamlı üstün.

9. Prognoz

- Kronik seyir; spontan remisyon azdır.
- "İkili depresyon" — distimisi olan ve daha önce majör epizod geçirmemiş hastaların %76,9'unda 5 yıl içinde gelişir (Klein D.N. et al. Am J Psychiatry 2000).
- Uzun süreli tedavi ile fonksiyonel düzey iyileşir.
- İzlem — periyodik ölçekler, uyum, komorbidite.

10. Mit ve yanlış inançlar

Mit 1: “Distimi — sadece ‘kederli karakter’, tıbbi bir bozukluk değildir”

Kanıt: sürekli fonksiyonel bozulma, intihar riski, “çifte depresyon” gelişimi; tıbbi bozukluk olarak değerlendirilmelidir.

Mit 2: “Distimik hasta antidepresana yanıt vermez”

Kanıt: yanıt yavaştır (6–8 hafta), ancak SSRI'lar etkilidir; CBASP ile kombinasyon üstün.

Mit 3: “Kronik depresyon yalnızca psikoterapi gerektirir, ilaçlar yardımcı değildir”

Kanıt: Keller NEJM 2000 — nefazodon + CBASP kombinasyonu monoterapiden üstün; farmakoterapi ana bileşendir.

Mit 4: “Hastanın ‘hep böyleydim’ açıklaması tanı temeli değildir — adaptasyon olarak kabul edilmelidir”

Kanıt: bu hasta perspektifi az-tanınma sorunu yaratır — uzun vadeli işlevsel uzlaşma tıbbi durum belirteci olabilir.

Mit 5: “Bitkisel preparatlar distimik için güvenli alternatiftir”

Kanıt: St John's Wort hafif depresyonda bazı etki gösterir, ancak CYP indüksiyon etkileşimi; standart antidepresan üstün.

11. Kaynaklar

1. WHO. ICD-11. 6A72 Dysthymic disorder. 2024.
2. APA. DSM-5-TR. 2022.
3. NICE NG222. 2022.
4. Keller M.B., McCullough J.P., Klein D.N. et al. A comparison of nefazodone, the cognitive behavioral-analysis system of psychotherapy, and their combination for the treatment of chronic depression. NEJM 2000;342(20):1462–1470.
5. Klein D.N., Shankman S.A., Rose S. Ten-year prospective follow-up study of the naturalistic course of dysthymic disorder and double depression. Am J Psychiatry 2006;163(5):872–880.
6. McCullough J.P. Treatment for Chronic Depression: Cognitive Behavioral Analysis System of Psychotherapy. Guilford Press; 2000.

ICD-11 **GA34.41**	**GA34.41 PREMENSTRÜEL DİSFORİK BOZUKLUK (PMDD)** **Premenstrual dysphoric disorder**
ICD-10 N94.3	Premenstrüal gerilim sendromu
DSM-5-TR N94.3	Aybaşı Öncesi (Premenstrüel) Disfori Bozukluğu

1. Tanım ve nozoloji

Premenstrüel Disforik Bozukluk (ICD-11: GA34.41; DSM-5-TR: N94.3) — menstrual siklustan önceki son haftada (luteal faz) belirgin duygusal ve davranışsal semptomlar, menstruasyon başladıktan sonra birkaç gün içinde tamamen geçen tekrarlayıcı bozukluktur. Premenstrüel Sendromdan (PMS) klinik şiddet ve belirgin işlevsel bozulma ile ayrılır.

2. Tarihçe

- Frank R.T. (1931) — premenstrüel gerginlik terimi.
- DSM-IV (1994) — Premenstrüel Disforik Bozukluk Section III araştırma kategorisinde.
- DSM-5 (2013) — depresif bozukluklar kategorisinde resmi tanı olarak kabul edilmiştir.
- ICD-11 (2019) — duygudurum bozuklukları içinde ayrı kategori olarak.

3. Epidemiyoloji

- Reproduktif yaştaki kadınlarda yaygınlık: %3–8 (Yonkers K.A. et al. Lancet 2008 derlemesi).
- PMS — daha hafif form — kadınların %30–80'inde.
- Komorbidite: majör depresif bozukluk, anksiyete, bipolar bozukluk — riski artırır.
- Suicidal düşünceler luteal fazda anlamlı şekilde artar.

4. Etiyoloji ve patogenez

- Genetik: Kalıtım ~%30–50 (Treloar S.A. et al. Psychol Med 2002 ikiz çalışmaları).
- Hormonal duyarlılık: PMDD hastalarının over hormonları (östrojen, progesteron) normal düzeydedir; ancak hassasiyet artmıştır — allopregnanolon (progesteron metaboliti) GABA-A reseptörleri üzerinde anormal etki gösterir (Schmidt P.J. et al. NEJM 1998 over supresyonu ve hormon replasman tedavisi çalışması).
- Serotonerjik disregülasyon: SSRI'ların hızlı etkisi (1–2 gün, klasik depresyondan farklı) bu mekanizmayı destekler.

5. Klinik özellikler

5.1 Afektif ve davranışsal semptomlar (luteal fazda)

- Afektif labilite (ani değişen duygudurum, ağlamaklılık, reddedilme duyarlılığı).
- İrritabilite ve öfkeli patlamalar (kişilerarası çatışma).
- Düşük duygudurum, umutsuzluk, özeleştiri.
- Anksiyete, gerginlik.

5.2 Davranışsal ve somatik semptomlar

- Olağan aktivitelere ilgide azalma.
- Konsantrasyon güçlüğü.
- Letarji ve yorgunluk.
- İştah değişikliği (özellikle karbonhidrat ihtiyacı), aşırı yeme.
- Uyku bozukluğu (insomni veya hipersomni).
- Kontrol kaybı hissi.
- Somatik — vücutta şişlik, bel ağrısı, baş ağrısı, meme hassasiyeti.

5.3 Süre ve ritim

Semptomlar luteal fazda (menstrüasyon öncesi 1 hafta) başlar, menstrüasyon başladıktan sonra birkaç gün içinde tamamen geçer; foliküler fazda (menstrüasyon sonrası) tam remisyon.

6. Tanı

6.1 Birleşik tanı ölçütleri (DSM-5-TR · ICD-11)

A. Çoğu menstrual siklusta luteal fazın son haftasında 5+ semptom; menstrüasyon başladıktan sonra birkaç gün içinde azalır; postmenstrual fazda tam remisyon.

B. Aşağıdakilerden en az 1'i:

1. Afektif labilite;
2. İrritabilite veya öfke;
3. Düşük duygudurum veya özeleştiri;
4. Anksiyete ve gerginlik.

C. Aşağıdakilerden ek semptomlar (B + C toplam 5+):

5. İlgi azalması;
6. Konsantrasyon güçlüğü;
7. Letarji, yorgunluk;
8. İştah değişikliği, aşırı yeme;
9. Uyku bozukluğu;
10. Kontrol kaybı hissi;
11. Somatik (şişlik, ağrı vb.).

D. Önemli sıkıntı veya işlevsel bozulma.

E. Prospektif duygu durum günlüğü ≥ 2 siklus — tanı doğrulaması için zorunlu.

F. Başka bir psikiyatrik bozukluğun (MDD, panik, distimik) semptom artışı değildir (PMDD ayrı tanıdır; ancak bu bozukluklar zemininde de ortaya çıkabilir — "premenstrual exacerbation").

6.2 Tanı algoritması

1. Klinik görüşme — siklusla ilişkili semptomların ritmi.
2. Prospektif duygu durum günlüğü 2 siklus — DRSP (Daily Record of Severity of Problems, Endicott J.) veya PRISM (Premenstrual Record of Impact and Severity of Menstruation) — tanı retrospektif anamnezle doğrulanamaz.
3. Komorbidite taraması (depresyon, anksiyete, bipolar).
4. Tibbi (tireoid, anemi, polikistik over).

6.3 Ayırıcı tanı

Durum	Ayırt edici belirtiler
PMS (premenstrual sendrom)	Hafif semptomlar, fonksiyonel bozulma yok.
MDD luteal alevlenmesi	Temel bozukluk (MDD) tüm siklusta mevcuttur, luteal fazda şiddetlenir.
Bipolar bozukluk	Hipomanik/manik epizodlar mevcut.
Tireoid bozukluğu	TSH.
Endometrioz, dismenore	Pelvik ağrı dominant; duygudurum belirtileri az.

7. Muayene ve değerlendirme

- DRSP veya PRISM duygudurum günlüğü.
- PHQ-9, GAD-7 — komorbidite.
- Pelvik muayene (jinekolog) ve TSH — somatik nedenler dışlanır.

8. Tedavi

8.1 Genel prensipler (ACOG · ISPMD · APA 2010)

1. SSRI birinci basamak: Fluoksetin, sertralin, paroksetin (FDA onayı PMDD için), essitalopram. İki mod mümkündür:
    - Sürekli (günlük): tüm döngüde.
    - Luteal faza intermitent: ovulasyondan menstrüasyon başlangıcına kadar (14 gün) — aynı etkili (Steiner M. et al. NEJM 1995 RKÇ).
2. Hormon supresyonu — kombine oral kontraseptifler (özellikle drospirenon içeren — Yaz, Beyaz; FDA onaylı); refrakter vakalarda GnRH agonistleri (leuprolid).
3. Ooforektomi — son seçenek, refrakter ağır vakalarda; östrojen replasman tedavisi ile.
4. BDT — adjunkt; Lustyk M.K. et al. derlemeleri ılımlı etki göstermiştir.
5. Yaşam tarzı: Fiziksel aktivite, kafein ve alkol azaltma — adjunkt.
6. Kalsiyum takviyesi (1200 mg/gün) — Thys-Jacobs S. et al. Am J Obstet Gynecol 1998 RKÇ — hafif etki; adjuvan rolde.

8.2 Tedavi metodolojileri

1. Sorunların Şiddetinin Günlük Kaydı (DRSP — Daily Record of Severity of Problems) — Endicott (Endicott J.) — 21 semptom, günlük 1–6 puan kaydı; PMDD tanısı için prospektif 2 siklus gerekir.
2. SSRI — Luteal Faz Rejimi — Ovulasyondan (14. gün) menstrüasyon başlangıcına kadar; sürekli kullanım kadar etkili. Steiner M. et al. NEJM 1995.
3. Drospirenon içeren Oral Kontraseptif — Yaz, Beyaz — FDA onayı PMDD için; hormonal stabilizasyon.
4. GnRH Agonist (Leuprolid) — Refrakter durumlarda over süpresyonu; uzun süreli kullanımda osteoporoz riski.

8.3 Kaynaklar arasındaki farklar

- ACOG (American College of Obstetricians and Gynecologists) Practice Bulletin: SSRI birinci basamak; oral kontraseptif ikinci.
- ISPMD (International Society for Premenstrual Disorders) konsensus: sürekli veya luteal SSRI aynı etkinlik; GnRH refrakter.

9. Prognoz

- SSRI veya hormonal tedavi ile çoğu hastada anlamlı iyileşme.
- Reproduktif dönem boyunca devam eder; menopozdan sonra remisyon.
- İzlem — siklus belirtileri, uyum, yan etkiler, komorbidite.

10. Mit ve yanlış inançlar

Mit 1: “PMDD 'kadın irade zayıflığı'dır, tıbbi bir bozukluk değildir”

Kanıt: Schmidt P.J. NEJM 1998 — overiyal hormonların supresyonu semptomları ortadan kaldırır, hormon yeniden başlaması semptomları geri getirir; nörobiyolojik temelli bozukluktur. DSM-5 ve ICD-11 resmi tanı.

Mit 2: “PMDD aynı zamanda PMS'dir, fark yoktur”

Kanıt: PMS kadınların %30–80'inde hafif formda; PMDD klinik şiddet ve fonksiyonel bozulma ile karakterizedir — %3–8 kadınlar.

Mit 3: “SSRI PMDD'de anlamlı etki göstermez, depresyon gibi beklemek gerekir”

Kanıt: SSRI PMDD'de hızlı (1–2 gün içinde) etki gösterir — majör depresyondan farklı farmakokinetik mekanizma; serotonerjik sistem üzerinde doğrudan etki gösterir.

Mit 4: “Yalnızca hormonal tedavi (gebelik, hormon replasmanı) etkilidir”

Kanıt: SSRI ve hormonal tedavi her ikisi de etkilidir; SSRI birinci basamak (çoğu hasta için); hormonal — jinekolojik komorbidite veya hasta tercihi ile.

Mit 5: “Bitkisel preparatlar (chasteberry, evening primrose oil, St John's Wort) PMDD'yi iyileştirir”

Kanıt: chasteberry (Vitex agnus-castus) bazı çalışmalarda PMS için hafif etki; PMDD için kanıt temeli sınırlıdır. Evening primrose oil — Cochrane olumsuz sonuçlar. St John's Wort — SSRI ile etkileşim riski.

Mit 6: “Kraniosakral terapi, homeopati, akupunktur PMDD'yi geçirir”

Kanıt: bu tamamlayıcı müdahalelerin PMDD için etkisi kanıtlanmamıştır.

Mit 7: “PMDD tanısı retrospektif anamnezden konulabilir”

Kanıt: retrospektif kayıtlar güvenilmezdir; prospektif 2 siklus günlüğü tanı için zorunludur — bu en sık az-tanı nedeni.

11. Kaynaklar

1. WHO. ICD-11. GA34.41 Premenstrual dysphoric disorder. 2024.
2. APA. DSM-5-TR. 2022.
3. Yonkers K.A., O'Brien P.M., Eriksson E. Premenstrual syndrome. Lancet 2008;371(9619):1200–1210.
4. Schmidt P.J., Nieman L.K., Danaceau M.A., Adams L.F., Rubinow D.R. Differential behavioral effects of gonadal steroids in women with and in those without premenstrual syndrome. NEJM 1998;338(4):209–216.
5. Steiner M., Steinberg S., Stewart D. et al. Fluoxetine in the treatment of premenstrual dysphoria. NEJM 1995;332(23):1529–1534.
6. Thys-Jacobs S., Starkey P., Bernstein D., Tian J. Calcium carbonate and the premenstrual syndrome. Am J Obstet Gynecol 1998;179(2):444–452.
7. ACOG Practice Bulletin No. 15. Premenstrual syndrome. 2000 (reviewed).

8. Nevatte T., O'Brien P.M.S., Bäckström T. et al. ISPMD consensus on the management of premenstrual disorders. Arch Womens Ment Health 2013;16(4):279–291.
9. Ismaili E., Walsh S., O'Brien P.M.S. et al. Fourth consensus of the International Society for Premenstrual Disorders (ISPMD): auditable standards for diagnosis and management of premenstrual disorder. Arch Womens Ment Health 2016;19(6):953–958.
10. Treloar S.A., Heath A.C., Martin N.G. Genetic and environmental influences on premenstrual symptoms. Psychol Med 2002;32(1):25–38.
11. Marjoribanks J., Brown J., O'Brien P.M.S., Wyatt K. Selective serotonin reuptake inhibitors for premenstrual syndrome. Cochrane Database Syst Rev 2013;(6):CD001396.
12. Endicott J., Nee J., Harrison W. Daily Record of Severity of Problems (DRSP): reliability and validity. Arch Womens Ment Health 2006;9(1):41–49.
13. Lustyk M.K.B., Gerrish W.G., Shaver S., Keys S.L. Cognitive-behavioral therapy for premenstrual syndrome and premenstrual dysphoric disorder: a systematic review. Arch Womens Ment Health 2009;12(2):85–96.

6B00–6B0Z ANKSİYETE BOZUKLUKLARI

Anxiety or fear-related disorders

ICD-11 **6B00**	**6B00 YAYGIN ANKSİYETE BOZUKLUĞU (YAB)** **Generalised anxiety disorder**
ICD-10 F41.1	Yaygın anksiyete bozukluğu
DSM-5-TR F41.1	Yaygın Kaygı Bozukluğu

1. Tanım ve nozoloji

Yaygın anksiyete bozukluğu (ICD-11: 6B00 Generalised Anxiety Disorder; DSM-5-TR: F41.1) — en az birkaç ay (DSM-5-TR'de ≥ 6 ay) süren, çok sayıda yaşam alanını (iş, aile, sağlık, günlük konular) kapsayan, kontrol edilemeyen, yeterli tetikleyicisi olmayan aşırı kaygı ile karakterize bozukluktur. Önemli somatik semptomlar (gerginlik, yorgunluk, uyku bozukluğu) eşlik eder.

2. Tarihçe

- 1920–60'lı yıllar — "anxiety neurosis" terimi, Freud etkisine bağlı.
- DSM-III (1980) — anksiyete nevrozu → panik bozukluk ve YAB ayrılması; YAB artık kategoriydi.
- DSM-IV (1994), DSM-5 (2013) — YAB ayrı bir bozukluk olarak; ≥ 6 aylık süre; karakteristik somatik belirtiler.
- ICD-11 (2019) — tanı için süre gereksinimini "birkaç ay" olarak formüle etmiştir (DSM-5'ten daha az katı).

3. Epidemiyoloji

- Yaşam boyu yaygınlık: %3–9 (Kessler R.C. ve ark. WMH derlemeleri).
- Yıllık yaygınlık: ~%2–3.

- Cinsiyet: kadınlarda 2 kat yüksek.
- Başlangıç — bimodal — ergenlik ve orta yaş; çoğunlukla kronik seyir.
- Komorbidite: MDD ~%60, sosyal anksiyete, panik, madde kullanımı, somatik (irritabl bağırsak, kardiyak şikayetler).

4. Etiyoloji ve patogenez

- Kalıtım %30–40 (Hettema J.M. et al. Am J Psychiatry 2001 meta-analiz).
- Nörobiyolojik — amigdala hiperresponsivitesi, prefrontal-amigdala düzenlemesinin bozulması; GABA-erjik ve serotonerjik disregülasyon.
- Kişilik özellikleri (nörotisizm, davranışsal inhibisyon) yüksek risk faktörleri.
- Çevre — çocukluk travması, kronik stres, ebeveyn aşırı korumacılığı.

5. Klinik özellikler

5.1 Psikolojik semptomlar

- Çok sayıda alanı kapsayan kontrol edilemeyen endişe.
- "Endişe hakkında endişe" — meta-anksiyete (Wells A. konsepti).
- Konsantrasyon güçlüğü, zihnin boş kalması.
- İrritabilite.

5.2 Somatik semptomlar

- Kas gerginliği.
- Yorgunluk.
- Uyku bozukluğu (uyumakta zorluk, uykuyu sürdürmede güçlük).
- Otonom semptomlar (taşikardi, terleme, ağız kuruluğu, baş ağrısı).
- Gastrointestinal şikayetler — IBS komorbiditesi sıktır.

6. Tanı

6.1 Birleşik tanı ölçütleri

A. Aşırı kaygı veya gerginlik, çok sayıda alana yönelik; günlük aktivite zamanının çoğunda mevcut; ≥ 6 ay (DSM-5-TR) / birkaç ay (ICD-11).

B. Anksiyeteyi yönetme güçlüğü.

C. Aşağıdakilerden ≥ 3 semptom (çocuklarda 1):

1. Huzursuzluk, sinirlilik, gergin veya «diken üstünde» olma hissi;

2. Kolayca yorulma
3. Konsantrasyon güçlüğü;
4. İrritabilite;
5. Kas gerginliği;
6. Uyku bozukluğu.

D. Önemli sıkıntı veya işlevsel bozulma.

E. Madde veya tıbbi durum dışlaması.

F. Başka bir psikiyatrik bozuklukla daha iyi açıklanmaz.

6.2 Kaynaklar arasındaki farklar

- DSM-5-TR: ≥ 6 aylık süre; ≥ 3 somatik semptom.
- ICD-11: süre "birkaç ay" — daha az katı; somatik semptomlar gereklidir, ancak spesifik sayı belirtilmez.
- NICE CG113 (Erişkinlerde yaygın anksiyete bozukluğu ve panik bozukluğu: yönetim, 2011, 2020 güncellemesi): basamaklı bakım (stepped care) — psikoeğitim + izlem → rehberli kendi kendine yardım → BDT veya farmakoterapi → kombinasyon → ağır vakada uzmanlaşmış hizmet.

6.3 Tanı algoritması

1. Klinik görüşme (endişe alanları, tetikleyiciler, somatik belirtiler, kaçınma).
2. SCID-5, MINI.
3. GAD-7 (tarama, başlangıç göstergeleri ve izleme) — ≥ 10 orta-ağır kaygı.
4. HAM-A (Hamilton Anksiyete) — klinisyen tarafından derecelendirilir.
5. Komorbidite taraması (PHQ-9 depresyon, panik, sosyal anksiyete).
6. Somatik nedeni dışla — TSH, anemi, kardiyak, kafein veya stimülan kullanımı.

6.4 Ayırıcı tanı

Durum	**Ayırt edici belirtiler**
Panik bozukluğu (6B01)	Diskret panik atakalar.
Sosyal anksiyete (6B04)	Sosyal değerlendirme korkusu dominant.
OKB (6B20)	Ego-distonik obsesyonlar, kompulsiyonlar.

Durum	Ayırt edici belirtiler
TSSB (6B40)	Travma öyküsü, intrusif semptomlar.
Majör depresif (6A70/6A71)	Afektif semptomlar dominant.
Hipertireoid	TSH azalması, fiziksel belirtiler.
Kafein veya stimülan intoksikasyonu	Kullanım öyküsü.
Aritmi, feokromositoma	Spesifik kardiyak ve endokrin testler.

7. Muayene ve değerlendirme

- GAD-7, HAM-A, PSWQ (Penn State Worry Questionnaire).
- Tıbbi ve laboratuvar (TSH, tam kan, kafein ve alkol kullanımı değerlendirmesi).
- EKG (kardiyak şikayet varsa).

8. Tedavi

8.1 Basamaklı yaklaşım (NICE CG113 · CANMAT 2014)

1. Basamak 1 — psikoeğitim ve aktif izlem.
2. Basamak 2 — rehberlik altında kendine yardım (internet temelli BDT), psikoeğitim grupları.
3. Basamak 3 — yüksek yoğunluklu BDT veya farmakoterapi.
4. Basamak 4 — uzmanlaşmış hizmet: kombinasyon tedavisi, dirençli olgular.

8.2 Birinci basamak

Psikoterapi — bilişsel davranışçı terapi (BDT). En güçlü kanıt tabanına sahip yöntem; 12–20 seans. Bileşenleri:

- Bilişsel yeniden yapılandırma — kaygıya ilişkin inançların sınanması: “endişelenmek beni hazırlıklı tutar” türü yargılar olgularla karşılaştırılır.
- Belirsizliğe tahammülsüzlükle çalışma (Dugas M.J. modeli) — hasta sonucu bilinmeyen durumları bilerek yaşar ve tahammülünü artırır.
- Maruz bırakma — kaygı doğuran durumlardan kaçınmanın kademeli olarak bırakılması; ertelenmiş kararların uygulanması.
- Problem çözme eğitimi — gerçek sorunu uygulanabilir adımlara bölmek, çözülemeyeni kabul etmek.
- Gevşeme — progresif kas gevşetme, diyafragmatik solunum.

Etki: Cuijpers P. ve arkadaşlarının derlemelerinde orta-büyük etki büyüklüğü; sonuç farmakoterapiyle karşılaştırılabilir, nüks riski ise daha düşüktür.

Farmakoterapi. Etki 4–6 haftada değerlendirilir, tam yanıt için 8–12 hafta gerekebilir:

- SSRI — sertralin, essitalopram, paroksetin.
- SNRI — venlafaksin, duloksetin.
- Başlangıç dozu düşük tutulur: ilk günlerde kaygının geçici artışı olabilir.

Slee A. ve arkadaşları (Lancet 2019) ağ meta-analizi: duloksetin, pregabalin ve venlafaksin yüksek etkinlik göstermiştir; tolerabilite profili ilaçtan ilaça değişir.

8.3 İkinci basamak

- Pregabalin — Avrupa'da bu endikasyonda onaylıdır; hızlı etki eder, ancak bağımlılık potansiyeli taşır.
- Buspiron — kısmi etki; benzodiazepine alternatif olarak.
- Mirtazapin — uyku bozukluğu eşlik ediyorsa ek ilaç.
- Ketiapin — CANMAT 2014'te ikinci basamak; metabolik yan etkiler nedeniyle sınırlı kullanım.

8.4 Kısa süreli kullanım ve sınırlar

- Benzodiazepinler — yalnızca akut dönemde, 2–4 haftayı aşmadan. Bağımlılık potansiyeli yüksektir, sürekli kullanım önerilmez.

8.5 Ek yöntemler

- Farkındalık temelli stres azaltma ve bilişsel terapi (MBSR / MBCT) — 8 haftalık grup programı; bu bozuklukta hafif etki. Hofmann S.G. ve ark., J Consult Clin Psychol 2010 meta-analiz.
- Kabul ve kararlılık terapisi (ACT) — semptomla savaşmak yerine onunla birlikte değerlere uygun yaşamayı öğretir; psikolojik esnekliği artırır. Roemer L. ve arkadaşlarının randomize çalışmaları.
- Uygulamalı gevşeme (Öst L.G. yöntemi) — yapılandırılmış progresif kas gevşetme, kaygı tetikleyicisi karşısında uygulanır.
- Yaşam tarzı — kafeinin sınırlandırılması, düzenli fiziksel aktivite, uyku hijyeni, alkol ve psikoaktif maddelerden kaçınma.

8.6 Tedavi süresi

- Remisyondan sonra en az 12 ay sürdürülür.
- Kronik seyir veya çok sayıda nüks durumunda tedavi uzun süreli planlanır.

- Bırakma kademelidir: ani kesme geri dönüş riskini artırır.

8.7 Kaynaklar arasındaki farklar

- NICE CG113 (2011, 2020'de teyit edilmiştir) — basamaklı yaklaşım; birinci basamak farmakoterapi SSRI ve SNRI; benzodiazepin yalnızca akut ve kısa süreli.
- APA — bu bozukluk için ayrı kılavuzu yoktur; ailedeki tek belge panik bozukluğa aittir (2009, arşiv statüsünde). Bu nedenle NICE CG113 ve CANMAT 2014'e atıf yapılır.
- CANMAT 2014 (Katzman M.A. ve ark.) — birinci basamak essitalopram, sertralin, venlafaksin, duloksetin; ikinci basamak pregabalin, buspiron, mirtazapin, ketiapin.

9. Prognoz

- Kronik seyir; spontan remisyon az.
- Yeterli tedavi ile belirgin semptom azalması ve fonksiyonel iyileşme.
- Komorbid MDD kötü prognoz markeri.
- İzlem — GAD-7 monitörü, yan etkiler, uyum, komorbidite.

10. Mit ve yanlış inançlar

Mit 1: "Kaygı normal bir yaşam hissidir, tıbbi bir durum değildir"

Kanıt: normal kaygı ve YAB arasında klinik fark mevcuttur — şiddet, süre (≥ 6 ay), kontrol edilememe, somatik bileşenler, fonksiyonel bozulma. Klinik tanı belirli kriterlere dayanarak konur.

Mit 2: "Benzodiazepinler YAB'ın birinci basamak tedavisidir"

Kanıt: NICE CG113, APA, CANMAT — benzodiazepinler yalnızca kısa süreli (2–4 hafta) kullanım için; bağımlılık potansiyeli yüksektir; SSRI ve SNRI birinci basamak.

Mit 3: "Yalnızca relaksasyon ya da yoga YAB'ı iyileştirir"

Kanıt: hafif adjunkt etki gösterirler, ancak orta-ağır vakada BDT ve/veya farmakoterapi gereklidir.

Mit 4: "Antidepresan anksiyete için etkisizdir — depresyon içindir"

Kanıt: SSRI ve SNRI anksiyete bozukluklarında etkilidir; serotonerjik sistemin amigdala aktivitesine etkisi ile. CANMAT 2014, Slee Lancet 2019.

Mit 5: “Hasta iradi olarak rahatsız olmamayı öğrenebilir”

Kanıt: YAB nörobiyolojik disregülasyondur; BDT veya farmakoterapi nörobiyolojik düzeyde etki eder.

Mit 6: “Kafein kısıtlaması YAB için yeterlidir”

Kanıt: Kafein semptomları şiddetlendirebilir; kısıtlama adjunkt adım, ana tedavi değildir.

Mit 7: “Bitkisel preparatlar (kava, valerian, passiflora) standart tedavinin yerini alabilir”

Kanıt: Kava ciddi hepatotoksisite (birkaç ölüm vakası — FDA uyarısı); kediotu ve çarkıfelek etkisi zayıf; St John's Wort etkileşim.

Mit 8: “Kannabis (CBD) anksiyeteyi iyileştirir”

Kanıt: CBD için ön çalışmalar mevcut, ancak klinik öneri için yeterli değil; THC kaygıyı artırabilir veya panik atağa neden olabilir.

Mit 9: “Antidepresanı ömür boyu kullanmak zorunda kalacaksın”

Kanıt: remisyondan sonra 12 ay; sonra kademeli kesme mümkündür; nüks halinde yeniden başlanır.

Mit 10: “Refrakter YAB'da elektrokonvülsif terapi etkilidir”

Kanıt: EKT YAB için endikasyon değil; refrakter durumda — ilaç değişimi, kombinasyon, atipik antipsikotik adjunkt.

11. Kaynaklar

1. WHO. ICD-11. 6B00 Generalised anxiety disorder. 2024.
2. APA. DSM-5-TR. 2022.
3. NICE CG113. Generalised anxiety disorder and panic disorder in adults: management. 2011, 2020 update.
4. Katzman M.A. et al. Canadian clinical practice guidelines for the management of anxiety, posttraumatic stress and obsessive-compulsive disorders. BMC Psychiatry 2014;14(Suppl 1):S1.
5. Slee A., Nazareth I., Bondaronek P. et al. Pharmacological treatments for generalised anxiety disorder: a systematic review and network meta-analysis. Lancet 2019;393(10173):768–777.

6. Hettema J.M., Neale M.C., Kendler K.S. A review and meta-analysis of the genetic epidemiology of anxiety disorders. Am J Psychiatry 2001;158(10):1568–1578.
7. Hofmann S.G., Sawyer A.T., Witt A.A., Oh D. The effect of mindfulness-based therapy on anxiety and depression. J Consult Clin Psychol 2010;78(2):169–183.
8. Spitzer R.L., Kroenke K., Williams J.B., Löwe B. A brief measure for assessing generalized anxiety disorder: the GAD-7. Arch Intern Med 2006;166(10):1092–1097.
9. Cuijpers P., Sijbrandij M., Koole S. et al. Psychological treatment of generalized anxiety disorder: a meta-analysis. Clin Psychol Rev 2014;34(2):130–140.
10. Dugas M.J., Robichaud M. Cognitive-Behavioral Treatment for Generalized Anxiety Disorder. New York: Routledge, 2007.
11. Meyer T.J., Miller M.L., Metzger R.L., Borkovec T.D. Development and validation of the Penn State Worry Questionnaire. Behav Res Ther 1990;28(6):487–495.
12. Roemer L., Orsillo S.M. An open trial of an acceptance-based behavior therapy for generalized anxiety disorder. Behav Ther 2007;38(1):72–85.
13. Wells A. Metacognitive Therapy for Anxiety and Depression. New York: Guilford Press, 2009.
14. Kessler R.C., Berglund P., Demler O. et al. Lifetime prevalence and age-of-onset distributions of DSM-IV disorders in the National Comorbidity Survey Replication. Arch Gen Psychiatry 2005;62(6):593–602.

ICD-11 **6B01**	**6B01 PANİK BOZUKLUĞU** **Panic disorder**
ICD-10 F41.0	Panik bozukluk [epizodik paroksismal anksiyete]
DSM-5-TR F41.0	Panik Bozukluğu

1. Tanım ve nozoloji

Panik bozukluğu (ICD-11: 6B01; DSM-5-TR: F41.0) — tekrarlayan, beklenmedik panik atakları (zirvesi 10 dakikada ulaşan akut korku veya anksiyete epizodları) ve

bu atakların tekrarı hakkında sürekli endişe, davranış değişiklikleri ile karakterize bozukluktur.

2. Tarihçe

- Da Costa J.M. (1871) "irritable heart" — Amerikan İç Savaşı askerlerinde.
- Freud (1894) "anxiety neurosis".
- Klein D.F. (1964) — panik atakların antidepresan yanıtını ayırma; "anxiety neurosis" bölünmesinin temeli.
- DSM-III (1980) — Panik bozukluk resmi tanısı.
- DSM-5 (2013), ICD-11 — Agorafobi panik bozukluktan ayrı kategoridir.

3. Epidemiyoloji

- Yaşam boyu yaygınlık: %2–5; yıllık ~%2,7 (Kessler R.C. WMH).
- Cinsiyet: kadınlarda 2 kat yüksek.
- Başlangıç: genç-orta yetişkinlik (20–30 yaş); ikinci pik orta yaşta.
- Komorbidite: agorafobi %30–50, MDD %50–60, diğer anksiyete bozuklukları, madde kullanımı, mitral kapak prolapsusu.

4. Etiyoloji ve patogenez

- Kalıtım ~%40 (Hettema 2001 meta-analiz).
- Nörobiyolojik — amigdala-locus coeruleus-prefrontal devre hiperreaktivitesi; serotonerjik, noradrenerjik, GABA-erjik disregülasyon.
- CO_2 duyarlılık hipotezi (Klein D.F. "suffocation false alarm") — hastalar hiperventilasyon ve CO_2 birikimine duyarlılık gösterir.
- Kişilik — anksiyete duyarlılığı (Reiss S.); çocukluk ayrılık anksiyetesi öyküsü.

5. Klinik özellikler

Panik atak — 4+ semptom 10 dakikada zirve

- Kalp atışı, çarpıntı, taşikardi.
- Terleme, titreme.
- Nefes darlığı, hava açlığı hissi.
- Boğulma hissi.
- Göğüs ağrısı veya rahatsızlık.

- Bulantı, karın rahatsızlığı.
- Baş dönmesi, gerçek dışı his.
- Soğuk veya sıcak dalgalar; parestezi.
- Derealizasyon, depersonalizasyon.
- Kontrol kaybı veya "deli olma" korkusu.
- Ölüm korkusu.

Atak 5–20 dakika sürer; hastane başvurusu sıktır (kardiyak şikayet ile).

6. Tanı

6.1 Birleşik tanı ölçütleri

A. Tekrarlayan beklenmedik panik atakları.

B. En az bir ataktan sonra ≥ 1 ay aşağıdakilerden biri:

- Bir sonraki ataktan sürekli kaygı;
- Atakların sonuçları hakkında korku (kalp krizi, delirme);
- Atakla ilişkili önemli davranış değişikliği (kaçınma, güvenlik davranışları).

C. Madde veya tıbbi durum dışlaması.

D. Başka bir ruhsal bozuklukla (sosyal anksiyete, OKB, TSSB, ayrılma) daha iyi açıklanmaz.

6.2 Kaynaklar arasındaki farklar

- DSM-5-TR — agorafobi ayrı tanı (F40.00); birlikte ortaya çıkabilir.
- ICD-11 — agorafobi 6B02 ayrı koddur; ancak bir aylık kaygı süresi istemez — "sürekli kaygı" yeterlidir.
- NICE CG113 — tanı somatik neden dışlanmasından sonra.

6.3 Tanı algoritması

1. Klinik görüşme + atak öyküsü.
2. SCID-5, MINI.
3. PDSS (Panic Disorder Severity Scale), GAD-7 komorbidite.
4. Tıbbi: EKG, TSH, tam kan, glukoz, kafein/stimülan; feokromositoma şüphesi — 24 saatlik idrar metanefrin.
5. Komorbidite (agorafobi, MDD, madde kullanımı).

6.4 Ayırıcı tanı

Durum	Ayırt edici
Agorafobi (6B02)	Kaçınma alanları temel; komorbid mümkün.
Sosyal anksiyete (6B04)	Sosyal değerlendirme tetikleyicisi.
Özgül fobi (6B03)	Somut nesne/durum.
TSSB (6B40)	Travma anamnezi, intrusifler.
Hipertireoid	TSH.
Feokromositoma	İdrar metanefrin.
Aritmi (SVT)	Holter EKG.
Madde indüksiyonlu (kafein, kokain)	Toksikoloji.

7. Muayene ve değerlendirme

- PDSS, ACQ (Agoraphobic Cognitions), BSQ (Body Sensations Questionnaire).
- EKG, TSH, tam kan, glukoz.
- Holter EKG (aritmi şüphesi).
- Toksikoloji.

8. Tedavi

8.1 Genel Prensipler (NICE CG113 · CANMAT 2014)

1. BDT panik için — psikoeğitim, interoseptif maruz bırakma (beden duyumlarına toleransın artırılması), in vivo maruz bırakma (kaçınılan durumlara), bilişsel yeniden yapılandırma. 12–16 seans. Kanıt: Cuijpers P. ve ark. derlemeleri — büyük etki.
2. Farmakoterapi: SSRI (sertralin, paroksetin, fluoksetin — FDA'nın panik bozukluk endikasyonu; essitalopram off-label) veya SNRI (venlafaksin) — birinci sıra. Başlangıç düşük dozda (jittery, “aktivasyon” etkisi paniği güçlendirebilir).
3. Benzodiazepin (klonazepam, lorazepam) — kısa süreli ilk stabilizasyon; ≤ 4 hafta; bağımlılık potansiyeli.
4. Tedavi süresi — remisyondan sonra ≥ 12 ay.

5. Kafein, alkol, marihuana kısıtlaması.

8.2 Tedavi metodolojileri

1. Panik için BDT — Clark (D.M.), Barlow (D.) — İnteroseptif maruz bırakma (kasıtlı beden hissi yaratma — hiperventilasyon, dönme, kafein) + in vivo maruz bırakma + bilişsel yeniden yapılandırma. Kanıt: Barlow D.H. et al. JAMA 2000 RKÇ.
2. Panik Kontrol Tedavisi (PCT — Panic Control Treatment) — Barlow (D.) — 11 seanslı manuelize edilmiş protokol; ABD'de yaygın kullanım.
3. Panik Bozukluk Şiddet Ölçeği (PDSS — Panic Disorder Severity Scale) — Shear (M.K.) — 7 madde; ilk göstergeler ve izlem.
4. İnternet-temelli BDT (iCBT — internet-based CBT) — Andersson G. et al. RKÇ'leri — bireysel BDT'ye kıyasla etkili olduğu gösterilmiştir.

8.3 Kaynaklar arasındaki farklar

- NICE CG113 — BDT ve SSRI birinci basamak; benzodiazepin yalnızca kısa süreli.
- APA Anxiety Guidelines — BDT ve farmakoterapi eşit etkili.
- Mitte K. J Affect Disord 2005 meta-analiz — BDT plasebodan ve bekleme listesinden üstün.

9. Prognoz

- Tedavi ile remisyon çoğu hastada.
- Komorbid agorafobi veya MDD kötü prognoz.
- Erken müdahale kaçınma davranışının kristalleşmesini önler.

10. Mit ve yanlış inançlar

Mit 1: "Panik atak kalp krizidir"

Kanıt: Semptomlar benzer olabilir; ancak panik atak kısa sürelidir, klinik başvurusundan sonra normal EKG. Klein'ın "suffocation false alarm" hipotezi mekanizmayı açıklar.

Mit 2: "Hasta iradi olarak paniği kontrol edebilir"

Kanıt: panik nörobiyolojik disregülasyondur; BDT ve farmakoterapi gerekir.

Mit 3: "Benzodiazepin paniğin temel tedavisidir"

Kanıt: kısa süreli stabilizasyon için; bağımlılık potansiyeli; SSRI ve BDT birinci sıra.

Mit 4: "Panik hastasını panik yaratan durumlardan korumak gerekir"

Kanıt: kaçınma semptomlarını güçlendirir; maruz bırakma temel terapötik mekanizmadır.

Mit 5: "Bitkisel preparatlar (kava, valerian) panik için güvenlidir"

Kanıt: Kava hepatotoksisite (FDA uyarısı); standart tedavi üstün.

11. Kaynaklar

1. WHO. ICD-11. 6B01 Panic disorder. 2024.
2. APA. DSM-5-TR. 2022.
3. NICE CG113. 2011/2020.
4. Katzman M.A. et al. CANMAT 2014. BMC Psychiatry 2014;14(Suppl 1):S1.
5. Barlow D.H. et al. Cognitive-behavioral therapy, imipramine, or their combination for panic disorder. JAMA 2000;283(19):2529–2536.
6. Shear M.K. et al. Multicenter collaborative panic disorder severity scale. Am J Psychiatry 1997;154(11):1571–1575.
7. Klein D.F. False suffocation alarms, spontaneous panics, and related conditions. Arch Gen Psychiatry 1993;50(4):306–317.
8. Clark D.M. A cognitive approach to panic. Behav Res Ther 1986;24(4):461–470.
9. Andersson G., Cuijpers P., Carlbring P. et al. Guided internet-based vs. face-to-face cognitive behaviour therapy for psychiatric and somatic disorders: a systematic review and meta-analysis. World Psychiatry 2014;13(3):288–295.
10. Reiss S., Peterson R.A., Gursky D.M., McNally R.J. Anxiety sensitivity, anxiety frequency and the prediction of fearfulness. Behav Res Ther 1986;24(1):1–8.
11. Kessler R.C., Berglund P., Demler O. et al. Lifetime prevalence and age-of-onset distributions of DSM-IV disorders in the National Comorbidity Survey Replication. Arch Gen Psychiatry 2005;62(6):593–602.

ICD-11 **6B02**	**6B02 AGORAFOBİ** **Agoraphobia**
ICD-10 F40.0	Agorafobi

ICD-11 **6B02**	**6B02 AGORAFOBİ** **Agoraphobia**
DSM-5-TR F40.00	Agorafobi

1. Tanım ve nozoloji

Agorafobi (ICD-11: 6B02; DSM-5-TR: F40.00) — kaçışın zor olduğu veya yardım alınamayacak durumlardan (toplu taşıma, açık alanlar, kapalı alanlar, kalabalık, evden tek başına çıkma) aşırı korku ve kaçınmadır. Hasta panik atak veya diğer kapasiteyi düşüren semptomların gelişmesinden korkar.

2. Tarihçe

- Westphal C. (1872) "agoraphobia" — Yunanca "agora" (meydan) + korku.
- DSM-III (1980) — panik bozukluk ile birlikte.
- DSM-5 (2013), ICD-11 — agorafobi panik bozukluktan AYRI kategori olarak resmileştirildi (komorbid mümkündür, ancak ayrı tanı esasında).

3. Epidemiyoloji

- Yaşam boyu yaygınlık: %1–2,5.
- Cinsiyet: kadınlarda 2 kat yüksek.
- Başlangıç: genç-orta yetişkinlik.
- Komorbidite: panik bozukluk %50, MDD, diğer anksiyete, madde kullanımı.

4. Etiyoloji ve patogenez

- Kalıtım ~%48 (Mosing M.A. et al. Depress Anxiety 2009;26(11):1004–1011).
- Klasik koşullanma — panik atak belirli bir durumda meydana geldiğinde o duruma korku transferi.
- Bilişsel faktörler — felaketleştirme ("yardım gelmeyecek").

5. Klinik özellikler

Tipik kaçınılan durumlar:

- Toplu taşıma (otobüs, tren, uçak).

- Açık alanlar (meydan, köprü, geniş alan).
- Kapalı alanlar (mağaza, sinema).
- Sıra beklemek veya kalabalık.
- Evden tek başına çıkma.

Hasta kaçınma, "güvenlik" davranışları (arkadaş, cep telefonu, ilaç taşıma), kısmen veya tamamen eve kapanma gösterir. Ağır vakada eve hapsolma.

6. Tanı

6.1 Birleşik tanı ölçütleri

A. Aşağıdaki beş kategoriden ≥ 2'sinde belirgin korku veya kaygı:

1. Toplu taşıma;
2. Açık alanlar
3. Kapalı alanlar;
4. Sıra veya kalabalık;
5. Evden tek başına çıkma.

B. Bu durumlar korkulur, çünkü kaçış zor veya yardım gelmeyecek — panik atak ya da inkapasite semptomu ortaya çıktığında.

C. Durumlar neredeyse her zaman korku yaratır.

D. Aktif kaçınma, refakatçi talebi veya akut anksiyete ile katlanma.

E. Korku, duruma uygun olmayan derecede.

F. Sürekli (≥ 6 ay DSM-5-TR).

G. Önemli fonksiyonel bozulma.

H. Tıbbi veya başka bir ruhsal bozuklukla daha iyi açıklanmaz.

6.2 Kaynaklar arasındaki farklar

- DSM-5-TR / ICD-11 — agorafobi panik bozukluktan ayrı; komorbid her iki tanı konur.
- NICE CG113 — agorafobi panik bozukluğu ile benzer müdahale.

6.3 Tanı algoritması

1. Klinik görüşme — kaçınılan durumlar, panik atak geçmişi, fonksiyonel yük.
2. SCID-5, MINI.
3. Mobility Inventory for Agoraphobia (MIA) — kaçınma şiddeti.

4. Komorbidite (panik, MDD, madde).
5. Tıbbi muayene.

6.4 Ayırıcı tanı

Durum	Ayırt edici
Panik bozukluğu (6B01)	Atak esas; kaçınma alanları sınırlı veya yok.
Özgül fobi (6B03)	Belirli tek nesne/durum.
Sosyal anksiyete (6B04)	Sosyal değerlendirme korkusu.
TSSB (6B40)	Travma anamnezi.
Ayrılma kaygısı (6B05)	Yakın kişiden ayrılma korkusu dominant.

7. Muayene ve değerlendirme

- MIA, ACQ, BSQ.
- GAD-7, PHQ-9, PDSS komorbidite.

8. Tedavi

1. BDT — maruz bırakma temelli; aşamalı in vivo maruz bırakma kaçınılan durumlara; bilişsel yeniden yapılandırma. Birinci basamak; etki büyük.
2. SSRI veya SNRI — birinci basamak farmakoterapi (panik bozukluk gibi).
3. Benzodiazepin — yalnızca kısa süreli.
4. Sanal gerçeklik maruziyeti — alternatif araç; kanıt tabanı gelişmekte.
5. Tedavi süresi — remisyondan sonra ≥ 12 ay.

8.1 Tedavi metodolojileri

1. In vivo maruz bırakma — Aşamalı yaklaşım — hasta kaçınılan durumlara yapılandırılmış şekilde girer; terapist eşlik edebilir (terapist destekli maruz bırakma). Birinci basamak yöntem.
2. Sanal Gerçeklik Maruziyet Terapisi (VRET — Virtual Reality Exposure Therapy) — Klinik bağlamda sanal ortam oluşturulur; in vivo maruziyete alternatif. Botella C. et al. Behav Res Ther 2007.
3. BDT panik için (Clark, Barlow) — agorafobiye uyarlanmış — İnteroseptif + in vivo maruz bırakma.

4. Mobilite Anketi (MIA — Mobility Inventory) — Chambless (Chambless D.L.) — 27 durum; tek başına ve arkadaşla kaçınma derecesi.

8.2 Kaynaklar arasındaki farklar

- NICE CG113 — BDT ve SSRI.
- CANMAT 2014 — aynı.
- Sánchez-Meca J. et al. Clin Psychol Rev 2010 meta-analiz — BDT maruziyet temelli büyük etki göstermiştir.

9. Prognoz

- Ekspozisyon BDT ile çoğu hastada fonksiyonel iyileşme.
- Erken müdahale olmadan kronikleşme — hasta evden çıkamaz hâle gelir.
- Komorbid MDD kötü prognoz.

10. Mit ve yanlış inançlar

Mit 1: “Agorafobili hastayı durumlara sokmamak gerekir”

Kanıt: kaçınma semptomlarını güçlendirir; maruz bırakma temel terapötik mekanizmadır.

Mit 2: “Agorafobi panik bozukluğun 'alt-tipi'dir”

Kanıt: DSM-5-TR ve ICD-11 — ayrı tanı kategorileri; komorbidite mümkündür, ancak biri olmadan da ortaya çıkabilir.

Mit 3: “Hasta 'tembel'dir, çıkmak istemez”

Kanıt: agorafobi nörobiyolojik ve davranışsal temelli klinik bir bozukluktur; iradi veya karakter sorunu değildir.

Mit 4: “Yalnızca ilaç agorafobiyi iyileştirir, terapi zorunlu değildir”

Kanıt: maruz bırakma temelli BDT olmadan sürekli remisyon zordur; farmakoterapi tek başına kaçınma davranışını değiştirmez.

Mit 5: “İnternetten sipariş veya uzaktan eğitim almak agorafobili hasta için uygun yaşam tarzıdır”

Kanıt: akomodasyon kısa vadeli rahatlık sağlar, ancak hastalığı güçlendirir ve fonksiyonel seviyeyi azaltır.

11. Kaynaklar

1. WHO. ICD-11. 6B02 Agoraphobia. 2024.
2. APA. DSM-5-TR. 2022.
3. NICE CG113. 2011/2020.
4. Sánchez-Meca J. et al. Psychological treatment of panic disorder with or without agoraphobia: a meta-analysis. Clin Psychol Rev 2010;30(1):37–50.
5. Chambless D.L., Caputo G.C., Jasin S.E. et al. The Mobility Inventory for Agoraphobia. Behav Res Ther 1985;23(1):35–44.
6. Botella C., García-Palacios A., Villa H. et al. Virtual reality exposure in the treatment of panic disorder and agoraphobia. Clin Psychol Psychother 2007;14(3):164–175.

ICD-11 **6B03**	**6B03 ÖZGÜL FOBİ** **Specific phobia**
ICD-10 F40.2	Özgül (izole) fobiler
DSM-5-TR F40.2xx	Özgül Fobi

1. Tanım ve nozoloji

Özgül fobi (ICD-11: 6B03; DSM-5-TR: F40.2xx) — belirli bir nesne veya duruma (hayvanlar, kan-enjeksiyon, yükseklik, uçuş, kapalı yer) karşı akut, irrasyonel korku ve kaçınmadır. Hasta korkunun aşırı olduğunu genellikle kabul eder.

2. Tarihçe

- Hipokrat (MÖ 5. yüzyıl) — fobi tanımları.
- Westphal C. (1872) — sistematik sınıflandırma.
- Marks I.M. (1969) — sistematik duyarsızlaştırma ve maruz bırakma çalışmaları.
- DSM-5 (2013), ICD-11 — alt tipler: hayvan, doğal çevre, kan-enjeksiyon-yaralanma, durumsal, diğer.

3. Epidemiyoloji

- Yaşam boyu yaygınlık %7–12 — en sık görülen anksiyete bozukluklarındandır.
- Cinsiyet: kadınlarda 2–3 kat yüksek (kan-enjeksiyon alt-tipi istisna — fark az).
- Başlangıç: çocukluk (hayvan, kan-enjeksiyon), genç yetişkinlik (durumsal).

4. Etiyoloji ve patogenez

- Kalıtım ~%30 (Hettema 2001).
- Klasik koşullanma (Watson J.B. "Little Albert", 1920), dolaylı öğrenme, bilgi aktarımı.
- Biyolojik hazırlık (Seligman M.E. "preparedness") — filogenetik olarak anlamlı uyaranlara (örn. yılan, örümcek) karşı korku geliştirmeye genetik yatkınlık.
- Kan-enjeksiyon alt tipinde — vazovagal yanıt (bradikardi, hipotansiyon, bayılma) diğer fobilerden farklılaşır.

5. Klinik özellikler

Alt-tipler

- Hayvan — örümcek, yılan, köpek, böcekler.
- Doğal ortam — yükseklik, su, fırtına.
- Kan-enjeksiyon-yaralanma — vazovagal reaksiyon (bayılma karakteri).
- Durumsal — uçuş, asansör, tünel, araba kullanma, kapalı alan.
- Diğer — boğulma, kusma, palyaçolar, belirli sesler.

6. Tanı

6.1 Birleşik tanı ölçütleri

A. Belirli bir nesne veya duruma karşı akut korku veya kaygı.

B. Nesne/durum neredeyse her zaman korku yaratır.

C. Aktif kaçınma veya akut anksiyete ile katlanma.

D. Korku, gerçek riske uygun olmayan derecede.

E. ≥ 6 ay sürer (DSM-5-TR).

F. Önemli sıkıntı veya işlevsel bozulma.

G. Başka bir ruhsal bozuklukla daha iyi açıklanmaz.

6.2 Kaynaklar arasındaki farklar

- DSM-5-TR / ICD-11 — alt tip kalifikatörü zorunludur.
- NICE — ayrı spesifik fobi kılavuzu yok; genel anksiyete ilkeleri.

6.3 Tanı algoritması

1. Klinik görüşme.
2. FSS (Fear Survey Schedule), spesifik fobi alt-skalaları.
3. İşlevsel yük değerlendirmesi.

6.4 Ayırıcı tanı

Durum	Ayırt edici
Panik bozukluğu (6B01)	Atak beklenmedik bir anda olur.
Agorafobi (6B02)	Çok sayıda durum kategorisi.
Sosyal anksiyete (6B04)	Sosyal değerlendirme korkusu.
OKB (6B20)	Obsesyon temel; kirlenme korkusu kompulsiyonlarla.
TSSB (6B40)	Travma anamnezi.
Hipokondriyazis (6B23)	Hastalık korkusu.

7. Muayene ve değerlendirme

- FSS, spesifik fobi skalası.
- BAT (Behavioral Avoidance Test) — hastanın fobik nesneye yaklaşma derecesi.

8. Tedavi

1. Ekspozisyon terapisi birinci basamak ve en etkilidir. Tek seans 2–3 saatlik yapılandırılmış maruz bırakma (Öst L.G. “one-session treatment”) çoğu hayvan ve durumsal fobi için etkilidir.
2. Basamaklı in vivo maruziyet — hastanın temposuna uyarlanmış.
3. Sanal Gerçeklik Maruziyeti — uçuş, yükseklik için özellikle uygun.
4. Kan-enjeksiyon alt tipinde — applied tension (Öst) — hastaya kaslarını germesi öğretilir, vazovagal yanıtı önler.

5. Farmakoterapi ana rolü yoktur; benzodiazepin yalnızca belirli olay için (örn. uçuş öncesi) kısa süreli adjunkt; bazen BDT maruziyetinin etkinliğini azaltabilir.
6. D-sikloserin adjunkt — maruziyet etkinliğini güçlendirebilir (kanıt tabanı gelişmekte).

8.1 Tedavi metodolojileri

1. Tek Seanslı Maruziyet (One-Session Treatment) — Öst (Öst L.G.) — 2–3 saatlik yapılandırılmış in vivo maruz bırakma; çoğu hayvan ve durumsal fobi için %80–90 etkililik. Öst L.G. Behav Res Ther 1989.
2. Sistematik Duyarsızlaştırma (Systematic Desensitization) — Wolpe J. — Tarihsel yöntem — gevşeme + kademeli fobik uyaran; in vivo maruz bırakma tarafından geçilmiştir.
3. Applied Tension (Öst — kan-enjeksiyon) — Kasları 10–15 saniye germek — vazovagal senkopu önler; spesifik kan-enjeksiyon fobisinde.
4. Sanal Gerçeklik Maruziyet Terapisi (VRET — Virtual Reality Exposure Therapy) — Uçuş, yükseklik, örümcek fobileri için. Botella C. et al. derlemeleri.
5. D-sikloserin adjunkt — NMDA kısmi agonisti; maruz bırakma seansı öncesi alındığında extinction öğrenmesini güçlendirebilir. Hofmann S.G. ve ark. derlemeleri — ılımlı kanıt.

8.2 Kaynaklar arasındaki farklar

- Öst L.G. — tek seanslık maruz bırakma %80–90 etkinlik gösterir (Behav Res Ther 1989).
- Wolitzky-Taylor K.B. ve ark. Clin Psychol Rev 2008 meta-analizi (33 RKÇ) — maruz bırakma bekleme listesine karşı büyük, plaseboya karşı orta etki; in vivo temas diğer maruz bırakma biçimlerinden üstün. Bu meta-analiz farmakoterapi ile karşılaştırma yapmamıştır.
- APA Anxiety Guidelines — maruz bırakma birinci sıra.

9. Prognoz

- Ekspozisyon BDT — çoğu hastada remisyon.
- Tedavisiz kronikleşme.

10. Mit ve yanlış inançlar

Mit 1: "Spesifik fobi sadece çocukluk fobisidir, yetişkinlerde tedavi gerektirmez"

Kanıt: Spesifik fobi yetişkinlikte de işlevsel bozulma yaratır (uçuştan kaçınma — mesleki kısıtlama; tıbbi prosedürlerden kaçınma — sağlık riski).

Mit 2: "Hastayı fobik nesneye 'zorlamak' travma yaratır"

Kanıt: uygun şekilde uygulanan kademeli maruz bırakma güvenli ve yüksek etkilidir; hastanın rızası ve temposu ile.

Mit 3: "Hipnoterapi veya NLP fobileri hızla iyileştirir"

Kanıt: Sistematik kanıt tabanı sınırlıdır; maruziyet temelli yaklaşım altın standarttır.

Mit 4: "Hasta fobik nesneden tamamen kaçınarak normal bir hayat sürebilir"

Kanıt: kaçınma fobiyi güçlendirir; durumsal fobiler (uçuş, asansör) tıbbi ve sosyal kısıtlamalar yaratır.

Mit 5: "Benzodiazepin uçuş gibi spesifik durumlar için etkili tedavidir"

Kanıt: kısa süreli adjunkt rolde mümkündür, ancak uzun vadeli çözüm değildir; BDT/maruz bırakmanın etkinliğini azaltabilir (state-dependent learning).

11. Kaynaklar

1. WHO. ICD-11. 6B03 Specific phobia. 2024.
2. APA. DSM-5-TR. 2022.
3. Öst L.G. One-session treatment for specific phobias. Behav Res Ther 1989;27(1):1–7.
4. Wolitzky-Taylor K.B., Horowitz J.D., Powers M.B., Telch M.J. Psychological approaches in the treatment of specific phobias: a meta-analysis. Clin Psychol Rev 2008;28(6):1021–1037.
5. Hettema J.M., Neale M.C., Kendler K.S. A review and meta-analysis of the genetic epidemiology of anxiety disorders. Am J Psychiatry 2001;158(10):1568–1578.
6. Wolpe J. Psychotherapy by Reciprocal Inhibition. Stanford: Stanford University Press, 1958.
7. Seligman M.E.P. Phobias and preparedness. Behav Ther 1971;2(3):307–320.

8. Hofmann S.G. Enhancing exposure-based therapy from a translational research perspective. Behav Res Ther 2007;45(9):1987–2001.
9. Botella C., Fernández-Álvarez J., Guillén V. et al. Recent progress in virtual reality exposure therapy for phobias: a systematic review. Curr Psychiatry Rep 2017;19(7):42.

ICD-11 **6B04**	**6B04 SOSYAL ANKSİYETE BOZUKLUĞU** **Social anxiety disorder**
ICD-10 F40.1	Sosyal fobiler
DSM-5-TR F40.10	Toplumsal Kaygı Bozukluğu (Sosyal Fobi)

1. Tanım ve nozoloji

Sosyal anksiyete bozukluğu (ICD-11: 6B04 Social Anxiety Disorder; DSM-5-TR: F40.10) — sosyal durumlarda başkaları tarafından olumsuz değerlendirilmekten veya utanç duymaktan belirgin ve sürekli korkudur. Hasta konuşma, etkileşim ve gözlem altında olma gibi durumlardan kaçınır.

2. Tarihçe

- Janet P. (1903) — “phobie des situations sociales”.
- Marks I.M., Gelder M.G. (1966) — sosyal fobinin agorafobiden ayrılması.
- DSM-III (1980) — “Social Phobia” resmi tanısı.
- DSM-5 (2013) — “Social Anxiety Disorder” — daha geniş ve kesin terim; performans-only alt tipi eklenmiştir.
- ICD-11 — paralel.

3. Epidemiyoloji

- Yaşam boyu yaygınlık: %7–13 (Kessler WMH; kültürel değişkenlik).
- Cinsiyet: kadınlarda nispeten yüksek, ancak erkekler kliniğe daha çok başvurur.

- Başlangıç: ergenlik (ortalama 13 yaş) — en erken başlayan anksiyete bozukluklarından biridir.
- Komorbidite: MDD %60, diğer anksiyete, alkol kullanımı (kendi kendine tedavi olarak).

4. Etiyoloji ve patogenez

- Kalıtım ~%30–40.
- Behavioral inhibition (Kagan J.) — çocukluk mizacı güçlü risk faktörü.
- Nörobiyolojik — amigdala hiperreaktivitesi sosyal uyaranlara karşı; serotonerjik disregülasyon.
- Bilişsel — kendine odaklanmış dikkat, olumsuz öz-imaj, felaketleştirme (Clark D.M., Wells A. modeli).
- Çevre — çocukluk akran mağduriyeti, ebeveyn aşırı korumacılığı.

5. Klinik özellikler

- Korkulan durumlar — konuşma, soru sorma, yemeği paylaşma, başkalarının önünde yazma veya yemek yeme, umumi tuvalet, telefonla konuşma.
- Somatik — kızarma, titreme, ter basması, taşikardi, ağız kuruluğu, ses titremesi.
- Bilişsel — kendisi hakkında olumsuz düşünceler, “post-event processing” (durum sonrası uzun süreli öz-eleştiri).
- Kaçınma ve “güvenlik” davranışları (göz teması kaçırma, az konuşma, alkol kullanımı).
- İşlevsel yük — akademik ve mesleki gelişim, arkadaşlar, romantik ilişkiler.

6. Tanı

6.1 Birleşik tanı ölçütleri

A. Bir veya daha fazla sosyal durumda yoğun korku — başkaları tarafından gözlemlenmek veya değerlendirilmek.

B. Hasta utanmaktan, başkaları tarafından reddedilmekten, başkalarını incitmekten korkar.

C. Durumlar neredeyse her zaman korku yaratır.

D. Kaçınma veya akut anksiyete ile katlanma.

E. Korku, sosyal duruma uygun olmayan derecede.

F. ≥ 6 ay sürer (DSM-5-TR).

G. Fonksiyonel bozulma.

H. Başka bir ruhsal bozukluk veya tıbbi durumla tam olarak açıklanmaz.

6.2 Kaynaklar arasındaki farklar

- DSM-5-TR — "performance only" alt tip niteleyicisi (yalnızca performans durumlarıyla sınırlı).
- ICD-11 — süre "en az birkaç ay" (DSM-5-TR'de 6 ay); çocuklarda akran ortamı da değerlendirilir, yalnızca yetişkinlerle iletişim değil.
- NICE CG159 (Sosyal anksiyete bozukluğu: tanıma, değerlendirme ve tedavi, 2013) — bireysel BDT birinci basamak.

6.3 Tanı algoritması

1. Klinik görüşme.
2. SCID-5, MINI.
3. Liebowitz Social Anxiety Scale (LSAS), SPIN (Social Phobia Inventory) — ölçek ve izlem.
4. Komorbidite (MDD, diğer anksiyete, alkol kullanımı).

6.4 Ayırıcı tanı

Durum	**Ayırt edici**
Agorafobi (6B02)	Kaçış zorluğu, yardım yok; sosyal değerlendirme yok.
Özgül fobi (6B03)	Somut nesne/durum.
Panik (6B01)	Atak beklenmedik bir anda olur.
Kaçıngan kişilik bozukluğu	Sürekli model, daha geniş; komorbidite sık.
Otizm spektrumu (6A02)	Sosyal-iletişimsel defisit erken başlangıç; sosyal ilgi değişken.
Seçici mutizm (6B06)	Spesifik bağlamda konuşmama.
Beden dismorfik bozukluk (6B21)	Görünüm temelli kaygı.

7. Muayene ve değerlendirme

- LSAS — altın standart ölçek (24 madde).
- SPIN — kısa tarama (17 madde)
- BFNE (Brief Fear of Negative Evaluation).

8. Tedavi

8.1 Genel Prensipler (NICE CG159 · CANMAT 2014)

1. Bireysel BDT (Clark D.M. modeli) birinci basamak — kendine odaklanmış dikkatin yeniden yönlendirilmesi, video geri bildirim, davranış deneyleri, bilişsel yeniden yapılandırma, in vivo maruz bırakma. 12–16 seans. NICE CG159 — bireysel BDT grup BDT'den üstün.
2. SSRI ve SNRI birinci basamak farmakoterapi — essitalopram, sertralin, paroksetin (FDA onaylı), venlafaksin (FDA onaylı).
3. İkinci sıra — moklobemid (RIMA, Avrupa'da onaylı), pregabalin (kanıt sınırlı), gabapentin.
4. Benzodiazepin — yalnızca belirli durum için (örn. konuşma öncesi) kısa süreli; sürekli değil.
5. β-bloker (propranolol) — performans alt tipinde, çıkış öncesi 1–2 saat; sosyal etkileşimde etkisiz.
6. Tedavi süresi — remisyondan sonra ≥ 12 ay.
7. Alkol kullanımı — kendi kendine tedavi şeklinde; özel dikkat ve paralel müdahale.

8.2 Tedavi metodolojileri

1. Clark BDT Modeli (Clark) — Sosyal kaygı için özel geliştirilmiş; kendine odaklanmış dikkatin dışa yönlendirilmesi, video geri bildirim (kendi performansını başkalarının gözüyle görme), davranış deneyleri (korku inançlarının test edilmesi), in vivo maruz bırakma. Kanıt: Clark D.M. ve ark. J Consult Clin Psychol 2003 RKÇ — deneysel bireysel BDT diğer müdahalelerden üstün.
2. Heimberg Grup BDT (Heimberg) — 12 seanslı grup formatı; Heimberg R.G. modeli. Etkili, ancak bireysel BDT'den nispeten zayıf (NICE CG159).
3. İnternet-temelli BDT (iCBT — internet-based CBT) — Andersson G. et al. RKÇ'leri — terapist destekli iCBT bireysel BDT'ye kıyasla.
4. Liebowitz Sosyal Anksiyete Ölçeği (LSAS — Liebowitz Social Anxiety Scale) — 24 madde (11 etkileşim + 13 performans); her madde hem

korku/anksiyete hem de kaçınma açısından değerlendirilir (48 puanlama, 0–144 puan, 4 alt ölçek); altın standart.

5. Sosyal Fobi Anketi (SPIN — Social Phobia Inventory) — 17 madde; kısa tarama.

8.3 Kaynaklar arasındaki farklar

- NICE CG159 (2013) — bireysel BDT (Clark) birinci basamak; SSRI alternatif; grup BDT veya kendi kendine yardım bazı hastalar için uygun olabilir.
- CANMAT 2014 — birinci basamak essitalopram, sertralin, paroksetin, venlafaksin.
- Mayo-Wilson E. et al. Lancet Psychiatry 2014 network meta-analiz — bireysel BDT en büyük etki; SSRI ikinci.

9. Prognoz

- Kronik seyir, tedavisiz nüks yüksek.
- BDT ve SSRI ile çoğu hastada anlamlı iyileşme.
- Erken başlangıç ve kaçıngan kişilik komorbid kötü prognoz belirteci.

10. Mit ve yanlış inançlar

Mit 1: “Sosyal kaygı — normal ‘hayattan utanma’, tedavi gerektirmez”

Kanıt: Sosyal anksiyete bozukluğu işlevsel bozulma, akademik ve mesleki kısıtlama, depresyon ve alkol kullanımı riski ile birlikte seyreder; tıbbi bir durum olarak değerlendirilir.

Mit 2: “Hasta sosyal durumlardan tamamen kaçınarak normal bir hayat sürebilir”

Kanıt: kaçınma semptomları güçlendirir ve izolasyona yol açar; maruz bırakma temel terapötik mekanizmadır.

Mit 3: “Alkol sosyal kaygıyı ‘tedavi eder’”

Kanıt: alkol kısa vadeli rahatlık sağlar, ancak uzun vadede anksiyeteyi güçlendirir ve alkol kullanım bozukluğuna yol açar; bu kombinasyonun yaygınlığı %20–40.

Mit 4: “Benzodiazepin sosyal anksiyete için uzun vadeli etkilidir”

Kanıt: kısa süreli etki; bağımlılık potansiyeli; BDT veya SSRI üstündür.

Mit 5: "Propranolol tüm sosyal anksiyete formları için etkilidir"

Kanıt: propranolol sadece performans alt tipinde (çıkış öncesi) etkilidir; sosyal etkileşimde (parti, ilişkiler) etkisizdir.

Mit 6: "Hastada kaçıngan kişilik bozukluğu var, bu nedenle tedavi yanıtsızdır"

Kanıt: komorbid kaçıngan kişilik hastasında da standart müdahalelere yanıt görülebilir; uzun süreli BDT veya şema terapi.

Mit 7: "Sadece hipnoterapi veya NLP hızlıca iyileştirir"

Kanıt: kanıt temeli yoktur; BDT ve SSRI altın standart.

Mit 8: "Kannabis (CBD) sosyal anksiyete için güvenli bir alternatiftir"

Kanıt: ilk çalışmalar var, ancak klinik öneri için yeterli değil; THC anksiyeteyi güçlendirebilir.

11. Kaynaklar

1. WHO. ICD-11. 6B04 Social anxiety disorder. 2024.
2. APA. DSM-5-TR. 2022.
3. NICE CG159. Social anxiety disorder: recognition, assessment and treatment. 2013.
4. Katzman M.A. et al. CANMAT 2014. BMC Psychiatry 2014;14(Suppl 1):S1.
5. Mayo-Wilson E. et al. Psychological and pharmacological interventions for social anxiety disorder in adults: a systematic review and network meta-analysis. Lancet Psychiatry 2014;1(5):368–376.
6. Clark D.M., Ehlers A., McManus F. ve ark. Cognitive therapy versus fluoxetine in generalized social phobia: a randomized placebo-controlled trial. J Consult Clin Psychol 2003;71(6):1058–1067.
7. Liebowitz M.R. Social phobia. Mod Probl Pharmacopsychiatry 1987;22:141–173.
8. Heimberg R.G., Becker R.E. Cognitive-Behavioral Group Therapy for Social Phobia. New York: Guilford Press, 2002.
9. Kagan J., Reznick J.S., Snidman N. Biological bases of childhood shyness. Science 1988;240(4849):167–171.
10. Wells A. Metacognitive Therapy for Anxiety and Depression. New York: Guilford Press, 2009.

11. Andersson G., Cuijpers P., Carlbring P. et al. Guided internet-based vs. face-to-face cognitive behaviour therapy for psychiatric and somatic disorders: a systematic review and meta-analysis. World Psychiatry 2014;13(3):288–295.

ICD-11 **6B05**	**6B05 AYRILIK ANKSİYETESİ BOZUKLUĞU** **Separation anxiety disorder**
ICD-10 F93.0	Çocukluk çağının ayrılık kaygısı bozukluğu
DSM-5-TR F93.0	Ayrılma Kaygısı Bozukluğu

1. Tanım ve nozoloji

Ayrılık anksiyetesi bozukluğu (ICD-11: 6B05; DSM-5-TR: F93.0) — bağlanılan kişiden (tipik ebeveyn) veya evden ayrılma ile ilişkili gelişime uygun olmayan aşırı korku ve kaygıdır. DSM-5'te ilk kez yetişkinlerde de tanı konulabilir (DSM-IV'te çocuklukla sınırlıydı).

2. Tarihçe

- Bowlby J. (1969–1980) — bağlanma kuramı.
- DSM-III (1980) — çocukluk bozukluğu olarak.
- DSM-5 (2013) — yaş sınırlaması kaldırılmıştır; yetişkinlerde de tanı mümkündür.

3. Epidemiyoloji

- Çocuklarda yaygınlık: ~%4; ergenlerde ~%1,6; yetişkinlerde ~%1,9 (Kessler R.C. NCS-R).
- Cinsiyet: kadınlarda nispeten yüksek.
- Başlangıç: tipik çocukluk (6–9 yaş); yetişkin formunda tekrar ortaya çıkma veya devam etmiş form.
- Komorbidite: özgül fobi, panik, YAB, MDD, okuldan kaçınma.

4. Etiyoloji ve patogenez

- Kalıtım ~%40.
- Bağlanma stilleri (insecure attachment), ebeveyn aşırı koruyuculuğu.
- Yakınların kayıp veya hastalık öyküsü.
- Stres olayları (taşınma, okul değişikliği, ebeveyn ayrılığı).

5. Klinik özellikler

- Bağlanılan kişiye zarar veya kayıp hakkında aşırı kaygı.
- Evden veya bağlanılan kişiden ayrılmaktan kaçınma.
- Yalnız kalma korkusu.
- Evden uzakta uyumayı veya bağlanılan kişi yakında olmadan uykuya dalmayı sürekli reddetme (kendi yatak odası, yabancı ev).
- Göç veya ayrılık hakkında kabuslar.
- Somatik şikayetler ayrılma antisipasyonunda (karın ağrısı, baş ağrısı, bulantı).
- Çocuklarda — okuldan kaçınma.
- Yetişkinlerde — partner veya çocuklardan ayrılma korkusu, aşırı kontrol davranışları.

6. Tanı

6.1 Birleşik tanı ölçütleri

A. Aşağıdaki semptomlardan ≥ 3'ü:

1. Bağlanılan kişiden ayrılma veya bunun beklentisinde aşırı kaygı;
2. Bağlanılan kişinin kaybı veya zarar görmesi hakkında sürekli kaygı;
3. Bağlanılan kişiden ayrılmaya neden olacak olaydan korku;
4. Ayrılma korkusu nedeniyle evden, okuldan, işten kaçınma;
5. Bağlanılan kişi olmadan yalnız kalmaktan korku;
6. Bağlanılan kişi yakında olmadan uyumayı reddetme;
7. Ayrılma kabusları;
8. Ayrılma beklentisinde somatik şikayetler.

B. Süre: çocuklar/ergenlerde ≥ 4 hafta; yetişkinlerde ≥ 6 ay.

C. Önemli sıkıntı veya işlevsel bozulma.

D. Başka bir ruhsal bozuklukla daha iyi açıklanmaz.

6.2 Kaynaklar arasındaki farklar

- DSM-5-TR — yetişkinlerde süre ≥ 6 ay; çocuklarda ≥ 4 hafta.
- ICD-11 — süre farklı: "en az birkaç ay"; DSM-5-TR'nin çocuklarda 4 hafta / erişkinlerde 6 ay ayrımı yoktur, ayrı yaş kalifikatörü de yoktur.

6.3 Tanı algoritması

1. Klinik görüşme (çocuklarda ebeveyn ile de).
2. Standardize edilmiş görüşme (K-SADS çocuklarda, SCID-5 yetişkinlerde).
3. Ölçek — SAAS (Separation Anxiety Assessment Scale)
4. Komorbidite taraması.

6.4 Ayırıcı tanı

Durum	**Ayırt edici**
YAB (6B00)	Çok sayıda endişe alanı.
Sosyal anksiyete (6B04)	Sosyal değerlendirme dominant.
Agorafobi (6B02)	Kaçışın zor olduğu durumlardan kaçınma.
Panik (6B01)	Atak beklenmedik bir anda olur.
Seçici mutizm (6B06)	Spesifik bağlamda konuşmama.
Davranış bozukluğu (okuldan kaçınma)	Antisosyal davranış bileşeni
Kaçıngan kişilik	Sürekli model tüm ilişkilere.

7. Muayene ve değerlendirme

- SAAS, K-SADS, MASC (Multidimensional Anxiety Scale for Children).
- Komorbidite (depresyon, diğer anksiyete).

8. Tedavi

1. BDT (çocuklarda Coping Cat, FRIENDS programları; yetişkinlerde standart BDT) — maruziyet temelli, ebeveyn katılımı çocuklarda kritik. Birinci basamak.
2. SSRI — orta-ağır vakada veya BDT yanıtsızlığında; sertralin, fluoksetin (çocuklarda).
3. Okula dönüş programları (school refusal) — aşamalı maruz bırakma.

4. Aile katılımı — ebeveyn psikoeğitimi, sık sık telefon aramaları/ziyaretlerden kaçınma (akomodasyon semptomları güçlendirir).

8.1 Tedavi metodolojileri

1. "Coping Cat" programı — Kendall (Kendall P.C.) — 7–17 yaş çocuklar için manuelize edilmiş BDT — 16 seans, psikoeğitim + gevşeme + maruz bırakma + ödül sistemi (FEAR planı).
2. FRIENDS Programı — Barrett (Barrett P.M.) — Avustralya'da geliştirilmiş; çocuk ve ergen anksiyete bozukluklarında grup BDT.
3. Basamaklı Okula Dönüş — Yapılandırılmış maruz bırakma — çocuk kademeli olarak okul ortamına döner; ebeveyn ve okul personeli koordinasyonu.
4. Ebeveyn Akomodasyonunu Azaltma — SPACE (Supportive Parenting for Anxious Childhood Emotions — Lebowitz E.) programı — ebeveynin çocuğun kaygısına uyumunun değiştirilmesi.

8.2 Kaynaklar arasındaki farklar

- AACAP Practice Parameter (Connolly S.D., Bernstein G.A. 2007) — BDT ve SSRI çocuklarda etkilidir.
- NICE — çocuk anksiyetesi için genel kılavuzlar (BDT birinci basamak).
- Walkup J.T. et al. NEJM 2008 (CAMS — Child/Adolescent Anxiety Multimodal Study) — BDT + sertralin kombinasyonu monoterapiden üstün.

9. Prognoz

- Erken BDT ile çoğu çocukta remisyon.
- Tedavisiz devam ergenlikte başka anksiyete bozukluklarına ve depresyon riski.

10. Mit ve yanlış inançlar

Mit 1: "Ayrılma kaygısı yalnızca çocuklukta olur"

Kanıt: DSM-5 ayrılık anksiyetesi yetişkinlerde de tanı konur — yaygınlık ~%1,9.

Mit 2: "Ebeveyn çocuğu 'rahatlatmak' için her talebe cevap vermelidir"

Kanıt: akomodasyon semptomları güçlendirir; SPACE programı veya ebeveyn eğitimi önerilir.

Mit 3: "Ayrılma kaygısı kötü yetiştirme sonucudur"

Kanıt: Kalıtım ~%40; bağlanma ve çevre modülatör. "Kötü terbiye" açıklaması damgalayıcı ve yanlıştır.

Mit 4: "Çocuk yalnız bırakılarak 'alışsın' — bu sert yaklaşım iyileştirir"

Kanıt: "flooding" veya kontrolsüz maruz bırakma travma yaratabilir; kademeli, yapılandırılmış maruz bırakma önerilir.

Mit 5: "Yalnızca ilaçla iyileşmek mümkündür"

Kanıt: BDT birinci basamak; SSRI orta-ağır vakada veya kombinasyonda.

Mit 6: "Okuldan kaçınma kişilik zayıflığıdır, disiplin gerektirir"

Kanıt: okuldan kaçınma klinik kaygı semptomudur; ceza temelli yaklaşım bozukluğu güçlendirir.

11. Kaynaklar

1. WHO. ICD-11. 6B05 Separation anxiety disorder. 2024.
2. APA. DSM-5-TR. 2022.
3. Connolly S.D., Bernstein G.A. AACAP Practice Parameter for the Assessment and Treatment of Children and Adolescents With Anxiety Disorders. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry 2007;46(2):267–283.
4. Walkup J.T. et al. CAMS: Cognitive behavioral therapy, sertraline, or a combination in childhood anxiety. NEJM 2008;359(26):2753–2766.
5. Kendall P.C. Treating anxiety disorders in children: results of a randomized clinical trial. J Consult Clin Psychol 1994;62(1):100–110.
6. Lebowitz E.R. et al. Parent-Based Treatment as Efficacious as Cognitive-Behavioral Therapy for Childhood Anxiety: A Randomized Noninferiority Study of Supportive Parenting for Anxious Childhood Emotions. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry 2020;59(3):362–372.
7. Barrett P.M., Turner C. Prevention of anxiety symptoms in primary school children. Br J Clin Psychol 2001;40(4):399–410.
8. Kessler R.C., Berglund P., Demler O. et al. Lifetime prevalence and age-of-onset distributions of DSM-IV disorders in the National Comorbidity Survey Replication. Arch Gen Psychiatry 2005;62(6):593–602.

ICD-11 **6B06**	**6B06 SEÇİCİ MUTİZM** **Selective mutism**
ICD-10 F94.0	Elektif mutizm
DSM-5-TR F94.0	Seçici Konuşmazlık (Mutizm)

1. Tanım ve nozoloji

Seçici mutizm (ICD-11: 6B06; DSM-5-TR: F94.0) — çocuğun dile tam olarak hakim olmasına rağmen, belirli sosyal durumlarda (örn. okul) sürekli konuşmama, diğer bağlamlarda (örn. ev) normal konuşmadır. Tipik çocukluk anksiyete bozukluğudur, bazen "aşırı utangaçlık" olarak yanlış algılanır.

2. Tarihçe

- Kussmaul A. (1877) — "aphasia voluntaria".
- Tramer M. (1934) — "elective mutism" — hastanın gönüllü seçim ifadesi.
- DSM-IV (1994) — "selective" terimi ile değiştirilmiştir (gönüllü değil, sosyal kaygı nedeniyle).
- DSM-5 (2013) — anksiyete bozuklukları kategorisine taşınmıştır.

3. Epidemiyoloji

- Yaygınlık: %0,7–1 okul çağı çocuklarda (Bergman R.L. et al. JAACAP 2002).
- Cinsiyet: kızlarda nispeten yüksek (1,5–2:1).
- Başlangıç: 2–5 yaş; tipik olarak okula başlama zamanında fark edilir.
- Komorbidite: sosyal anksiyete bozukluğu ~%70, YAB, diğer anksiyete, konuşma veya dil bozukluğu.

4. Etiyoloji ve patogenez

- Kalıtım — aile öyküsünde anksiyete sıktır (~%70 ailede anksiyete bozukluğu).
- Behavioral inhibition (Kagan) — mizaçsal yatkınlık temel faktördür.

- Komorbid gelişimsel konuşma ve dil bozuklukları (özellikle iki dilli ortamda) — risk faktörü.
- Çevre — iki dilli ailelerde bazen yanlışlıkla dil geçişi olarak kabul edilir.

5. Klinik özellikler

- Spesifik sosyal durumlarda (okul, kamusal alanlar) konuşmama.
- Evde yakınları ile normal konuşma.
- Bazen fısıltı veya jest kullanımı.
- Akademik ve sosyal bozulma (soru yanıtlama, akran ilişkileri).
- Eşlik eden utangaçlık, sosyal geri çekilme, somatik yakınmalar.

6. Tanı

6.1 Birleşik tanı ölçütleri

A. Belirli sosyal durumlarda (konuşmanın beklendiği) sürekli konuşmama, diğer durumlarda konuşma normaldir.

B. Akademik, mesleki veya sosyal iletişimde belirgin bozulma.

C. Süre ≥ 1 ay (okulun ilk ayı hariç).

D. Konuşmamak, dili öğrenememekten veya o dilde rahat olmamaktan kaynaklanmaz.

E. İletişim bozukluğu (örn. akıcılık), otizm spektrumu, şizofreni veya başka bir psikotik bozuklukla daha iyi açıklanmaz.

6.2 Kaynaklar arasındaki farklar

- DSM-5-TR / ICD-11 — anksiyete bozuklukları kategorisinde; “selective” — gönüllü seçim değil, duruma özgü anksiyete yanıtıdır.

6.3 Tanı algoritması

1. Ebeveyn, öğretmen görüşmesi.
2. Evde konuşma video kayıtları — tanı doğrulaması.
3. SMQ (Selective Mutism Questionnaire).
4. Konuşma-dil değerlendirmesi (SLT) — iletişim bozukluğu dışlaması.
5. İşitme testi.
6. Komorbid anksiyete, otizm, dil bozukluğu taraması.

6.4 Ayırıcı tanı

Durum	Ayırt edici
Gelişimsel dil bozukluğu (6A01)	Dil tüm bağlamlarda zayıftır.
Otizm spektrumu (6A02)	Sosyal-iletişimsel defisit tüm bağlamlarda.
Bilingual ortam geçici	Yeni dil adaptasyonu döneminde — genellikle aylar.
İşitme bozukluğu	Odyometri.
Sosyal anksiyete (6B04)	Komorbidite sık — hasta konuşur, ancak sosyal değerlendirmeden korkar.
Travma bağlamında mutizm	Travmatik olay öyküsü.

7. Muayene ve değerlendirme

- SMQ — altın standart; SAS (School Anxiety Scale).
- Konuşma-dil değerlendirmesi.
- Odyometri.

8. Tedavi

1. Davranış temelli yaklaşım birinci basamak — basamaklı maruz bırakma, fading-in tekniği (yakın kişinin kademeli olarak ortama çıkarılması).
2. Entegre Davranış Terapisi (Bergman R.L.) — manualize edilmiş, aile + okul katılımı.
3. Okul temelli müdahale — iletişim gereksinimlerinin aşamalı artırılması, öğretmen koordinasyonu.
4. SSRI (fluoksetin, sertralin) — orta-ağır veya davranış müdahalesine yanıtsız vakalarda. Black B. et al. JAACAP 1994 RKÇ.
5. Akomodasyonu azaltma — ebeveynin çocuk yerine konuşmasının durdurulması.

8.1 Tedavi metodolojileri

1. Kademeli Dahil Etme (Fading-In) Tekniği — Hasta rahat olduğu kişiyle konuşur; kademeli olarak yabancı kişi bu bağlama dahil edilir; sonra hasta yabancı kişiyle konuşmaya geçer.

2. Entegre Davranış Terapisi (IBT — Integrated Behavior Therapy) — Bergman (Bergman R.L.) — Aşamalı maruz bırakma, olumlu pekiştirme, sistematik duyarsızlaştırma; 20 seans. Kanıt: Bergman R.L. et al. JAACAP 2013 RKÇ.
3. Selektif Mutizm Anketi (SMQ — Selective Mutism Questionnaire) — Bergman — 23 madde; ebeveyn formu.
4. SSRI — Fluoksetin — Pediatrik selektif mutizmde kanıt temeli; Black B., Uhde T.W. JAACAP 1994 RKÇ.

8.2 Kaynaklar arasındaki farklar

- AACAP — davranış müdahalesi ilk sıra, SSRI adjunkt.
- NICE — anksiyete bozukluklarının ilkeleri uygulanır.

9. Prognoz

- Erken müdahale ile çoğu çocukta konuşma geri kazanılır.
- Tedavisiz kronikleşme ve sosyal anksiyete bozukluğuna geçiş.

10. Mit ve yanlış inançlar

Mit 1: “Selektif mutizm çocuğun 'inatçılığı'dır”

Kanıt: Selektif mutizm anksiyete bozukluğudur — çocuk konuşamaz, konuşmak istemez pozisyonu yanlıştır.

Mit 2: “Çocuk konuşmuyorsa ona güçlü baskı gerekir”

Kanıt: baskı kaygıyı ve mutizmi güçlendirir; kademeli maruz bırakma önerilir.

Mit 3: “Yaşa göre geçecek, müdahale gerektirmez”

Kanıt: erken müdahale olmadan akademik ve sosyal bozulma devam eder; yetişkinlikte sosyal anksiyete bozukluğuna geçiş riski.

Mit 4: “İki dilli çocukta mutizm normaldir”

Kanıt: “sessiz dönem” yeni dil öğrenirken birkaç ay normal; ≥ 6 ay süren mutizm veya iki dilde de olan — seçici mutizm tanısı düşünülür.

Mit 5: “Yalnızca psikanalitik derin terapi etkilidir”

Kanıt: davranış temelli ve BDT yaklaşımları birinci basamak; psikanalitik müdahale kanıt temeline sahip değildir.

11. Kaynaklar

1. WHO. ICD-11. 6B06 Selective mutism. 2024.
2. APA. DSM-5-TR. 2022.
3. Bergman R.L. et al. Prevalence and description of selective mutism in a school-based sample. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry 2002;41(8):938–946.
4. Bergman R.L., Gonzalez A., Piacentini J., Keller M.L. Integrated Behavior Therapy for Selective Mutism: a randomized controlled pilot study. Behav Res Ther 2013;51(10):680–689.
5. Black B., Uhde T.W. Treatment of elective mutism with fluoxetine: a double-blind, placebo-controlled study. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry 1994;33(7):1000–1006.

6B20–6B2Z OBSESİF-KOMPULSİF (OKB)

Obsessive-compulsive or related disorders

ICD-11 **6B20**	**6B20 OBSESİF-KOMPULSİF BOZUKLUK (OKB)** **Obsessive-compulsive disorder**
ICD-10 F42	Obsesif-kompulsif bozukluk
DSM-5-TR F42.2	Takıntı-Zorlantı Bozukluğu (Obsesif-Kompulsif Bozukluk)

1. Tanım ve nozoloji

Obsesif-Kompulsif Bozukluk (OKB; ICD-11: 6B20; DSM-5-TR: F42.2) — tekrarlayan, ego-distonik obsesyonlar (istenmeyen, müdahale eden düşünceler, görüntüler, dürtüler) veya kompulsiyonlar (tekrarlayan davranış veya zihinsel eylemler) ile karakterize edilen bozukluktur. Genellikle her ikisi de mevcuttur. Hasta, kaygıyı azaltmak veya korkulan sonucu önlemek için kompulsiyonu gerçekleştirir.

DSM-5 (2013)'te OKB anksiyete bozukluklarından ayrılarak "Obsessive-Compulsive and Related Disorders" kategorisine alınmıştır; ICD-11 paralel adım.

2. Tarihçe

- Esquirol J.E.D. (1838) — "monomanie raisonnante".
- Janet P. (1903) — "psychasthénie".
- Freud (1909) — "Rat Man" vakası.
- Mowrer O.H. (1947) — iki faktörlü öğrenme teorisi (klasik koşullanma + operant kaçınma); ERP'nin temeli.
- Meyer V. (1966) — Exposure and Response Prevention (ERP) ilk klinik uygulama.

- DSM-5 (2013) ve ICD-11 (2019) — OKB anksiyete bozukluklarından ayrılmıştır.

3. Epidemiyoloji

- Yaşam boyu yaygınlık: %1,6–2,3 (Ruscio A.M. et al. Mol Psychiatry 2010).
- Cinsiyet: yaklaşık eşit; kadınlarda nispeten daha sık erişkinlikte, erkeklerde çocuklukta erken başlangıç.
- Başlangıç: bimodal — puberte öncesi (10–12 yaş, erkekler) ve erken yetişkinlik (20–25 yaş).
- Komorbidite: MDD ~%60, anksiyete bozuklukları, tik bozuklukları, otizm, istifleme, BDD.

4. Etiyoloji ve patogenez

- Kalıtım %40–50 (Mataix-Cols D. et al. JAMA Psychiatry 2013).
- Nörobiyolojik — kortiko-striato-talamo-kortikal (CSTC) devresinin hiperaktivitesi (orbitofrontal, singulat, kaudat); serotonerjik disregülasyon (SSRI etkisi); glutamat disregülasyonu.
- Genetik araştırma — SLC1A1 (glutamat taşıyıcı), serotonin genleri.
- PANDAS — nadiren streptokok enfeksiyonu sonrası OKB başlangıcı (NIMH 2017).
- Travma, stres tetikleyici faktörler.

5. Klinik özellikler

Tipik semptom alanları

- Kirlenme / temizlik — en yoğun; el yıkama, dezenfeksiyon kompulsiyonları.
- Şüphe / kontrol — kilit, plaka, elektrikli cihazlar.
- Simetri / kesinlik / “just right” — düzenlilikle ilgili.
- Agresif / cinsel / dini obsesyonlar — ego-distonik, anksiyete yaratan.
- İstifleme (biriktirme) — ICD-11'de ayrı kategori (6B24).

Ego-distoni

Hasta obsesyonların kendi düşünceleri olduğunu ancak istenmeyen, mantıksız veya kabul edilemez olduğunu kabul eder (içgörü değişkendir — DSM-5-TR içgörü niteleyicileri: iyi / zayıf / yok).

6. Tanı

6.1 Birleşik tanı ölçütleri

A. Obsesyon, kompulsiyon veya her ikisinin varlığı.

- Obsesyonlar: tekrarlayan, sürekli, istenmeyen düşünceler/görüntüler/dürtüler; rahatsızlık yaratır; hasta bunları bastırmaya veya başka düşünce/hareketlerle nötralize etmeye çalışır.
- Kompulsiyonlar: obsesyona yanıt olarak veya katı bir kurala uygun şekilde gerçekleştirilen tekrarlayan davranış (el yıkama, kontrol etme, sıralama) veya zihinsel eylem (sayma, dua); kaygıyı azaltmaya yönelik, ancak ya gerçekçi değil ya da aşırı.

B. Obsesyon/kompulsiyonlar günde > 1 saat sürer veya belirgin sıkıntı/işlevsel bozulma.

C. Madde veya tıbbi durum dışlaması.

D. Başka bir ruhsal bozuklukla daha iyi açıklanmaz.

6.2 Kaynaklar arasındaki farklar

- DSM-5-TR — içgörü niteleyicileri (iyi/orta — zayıf — yok/sanrı düzeyinde); tik ilişkili alt tip.
- ICD-11 — paralel; biriktirme (6B24), BDD (6B21), koku referans (6B22) ayrı kategoriler.
- NICE CG31 (2005, 2019 surveillance) — tanı klinik görüşme + Y-BOCS ile.

6.3 Tanı algoritması

1. Klinik görüşme.
2. SCID-5, Y-BOCS (Yale-Brown Obsessive Compulsive Scale) — altın standart şiddet ölçeği; CY-BOCS çocuklarda.
3. OCI-R (Obsessive Compulsive Inventory-Revised) — öz değerlendirme.
4. Komorbidite (depresyon, anksiyete, tik, otizm, BDD, biriktirme).

6.4 Ayırıcı tanı

Durum	Ayırt edici
YAB (6B00)	Gerçek hayat kaygıları, kompulsiyonlar yok.

Durum	Ayırt edici
Tik bozuklukları (8A05)	Motor/vokal; amaçlı değil; premonitor his.
BDD (6B21)	Görünüm temelli obsesyonlar.
İstifleme (6B24)	Nesneleri atmada zorluk.
Yeme bozuklukları (6B8x)	Yeme davranışı temel.
Trikotilomania, dermatilomania (6B25.x)	Beden odaklı tekrarlayıcı davranış.
Obsesif-Kompulsif Kişilik Bozukluğu (OKKB)	Sürekli kişilik örüntüsü, ego-sintonik; OKB ego-distonik.
Şizofreni / sanrısal bozukluk	Sanrı düzeyinde içgörü; OKB'de içgörü değişkendir.
Otizm spektrumu	Sınırlı-tekrarlayan davranış; ego-sintonik.

7. Muayene ve değerlendirme

- Y-BOCS / CY-BOCS — altın standart.
- OCI-R — öz değerlendirme.
- Komorbidite (depresyon, anksiyete).

8. Tedavi

8.1 Genel Prensipler (NICE CG31 · APA · WFSBP)

1. Birinci basamak psikoterapi: ERP (Maruz Bırakma ve Tepki Önleme) — hasta korkulan nesne/duruma maruz kalır ve kompulsiyonu gerçekleştirmez. 12–20 seans. Kanıt: Foa E.B. et al. RKÇ'leri; etki büyük.
2. Birinci basamak farmakoterapi: SSRI yüksek dozda — fluoksetin (40–80 mg), sertralin (200 mg), paroksetin (40–60 mg), fluvoksamin (200–300 mg), essitalopram (20–40 mg). OKB'de standart depresyon dozundan yüksek doz gereklidir; etki 8–12 hafta (depresyondan yavaş).
3. Kombinasyon BDT/ERP + SRI — tek başına ERP'ye üstünlük sağlamaz: Foa E.B. et al. Am J Psychiatry 2005 RKÇ'sinde (n=122, klomipramin) ERP ile ERP+klomipramin farklılaşmadı, ikisi de tek klomipraminden üstündü (yanıt %62–86 ERP, %70–79 kombinasyon, %42–48 klomipramin, %8–10

plasebo). Güçlü bileşen ERP'dir; farmakoterapi ERP yoksa veya komorbidite varsa eklenir.

4. Klomipramin (TCA) — birinci sıra alternatif; SSRI'ya yanıtsızlıkta; antikolinerjik ve kardiyak yan etkiler.
5. Augmentasyon (SSRI + atipik antipsikotik düşük dozda) — risperidon, aripiprazol; refrakter durumda.
6. Refrakter ağır OKB: Deep Brain Stimulation (DBS — ventral kapsül/ventral striatum), nörocerrahi (kapsülotomi, singulotomi); EKT etkisiz; ketamin/esketamin hızlı etki çalışmaları devam ediyor.
7. Tedavi süresi — uzun süreli; remisyondan sonra ≥ 1–2 yıl, çok sayıda nüks durumunda ömür boyu.

8.2 Tedavi metodolojileri

1. Ekspozisyon ve Tepki Önleme (ERP — Exposure and Response Prevention) — Meyer (Meyer V.), Foa (Foa E.B.) — Hasta korkulan nesneye (örn. "kirli" eşya) maruz kalır ve kompulsiyonu (el yıkama) gerçekleştirmez; anksiyete kademeli azalır (habituasyon). Standart kurs 12–20 seans, haftada 1–2 kez; daha yoğun format (günlük) etkilidir. Kanıt: Foa E.B. et al. Am J Psychiatry 2005.
2. BDT — bilişsel bileşen — ERP'ya ek; obsesyon hakkında düşüncelerin yeniden değerlendirilmesi; "thought-action fusion" (TAF) ve hiper-sorumluluk kognisyonlarına yönelir.
3. Yale-Brown Obsesif-Kompulsif Ölçeği (Y-BOCS — Yale-Brown Obsessive Compulsive Scale) — Goodman (Goodman W.K.) — 10 madde; 5 obsesyon + 5 kompulsiyon; altın standart; CY-BOCS çocuklarda.
4. SSRI Yüksek Doz — OKB'de standart depresyon dozundan anlamlı derecede yüksek doz gerekir; titrasyon 8–12 hafta; yanıtsızlıkta doz maksimuma çıkarılır.
5. Klomipramin (TCA) — OKB'de kanıt güçlü (CMI multicenter trial 1991); kardiyak ve antikolinerjik yan etkiler; ikinci sıra.
6. Derin Beyin Stimülasyonu (DBS — Deep Brain Stimulation) — Refrakter ağır OKB'de cerrahi müdahale; ventral kapsül/ventral striatum hedefi. Greenberg B.D. et al. Mol Psychiatry 2010.

8.3 Kaynaklar arasındaki farklar

- NICE CG31 (2005, 2019 surveillance) — şiddete göre basamaklı yaklaşım; ERP birinci basamak; SSRI orta-ağır.
- APA Practice Guideline for OCD (2007) — aynı; klomipramin kanıt tabanına göre güçlü, ancak yan etkiye göre ikinci sıra.

- WFSBP (Bandelow B. et al. 2008) — SSRI doz aralıkları ve titrasyon.
- NICE CG31 PANDAS — rutin antibiyotik profilaksisi önerilmez.

9. Prognoz

- Kronik seyir, ancak adekvat tedavi ile anlamlı iyileşme.
- Komorbid depresyon, tikli, otizm kötü prognoz markeri.
- Erken başlangıç ve zayıf içgörü — daha zor tedavi.

10. Mit ve yanlış inançlar

Mit 1: "OKB sadece temizlik ve düzenlilikle ilgili bir kişilik özelliğidir"

Kanıt: Klinik OKB ego-distonic, sıkıntı yaratan ve işlevsel bozulmaya yol açar; obsesif-kompulsif kişilik bozukluğu (OKKB) ego-sintonik farklı bir bozukluktur. Y-BOCS şiddeti ve süre temelinde klinik tanı.

Mit 2: "Hasta iradi olarak obsesyonları 'durdurabilir'"

Kanıt: OKB CSTC devresinin disregülasyonudur; iradi kontrol edilmez; ERP ve SSRI nörobiyolojik düzeyde etki eder.

Mit 3: "SSRI depresyon dozunda OKB'de işe yarar"

Kanıt: OKB'de SSRI yüksek dozda (fluoksetin 60–80 mg, sertralin 200 mg) gerekir; depresyon dozu (örn. fluoksetin 20 mg) çoğu zaman yanıt vermez.

Mit 4: "ERP travma yaratır, çünkü hastayı korkulan durumda tutar"

Kanıt: ERP yapılandırılmış, aşamalı ve hastanın onayı ile gerçekleştirilir; uzun vadeli kanıtlanmış etkinlik gösterir.

Mit 5: "PANDAS OKB'nin ana nedenidir, herkes antibiyotik almalıdır"

Kanıt: NIMH 2017 — PANDAS nadir bir olaydır; rutin antistreptolizin O testleri ve antibiyotik profilaksisi önerilmez; yalnızca klasik klinik tablo varsa.

Mit 6: "Kompulsiyonları yerine getirmeye izin vermek semptomları sakinleştirir"

Kanıt: kompulsiyonlara izin (akomodasyon) OKB'yi güçlendirir; aile akomodasyonunun azaltılması tedavinin önemli bir bileşenidir.

Mit 7: "Bitkisel preparatlar (St John's Wort, kava, omega-3) OKB'yi iyileştirir"

Kanıt: hiçbirinin OKB'de kanıtlanmış etkisi yok; St John's Wort SSRI'larla etkileşim riski.

11. Kaynaklar

1. WHO. ICD-11. 6B20 Obsessive-compulsive disorder. 2024.
2. APA. DSM-5-TR. 2022.
3. NICE CG31. Obsessive-compulsive disorder and body dysmorphic disorder. 2005, 2019 surveillance.
4. APA. Practice Guideline for the Treatment of Patients with Obsessive-Compulsive Disorder. 2007.
5. Bandelow B. et al. WFSBP guidelines for the pharmacological treatment of anxiety, obsessive-compulsive and post-traumatic stress disorders. World J Biol Psychiatry 2008;9(4):248–312.
6. Foa E.B., Liebowitz M.R., Kozak M.J. et al. Randomized, placebo-controlled trial of exposure and ritual prevention, clomipramine, and their combination in the treatment of obsessive-compulsive disorder. Am J Psychiatry 2005;162(1):151–161.
7. Ruscio A.M., Stein D.J., Chiu W.T., Kessler R.C. The epidemiology of obsessive-compulsive disorder in the National Comorbidity Survey Replication. Mol Psychiatry 2010;15(1):53–63.
8. Mataix-Cols D. et al. Familial risks of obsessive-compulsive disorder. JAMA Psychiatry 2013;70(7):709–717.
9. Greenberg B.D. et al. Deep brain stimulation of the ventral internal capsule/ventral striatum for obsessive-compulsive disorder. Mol Psychiatry 2010;15(1):64–79.
10. NIMH. PANDAS/PANS Information for Clinicians. 2017.
11. Goodman W.K., Price L.H., Rasmussen S.A. et al. The Yale-Brown Obsessive Compulsive Scale. I. Development, use, and reliability. Arch Gen Psychiatry 1989;46(11):1006–1011.

ICD-11 **6B21**	**6B21 BEDEN DİSMORFİK BOZUKLUĞU (BDD)** **Body dysmorphic disorder**
ICD-10 F45.2	Hipokondriak bozukluk
DSM-5-TR F45.22	Beden Algısı Bozukluğu (Vücut Dismorfik Bozukluğu)

1. Tanım ve nozoloji

Beden Dismorfik Bozukluğu (BDD; ICD-11: 6B21; DSM-5-TR: F45.22) — hastanın görünümündeki gerçek olmayan veya çok küçük bir kusurla ilgili obsesif uğraş; bu uğraş tekrarlayan davranışlara (aynaya bakma, deri yolma, kozmetik prosedür arayışı) veya zihinsel eylemlere (karşılaştırma) yol açar.

2. Tarihçe

- Morselli E. (1891) — "dysmorphophobia".
- DSM-III-R (1987) — "Body Dysmorphic Disorder" somatoform bozukluklar içinde.
- DSM-5 (2013) ve ICD-11 — Obsesif-kompulsif spektrum kategorisine taşınmıştır.

3. Epidemiyoloji

- Genel popülasyonda yaygınlık: %1,7–2,4 (Buhlmann U. et al. Psychiatry Res 2010).
- Kozmetik dermatoloji ve plastik cerrahi kliniklerinde %9–15.
- Cinsiyet: yaklaşık eşit.
- Başlangıç: ortalama 15–16 yaş.
- Komorbidite: MDD ~%75, OKB ~%30, sosyal anksiyete ~%37, madde kullanımı.
- İntihar riski yüksek: girişim ~%24–28, tamamlanma popülasyondan 45 kat yüksek (Phillips K.A. derlemeleri).

4. Etiyoloji ve patogenez

- Genetik örtüşme OKB ile.
- Nörobiyolojik — orbitofrontal-striatal devre hiperaktivitesi (OKB'ye benzer); görsel işlem bozukluğu (Feusner J.D. ve ark. derlemeleri — hasta detaylara aşırı odaklanır, genel görüntüyü entegre etmez).
- Sosyo-kültürel — kitle medyasında idealize edilmiş görünüm.
- Çocukluk akran mağduriyeti (aşağılama, zorbalık).

5. Klinik özellikler

- Görünümün belirli bir kısmına (yüz, cilt, saç, burun, vücut şekli) obsesif odaklanma.
- Gerçek kusur yok veya başkaları için görünmez/önemsizdir.
- Tekrarlayan davranışlar: aynaya bakma, deri yolma, karşılaştırma, kozmetik prosedür arayışı, giyim/makyaj/kamuflaj.
- Zihinsel hareketler: kendini başkalarıyla karşılaştırma.
- İçgörü çoğu zaman zayıftır; bazen sanrı düzeyinde.
- "Muscle dysmorphia" alt tipi — erkeklerde kasın "yeterince gelişmemiş olması" obsesyonu; anabolik steroid kullanımına yol açar.
- Yüksek sosyal izolasyon, akademik ve mesleki bozulma.

6. Tanı

6.1 Birleşik tanı ölçütleri

A. Görünümdeki kusur veya eksiklikle meşguliyet; başkalarına görünmez veya küçük.

B. Hasta herhangi bir noktada tekrarlayan davranış (ayna, deri yolma, aşırı giyim) veya zihinsel eylem (karşılaştırma) gerçekleştirmiştir.

C. Meşguliyet belirgin sıkıntıya veya işlevsel bozulmaya yol açar

D. Yeme bozukluğu kriterine uyan vücut imajı meşguliyeti olmamalıdır (anorexia/bulimia).

Niteleyiciler: muscle dysmorphia ile; içgörü (iyi / orta — zayıf / yok / sanrılı).

6.2 Kaynaklar arasındaki farklar

- DSM-5-TR / ICD-11 — OKB spektrumu kategorisinde; muscle dysmorphia kalifikatör.

- NICE CG31 — BDD ve OKB ortak öneriler.

6.3 Tanı algoritması

1. Klinik görüşme (hasta çoğu zaman utançtan açık konuşmaz).
2. BDDQ (Body Dysmorphic Disorder Questionnaire) — tarama.
3. BDD-YBOCS — şiddet ölçeği.
4. Komorbidite (depresyon, OKB, sosyal anksiyete, intihar riski).
5. Anabolik steroid veya kozmetik prosedür öyküsü.

6.4 Ayırıcı tanı

Durum	**Ayırt edici**
OKB (6B20)	Obsesyonlar görünümle sınırlı değil.
Yeme bozukluğu (6B8x)	Kilo ve şekil temel; yeme davranışı bozulmuştur.
Sanrı bozukluğu (6A24)	İçgörü yok; BDD'de çoğu zaman değişkendir.
Sosyal anksiyete (6B04)	Sosyal değerlendirme geniş; BDD'de spesifik görünüm kısmına odak.
Trikotilomania (6B25.0)	Saç çekme esas; görünüş kaygısı ikincil.
Olfactory Reference Disorder (6B22)	Koku temelli.

7. Muayene ve değerlendirme

- BDDQ — tarama (Phillips K.A.).
- BDD-YBOCS — modifiye OKB ölçeği, 12 madde.
- C-SSRS — intihar riski (yüksek).

8. Tedavi

1. Birinci basamak psikoterapi: BDT (BDD'ye uyarlanmış, Wilhelm S., Phillips K.A.) — bilişsel yeniden yapılandırma + maruz bırakma + ayna yeniden eğitimi + davranış deneyleri. 12–22 seans.
2. Birinci basamak farmakoterapi: SSRI yüksek dozda — OKB'ye benzer; fluoksetin (40–80 mg), essitalopram, sertralin.
3. Klomipramin — alternatif.
4. Augmentasyon — atipik antipsikotik (özellikle sanrı düzeyinde içgörü).

5. Tedavi süresi uzun; remisyondan sonra ≥ 1–2 yıl.
6. İntihar riski izlenmesi.
7. Kozmetik prosedürlerin önlenmesi — hasta dermatolog/plastik cerrahla işbirliği; kanıt: cerrahi prosedür BDD semptomlarını iyileştirmez, çoğu zaman yeni odak yaratır (Crerand C.E. et al. Ann Plast Surg 2010;65(1):11–16).

8.1 Tedavi metodolojileri

1. BDD için BDT — Wilhelm S., Phillips K.A — Manuelize edilmiş 22-seanslı protokol — psikoeğitim, bilişsel yeniden yapılandırma, ayna yeniden eğitimi (mirror retraining), davranış deneyleri, ritüelin önlenmesi (ERP), nüks önleme.
2. Beden Dismorfik Bozukluk Anketi (BDDQ — Body Dysmorphic Disorder Questionnaire) — Phillips (K.A.) — Tarama.
3. BDD-YBOCS — OKB için Y-BOCS'un BDD'ye uyarlanması.
4. SSRI Yüksek Doz — OKB'ye benzer; yanıt 8–12 hafta.

8.2 Kaynaklar arasındaki farklar

- NICE CG31 — BDT + SSRI yüksek doz birinci basamak.
- Phillips K.A. araştırmaları — SSRI'lar BDD'de etkili; yüksek doz, uzun süreli.

9. Prognoz

- Kronik seyir.
- Yeterli tedavi ile belirgin iyileşme; remisyon mümkündür, ancak uzun süreli idame gerektirir.
- İntihar riski izlenir.

10. Mit ve yanlış inançlar

Mit 1: “BDD hastasının ‘gerçek bir kusuru’ vardır, kozmetik cerrahi yardımcı olur”

Kanıt: Crerand C.E. Ann Plast Surg 2010 — kozmetik prosedürler BDD'yi iyileştirmez; hastaların çoğu sonuçtan memnun değildir veya yeni bir odak geliştirir. Cerrahların BDD taraması yapmaları önerilir.

Mit 2: “BDD hastasının görünüşünü överek ‘rahatlatmak’ gerekir”

Kanıt: övgü veya güvence verme kısa süreli rahatlama sağlar, ancak obsesyonu güçlendirir; aile uyumunun azaltılması tedavi bileşenidir.

Mit 3: “BDD sıradan 'kendine güvensizlik'tir”

Kanıt: BDD fonksiyonel bozulma ve yüksek intihar riski ile birlikte görülür (girişim %24–28, popülasyondan 45 kat yüksek); klinik durum olarak değerlendirilir.

Mit 4: “SSRI depresyon dozunda BDD'de etkilidir”

Kanıt: OKB benzeri — yüksek doz gerekir; yanıt 8–12 hafta.

Mit 5: “Muscle dysmorphia kadın bozukluğu değildir, erkeklerde de olmaz, sadece fitness motivasyonudur”

Kanıt: muscle dysmorphia erkeklerde yaygındır; anabolik steroid kullanımı, kompulsif egzersiz, sosyal izolasyon ve depresyon ile eşlik eder; DSM-5-TR'de niteleyici.

Mit 6: “Plastik cerrahtan ardışık prosedür aramak normaldir”

Kanıt: ardışık prosedürler BDD'nin bir belirtisidir; cerrah BDD taraması yapmalı ve psikiyatriye yönlendirmelidir.

11. Kaynaklar

1. WHO. ICD-11. 6B21 Body dysmorphic disorder. 2024.
2. APA. DSM-5-TR. 2022.
3. NICE CG31. 2005, 2019 surveillance.
4. Phillips K.A. The Broken Mirror: Understanding and Treating Body Dysmorphic Disorder. Oxford Univ Press; 2005.
5. Wilhelm S., Phillips K.A., Steketee G. Cognitive-Behavioral Therapy for Body Dysmorphic Disorder: A Treatment Manual. Guilford Press; 2013.
6. Buhlmann U. et al. Updates on the prevalence of body dysmorphic disorder: a population-based survey. Psychiatry Res 2010;178(1):171–175.
7. Crerand C.E., Menard W., Phillips K.A. Surgical and minimally invasive cosmetic procedures among persons with body dysmorphic disorder. Ann Plast Surg 2010;65(1):11–16.
8. Feusner J.D., Townsend J., Bystritsky A., Bookheimer S. Visual information processing of faces in body dysmorphic disorder. Arch Gen Psychiatry 2007;64(12):1417–1425.

ICD-11 **6B22**	**6B22 OLFAKTÖR REFERANS BOZUKLUĞU (ORS)** **Olfactory reference disorder**
ICD-10 F45.8	Somatoform bozukluklar, diğer
DSM-5-TR F42.8	Başka Türlü Belirlenmiş Obsesif-Kompulsif ve İlişkili Bozukluk (Koku Referans Sendromu)

1. Tanım ve nozoloji

Olfaktör Referans Bozukluğu (ORS) (ICD-11: 6B22 Olfactory Reference Disorder; DSM-5-TR: F42.8 Other Specified Obsessive-Compulsive and Related Disorder) — hastanın vücudundan gerçek olmayan veya aşırı değerlendirilmiş kötü koku yayıldığına dair obsesif inançla karakterize bozukluktur. Hasta başkalarının onu eleştirdiğini veya utandırdığını düşünür, kompulsif yıkanma, deodorant kullanımı, sosyal kaçınma davranışı gösterir.

2. Tarihçe

- Pryse-Phillips W. (1971) — “olfactory reference syndrome” terimi.
- DSM-IV — ayrı kategori yoktu (Sanrısal bozukluk somatik alt tip olarak).
- DSM-5 (2013) — OKB spektrumu karşılıklı bozukluk olarak belirtilmiş; ancak ayrı kod atanmamıştır.
- ICD-11 (2019) — ilk defa resmi tanı kategorisi olarak (6B22).

3. Epidemiyoloji

- Yaygınlık: Kesin epidemiyolojik veri sınırlı; klinik ve derleme raporlarına göre nadir, ancak yetersiz tanı konmakta (Phillips K.A., Menard W. Gen Hosp Psychiatry 2011).
- Başlangıç: erken yetişkinlik (ortalama 20–25 yaş).
- Cinsiyet: yaklaşık eşit.

- Komorbidite: MDD, sosyal anksiyete, OKB, BDD, yüksek intihar riski (intihar düşüncesi ~%68, girişim ~%32 — Phillips K.A., Menard W. Gen Hosp Psychiatry 2011, n=20).

4. Etiyoloji ve patogenez

- Genetik ve nörobiyolojik örtüşme OKB ve BDD ile.
- İçgörü değişkendir — bazen sanrı düzeyinde.
- Sosyo-kültürel faktörler — vücut kokusu hakkında sosyal stigma.

5. Klinik özellikler

- Beden kokusu (ağız, ayak, koltuk altı, genital, genel vücut) veya nefes kokusu hakkında obsesif meşguliyet.
- Başkalarının tepkisini "yanlış okuma" (referans düşünceler) — öksürme, burnu kaşıma, pencere açma "koku sonucu" olarak yorumlanır.
- Kompulsif davranışlar — sık sık yıkanma, kıyafet değiştirme, deodorant, parfüm, ağız temizliği, sakız çiğneme, sıkı diş fırçalama.
- Sosyal kaçınma — iş ve okuldan kaçınma, sosyal izolasyon.
- Telafi edici davranışlar — başkalarından mesafe tutma.

6. Tanı

6.1 Birleşik tanı ölçütleri (ICD-11)

A. Hastanın vücudundan kötü koku yayıldığı veya nefeste kötü koku olduğu hakkında sürekli uğraşı — başkaları için ya görünmez ya da küçük.

B. Hasta obsesyona yanıt olarak tekrarlayan davranışlar (yıkanma, koku maskeleme, deri kontrolü) veya zihinsel eylemler (kendini başkalarıyla karşılaştırma) gerçekleştirir.

C. Meşguliyet belirgin sıkıntıya veya işlevsel bozulmaya yol açar

D. Madde veya tıbbi durum (gerçek halitoz, hiperhidroz, trimetilaminüri, koku maddesinin metabolik hastalıkları) dışlaması.

İçgörü niteleyicisi: iyi / orta — zayıf / yok-sanrı düzeyinde.

6.2 Kaynaklar arasındaki farklar

- ICD-11 — ayrı kategori olarak resmileştirildi.

- DSM-5-TR — “Other specified obsessive-compulsive and related disorder” içinde.

6.3 Tanı algoritması

1. Klinik görüşme.
2. Tıbbi ve otorinolaringolojik muayene — gerçek halitoz, sinüzit, hiperhidroz, mide-bağırsak hastalıkları dışlaması.
3. Trimetilaminüri (TMAU) — idrarda trimetilamin testi (nadir genetik metabolik hastalık, “balık kokusu sendromu”).
4. İçgörü düzeyi değerlendirmesi.
5. Komorbidite ve intihar riski (yüksek!).

6.4 Ayırıcı tanı

Durum	Ayırt edici
Real halitoz / hipergidroz / TMAU	Nesnel olarak doğrulanmış.
BDD (6B21)	Görünüm temelli.
OKB (6B20)	Çok sayıda obsesyon.
Sanrı bozukluğu (6A24) — somatik	İçgörü yok; klinik belirtiler örtüşüyor.
Şizofreni	Diğer psikotik belirtiler.
Sosyal anksiyete (6B04)	Sosyal değerlendirme korkusu geniş.

7. Muayene ve değerlendirme

- Tıbbi muayene — diş hekimliği, KBB, mide-bağırsak.
- TMAU testi (idrar trimetilamin).
- Ölçek — spesifik değil; Y-BOCS uyarlanmış kullanım.
- C-SSRS (yüksek intihar riski).

8. Tedavi

1. BDT — OKB/BDD'ye uygun yaklaşım; maruz bırakma (koku kontrol davranışının durdurulması, sosyal duruma dönüş), bilişsel yeniden yapılandırma.
2. SSRI yüksek dozda — OKB'ye benzer.
3. Augmentasyon — atipik antipsikotik (sanrı düzeyinde içgörü).
4. Sosyal rehabilitasyon.

5. İntihar riski izlenmesi.

8.1 Tedavi metodolojileri

1. BDT (OKB/BDD'ye uyarlanmış) — Maruziyet + ritüellerin önlenmesi + kognitif yeniden yapılandırma.
2. SSRI Yüksek Doz — OKB'ye benzer; 8–12 hafta.

9. Prognoz

Kanıt temeli sınırlıdır. SSRI + BDT ile iyileşme; intihar riski izlenir.

10. Mit ve yanlış inançlar

Mit 1: "Hasta gerçekten kötü kokabilir — önce tıbbi inceleme olmadan psikiyatrik tanı konulamaz"

Kanıt: doğru — tıbbi nedenler (halitoz, hiperhidroz, TMAU) mutlaka dışlanmalıdır; ancak tıbbi neden yoksa ve obsesif uğraşı devam ediyorsa, klinik durum koku referans bozukluğudur.

Mit 2: "Sık sık yıkanma ve deodorant kullanımı sorunu çözer"

Kanıt: kompulsif davranışlar kısa süreli rahatlama sağlar, ancak bozukluğu güçlendirir; cilt irritasyonu, sosyal bozulma artar.

Mit 3: "Hasta basit öz-değer problemi yaşar"

Kanıt: klinik bozukluktur; intihar riski yüksektir (intihar düşüncesi ~%68, girişim ~%32); tıbbi müdahale gereklidir.

Mit 4: "Yalnızca antipsikotik etkilidir, çünkü sanrıdır"

Kanıt: insight değişkendir; SSRI yüksek doz + BDT birinci sıra; antipsikotik augmentasyonu yalnızca sanrı düzeyinde.

11. Kaynaklar

1. WHO. ICD-11. 6B22 Olfactory reference disorder. 2024.
2. APA. DSM-5-TR. 2022.
3. Phillips K.A., Menard W. Olfactory reference syndrome: demographic and clinical features of imagined body odor. Gen Hosp Psychiatry 2011;33(4):398–406.
4. Pryse-Phillips W. An olfactory reference syndrome. Acta Psychiatr Scand 1971;47(4):484–509.

ICD-11 **6B23**	**6B23** **HİPOKONDRİYAZİS** **Hypochondriasis**
ICD-10 F45.2	Hipokondriak bozukluk
DSM-5-TR F45.21	Hastalık Kaygısı Bozukluğu

1. Tanım ve nozoloji

Hipokondriyazis (ICD-11: 6B23 Hypochondriasis; DSM-5-TR: F45.21 Illness Anxiety Disorder — yeni adı, somatik semptom bozukluğundan ayrılarak) — ciddi tıbbi hastalığı var veya gelişiyor şeklinde sürekli meşguliyet ve kaygı. Hasta tekrarlayan tıbbi kontroller (klinik başvuru, internette "Dr. Google" araması, arkadaşlardan tavsiye) veya tersine tıbbi kaçınma davranışı gösterir.

DSM-5 (2013)'te hipokondri tanısı iki yeni kategoriye bölünmüştür:

- Somatic Symptom Disorder (F45.1) — somatik şikayetler mevcuttur;
- Illness Anxiety Disorder (F45.21) — somatik semptomlar minimal veya yok, anksiyete dominant.

ICD-11 (2019) — hipokondriyazis OKB spektrumu içine dahil edilmiştir (somatoform bozukluklardan ayrılarak) — bu kavramsal geçiş kanıt temelini yansıtır (OKB'ye benzer nörobiyoloji ve tedavi yanıtı).

2. Tarihçe

- Yunan tıbbı — "hypochondrium" (kaburga altı) — antik humoral teori.
- DSM-III (1980) — somatoform bozukluklar kategorisinde.
- DSM-5 (2013) — hastalık anksiyetesi bozukluğu ve somatik semptom bozukluğu ayrımı.
- ICD-11 (2019) — OKB spektrumu kategorisine geçiş.

3. Epidemiyoloji

- Yaşam boyu yaygınlık: %1–6 (Bleichhardt G., Hiller W. Br J Health Psychol 2007).
- Birinci basamak hastalarında: ~%3–10.

- Cinsiyet: yaklaşık eşit.
- Başlangıç: erken-orta yetişkinlik.
- Komorbidite: MDD, YAB, OKB, panik bozukluk.

4. Etiyoloji ve patogenez

- Genetik örtüşme OKB ve anksiyete bozuklukları ile.
- Çocukluk travması veya tıbbi hastalıklar ile deneyim.
- Bilişsel — beden duyumlarının felaketleştirilmesi; seçici dikkat; "tıbbi bilgi arayışı" (cyberchondria).
- Modelleme — ailede hastalığa yüksek duyarlılık.

5. Klinik özellikler

- Ciddi hastalığın (kanser, kalp krizi, çeşitli kronik hastalıklar) gelişmesinden korku.
- Normal beden duyumlarının (kalp atışı, baş ağrısı, yavaş bağırsak) ciddi hastalık belirteci olarak yorumlanması.
- Davranış modelleri (iki kutuplu):
    - Care-seeking — tekrarlayan tıbbi muayene, çok sayıda doktora başvuru (doctor shopping), internet araması (cyberchondria), beden muayeneleri.
    - Care-avoiding — tıbbi muayenelerden kaçınma (korkulan tanının doğrulanmasını duymaktan kaçınma), hastane, tıbbi cihazlardan kaçınma.
- Tıbbi güvence kısa süreli rahatlık verir, sonra kaygı geri döner.
- İşlevsel bozulma — işten kalma, sosyal izolasyon.

6. Tanı

6.1 Birleşik tanı ölçütleri

A. Ciddi hastalığı var veya gelişiyor meşguliyet.

B. Somatik semptomlar minimal veya yok; mevcutsa, meşguliyet şiddetine uygun olmayan.

C. Sağlıkla ilgili yüksek kaygı.

D. Hasta aşırı sağlıkla ilgili davranışlar sergiler (kontrol) veya hastalık kaçınması.

E. Devam ≥ 6 ay (DSM-5-TR); hastalığın tipik içeriği zamanla değişebilir.

F. Başka bir psikiyatrik bozukluk (MDD, panik, YAB, OKB, BDD, somatik sanrı) ile daha iyi açıklanmaz.

6.2 Kaynaklar arasındaki farklar

- DSM-5-TR — Illness Anxiety Disorder (F45.21); care-seeking ve care-avoiding alt tipleri.
- ICD-11 — OKB spektrum kategorisinde (6B23); klasik somatoform yerinden farklı yeni yer.

6.3 Tanı algoritması

1. Klinik görüşme.
2. Tıbbi değerlendirme — gerçek hastalığın dışlanması (ancak aşırı testten kaçınılmalıdır)
3. Ölçek — Whiteley Index, SHAI (Short Health Anxiety Inventory)
4. Komorbidite taraması.

6.4 Ayırıcı tanı

Durum	**Ayırt edici**
Somatik Belirti Bozukluğu (6C20)	Somatik şikayetler dominant.
Gerçek tıbbi hastalık	Klinik ve laboratuvar doğrulaması.
OKB (6B20)	Çok sayıda obsesyon; hastalık sınırlı değil.
YAB (6B00)	Çok sayıda endişe alanı.
Panik (6B01)	Atak döneminde “kalp krizi” korkusu.
Sanrı bozukluğu (6A24) — somatik	İçgörü yok.
Major depresif bozukluk — somatik odak	Afektif komponent dominant.

7. Muayene ve değerlendirme

- Whiteley Index (14 madde), SHAI.
- Tıbbi inceleme — bir kez tam, sonra tekrarlanmaz.
- PHQ-9, GAD-7 komorbidite.

8. Tedavi

1. BDT birinci basamak — bilişsel yeniden yapılandırma (felaketleştirme), beden kontrolü ve güvence arayışının önlenmesi (maruziyet + ritual prevention), dikkat eğitimi. Etki: Cooper K. ve ark. Behav Res Ther 2017 meta-analiz.
2. SSRI — orta-ağır vakada veya komorbid depresyon/YAB.
3. Tek hekim modeli (single physician) — hasta yalnızca bir birinci basamak hekimiyle çalışır; çoklu muayeneden ve "doctor shopping"den kaçınma.
4. Güvence sınırı — doktor kaygı yanıtında aşırı kanıt sunmaz; kısa, tutarlı mesaj.
5. Mindfulness-temelli yaklaşım adjunkt.

8.1 Tedavi metodolojileri

1. Hipokondriyazis için BDT — Salkovskis P., Warwick H — Bilişsel model — beden duyumlarının "felaketleştirilmesi" merkezde. Müdahale: psikoeğitim, alternatif açıklamaların araştırılması, beden kontrolü ve güvence arayışının davranış deneyleri, maruz bırakma. 12–16 seans.
2. Whiteley İndeksi (Whiteley Index) — 14 maddelik hastalık kaygısı ölçeği — altın standart tarama.
3. Kısa Sağlık Anksiyetesi Envanteri (SHAI — Short Health Anxiety Inventory) — Salkovskis — 18 madde; klinik ve popülasyon araştırmaları.
4. Tek Hekim Modeli (single physician approach) — Hasta yalnızca bir doktorla çalışır; tüm şikayetler o doktor aracılığıyla yönetilir; çoklu tetkik ve çelişkili görüşlerin önüne geçilir.

8.2 Kaynaklar arasındaki farklar

- Cooper K. et al. Behav Res Ther 2017 meta-analiz — BDT anlamlı etki; orta etki büyüklüğü.
- Greeven A. ve ark. Am J Psychiatry 2007 RKÇ — BDT ve paroksetin her ikisi de plasebodan üstün.

9. Prognoz

- BDT veya SSRI ile çoğu hastada anlamlı iyileşme.
- Kronikleşme tedavisiz; sürekli tıbbi kaynak kullanımı.

10. Mit ve yanlış inançlar

Mit 1: "Hasta 'uydurma' hastalık gösterir, oyun oynar"

Kanıt: hipokondri klinik psikiyatrik bozukluktur; hastanın kaygısı gerçektir; "oyun" veya simülasyon değildir. Faktitiyöz bozukluktan (6D50) ayrılır.

Mit 2: "Tıbbi inceleme ne kadar çok yapılırsa hasta o kadar rahatlar"

Kanıt: tekrarlayan kontrol kısa süreli rahatlama verir, sonra kaygı geri döner; "kontrol bağımlılığı" gelişir. Tek hekim modeli ve kontrol sınırlaması önerilir.

Mit 3: "Reassurance ('sen sağlıklısın') tedavi aracıdır"

Kanıt: tekrarlayan güvence bozukluğu güçlendirir — hasta kanıt aramaya devam eder. Yapılandırılmış hekim yanıtı: tek seferlik değerlendirme, ardından kısa standart mesaj.

Mit 4: "İnternet araması hastanın kendi kendine eğitimine yardımcı olur"

Kanıt: "cyberchondria" — internet araması kaygıyı güçlendirir, felaketleştirmeyi artırır; sınırlama veya yapılandırma önerilir.

Mit 5: "Hipokondri yalnızca yaşlı hastalarda görülür"

Kanıt: başlangıç erken-orta yetişkinlikte; yaş aralığı geniş.

Mit 6: "Sadece antidepresan etkilidir, terapi yardımcı değildir"

Kanıt: Greeven 2007 — BDT ve paroksetin her ikisi de plasebodan üstün; BDT birinci sıra (uzun vadeli etki SSRI'ya kıyasla).

11. Kaynaklar

1. WHO. ICD-11. 6B23 Hypochondriasis. 2024.
2. APA. DSM-5-TR. 2022.
3. Cooper K. et al. Cognitive behaviour therapy for health anxiety: a systematic review and meta-analysis. Behav Res Ther 2017;90:8–20.
4. Greeven A. et al. Cognitive behavior therapy and paroxetine in the treatment of hypochondriasis: a randomized controlled trial. Am J Psychiatry 2007;164(1):91–99.
5. Salkovskis P.M., Rimes K.A., Warwick H.M. The Health Anxiety Inventory: development and validation of scales for the measurement of health anxiety and hypochondriasis. Psychol Med 2002;32(5):843–853.

6. Bleichhardt G., Hiller W. Hypochondriasis and health anxiety in the German population. Br J Health Psychol 2007;12(Pt 4):511–523.

ICD-11 **6B24**	**6B24 İSTİFLEME BOZUKLUĞU** **Hoarding disorder**
ICD-10 F63.8	Alışkanlık ve impuls bozuklukları, diğer
DSM-5-TR F42.3	Biriktiricilik Bozukluğu

1. Tanım ve nozoloji

İstifleme bozukluğu (ICD-11: 6B24; DSM-5-TR: F42.3 Biriktirme Bozukluğu) — eşyaları edinme veya saklama ihtiyacı ve onları atmaktan sürekli zorluk, bu da yaşam alanının (odaların işlevsel amaçlı kullanılamayacak kadar) tıkanmasına yol açar. OKB spektrum kategorisinde.

2. Tarihçe

- Frost R.O., Hartl T.L. (1996) — biriktirmenin bilişsel-davranışçı modeli.
- DSM-IV — OKB'nin alt tipi olarak belirtiliyordu.
- DSM-5 (2013) ve ICD-11 — ayrı tanısal kategori olarak resmileştirildi (kanıt temeli — farklı klinik tezahürler, gidişat, tedavi yanıtı).

3. Epidemiyoloji

- Yaşam boyu yaygınlık: %2–6 (Samuels J.F. ve ark. Behav Res Ther 2008).
- Yaşlılarda yaygınlık daha yüksek (~%6).
- Cinsiyet: yaklaşık eşit; klinik örneklemlerde kadınlar baskın.
- Başlangıç: ergenlik (ortalama 11–15 yaş); şiddet yaşla artar.
- Komorbidite: MDD ~%50, OKB ~%20, YAB, sosyal anksiyete, DEHB.

4. Etiyoloji ve patogenez

- Kalıtım %50.
- Nörobiyolojik — frontostriatal devre bozukluğu; OKB'den farklı aktivasyon modelleri (Tolin D.F. ve ark. derlemeleri).

- Bilişsel defisitler — kategorizasyon, karar verme, dikkat (Frost & Hartl modeli).
- Duygusal bağlanma nesnelere; kayıp travması.
- Yaşlılarda — kognitif düşüş tetikleyicisi.

5. Klinik özellikler

- Nesnelerin edinilmesi (satın alma, ücretsiz edinme, bağış) veya saklanması için sürekli zorluk.
- Nesneleri atma veya bırakma düşüncesi belirgin sıkıntı yaratır.
- Çok sayıda eşya biriktirme ve yaşam alanını işgal etme — odalar işlevsel amaçlı kullanılamaz (yatak odası uyumak için, mutfak yemek için vb.).
- Bazen "hayvan biriktirme" — hayvanların kitlesel barındırılması.
- İçgörü çoğu zaman zayıftır — hasta sorunu kabul etmez.
- Sağlık ve güvenlik riskleri — yangın, enfeksiyonlar, düşme, sosyal izolasyon, evden uzaklaştırılma.

6. Tanı

6.1 Birleşik tanı ölçütleri

A. Edinilen eşyaları atmada veya bırakmada sürekli zorluk, değerinden bağımsız olarak.

B. Bu güçlük eşyaları saklamaya yönelik sürekli talep ve atmayla ilgili distressten kaynaklanır.

C. Birikme yaşam alanını tıkar ve odaların amaçlı kullanımını önemli ölçüde bozar.

D. Önemli sıkıntı veya işlevsel bozulma (kendine, aileye, başkalarına tehlikeli ortam dahil).

E. Tıbbi durum (beyin hasarı, demans) dışlanması.

F. Başka bir ruhsal bozuklukla (OKB "obsesyonları", MDD "enerji yokluğu", psikotik bozukluk sanrıları, otizm "sınırlı ilgi alanları") daha iyi açıklanmaz.

Kalifikatör: excessive acquisition ile; insight (iyi / orta — zayıf / yok).

6.2 Kaynaklar arasındaki farklar

- DSM-5-TR / ICD-11 — ayrı kategori; içgörü kalifikatörü.

- "Hayvan biriktirme" — ayrı bir belirteç olmasa da klinik olarak tanınmış varyant; veteriner ve halk sağlığı kurumlarıyla iş birliği gerektirir.

6.3 Tanı algoritması

1. Klinik görüşme.
2. Ev ziyareti veya fotoğraf kanıtı — yaşam alanının durumu (Clutter Image Rating).
3. Ölçek — Saving Inventory-Revised (SI-R)
4. Komorbidite ve kognitif değerlendirme (yaşlılarda demans dışlaması — MMSE/MoCA).
5. Güvenlik ve sağlık riski değerlendirmesi.

6.4 Ayırıcı tanı

Durum	**Ayırt edici**
OKB (6B20)	Klasik obsesyonlar (temizlik, simetri); biriktirmede ise eşyaların duygusal değeri.
MDD (6A70/6A71)	"Enerji yokluğu" nedeniyle temizlememe; aktif eşya elde etme yok.
Demans	Bilişsel gerileme dominant; sonradan gelişmiş istifleme.
Otizm spektrumu (6A02)	Sınırlı ilgi alanları ve nesnelere bağlılık; sosyal-iletişimsel defisit de mevcuttur.
Şizofreni / sanrı	Sanrı içeriği (tehdit, anlam).
Diogenes sendromu (yaşlılarda)	Öz-bakım bozukluğu + biriktirme; sosyal izolasyon; demans komorbiditesi sıktır.

7. Muayene ve değerlendirme

- SI-R (Saving Inventory-Revised), CIR (Clutter Image Rating).
- Tıbbi ve kognitif muayene (MMSE/MoCA yaşlılarda).
- Güvenlik değerlendirmesi.

8. Tedavi

1. BDT biriktirme için (Frost R.O., Tolin D.F., Steketee G.) — birinci sıra; manuelize edilmiş 26-seanslı protokol — motivasyon artırma, bilişsel yeniden yapılandırma, karar verme eğitimi, sıralama ve atma egzersizleri, ev ziyaretleri. Kanıt: Tolin D.F. et al. Depress Anxiety 2015 meta-analizi (12 örneklem, n=232) — belirtiler anlamlı azalır, ancak hastaların yarısından fazlasında tedaviden sonra da güçlük sürer.
2. SSRI — kanıt temeli sınırlıdır; OKB'de etkili olan SSRI biriktirmede daha zayıf yanıt. Adjuvan rolde.
3. Bilişsel remediasyon — dikkat, kategorizasyon, karar verme eğitimi.
4. Buoyancy yaklaşımı — hastanın içsel motivasyonunun desteklenmesi; zorunlu temizlikle tekrar tıkanma riski.
5. Toplum müdahalesi — halk sağlığı, sosyal hizmet, yangın güvenliği.
6. Yaşlılarda — demans skrinlemesi ve komorbid müdahale.

8.1 Tedavi metodolojileri

1. Toplama bozukluğu için BDT (Hoarding) — Steketee (Steketee G.), Frost (Frost R.O.) — Manuelize edilmiş 26 seans — motivasyonel görüşme, karar verme eğitimi, sıralama egzersizi, ev ziyaretleri, bilişsel yeniden yapılandırma. IOCDF.
2. İstifleme Envanteri-Gözden Geçirilmiş (SI-R — Saving Inventory-Revised) — Frost (Frost R.O.) — 23 madde; üç alt ölçek (edinme, atmada zorluk, dağınıklık).
3. Dağınıklık Görüntü Derecelendirmesi (CIR — Clutter Image Rating) — 9 puanlık ölçek; odanın tıkanma derecesinin fotoğraf temelli değerlendirilmesi.
4. Grup BDT — Maliyet-etkin format; uzun süreli destek.

8.2 Kaynaklar arasındaki farklar

- Tolin D.F. et al. RKÇ'ler — BDT etkilidir; SSRI sınırlı.
- Saxena S. incelemeleri — SSRI'ye yanıt OKB'de gözlemlenenden zayıftır.

9. Prognoz

- Kronik seyir, yaşla şiddet artar.
- BDT ile anlamlı iyileşme, ancak tam remisyon nadir.
- Komorbid demans kötü prognoz.

10. Mit ve yanlış inançlar

Mit 1: “Biriktirme sadece ‘koleksiyoncu’ kişilik özelliği veya tembelliktir”

Kanıt: biriktirme klinik bozukluktur — Frost & Hartl bilişsel-davranışçı model; ayrı nörobiyolojik model; işlevsel bozulma ve sağlık riski. Koleksiyonculuktan farklı olarak eşyalar sistematik değildir ve yaşam alanını tıkar.

Mit 2: “Hastanın evini zorla temizlemek soruna son verir”

Kanıt: zorla temizleme hastanın rızası olmadan — kitlesel distress, travma ve 12 ay içinde tıkanıklığın yeniden oluşmasıyla sonuçlanır. Hasta katılımıyla kademeli sıralama önerilir.

Mit 3: “Biriktirme normal OKB'nin alt-tipidir, SSRI yeterlidir”

Kanıt: DSM-5 ve ICD-11 ayrı kategori; SSRI'ya yanıt OKB'den zayıftır; BDT manualize edilmiş protokol birinci sıra.

Mit 4: “Hayvanları ‘yardım niyetiyle’ çok sayıda tutmak hayvanlar için iyidir”

Kanıt: “hayvan biriktirme” — hayvanların kötü hijyen, beslenme, tıbbi bakım almasıyla sonuçlanır; çok sayıda hayvan ölümü, hayatta kalanların ağır durumda olması; veteriner ve halk sağlığı kurumlarının müdahalesi gerekir.

Mit 5: “Yaşlılarda biriktirme 'normal yaşlanma'dır”

Kanıt: yaşlılarda istifçilik demans belirteci olabilir (özellikle frontotemporal); bilişsel değerlendirme gereklidir.

Mit 6: “Bir kere temizledikten sonra sorun çözülür”

Kanıt: biriktirme kronik bozukluktur; uzun süreli tedavi ve toplum desteği gerekir.

11. Kaynaklar

1. WHO. ICD-11. 6B24 Hoarding disorder. 2024.
2. APA. DSM-5-TR. 2022.
3. Frost R.O., Hartl T.L. A cognitive-behavioral model of compulsive hoarding. Behav Res Ther 1996;34(4):341–350.
4. Steketee G., Frost R.O. Treatment for Hoarding Disorder: Therapist Guide. Oxford Univ Press; 2014.
5. Tolin D.F., Frost R.O., Steketee G. et al. Cognitive behavioral therapy for hoarding disorder: a meta-analysis. Depress Anxiety 2015;32(3):158–166.

6. Samuels J.F. et al. Prevalence and correlates of hoarding behavior in a community-based sample. Behav Res Ther 2008;46(7):836–844.
7. Saxena S. Pharmacotherapy of compulsive hoarding. J Clin Psychol 2011;67(5):477–484.

ICD-11 **6B25**	**6B25 BEDENE ODAKLI YİNELEYİCİ DAVRANIŞ BOZUKLUKLARI** **Body-focused repetitive behaviour disorders**
ICD-10 F63.3	Trikotillomani
DSM-5-TR F63.3 / F42.4	Trikotillomani (Saç Yolma Bozukluğu)

1. Tanım ve nozoloji

Bedene odaklı yineleyici davranış bozuklukları (ICD-11: 6B25 Body-focused Repetitive Behaviour Disorders) — hastanın kendi vücuduna (saç, deri, tırnak) tekrarlayan müdahalesi ile karakterize bozukluklar grubudur. Ana alt tipler:

- 6B25.0 Trikotilomani (saç çekme bozukluğu);
- 6B25.1 Ekskoriyasyon / Dermatillomani (deri yolma bozukluğu);
- 6B25.Y Diğer spesifikleştirilmiş (tırnak yeme — onikofaji, dudak yeme, yanak yeme).

DSM-5-TR'de Trikotilomani (F63.3) ve Ekskoriyasyon (L98.1) ayrı kodlanır, ancak OKB spektrum kategorisinde.

2. Tarihçe

- Hallopeau F.H. (1889) — "trikotillomani" terimi.
- DSM-III-R (1987) — Trikotilomani dürtü kontrol bozukluğu olarak.
- DSM-5 (2013) — OKB spektrum kategorisine taşınmış; ekskoriyasyon ayrı tanı olarak eklenmiştir.
- ICD-11 (2019) — ortak kategori olarak (6B25 şemsiyesi).

3. Epidemiyoloji

- Trikotilomani yaşam boyu yaygınlık: %0,5–2; klinik formda kadınlarda 4:1.
- Ekskoriasyon: %1,4–5,4; kadınlarda yüksek.
- Başlangıç: ergenlik (10–13 yaş).
- Komorbidite: MDD, anksiyete, OKB, BDD, DEHB.

4. Etiyoloji ve patogenez

- Kalıtım %30–40; aile öyküsü yaygın.
- Genetik — SAPAP3 (SLITRK1) — farelerde hipergrooming fenotipi.
- Nörobiyolojik — OKB-benzeri kortiko-striato-talamo-kortikal disregülasyon, ancak farklı profil.
- Davranış mekanizmaları: stres reaksiyonu, "automatic" (otomatik, bilinçsiz) ve "focused" (amaçlı, yoğun dikkatle) alt-tipleri.

5. Klinik özellikler

Trikotilomania (6B25.0)

- Saç çekme — genellikle baştan, kaşlardan, kirpiklerden; bazen vücudun diğer bölgelerinden.
- Saçın gözle görülür kaybı.
- "Pre-pulling tension" veya "post-pulling relief" — tüm hastalarda olmayabilir.
- Trikofaji (çektiği saçın yenmesi) — %10–20 hastada; "trikobezoar" — gastrointestinal tıkanıklık cerrahi gerektirebilir.

Ekskoriasyon / Dermatilomania (6B25.1)

- Derinin yolunması — yüz, kol, derinin bozulmuş alanları ("akne", böcek ısırığı yeri).
- Yaralanma, kabuk, izler.
- Enfeksiyon, yara izi, kozmetik sonuçlar.

Genel özellikler

- Hasta, davranışı durdurmak için tekrarlayan başarısız girişimler gösterir.
- Utançtan sosyal izolasyon (peruk kullanımı, ağzı/kolu örtmek).

6. Tanı

6.1 Birleşik tanı ölçütleri

A. Saç çekme (trikotilomanide) veya deri yolma (ekskoriyasyonda) — gözle görülür saç kaybı veya deri hasarı.

B. Hasta, davranışı durdurmak veya azaltmak için tekrarlayan girişimler gösterir.

C. Davranış klinik olarak anlamlı sıkıntı veya işlevsel bozulmaya yol açar.

D. Tıbbi durum (alopecia areata, dermatolojik hastalık) veya başka bir ruhsal bozukluk (BDD'de görünüm motivli; psikoz sanrıda; madde indüksiyonlu) dışlaması.

6.2 Kaynaklar arasındaki farklar

- DSM-5-TR — Trikotilomani (F63.3) ve Ekskoriyasyon (L98.1) ayrı.
- ICD-11 — ortak 6B25 şemsiyesi; alt-spesifikatörler.

6.3 Tanı algoritması

1. Klinik görüşme (hasta çoğu zaman utançtan açık konuşmaz).
2. Dermatolojik muayene — saç dökülmesi ve cilt hasarının diğer nedenlerinin dışlanması (alopecia areata, tinea capitis, egzama).
3. Ölçek — Massachusetts General Hospital Hairpulling Scale (MGH-HPS), Skin Picking Scale.
4. Komorbidite taraması.
5. Trikofaji taraması — gastrointestinal semptomlar varsa.

6.4 Ayırıcı tanı

Durum	Ayırt edici
Alopecia areata	Otoimmün; sınırlar net, “ünlem işareti saçları”; saç çekme davranışı yok.
Tinea capitis	Mantar enfeksiyonu; KOH incelemesi.
BDD (6B21)	Görünüm temelli obsesyon; cilt yolma kozmetik amaçlı.
OKB (6B20)	Çok sayıda obsesyon; saç ve deri davranışı dominant değil.
Stereotipik hareket bozukluğu (6A06)	Ritmik tekrarlayan motor; vücuda özgü müdahale yok.

Durum	Ayırt edici
Yapay bozukluk (6D50)	Tıbbi kanıt arama motivasyonu.
Psikotik sanrı (parazit hissi — Ekbom)	Sanrı içeriği.

7. Muayene ve değerlendirme

- MGH-HPS (trikotilomani), Skin Picking Scale-Revised.
- Dermatolojik muayene.
- Trikofaji durumunda mide ultrasonu.

8. Tedavi

1. Habit Reversal Training (HRT) birinci basamak — farkındalık eğitimi, karşıt tepki (örn. yumruğu sıkma), motivasyon, sosyal destek. Kanıt: Bloch M.H. et al. Biol Psychiatry 2007 meta-analiz.
2. ACT (Acceptance and Commitment Therapy) — duygusal bileşene odaklanır.
3. Comprehensive Behavioral Treatment (ComB, Mansueto) — HRT + multimodal davranış müdahalesi.
4. N-asetilsistein (NAC) — kanıt tabanı gelişmekte; Grant J.E. ve ark. Arch Gen Psychiatry 2009 RKÇ — trikotilomanide etkililik.
5. SSRI — kanıt temeli sınırlıdır; OKB'de etkili olan SSRI trikotilomanide zayıf yanıt; klomipramin nispeten üstün.
6. Atipik antipsikotik adjunkt — refrakter durumda.
7. Dermatolojik bakım — yaralanma ve enfeksiyonların yönetimi.

8.1 Tedavi metodolojileri

1. Alışkanlık Değiştirme Eğitimi (HRT — Habit Reversal Training) — Azrin (Azrin N.H.), Nunn (Nunn R.G.) — Beş temel bileşen — farkındalık eğitimi, rakip yanıt, motivasyon, sosyal destek, genelleme. Bedene yönelik tekrarlayan davranışlarda altın standart.
2. Kapsamlı Davranış Tedavisi (ComB — Comprehensive Behavioral Treatment) — Mansueto (Mansueto C.S.) — SCAMP modeli — Duyusal, Bilişsel, Duygusal, Motor, Yer modalitelerine göre bireyselleştirilmiş yaklaşım.
3. Kabul ve Kararlılık Terapisi (ACT — Acceptance and Commitment Therapy) — Emosyonel bileşene odak; Woods D.W. et al. Behav Res Ther 2006 RKÇ.

4. NAC — N-asetilsistein — Glutamaterjik modülatör; 1200–2400 mg/gün; Grant J.E. Arch Gen Psychiatry 2009.
5. Massachusetts General Hospital Saç Yolma Ölçeği (MGH-HPS — Massachusetts General Hospital Hairpulling Scale) — 7 madde; sıklığı, yoğunluğu.

8.2 Kaynaklar arasındaki farklar

- Bloch M.H. Biol Psychiatry 2007 meta-analizi — HRT trikotilomani için en kanıtlı.
- Grant J.E. Arch Gen Psychiatry 2009 — NAC 1200–2400 mg/gün etkililik.

9. Prognoz

- Kronik seyir, “waxing and waning”.
- HRT ile anlamlı iyileşme; komorbidite tedavisi önemlidir.

10. Mit ve yanlış inançlar

Mit 1: “Saç çekme ve deri yolma 'kötü alışkanlık'tır, ciddi bir bozukluk değildir”

Kanıt: klinik bozukluktur; işlevsel bozulma, sosyal izolasyon, enfeksiyon ve trikobezoar (cerrahi) riskleri.

Mit 2: “Hasta iradi olarak durdurabilir”

Kanıt: hasta tekrar tekrar deneyip başarısız olur — bu bozukluğun temel belirtisidir; HRT veya farmakoterapi gerekir.

Mit 3: “SSRI trikotilomani için etkilidir (OKB gibi)”

Kanıt: SSRI'ya yanıt OKB'den zayıftır; HRT birinci basamak; NAC adjuvan; klomipramin SSRI'dan nispeten üstün.

Mit 4: “Saçın gizlenmesi (peruk, makyaj) çözüm yoludur”

Kanıt: kozmetik kamuflaj kısa sürelidir; temel davranışa müdahale gereklidir.

Mit 5: “Yalnızca hipnoz ya da psikanalitik derin terapi temel davranış nedenini çözer”

Kanıt: kanıt temeli kısıtlıdır; HRT temelli davranış yaklaşımları üstün.

Mit 6: "Deri yolma 'akne' veya kozmetik soruna yanıttır"

Kanıt: klinik bozukluk — hasta davranışı engelleyemez, deride yara izi ve enfeksiyon oluşturur; klinik müdahale gereklidir.

11. Kaynaklar

1. WHO. ICD-11. 6B25 Body-focused repetitive behaviour disorders. 2024.
2. APA. DSM-5-TR. 2022.
3. Bloch M.H. et al. Systematic review: pharmacological and behavioral treatment for trichotillomania. Biol Psychiatry 2007;62(8):839–846.
4. Grant J.E. et al. N-acetylcysteine, a glutamate modulator, in the treatment of trichotillomania: a double-blind, placebo-controlled study. Arch Gen Psychiatry 2009;66(7):756–763.
5. Woods D.W., Wetterneck C.T., Flessner C.A. A controlled evaluation of acceptance and commitment therapy plus habit reversal for trichotillomania. Behav Res Ther 2006;44(5):639–656.
6. Mansueto C.S., Goldfinger Golomb R., Thomas A.M., Stemberger R.M.T. A comprehensive model for behavioral treatment of trichotillomania. Cogn Behav Pract 1999;6(1):23–43.
7. Azrin N.H., Nunn R.G. Habit-reversal: a method of eliminating nervous habits and tics. Behav Res Ther 1973;11(4):619–628.

6B40–6B4Z STRESLE İLGİLİ

Disorders specifically associated with stress

ICD-11 **6B40**	**6B40 TRAVMA SONRASI STRES BOZUKLUĞU (TSSB)** **Post traumatic stress disorder**
ICD-10 F43.1	Travma sonrası stres bozukluğu
DSM-5-TR F43.10	Örselenme Sonrası Gerginlik (Travma Sonrası Stres) Bozukluğu

1. Tanım ve nozoloji

Travma sonrası stres bozukluğu (TSSB; ICD-11: 6B40; DSM-5-TR: F43.10) — ölüm veya ölüm tehdidi, ciddi yaralanma veya cinsel şiddete bireysel olarak maruz kalma veya doğrudan tanık olma sonrası gelişen, üç ana semptom alanı ile karakterize bozukluktur: Yeniden yaşantılama (intrüzyonlar), Kaçınma, sürekli tehlike hissi (ICD-11) / kognitif-duygudurum değişiklikleri ve hiperarozal (DSM-5-TR).

2. Tarihçe

- “Shell shock” (Birinci Dünya Savaşı), “combat fatigue” (İkinci Dünya Savaşı).
- DSM-III (1980) — “Posttraumatic Stress Disorder” — Vietnam gazisi araştırmaları temelinde.
- DSM-5 (2013) — anksiyete bozukluklarından ayrılarak “Travma ve Stresörle İlişkili Bozukluklar” kategorisine taşınmıştır; A kriteri daraltılmıştır (yalnızca belirli travma türleri).
- ICD-11 (2019) — daha kompakt tanısal konsept; Kompleks TSSB (6B41) ayrı bir kategori olarak resmiyet kazanmıştır.

3. Epidemiyoloji

- Yaşam boyu yaygınlık: %3,9 (WHO World Mental Health), ABD'de ~%6,8.

- Cinsiyet: kadınlarda 2 kat yüksek (cinsel şiddete maruz kalma riskine göre).
- Travma türüne göre risk: cinsel şiddet ~%50 TSSB, fiziksel saldırı ~%25, kaza ~%10, doğal afet ~%5.
- Komorbidite: MDD ~%50, YAB, panik, madde kullanımı, BPD, kompleks TSSB.
- İntihar riski anlamlı derecede yüksek.

4. Etiyoloji ve patogenez

- Kalıtım %30–40.
- Nörobiyolojik — amigdala hiperreaktivitesi, prefrontal-amigdala düzenlemesinin bozulması, hipokamp hacim azalması, HPA ekseni disregülasyonu (paradoksal kortizol düşüklüğü).
- Travma özellikleri — şiddet, süre, başkaları tarafından organize edilmiş şiddet (intentional), çocukluk döneminde meydana gelmesi.
- Risk faktörleri — önceki travma, önceki psikiyatrik öykü, sosyal desteğin olmaması, kadın cinsiyeti, peritravmatik dissosiyasyon.
- Koruyucu — sosyal destek, travma sonrası anlam arayışı.

5. Klinik özellikler

Üç ana alan (ICD-11)

- Yeniden yaşantılama — müdahaleci anılar, flashback, kabuslar; tetikleyicilerle akut sıkıntı ve somatik reaksiyonlar.
- Kaçınma — travma hakkındaki düşüncelerden, hislerden, hatırlatıcılardan, durumlardan kaçınma.
- Sürekli tehlike hissi (hiperuyarılma) — hipervijilans, kolay irkilme, uyku bozukluğu, irritabilite.

DSM-5-TR ek alan — bilişsel-duygudurum değişiklikleri

- Olumsuz inançlar (kendine, başkalarına, dünyaya dair)
- Anhedoni, sosyal izolasyon.
- Duygularda küntleşme, sürekli negatif duygudurum.

Süre ve zamanlama

Semptomlar ≥ 1 ay; başlangıç travmadan sonra gecikmiş olabilir (gecikmiş başlangıç > 6 ay).

6. Tanı

6.1 Birleşik tanı ölçütleri

A. Travmatik olaya maruz kalma (bireysel, tanık, yakınların ölümü/yaralanması hakkında bilgi, mesleki bağlamda travmatik bilgiye tekrar maruz kalma).

B. Tekrar yaşama (intruzif bellek, flashback, kabuslar).

C. Travma hatırlatıcılarından kaçınma.

D. ICD-11: sürekli tehlike hissi; DSM-5-TR: bilişsel-duygudurum değişiklikleri + hiperarousal.

E. Süre ≥ 1 ay.

F. Önemli sıkıntı veya işlevsel bozulma.

G. Madde veya tıbbi durum dışlaması.

6.2 Kaynaklar arasındaki farklar

- DSM-5-TR: 4 semptom alanı (müdahaleci, kaçınma, bilişsel-duygudurum, hiperuyarılma); disosiyatif alt tip niteleyicisi (depersonalizasyon/derealizasyon); başlangıcı gecikmiş.
- ICD-11 (6B40): 3 semptom alanı (daha kompakt); karmaşık TSSB ayrı kategori (6B41).
- NICE NG116 (2018, Post-traumatic stress disorder): tanı yapılandırılmış görüşme (CAPS-5).
- VA/DoD 2023: altın standart tanı CAPS-5; birinci basamakta PCL-5 tarama.

6.3 Tanı algoritması

1. Klinik görüşme + travma geçmişi.
2. CAPS-5 (Clinician-Administered PTSD Scale) — altın standart yapılandırılmış görüşme.
3. PCL-5 (PTSD Checklist) — öz değerlendirme taraması, 20 madde.
4. Komorbidite (MDD, YAB, madde, BPD, kompleks TSSB).
5. İntihar riski (C-SSRS).
6. Tıbbi ve travmatik beyin hasarı (TBH) dışlaması.

6.4 Ayırıcı tanı

Durum	Ayırt edici
Akut stres bozukluğu (6B40 benzer, DSM-5: ASD)	3 gün ile 1 ay arası.
Kompleks TSSB (6B41)	Kendini organize etme bozukluğu (duygulanım, benlik, ilişkiler).
Uyum bozukluğu (6B43)	Travma kriter A'ya ulaşmıyor.
MDD (6A70/6A71)	Afektif semptomlar; intrusifler ve kaçınma yok.
Panik bozukluğu (6B01)	Atak beklenmedik bir anda olur.
BPD (6D10.x)	Sürekli kişilik örüntüsü; dürtüsellik ve ilişkiler.
Disosiyatif bozukluklar (6B6x)	Dissosiyasyon baskın; TSSB'de disosiyatif alt tip niteleyici olabilir.
Travmatik beyin hasarı (TBH)	Nörolojik bulgular; bilişsel defisit.

7. Muayene ve değerlendirme

- CAPS-5 — altın standart.
- PCL-5 (20 madde) — tarama.
- PHQ-9, GAD-7, C-SSRS — komorbidite.
- Travma öyküsü (LEC-5 — Life Events Checklist).

8. Tedavi

8.1 Genel Prensipler (VA/DoD 2023 · APA 2017 · NICE NG116 konsensüsü)

1. Birinci sıra: travma odaklı psikoterapi — bireysel format:
    - Prolonged Exposure (PE, Foa E.B.) — in vivo ve imajinal ekspozisyon travmatik anıya.
    - Cognitive Processing Therapy (CPT, Resick P.A.) — bilişsel yeniden yapılandırma; 12 seans.
    - EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing, Shapiro F.) — bilateral stimülasyon + travmatik anı işleme.
    - Trauma-Focused BDT (TF-CBT, Cohen J.) — çocuk ve ergenlerde.

2. Birinci basamak farmakoterapi: SSRI (sertralin ve paroksetin — FDA onayı TSSB için), SNRI (venlafaksin).
3. İkinci sıra: mirtazapin, nefazodon (karaciğer tehlikesi — dikkatle).
4. Kabuslar için — prazosin (α1 antagonisti) — kanıt temeli tartışmalıdır (Raskind 2003 olumlu, 2018 PACT trial nötr); bireysel yanıt.
5. Adjunkt — atipik antipsikotik (refrakter durumda); benzodiazepin uzun süreli kullanımda kontrendikedir (TSSB gidişini kötüleştirir).
6. EKT — refrakter ağır komorbid depresyonda.
7. Tedavi süresi — psikoterapi 12–16 seans; farmakoterapi remisyondan sonra ≥ 12 ay.

8.2 Tedavi metodolojileri

1. Uzatılmış Maruziyet (PE — Prolonged Exposure) — Foa (Foa E.B.) — Travmatik anıya imajinal maruz bırakma (tekrarlayan, ardışık betimleme) + in vivo maruz bırakma (kaçınılan durumlara). 10-15 seans. Kanıt: Foa E.B. et al. RKÇ'leri; meta-analizlerde altın standart etki.
2. Bilişsel İşleme Terapisi (CPT — Cognitive Processing Therapy) — Resick (Resick P.A.) — Bilişsel yeniden yapılandırma — travma hakkında "stuck points" (güvenlik, itimat, güç, öz-değer, yakınlık). 12 seans. Resick P.A. ve ark. RKÇ'leri.
3. Göz Hareketleriyle Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme (EMDR — Eye Movement Desensitization and Reprocessing) — Shapiro (Shapiro F.) — Bilateral stimülasyon (göz hareketi, işitsel veya taktil) ile travmatik anının yeniden işlenmesi. 8 fazlı protokol. Kanıt: Bisson J.I. et al. Cochrane 2013 — BDT'ye karşılaştırmalı etki.
4. Travma-Odaklı Bilişsel-Davranışçı Terapi (TF-CBT — Trauma-Focused Cognitive Behavioral Therapy) — Cohen (Cohen J.), Mannarino (Mannarino A.) — 3–18 yaşlı çocuk ve ergenler için; PRACTICE protokolü (Psikoeğitim, Gevşeme, Duygusal düzenleme, Bilişsel başa çıkma, Travma öyküsü, In vivo, Ortak seanslar, Güvenliği artırma).
5. Klinisyen Tarafından Uygulanan TSSB Ölçeği (CAPS-5 — Clinician-Administered PTSD Scale) — 30 maddelik yapılandırılmış görüşme; altın standart.
6. TSSB Kontrol Listesi (PCL-5 — PTSD Checklist) — 20 maddelik öz değerlendirme; tarama ve izlem.

8.3 Kaynaklar arasındaki farklar

- VA/DoD 2023 Clinical Practice Guideline for the Management of Posttraumatic Stress Disorder and Acute Stress Disorder: travma-odaklı

psikoterapi birinci sıra (güçlü öneri); farmakoterapi birinci sıra alternatif; psikoterapi + farmakoterapi kombinasyonu rutin öneri değildir; benzodiazepin kontrendikedir.

- APA 2017 PTSD Guideline: CPT, PE, bilişsel terapi ve travma odaklı BDT — güçlü öneri; EMDR — koşullu öneri. VA/DoD 2023 ve ISTSS 2018 EMDR'yi CPT ve PE ile aynı üst düzeye koyar.
- NICE NG116 (2018): travma-odaklı BDT veya EMDR; SSRI ikinci sıra.
- ISTSS 2018: uluslararası öneriler.
- Critical Incident Stress Debriefing (CISD) — Cochrane (Rose S. ve ark. 2002) ve NICE açıkça önermiyor; bazı çalışmalarda TSSB riskini artırıyor.

9. Prognoz

- Travma-odaklı psikoterapi ile çoğu hastada belirgin iyileşme.
- Erken müdahalesiz kronikleşme.
- Komorbid MDD, madde kullanımı kötü prognoz belirteçleri.

10. Mit ve yanlış inançlar

Mit 1: “TSSB sadece savaş gazilerinde görülür”

Kanıt: TSSB herhangi bir travmatik olaydan sonra gelişebilir — cinsel şiddet (~%50 gelişim), fiziksel saldırı, kazalar, doğal afetler, tıbbi prosedürler. Gazilerde yaygınlık yüksektir, ancak popülasyonda da yaygındır.

Mit 2: “CISD (Critical Incident Stress Debriefing) travma sonrası TSSB'yi önler”

Kanıt: Cochrane (Rose S. ve ark. 2002) — CISD TSSB riskini azaltmaz, bazı çalışmalarda artırır. NICE ve VA/DoD açıkça önermez. Erken müdahale olarak “watchful waiting” ve yalnızca semptomlu hastalara travma-odaklı BDT.

Mit 3: “Hasta travma hakkında konuşmamalıdır, ‘açmak’ zararlıdır”

Kanıt: kanıtlanmış travma odaklı terapiler (PE, CPT, EMDR) spesifik travmatik anı ile çalışır; uygun yapılandırılmış formda etkin. Kaçınma TSSB'yi pekiştirir.

Mit 4: “Benzodiazepin TSSB için iyi bir tedavidir”

Kanıt: VA/DoD 2023, APA, NICE — benzodiazepin kontrendikedir; TSSB gidişatını kötüleştirir, bilişsel işlemeye engel olur, bağımlılık potansiyeli.

Mit 5: "Travmatik anıları unutmak ana hedeftir"

Kanıt: amaç unutkanlık değil, anıyla işlev görebilmek — duygusal tepki azalır, ancak anı kalır. Hasta travma hakkında distress olmadan konuşabilir.

Mit 6: "Kannabis (CBD) TSSB'yi iyileştirir"

Kanıt: VA/DoD — kannabis önerilmez; ön çalışmalar var, ancak klinik öneri için yeterli değil; THC TSSB gidişatını kötüleştirebilir.

Mit 7: "MDMA-temelli terapi resmi tedavidir"

Kanıt: MDMA destekli psikoterapi araştırma aşamasındadır; FDA 2024 onay talebi reddedilmiştir (yeniden araştırma gereklidir); standart klinik pratikte değildir.

Mit 8: "EMDR kanıtı zayıftır — sadece plasebo etkisi"

Kanıt: Bisson J.I. Cochrane 2013, VA/DoD 2023 ve ISTSS 2018 — EMDR güçlü öneri, CPT ve PE ile karşılaştırılabilir etki. APA 2017 ve 2025 istisnadır: orada EMDR koşullu öneridir.

11. Kaynaklar

1. WHO. ICD-11. 6B40 Post traumatic stress disorder. 2024.
2. APA. DSM-5-TR. 2022.
3. Department of Veterans Affairs / Department of Defense. Clinical Practice Guideline for the Management of Posttraumatic Stress Disorder and Acute Stress Disorder. 2023.
4. APA. Clinical Practice Guideline for the Treatment of PTSD. 2017.
5. NICE NG116. Post-traumatic stress disorder. 2018.
6. Bisson J.I., Roberts N.P., Andrew M. et al. Psychological therapies for chronic post-traumatic stress disorder (PTSD) in adults. Cochrane Database Syst Rev 2013;(12):CD003388.
7. Foa E.B., Hembree E.A., Rothbaum B.O. Prolonged Exposure Therapy for PTSD. Oxford Univ Press; 2007.
8. Resick P.A., Monson C.M., Chard K.M. Cognitive Processing Therapy for PTSD: A Comprehensive Manual. Guilford Press; 2017.
9. Rose S., Bisson J., Churchill R., Wessely S. Psychological debriefing for preventing post-traumatic stress disorder. Cochrane Database Syst Rev 2002;(2):CD000560.
10. Shapiro F. Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR) Therapy: Basic Principles, Protocols, and Procedures. 3rd ed. New York: Guilford Press, 2018.

11. Cohen J.A., Mannarino A.P., Deblinger E. Treating Trauma and Traumatic Grief in Children and Adolescents. 2nd ed. New York: Guilford Press, 2017.
12. Raskind M.A., Peskind E.R., Chow B. et al. Trial of prazosin for post-traumatic stress disorder in military veterans. N Engl J Med 2018;378(6):507 –517.

	6B41 KARMAŞIK TRAVMA SONRASI STRES BOZUKLUĞU (KTSSB)
ICD-11 **6B41**	**Complex post traumatic stress disorder**
ICD-10 F43.1	Travma sonrası stres bozukluğu
DSM-5-TR F43.10	Travma Sonrası Stres Bozukluğu (DSM-5-TR'de ayrı kategori yoktur)

1. Tanım ve nozoloji

Karmaşık travma sonrası stres bozukluğu (KTSSB; ICD-11: 6B41 Complex Post-Traumatic Stress Disorder) — uzun süreli veya tekrarlayan, kaçışın zor veya imkansız olduğu travmaya (uzun süreli istismar, çocuklukta fiziksel veya cinsel şiddet, savaş, işkence, insan ticareti) yanıt olarak gelişen bozukluktur. TSSB'nin üç semptom alanına (yeniden yaşantılama, kaçınma, sürekli tehdit hissi) ek olarak, "self-organization bozukluğu" (DSO) eklenir: duygulanım düzenleme bozukluğu, olumsuz benlik değerlendirmesi, ilişkilerde zorluk.

ICD-11'de ilk kez resmi tanı kategorisi olarak eklenmiştir; DSM-5-TR'de ayrıca KTSSB kategorisi yoktur (TSSB disosiyatif alt-tip kalifikatörü bazı özellikleri kapsar).

2. Tarihçe

- Herman J.L. (1992) — "Complex PTSD" konsepti ("Trauma and Recovery" kitabı); "Disorder of Extreme Stress Not Otherwise Specified" (DESNOS) — DSM-IV'e dahil edilmedi.
- ICD-11 (2019) — resmi 6B41 kodu; TSSB'den ayrılma kanıt tabanına dayanır (Cloitre M. ve ark. derlemeleri).

3. Epidemiyoloji

- Yaygınlık: Birinci basamak sağlık hizmetinde travmaya maruz kalmış hastalar arasında %1–8 (Brewin C.R. ve ark. derlemeleri).
- Çocukluk istismarı öyküsü olan hastalarda özellikle yüksek.
- Komorbidite: MDD, YAB, disosiyatif bozukluklar, BPD (klinik örtüşme), madde kullanımı, yeme bozuklukları.

4. Etiyoloji ve patogenez

- Travma tipi — uzun süreli, tekrarlayan, başkaları tarafından organize edilmiş (interpersonal), kaçışın zor olması.
- Çocuklukta meydana gelen travma — kişilik gelişimine geniş etki.
- Nörobiyolojik — TSSB ile benzer, ancak daha yaygın HPA disregülasyonu, dissosiyasyon, afekt düzenleme bozukluğu.

5. Klinik özellikler

TSSB üç ana alanı

- Yeniden yaşantı (yaygın belirtiler).
- Kaçınma.
- Sürekli tehlike hissi.

Self-Organizasyon Bozukluğu (DSO) — K-TSSB'nin temel eklemesi

- Affekt düzenleme bozukluğu — duygusal değişkenlik, yoğun reaksiyonlar, duygusal küntleşme.
- Olumsuz öz-değer — sürekli utanç, suçluluk, değersizlik hissi.
- İlişkilerde zorluk — yakın ilişkilerden kaçınma, sürekli şekilde bozulmuş bağlanma.

6. Tanı

6.1 Birleşik tanı ölçütleri (ICD-11)

A. Uzun süreli veya tekrarlayan travmaya maruz kalma.

B. TSSB için üç ana alan mevcuttur.

C. Self-Organizasyon Bozukluğu (DSO) üç alanı:

1. Affekt düzenleme bozukluğu;

2. Olumsuz öz-değer;
3. İlişkilerde zorluk.

D. Önemli fonksiyonel bozulma.

6.2 Kaynaklar arasındaki farklar

- ICD-11 — ayrı kategori; DSO ek talep.
- DSM-5-TR — karmaşık TSSB ayrıca yok; TSSB "with dissociative features" niteleyicisi bazı özellikleri kapsar.
- ISTSS 2019 Complex PTSD Guidelines — aşamalı yaklaşım önerir.

6.3 Tanı algoritması

1. Klinik görüşme + travma geçmişi (uzun süreli, tekrarlayan).
2. ITQ (International Trauma Questionnaire — Cloitre M.) — TSSB ve KTSSB ayırt edilmesi için tasarlanmış.
3. Komorbidite (özellikle BPD, disosiyatif bozukluklar).
4. İntihar ve kendine zarar riski değerlendirmesi.

6.4 Ayırıcı tanı

Durum	**Ayırt edici**
TSSB (6B40)	DSO komponenti yok.
BPD (6D10.x)	Klinik örtüşme anlamlı; BPD'de dürtüsellik, kimlik bozukluğu ve kronik suicidalite dominant; cPTSS'de travma temelinde gelişmiş semptomlar.
Disosiyatif bozukluklar (6B6x)	Disosiyasyon dominant.
MDD (6A70/6A71)	Afektif semptomlar; travma ve DSO yok.

7. Muayene ve değerlendirme

- ITQ (International Trauma Questionnaire) — altın standart.
- PCL-5 + DSO ek ölçekler.
- BPD taraması (McLean Screening Instrument for BPD).
- İntihar ve kendine zarar (C-SSRS).

8. Tedavi

8.1 Genel prensipler (ISTSS 2019)

1. Fazlı yaklaşım (phase-based):
    - Faz 1 — stabilizasyon: güvenlik, duygusal düzenleme becerileri, başa çıkma stratejileri, psikoeğitim.
    - Faz 2 — travmatik anıların işlenmesi: TSSB için kanıtlanmış yöntemler (PE, CPT, EMDR), ancak daha uzun süreli ve sürekli.
    - Faz 3 — reintegrasyon: ilişkilerin onarımı, yaşam kalitesinin iyileştirilmesi.
2. Skills Training in Affective and Interpersonal Regulation (STAIR — Cloitre M.) — travmatik anıların işlenmesinden önceki faz 1 müdahalesi.
3. Travma-odaklı BDT ve EMDR — uyarlanmış formda.
4. DBT-PTSD (Bohus M.) — BPD komorbid vakalarında.
5. SSRI adjunkt — komorbid depresyon ve anksiyete.
6. Tedavi süresi uzun (1–2 yıl veya daha fazla).
7. Klinisyen sürekliliği ve terapötik ittifak kritik öneme sahiptir.

8.2 Tedavi metodolojileri

1. Afektif ve Kişilerarası Düzenlemede Beceri Eğitimi (STAIR — Skills Training in Affective and Interpersonal Regulation) — Cloitre M — Faz 1 — emosyonel düzenleme ve interpersonal becerilerin gelişimi; sonra Narrative Story Telling (NST) ile travmatik anıların işlenmesi. 16–24 seans.
2. Diyalektik Davranış Terapisi — TSSB (DBT-PTSD) — Bohus (Bohus M.), Linehan (Linehan M.) — DBT ilkeleri + travma odaklı bileşenler; özellikle BPD komorbid durumlarda.
3. Narratif Maruziyet Terapisi (NET — Narrative Exposure Therapy) — Schauer M., Neuner F., Elbert T. — Hasta yaşam öyküsünü ardışık anlatır, travmatik epizodlar işlenir; mülteci ve işkence mağdurlarında etkinlik.
4. EMDR, CPT, PE — uyarlanmış — Daha uzun, fazlı yaklaşım içinde.
5. Uluslararası Travma Anketi (ITQ — International Trauma Questionnaire) — Cloitre (Cloitre M.) — TSSB ve KTSSB ayrımı için spesifik valide edilmiş araç.

8.3 Kaynaklar arasındaki farklar

- ISTSS 2019 Complex PTSD Guidelines — fazlı yaklaşım.
- Cloitre M. ve ark. derlemeleri — STAIR + Narrative Exposure Therapy etkili.

- Bohus M. DBT-PTSD — RKÇ kanıt temeli gelişmektedir.

9. Prognoz

- Kronik seyir; ancak fazlı yaklaşımla anlamlı iyileşme.
- Komorbid BPD, disosiyatif bozukluklar, madde kullanımı kötü prognoz.

10. Mit ve yanlış inançlar

Mit 1: "Karmaşık TSSB — yalnızca borderline kişilik bozukluğunun yeni adıdır"

Kanıt: klinik örtüşme anlamlıdır, ancak ICD-11 KTSSB travma temelli; BPD ayrı bir kişilik bozukluğu. ITQ ve BPD ölçekleri ayırt eder; çoğu KTSSB hastası BPD kriterlerini karşılamaz.

Mit 2: "Travma 'kapatıldıktan' sonra hasta normale döner"

Kanıt: uzun süreli travma kişilik gelişimini etkiler; "bağlanma" yeterli değildir; fazlı yaklaşım ve uzun tedavi gereklidir.

Mit 3: "Standart TSSB tedavisi (PE, CPT) karmaşık TSSB için aynı etkilidir"

Kanıt: ISTSS 2019 — KTSSB'de fazlı yaklaşım; hasta travma işlemesi için stabilize olmalıdır (faz 1); doğrudan maruziyet re-travmatizasyon riski yaratabilir.

Mit 4: "Yalnızca antidepresan kompleks TSSB için yeterlidir"

Kanıt: psikoterapi birinci sıra; farmakoterapi adjunkt rolde.

Mit 5: "Hastayı travma hakkında hemen konuşturmak gerekir"

Kanıt: Faz 1 stabilizasyonu olmadan travma işleme zararlı olabilir; trauma-informed care prensipleri.

11. Kaynaklar

1. WHO. ICD-11. 6B41 Complex post traumatic stress disorder. 2024.
2. Cloitre M., Garvert D.W., Brewin C.R. ve ark. Evidence for proposed ICD-11 PTSD and complex PTSD: a latent profile analysis. Eur J Psychotraumatol 2013;4:20706.
3. ISTSS Complex PTSD Treatment Guidelines. International Society for Traumatic Stress Studies; 2019.
4. Herman J.L. Trauma and Recovery. Basic Books; 1992.

5. Cloitre M., Koenen K.C., Cohen L.R., Han H. Skills training in affective and interpersonal regulation followed by exposure: a phase-based treatment for PTSD related to childhood abuse. J Consult Clin Psychol 2002;70(5):1067–1074.
6. Bohus M. et al. DBT-PTSD for posttraumatic stress disorder after childhood abuse: RCT. JAMA Psychiatry 2020;77(12):1235–1245.
7. Schauer M., Neuner F., Elbert T. Narrative Exposure Therapy: A Short-Term Treatment for Traumatic Stress Disorders. 2nd ed. Göttingen: Hogrefe, 2011.
8. Linehan M.M. DBT Skills Training Manual. 2nd ed. New York: Guilford Press, 2015.

ICD-11 **6B42**	**6B42 UZAMIŞ YAS BOZUKLUĞU** **Prolonged grief disorder**
ICD-10 F43.8	Ağır strese karşı diğer tepkiler
DSM-5-TR F43.81	Uzamış Yas Bozukluğu

1. Tanım ve nozoloji

Uzamış yas bozukluğu (ICD-11: 6B42 Prolonged Grief Disorder; DSM-5-TR: F43.81 — 2022'de eklenmiştir) — yakın bir kişinin kaybından sonra, kültürel ve dini beklentilerden daha uzun süren ve önemli işlevsel bozulmaya yol açan keder ve meşguliyet bozukluğudur.

Normal yastan farkı: süre, yoğunluk ve fonksiyonel yük; klinik tanı spesifik süre (ICD-11: ≥ 6 ay; DSM-5-TR: ≥ 12 ay yetişkin, ≥ 6 ay çocuk) ve semptom profiline dayanır.

2. Tarihçe

- Lindemann E. (1944) — akut yas dinamiği araştırmaları.
- Bowlby J. (1980) — bağlanma ve yas.
- Prigerson H.G. et al. (1995–2009) — “Complicated Grief” / “Prolonged Grief” konsepti; tanı kriterlerinin gelişimi.
- ICD-11 (2019) — ilk kez resmi kategori.

- DSM-5-TR (2022) — “Prolonged Grief Disorder” resmi tanı olarak eklenmiştir.

3. Epidemiyoloji

- Yakın kaybından sonra gelişim: genel popülasyonda %7–10, ani/şiddetli ölüm durumunda %49 (Lundorff M. et al. J Affect Disord 2017 meta-analiz).
- Cinsiyet: kadınlarda yüksek.
- Risk faktörleri: genç yaşta kayıp, ani veya şiddetli ölüm, çocuk kaybı, anksiyöz/ambivalent bağlanma.
- COVID-19 pandemisi — uzamış yas yayılımını anlamlı şekilde artırmıştır (Eisma M.C. et al.).

4. Etiyoloji ve patogenez

- Bağlanma kuramı — yakın bağlanılan kişiden ayrılmanın bilişsel işlenmesinde bozulma.
- Nörobiyolojik — kaybedilen bağlanmaya nostaljiye bağlı ödül devresinin aktivasyonu (O'Connor M.F. fMRI çalışmaları).
- Bilişsel — “takılıp kalmış” düşünceler, sağlıklı anlamlandırmanın olmaması.

5. Klinik özellikler

- Sürekli, yoğun “nostalji” veya kaybedilen kişiye meşguliyet.
- Aşağıdakilerden sürekli semptomlar:
    - Benlik duygusunun bozukluğu (kendimin bir parçası öldü)
    - Kaybı kabullenmede zorluk;
    - Kayba bağlı emosyonel ağrı (keder, öfke, suçluluk);
    - Yaşam anlamı kaybı;
    - Duygusal küntleşme;
    - Sosyal aktivitelerden kaçınma;
    - İlişkileri sürdürmede zorluk.

6. Tanı

6.1 Birleşik tanı ölçütleri

A. Yakın kişinin (partner, ebeveyn, çocuk, kardeş, yakın arkadaş) ölümü.

B. Kayıptan sonra ≥ 6 ay (ICD-11) / ≥ 12 ay (DSM-5-TR yetişkin, ≥ 6 ay çocuk) devam eden sürekli ve yoğun özlem veya kaybedilen kişiye sürekli meşguliyet.

C. Aşağıdaki semptomlardan ≥ 3'ü:

1. Benlik duygusu bozukluğu;
2. Kaybı kabullenmede güçlük;
3. Hatırlatıcı uyaranlardan kaçınma;
4. Yoğun duygusal ağrı;
5. Sosyal veya diğer aktivitelere geri dönüşte zorluk;
6. Duygusal küntleşme;
7. Yaşam anlamı kaybı;
8. Yalnızlık ve izolasyon hissi.

D. Süre ve yoğunluk kültürel, sosyal veya dini normlardan anlamlı derecede fazla.

E. Önemli fonksiyonel bozulma.

6.2 Kaynaklar arasındaki farklar

- ICD-11 — ≥ 6 ay süre.
- DSM-5-TR (2022 güncellemesi) — yetişkinde ≥ 12 ay, çocukta ≥ 6 ay; en az 1 ana semptom (yoğun nostalji veya meşguliyet) + ≥ 3 ek semptom.
- NICE — uzamış yas için ayrı kılavuz yok; genel yas yönetimi ilkeleri.

6.3 Tanı algoritması

1. Klinik görüşme — kayıp geçmişi, semptom profili, kültürel bağlam.
2. Ölçek — Prolonged Grief Disorder-13 (PG-13, Prigerson H.G.)
3. Komorbidite (MDD, TSSB — yas bağlamında ayırt edilmesi önemlidir).
4. İntihar riski (yas hastalarında yüksek).

6.4 Ayırıcı tanı

Durum	**Ayırt edici**
Normal yas	"Dalga dalga" gidiş; sosyal işlev korunur; süre kültürel norm dahilinde.
MDD (6A70/6A71)	Anhedoni, değersizlik, intihar düşünceleri kendine yönelik; yas temelde kayıp içerikli.

Durum	Ayırt edici
TSSB (6B40)	Travma ve intrusifler; uzamış yasta intrusifler olumlu anılar olabilir.
Uyum bozukluğu (6B43)	Stres faktörü kayıp olmayabilir; daha kısa süre.

7. Muayene ve değerlendirme

- PG-13 (Prolonged Grief Disorder-13, Prigerson H.G.) ve PG-13-R güncellemesi.
- ICG (Inventory of Complicated Grief) — 19 madde.
- PHQ-9, C-SSRS komorbidite.

8. Tedavi

1. İlk sıra: Komplike Yas Tedavisi (CGT — Shear M.K.) — 16 seans; psikoeğitim, imajinal ve durumsal maruz bırakma, olumlu anıların yeniden yapılandırılması, geleceğe yönelim. Kanıt: Shear M.K. et al. JAMA 2005 RKÇ — kişilerarası terapiden üstün.
2. BDT yas için uyarlanmış — Boelen P.A. modeli; bilişsel yeniden yapılandırma + maruz bırakma.
3. Farmakoterapi: kanıt temeli kısıtlıdır. Komorbid MDD için SSRI. CGT + sitalopram karşılaştırma (Shear et al. JAMA Psychiatry 2016) — CGT tek başına veya kombinasyon CGT'ye göre benzer etkin; sitalopram tek başına plasebodan üstün değil.
4. Aile ve grup desteği.
5. İntihar riski izlemi.

8.1 Tedavi metodolojileri

1. Karmaşık Yas Tedavisi (CGT — Complicated Grief Treatment) — Shear M.K. — 16 seanslı manuelize edilmiş protokol; “kayıp odaklı” + “onarım odaklı” çalışma; imajinal ve durumsal maruz bırakma, olumlu anılar, geleceğe yönelim. Kanıt: Shear M.K. et al. JAMA 2005, JAMA Psychiatry 2016 RKÇ.
2. Uzamış Yas Ölçeği (PG-13 — Prolonged Grief-13) — Prigerson (Prigerson H.G.) — 13 maddelik ölçek; klinik ve popülasyon taraması; PG-13-R güncellemesi.
3. Karmaşık Yas Envanteri (ICG — Inventory of Complicated Grief) — 19 madde.

8.2 Kaynaklar arasındaki farklar

- Shear M.K. derlemeleri ve RKÇ'leri — CGT altın standart.
- Wittouck C. et al. Clin Psychol Rev 2011 meta-analiz — yas-spesifik müdahaleler evrensel yas desteğinden üstün uzamış yasta.

9. Prognoz

- CGT ile çoğu hastada anlamlı iyileşme.
- Tedavisiz kronikleşme ve komorbid MDD/TSSB gelişimi.

10. Mit ve yanlış inançlar

Mit 1: "Yas her zaman '5 aşamadan' geçer — inkar, öfke, pazarlık, depresyon, kabullenme"

Kanıt: Kübler-Ross modeli yarı-ampirik bir kavramdır; sistematik kanıt temeli yoktur; yas nonlineer, bireyselleştirilmiş bir süreçtir.

Mit 2: "Uzamış yas — patolojikleştirilmiş normal kederdir, tedavi gerektirmez"

Kanıt: Klinik tanı süre ve işlevsel bozulma temelinde konur; kanıtlanmış müdahaleler önemli fayda sağlar.

Mit 3: "Antidepresan uzamış yas için birinci basamaktır"

Kanıt: Shear JAMA Psychiatry 2016 — CGT birinci basamak; sitalopram plasebodan üstün değil; yalnız komorbid MDD'de SSRI.

Mit 4: "Zaman tüm yaraları iyileştirir — sadece beklemek gerekir"

Kanıt: Çoğu insan kademeli olarak uyum sağlar, ancak %7-10'u uzamış yas geliştirir; tedavisiz kronikleşme.

Mit 5: "Yas hakkında konuşmak hastaya zararlıdır"

Kanıt: kanıtlanmış müdahaleler (CGT) spesifik kayıp içeriği ile yapılandırılmış formda çalışır; kaçınma uzamış kaybı pekiştirir.

Mit 6: "Sosyal ritüeller (sadaka, anma) zararlıdır, hastayı güzel anıdan ayırmaz"

Kanıt: kültürel ve dini ritüeller yas sürecine destek olur; klinik müdahalede kültürel saygı önemli bir bileşendir.

11. Kaynaklar

1. WHO. ICD-11. 6B42 Prolonged grief disorder. 2024.
2. APA. DSM-5-TR. 2022.
3. Shear M.K., Frank E., Houck P.R., Reynolds C.F. Treatment of complicated grief: a randomized controlled trial. JAMA 2005;293(21):2601–2608.
4. Shear M.K. et al. Optimizing treatment of complicated grief: a randomized clinical trial. JAMA Psychiatry 2016;73(7):685–694.
5. Prigerson H.G. et al. Prolonged grief disorder: Psychometric validation of criteria proposed for DSM-V and ICD-11. PLoS Med 2009;6(8):e1000121.
6. Lundorff M. et al. Prevalence of prolonged grief disorder in adult bereavement: a systematic review and meta-analysis. J Affect Disord 2017;212:138–149.
7. Wittouck C. et al. The prevention and treatment of complicated grief: a meta-analysis. Clin Psychol Rev 2011;31(1):69–78.
8. Boelen P.A., van den Hout M.A., van den Bout J. A cognitive-behavioral conceptualization of complicated grief. Clin Psychol Sci Pract 2006;13(2):109–128.
9. O'Connor M.F., Wellisch D.K., Stanton A.L. et al. Craving love? Enduring grief activates brain's reward center. Neuroimage 2008;42(2):969–972.
10. Eisma M.C., Boelen P.A., Lenferink L.I.M. Prolonged grief disorder following the Coronavirus (COVID-19) pandemic. Psychiatry Res 2020;288:113031.

ICD-11 **6B43**	**6B43 UYUM BOZUKLUĞU** **Adjustment disorder**
ICD-10 F43.2	Uyum bozuklukları
DSM-5-TR F43.2x	Uyum Bozukluğu

1. Tanım ve nozoloji

Uyum bozukluğu (ICD-11: 6B43 Adjustment Disorder; DSM-5-TR: F43.2x) — tanımlanabilir bir stres etkenine (akut veya kronik, bireysel veya kolektif) yanıt olarak başlamış, klinik olarak anlamlı emosyonel veya davranışsal semptomlardır.

Semptomlar başka bir ruhsal bozukluğun (MDD, YAB vb.) tam kriterlerini karşılamaz.

2. Tarihçe

- DSM-III (1980) — "Adjustment Disorder" resmi tanı.
- ICD-11 — stresle ilişkili bozukluklar grubunda; genel semptom profili "preoccupation" (stres faktörü hakkında meşguliyet) + uyum güçlüğü.

3. Epidemiyoloji

- Birinci basamakta en sık psikiyatrik tanılardan; klinik popülasyonlarda %5–20.
- Cinsiyet ve yaş — evrensel; genç yaşta ve yeni stres dönemlerinde daha yoğun.
- Komorbidite: MDD, anksiyete, madde kullanımı, intihar riski (özellikle kısa süreli akut formda).

4. Etiyoloji ve patogenez

- Stres faktörü — tek olay (boşanma, iş kaybı, hastalık tanısı, yas) veya çoklu/sürekli stresör.
- Kişilik ve başa çıkma kaynaklarının rolü — aynı stres farklı kişilerde farklı yanıt.
- Sosyal destek — koruyucu faktör.

5. Klinik özellikler

- Stres faktörü hakkında meşguliyet — tekrarlayan düşünceler, kaygı.
- Yeni duruma adaptasyon zorluğu.
- Duygusal semptomlar — depresif duygudurum, anksiyete, irritabilite.
- Davranış semptomları — sosyal geri çekilme, iş/okul performansında azalma, riskli davranış.

DSM-5-TR alt tipleri

- Depresif duygudurum ile (F43.21);
- Anksiyete ile (F43.22);
- Depresif duygudurum ve anksiyete ile karışık (F43.23);
- Davranış bozukluğu ile (F43.24);

- Duygusal ve davranışsal karışık (F43.25);
- Non-spesifikleştirilmiş (F43.20).

6. Tanı

6.1 Birleşik tanı ölçütleri

A. Tanımlanabilir stres etkenine yanıt — başlangıç 3 ay içinde (DSM-5-TR) / 1 ay içinde (ICD-11).

B. Semptomlar klinik olarak anlamlı — strese uygun olmayan derecede distress veya fonksiyonel bozulma.

C. Başka bir ruhsal bozukluğun (MDD, YAB, TSSB, kompleks TSSB, uzamış yas) kriterlerini karşılamaz.

D. Normal yas (keder) değil.

E. Stres faktörü (veya sonuçları) sonlandıktan sonra semptomlar 6 ay içinde geçer (DSM-5-TR).

6.2 Kaynaklar arasındaki farklar

- DSM-5-TR — başlangıç 3 ay; alt tip niteleyicileri.
- ICD-11 — başlangıç 1 ay; "preoccupation with the stressor" temel belirti; alt-tip yok, ancak ek duygudurum-anksiyete kalifikatörleri.

6.3 Tanı algoritması

1. Klinik görüşme — stres faktörü, semptomların başlangıcı, önceki psikiyatrik geçmiş.
2. SCID-5, MINI.
3. Ölçek — PHQ-9, GAD-7 semptom şiddeti.
4. MDD, YAB, TSSB, kompleks TSSB dışlaması.
5. İntihar riski (C-SSRS) — akut formda özellikle yüksek.

6.4 Ayırıcı tanı

Durum	Ayırt edici
MDD (6A70/6A71)	5+ semptom 2 hafta, tam kriter.
YAB (6B00)	≥ 6 ay (DSM); çoklu alanlar.

Durum	Ayırt edici
TSSB (6B40)	Travmatik olay + intrusifler, kaçınma, hiperarousal.
Uzamış yas (6B42)	Yakın kayıptan ≥ 6 ay (ICD-11) / 12 ay (DSM-5-TR).
Normal yas/stres reaksiyonu	İşlevsel bozulma yok veya bağlama uygun.
Davranış Bozukluğu (6C91)	Sürekli model, strese bağlı değil.

7. Muayene ve değerlendirme

- PHQ-9, GAD-7, C-SSRS.
- Stres faktörünün belgelenmesi.

8. Tedavi

1. Birinci sıra: kısa süreli psikoterapi — destekleyici, problem-çözme, BDT-temelli kısa müdahale (8–12 seans).
2. Stres yönetimi, sosyal desteğin güçlendirilmesi, başa çıkma stratejilerinin geliştirilmesi.
3. Farmakoterapi — yalnızca ağır vakada veya komorbid; SSRI kısa süreli; benzodiazepin akut anksiyetede 1–2 hafta.
4. İntihar riski izlemi.
5. Stres faktörünün ortadan kaldırılması veya düzenlenmesi (mümkünse).

8.1 Tedavi metodolojileri

1. Kısa süreli problem çözme terapisi (Problem-Solving Therapy) — Nezu (Nezu A.M.) — 4–8 seans; somut sorun tanımlama, çözüm seçeneklerinin değerlendirilmesi, davranış uygulaması.
2. Destekleyici Psikoterapi — Doğrulama, duygusal ifade, sosyal destek.
3. BDT kısa formda — Bilişsel yeniden yapılandırma + davranış aktivasyonu.
4. Stres yönetimi ve gevşeme — Nefes egzersizleri, progresif kas gevşemesi, mindfulness.

8.2 Kaynaklar arasındaki farklar

- NICE — uyum bozukluğu için ayrı kılavuz yok; genel anksiyete ve depresyon ilkeleri.

- WHO mhGAP — akut stres reaksiyonlarında destekleyici yaklaşım, hafif vakalarda “watchful waiting”.
- Kanıt temeli sınırlıdır — tanının rezidüel karakteri.

9. Prognoz

- Çoğu vakada 6 ay içinde remisyon.
- Bir kısım uzar veya MDD/TSSB'ye geçer — izlem önerilir.

10. Mit ve yanlış inançlar

Mit 1: “Uyum bozukluğu gerçek bir tanı değildir, sadece 'hayatın zorluğu'dur”

Kanıt: Klinik tanı işlevsel bozulma veya akut sıkıntı gerektirir; özellikle intihar riski değerlendirilmelidir.

Mit 2: “Stres faktörü geçtiğinde tanı da otomatik olarak geçer, tedavi gerektirmez”

Kanıt: bazı vakalar uzar veya MDD/TSSB'ye dönüşür; kısa süreli müdahale tedavi geçişini önler.

Mit 3: “Antidepresan uyum bozukluğu için birinci basamaktır”

Kanıt: psikoterapi birinci sıra; farmakoterapi yalnızca ağır veya komorbid durumda.

Mit 4: “İntihar riski adaptasyon bozukluğunda az olur”

Kanıt: akut stres reaksiyonları yüksek impulsif intihar riski ile birliktedir; aktif değerlendirme.

Mit 5: “Hasta güçsüzdür ya da ‘zayıf karakterlidir’”

Kanıt: reaksiyon stresin şiddeti ve başa çıkma kaynaklarının karşılıklı etkileşiminin sonucudur; karakter zayıflığı açıklaması stigmatik ve yanlıştır.

11. Kaynaklar

1. WHO. ICD-11. 6B43 Adjustment disorder. 2024.
2. APA. DSM-5-TR. 2022.
3. Maercker A. et al. ICD-11 stress-related disorders. World Psychiatry 2013;12(3):198–206.

4. Casey P. Adjustment disorder: epidemiology, diagnosis and treatment. CNS Drugs 2009;23(11):927–938.
5. Nezu A.M., Nezu C.M., D'Zurilla T.J. Problem-Solving Therapy: A Treatment Manual. New York: Springer, 2013.

ICD-11 **6B44**	**6B44 TEPKİSEL BAĞLANMA BOZUKLUĞU** **Reactive attachment disorder**
ICD-10 F94.1	Çocuklukta reaktif bağlılık bozukluğu
DSM-5-TR F94.1	Tepkisel Bağlanma Bozukluğu

1. Tanım ve nozoloji

Tepkisel bağlanma bozukluğu (ICD-11: 6B44; DSM-5-TR: F94.1 Reactive Attachment Disorder) — çocukluğun erken evresinde ağır psikososyal yoksunluk veya yetersiz bakım sonucu gelişen bağlanma davranışının bozulması; çocuk sıkıntı anında bakıcıdan yardım aramaz veya bu arayış belirgin şekilde azalmıştır.

2. Tarihçe

- Bowlby J. (1951) — maternal deprivation raporu (WHO).
- Spitz R.A. (1945) — "hospitalism" kurumsal çocuklarda.
- DSM-III (1980) — "Reactive Attachment Disorder of Infancy" resmi tanı olarak belirlendi.
- DSM-5 (2013) ve ICD-11 — RAD ve Disinhibited Social Engagement Disorder (DSED) ayrı tanılar olarak.
- Nelson C.A. et al. Science 2007 — Bucharest Early Intervention Project — kurumsal yoksunluk ve erken koruyucu aile etkisi.

3. Epidemiyoloji

- Genel popülasyonda nadir; ağır ihmal yaşamış çocuklarda bile %10'dan azdır (DSM-5-TR); kurumsallaşmış çocuklarda inhibe (RAD) tip ~%5 (Gleason M.M. ve ark. JAACAP 2011, BEIP). %30'un üzerindeki oranlar dezinhibe sosyal ilişki bozukluğuna (6B45) aittir, RAD'a değil.

- Başlangıç 5 yaşa kadar.
- Komorbidite: bilişsel eksiklikler, nörogelişimsel bozukluklar, depresif belirtiler.

4. Etiyoloji ve patogenez

- Ağır psikososyal yoksunluk — kurum bakımı, çok sayıda yer değişikliği, ihmal.
- Erken 5 yıla kadar kritik dönemde bakıcı-çocuk etkileşiminin bozulması.
- Bağlanma sistemi nörobiyolojisi — oksitosin, prefrontal-amigdala devresi.

5. Klinik özellikler

- Sıkıntıda bakıcıdan yardım aramama veya minimum çaba.
- Teselli kabul etmede güçlük.
- Sosyal ve duygusal tepkilerin azalması (geri çekilme, sinirlilik, üzüntü).
- Olumlu duygulanımın azaltılması.
- Geri çekilen, hipovijilans davranışı.

6. Tanı

6.1 Birleşik tanı ölçütleri

A. Sürekli şekilde bağlanma davranışının bozulması — çocuk sıkıntıda bakıcıdan yardım aramaz veya temasta minimum tepki.

B. Sürekli duygusal ve sosyal bozulma (pozitif duygulanım azlığı, açıklanamayan irritabilite, üzüntü veya korku).

C. Bozulma erken ağır bakım bozukluğu sonucunda gelişmiştir (ihmal, çok sayıda yer değişikliği, institusyonalizm).

D. Başlangıç 5 yaşa kadar.

E. Otizm spektrumu ile daha iyi açıklanmaz.

F. Çocuğun gelişim yaşı en az 9 ay (bağlanma oluşumuna izin).

6.2 Kaynaklar arasındaki farklar

- DSM-5-TR — RAD geri çekilme formu; DSED sınırsız formu — ayrı tanı (6B45).
- ICD-11 — aynı iki ayrı kategori.

6.3 Tanı algoritması

1. Görüşme bakıcı veya sosyal hizmet uzmanı ile — bakım öyküsü (kurumsallaşma, yer değişiklikleri, ihmal).
2. Yapılandırılmış görüşme (DAI — Disturbances of Attachment Interview, Smyke A.T., Zeanah C.H.).
3. Klinik gözlem çocuk-bakıcı etkileşimi.
4. Otizm spektrumu dışlaması (M-CHAT-R/F, ADOS).
5. Bilişsel ve gelişimsel değerlendirme.

6.4 Ayırıcı tanı

Durum	**Ayırt edici**
Otizm spektrumu (6A02)	Sosyal-iletişimsel defisit, sınırlı-tekrarlayan davranış; bağlanma davranışı değişkendir.
DSED (6B45)	Sınırlandırılmamış sosyal yaklaşım, yabancı kişilerle uygunsuz etkileşim.
Entelektüel yetersizlik (6A00)	Genel kognitif defisit.
TSSB (6B40)	Belirli travmatik olay; intrusifler.
Depresif bozukluk	Afektif komponent.

7. Muayene ve değerlendirme

- DAI (Disturbances of Attachment Interview).
- Strange Situation Procedure (Ainsworth M.) — araştırma bağlamında.
- Gelişim değerlendirmesi (Bayley, Mullen).

8. Tedavi

1. Stabil, sürekli bakım ortamının sağlanması — koruyucu aile, evlat edinme; kurumsal ortam kontrendikedir.
2. Bakıcı-çocuk etkileşimine yönelik müdahaleler — Attachment and Biobehavioral Catch-up (ABC, Dozier M.), Child-Parent Psychotherapy (CPP, Lieberman A.).
3. Travma-odaklı yaklaşım — TF-CBT eklenir travma bağlamında.
4. Komorbid bozukluklar (depresyon, anksiyete, DEHB) tedavisi.

5. Farmakoterapi — RAD'ın kendisi için spesifik onay yok; komorbid semptomlar için.
6. “Holding therapy”, “rebirthing” — tehlikeli, yasaktır (çocuk ölümü kaydedilmiş; APSAC 2006 statement).

8.1 Tedavi metodolojileri

1. Bağlanma ve Biyodavranışsal Onarım (ABC — Attachment and Biobehavioral Catch-up) — Dozier (Dozier M.) — Ebeveyn eğitimi 10 seansta; ev temelli; “nurturance” ve “synchronous” etkileşimin güçlendirilmesi. Kanıt: Dozier M. et al. Dev Psychopathol 2008;20(3):845–859.
2. Çocuk-Ebeveyn Psikoterapisi (CPP — Child-Parent Psychotherapy) — Lieberman A — Travma zemininde RAD için; 0-5 yaş; ebeveyn-çocuk etkileşimi bağlamında.
3. Bağlanma Bozuklukları Görüşmesi (DAI — Disturbances of Attachment Interview) — Smyke (Smyke A.T.), Zeanah (Zeanah C.H.) — 12 maddelik klinisyen-görüşmesi.
4. Stabil bakım ve koruyucu aile — Bucharest Early Intervention Project — kurumsal çocukların erken foster bakımı ile gelişim sonuçlarında anlamlı iyileşme.

8.2 Kaynaklar arasındaki farklar

- AACAP Practice Parameter (Zeanah C.H., Chesher T., Boris N.W. JAACAP 2016).
- APSAC (American Professional Society on the Abuse of Children) — “holding therapy” ve benzeri koersif yöntemler yasaktır.
- Bucharest Early Intervention Project (Nelson Science 2007) — erken koruyucu aile kurumsal çocuklarda sonuçları önemli ölçüde iyileştirir.

9. Prognoz

- Erken stabil bakım ve müdahale ile anlamlı iyileşme.
- Uzun süreli kurumsal yoksunluk — kalıcı kognitif ve emosyonel defisitler.

10. Mit ve yanlış inançlar

Mit 1: "'Holding therapy' ve 'rebirthing' RAD'ı iyileştirir"

Kanıt: APSAC 2006 — bu yöntemler bilimsel temelli değil, zararlıdır; Candace Newmaker (2000) "rebirthing" sırasında ölüm kaydedilmiştir. AACAP, APSAC — mutlak kontrendikasyon.

Mit 2: "Evlat edinilmiş çocuk sevgiyle 'düzelir'"

Kanıt: Stabil ilişkilerin kurulması önemlidir, ancak yoğun RAD için yapılandırılmış tedavi (ABC, CPP) gerektirir.

Mit 3: "RAD otizmin bir formudur"

Kanıt: RAD psikososyal yoksunluk temelli; otizm nörogelişimsel bozukluk. Stabil bakımda RAD önemli ölçüde iyileşir, otizm iyileşmez.

Mit 4: "Hasta 'manipülatif'tir, sert disiplin gerektirir"

Kanıt: RAD'ın klinik belirtileri bağlanma sistemi bozukluğunun sonucudur, manipülasyon değil; ceza temelli yaklaşım semptomları güçlendirir.

Mit 5: "Yalnızca antipsikotik ya da stimülanlar RAD için etkilidir"

Kanıt: RAD için spesifik FDA onaylı ilaç yok; çevre değişikliği ve psikososyal müdahale birinci basamak.

11. Kaynaklar

1. WHO. ICD-11. 6B44 Reactive attachment disorder. 2024.
2. APA. DSM-5-TR. 2022.
3. Zeanah C.H., Chesher T., Boris N.W. AACAP Practice Parameter for the Assessment and Treatment of Children and Adolescents With Reactive Attachment Disorder and Disinhibited Social Engagement Disorder. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry 2016;55(11):990–1003.
4. Nelson C.A., Zeanah C.H., Fox N.A. et al. Cognitive recovery in socially deprived young children: the Bucharest Early Intervention Project. Science 2007;318(5858):1937–1940.
5. Dozier M. et al. Effects of an attachment-based intervention on the cortisol production of infants and toddlers in foster care. Dev Psychopathol 2008;20(3):845–859.

6. APSAC Task Force Report on Attachment Therapy, Reactive Attachment Disorder, and Attachment Problems. American Professional Society on the Abuse of Children; 2006.
7. Ainsworth M.D.S., Blehar M.C., Waters E., Wall S. Patterns of Attachment: A Psychological Study of the Strange Situation. Hillsdale: Erlbaum, 1978.
8. Lieberman A.F., Van Horn P. Psychotherapy with Infants and Young Children: Repairing the Effects of Stress and Trauma on Early Attachment. New York: Guilford Press, 2008.
9. Smyke A.T., Dumitrescu A., Zeanah C.H. Attachment disturbances in young children. I: The continuum of caretaking casualty. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry 2002;41(8):972–982.
10. Gleason M.M., Fox N.A., Drury S. et al. Validity of evidence-derived criteria for reactive attachment disorder: indiscriminately social/disinhibited and emotionally withdrawn/inhibited types. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry 2011;50(3):216–231.

ICD-11 **6B45**	**6B45 DİSİNHİBE SOSYAL KATILIM BOZUKLUĞU** **Disinhibited social engagement disorder**
ICD-10 F94.2	Çocukluk çağının ketlenmiş bağlanma bozukluğu
DSM-5-TR F94.2	Sınırlanmamış Toplumsal Katılım Bozukluğu

1. Tanım ve nozoloji

Disinhibe Sosyal Katılım Bozukluğu (ICD-11: 6B45; DSM-5-TR: F94.2 Disinhibited Social Engagement Disorder, DSED) — çocuğun yabancılarla aşırı ve uygunsuz derecede arkadaşça davranması, ihtiyatsızca yaklaşma veya gitme davranışı — erken psikososyal yoksunluk (kurumsallaşma, çoklu yer değiştirme) sonucu.

RAD ile aynı etiyolojik kökene sahiptir, ancak zıt klinik belirtiyle — geri çekilme yerine sınırsız yaklaşım.

2. Tarihçe

- DSM-IV (1994) — "Reactive Attachment Disorder, Disinhibited Type".
- DSM-5 (2013) — ayrı tanı olarak "Disinhibited Social Engagement Disorder" eklenmiştir.
- ICD-11 (2019) — paralel.

3. Epidemiyoloji

- Genel popülasyonda nadir; kurumsal çocuklarda %20, koruyucu aile yanındaki çocuklarda %10–15.
- Başlangıç 5 yaşa kadar.
- Erken koruyucu aile bakımı ile anlamlı azalma (Bucharest Early Intervention Project), ancak RAD'dan farklı olarak DSED bazen stabil bakım ortamında da devam eder.

4. Etiyoloji ve patogenez

- Ağır psikososyal yoksunluk — RAD ile aynı.
- Kurumsal ortamda çok sayıda bakıcı rotasyonu — "promiscuous attachment" oluşumu.

5. Klinik özellikler

- Yabancı kişilerle açık yaklaşma, ihtiyat olmadan onlarla gitme.
- Dikkatsiz fiziksel yakınlık (sarılmak, oturmak).
- Bakıcı ile kontrol davranışının azaltılması yabancı kişiyle etkileşimde.
- Yabancı korkusu algısının olmaması.
- Akademik ve sosyal bozulma.

6. Tanı

6.1 Birleşik tanı ölçütleri

A. Yabancı kişilerle uygunsuz derecede açık, dostça davranış — aşağıdakilerden ≥ 2'si:

1. Yabancı kişilere yaklaşmada azalmış veya hiç ihtiyat;
2. Kültürel veya yaşa uygun olmayan derecede fiziksel veya sözel yakınlık;
3. Tanıdık olmayan yerde bakıcıyı kontrol etme- arama davranışının azalması;
4. Yabancı kişiyle gitmeye minimum veya hiç ihtiyat.

B. Davranışlar yalnızca dürtüsellik (ADHD) ile sınırlı değil — sosyal çekicilik bileşeni belirgindir.

C. Erken ağır bakım bozukluğu — ihmal, çok sayıda yer değişikliği, enstitüsyonelleşme.

D. Çocuğun gelişim yaşı ≥ 9 ay.

6.2 Kaynaklar arasındaki farklar

- DSM-5-TR / ICD-11 — aynı kriterler; DSED RAD'dan ayrı.
- Yaşa göre gelişim dikkate alınmalıdır — küçük çocuklarda normal sosyal ilgi DSED ile karıştırılmamalıdır.

6.3 Tanı algoritması

1. Görüşme ve gözlem — çocuğun yabancılarla etkileşimi.
2. Bakım geçmişi.
3. DAI (Disturbances of Attachment Interview).
4. Komorbidite taraması (DEHB, otizm).

6.4 Ayırıcı tanı

Durum	**Ayırt edici**
RAD (6B44)	Geri çekilme, bağlanma yok; DSED'de açık yaklaşım.
DEHB (6A05)	Dürtüsellik, ancak sosyal çekicilik bileşeni yok.
Otizm spektrumu (6A02)	Sosyal-iletişimsel defisit.
Williams sendromu	Genetik; “hipersosyabilite” + spesifik fiziksel özellikler.

7. Muayene ve değerlendirme

- DAI.
- Gözlem, alışılmadık ortamda.
- Williams sendromu genetik test (FISH 7q11.23) — şüphe varsa.

8. Tedavi

1. Stabil bakım ortamı.

2. Ebeveyn eğitimi — çocuğa "güvenli üs" konseptinin geliştirilmesi; ABC programları.
3. Yabancı kişi ile uygun mesafe öğretme.
4. Komorbidite tedavisi (DEHB).
5. Toplum ve okul personeli koordinasyonu — çocuğun güvenliği.
6. Spesifik farmakoterapi yoktur; komorbid semptomlar için.

8.1 Tedavi metodolojileri

1. Bağlanma ve Biyodavranışsal Onarım (ABC — Attachment and Biobehavioral Catch-up) — Dozier (Dozier M.) — RAD için de kullanılır; DSED'de bakıcı-çocuk senkronizasyonunun güçlendirilmesi.
2. Güvenlik eğitimi — Çocuğa yabancı kişilerle uygun mesafe öğretme; bakıcıyı kontrol etme davranışının pekiştirilmesi.
3. DAI — RAD ve DSED ayrımında.

8.2 Kaynaklar arasındaki farklar

- AACAP 2016 — RAD ile aynı yönergeler.
- DSED, RAD'dan farklı olarak stabil ortamda da devam edebilir — uzun süreli izlem.

9. Prognoz

- Stabil bakım ve müdahale ile iyileşme; ancak DSED bazen uzun süreli devam eder.
- Yetişkinlikte dürtüsel ilişkiler, istismar riskleri kalabilir.

10. Mit ve yanlış inançlar

Mit 1: "Açık, dost canlısı çocuk olumlu bir özelliktir, bozukluk değildir"

Kanıt: uygun sosyal mesafe gelişim evresinin işaretidir; DSED'de sınırların olmaması çocuğun istismar riskini artırır.

Mit 2: "DSED stabil bakımda kısa sürede geçer"

Kanıt: RAD'dan farklı olarak DSED bazen stabil ortamda da devam eder (Bükreş çalışması); uzun süreli müdahale gerektirir.

Mit 3: "DSED otizmin 'hafif formu'dur"

Kanıt: ayrı bir bozukluktur; etiyolojisi psikososyal yoksunluktur; klinik tezahürler zıttır (otizmde sosyal geri çekilme, DSED'de sınırsız yaklaşım).

Mit 4: “Ceza ile çocuğu ‘düzeltmek’ mümkündür”

Kanıt: ceza bozukluğu güçlendirir ve travmatik etki gösterir; pozitif bağlanma temelli yaklaşım önerilir.

Mit 5: “Williams sendromu ve DSED aynıdır”

Kanıt: Williams sendromu genetik (7q11.23 delesyonu), spesifik fiziksel ve kognitif profil; “hipersosyabilite” belirtisi olsa da farklı nörobiyolojik ve etiyolojik bozukluktur.

11. Kaynaklar

1. WHO. ICD-11. 6B45 Disinhibited social engagement disorder. 2024.
2. APA. DSM-5-TR. 2022.
3. Zeanah C.H. et al. AACAP Practice Parameter. JAACAP 2016;55(11):990–1003.
4. Gleason M.M. et al. Validity of evidence-derived criteria for reactive attachment disorder: indiscriminately social/disinhibited and emotionally withdrawn/inhibited types. JAACAP 2011;50(3):216–231.
5. Nelson C.A. et al. Bucharest Early Intervention Project. Science 2007;318(5858):1937–1940.
6. Dozier M., Bernard K. Attachment and biobehavioral catch-up: addressing the needs of infants and toddlers exposed to inadequate or problematic caregiving. Curr Opin Psychol 2017;15:111–117.

6B60–6B6Z DİSOSİYATİF BOZUKLUKLAR

Dissociative disorders

ICD-11 **6B64**	**6B64 DİSOSİYATİF KİMLİK BOZUKLUĞU (DKB)** **Dissociative identity disorder**
ICD-10 F44.81	—
DSM-5-TR F44.81	Kimlik Çözülmesi Bozukluğu

1. Tanım ve nozoloji

Disosiyatif Kimlik Bozukluğu (DKB; ICD-11: 6B64 Disosiyatif Kimlik Bozukluğu; DSM-5-TR: F44.81) — iki veya daha fazla farklı kişilik durumu ("kimlikler", "alterlar") arasında geçişlerle karakterize olan ağır disosiyatif bozukluktur. Her kimlik görece sürekli bir benlik hissi, bellek, davranış, duygulanım, algı ve biliş örüntülerine sahiptir. Aynı zamanda sürekli disosiyatif amneziler (günlük olaylar, önemli kişisel bilgiler, travma).

DKB — çocukluğun ağır travması (özellikle tekrarlayan fiziksel veya cinsel şiddet) ile ilişkili; "split personality" kitle medyasında çarpıtılmış imaj, klinik gerçeklikten farklıdır.

2. Tarihçe

- 1791 — Eberhardt Gmelin ilk vaka tanımı.
- Janet P. (1880'ler) — "dissociation" konsepti.
- DSM-III (1980) — "Multiple Personality Disorder".
- DSM-IV (1994) — "Dissociative Identity Disorder" terimi.
- 1980-90'lar — "False Memory" tartışması; bazı tanı vakalarında "iyatrojenik indüksiyon" iddiaları.

- ISSTD Treatment Guidelines (Adult Treatment, 3rd Revision 2011) — fazalı (phase-oriented) yaklaşımı standartlaştırmıştır.

3. Epidemiyoloji

- Klinik popülasyonlarda yaygınlık: %1–3; genel popülasyonda ~%1,5 (Sar V. ISRN Psychiatry 2011 derlemesi).
- Cinsiyet: kadınlarda klinik popülasyonlarda 5–9 kat yüksek.
- Başlangıç: semptomlar çocuklukta oluşur, kliniğe çoğunlukla 20–40 yaşında başvurulur.
- Komorbidite: MDD, TSSB, kompleks TSSB, BPD, somatik semptom, yeme bozuklukları, madde kullanımı, intihar riski çok yüksek.

4. Etiyoloji ve patogenez

- Travma modeli — çocuklukta tekrarlayan ağır travma (cinsel veya fiziksel şiddet, ihmal, bakıcı şiddeti); hastaların %90+ travma öyküsü gösterir (Putnam F.W. derlemeleri).
- Nörobiyolojik — hipokampus ve amigdala hacim azalması; default mode ve salience network disregülasyonu (Reinders A.A. ve ark. derlemeleri).
- Bağlanma — düzensiz bağlanma stili çocuklukta.
- İyatrojenez / sosyal-bilişsel model savunucuları — bazı tanılar terapötik indüksiyon sonucu olabilir (Lilienfeld S.O. eleştirisi); ancak çoğu araştırma travma temelli modeli destekler.

5. Klinik özellikler

- İki veya daha fazla farklı kimlik durumu — bir kısım hasta açık geçişleri belgeler, diğerleri yalnızca "iç sesler", "kontrol kaybı" hissi ile görünür.
- Sürekli amneziler — günlük olaylar, kişisel bilgiler, travmatik epizodlar.
- Depersonalizasyon ve derealizasyon.
- Kimlik geçişleri strese, tetikleyicilere yanıt olarak.
- Kendine zarar verme, intihar girişimleri, somatik semptomlar.
- Kompleks disosiyatif semptomlar (disosiyatif tutmalar, somatoform).

6. Tanı

6.1 Birleşik tanı ölçütleri

A. İki veya daha fazla farklı kişilik durumu — benlik ve eylemlilik duygusunda belirgin kesinti, davranış, duygulanım, algı, biliş veya sensorimotor işlevlerde değişiklikler.

B. Günlük olaylar, önemli kişisel bilgiler ve/veya travmatik olaylarla ilgili tekrarlayan amneziler.

C. Önemli sıkıntı veya işlevsel bozulma.

D. Yaygın bir kültürel veya dini uygulamanın parçası değil.

E. Madde veya tıbbi durum (örn. nöbet) dışlaması.

6.2 Kaynaklar arasındaki farklar

- DSM-5-TR — aynı kriterler; çocuklarda hayali arkadaş normal gelişimin parçası olduğu için istisna.
- ICD-11 — amnezi zorunlu değildir: “tipik olarak amnezi dönemleri görülür” denir, DSM-5-TR ise onu B ölçütü olarak ister. Trans ve possession bozuklukları ICD-11’de ayrı kategorilerdir (6B62, 6B63).
- ISSTD Guidelines 2011 — tanı yapılandırılmış görüşme (SCID-D) ile doğrulanmalıdır.

6.3 Tanı algoritması

1. Klinik görüşme — travma geçmişi, disosiyatif semptomlar.
2. SCID-D (Structured Clinical Interview for DSM Dissociative Disorders) — altın standart.
3. Ölçek — DES (Dissociative Experiences Scale, ≥ 30 cut-off, ≥ 45 DKB göstergesi); MID (Multidimensional Inventory of Dissociation).
4. Komorbidite (TSSB, BPD, MDD, madde).
5. İntihar ve kendine zarar verme riski (yüksek).
6. Tıbbi ve nörolojik — nöbet, ensefalit dışlaması (EEG, MR).

6.4 Ayırıcı tanı

Durum	Ayırt edici
BPD (6D10.x)	Duygusal değişkenlik ve dürtüsellik dominant; klinik örtüşme anlamlı, komorbidite sık.
TSSB / KTSSB (6B40/6B41)	Travmatik intrusifler ve kaçınma temel; dissosiyasyon bileşen olabilir.
Şizofreni (6A20)	"Sesler" şizofreniden farklı — iç diyalog gibi; psikoz karakteristiği yok.
Bipolar (6A60)	Afektif epizodlar; dissosiyasyon yok.
Yapay bozukluk (6D50)	Tıbbi role göre yalan; kazanç motivasyonu.
Nöbet (epileptik veya non-epileptik)	EEG.
"Possession" — kültürel	Bağlam ve kültürel norm.

7. Muayene ve değerlendirme

- SCID-D-R — altın standart yapılandırılmış görüşme.
- DES, MİD ölçekleri.
- C-SSRS intihar; kendine zarar değerlendirmesi.
- EEG tutma istisnası.

8. Tedavi

8.1 Genel prensipler (ISSTD 2011)

1. Phase-oriented (üç fazlı) yaklaşım:
    - Faz 1 — stabilizasyon ve semptom azaltılması: güvenlik, duygusal düzenleme, başa çıkma becerileri, hastaneye yatışı azaltma, kendine zarar yönetimi.
    - Faz 2 — travmatik anıların işlenmesi: uyarlanmış travma-odaklı müdahale.
    - Faz 3 — entegrasyon ve rehabilitasyon: kimlikler arası iletişim, fonksiyonel iyileşme, ilişkiler.
2. Spesifik psikoterapötik yaklaşımlar — Internal Family Systems (Schwartz R.) atfı, modifiye EMDR.

3. Farmakoterapi — DKB için spesifik onay yok; komorbid TSSB, MDB, anksiyete semptomları için SSRI, prazosin (kabuslar).
4. Hospitalizasyon — akut kendine zarar verme veya intihar riskinde.
5. Multidisipliner yaklaşım — psikiyatrist, psikolog, sosyal destek.
6. Uzun süreli tedavi (yıllar); klinisyen sürekliliği ve terapötik ittifak kritik.

8.2 Tedavi metodolojileri

1. Faz-Yönelimli Tedavi (Phase-Oriented Treatment — ISSTD) — Üç fazlı yaklaşım; tutarlılık ve hasta stabilitesi esastır.
2. Disosiyatif Bozukluklar için Yapılandırılmış Klinik Görüşme (SCID-D-R — Structured Clinical Interview for DSM Dissociative Disorders, Revised) — 277 maddelik yapılandırılmış görüşme; altın standart.
3. Disosiyatif Yaşantılar Ölçeği (DES — Dissociative Experiences Scale) — 28 madde; tarama.
4. Çok Boyutlu Dissosiyasyon Envanteri (MID — Multidimensional Inventory of Dissociation) — 218 madde; ayrıntılı disosiyatif profil.
5. EMDR — modifikasyonlu — Stabilizasyondan sonra travma işleme; ardışık ve hasta dayanıklılığına uyarlanmış.

8.3 Kaynaklar arasındaki farklar

- ISSTD 2011 — fazalı yaklaşım altın standarttır.
- Travma-temelli yaklaşım ve iyatrojenez riski — “alters” arayışı veya indüksiyonundan kaçınma.

9. Prognoz

- Uzun süreli evre odaklı terapi ile fonksiyonel iyileşme.
- Yüksek intihar ve kendine zarar verme riski izlenir.
- Komorbidite tedavisi önemlidir.

10. Mit ve yanlış inançlar

Mit 1: “DID — kitle medyasındaki gibi 'bölünmüş kişilik'tir”

Kanıt: Film veya televizyon tasvirleri (dramatik geçişler, “farklı insanlar”) çoğu hastada daha ince klinik tabloyla örtüşmez — daha çok “kontrol kaybı”, iç sesler, amneziler dominant.

Mit 2: “DKB terapist tarafından indüklenmiş bir yalandır”

Kanıt: çocukluk travması ile güçlü ilişki (Putnam derlemeleri); nörobiyolojik belirteçler (Reinders fMRI); uluslararası çalışmalar tutarlı. Ancak tanı dikkatli olmalıdır — alter indüksiyon tekniklerinden kaçınmak önemlidir.

Mit 3: “DKB nadir ya da uydurma bir bozukluktur”

Kanıt: klinik popülasyonlarda %1–3 yaygınlık (Sar 2011); yetersiz tanı konulan bir durumdur.

Mit 4: “Hipnoz veya hastaneye yatış ana tedavidir”

Kanıt: faz odaklı psikoterapi birinci sıra; hipnoz adjunkt olarak kullanılabilir (dikkatle); hastaneye yatış yalnızca akut kendine zarar veya intihar riskinde.

Mit 5: “DKB'li hasta şiddet uygulamaya eğilimlidir”

Kanıt: DKB hastaları şiddetin mağduru olma olasılığı daha yüksektir; şiddet başkalarına karşı nadirdir. “Şizofrenili insanlar tehlikelidir” mitinin paralelidir.

Mit 6: “Tüm kimlikleri ‘birine birleştirmek’ temel amaçtır”

Kanıt: entegrasyon tipik hedeftir, ancak tüm hastalarda tam iyileşmeye ulaşmak mümkün değildir; “kooperasyon” ve “işlevsel aktivite” de klinik sonuç olarak kabul edilir.

11. Kaynaklar

1. WHO. ICD-11. 6B64 Dissociative identity disorder. 2024.
2. APA. DSM-5-TR. 2022.
3. International Society for the Study of Trauma and Dissociation. Guidelines for Treating Dissociative Identity Disorder in Adults, Third Revision. J Trauma Dissociation 2011;12(2):115–187.
4. Sar V. Epidemiology of dissociative disorders: an overview. Epidemiology Research International 2011;2011:404538.
5. Putnam F.W. Diagnosis and Treatment of Multiple Personality Disorder. Guilford Press; 1989.
6. Reinders A.A.T.S. et al. The psychobiology of authentic and simulated dissociative personality states: the full Monty. J Nerv Ment Dis 2016;204(6):445–457.
7. Steinberg M. Structured Clinical Interview for DSM-IV Dissociative Disorders, Revised (SCID-D-R). APA Press; 1994.

8. Lilienfeld S.O., Lynn S.J., Kirsch I. et al. Dissociative identity disorder and the sociocognitive model: recalling the lessons of the past. Psychol Bull 1999;125(5):507–523.
9. Schwartz R.C., Sweezy M. Internal Family Systems Therapy. 2nd ed. New York: Guilford Press, 2020.

ICD-11 **6B65**	**6B65 KISMİ DİSOSİYATİF KİMLİK BOZUKLUĞU** **Partial dissociative identity disorder**
ICD-10 F44.8	Disosiyatif [konversiyon] bozuklukları, diğer
DSM-5-TR F44.89	Başka Türlü Belirlenmiş Dissosiyatif Bozukluk

1. Tanım ve nozoloji

Kısmi Disosiyatif Kimlik Bozukluğu (ICD-11: 6B65 Partial Dissociative Identity Disorder) — DKB'ye (6B64) benzer, ancak non-dominant kimliklerin tutarlı bir şekilde hastanın davranışını veya bilinç fonksiyonunu tamamen ele geçirmemesi ile farklılaşır. Bunun yerine non-dominant kimlikler müdahale eder, ancak "executive control"u tamamen ele geçirmez.

ICD-11'de ilk kez resmi tanı kategorisi olarak eklenmiştir; DSM-5-TR'de ayrıca yoktur (DSM-5-TR'de Other Specified Dissociative Disorder içinde değerlendirilebilir).

2. Tarihçe

- ICD-11 (2019) — DKB'nin spektrumu olarak tanınması, parsiyel form resmi kategori.
- Klinik pratikte "DDNOS" veya "DKB-NOS" olarak bilinen durumlar için yeni tanısal çerçeve.

3. Epidemiyoloji

- Yaygınlık kesin veri sınırlıdır — DKB'den sık olduğu varsayılır.
- Travma temelinde gelişir.

- Komorbidite DKB benzeri.

4. Etiyoloji ve patogenez

DKB ile aynı — çocukluk çağı ağır travması, organize olmayan bağlanma, nörobiyolojik disosiyatif süreçler.

5. Klinik özellikler

- İki veya daha fazla farklı kimlik durumu.
- Baskın olmayan kimlikler müdahale eder — iç sesler, düşünceler, duygular, hareketler — ancak hastanın davranışını ve bilincini tamamen ele geçirmez.
- Baskın kimlik günlük aktiviteyi yönetir.
- DKB ile karşılaştırıldığında daha az amnezi.
- Distress ve fonksiyonel bozulma.

6. Tanı

6.1 Birleşik tanı ölçütleri (ICD-11)

A. İki veya daha fazla farklı kimlik durumu.

B. Non-dominant kimlikler dominant kimliğin bilinç ve davranış kontrolünü tutarlı bir şekilde tamamen ele geçirmez; ancak girici (intrüzyon) bir deneyim olarak mevcuttur.

C. Önemli sıkıntı veya işlevsel bozulma.

D. Madde veya tıbbi durum dışlaması.

6.2 Kaynaklar arasındaki farklar

- ICD-11 — DKB'den “tam ele geçirmeme” ile farklılaşır.
- DSM-5-TR — Other Specified Dissociative Disorder (F44.89) içinde değerlendirilebilir.

6.3 Tanı algoritması

DKB ile aynı (bkz. 6B64 §6.3).

6.4 Ayırıcı tanı

Durum	Ayırt edici
DKB (6B64)	Non-dominant kimlikler dominant kontrolü ardışık olarak ele geçirir + amnezi.
TSSB / KTSSB (6B40/6B41)	Travmatik intrusifler; ayrı kimlikler yok.
BPD (6D10.x)	Duygusal değişkenlik dominant.
Şizofreni (6A20)	Psikotik semptomlar.
Possession trance (kültürel)	Kültürel ve dini bağlam.

7. Muayene ve değerlendirme

DKB ile aynı (SCID-D-R, DES, MID).

8. Tedavi

DKB için fazalı yaklaşım uyarlanır (ISSTD 2011). Tedavi prensipleri, aşamaları ve spesifik metodolojiler için bkz. 6B64 “Tedavi” bölümü (dahil “Tedavi metodolojileri”).

9. Prognoz

Phase-oriented terapi ile işlevsel iyileşme; DKB'ye benzer.

10. Mit ve yanlış inançlar

Mit 1: “Parsiyel DKB'in 'hafif formu'dur”

Kanıt: ayrı bir tanısal kategoridir; işlevsel bozulma ve travma yükü DKB ile karşılaştırılabilir olabilir.

Mit 2: “İç sesler her zaman psikotik semptomdur”

Kanıt: disosiyatif sesler psikotik semptomlardan ayrılır — iç diyalog, “ben” hissi, antipsikotiğe zayıf yanıt; SCID-D-R ayırıcı tanı için.

Mit 3: “Antipsikotik parsiyel DKB'de ‘sesleri’ iyileştirir”

Kanıt: disosiyatif sesler antipsikotiğe yanıt vermez; psikoterapi birinci sıra.

Mit 4: "Hasta 'rol yapıyor'"

Kanıt: Faktisiyöz bozukluktan (6D50) farklı — kazanç motivasyonu yok; klinik deneyim hasta için distresslidir.

11. Kaynaklar

1. WHO. ICD-11. 6B65 Partial dissociative identity disorder. 2024.
2. APA. DSM-5-TR. 2022.
3. ISSTD. Guidelines for Treating Dissociative Identity Disorder in Adults, Third Revision. J Trauma Dissociation 2011;12(2):115–187.
4. Reinders A.A.T.S. et al. J Nerv Ment Dis 2016;204(6):445–457.

ICD-11 **6B66**	**6B66** **DEPERSONALİZASYON-DEREALİZASYON BOZUKLUĞU** **Depersonalization-derealization disorder**
ICD-10 F48.1	Depersonalizasyon-derealizasyon sendromu
DSM-5-TR F48.1	Kendine Yabancılaşma (Depersonalizasyon)/Gerçekdışılık (Derealizasyon) Çözülmesi

1. Tanım ve nozoloji

Depersonalizasyon-Derealizasyon Bozukluğu (ICD-11: 6B66; DSM-5-TR: F48.1) — sürekli veya tekrarlayan depersonalizasyon (kendinden dışarıda olma, bedenden ve düşüncelerden kopma hissi) ve/veya derealizasyon (çevrenin gerçek dışı, "puslu film gibi" görünmesi) ile karakterize disosiyatif bozukluktur. Gerçeklik testi korunur (hasta deneyimin gerçek dışı olduğunu bilir).

2. Tarihçe

- Krishaber M. (1873) — ilk tanım.
- Dugas L. (1898) — "dépersonnalisation" terimi.
- DSM-III (1980) — ayrı tanı.

- DSM-5 (2013) — depersonalizasyon ve derealizasyon birlikte kategori olarak.

3. Epidemiyoloji

- Yaşam boyu yaygınlık: klinik formda %1–2; subklinik deneyimler nüfusun %50'sinde en az bir kez.
- Cinsiyet: yaklaşık eşit.
- Başlangıç: ergenlik ve erken yetişkinlik (ortalama 16 yaş).
- Komorbidite: MDD, panik, YAB, TSSB, BPD.

4. Etiyoloji ve patogenez

- Travma ve stres tetikleyici (özellikle kannabis, halüsinojen kullanımı).
- Nörobiyolojik — prefrontal-limbik düzenlemenin bozulması; duyusal işlem anomalileri (Simeon D. derlemeleri).
- Komorbid anksiyete ve panik atak yoğunluğu yüksek.

5. Klinik özellikler

- Depersonalizasyon: Kendine dışarıdan bakma hissi, robot gibi olma, duygusal uyuşma, "bedenim bana ait değil" hissi.
- Derealizasyon: çevrenin "puslu", "puslu film gibi" veya "yapay" görünmesi; mesafe algısı değişikliği.
- Gerçeklik testi korunur — hasta deneyimin gerçek dışı olduğunu bilir.
- Önemli sıkıntı ve işlevsel bozulma.
- Tipik gidiş — sürekli veya tekrarlayan epizodlar.

6. Tanı

6.1 Birleşik tanı ölçütleri

A. Sürekli veya tekrarlayan depersonalizasyon ve/veya derealizasyon deneyimleri.

B. Gerçeklik testi korunur.

C. Önemli sıkıntı veya işlevsel bozulma.

D. Madde (kannabis, halüsinojen) veya tıbbi durum (nöbet, beyin hasarı) dışlaması.

E. Başka bir ruhsal bozuklukla (panik atak sırasında kısa süreli; TSSB zemininde; şizofreni) daha iyi açıklanmaz.

6.2 Kaynaklar arasındaki farklar

- DSM-5-TR / ICD-11 — aynı kriterler.

6.3 Tanı algoritması

1. Klinik görüşme.
2. CDS (Cambridge Depersonalisation Scale, Sierra M., Berrios G.E.) — 29 madde.
3. Tıbbi ve nörolojik muayene (nöbet, beyin hasarı dışlaması).
4. Toksikoloji tarama.
5. Komorbidite.

6.4 Ayırıcı tanı

Durum	**Ayırt edici**
Panik atak	Atak bağlamında kısa süreli.
TSSB (6B40)	Travma zemininde; intrusifler.
DKB (6B64)	Farklı kimliklendirmeler.
Tutma (epileptik)	EEG; postiktal durum.
Şizofreni	Gerçeklik testi bozulmuştur.
Madde indüksiyonlu (kannabis, LSD)	Toksikoloji.

7. Muayene ve değerlendirme

- CDS altın standart.
- EEG tutma istisnası varsa.
- Toksikoloji.

8. Tedavi

1. BDT — depersonalizasyon için uyarlanmış; bilişsel yeniden yapılandırma + maruz bırakma. Hunter E.C. ve ark. Behav Res Ther 2005.
2. SSRI — komorbid depresyon ve anksiyetede etkililik; bozukluğun kendisi için kanıt temeli sınırlı.
3. Lamotrijin adjunkt — bazı çalışmalarda etkili.
4. Travma zemininde — travma-odaklı yaklaşım.
5. Kannabis ve halüsinojen kullanımından kaçınma kritik.

8.1 Tedavi metodolojileri

1. Depersonalizasyon için BDT — Hunter (Hunter E.C.), Sierra (Sierra M.) — Bilişsel yeniden yapılandırma, maruz bırakma, grounding teknikleri.
2. Cambridge Depersonalizasyon Ölçeği (CDS — Cambridge Depersonalisation Scale) — 29 madde.
3. Topraklanma (grounding) teknikleri — 5-4-3-2-1 (5 görünen nesne, 4 ses vb.); duyusal dikkat.

8.2 Kaynaklar arasındaki farklar

- Sierra M. derlemeleri — BDT ve SSRI adjunkt.
- Spesifik FDA onaylı ilaç yok.

9. Prognoz

- Kronik seyir, ancak BDT ile anlamlı iyileşme.

10. Mit ve yanlış inançlar

Mit 1: "Depersonalizasyon psikoz belirtisidir"

Kanıt: reality testing korunur; psikotik bozukluktan farklıdır; antipsikotik etkisizdir.

Mit 2: "Depersonalizasyon geçicidir, tedavi gerektirmez"

Kanıt: klinik formda kronik seyir ve işlevsel bozulma; müdahale önerilir.

Mit 3: "Kannabis depersonalizasyonu iyileştirir"

Kanıt: Kannabis tetikleyici ve sürdürücü faktördür; uzak durma kritiktir.

Mit 4: "Benzodiazepin ana tedavidir"

Kanıt: benzodiazepin kısa süreli rahatlama sağlar, ancak bağımlılık ve depersonalizasyonu güçlendirme riski.

Mit 5: "Yalnızca antidepresan etkilidir"

Kanıt: BDT birinci basamak; SSRI komorbid semptomlarda.

11. Kaynaklar

1. WHO. ICD-11. 6B66 Depersonalization-derealization disorder. 2024.
2. APA. DSM-5-TR. 2022.

3. Sierra M. Depersonalization: A New Look at a Neglected Syndrome. Cambridge Univ Press; 2009.
4. Hunter E.C.M. et al. Cognitive-behaviour therapy for depersonalisation disorder: an open study. Behav Res Ther 2005;43(9):1121–1130.
5. Simeon D. Depersonalisation disorder: a contemporary overview. CNS Drugs 2004;18(6):343–354.
6. Sierra M., Berrios G.E. The Cambridge Depersonalisation Scale: a new instrument for the measurement of depersonalisation. Psychiatry Res 2000;93(2):153–164.

	6B60 DİSOSİYATİF NÖROLOJİK BELİRTİ BOZUKLUĞU
ICD-11 **6B60**	**Dissociative neurological symptom disorder**
ICD-10 F44.4–F44.7	Dissosiyatif motor ve duyusal bozukluklar
DSM-5-TR F44.4–F44.7	Dönüştürme (Konversiyon) Bozukluğu

1. Tanım ve nozoloji

Disosiyatif Nörolojik Belirti Bozukluğu (ICD-11: 6B60 Dissociative Neurological Symptom Disorder; DSM-5-TR: F44.4–F44.7 Fonksiyonel Nörolojik Belirti Bozukluğu / Konversiyon Bozukluğu) — istemli kontrol altında olan motor, duyusal veya bilişsel işlevlerin bozulması, nörolojik veya tıbbi bir hastalıkla tam olarak açıklanamaz. Önceden “konversiyon bozukluğu” veya “histeri” olarak adlandırılırdı.

2. Tarihçe

- Charcot J.M. (XIX. yüzyıl) — Salpêtrière'de “histeri” çalışmaları.
- Freud S. — psikanalitik “konversiyon” modeli.
- DSM-III (1980) — “Conversion Disorder” somatoform bozukluklar içinde.
- DSM-5 (2013) — “Functional Neurological Symptom Disorder” — nörolojik ve psikiyatrik birlikte değerlendirme vurgusu.
- ICD-11 (2019) — disosiyatif bozukluklar kategorisine taşındı.

3. Epidemiyoloji

- Birinci basamakta ve nöroloji kliniklerinde — %5–10 (Carson A.J. ve ark. derlemeleri).
- Cinsiyet: kadınlarda 2–3 kat yüksek.
- Başlangıç: yetişkinlik, ancak çocuk ve yaşlılarda da.
- Komorbidite: MDD, anksiyete, travma öyküsü, somatik hastalıklar.

4. Etiyoloji ve patogenez

- Travmatik veya stres kaynaklı tetikleyici sık görülür, ancak hastaların önemli ve değişken bir bölümünde belirgin tetikleyici saptanmaz (çalışmalar arasında %0–77; Ludwig L. ve ark. Lancet Psychiatry 2018 meta-analizi) — DSM-5 ve ICD-11'in tanı için stresör aramamasının nedeni budur.
- Nörobiyolojik — sensorimotor ve bilişsel tahmin işleminde bozulma; predictive coding hipotezi (Edwards M.J.).
- "Functional" terimi — hastaya "uydurma" demek değil, sinir sisteminin işlevsel bozukluğu.

5. Klinik özellikler

Tipik semptomlar

- Motor: güçsüzlük, felç, istemsiz hareketler (fonksiyonel tremor, distoni), yürüyüş bozukluğu.
- Duyusal: his kaybı (anestezi), görme bozukluğu (functional blindness), işitme bozukluğu.
- Functional (psikogen) non-epileptik tutmalar (PNES): nöbet benzeri epizodlar, EEG'de epileptik aktivite yok.
- Kognitif: "donuk" konsantrasyon, yavaş işleme — "functional cognitive disorder".

Klinik belirtiler (pozitif özellikler)

- Tipik nörolojik patogenezden farklı patern (ör. Hoover belirtisi motor zayıflıkta — fonksiyonel bileşenin pozitif göstergesi).
- Distractibility — semptom dikkat başka yöne çevrildiğinde değişir.
- Entrainability — tremor başka ritme uyum sağlar.

6. Tanı

6.1 Birleşik tanı ölçütleri

A. Bir veya daha fazla motor, duyusal veya bilişsel işlevin bozulması.

B. Klinik bulgular, bozukluğun bilinen nörolojik veya tıbbi bir hastalıkla uyumsuzluğunu kanıtlar (pozitif klinik özellikler).

C. Semptomlar başka bir psikiyatrik veya tıbbi durumla daha iyi açıklanamaz.

D. Önemli sıkıntı veya işlevsel bozulma.

6.2 Kaynaklar arasındaki farklar

- DSM-5-TR — tanı "positive features" temelinde konulur (yok-isnad yöntemi değil); nörolog ve psikiyatrın ortak değerlendirmesi.
- ICD-11 — disosiyatif bozukluklar kategorisinde.

6.3 Tanı algoritması

1. Nörolojik muayene — fonksiyonel positive features (Hoover, entrainability, distractibility).
2. Tipik nörolojik durum dışlaması — MRG, EEG, EMG, lomber ponksiyon (klinik gereğince).
3. PNES durumunda — video-EEG monitorizasyonu altın standarttır.
4. Psikiyatrik değerlendirme — komorbid travma, MDD, anksiyete.
5. Hastaya tanının olumlu açıklaması — "uydurma değil, sinir sisteminde işlevsel bozulma".

6.4 Ayırıcı tanı

Durum	**Ayırt edici**
Gerçek nörolojik hastalık	Klinik ve laboratuvar doğrulaması.
Yapay bozukluk (6D50)	Bilinçli yalan; kazanç motivasyonu
Malingering	Açık kazanç (mahkeme, sigorta).
Somatik Belirti Bozukluğu (6C20)	Çok sayıda somatik şikayet; bedene odaklanma.
Hipokondriyazis (6B23)	Hastalık anksiyetesi dominant.
Epileptik nöbet	Video-EEG.

7. Muayene ve değerlendirme

- Nörolojik muayene (positive features).
- Video-EEG — PNES durumunda.
- MRG, laboratuvar nörolojik hastalık dışlaması.
- Travma ve psikiyatrik değerlendirme.

8. Tedavi

1. Tanının olumlu açıklaması hastaya — sinir sistemi fonksiyonel bozukluğu, uydurma değil; tanının yapılandırılmış açıklaması fonksiyonel iyileşme için kritiktir (Stone J. derlemeleri).
2. Multidisipliner yaklaşım — nörolog + psikiyatrist + fizyoterapist.
3. Fizyoterapi (motor semptomlarda) — kanıtlanmış fayda (Nielsen G. et al. J Neurol Neurosurg Psychiatry 2017 RCT).
4. BDT — bilişsel yeniden yapılandırma; PNES için özel protokoller (LaFrance W.C. JAMA Psychiatry 2014).
5. Travma zemininde — travma-odaklı yaklaşım.
6. Antikonvülzanlar PNES için etkisizdir ve zararlıdır — hastanın tanısının doğru konulması ve antiepileptiğin kesilmesi kritiktir.
7. Komorbid depresyon/anksiyete için SSRI.

8.1 Tedavi metodolojileri

1. Pozitif klinik tanı sunumu — Stone (Stone J.) — Tanı "rule-out" değil, "rule-in"; hastaya pozitif klinik belirtiler açıklanır (örn. Hoover sign gösterilir).
2. Fizyoterapi FND için — Spesifik manuel eğitim, hareket öğretimi; Nielsen G. ve ark. J Neurol Neurosurg Psychiatry 2017.
3. PNES için BDT — LaFrance (LaFrance W.C.) — Manuelize edilmiş 12 seans; tutma günlüğü, bilişsel yeniden yapılandırma; LaFrance W.C. ve ark. JAMA Psychiatry 2014.
4. Video-EEG — PNES tanısı altın standart.

8.2 Kaynaklar arasındaki farklar

- FND-spesifik uluslararası konsensus (Stone J., Carson A., LaFrance W.C.).
- NICE — fonksiyonel semptomlar için multidisipliner yaklaşım.

9. Prognoz

- Erken doğru tanı ve müdahale ile iyileşme.
- Geç tanı ve polifarmasi — kronikleşme.

10. Mit ve yanlış inançlar

Mit 1: “Hasta simülasyon yapıyor / 'uydurma'dır”

Kanıt: Fonksiyonel bozukluk gerçek klinik durumdur — sinir sisteminin fonksiyonel bozulması; pozitif klinik belirtiler kanıtlar. Faktisiyöz bozukluktan ve simülasyondan farklıdır.

Mit 2: “PNES için antikonvülzan gereklidir”

Kanıt: antikonvülzanlar PNES'te etkisizdir, polifarmasi yan etkilerine neden olur; doğru tanı ve antiepileptiğin kesilmesi kritiktir.

Mit 3: “Fonksiyonel bozukluk psikolojik 'zayıflık'tır, fiziksel değil”

Kanıt: Fonksiyonel bozukluk sinir sisteminin biyolojik sürecidir; psikiyatrik ve nörolojik birlikte değerlendirme gerektirir.

Mit 4: “Hastayı psikiyatra ‘atmak’ yeterlidir”

Kanıt: nörolog ve psikiyatrist birlikte çalışmalıdır; hastanın “atılması” terapötik ittifakı bozar ve iyileşme şansını azaltır.

Mit 5: “Fonksiyonel semptomlar tedavi edilmez”

Kanıt: Fizyoterapi, BDT, multidisipliner yaklaşım önemli etki gösterir.

11. Kaynaklar

1. WHO. ICD-11. 6B60 Dissociative neurological symptom disorder. 2024.
2. APA. DSM-5-TR. 2022.
3. Stone J., Carson A. Functional neurological disorders: the neurological assessment as treatment. Pract Neurol 2016;16(1):7–17.
4. Nielsen G. et al. Physiotherapy for functional motor disorders: a consensus recommendation. J Neurol Neurosurg Psychiatry 2015;86(10):1113–1119.
5. LaFrance W.C. et al. Multicenter pilot treatment trial for psychogenic nonepileptic seizures: a randomized clinical trial. JAMA Psychiatry 2014;71(9):997–1005.

6. Edwards M.J., Adams R.A., Brown H., Pareés I., Friston K.J. A Bayesian account of “hysteria”. Brain 2012;135(Pt 11):3495–3512.

ICD-11 **6B61**	**6B61 DİSOSİYATİF AMNEZİ** **Dissociative amnesia**
ICD-10 F44.0	Disosiyatif amnezi
DSM-5-TR F44.0	Unutkanlık Çözülmesi (Dissosiyatif Amnezi)

1. Tanım ve nozoloji

Disosiyatif Amnezi (ICD-11: 6B61; DSM-5-TR: F44.0) — önemli otobiyografik bilgiyi (genellikle travmatik veya stresli) hatırlayamama, genel unutkanlıkla açıklanamayacak düzeyde. Tıbbi veya nörolojik neden yoktur.

Alt tipler: lokalize (belirli dönem), seçici (dönemin parçası), generalize (tüm yaşam öyküsü), sistematik (belirli kategori), sürekli.

“Disosiyatif füg” — DSM-5-TR'de disosiyatif amnezinin niteleyicisi olarak (DSM-IV'te ayrı tanıydı); hasta beklenmedik şekilde seyahat eder, yeni kimlik oluşturur.

2. Tarihçe

- Janet P. — dissosiyasyon konseptinin yaratıcısı.
- DSM-IV — disosiyatif füg ayrı tanı.
- DSM-5 (2013) — füg kalifikatör olarak entegre edilmiştir.
- “False Memory” tartışması (1990'lar) — terapötik indüksiyonlu “geri kazanılmış anı” tartışması.

3. Epidemiyoloji

- Yaşam boyu yaygınlık: %1–2; toplumsal felaketler (savaş, afet) sonrası daha yüksek.
- Cinsiyet: kadınlarda nispeten yüksek.
- Komorbidite: TSSB, K-TSSB, DKB, Sınırda KB, MDD.

4. Etiyoloji ve patogenez

- Travma — ağır psikolojik veya fiziksel travmaya yanıt; "savunma mekanizması" olarak hipotez edilir.
- Nörobiyolojik — hipokampus ve prefrontal bilişsel işlem bozukluğu.

5. Klinik özellikler

- Travmatik veya stresli olayın hatırlanmaması.
- Lokalize (ör. savaş dönemi), seçici, generalize.
- Disosiyatif füg — beklenmedik seyahat, yeni kimlik, genellikle gün-hafta sürer.
- Örtük bellek (beceriler) kalır; açık bellek seçicidir.

6. Tanı

6.1 Birleşik tanı ölçütleri

A. Önemli otobiyografik bilginin (genellikle travmatik) unutulması, normal unutkanlıkla açıklanamaz.

B. Önemli sıkıntı veya işlevsel bozulma.

C. Madde, tıbbi/nörolojik durum (TBI, ensefalit, demans) dışlaması.

D. DKB, TSSB, KTSSB, somatik semptom veya başka bir psikiyatrik bozuklukla daha iyi açıklanmaz.

Kalifikatör: with dissociative fugue.

6.2 Kaynaklar arasındaki farklar

- DSM-5-TR / ICD-11 — aynı; füg kalifikatör.

6.3 Tanı algoritması

1. Klinik görüşme + travma geçmişi.
2. Tıbbi ve nörolojik muayene — TBH, demans, ensefalit, nöbet dışlaması.
3. MRG, EEG klinik şüphede.
4. SCID-D-R.
5. Toksikoloji.

6.4 Ayırıcı tanı

Durum	Ayırt edici
Travmatik beyin hasarı (TBH)	Anamnez, MRT.
Transient global amnesia (TGA)	Akut, 24 saatten az; vasküler etiyoloji.
Demans	Sürekli bilişsel düşüş.
Tutma (post-iktal)	EEG.
Madde indüksiyonlu amnezi (alkol blackout)	Anamnez.
Yapay bozukluk / temaruz	Kazanç motivasyonu.
DKB (6B64)	Çok sayıda kimlik.

7. Muayene ve değerlendirme

- SCID-D-R.
- MRT, EEG.
- Nöropsikolojik test (bellek profili).

8. Tedavi

1. Güvenli ortam ve destekleyici psikoterapi.
2. Travma-odaklı psikoterapi — fazalı yaklaşım.
3. Füg epizodunda — hastanın aile ve toplumla yeniden birleştirilmesi.
4. Farmakoterapi komorbid semptomlar için; “amobarbital görüşmesi” veya hipnoz tarihsel olarak kullanılırdı — indüklenmiş false memory riski nedeniyle dikkatli.
5. Uzun süreli psikoterapi — travma işleme.

8.1 Tedavi metodolojileri

1. Travma-odaklı fazalı psikoterapi — Stabilizasyon → işleme → yeniden bütünleştirme.
2. Disosiyatif Bozukluklar için Yapılandırılmış Klinik Görüşme (SCID-D-R) — Tanıda altın standart.
3. Hipnoz — dikkatli kullanım — False memory indüksiyonu riski; yalnızca eğitimli klinisyen tarafından.

8.2 Kaynaklar arasındaki farklar

- ISSTD — disosiyatif bozukluklar genel rehberliği.
- Spesifik FDA onaylı farmakoterapi yok.

9. Prognoz

- Akut formda çoğu spontan remisyon;
- Kronik formda uzun süreli müdahale.

10. Mit ve yanlış inançlar

Mit 1: "Hipnoz 'geri getirilmiş anı' için güvenilir bir araçtır"

Kanıt: hipnoz altında anılar false memory ile dolu olabilir — indüklenmiş veya çarpıtılmış; adli bağlamda özellikle dikkatli olunmalıdır (Loftus E.F. araştırmaları).

Mit 2: "Disosiyatif amnezi uydurma veya filmlerden gelen 'drama'dır"

Kanıt: klinik durum belgelenmiştir; nörobiyolojik temelleri araştırılmaktadır.

Mit 3: "Hasta 'hatırlamaya zorlanmalıdır'"

Kanıt: baskı travma veya sıkıntı yaratabilir; destekleyici yaklaşım önerilir.

Mit 4: "Amobarbital görüşmesi etkilidir"

Kanıt: tarihsel kullanımı vardır, ancak modern pratikte yanlış anı ve yan etki riski nedeniyle önerilmez.

Mit 5: "Tüm travmatik anılar 'gerçek'tir"

Kanıt: bazı "geri kazanılmış anılar" terapötik indüksiyon sonucu olabilir; dikkatli klinik yaklaşım ve kaynak doğrulaması önemlidir.

11. Kaynaklar

1. WHO. ICD-11. 6B61 Dissociative amnesia. 2024.
2. APA. DSM-5-TR. 2022.
3. ISSTD. Guidelines for Treating DID in Adults, 3rd Revision. J Trauma Dissociation 2011;12(2):115–187.
4. Loftus E.F. The reality of repressed memories. Am Psychol 1993;48(5):518–537.
5. Staniloiu A., Markowitsch H.J. Dissociative amnesia. Lancet Psychiatry 2014;1(3):226–241.

6B80–6B8Z YİYECEK ALIM BOZUKLUKLARI

Feeding or eating disorders

ICD-11 **6B80**	**6B80 ANOREKSİYA NERVOZA** **Anorexia Nervosa**
ICD-10 F50.0	Anoreksia nervosa
DSM-5-TR F50.0x	Anoreksiya Nervoza

1. Tanım ve nozoloji

Anoreksiya Nervoza (ICD-11: 6B80; DSM-5-TR: F50.0x) — gıda alımının kısıtlanması sonucu belirgin düşük vücut ağırlığı, kilo almaktan yoğun korku ve beden imajının bozulması ile karakterize ağır bir yeme bozukluğudur. Mortalite en yüksek psikiyatrik bozukluklar arasındadır.

2. Tarihçe

- Morton R. (1689) — ilk klinik tanım.
- Lasègue C. (1873) ve Gull W. (1874) — “anorexia hysterica” ve “sinir anoreksiyası”.
- DSM-III (1980) — resmi tanı.
- DSM-5 (2013) — amenore kriteri kaldırılmıştır (erkeklerde ve premenarşal dönemde tanı mümkün).

3. Epidemiyoloji

- Yaşam boyu yaygınlık: Kadınlarda %0,9–4, erkeklerde %0,3 (Smink F.R. derlemeleri).
- Cinsiyet: kadınlarda 10:1; ancak erkek hastalarda tanı sıklıkla atlanır.
- Başlangıç: ergenlik (14–18 yaş); ikinci pik orta yaşta.

- Mortalite: ömür boyu %5–6; yarısı tıbbi (kaşeksi, kalp), yarısı intihar (Arcelus J. et al. Arch Gen Psychiatry 2011 meta-analiz).
- Komorbidite: MDD, OKB, anksiyete, BPD.

4. Etiyoloji ve patogenez

- Kalıtım %50–60 (Bulik C.M. derlemeleri).
- Nörobiyolojik — bilişsel esneklik azalması, ödül devresi disregülasyonu, açlığa atipik yanıt.
- Sosyo-kültürel faktörler — incelik ideali; sosyal medya etkisi.
- Kişilik — mükemmeliyetçilik, kaygı, aile öyküsünde yeme bozukluğu.

5. Klinik özellikler

- Gıda kısıtlaması — kalori, gıda türleri.
- Vücut ağırlığının önemli derecede düşük olması (BMI < 18,5 yetişkinlerde; çocuklarda BMI persentili).
- Kilo alımına karşı yoğun korku veya bunu önlemeye yönelik sürekli davranış.
- Beden imajının bozulması — "kendimi şişman hissediyorum" zayıfken dahi.
- Alt tipler:
    - Restriktif tip — yalnızca gıda kısıtlaması.
    - Tıkınırcasına yeme/arınma tipi — kusma, laksatif, egzersiz.
- Tıbbi komplikasyonlar — bradikardi, hipotansiyon, hipotermi, elektrolit dengesizliği, osteoporoz, amenore, lanugo, kardiyak aritmi, ölüm.

6. Tanı

6.1 Birleşik tanı ölçütleri

A. Yiyecek alımının kısıtlanması sonucu önemli düşük kilo (BMI < 18,5 yetişkinlerde; çocuklarda yaşa uygun normdan düşük).

B. Kilo alımına karşı yoğun korku veya buna yönelik sürekli davranış, kilo düşük olsa bile.

C. Beden imajının bozulması veya mevcut kilonun ciddiyetini tanımama.

6.2 Kaynaklar arasındaki farklar

- DSM-5-TR — şiddeti BMI temelli (hafif BMI ≥ 17, orta 16–16,99, şiddetli 15–15,99, ekstrem < 15).
- ICD-11 — farklı bir şiddet ölçeği: 6B80.0 belirgin düşük beden ağırlığı (erişkinde BMI 18,5–14,0; çocukta yaşa göre BMI 5.–0,3. persentil), 6B80.1 tehlikeli düzeyde düşük beden ağırlığı (BMI < 14,0), 6B80.2 normal ağırlıkla iyileşme dönemi — tanı tam ve kalıcı iyileşmeye kadar korunur. ICD-11'de ayrı bir "atipik anoreksiya nervoza" kategorisi yoktur (terim DSM-5-TR'nin OSFED'ine aittir): normal BMI'li tablo 6B80.2'dir, ölçütler karşılanmıyorsa 6B8Y diğer belirlenmiş beslenme veya yeme bozuklukları.
- NICE NG69 (Yeme bozuklukları, 2017, güncelleme) — tanı ve tedavi algoritmaları.

6.3 Tanı algoritması

1. Klinik görüşme.
2. EDE-Q (Eating Disorder Examination Questionnaire) veya EDE — altın standart.
3. Tıbbi muayene — BMI, vital bulgular, elektrolitler, EKG, kemik dansitometrisi.
4. Laboratuvar: tam kan, elektrolitler (özellikle K, P, Mg), karaciğer, böbrek, glukoz, tiroid.
5. Komorbidite (MDD, OKB, anksiyete).
6. Refeeding sendromu riski değerlendirmesi (özellikle BMI < 13 ya da minimal yiyecek alımı uzun süre).

6.4 Ayırıcı tanı

Durum	**Ayırt edici**
Bulimiya Nervoza (6B81)	Normal kilo; tıkınırcasına yeme + kompansatuvar davranış.
ARFID (6B83)	Kilo kaybı, ancak beden imajı bozukluğu yok.
Tıbbi hastalık (kanser, hipertiroidi, IBS, Crohn)	Klinik doğrulama.
MDD (gıda alımında azalma)	Beden imajı bozulması yoktur.
Şizofreni (yemek sanrısı)	Psikotik düşünce temel.

7. Muayene ve değerlendirme

- EDE-Q, EDE.
- Vital bulgular, BMI, kilo geçmişi.
- Laboratuvar: tam kan, elektrolitler, karaciğer, böbrek, tiroid, FSH/LH, prolaktin, vitamin D, B12, demir.
- EKG — bradikardi, QTc.
- DEXA — osteoporoz.
- C-SSRS intihar riski.

8. Tedavi

8.1 Genel Prensipler (NICE NG69 · APA 2023)

1. Tıbbi stabilizasyon kritik: elektrolitler, refeeding sendromu profilaksisi (fosfor, magnezyum, tiamin), kardiyak monitorizasyon.
2. Hospitalizasyon endikasyonu: BMI < 13, bradikardi < 40, hipokalemi, ortostatik değişiklikler, intihar riski, ayakta tedavide başarısızlık.
3. Psikoterapi birinci sıra:
    - FBT — Family-Based Treatment (Maudsley Model, Lock J., Le Grange D.) — çocuk ve ergenlerde altın standart; 20 seans 3 fazda.
    - CBT-E — Enhanced Cognitive Behavioral Therapy (Fairburn C.G.) — yetişkinlerde birinci basamak; 40 seans 40 hafta.
    - MANTRA, SSCM yetişkin alternatifleri.
4. Farmakoterapi AN için spesifik etkili ilaç yoktur — antidepresan ve antipsikotik komorbidite için; olanzapin düşük dozda (2,5–10 mg) bazı hastalarda kilo alımına yardımcı olabilir (Attia E. et al. Am J Psychiatry 2019), ancak temel müdahale değildir.
5. Nutrisyon — grupla veya bireysel nütrisyonist; refeeding sendromu profilaksisi — başlangıç enerjisi düşük başlanır, fosfor monitorizasyonu.
6. Tedavi süresi uzun (1–2 yıl veya daha fazla).

8.2 Tedavi metodolojileri

1. Aile Temelli Tedavi / Maudsley Modeli (FBT — Family-Based Treatment) — Lock (Lock J.), Le Grange (Le Grange D.) — 3 aşamalı 20 seans: (1) kilonun geri kazanılması — aile besin alımını kontrol eder; (2) yeme kontrolünün ergene kademeli olarak geri verilmesi; (3) ergen-spesifik konular. Kanıt: Lock J. et al. Arch Gen Psychiatry 2010 RKÇ.

2. Güçlendirilmiş Bilişsel-Davranışçı Terapi (CBT-E — Enhanced Cognitive Behavioral Therapy) — Fairburn (Fairburn C.G.) — Transdiyagnostik (AN, BN, BED birlikte) yaklaşım; 40 seans 40 hafta; merkezde beden ve kilo hakkında aşırı değer. cbte.co.
3. Maudsley Yetişkinlerde Sinir Anoreksiyası Tedavisi (MANTRA — Maudsley Anorexia Nervosa Treatment for Adults) — Schmidt (Schmidt U.) — Yetişkinler için manualize edilmiş; sosyal-mükemmeliyetçi özelliklere odak.
4. Uzman Destekleyici Klinik Yönetim (SSCM — Specialist Supportive Clinical Management) — Klinik denetim ve psikoeğitim temelli.
5. Yeme Bozukluğu İnceleme Soru Formu (EDE-Q — Eating Disorder Examination Questionnaire) — 28 madde; başlangıç göstergeleri ve izlem.
6. Refeeding Protokolu (Maudsley, AED) — Riske göre başlangıç: yüksek riskte 10 kkal/kg/gün, aşırı riskte (BKİ < 14 veya 15 günden uzun süredir neredeyse hiç besin alımı yok) 5 kkal/kg/gün; artış kademeli. Fosfor, magnezyum, potasyum takviyeleri; tiamin; günlük elektrolit izlemi. Daha yüksek hız yalnızca uzmanlaşmış serviste, yakın izlem altında.

8.3 Kaynaklar arasındaki farklar

- NICE NG69 (2017) — çocuk ve ergenlerde FBT; yetişkinlerde CBT-E.
- APA 2023 Practice Guideline for the Treatment of Patients with Eating Disorders, 4th ed.
- AED (Academy for Eating Disorders) — refeeding sendromu medical care standartları.
- NICE — antidepresan rutin olarak önerilmez AN için.

9. Prognoz

- %50 remisyon, %30 kalıntı semptomlar, %20 kronik gidiş.
- Mortalite yüksek (%5–6).
- Erken müdahale (özellikle ergenlikte FBT) prognozu anlamlı şekilde iyileştirir.

10. Mit ve yanlış inançlar

Mit 1: “Anoreksiya ‘imaj’ bozukluğudur, ciddi tıbbi durum değildir”

Kanıt: Arcelus 2011 meta-analiz — AN yaşam boyu mortalite %5–6; psikiyatrik bozukluklar arasında en yüksek

Mit 2: “Hasta iradi olarak yiyebilir — sadece talep etmek gerekir”

Kanıt: AN nörobiyolojik ve psikolojik kompleks bir bozukluktur; “iradeli olarak yememe” açıklaması yanlış ve zararlıdır.

Mit 3: “Antidepresan AN'da temel tedavidir”

Kanıt: NICE NG69 — AN için antidepresan rutin olarak önerilmez; komorbid MDD için kullanılabilir (kilo alımından sonra daha etkili).

Mit 4: “AN yalnızca ergen kızlarda olur”

Kanıt: AN erkeklerde de mevcuttur (~%10); orta yaşta da gelişebilir; az tespit edilme yaygındır.

Mit 5: “Kilo geri kazanımından sonra sorun çözülür”

Kanıt: Kilo geri kazanımı önemli bir adımdır, ancak bilişsel-davranışsal bileşen müdahalesiz nüks yüksektir; psikoterapi kritiktir.

Mit 6: “Refeeding hızlı olmalıdır”

Kanıt: hızlı refeeding sendromuna (hipofosfatemi, kardiyak yetmezlik) yol açabilir; kademeli yaklaşım ve elektrolit izlemi kritik.

Mit 7: “Hasta mükemmeliyetçi ve yüksek performanslıdır — bu özellik korunmalıdır”

Kanıt: mükemmeliyetçilik AN'ın sürdürücü faktörlerindendir; terapi bu özelliğe yönelir.

11. Kaynaklar

1. WHO. ICD-11. 6B80 Anoreksiya nervoza. 2024.
2. APA. DSM-5-TR. 2022.
3. NICE NG69. Eating disorders: recognition and treatment. 2017, 2020 update.
4. APA. Practice Guideline for the Treatment of Patients With Eating Disorders, 4th ed. 2023.
5. Lock J., Le Grange D., Agras W.S. et al. Randomized clinical trial comparing family-based treatment with adolescent-focused individual therapy for adolescents with anorexia nervosa. Arch Gen Psychiatry 2010;67(10):1025–1032.
6. Fairburn C.G. Cognitive Behavior Therapy and Eating Disorders. Guilford Press; 2008.

7. Arcelus J., Mitchell A.J., Wales J., Nielsen S. Mortality rates in patients with anorexia nervosa and other eating disorders: a meta-analysis. Arch Gen Psychiatry 2011;68(7):724–731.
8. Attia E. et al. Olanzapine versus placebo in adult outpatients with anorexia nervosa. Am J Psychiatry 2019;176(6):449–456.
9. Smink F.R., van Hoeken D., Hoek H.W. Epidemiology of eating disorders. Curr Psychiatry Rep 2012;14(4):406–414.
10. Lock J., Le Grange D. Treatment Manual for Anorexia Nervosa: A Family-Based Approach. 2nd ed. New York: Guilford Press, 2013.
11. Schmidt U., Treasure J. Anorexia nervosa: valued and visible. A cognitive-interpersonal maintenance model. Br J Clin Psychol 2006;45(3):343–366.
12. Bulik C.M., Sullivan P.F., Tozzi F. et al. Prevalence, heritability, and prospective risk factors for anorexia nervosa. Arch Gen Psychiatry 2006;63(3):305–312.

ICD-11 **6B81**	**6B81 BULİMİYA NERVOZA** **Bulimia Nervosa**
ICD-10 F50.2	Bulimia nervosa
DSM-5-TR F50.2	Bulimiya Nervoza

1. Tanım ve nozoloji

Bulimiya Nervoza (ICD-11: 6B81; DSM-5-TR: F50.2) — tekrarlayan tıkınırcasına yeme epizodları (kısa sürede aşırı miktarda gıda + kontrol kaybı hissi) ve kompansatuvar davranışlar (kusma, laksatif, egzersiz, oruç) ile karakterize yeme bozukluğudur. Anoreksiyadan farklı olarak kilo tipik olarak normal veya fazladır.

2. Tarihçe

- Russell G.F. (1979) — “bulimia nervosa” terimi ve ilk klinik tanım.
- DSM-III (1980) — resmi tanı.
- DSM-5 (2013) — sıklık kriteri haftada 1 defaya indirilmiştir (DSM-IV'te 2 defa).

3. Epidemiyoloji

- Yaşam boyu yaygınlık: Kadınlarda %1,5–3, erkeklerde %0,5.
- Başlangıç: ergenlik ve erken yetişkinlik.
- Komorbidite: MDD ~%70, anksiyete, madde kullanımı, BPD, anoreksiya öyküsü.
- İntihar riski yüksek.

4. Etiyoloji ve patogenez

- Kalıtım %50–60.
- Nörobiyolojik — serotonerjik disregülasyon, dopamin ödül sistemi.
- Sosyo-kültürel — incelik ideali, diyet geçmişi.
- Kişilik — dürtüsellik, mükemmeliyetçilik, düşük benlik saygısı.

5. Klinik özellikler

- Tıkınırcasına yeme epizodları — kontrol kaybı, gizli.
- Telafi edici davranışlar:
    - Purging — kendi kendine kusma, laksatif, diüretik;
    - Non-purging — oruç, aşırı egzersiz.
- Beden imajı ve kilo meşguliyeti.
- Tıbbi komplikasyonlar: hipokalemi (kusma), Russell belirtisi (parmak kallusları), diş erozyonu, parotis hipertrofisi, özofajit, mide-bağırsak.

6. Tanı

6.1 Birleşik tanı ölçütleri

A. Tekrarlayan tıkınırcasına yeme epizodları — kısa sürede (≤ 2 saat) çok miktarda yiyecek + kontrol kaybı hissi.

B. Kilo alımını önlemek için tekrarlayan uygunsuz telafi edici davranışlar.

C. Sıklık: en az haftada 1 kez — DSM-5-TR ≥ 3 ay, ICD-11 ≥ 1 ay gerektirir

D. Öz-değer, kilo ve vücut şeklinden aşırı derecede bağımlı.

E. Anoreksiya Nervoza epizodu bağlamında ortaya çıkmaz.

6.2 Kaynaklar arasındaki farklar

- DSM-5-TR — şiddet epizod sıklığına göre (hafif 1–3, orta 4–7, ağır 8–13, ekstrem ≥ 14 haftada).
- ICD-11 — ölçütler örtüşür, ancak süre farklıdır: ICD-11 en az 1 ay, DSM-5-TR 3 ay gerektirir; "atipik bulimia nervoza" kalifikatörü.
- NICE NG69 — tanı ve tedavi.

6.3 Tanı algoritması

1. Klinik görüşme.
2. EDE-Q, EDE.
3. Tıbbi: elektrolitler (K, P, Mg, Cl), karaciğer, böbrek, EKG (QTc).
4. Diş muayenesi (erozyon).
5. Komorbidite ve intihar riski.

6.4 Ayırıcı tanı

Durum	**Ayırt edici**
Anoreksiya Nervoza, tıkınırcasına yeme/çıkarma tipi (6B80)	Kilo önemli ölçüde düşük.
BED (6B82)	Telafi edici davranış yok.
Night Eating Syndrome	Gece besin alımı baskındır.
Kleine-Levin sendromu	Hipersomni + hiperfaji.

7. Muayene ve değerlendirme

- EDE-Q.
- Tıbbi: elektrolitler, EKG, diş muayenesi.
- C-SSRS.

8. Tedavi

1. CBT-E birinci basamak (Fairburn) — 20 seans 20 hafta; kanıt: Fairburn C.G. et al. Am J Psychiatry 2009;166(3):311–319.
2. Fluoksetin 60 mg/gün — FDA onayı BN için; tıkınırcasına yeme ve kusmayı azaltır.
3. FBT (Lock J., Le Grange D.) — ergenlerde.
4. İPT alternatif.

5. Tıbbi: elektrolit düzeltmesi, refeeding, diş bakımı.
6. Bupropion kontrendikedir (nöbet riski).

8.1 Tedavi metodolojileri

1. CBT-E (Fairburn) — 20 seans; transdiagnostik; tıkınırcasına-arınma döngüsünün kırılması.
2. FBT BN için — Ergenlerde uyarlanmış.
3. Kişilerarası Terapi (İPT / IPT — Interpersonal Therapy) — Alternatif; yavaş yanıt, ancak uzun süreli etki.

8.2 Kaynaklar arasındaki farklar

- NICE NG69 — CBT-E birinci basamak; ergenlerde FBT.
- APA 2023.

9. Prognoz

- %50–70 remisyon CBT-E ile; uzun süreli izlem önemli.

10. Mit ve yanlış inançlar

Mit 1: “Bulimia 'diyet başarısızlığı'dır”

Kanıt: klinik bozukluktur; kısıtlayıcı diyet tipik tetikleyicidir.

Mit 2: “Kusma etkili bir kilo verme yöntemidir”

Kanıt: kusma kalori alımının yalnız %30–50'sini engeller; tıbbi ciddi komplikasyonlar.

Mit 3: “Bupropion antidepresan olarak BN'da kullanılabilir”

Kanıt: bupropion BN’da kontrendikedir — nöbet riski yüksek.

Mit 4: “BN normal kiloda olduğunda sorun yoktur”

Kanıt: tıbbi komplikasyonlar (elektrolit, kardiyak) ve psikiyatrik yük önemlidir.

Mit 5: “Yalnızca antidepresan yeterlidir”

Kanıt: CBT-E + farmakoterapi kombinasyonu üstün.

11. Kaynaklar

1. WHO. ICD-11. 6B81 Bulimia nervoza. 2024.

2. APA. DSM-5-TR. 2022.
3. NICE NG69. 2017/2020.
4. APA. Practice Guideline for Eating Disorders, 4th ed. 2023.
5. Fairburn C.G. Cognitive Behavior Therapy and Eating Disorders. Guilford Press; 2008.
6. Russell G. Bulimia nervosa: an ominous variant of anorexia nervosa. Psychol Med 1979;9(3):429–448.
7. Lock J., Le Grange D. Treatment Manual for Anorexia Nervosa: A Family-Based Approach. 2nd ed. New York: Guilford Press, 2013.

ICD-11 **6B82**	**6B82 TIKINIRCASINA YEME BOZUKLUĞU (BED)** **Binge eating disorder**
ICD-10 F50.8	Yeme bozuklukları, diğer
DSM-5-TR F50.81	Tıkınırcasına Yeme Bozukluğu

1. Tanım ve nozoloji

Tıkınırcasına Yeme Bozukluğu (BED) (ICD-11: 6B82; DSM-5-TR: F50.81) — tekrarlayan tıkınırcasına yeme epizodları (kısa sürede aşırı miktarda gıda + kontrol kaybı hissi) kompansatuvar davranışlar olmadan. Tipik olarak kilo fazladır ve obezite ile birlikte görülür.

2. Tarihçe

- Stunkard A.J. (1959) — obezite bağlamında tıkınırcasına yeme tanımı.
- DSM-IV (1994) — araştırma kategorisinde.
- DSM-5 (2013) — ayrı resmi tanı.

3. Epidemiyoloji

- Yaşam boyu yaygınlık: %1,9–3,5; yeme bozuklukları arasında en sık.
- Cinsiyet: kadınlarda 1,5–2:1; ancak erkeklerde de anlamlı.
- Obezite ile güçlü ilişki.

- Komorbidite: MDD, anksiyete, BPD, madde kullanımı.

4. Etiyoloji ve patogenez

- Kalıtım %40–50.
- Nörobiyolojik — ödül devresi disregülasyonu; “food addiction” hipotezi.
- Duygusal yeme — stres tetikleyici.
- Restriktif diyet öyküsü.

5. Klinik özellikler

- Tıkınırcasına yeme epizodları — kısa sürede çok miktarda yiyecek, kontrol kaybı.
- Tipik özellikler: hızlı yeme, tokken de devam etme, gizli yeme, sonrasında utanç, pişmanlık.
- Telafi edici davranış yok.
- Kilo alımı ve obezite komplikasyonları (Tip 2 diyabet, kardiyovasküler, OSA).

6. Tanı

6.1 Birleşik tanı ölçütleri

A. Tekrarlayan tıkınırcasına yeme epizodları.

B. Epizodlar aşağıdakilerden en az ≥ 3'ü ile ilişkilidir:

1. Hızlı yeme;
2. Fiziksel doyana kadar yemek;
3. Açlık olmadan çok yeme;
4. Gizli yeme (utançtan);
5. Sonrasında kendinden tiksinme, depresif duygudurum veya yoğun suçluluk.

C. Önemli sıkıntı.

D. Sıklık: haftada 1 kez, ≥ 3 ay

E. Bulimiya ya da anoreksiya bağlamında ortaya çıkmaz; kompansatuvar davranış yok.

6.2 Kaynaklar arasındaki farklar

- DSM-5-TR — şiddet epizod sıklığına göre.

- ICD-11 — şiddet ölçeği yoktur: DSM-5-TR epizod sayısına göre derecelendirir (hafif 1–3, orta 4–7, ağır 8–13, aşırı ≥14 haftada), ICD-11 ise yalnızca "haftada bir ya da daha sık, birkaç ay boyunca" der.

6.3 Tanı algoritması

1. Klinik görüşme.
2. EDE-Q.
3. Tıbbi değerlendirme — metabolik sendrom taraması (glukoz, HbA1c, lipid, kan basıncı)
4. Komorbidite.

6.4 Ayırıcı tanı

Durum	**Ayırt edici**
Bulimiya (6B81)	Telafi edici davranış.
Obezite (kompulsif yeme olmadan)	Tıkınırcasına yeme epizodu özellikleri yok.
Kleine-Levin	Hiperfaji + hipersomni.
Prader-Willi sendromu	Genetik; hiperfaji kontrol dışı.

7. Muayene ve değerlendirme

- EDE-Q.
- BMI, kilo, vital bulgular.
- Metabolik panel.

8. Tedavi

1. CBT-E birinci basamak — BED'de anlamlı etki; Wilson G.T. et al. derlemeleri.
2. Lisdeksamfetamin (Vyvanse) 50–70 mg/gün — FDA onayı BED için; tıkınırcasına yeme sıklığını anlamlı azaltır (McElroy S.L. JAMA Psychiatry 2015).
3. SSRI — komorbid MDB için; tıkınırcasına yeme sıklığına mütevazı etki.
4. İPT alternatif.
5. Kilo yönetimi — diyet, fiziksel aktivite; kilo kaybı BED müdahalesi olmadan etkili olmaz.

6. Bariatrik cerrahi — uzun süreli izlem gerektirir (BED preoperatif değerlendirme).

8.1 Tedavi metodolojileri

1. CBT-E BED için — Tıkınırcasına yeme zincirinin kırılması, alternatif başa çıkma.
2. Lisdeksamfetamin — FDA onayı BED için; başlangıç 30 mg, hedef 50–70 mg/gün.
3. İPT — Kişilerarası sorunlara odaklanma.
4. Rehberlik altında Kendine Yardım BDT (Guided Self-Help) — İnternet tabanlı, kitap tabanlı.

8.2 Kaynaklar arasındaki farklar

- NICE NG69 — BDT veya rehberli kendi kendine yardım birinci basamak.
- APA 2023.
- McElroy lisdeksamfetamin RKÇ'leri.

9. Prognoz

- CBT-E ile %50–60 remisyon.
- Kilo yönetimi ve metabolik komplikasyonlar uzun süreli takip gerektirir.

10. Mit ve yanlış inançlar

Mit 1: “BED sadece obezite veya ‘çok yeme’ kişilik özelliğidir”

Kanıt: klinik yeme bozukluğudur; tıkınırcasına yeme olayından farklı özellikler (kontrol kaybı, utançla yeme).

Mit 2: “Kısıtlayıcı diyet BED'i iyileştirir”

Kanıt: kısıtlayıcı diyet BED tetikleyicisidir — psikolojik müdahalesiz kilo yönetimi tıkınırcasına yemeyi artırır.

Mit 3: “Bariatrik cerrahi BED'i iyileştirir”

Kanıt: cerrahi mide kapasitesini azaltır, ancak bilişsel-davranışsal bileşeni değiştirmez; bazı hastada “grazing” yeni model olarak gelişir.

Mit 4: "Yemek 'bağımlılık'tır (food addiction), uyuşturucu gibi tedavi edilmelidir"

Kanıt: "food addiction" bir konsepttir, ancak klinik tanı olarak kabul edilmemiştir; standart yeme bozukluğu müdahaleleri önceliklidir.

Mit 5: "BED yalnızca antidepresan gerektirir"

Kanıt: Lisdeksamfetamin FDA onayı BED için; BDT birinci basamak.

11. Kaynaklar

1. WHO. ICD-11. 6B82 Binge eating disorder. 2024.
2. APA. DSM-5-TR. 2022.
3. NICE NG69. 2017/2020.
4. McElroy S.L. et al. Efficacy and safety of lisdexamfetamine for treatment of adults with moderate to severe binge eating disorder. JAMA Psychiatry 2015;72(3):235–246.
5. Wilson G.T., Wilfley D.E., Agras W.S., Bryson S.W. Psychological treatments of binge eating disorder. Arch Gen Psychiatry 2010;67(1):94–101.

ICD-11 **6B84**	**6B84 PİKA** **Pica**
ICD-10 F98.3	Bebeklik veya çocukluk dönemi pikası
DSM-5-TR F98.3 / F50.89	Pika

1. Tanım ve nozoloji

Pika (ICD-11: 6B84; DSM-5-TR: F98.3) — gıda olarak kabul edilmeyen, besin değeri olmayan maddelerin (kil, saç, kağıt, sabun, metal, taş) sürekli (≥ 1 ay) alımı — gelişim yaşı için uygun olmayan derecede.

2. Tarihçe

- "Pica" — Latince "saksağan" sözcüğünden (saksağan her şeyi yer).
- DSM-III (1980) — çocukluk bozukluğu olarak.

- DSM-5 (2013) — tüm yaşlarda tanı mümkün.

3. Epidemiyoloji

- Yaygınlık: Çocuklarda %4–26, zihinsel engellilerde yüksek, gebelikte kadınlarda %8–65, demir eksikliği anemisinde.
- Komorbidite: otizm, entelektüel yetersizlik, demir eksikliği, yetişkin malabsorbsiyonu.

4. Etiyoloji ve patogenez

- Nutrisyonel eksiklikler (demir, çinko) — bazı hastalarda pika madde yenmesi sonucu kötüleşebilir.
- Nörogelişimsel bozukluklar (otizm, İD).
- Gebelik — fizyolojik ve mikrobesin.
- Kültürel — bazı geleneklerde kil tüketimi (geophagy).

5. Klinik özellikler

- Jeofaji (kil, toprak), trikofaji (saç), pagofaji (buz), amilofaji (nişasta), plumbofaji (boya — kurşun riski).
- Komplikasyonlar: intestinal obstrüksiyon (trikobezoar), kurşun zehirlenmesi, paraziter enfeksiyon, diş hasarı, perforasyon.

6. Tanı

6.1 Birleşik tanı ölçütleri

A. Besleyici değeri olmayan maddelerin sürekli alımı ≥ 1 ay.

B. Davranış gelişimsel yaşa uygun değil (≥ 2 yaş).

C. Kültürel veya sosyal olarak kabul edilmiş bir pratik değil.

D. Başka bir ruhsal bozukluk, tıbbi durum bağlamında ortaya çıkıyorsa — tanı eklenmesi gerekir (özellikle İD ve OSB'de).

6.2 Kaynaklar arasındaki farklar

- DSM-5-TR en az 1 aylık süre ister; ICD-11'de süre ölçütü yoktur — "klinik ilgi gerektirecek kadar sürekli ya da ağır" denir. Gelişimsel yaş ≈2 yıl her ikisinde aynıdır.

6.3 Tanı algoritması

1. Görüşme + gözlem.
2. Laboratuvar — tam kan, ferritin, demir, kurşun düzeyi, çinko.
3. Abdominal görüntüleme (obstrüksiyon).
4. Nörogelişimsel değerlendirme.

6.4 Ayırıcı tanı

Durum	Ayırt edici
OKB (6B20)	Obsesyon temellidir.
Yapay bozukluk (6D50)	Kazanç motivasyonu.
Anoreksiya tıkınırcasına yeme tipi (6B80)	Beden imajı.
Kültürel beslenme pratiği	Kontekst.

7. Muayene ve değerlendirme

- Demir, kurşun, çinko, parazit testleri.
- Batın grafisi / USG.

8. Tedavi

1. Nutrisyonel eksikliğin düzeltilmesi (demir, çinko).
2. Davranış müdahalesi — habit reversal, çevre modifikasyonu, alternatif uyaranlar.
3. Entelektüel yetersizlik ve OSB zemininde — fonksiyonel davranış analizi ve ABA temelli yaklaşım.
4. Komplikasyonların tıbbi yönetimi (kurşun zehirlenmesi — şelasyon yalnızca belirli endikasyonda).
5. Gebelikte — beslenme desteği.

8.1 Tedavi metodolojileri

1. İşlevsel Davranış Analizi (FBA) — Davranışın tetikleyicisi ve sürdürücüsünün tanımlanması.
2. Çevre Modifikasyonu — Gıda dışı maddelere erişimin kısıtlanması.
3. Nutrisyonel Düzeltme — Demir, çinko, vitamin takviyeleri.
4. ABA temelli müdahale — İD ve OSB'de.

8.2 Kaynaklar arasındaki farklar

- AAP — çocuklarda pika değerlendirmesi ve kurşun taraması.

9. Prognoz

- Çocuklarda nütrisyonel düzeltme ve davranış müdahalesi ile remisyon.
- İD/OSB zemininde devam edebilir; uzun süreli izlem.

10. Mit ve yanlış inançlar

Mit 1: "Pika sadece çocuğun 'keşfetme' davranışıdır"

Kanıt: 2 yaşa kadar genel gelişim parçası; sonraki devam etmesi kliniktir ve komplikasyon riski yaratır.

Mit 2: "Kurşun zehirlenmesi herkes için şelasyon gerektirir"

Kanıt: şelasyon yalnızca onaylanmış yüksek düzeyde (BLL ≥ 45 μg/dl tipik); düşük düzeylerde çevre düzeltmesi birinci sıra.

Mit 3: "Hamilelikte pika 'çocuğun isteği'dir, müdahale gerektirmez"

Kanıt: demir veya diğer eksiklik belirtecidir; nütrisyonel düzeltme önerilir.

Mit 4: "İD/OSB hastasında pika 'kaçınılmazdır'"

Kanıt: davranış müdahaleleri (ABA, FBA) etkilidir; "kaçınılmaz" açıklama trikobezoar, obstrüksiyon gibi ağır komplikasyonlara yol açar.

11. Kaynaklar

1. WHO. ICD-11. 6B84 Pica. 2024.
2. APA. DSM-5-TR. 2022.
3. Young S.L. Pica in pregnancy: new ideas about an old condition. Annu Rev Nutr 2010;30:403–422.
4. Hyman S.L. et al. AAP 2020 Clinical Report (ASD). Pediatrics 2020;145(1):e20193447.

ICD-11 **6B85**	**6B85 GEVİŞ GETİRME BOZUKLUĞU** **Rumination-regurgitation disorder**
ICD-10 F98.21	—
DSM-5-TR F98.21	Geri Çıkarma (Geviş Getirme) Bozukluğu

1. Tanım ve nozoloji

Geviş Getirme Bozukluğu (ICD-11: 6B85 Rumination-Regurgitation Disorder; DSM-5-TR: F98.21) — yutulmuş gıdanın istemli veya yarı-istemli geri çıkarılması (regürjitasyon) ardından yeniden çiğneme, yeniden yutma veya tükürme ile karakterizedir. Tıbbi (gastroözofageal reflü veya başka GI hastalık) ile tam olarak açıklanmaz.

2. Tarihçe

- Antik dönemde "mericism" terimi.
- DSM-IV — bebek ve çocukluk bozukluğu olarak.
- DSM-5 (2013) — tüm yaşlarda tanı.

3. Epidemiyoloji

- Yaygınlık: Bebek ve çocuklarda nadir; zihinsel engelli hastalarda %6–10; yetişkinlerde (özellikle yeme bozukluğu komorbid) tanınması artmaktadır.
- Komorbidite: İD, OSB, anksiyete, BN, BED.

4. Etiyoloji ve patogenez

- Davranış koşullanması — "postprandiyal geğirme" ardından regürjitasyon öğrenilmiş davranış.
- Stres ve kaygı.
- İD/OSB'de yiyecekle kendini uyarma.

5. Klinik özellikler

- Gıda alımından dakikalar-saatler sonra regürjitasyon.

- Yeme bozukluğu sonuçları: kilo kaybı, malnutrisyon, elektrolit bozukluğu, diş erozyonu, halitoz.
- Sosyal sonuçlar: utanç, sosyal izolasyon.

6. Tanı

6.1 Birleşik tanı ölçütleri

A. Yutulan gıdanın tekrarlayan regürjitasyonu — DSM-5-TR: ≥ 1 ay; ICD-11: haftada birkaç kez, en az birkaç hafta boyunca; yeniden çiğneme, yutma veya tükürme.

B. Regürjitasyon tıbbi durum (örn. reflü, pilorik stenoz, pilorik duodenum obstrüksiyonu) ile ilişkili değildir.

C. Anoreksiya, bulimia, BED, ARFID bağlamında ortaya çıkmaz.

D. Başka bir ruhsal bozukluk (özellikle İD, OSB) zemininde ortaya çıkıyorsa, belirgin şiddet ayrı değerlendirme gerektirir.

6.2 Kaynaklar arasındaki farklar

- DSM-5-TR / ICD-11 — ölçütler örtüşür; süre ve yaş eşiği farklıdır: DSM-5-TR ≥ 1 ay, ICD-11 haftada birkaç kez en az birkaç hafta ve gelişimsel yaşın ≥ 2 yıl olmasını gerektirir.

6.3 Tanı algoritması

1. Klinik görüşme.
2. Tıbbi değerlendirme — GERD, pilorik patoloji, gastroparezi dışlanması (üst endoskopi, motilite çalışması)
3. Manometri — fonksiyonel regürjitasyonun doğrulanması.
4. Kilo ve beslenme durumu.
5. Komorbid yeme bozukluğu taraması.

6.4 Ayırıcı tanı

Durum	**Ayırt edici**
GERD	Tipik asit reflüsü; pH-monitörizasyon.
Bulimiya (6B81)	İstemli kusma kompansatuvar amaçlı.
Anorexia (6B80)	Kilo korkusu.
Gastroparesis	Motilite çalışması.

Durum	Ayırt edici
Pylorik obstrüksiyon	Endoskopi.

7. Muayene ve değerlendirme

- Endoskopi, manometri, pH izlemi.
- Tam kan sayımı, elektrolitler.

8. Tedavi

1. Diyafragmatik solunum — birinci basamak davranış müdahalesi (Chitkara D.K. et al. Am J Gastroenterol 2006; etki %50–70).
2. Habit reversal — alternatif davranış öğrenme.
3. Biofeedback.
4. Stres yönetimi ve BDT.
5. İD/OSB'de işlevsel davranış analizi ve ABA.
6. Tıbbi: GERD ile birlikte proton pompa inhibitörü ilk müdahale.

8.1 Tedavi metodolojileri

1. Diyafragmatik Solunum (Diaphragmatic Breathing) — Yemek alımından sonra 5–10 dakika yavaş abdominal nefes alma — regürjitasyonu önler.
2. Alışkanlık Değiştirme Eğitimi (HRT — Habit Reversal Training) — Alternatif davranış geliştirme.
3. Biofidbek (Biofeedback) — Abdominal kas kontrolü.
4. FBA — işlevsel davranış analizi (İD/OSB'de) — Davranışın tetikleyici ve sürdürücüsünün analizi.

8.2 Kaynaklar arasındaki farklar

- Rome Foundation kriterleri (fonksiyonel GI).
- NICE NG69 — genel yeme bozukluğu prensipleri.

9. Prognoz

- Diyafragmatik solunum ve alışkanlık tersine çevirme ile anlamlı iyileşme.

10. Mit ve yanlış inançlar

Mit 1: “Ruminasyon GERD'in bir formudur”

Kanıt: ayrı bir bozukluktur; manometri ve klinik model farklılık gösterir.

Mit 2: “Yalnızca tıbbi cerrahi (Nissen) çözer”

Kanıt: Nissen fundoplikasyonu fonksiyonel ruminasyon için etkisiz ve kontrendikedir; davranışsal müdahale birinci basamak.

Mit 3: “Hasta ‘iradi olarak’ davranır, disiplin gerektirir”

Kanıt: yarı-istemli davranıştır, koşullanma temelli; ceza etkisizdir.

Mit 4: “Antiemetik etkilidir”

Kanıt: antiemetikler (örn. ondansetron) ruminasyonda etkisizdir.

Mit 5: “İD/OSB hastada durdurulamaz”

Kanıt: davranış müdahaleleri etkilidir; nutrisyonel komplikasyonlar için aktif müdahale önemlidir.

11. Kaynaklar

1. WHO. ICD-11. 6B85 Rumination-regurgitation disorder. 2024.
2. APA. DSM-5-TR. 2022.
3. Chitkara D.K., Van Tilburg M., Whitehead W.E., Talley N.J. Teaching diaphragmatic breathing for rumination syndrome. Am J Gastroenterol 2006;101(11):2449–2452.
4. Rome IV Diagnostic Criteria for Disorders of Gut-Brain Interaction. Rome Foundation; 2016.

ICD-11 **6B83**	**6B83 KAÇINGAN-KISITLI GIDA ALIM BOZUKLUĞU (ARFID)** **Avoidant-restrictive food intake disorder**
ICD-10 F98.2	Bebeklik ve çocuklukta beslenme bozukluğu

	6B83 KAÇINGAN-KISITLI GIDA ALIM BOZUKLUĞU (ARFID)
ICD-11 **6B83**	**Avoidant-restrictive food intake disorder**
DSM-5-TR F50.82	Kaçıngan/Kısıtlı Yiyecek Alımı Bozukluğu

1. Tanım ve nozoloji

Kaçıngan-kısıtlı gıda alım bozukluğu (ARFID; ICD-11: 6B83; DSM-5-TR: F50.82) — gıda alımından kaçınma veya kısıtlama sonucu belirgin kilo kaybı, beslenme yetersizliği, enteral beslenme veya psikososyal bozulma. Beden imajı bozukluğu veya kilo almaktan korku yoktur (anoreksiyadan temel farkı).

2. Tarihçe

- DSM-IV "Feeding Disorder of Infancy or Early Childhood" — yalnız çocuklarda.
- DSM-5 (2013) — ARFID tüm yaşlara genişletilmiştir.

3. Epidemiyoloji

- Yaygınlık: %0,3–3,2 (yeme bozukluğu kliniklerinde ~%5–14).
- Cinsiyet: yaklaşık eşit (anoreksiyadan farklı).
- Başlangıç: çocukluk ve ergenlik baskın.
- Komorbidite: otizm spektrumu, anksiyete, OKB.

4. Etiyoloji ve patogenez

- Duyusal hassasiyet (besin dokusu, koku, görünüm) — özellikle otizm zemininde.
- Boğulma ya da kusma travmasından korku.
- Yiyeceğe düşük ilgi (low appetite, low food interest).

5. Klinik özellikler

Üç klinik prezentasyon

- Duyusal hassasiyet — seçici yiyici — sınırlı yiyecek türü, doku hassasiyeti.
- Yiyeceğe düşük ilgi — açlık hissi az, yiyeceğe uyaran yok.
- Korku (boğulma, kusma) — belirli tetikleyici olaydan sonra kaçınma.

Sonuçlar: anlamlı kilo kaybı veya yeterli kilo artışı olmaması (çocuklarda), nutrisyonel eksiklikler (demir, çinko, vitamin), enteral beslenme bağımlılığı, sosyal bozulma (okul yemeği, arkadaşla yemek).

6. Tanı

6.1 Birleşik tanı ölçütleri

A. Gıda alımından kaçınma veya kısıtlama sonucunda en az biri:

1. Önemli kilo kaybı veya yeterli kilo artışı olmaması;
2. Önemli nütrisyonel eksiklik;
3. Enteral beslenme veya oral beslenme desteği bağımlılığı;
4. Önemli psikososyal bozulma.

B. Bozukluk mevcut besin eksikliği veya kültürel pratikle açıklanmıyor.

C. Anoreksiya veya bulimia bağlamında ortaya çıkmaz; beden imajı bozukluğu yok.

D. Başka bir tıbbi veya ruhsal durumla (örn. alerji, OKB) daha iyi açıklanmaz.

6.2 Kaynaklar arasındaki farklar

- DSM-5-TR / ICD-11 — aynı.
- NICE NG69 — ARFID için spesifik müdahale kuralları.

6.3 Tanı algoritması

1. Klinik görüşme ve beslenme geçmişi.
2. NIAS (Nine Item ARFID Screen) — tarama.
3. Tıbbi değerlendirme — kilo, boy, BMI, besin eksikliği laboratuvar.
4. Otizm ve OKB taraması.
5. Alerji ve GI patolojinin dışlanması.

6.4 Ayırıcı tanı

Durum	Ayırt edici
Anorexia (6B80)	Beden imajı ve kilo korkusu esastır.
Otizm spektrumu (6A02)	Duyusal hassasiyet bileşeni; ARFID ASD ile komorbid olabilir.
OKB (6B20)	Kirlenme obsesyonları temel; ritualize edilmiş davranış.
Özgül fobi (6B03)	Belirli nesne; ARFID'de çok sayıda yiyecek türü.
Alerji / Crohn / çölyak hastalığı	Tıbbi onay.

7. Muayene ve değerlendirme

- NIAS, EDE-Q.
- Kilo, boy, BMI geçmişi.
- Laboratuvar: tam kan, ferritin, sink, vitamin D, B12, folat.
- Otizm taraması (M-CHAT, ADOS).

8. Tedavi

1. Multidisipliner yaklaşım: beslenme uzmanı + BDT terapisti + yeme-uğraşı terapisti.
2. FBT-ARFID — Lock J. tarafından uyarlanmış.
3. BDT-AR — ARFID için Bilişsel Davranışçı Terapi (Thomas J.J.) — manualize edilmiş.
4. Basamaklı besin maruziyeti — yeni besin türlerinin kademeli olarak tanıtılması.
5. Duyusal entegrasyon unsurları (otizm zemininde).
6. Tıbbi: nütrisyonel düzeltme; ağır vakada enteral beslenme.
7. Komorbid anksiyete için SSRI; ARFID için spesifik FDA onaylı ilaç yok.

8.1 Tedavi metodolojileri

1. ARFID için BDT (CBT-AR — CBT for ARFID) — Thomas (Thomas J.J.) — Manuelize edilmiş; duyusal, low interest, korku alt-tiplerine uygun protokoller.
2. FBT-ARFID — Ailenin yiyecek maruziyetindeki rolüne odaklanma.

3. Basamaklı Besin Maruziyeti — Yeni yiyeceğe bakma → dokunma → tatma → yutma aşamaları.
4. Dokuz Maddeli ARFID Taraması (NIAS — Nine Item ARFID Screen) — 3 alt tip tarama.

8.2 Kaynaklar arasındaki farklar

- NICE NG69 — basamaklı gıda maruziyeti.
- Thomas J.J. CBT-AR — yeni kanıt temeli.

9. Prognoz

- Multidisipliner yaklaşımla çoğu hastada iyileşme.
- Otizm ve OKB zemininde uzun süreli izlem.

10. Mit ve yanlış inançlar

Mit 1: “ARFID sadece 'seçici yeme'dir”

Kanıt: klinik tanı anlamlı işlevsel bozulma veya beslenme yetersizliği gerektirir.

Mit 2: “Hasta açlıkla yemeye zorlanabilir”

Kanıt: Açlık stratejisi ARFID'de etkisiz ve aile-çocuk ilişkisine zararlı; kademeli maruziyet önerilir.

Mit 3: “ARFID anoreksiyanın 'hafif formu'dur”

Kanıt: ayrı bir klinik birimdir; beden imajı bozukluğu ve kilo korkusu yoktur; müdahale farklıdır.

Mit 4: “Otizm zemininde ARFID tedavi edilemez”

Kanıt: Duyusal entegrasyon ve davranışsal yaklaşımlar otizm zemininde de etkilidir.

Mit 5: “Hasta ‘büyüdüğünde geçer’”

Kanıt: tedavisiz devam edebilir; erken müdahale nütrisyonel komplikasyonları önler.

11. Kaynaklar

1. WHO. ICD-11. 6B83 ARFID. 2024.
2. APA. DSM-5-TR. 2022.
3. NICE NG69. 2017/2020.

4. Thomas J.J., Eddy K.T. Cognitive-Behavioral Therapy for ARFID. Cambridge University Press; 2018.
5. Zickgraf H.F., Ellis J.M. Initial validation of the Nine Item Avoidant/Restrictive Food Intake Disorder Screen (NIAS). Appetite 2018;123:32–42.
6. Lock J., Le Grange D. Treatment Manual for Anorexia Nervosa: A Family-Based Approach. 2nd ed. New York: Guilford Press, 2013.

6C00–6C0Z BOŞALTIM BOZUKLUKLARI

Elimination disorders

ICD-11 **6C00**	**6C00 ENÜREZİS** **Enuresis**
ICD-10 F98.0	Organik olmayan enürezis
DSM-5-TR F98.0	Enürezis (İdrar Kaçırma)

1. Tanım ve nozoloji

Enürezis (ICD-11: 6C00; DSM-5-TR: F98.0) — çocuğun gelişim yaşı en az 5 yaşa ulaştığında devam eden istemsiz idrar kaçırmadır. Süre: haftada en az 2 kez ≥ 3 ay veya belirgin işlevsel bozulma.

Alt tipler (ICCS — International Children's Continence Society 2014):

- Monosimptomatik nokturnal enurez — yalnızca gece, gündüz semptomlar yok;
- Non-monosimptomatik enurez — gündüz semptomları (sıkışma, sıklık artışı, inkontinans) ek;
- Primary — çocuk hiçbir zaman 6 ay sürekli kuruluk elde etmemiş;
- Secondary — kuru dönemden sonra nüks.

2. Tarihçe

- 19. yüzyılda enürezisin ailesel kümelenmesi klinik literatürde kaydedilmeye başlanmıştır.
- Mowrer O.H. (1938) — pad-and-bell alarmı icat etmiştir.
- ICCS (1989) — uluslararası standardizasyon.
- NICE CG111 (2010) — nokturnal enürezis klinik kılavuzu.

3. Epidemiyoloji

- Yaygınlık: 5 yaş %15–20, 7 yaş %5–10, 10 yaş %3–5, yetişkin %1–2.
- Cinsiyet: erkek 2:1.
- Spontan remisyon yılda ~%15.
- Komorbidite: DEHB ~%30, anksiyete, davranış bozuklukları, konstipasyon.

4. Etiyoloji ve patogenez

- Kalıtım %70 (Bayoumi R.A. incelemeleri).
- Üç ana mekanizma (monosemptomatik nokturnal):
    - Gece vazopressin (ADH) sekresyonunun olgunlaşmaması (nokturnal poliüri);
    - Uyanma eşiğinin yüksekliği;
    - Mesane kapasitesinin yaş normundan küçük olması.
- Non-monosemptomatik formda — mesane aşırı aktivitesi, konstipasyon ilişkisi.
- Sekonder enürezis — stres, idrar yolu enfeksiyonu (İYE), diyabet, psikiyatrik tetikleyici.

5. Klinik özellikler

- Gece yatağa idrar kaçırma.
- Gündüz semptomlar (non-monosemptomatik): sıkışma, “tutma manevraları” (Vincent's curtsy, bacakların sıkıştırılması), sıklık artışı, inkontinans.
- Sosyo-duygusal: utanç, özdeğer azalması, sosyal aktiviteden kaçınma (kamp, arkadaşta kalma).

6. Tanı

6.1 Birleşik tanı ölçütleri (DSM-5-TR / ICD-11 / ICCS 2014)

A. Tekrarlayan idrar kaçırma (yatakta veya giyside), istemli veya istemsiz.

B. Sıklık: haftada ≥ 2 kez, ≥ 3 ay; veya önemli distress/fonksiyonel bozulma

C. Gelişim yaşı ≥ 5 yaş.

D. Madde (diüretik) veya tıbbi durum (diyabet, İYE, yapısal anomali) ile tam olarak açıklanmaz.

Niteleyiciler: yalnız nokturnal / yalnız diurnal / nokturnal ve diurnal; primer / sekonder; monosemptomatik / non-monosemptomatik.

6.2 Kaynaklar arasındaki farklar

- ICCS 2014 — alt tip terminolojisi standardı.
- NICE CG111 — tanı ve algoritma.
- AAP — pediatrik değerlendirme.

6.3 Tanı algoritması

1. Klinik görüşme — başlangıç, sıklık, gündüz semptomları, aile geçmişi.
2. İdrar analizi ve kültürü — UTI dışlanması.
3. Voiding günlüğü 3 gün — gündüz semptomları için.
4. Konstipasyon değerlendirmesi (Bristol Stool Chart).
5. Tıbbi: kilo, glukoz, kan basıncı.
6. Yapısal anomali şüphesi varsa — üriner USG; non-monosemptomatik durumda üroflovmetri.

6.4 Ayırıcı tanı

Durum	**Ayırt edici**
UTI	İdrar kültürü pozitif.
Diabet (Tip 1)	Poliüri, polidipsi; glukoz yüksek.
Diabetes insipidus	Özgül ağırlık düşük.
Yapısal anomali (ektopik üreter)	Sürekli sızıntı; USG.
Nörojenik mesane	Omurilik patolojisi.
Konstipasyon	Klinik ve Bristol Dışkı.
Tutma (ictal enuresis)	EEG.

7. Muayene ve değerlendirme

- İdrar analizi, kültür.
- Voiding ve konstipasyon günlüğü.
- üriner USG (atipik klinik).
- Komorbid DEHB, anksiyete taraması.

8. Tedavi

8.1 Genel prensipler (ICCS 2020 · NICE CG111)

1. Davranış müdahalesi:
    - Konservatif öneriler — yatmadan önce sıvı alımının azaltılması, gündüz yeterli su tüketimi, düzenli idrar yapma, konstipasyonun çözümü.
    - Olumlu pekiştirme (yıldız çizelgesi) — kuru geceler için.
2. Birinci basamak spesifik müdahale:
    - Enürezis alarmı (alarm) — pad-and-bell; ≥ 6 yaş, motivasyon varsa; uzun vadeli iyi sonuç; art arda 14 kuru geceye ulaşanlar ~%50, izlemde kuru kalanlar ~%40 (kanıt kalitesi düşük). Kanıt: Caldwell P.H. Cochrane 2020.
    - Desmopressin — sentetik ADH analogu; hızlı etki, ancak kesildiğinde yüksek nüks. ≥ 6–7 yaş.
3. İkinci sıra:
    - Alarm + desmopressin kombinasyonu;
    - Antikolinerjik (oksibutinin) — non-monosemptomatik over-active bladder bağlamında.
4. Refrakter: imipramin (TCA) — kardiyak monitorizasyon; dikkatle, aşırı doz toksisite.
5. Konstipasyonun çözümü — PEG (polietilen glikol) ilk sıra; non-monosemptomatik veya komorbid enkoprezis bağlamında.

8.2 Tedavi metodolojileri

1. Enürezis Alarmı — Mowrer (Mowrer) — Yatak alarmı veya giysi alarmı (nem sensörü); ≥ 4 hafta sürekli kullanım; tipik kullanım 12-16 hafta. Cochrane meta-analizi — en kanıtlı uzun süreli yöntem.
2. Desmopressin — Oral 0,2–0,4 mg veya sublingual; yatmadan önce 1 saat; yatmadan önce sıvı kısıtlaması önemlidir (hiponatremi riski).
3. Voiding ve Konstipasyon Günlüğü — 3 günlük; sıklık, hacim, mesane kapasitesi, gündüz semptomları, dışkılama sıklığı.
4. Antikolinerjik (Oksibutinin) — Over-active bladder zemininde; gündüz semptomları varsa.
5. PEG (Konstipasyon düzeltmesi) — İlk basamak; enkopreziste de kullanılır.

8.3 Kaynaklar arasındaki farklar

- ICCS 2020 — alarm ve desmopressin birinci sıra; "wait and see" 5 yaşa kadar, sonra aktif müdahale.
- NICE CG111 — aynı algoritma.
- AAP — pediatrik öneriler.

9. Prognoz

- Spontan remisyon yılda ~%15; müdahale ile çoğu hastada remisyon.
- Konstipasyon yönetimi önemlidir.
- Komorbid DEHB, anksiyete — paralel müdahale.

10. Mit ve yanlış inançlar

Mit 1: "Gece enürezisinde kasık ve kalça bölgesine elektroforez idrar merkezini uyarır"

Neden yaygınlaştı: Sovyet dönemi fizyoterapi pratiği; aile hekimleri tarafından "güvenli" olarak sunulur.

Klinik mantık: Eğer gündüz idrar yapma normal ise ve sorun herhangi bir hastalıktan sonra spontan ortaya çıkmamışsa, sorun böbrek/mesane/omurilik seviyesinde değildir. Patogenez ADH disregülasyonu, uyanma eşiği ve mesane kapasitesidir — elektroforez bunları etkilemez.

Kanıt: ICCS 2020, NICE CG111 — hiçbir uluslararası kılavuzda elektroforez yer almaz. Risk: deri irritasyonu, psikoseksüel yük.

Gerçek klinik adım: alarm veya desmopressin.

Mit 2: "Kendi kendine geçer, müdahale gerektirmez"

Kanıt: spontan remisyon yılda ~%15, ancak tedavi edilmeden sürdürmek sosyo-duygusal yük oluşturur; ICCS 2020 — 5+ yaştan aktif tedavi tavsiye edilir.

Mit 3: "Ceza ya da hakaret çocuğu düzeltir"

Kanıt: ceza kontrendikedir; öz saygı azalması, depresyon riski; pozitif pekiştirme üstündür.

Mit 4: "Yatak öncesi su kısıtlaması tek başına yeterlidir"

Kanıt: Adjunkt önlem; tek başına çoğu hastada etkisizdir; spesifik müdahale gereklidir.

Mit 5: "İmipramin ya da antidepresan birinci sıradır"

Kanıt: imipramin refrakter durumda; kardiyak yan etkiler ve aşırı doz riski; alarm ve desmopressin üstündür.

Mit 6: "Akupunktur ve homeopati enürezisi iyileştirir"

Kanıt: Cochrane derlemeleri — bu tamamlayıcı müdahalelerin etkisi kanıtlanmamıştır.

11. Kaynaklar

1. WHO. ICD-11. 6C00 Enuresis. 2024.
2. APA. DSM-5-TR. 2022.
3. NICE CG111. Nocturnal enuresis in children and young people under 19. 2010.
4. Nevéus T. et al. Management and treatment of nocturnal enuresis — an updated standardization document from the International Children's Continence Society. J Pediatr Urol 2020;16(1):10–19.
5. Caldwell P.H., Codarini M., Stewart F. et al. Alarm interventions for nocturnal enuresis in children. Cochrane Database Syst Rev 2020; (5):CD002911.
6. Bayoumi R.A., Eapen V., Al-Yahyaee S. et al. The genetic basis of inherited primary nocturnal enuresis: a UAE study. J Psychosom Res 2006;61(3):317–320.

ICD-11 **6C01**	**6C01 ENKOPREZİS** **Encopresis**
ICD-10 F98.1	Organik Olmayan Enkopresis
DSM-5-TR F98.1	Enkoprezis (Dışkı Kaçırma)

1. Tanım ve nozoloji

Enkoprezis (ICD-11: 6C01; DSM-5-TR: F98.1) — çocuğun gelişim yaşı en az 4 yaşa ulaştığında devam eden uygun olmayan yerlere (giysiye, yere) istemli veya istemsiz dışkılamadır. Süre: ayda en az 1 kez ≥ 3 ay.

Alt tipler:

- Retentif (overflow inkontinens) — kabızlık temelinde; ~%80 vakada;
- Non-retentif — kabızlık yok.

2. Tarihçe

- DSM-III (1980) — resmi tanı.
- Rome IV — fonksiyonel GI çerçevesinde konsensus.
- NASPGHAN/ESPGHAN fonksiyonel konstipasyon rehberi (Tabbers M.M. ve ark. 2014).

3. Epidemiyoloji

- 4–17 yaş arasında %1–4; erkeklerde 3–6 kat daha yüksek.
- ~%80 — kabızlık temelli (retentif).
- Komorbidite: enürezis, DEHB, anksiyete, otizm spektrumu.

4. Etiyoloji ve patogenez

- Konstipasyon — temel mekanizma (retentif enkopreziste); ağrılı defekasyon → tutma → rektal genişleme → duyusal azalma → overflow.
- Tuvalet eğitimi sürecinde travma, korku, disiplin.
- Diyet (düşük lif, dehidratasyon).
- Davranış ve duygusal faktörler — opozisyonel, anksiyete.
- Nadir durumlarda — Hirschsprung hastalığı (rektal aganglionoz), spinal patoloji.

5. Klinik özellikler

- Giysilerde fekal sızıntı (soiling).
- Retentif — abdominal palpasyonda fekal kitle; gergin rektum; büyük (masif) defekasyon epizodları.
- Sosyo-duygusal: utanç, sosyal izolasyon, okuldan kaçınma.

6. Tanı

6.1 Birleşik tanı ölçütleri

A. Uygun olmayan yerlere (giysi, zemin) defekasyon, istemli veya istemsiz.

B. Sıklık: ayda ≥ 1 kez, ≥ 3 ay

C. Gelişim yaşı ≥ 4 yaş.

D. Madde (laksatif) veya tıbbi durum (Hirschsprung, anatomik anomali, spinal patoloji) ile tam olarak açıklanmaz.

Niteleyici: konstipasyon ve overflow ile / olmadan.

6.2 Kaynaklar arasındaki farklar

- NASPGHAN/ESPGHAN 2014 — fonksiyonel konstipasyon rehberi (Rome IV)
- NICE CG99 (2010) — çocuk ve ergenlerde kabızlık.

6.3 Tanı algoritması

1. Klinik görüşme — defekasyon sıklığı, ağrı, tuvalet eğitimi geçmişi.
2. Abdominal palpasyon — fekal kitle.
3. Rektal muayene — fekal impaksiyon (veya son durumun klinik şüphesi).
4. Defekasyon günlüğü (Bristol Stool Chart).
5. Tıbbi: tiroid (hipotiroid konstipasyon), serum kalsiyum, çölyak hastalığı taraması.
6. Atipik klinik: USG, anorektal manometri, suction (emme) biyopsisi (Hirschsprung).

6.4 Ayırıcı tanı

Durum	**Ayırt edici**
Hirschsprung hastalığı	Doğumdan konstipasyon; rektal muayenede dar; biyopsi aganglionoz.
Hipotireoid	TSH.
Spinal patoloji	Nörolojik bulgular; MRG.
Çölyak hastalığı	Anti-tTG.
Anal yapısal anomali	Fizik muayene, USG.

7. Muayene ve değerlendirme

- Abdominal ve rektal muayene.
- Bristol Dışkı, defekasyon günlüğü.
- TSH, kalsiyum, anti-tTG seçici.
- USG, manometri atipik durumda.

8. Tedavi

8.1 Genel prensipler (NASPGHAN/ESPGHAN · NICE CG99)

1. Impaksiyonun giderilmesi (disimpaksiyon) — PEG (polietilen glikol) yüksek dozda 3–7 gün; oral yol üstündür; lavman önerilmez — travmatiktir.
2. İdame (maintenance) — PEG 0,4 g/kg/gün, aylarca-yıllarca; defekasyonun düzenli ve ağrısız sürmesini sağlar.
3. Davranış müdahalesi:
    - Düzenli tuvalet zamanı (yemekten 15–20 dk sonra, gastrokolik refleks);
    - Doğru ayak desteği (defekasyon pozisyonu);
    - Olumlu pekiştirme (ceza yok).
4. Diyet: Fiber, su alımı artışı (hafif etki; PEG'in yerini almaz).
5. Psikolojik destek: kaygının azaltılması, aile eğitimi.
6. Refrakter durumda biofeedback, multidisipliner yaklaşım; cerrahi nadir (Malone antegrad enema).

8.2 Tedavi metodolojileri

1. PEG (Polietilen Glikol) — Ozmotik laksatif; disimpaksiyon 1–1,5 g/kg/gün × 3 gün; idame 0,4 g/kg/gün; aylar-yıllar; yan etkiler minimal.
2. Tuvalet Zamanı ve Pozisyonu — Yemekten 15-20 dk sonra 5-10 dakikalık tuvalet; ayak desteği — kalça fleksiyonu anorektal açıyı düzleştirir ve ıkınmayı azaltır; videomanometride defekasyon sırasında açı otururken ~100°, çömelirken ~126° olur (Sakakibara R. ve ark. LUTS 2010).
3. Olumlu Pekiştirme (Star Chart — yıldız çizelgesi) — Ceza yerine olumlu davranış ödülü.
4. Biofidbek (Biofeedback) — Refrakter durumda; anorektal koordinasyon eğitimi.

8.3 Kaynaklar arasındaki farklar

- NASPGHAN/ESPGHAN 2014 — PEG birinci basamak; enema travmatik ve ikinci basamak.
- NICE CG99 — aynı.
- Cochrane (Gordon M. ve ark. 2016) — PEG laktüloza kıyasla üstün.

9. Prognoz

- PEG ve davranış müdahalesi ile çoğu hastada remisyon (%50–80 1 yılda).

- Uzun süreli idame tedavisi önerilir; erken kesme nüks riski yaratır.

10. Mit ve yanlış inançlar

Mit 1: "Enkoprez psikolojik 'inatçılık' veya duygusal bozukluk sonucudur"

Kanıt: ~%80 vaka kabızlık temellidir; tıbbi/davranışsal danışmanlık birinci sıradadır, psikolojik değil. Hastanın "kasıtlı" davranış açıklaması yanlıştır.

Mit 2: "Ceza ile çocuğu düzeltmek mümkündür"

Kanıt: NASPGHAN/ESPGHAN — ceza kontrendikedir; öz-değer ve sıkıntıyı artırır

Mit 3: "Enema birinci basamak müdahaledir"

Kanıt: oral PEG üstündür; enema travmatiktir, ikinci sıra.

Mit 4: "Diyet değişikliği tek başına yeterlidir"

Kanıt: Fiber/su hafif adjunkt etki; impaksiyon düzeltmesi ve idame PEG gerektirir.

Mit 5: "Enkoprezis yaşla geçer, tedavi gerektirmez"

Kanıt: tedavisiz kronikleşme, sosyo-emosyonel yük; aktif müdahale önerilir.

Mit 6: "Probiyotikler enkopreziyi iyileştirir"

Kanıt: Cochrane — probiyotiklerin anlamlı etkisi kanıtlanmamıştır.

11. Kaynaklar

1. WHO. ICD-11. 6C01 Encopresis. 2024.
2. APA. DSM-5-TR. 2022.
3. Tabbers M.M. et al. Evaluation and treatment of functional constipation in infants and children: evidence-based recommendations from ESPGHAN and NASPGHAN. J Pediatr Gastroenterol Nutr 2014;58(2):258–274.
4. NICE CG99. Constipation in children and young people. 2010.
5. Gordon M. et al. Osmotic and stimulant laxatives for the management of childhood constipation. Cochrane Database Syst Rev 2016;(8):CD009118.
6. Sakakibara R., Tsunoyama K., Hosoi H. et al. Influence of body position on defecation in humans. LUTS: Lower Urinary Tract Symptoms 2010;2(1):16–21.

6C20 BEDENSEL DİSTRESS

Disorders of bodily distress or bodily experience

ICD-11 **6C20**	**6C20 BEDENSEL ENDİŞE BOZUKLUĞU** **Bodily distress disorder**
ICD-10 F45.0	Somatizasyon bozukluğu
DSM-5-TR F45.1	Bedensel Belirti Bozukluğu

1. Tanım ve nozoloji

Bedensel endişe bozukluğu (ICD-11: 6C20 Bodily Distress Disorder; DSM-5-TR: F45.1 Somatic Symptom Disorder) — somatik yakınmaların (ağrı, yorgunluk, gastrointestinal veya kardiyopulmoner semptomlar) aşırı odak, kaygı ve davranış müdahalesi yarattığı, işlevsel bozulma ile seyreden psikiyatrik bozukluktur. Klinik tanı Semptomların "açıklanamaması" temelinde değil, sürekli meşguliyet ve sıkıntı temelinde konur (DSM-5-TR güncellemesinin temel değişikliği).

2. Tarihçe

- Briquet P. (1859) — "histeri" çok sayıda somatik semptomla.
- DSM-III (1980) — "Somatoform Disorders" grubu.
- DSM-5 (2013) — Temel değişiklik: "tıbben açıklanamayan semptomlar" gerekliliği kaldırıldı; somatik semptomun gerçek olup olmaması kriter değil — hastanın tepkisi tanısal odaktadır.
- ICD-11 (2019) — "Bodily Distress Disorder" — bedensel sıkıntı üzerine Avrupa modeline dayanan (Fink P., Schröder A.).

3. Epidemiyoloji

- Birinci basamakta %5–15.
- Cinsiyet: kadınlarda 2–3 kat yüksek.
- Komorbidite: MDD, anksiyete, panik, faktisyöz, gerçek tıbbi hastalıklar.

- Yüksek tıbbi hizmet kullanımı ve maliyetler.

4. Etiyoloji ve patogenez

- Biyopsikososyal model — biyolojik hassasiyet + bilişsel-duygusal bileşenler + sosyal pekiştirme.
- Travma ve çocukluk hastalıkları öyküsü.
- Bilişsel — beden duyumlarına felaketleştirme ve hipervigilans.

5. Klinik özellikler

- Sürekli somatik belirtiler (ağrı, yorgunluk, gastrointestinal, kardiyopulmoner).
- Aşağıdakilerden ≥ 1:
    - Semptomların şiddeti hakkında aşırı ve sürekli düşünce;
    - Sağlıkla ilgili yüksek kaygı;
    - Semptomlara aşırı zaman ve enerji harcanması.
- Süre ≥ 6 ay.
- Fonksiyonel bozulma.
- "Doctor shopping", tekrar kontrol, kaçınma davranışı.

6. Tanı

6.1 Birleşik tanı ölçütleri

A. Bir veya daha fazla somatik semptom — hastada sıkıntıya veya işlevsel bozulmaya neden olur.

B. Aşağıdakilerden ≥ 1:

1. Semptomların şiddeti hakkında aşırı düşünce;
2. Sağlıkla ilgili yüksek kaygı;
3. Semptomlara aşırı zaman/enerji.

C. Süreklilik ≥ 6 ay.

6.2 Kaynaklar arasındaki farklar

- DSM-5-TR — "with predominant pain" ve şiddet niteleyicileri.
- ICD-11 — "Bodily Distress Disorder" — Avrupa "bodily distress syndrome" (Fink P.) konseptine yakın; şiddet (hafif, orta, ağır).

- Alman S3 Guideline (Funktionelle Körperbeschwerden, 2018) — biyopsikososyal yaklaşım.

6.3 Tanı algoritması

1. Klinik görüşme.
2. PHQ-15 (somatik semptom ölçeği), SSS-8.
3. Tıbbi değerlendirme — somatik hastalık dışlanması (ancak aşırı testten kaçınma)
4. Komorbidite (MDD, anksiyete, faktisyöz, gerçek hastalıklar).

6.4 Ayırıcı tanı

Durum	**Ayırt edici**
Hipokondriyazis (6B23)	Hastalık anksiyetesi dominant; somatik semptomlar minimal.
Gerçek tıbbi hastalık	Klinik ve laboratuvar doğrulaması; ancak somatik semptom bozukluğu komorbid olabilir.
FND (6B60)	Spesifik nörolojik semptomlar; “positive signs”.
Yapay bozukluk (6D50)	Bilinçli yalan; kazanç motivasyonu
Malingering	Açık maddi/hukuki kazanç.
MDD somatik formu	Afektif semptomlar dominant.

7. Muayene ve değerlendirme

- PHQ-15, SSS-8, Whiteley Index (örtüşme).
- Tek seferlik kapsamlı tıbbi muayene; sonra tekrar minimum.
- Komorbidite ölçekleri.

8. Tedavi

1. Biyopsikososyal yaklaşım ve “stepped care” — birinci basamak sağlık hizmeti hekimi merkez, psikiyatrist/psikolog adjunkt.
2. Tek hekim modeli (single physician approach) — tüm şikayetler o hekim aracılığıyla yönetilir.

3. BDT — bilişsel yeniden yapılandırma, beden duyumlarının felaketleştirilmesinin azaltılması, davranışsal aktivasyon. Kanıt: van Dessel N. Cochrane 2014 (CD011142).
4. SSRI — komorbid MDB/anksiyete; ağrı dominant olduğunda duloksetin, amitriptilin.
5. Yapılandırılmış sınırlı kontrol — hastaya bir kez kapsamlı kontrol, ardından sınırlı "reassurance".
6. Mindfulness, fiziksel aktivite, mesleki rehabilitasyon.

8.1 Tedavi metodolojileri

1. BDT Somatik Semptom için — Bilişsel yeniden yapılandırma + davranış müdahalesi (kaçınma azaltma, maruz bırakma). van Dessel N. Cochrane 2014 (CD011142).
2. Tek Hekim Modeli — Yapılandırılmış ziyaret; sınırlı sayıda kontrol; tutarlı açıklama.
3. PHQ-15, SSS-8 — Somatik yakınma ölçekleri.
4. Basamaklı Bakım (Stepped Care) — Birinci basamak düzeyinde BDT-temelli kısa müdahale; sonra uzmanlaşmış hizmet.

8.2 Kaynaklar arasındaki farklar

- Alman S3 Guideline — birinci basamak sağlık hizmeti düzeyinde entegre bakım.
- NICE — somatik semptom bozukluğu için ayrı kılavuz yok; genel ilkeler.

9. Prognoz

- BDT ve multidisipliner yaklaşımla anlamlı iyileşme; kronik seyir.

10. Mit ve yanlış inançlar

Mit 1: "Hasta semptomları 'uydurur'"

Kanıt: Semptomlar hasta için gerçektir; somatik bozukluk klinik bir durumdur, simülasyon değildir.

Mit 2: "Tıbbi incelemeden sonra 'hiçbir şey yok' denmesi hastayı rahatlatır"

Kanıt: negatif güvence kısa süreli; uzun süreli kaygıyı sürdürür. Yapılandırılmış açıklama ve biyopsikososyal model üstündür.

Mit 3: “Yalnızca tıbbi araştırma uzun sürerse tanı ortaya çıkar”

Kanıt: tekrarlayan kontrol somatik odak ve maliyetleri artırır; tek seferlik kapsamlı değerlendirme, ardından sınırlı güvence önerilir.

Mit 4: “Somatik semptom bozukluğu yalnızca 'akıl hastalığı'dır”

Kanıt: biyopsikososyal bozukluktur; biyolojik bileşenler (duyarlılık, bağırsak-beyin ekseni) gerçektir.

Mit 5: “Antidepresan somatik semptom bozukluğunun ‘tedavisidir’”

Kanıt: SSRI komorbid semptomlar için; BDT birinci basamak.

11. Kaynaklar

1. WHO. ICD-11. 6C20 Bodily distress disorder. 2024.
2. APA. DSM-5-TR. 2022.
3. Kleinstäuber M. et al. Pharmacological interventions for somatoform disorders in adults. Cochrane Database Syst Rev 2014;(11):CD010628.
4. Henningsen P. et al. Management of somatic symptom disorder. Dialogues Clin Neurosci 2018;20(1):23–31.
5. Schaefert R. et al. Non-specific, functional, and somatoform bodily complaints. Dtsch Arztebl Int 2012;109(47):803–813.
6. van Dessel N., den Boeft M., van der Wouden J.C. et al. Non-pharmacological interventions for somatoform disorders and medically unexplained physical symptoms (MUPS) in adults. Cochrane Database Syst Rev 2014;(11):CD011142.

6C40–6C5Z MADDE İLE İLGİLİ

Disorders due to substance use or addictive behaviours

ICD-11 **6C40**	**6C40 ALKOL KULLANIMI NEDENLİ BOZUKLUKLAR** **Disorders due to use of alcohol**
ICD-10 F10	Alkol kullanımına bağlı ruhsal ve davranışsal bozukluklar
DSM-5-TR F10.20	Alkol Kullanım Bozukluğu, Orta veya Ağır

1. Tanım ve nozoloji

Alkol Kullanımı Nedenli Bozukluklar (ICD-11: 6C40; DSM-5-TR: F10.20 Alkol Kullanım Bozukluğu, AUD) — alkol kullanımının kontrolünün bozulması, alkolün fiziksel veya psikolojik zarar yaratmasına rağmen sürdürülmesi ile karakterize bozukluklar grubudur. ICD-11'de alt tipler: zararlı kullanım paterni (6C40.1), alkol bağımlılığı (6C40.2), intoksikasyon (6C40.3), yoksunluk sendromu (6C40.4), alkol kaynaklı deliryum, psikotik, duygudurum, anksiyete bozuklukları.

2. Tarihçe

- Jellinek E.M. (1960) — “The Disease Concept of Alcoholism” — alkolizm hastalık olarak.
- DSM-IV — “Abuse” ve “Dependence” ayrı kategoriler.
- DSM-5 (2013) — tek “Alcohol Use Disorder” (hafif, orta, ağır şiddet).
- ICD-11 — epizodik zararlı kullanım veya bağımlılık paterninin ayrılması.

3. Epidemiyoloji

- Yaşam boyu yaygınlık: %14–29 (NIAAA NESARC); yıllık %5–14.
- Cinsiyet: erkeklerde 2–3 kat yüksek, ancak kadınlarda artmaktadır.
- Mortalite: dünyada yılda 3 milyon ölüm (WHO).

- Komorbidite: MDD, anksiyete, TSSB, BPD, diğer madde kullanımı, karaciğer hastalığı, kardiyovasküler.

4. Etiyoloji ve patogenez

- Kalıtım ~%49 (%95 GA 43–53) (Verhulst B. et al. Psychol Med 2015).
- Nörobiyolojik — dopamin ödül devresi, GABA, glutamat, opioid sistemleri.
- Çevre — akran, stres, alkol erişilebilirliği, kültürel norm.
- Genetik belirteçler — ADH1B, ALDH2 (Asya popülasyonunda koruyucu).

5. Klinik özellikler

5.1 Bağımlılık sendromu (DSM-5-TR kriterleri, 11'den ≥ 2)

- Daha fazla/daha uzun kullanım;
- Azaltma girişimleri başarısız;
- Zamanın çoğu madde elde etme, kullanma, iyileşmede;
- Kullanıma yönelik istek (craving);
- İş/okul bozulması;
- Sosyal-kişilerarası soruna rağmen devam;
- Önemli faaliyetlerden vazgeçme;
- Tehlikeli durumda kullanım;
- Fiziksel/psikolojik soruna rağmen devam;
- Tolerans;
- Kesilme sendromu.

5.2 İntoksikasyon

- Disinhibisyon, dizartri, ataksi, nistagmus, kognitif bozulma.
- Ağır intoksikasyon — koma, solunum depresyonu, hipoglisemi, ölüm.

5.3 Yoksunluk (withdrawal)

- Hafif: tremor, ter, taşikardi, anksiyete, bulantı (son içkiden 6–24 saat).
- Orta: hiperaktif otonom, halüsinasyonlar (alkol halüsinozu).
- Ağır: delirium tremens (DT) — 48–96 saat; bilinç değişiklikleri, halüsinasyonlar, otonom kriz; hastaneye yatırılan hastalarda mortalite ~%1–4 (Schuckit M.A. N Engl J Med 2014); tedavi edilmemiş tarihsel serilerde belirgin biçimde daha yüksek; nöbetler.

5.4 Komplikasyonlar

- Wernicke-Korsakoff (B1 eksikliği), alkol karaciğer hastalığı, kardiyomiyopati, polinöropati, gebelikte FAS.

6. Tanı

6.1 Birleşik tanı ölçütleri

DSM-5-TR — 11 kriterden ≥ 2 (hafif 2–3, orta 4–5, ağır ≥ 6); ICD-11 — kullanım paterni (zararlı kullanım epizodu, zararlı kullanım paterni, bağımlılık); "riskli kullanım" 6C4x'e değil, QE10 koduna aittir. ICD-11 süre gerekliliği: zararlı kullanım örüntüsü — epizodik kullanımda en az 12 ay, sürekli kullanımda en az 1 ay; bağımlılık — en az 12 ay ya da sürekli (günlük veya neredeyse günlük) kullanımda en az 3 ay.

6.2 Kaynaklar arasındaki farklar

- WHO AUDIT (Saunders 1993) — 10 maddelik tarama.
- NICE CG115 — alkol bozukluklarının tanı ve tedavisi.
- SAMHSA TIP — uluslararası protokoller.

6.3 Tanı algoritması

1. AUDIT, AUDIT-C tarama birinci basamakta.
2. Klinik görüşme — TLFB (Timeline Followback) kullanım paterni.
3. Laboratuvar: GGT, AST/ALT, MCV, CDT (carbohydrate-deficient transferrin), tam kan.
4. Komorbidite (MDD, anksiyete, TSSB, somatik hastalıklar).
5. Kesilme riski (CIWA-Ar).

6.4 Ayırıcı tanı

Durum	Ayırt edici
Başka madde kullanımı	Toksikoloji tarama.
MDD ile kendini tedavi	Afektif semptomlar primary.
Bipolar bozukluk	Afektif epizodlar.
Hipertiroid	TSH.
Nöbet bozukluğu	EEG.

7. Muayene ve değerlendirme

- AUDIT, CIWA-Ar (kesilme şiddeti).
- GGT, MCV, CDT, transaminazlar.
- Tiamin düzeyi.
- EKG, kalp USG (kardiyomiyopati).
- Komorbidite taraması.

8. Tedavi

8.1 Genel Prensipler (NICE CG115 · SAMHSA TIP 49 · APA 2018)

1. Detoksifikasyon:
    - Hafif (CIWA-Ar < 10) — ayaktan tedavi;
    - Orta-ağır — yatarak tedavi (hastaneye yatış);
    - Benzodiazepin (lorazepam, diazepam) — altın standart kesilme tedavisi;
    - Tiamin 100–300 mg IV/IM × 3–5 gün (Wernicke profilaksisi — glukozdan ÖNCE)
    - Hidrasyon, elektrolit düzeltmesi.
2. Relaps önleyici farmakoterapi:
    - Naltrekson (oral 50 mg veya IM Vivitrol 380 mg aylık) — birinci sıra; cravings azaltır.
    - Akamprosat (666 mg × 3 kez/gün) — birinci sıra; abstinensin sürdürülmesi.
    - Disulfiram — ikinci sıra; motive hastada; aversif reaksiyon.
    - Topiramat, gabapentin — off-label.
3. Psikososyal: Motivasyonel Görüşme (MI), BDT, 12-Step facilitation (AA, NA), koşullu ödül yönetimi.
4. SAMHSA — eşlik eden kullanım bozukluğu ve psikiyatrik komorbidite (dual diagnosis).
5. Uzun süreli nüks profilaksisi.

8.2 Tedavi metodolojileri

1. Motivasyonel Görüşme (MI — Motivational Interviewing) — Miller (Miller W.R.), Rollnick (Rollnick S.) — Davranış değişikliğine hazırlığın artırılması; 'ambivalans'a yönelir.

2. Madde kullanımı için BDT — Tetikleyicilerin tanınması, aşerme yönetimi, başa çıkma becerileri, nüks önleme.
3. Naltrekson, Akamprosat, Disulfiram — Nüks önleyici farmakoterapi.
4. 12 Adım Programı Desteği (12-Step Facilitation — AA, NA) — Project MATCH RKÇ — BDT ve MI ile karşılaştırmalı etki.
5. AUDIT, CIWA-Ar — Tarama ve kesilme şiddeti.

8.3 Kaynaklar arasındaki farklar

- NICE CG115 (2011).
- APA Practice Guideline for the Pharmacological Treatment of Patients with Alcohol Use Disorder (2018).
- SAMHSA TIP 49 (2009).

9. Prognoz

- Multimodal yaklaşımla %40–50 uzun süreli remisyon.
- Komorbid MDD, BPD, başka madde — kötü prognoz.

10. Mit ve yanlış inançlar

Mit 1: "Alkolizm karakter zayıflığıdır"

Kanıt: Jellinek 1960; DSÖ — alkol kullanım bozukluğu tıbbi durumdur; kalıtım %50 –60.

Mit 2: "Detoksifikasyon tek başına tedavidir"

Kanıt: detoks ilk adımdır; nüks önleyici müdahale gereklidir; tek başına detoks %90+ nüks.

Mit 3: "Naltrekson alkolü 'kabul edilemez' yapar"

Kanıt: naltrekson craving'i azaltır ve alkolün "reward" etkisini azaltır; disülfiramdan farklıdır.

Mit 4: "Hasta tedavi başlamadan önce 'rock bottom'a ulaşmalıdır"

Kanıt: erken müdahale daha etkilidir; "rock bottom" kavramı kanıta dayanmaz.

Mit 5: “Alkol en güvenli maddedir, tedavi gerektirmez”

Kanıt: WHO — alkol yıllık 2,6 milyon ölüme neden olur (DSÖ 2024, 2019 verileri); DT letalitesi hastaneye yatırılan hastalarda ~%1–4 (Schuckit M.A. N Engl J Med 2014); tedavi edilmemiş tarihsel serilerde belirgin biçimde daha yüksek.

Mit 6: “Hamile kadında ‘az alkol güvenlidir’”

Kanıt: CDC, AAP — gebelikte her miktar alkol FAS riski oluşturur; “güvenli” doz yoktur.

11. Kaynaklar

1. WHO. ICD-11. 6C40 Disorders due to use of alcohol. 2024.
2. APA. DSM-5-TR. 2022.
3. NICE CG115. Alcohol-use disorders: diagnosis, assessment and management. 2011.
4. APA. Practice Guideline for the Pharmacological Treatment of Patients with AUD. 2018.
5. SAMHSA. TIP 49: Incorporating Alcohol Pharmacotherapies Into Medical Practice. 2009.
6. Anton R.F. et al. COMBINE trial. JAMA 2006;295(17):2003–2017.
7. Project MATCH Research Group. Matching alcoholism treatments to client heterogeneity. J Stud Alcohol 1997;58(1):7–29.
8. Verhulst B., Neale M.C., Kendler K.S. The heritability of alcohol use disorders: a meta-analysis of twin and adoption studies. Psychol Med 2015;45(5):1061–1072.
9. Schuckit M.A. Recognition and management of withdrawal delirium (delirium tremens). N Engl J Med 2014;371(22):2109–2113.
10. Saunders J.B., Aasland O.G., Babor T.F. et al. Development of the Alcohol Use Disorders Identification Test (AUDIT). Addiction 1993;88(6):791–804.
11. Miller W.R., Rollnick S. Motivational Interviewing: Helping People Change. 3rd ed. New York: Guilford Press, 2013.

ICD-11 **6C43**	**6C43 OPİYATLARIN KULLANIMI NEDENLİ BOZUKLUKLAR** **Disorders due to use of opioids**
ICD-10 F11	Opioid kullanımına bağlı ruhsal ve davranışsal bozukluklar
DSM-5-TR F11.20	Opioid Kullanım Bozukluğu, Orta veya Ağır

1. Tanım ve nozoloji

Opioid Kullanım Bozuklukları (ICD-11: 6C43; DSM-5-TR: F11.20 Opioid Use Disorder, OUD) — opioidlerin (eroin, morfin, oksikodon, fentanil vb.) kontrolünün bozulmuş kullanımı veya zarar verici kullanım paterni. Tıbbi-adli bağlantılı yüksek mortalite (aşırı doz).

2. Tarihçe

- Dole V.P., Nyswander M. (1965) — metadon idame tedavisi ilk çalışmaları.
- 2010+ ABD'de opioid salgını — reçeteli opioidlerle başlayıp, fentanil aşırı doz krizine kadar.
- WHO, SAMHSA, NICE — opioid agonist idame tedavisi (OAT) altın standart.

3. Epidemiyoloji

- Dünya: 40 milyon+ hasta (UNODC); ABD'de yıllık 80.000+ aşırı doz ölümü.
- Cinsiyet: erkeklerde 2 kat yüksek.
- Komorbidite: MDD, anksiyete, TSSB, BPD, HIV/HCV, kardiyak.
- Mortalite: tedavideki OUD hastalarında popülasyonla karşılaştırıldığında 10 –20 kat yüksek.

4. Etiyoloji ve patogenez

- Kalıtım %50.

- Nörobiyolojik — μ-opioid reseptör sisteminin dopaminerjik ödül devresine etkisi.
- Çevre — reçeteli opioid erişilebilirliği, sosyoekonomik faktörler.
- Ağrı sendromları — reçete başlangıcından bağımlılığa geçiş.

5. Klinik özellikler

- Bağımlılık sendromu (AUD ile aynı kriterler).
- Entoksikasyon — miyozis, sedasyon, solunum depresyonu, hipotansiyon, koma.
- Overdoz — respiratuar depresyon ana ölüm nedenidir; nalokson antidot.
- Kesilme — başlangıç 8–24 saat (kısa etkili), 36–72 saat (uzun etkili metadon); rinore, lakrimasyon, midriyazis, anksiyete, taşikardi, karın krampları, ishal, piloereksiyon.
- Kesilme erişkinde hayatı tehdit edici değildir (alkol/sedatiften farklı), ancak yenidoğanda ağırdır (NAS — Neonatal Abstinence Syndrome).

6. Tanı

6.1 Birleşik tanı ölçütleri

DSM-5-TR: AUD ile aynı 11 kriter yapısı (hafif/orta/ağır). ICD-11, DSM-5-TR'nin tek ölçeğinden farklı olarak üç ayrı kategori kullanır: zararlı kullanım epizodu, zararlı kullanım örüntüsü ve bağımlılık. ICD-11 süre gerekliliği: zararlı kullanım örüntüsü — epizodik kullanımda en az 12 ay, sürekli kullanımda en az 1 ay; bağımlılık — en az 12 ay ya da sürekli (günlük veya neredeyse günlük) kullanımda en az 3 ay.

6.2 Kaynaklar arasındaki farklar

- SAMHSA TIP 63 — Medications for Opioid Use Disorder.
- NICE CG52 — opioid bağımlılığı.
- WHO mhGAP.

6.3 Tanı algoritması

1. Klinik görüşme.
2. Toksikoloji tarama (idrar).
3. HIV, HCV, sifiliz, gebelik testi.
4. Komorbidite ve aşırı doz öyküsü.
5. COWS (Clinical Opiate Withdrawal Scale) — kesilme şiddeti.

6.4 Ayırıcı tanı

Durum	Ayırt edici
Kronik ağrı (bağımlılık olmadan)	Tıbbi endikasyon; kullanım paterni
Başka madde kullanımı (sedatif, alkol)	Toksikoloji.
Fonksiyonel GI belirtileri; piloereksiyon (kesilme farkı)	Tıbbi değerlendirme.

7. Muayene ve değerlendirme

- Toksikoloji tarama.
- COWS skalası.
- HIV, HCV, HBV, sifilis.
- EKG (metadon başlamadan önce — QTc).
- Gebelik testi.

8. Tedavi

8.1 OAT — Opioid Agonist Tedavisi (altın standart)

1. Metadon (idame kliniğinde, günlük kontrol altında) — tam μ-agonist; 60–120 mg/gün; uzun yarı ömür; QTc monitorizasyonu.
2. Buprenorfin/nalokson (Suboxone) — parsiyel μ-agonist + nalokson; ofis bazlı reçete ile; düşük aşırı doz potansiyeli; "induction" — hafif yoksunluk durumunda başlanır.
3. OAT mortaliteyi (Sordo L. et al. BMJ 2017;357:j1550 meta-analiz) ve HIV transmisyonunu (MacArthur G.J. et al. BMJ 2012 meta-analiz) anlamlı ölçüde azaltır.
4. OAT psikososyal müdahaleden üstündür mortalite azalmasında; ancak psikososyal müdahale (MI, BDT, koşullu ödül yönetimi, akran desteği, 12-step — bkz. "Tedavi metodolojileri") ile kombinasyon optimaldir.

8.2 Antagonistler

- Naltrekson (oral 50 mg veya IM Vivitrol 380 mg aylık) — hasta başlamadan 7–10 gün önce abstinent olmalıdır; motive hastalar veya formal idame programları olmadığı durumlarda.

8.3 Doz aşımı yönetimi

- Nalokson — IM/IN; yaygın; "take-home" programları (toplum temelli) ölümü azaltır.

8.4 Gebelikte

- Metadon veya buprenorfin — OAT gebelikte sürdürülür; detoks kontrendikedir (yeniden bağımlılık ve gebelik kaybı riski).
- Yenidoğanda NAS müdahalesi — morfin veya metadon.

8.5 Kaynağa-özgü belirleyiciler

- SAMHSA TIP 63 (2021).
- NICE CG52 (opioid detoksifikasyonu) ve CG51 (psikososyal müdahaleler).
- WHO — OAT altın standart, abstinans-yönelimli yaklaşımdan üstün.

8.6 Tedavi metodolojileri

1. Metadon İdame Tedavisi (MMT — Methadone Maintenance Therapy) — Dole-Nyswander modeli; klinik-temelli.
2. Buprenorfin/Nalokson — Ofis bazlı; "Suboxone induction" protokolü; tavan etkisi sayesinde daha düşük aşırı doz potansiyeli.
3. Nalokson Eve-Verilen (Take-Home) Programı — Toplum temelli; aileye panzehir eğitimi.
4. Klinik Opioid Yoksunluk Ölçeği (COWS — Clinical Opiate Withdrawal Scale) — 11 madde; indüksiyonda önemli.
5. Naltrekson IM (Vivitrol) — Aylık; abstinent hastada.

9. Prognoz

- OAT ile uzun süreli stabilizasyon ve mortalite azalması.
- Komorbidite müdahalesi önemli.

10. Mit ve yanlış inançlar

Mit 1: "OAT (metadon, buprenorfin) bir bağımlılığı başka bir bağımlılıkla değiştirir"

Kanıt: OAT tıbbi tedavidir — mortalite, HIV, suç, sosyal bozulmayı anlamlı ölçüde azaltır; "hassas" anti-OAT pozisyon kanıta dayanmaz. WHO, SAMHSA, NICE — OAT altın standart.

Mit 2: "Detoksifikasyon yeterlidir, OAT gerekmez"

Kanıt: tek detoks %90+ nüks, doz aşımı mortalitesi detokstan hemen sonra en yüksek (tolerans kaybı). OAT mortaliteyi %50+ azaltır.

Mit 3: "Ultra-Rapid Opioid Detoxification (UROD) etkilidir"

Kanıt: UROD ölüm vakaları ve ciddi yan etkilerle ilişkilidir; etki kanıtı yoktur; SAMHSA ve NICE önermemektedir.

Mit 4: "Hamile kadında detoks gereklidir"

Kanıt: Gebelikte detoks kontrendikedir; OAT (metadon veya buprenorfin) sürdürülür.

Mit 5: "İbogain ya da ayahuasca opioid bağımlılığını iyileştirir"

Kanıt: kanıtlanmış değil; ibogaine kardiyak aritmi ve ölüm vakaları ile ilişkilidir (FDA uyarısı); standart pratikte değil.

Mit 6: "Naltrekson birinci sıra OUD için"

Kanıt: SAMHSA TIP 63 — metadon ve buprenorfin mortaliteyi azaltmada daha etkilidir; naltrekson motive abstinent hastada.

Mit 7: "Nalokson take-home programları kullanımı teşvik eder"

Kanıt: Walley A.Y. et al. BMJ 2013 — toplum nalokson programları aşırı doz ölümünü anlamlı derecede azaltır; kullanımı artırmaz.

11. Kaynaklar

1. WHO. ICD-11. 6C43 Disorders due to use of opioids. 2024.
2. APA. DSM-5-TR. 2022.
3. SAMHSA. TIP 63: Medications for Opioid Use Disorder. 2021.
4. NICE CG52; NICE CG51.
5. MacArthur G.J. et al. Opioid substitution treatment and HIV transmission in people who inject drugs. BMJ 2012;345:e5945.
6. Sordo L., Barrio G., Bravo M.J. et al. Mortality risk during and after opioid substitution treatment: systematic review and meta-analysis of cohort studies. BMJ 2017;357:j1550.
7. Walley A.Y. et al. Opioid overdose rates and implementation of overdose education and nasal naloxone distribution. BMJ 2013;346:f174.

ICD-11 **6C41**	**6C41 KANNABİS KULLANIMI NEDENLİ BOZUKLUKLAR** **Disorders due to use of cannabis**
ICD-10 F12	Kannabinoid kullanımına bağlı ruhsal ve davranışsal bozukluklar
DSM-5-TR F12.20	Kenevir Kullanım Bozukluğu, Orta derecede / Ağır

1. Tanım ve nozoloji

Kannabis Kullanımı Nedenli Bozukluklar (ICD-11: 6C41; DSM-5-TR: F12.20) — THC içeren kenevirin kullanımının kontrolünün bozulması ve/veya zarar verici kullanımı. Sentetik kannabinoidler ICD-11'de ayrıca kodlanır (6C42).

2. Tarihçe

- DSM-III (1980) — Cannabis Dependence resmi tanısı.
- DSM-5 (2013) — "kannabis yoksunluğu" resmi kategori olarak eklendi.
- 2010+ — yüksek potensli kenevir ve sentetik kannabinoidler ("Spice", "K2") salgını.

3. Epidemiyoloji

- Yaşam boyu yaygınlık: Esrar kullanıcılarının %7-9'unda bağımlılık gelişir; ergenlikte başlayanlarda risk %17.
- Cinsiyet: erkeklerde yüksek.
- Komorbidite: psikoz riski, anksiyete, MDD, DEHB, diğer madde kullanımı.

4. Etiyoloji ve patogenez

- Kalıtım %50–60.
- Endokannabinoid sistemi.
- Sosyal ve kültürel faktörler; erişilebilirlik.

5. Klinik özellikler

- Bağımlılık sendromu (AUD ile aynı kriterler).
- Entoksikasyon — kızarmış göz, taşikardi, iştah artışı (“munchies”), zaman algısı bozukluğu, yoğun hisler.
- Ağır intoksikasyon — kannabinoid hiperemezis sendromu (kronik kullanımda kusma sendromu), panik, psikoz.
- Kesilme (DSM-5 yeni): irritabilite, anksiyete, uyku bozukluğu, iştah azalması, duygudurum düşüklüğü, somatik yakınmalar; 24–72 saatte başlar, 1–2 hafta sürer.
- Sentetik Kannabinoidler (“Spice”, “K2”) — daha güçlü, öngörülemez; ağır intoksikasyon, akut psikoz, ölüm vakaları.

6. Tanı

6.1 Birleşik tanı ölçütleri

DSM-5-TR — 11 kriter (AUD yapısı). ICD-11, DSM-5-TR’nin tek ölçeğinden farklı olarak üç ayrı kategori kullanır: zararlı kullanım epizodu, zararlı kullanım örüntüsü ve bağımlılık. ICD-11 süre gerekliliği: zararlı kullanım örüntüsü — epizodik kullanımda en az 12 ay, sürekli kullanımda en az 1 ay; bağımlılık — en az 12 ay ya da sürekli (günlük veya neredeyse günlük) kullanımda en az 3 ay.

6.2 Kaynaklar arasındaki farklar

- NIDA — kannabis kullanım bozukluğu ilkeleri.
- WHO mhGAP — birinci basamak düzeyinde değerlendirme.

6.3 Tanı algoritması

1. Klinik görüşme.
2. CUDIT-R (Cannabis Use Disorders Identification Test-Revised).
3. Toksikoloji tarama (idrar THC).
4. Komorbid psikoz, anksiyete, MDD.

6.4 Ayırıcı tanı

Durum	Ayırt edici
Sentetik kannabinoid bozukluğu (6C42)	Daha güçlü psikotik ve otonom etki.
Psikoz (kannabis indüksiyonlu veya primer)	Madde kesilmesinden sonra kalıntı durumuna bağlı.

Durum	Ayırt edici
Fonksiyonel GI (kannabis hyperemesis)	Kullanımın kesilmesiyle remisyon.

7. Muayene ve değerlendirme

- CUDIT-R.
- Toksikoloji.
- Komorbidite (psikoz, anksiyete, MDD).

8. Tedavi

1. Psikososyal müdahale birinci sıra — MI, BDT, koşullu ödül yönetimi. Kanıt: Davis M.L. et al. Eval Health Prof 2015 meta-analiz.
2. Spesifik FDA onaylı farmakoterapi yoktur. Off-label: N-asetilsistein (ergenlerde Gray K.M. Am J Psychiatry 2012 RKÇ pozitif — yalnızca koşullu ödül yönetimi platformunda; erişkinlerde Gray K.M. Drug Alcohol Depend 2017 RKÇ negatif), gabapentin.
3. Komorbid psikoz — antipsikotik; kannabisten uzak durma kritik.
4. Sentetik Kannabinoid İntoksikasyonu — destekleyici, gerektiğinde atipik antipsikotik.

8.1 Tedavi metodolojileri

1. BDT ve Motivasyonel Görüşme (MI) — Tetikleyicilerin kontrolü, motivasyon, davranış değişikliği.
2. Koşullu ödül yönetimi (Contingency Management) — Negatif toksikoloji testleri için ödül.
3. CUDIT-R — 8 maddelik tarama.
4. N-asetilsistein (NAC) — Ergenlerdeki erken pozitif sonuç tekrarlanmadı (Cochrane 2025 RR 1,17; %95 GA 0,73–1,88) — deneysel; off-label.

8.2 Kaynaklar arasındaki farklar

- NIDA — BDT ve koşullu ödül yönetimi birinci basamak.
- WHO mhGAP.

9. Prognoz

- Psikososyal müdahale ile anlamlı iyileşme.
- Erken kullanım başlangıcı — kötü prognoz.

10. Mit ve yanlış inançlar

Mit 1: “Kannabis 'doğal'dır, bağımlılık yapmaz”

Kanıt: CUD yaşam boyu %7–9 kullanıcılarda gelişir; ergenlerde %17.

Mit 2: “Kannabis yoksunluk sendromu yoktur”

Kanıt: DSM-5 (2013) — yoksunluk sendromu resmi kategori; irritabilite, uyku, iştah bozukluğu.

Mit 3: “Tıbbi kannabis psikoz riskini azaltır”

Kanıt: Marconi 2016 — THC psikoz riskini doza bağımlı olarak artırır: ortalama kullanımda yaklaşık 2 kat (OR 1,97), en ağır kullanıcılarda yaklaşık 4 kat (OR 3,90); CBD için ön kanıt, klinik öneri değil.

Mit 4: “Kannabis ‘gateway drug’ değildir”

Kanıt: “geçit” konsepti tartışmalıdır, ancak ardışık kullanım paterni istatistiksel olarak açıktır; nedensellik farklı açıklamalar.

Mit 5: “Yüksek THC'li kenevir normal kenevirden daha güvenlidir”

Kanıt: THC dozu psikoz, bağımlılık, bilişsel bozukluk riski ile doğru orantılıdır; son on yıllarda “potency creep” (güç artışı) gözlenmektedir.

Mit 6: “Sentetik kannabinoidler (‘Spice’) güvenlidir”

Kanıt: Sentetik kannabinoidler çok güçlü, öngörülemez; akut psikoz ve ölüm vakaları kaydedilmiştir.

11. Kaynaklar

1. WHO. ICD-11. 6C41 Disorders due to use of cannabis. 2024.
2. APA. DSM-5-TR. 2022.
3. NIDA. Research Report on Cannabis. 2020.
4. Davis M.L. et al. Behavioral therapies for treatment-seeking cannabis users: a meta-analysis of randomized controlled trials. Eval Health Prof 2015;38(1):94–114.
5. Gray K.M. et al. A randomized placebo-controlled trial of N-acetylcysteine for cannabis use disorder in adults. Drug Alcohol Depend 2017;177:249–257.
6. Marconi A. et al. Schizophr Bull 2016;42(5):1262–1269.

7. Spiga F., Parkhouse T., Tang V.M. et al. Pharmacotherapies for cannabis use disorder. Cochrane Database Syst Rev 2025;9(9):CD008940.

ICD-11 **6C44**	**6C44 SEDATİF, HİPNOTİK VEYA ANKSİYOLİTİKLERİN KULLANIMI NEDENLİ BOZUKLUKLAR** **Disorders due to use of sedatives, hypnotics or anxiolytics**
ICD-10 F13	Sedatif veya hipnotik kullanımına bağlı ruhsal ve davranışsal bozukluklar
DSM-5-TR F13.20	Sedatif, Hipnotik veya Anksiyolitik Kullanım Bozukluğu, Orta veya Ağır

1. Tanım ve nozoloji

Sedatif, hipnotik veya anksiyolitiklerin kullanımı nedenli bozukluklar (ICD-11: 6C44; DSM-5-TR: F13.20 Sedative, Hypnotic, or Anxiolytic Use Disorder) — benzodiazepinler, z-ilaçlar (zolpidem, zopiklon), barbitüratlar ve diğer anksiyolitiklerin kontrolünün bozulmuş kullanımı. Klinik pratikte sıklıkla tıbbi reçeteli başlangıç; "iyatrojenik bağımlılık" yoğunluğu.

2. Tarihçe

- 1960'lar — benzodiazepinlerin klinik uygulaması (chlordiazepoxide 1960, diazepam 1963).
- 1980'ler — uzun süreli kullanımın bağımlılık potansiyelinin tanınması.
- NICE ve APA — kısa süreli kullanım önerisi (2–4 hafta).

3. Epidemiyoloji

- Benzodiazepin uzun süreli kullanımı yaşlılarda %10–20; sorun tanımlaması az.
- Cinsiyet: kadınlarda yüksek resept.
- Komorbidite: alkol ve opioid kullanımı (tehlikeli kombinasyon — aşırı doz riski).

4. Etiyoloji ve patogenez

- İyatrojenik — uzun süreli reçeteler.
- GABA-A reseptör sistemine uyum — tolerans ve kesilme.
- Anksiyete, uyku bozukluğu hastalarında kendi kendine tedavi paterni.

5. Klinik özellikler

- Bağımlılık sendromu — kontrol kaybı, tolerans, yoksunluk.
- Entoksikasyon — sedasyon, ataksi, dizartri, disinhibisyon, anterograd amnezi.
- Overdoz — opioidlerle birlikte hayatı tehdit eden respiratuar depresyon.
- Kesilme — hayatı tehdit edici (alkol gibi): tremor, anksiyete, taşikardi, hipertansiyon; ağır vakalarda nöbetler ve DT-benzeri sendrom.

6. Tanı

6.1 Birleşik tanı ölçütleri

DSM-5-TR — 11 kriter (AUD yapısı). ICD-11, DSM-5-TR'nin tek ölçeğinden farklı olarak üç ayrı kategori kullanır: zararlı kullanım epizodu, zararlı kullanım örüntüsü ve bağımlılık. ICD-11 süre gerekliliği: zararlı kullanım örüntüsü — epizodik kullanımda en az 12 ay, sürekli kullanımda en az 1 ay; bağımlılık — en az 12 ay ya da sürekli (günlük veya neredeyse günlük) kullanımda en az 3 ay.

6.2 Kaynaklar arasındaki farklar

- NICE — benzodiazepin reçetesi 2–4 hafta; uzun süreli kullanım yeniden değerlendirilmelidir.
- Beers Criteria — yaşlılarda benzodiazepin kaçınma.

6.3 Tanı algoritması

1. Klinik görüşme + reçete geçmişi.
2. Toksikoloji tarama.
3. Komorbid alkol ve opioid kullanımı (özellikle aşırı doz riski).
4. Klinik muayene — yoksunluk belirtileri.

6.4 Ayırıcı tanı

Durum	Ayırt edici
Gerçek kaygı bozukluğu	Komorbid; madde kullanımı semptomatiktir.
Alkol kullanımı	Sıklıkla komorbid.
Opioid kullanımı	Komorbid; aşırı doz riski yüksek.

7. Muayene ve değerlendirme

- Toksikoloji tarama.
- Vital bulgular (kesilme).

8. Tedavi

1. Kademeli kesme (taper) altın standart: uzun etkili benzodiazepine (diazepam) eşdeğer doz dönüşümü, ardından haftada %10–25 azaltma; toplam 6–12 hafta (bazen aylar). Hızlı kesme hayatı tehdit edicidir.
2. Hospitalizasyon — ağır yoksunluk veya komorbid madde kullanımı.
3. Psikososyal müdahale — BDT anksiyete veya uyku bozukluğu için; bu farmakoterapi ihtiyacını azaltır.
4. Komorbid bozukluklar tedavisi (anksiyete, depresyon, uyku).
5. Reçete yönetimi — birinci basamak sağlık hizmeti düzeyinde.

8.1 Tedavi metodolojileri

1. Ashton Manual Taper — Diazepam eşdeğer dönüşümü, ardından kademeli azaltma; aile desteği.
2. BDT Anksiyete ve Uyku için — BZ kullanımına alternatif; uyku için CBT-I.
3. Toksikolojik İzlem — İdame döneminde.

8.2 Kaynaklar arasındaki farklar

- NICE, BNF — taper protokolleri.
- Ashton Manual — Heather Ashton (C.H. Ashton) tarafından pratik klinik rehber; 1999 baskısı, 2002'de güncellendi.

9. Prognoz

- Kademeli taper ve BDT ile anlamlı iyileşme.

- Yaşlılarda kesme hem tıbbi hem psikolojik olarak zordur.

10. Mit ve yanlış inançlar

Mit 1: "Benzodiazepinler ömür boyu güvenle alınabilir"

Kanıt: uzun süreli kullanım — tolerans, bağımlılık, bilişsel bozukluk, düşme riski (yaşlılarda). NICE — kısa süreli kullanım.

Mit 2: "Hızlı kesmek güvenlidir"

Kanıt: hızlı kesme nöbet ve ölüm riskli; kademeli azaltma kritik.

Mit 3: "Z-ilaçlar (zolpidem) bağımlılık yapmaz"

Kanıt: z-ilaçları da bağımlılık yapar; AAFP ve NICE kısa süreli kullanım önerir.

Mit 4: "Benzodiazepin + opioid güvenlidir"

Kanıt: FDA black box uyarısı — bu kombinasyon solunum depresyonu ve ölüm riskini önemli ölçüde artırır.

Mit 5: "Detoksifikasyon yeterlidir"

Kanıt: kesilmeden sonra alternatif tedavi (BDT, anksiyete yönetimi) gereklidir.

11. Kaynaklar

1. WHO. ICD-11. 6C44 Disorders due to sedative, hypnotic, anxiolytic. 2024.
2. APA. DSM-5-TR. 2022.
3. NICE Quick Reference Guide. Benzodiazepines.
4. Ashton C.H. Benzodiazepines: How They Work and How to Withdraw (Ashton Manual). 2002.
5. FDA Drug Safety Communication. Opioid pain or cough medicines combined with benzodiazepines: serious side effects. 2016.

ICD-11 **6C45**	**6C45 KOKAİN KULLANIMI NEDENLİ BOZUKLUKLAR** **Disorders due to use of cocaine**
ICD-10 F14	Kokain kullanımına bağlı ruhsal ve davranışsal bozukluklar
DSM-5-TR F14.20	Uyarıcı Kullanım Bozukluğu (Kokain), Orta derecede / Ağır

1. Tanım ve nozoloji

Kokain kullanımı nedenli bozukluklar (ICD-11: 6C45; DSM-5-TR: F14.20) — kokainin kontrolü bozulmuş kullanımı veya zarar yaratan kullanımı. İntoksikasyon, yoksunluk, zararlı kullanım paterni, bağımlılık, madde kaynaklı psikotik ve duygudurum bozukluklarını kapsar.

2. Tarihçe

- Koka yaprakları binlerce yıldır And Dağları'nda kullanılmaktadır.
- Niemann A. (1860) — kokain izolasyonu.
- Freud (1884) — "Über Coca" — sonradan klinik etkiyi eleştirmiştir.
- 1970–80'ler — "crack" salgını ABD'de.

3. Epidemiyoloji

- Dünyada yıllık kullanıcı 21 milyon (UNODC).
- Cinsiyet: erkeklerde 2 kat yüksek.
- Komorbidite: alkol, opioid, MDD, BPD, psikoz, kardiyovasküler mortalite.

4. Etiyoloji ve patogenez

- Kalıtım %40–50.
- Nörobiyolojik — dopamin geri alımının blokajı → mezolimbik ödül artışı; tolerans ve "down-regulation".
- Sosyo-kültürel — akran, erişilebilirlik, sosyo-ekonomik.

5. Klinik özellikler

- Bağımlılık sendromu (DSM-5-TR kriterleri).
- Entoksikasyon — öfori, hipervigilans, midriyazis, taşikardi, hipertansiyon, hipertermi; ağır vakada paranoid sanrı, halüsinasyon, ajitasyon, miyokard enfarktüsü, inme, nöbetler.
- Kesilme — "crash" — depresif duygudurum, anhedoni, yorgunluk, hipersomni, iştah artışı, yoğun cravings; intihar riski yüksek.

6. Tanı

6.1 Birleşik tanı ölçütleri

DSM-5-TR 11 kriter (AUD yapısı). ICD-11, DSM-5-TR'nin tek ölçeğinden farklı olarak üç ayrı kategori kullanır: zararlı kullanım epizodu, zararlı kullanım örüntüsü ve bağımlılık. ICD-11 süre gerekliliği: zararlı kullanım örüntüsü — epizodik kullanımda en az 12 ay, sürekli kullanımda en az 1 ay; bağımlılık — en az 12 ay ya da sürekli (günlük veya neredeyse günlük) kullanımda en az 3 ay.

6.2 Kaynaklar arasındaki farklar

- SAMHSA TIP 33 — uyarıcı kullanımı.

6.3 Tanı algoritması

1. Klinik görüşme + toksikolojik.
2. EKG, troponin (özellikle göğüs ağrısı).
3. HIV, HCV, sifilis.
4. Komorbidite ve intihar riski (kesilme döneminde yüksek).

6.4 Ayırıcı tanı

Durum	Ayırt edici
Amfetamin/stimülan (6C46)	Toksikolojik ayırım.
Manik epizod	Madde anamnezi ve zaman ilişkisi.
Psikoz (kokain indüksiyonlu veya primer)	Madde eliminasyonundan sonra remisyon.
Hipertireoid, feokromositoma	Endokrin testler.

7. Muayene ve değerlendirme

- Toksikoloji.
- EKG, troponin, kardiyak değerlendirme.
- HIV, HCV.
- C-SSRS.

8. Tedavi

1. Psikososyal — birinci sıra:
    - Koşullu ödül yönetimi — kanıt temeli en güçlü (Petry N.M. derlemeleri).
    - BDT;
    - MI;
    - Community Reinforcement Approach (CRA).
2. Farmakoterapi — spesifik FDA onaylı ilaç yoktur. Off-label çalışmalar — disulfiram, modafinil, topiramat — karışık sonuçlar.
3. Komorbidite tedavisi.
4. Akut intoksikasyon — benzodiazepin (lorazepam); kardiyak monitorizasyon; antipsikotik psikoz durumunda.

8.1 Tedavi metodolojileri

1. Koşullu ödül yönetimi (Contingency Management) — Petry (Petry N.M.), Higgins (Higgins S.) — Negatif toksikoloji testler için kupon/ödül; kanıt temeli kokain için en güçlü.
2. BDT ve Topluluk Güçlendirme Yaklaşımı (CRA — Community Reinforcement Approach) — Tetikleyicilerin kontrolü, alternatif ödül aktiviteleri.
3. MI — Davranış değişikliğine motivasyon.

8.2 Kaynaklar arasındaki farklar

- SAMHSA TIP 33 — koşullu ödül yönetimi altın standart.
- NIDA — kokaine spesifik farmakoterapi yoktur.

9. Prognoz

- Koşullu ödül yönetimi ile anlamlı iyileşme.
- Komorbid madde kullanımı ve psikiyatrik bozukluk kötü prognoz.

10. Mit ve yanlış inançlar

Mit 1: “Kokain ‘rekreasyonel’ bir maddedir, bağımlılık yapmaz”

Kanıt: kokain yüksek bağımlılık potansiyeline sahiptir; kardiyovasküler mortalite, psikoz, sosyal bozulma.

Mit 2: “Kokain için FDA onaylı tedavi mevcuttur”

Kanıt: henüz yok; psikososyal müdahale birinci sıra.

Mit 3: “Kokainin 'crash'i güvenlidir, tedavi gerektirmez”

Kanıt: kesilme döneminde intihar riski yüksek; aktif izlem gereklidir.

Mit 4: “Crack ve kokain tozu farklı bozukluklardır”

Kanıt: Aynı madde (kokain); uygulama yolu (smoked vs intranazal) farmakokinetik ve bağımlılık hızını değiştirir.

Mit 5: “Gebelikte ‘crack baby’ konsepti — çocuklarda kalıcı hasar”

Kanıt: Son derlemeler — prenatal kokain maruziyetinin uzun vadeli etkileri başlangıçta düşünülenden daha az; sosyoekonomik faktörler daha güçlü etki gösterir (Frank D.A. JAMA 2001 derlemesi).

11. Kaynaklar

1. WHO. ICD-11. 6C45 Disorders due to use of cocaine. 2024.
2. APA. DSM-5-TR. 2022.
3. SAMHSA. TIP 33: Treatment for Stimulant Use Disorders. 2021 update.
4. NIDA. Research Report: Cocaine. 2016.
5. Petry N.M., Alessi S.M., Olmstead T.A. Contingency management treatment for substance use disorders. Psychol Addict Behav 2017;31(8):897–906.
6. Frank D.A. et al. Growth, development, and behavior in early childhood following prenatal cocaine exposure. JAMA 2001;285(12):1613–1625.
7. Higgins S.T., Budney A.J., Bickel W.K. et al. Incentives improve outcome in outpatient behavioral treatment of cocaine dependence. Arch Gen Psychiatry 1994;51(7):568–576.

ICD-11 **6C46**	**6C46 AMFETAMİNLER, METAMFETAMİN VEYA METKATİNONU İÇEREN UYARICILARIN KULLANIMI NEDENLİ BOZUKLUKLAR** **Disorders due to use of stimulants including amphetamines, methamphetamine or methcathinone**
ICD-10 F15	Kafein ve diğer uyarıcıların kullanımına bağlı ruhsal ve davranışsal bozukluklar
DSM-5-TR F15.20	Uyarıcı Kullanım Bozukluğu (Amfetamin Tipi), Orta veya Ağır

1. Tanım ve nozoloji

Amfetaminler, metamfetamin veya metkatinonu içeren uyarıcıların kullanımı nedenli bozukluklar (ICD-11: 6C46; DSM-5-TR: F15.20 Stimulant Use Disorder) — amfetamin, metamfetamin, metkatinon ve diğer uyarıcıların kullanımı sonucu gelişen bozukluklar. Ayrıca kodlanır: kokain (6C45), mefedron dâhil sentetik katinonlar (6C47), kafein (6C48), MDA dâhil MDMA ve benzeri maddeler (6C4C).

2. Tarihçe

- Amfetamin ilk kez 1887'de Edeleano L. tarafından sentezlenmiştir; II. Dünya Savaşı'nda yaygın kullanım.
- 1950–60'lı yıllar — eczane reçetesi salgını.
- Metamfetamin epidemisi 1990'lı yıllardan.
- “Bath salts” (sentetik katinonlar) — 2010+ salgını. “Krokodil” (dezomorfin) bir opioiddir ve ICD-11'de ayrıca kodlanır (6C43).

3. Epidemiyoloji

- Dünya kullanıcı: amfetamin 30 milyon+ (UNODC).
- Cinsiyet: erkeklerde yüksek.

- Komorbidite: psikoz, MDD, anksiyete, kardiyovasküler, cilt lezyonları (kendini kaşıma, “meth mouth”).

4. Etiyoloji ve patogenez

- Kalıtım %40–50.
- Nörobiyolojik — dopamin ve noradrenalin salınımı ve geri alım blokajı; ağır nörotoksisite (özellikle metamfetamin — dopamin nöronlarına).

5. Klinik özellikler

- Entoksikasyon — öfori, hipervigilans, midriyazis, taşikardi, hipertansiyon, hipertermi; ağır vakada paranoid psikoz, ajitasyon, miyokard enfarktüsü, inme, nöbetler, rabdomiyoliz.
- Kesilme — “crash” — depresif duygudurum, anhedoni, yorgunluk, hipersomni, iştah, yoğun cravings; intihar riski yüksek.
- Kronik kullanım — psikoz (paranoid sanrılar, halüsinasyonlar), kognitif defisit, “meth mouth” (diş çürüklüğü), deri kaşıma.
- MDMA (6C4C) — hiponatremi, hipertermi, serotonin sendromu, nörotoksisite.

6. Tanı

6.1 Birleşik tanı ölçütleri

DSM-5-TR 11 kriter (AUD yapısı). ICD-11, DSM-5-TR’nin tek ölçeğinden farklı olarak üç ayrı kategori kullanır: zararlı kullanım epizodu, zararlı kullanım örüntüsü ve bağımlılık. ICD-11 süre gerekliliği: zararlı kullanım örüntüsü — epizodik kullanımda en az 12 ay, sürekli kullanımda en az 1 ay; bağımlılık — en az 12 ay ya da sürekli (günlük veya neredeyse günlük) kullanımda en az 3 ay.

6.2 Kaynaklar arasındaki farklar

- SAMHSA TIP 33 — uyarıcı kullanımı.
- NIDA — metamfetamin araştırma raporları.

6.3 Tanı algoritması

1. Klinik görüşme.
2. Toksikoloji.
3. EKG, troponin.
4. Komorbidite (psikoz, MDD, kardiyovasküler).

6.4 Ayırıcı tanı

Durum	Ayırt edici
Kokain (6C45)	Toksikoloji.
Manik epizod	Madde zaman bağlantısı.
Şizofreni	Madde eliminasyonundan sonra remisyon yok.
Hipertireoid, feokromositoma	Endokrin.

7. Muayene ve değerlendirme

- Toksikoloji.
- EKG, troponin, CPK (rabdomioliz).
- Diş ve cilt muayenesi.
- C-SSRS.

8. Tedavi

1. Psikososyal — birinci sıra:
    - Koşullu ödül yönetimi;
    - BDT;
    - MI;
    - Matrix Model — amfetamin bağımlılığı için manuelize edilmiş kompleks program.
2. Farmakoterapi — spesifik FDA onaylı ilaç yoktur; off-label: mirtazapin, naltrekson + bupropion (Trivedi M.H. NEJM 2021 — ADAPT-2 çalışması metamfetamin için kombinasyon — mütevazı etki).
3. Akut intoksikasyon — benzodiazepin ajitasyon için; antipsikotik psikozda.
4. Komorbid psikoz — paralel tedavi.

8.1 Tedavi metodolojileri

1. Matriks Modeli (Matrix Model) — 16 haftalık yapılandırılmış program — BDT + aile + 12-step + tek hekim. Kanıt temeli amfetamin/metamfetamin için.
2. Koşullu ödül yönetimi (Contingency Management) — Negatif test için ödül.
3. Naltrekson + Bupropion (ADAPT-2) — Metamfetamin bağımlılığında ilk RKÇ kanıtı; off-label.

8.2 Kaynaklar arasındaki farklar

- SAMHSA TIP 33.
- NIDA.
- Trivedi M.H. et al. NEJM 2021 — naltrekson + bupropion metamfetamin bağımlılığında ilk kanıt temeli.

9. Prognoz

- Multimodal yaklaşımla remisyon %30–50.
- Komorbid psikoz kötü prognoz.

10. Mit ve yanlış inançlar

Mit 1: “Metamfetamin 'Spice'dan veya başka 'designer drug'lardan daha güvenlidir”

Kanıt: metamfetamin yüksek nörotoksisite, psikoz, mortalite yaratır.

Mit 2: “MDMA ‘temiz’ madde olarak güvenlidir”

Kanıt: MDMA için hipertermi, hiponatremi, serotonin sendromu; “saf” madde tipik olarak karışıktır (sentetik katinonlar, fentanil).

Mit 3: “Detoksifikasyon uyarıcı bağımlılığı için yeterlidir”

Kanıt: koşullu ödül yönetimi ve BDT temel; tek başına detoks %90+ nüks.

Mit 4: “Antidepresan uyarıcı bağımlılığını iyileştirir”

Kanıt: tek antidepresan etkisiz; ADAPT-2 ilk kanıt kombinasyon için gösteriyor.

Mit 5: “Stimülan kullanıcıları ‘üretkendir’, müdahale gerektirmez”

Kanıt: kısa süreli performans artışı görüntüsü; uzun vadeli kognitif, psikiyatrik, kardiyak komplikasyonlar.

11. Kaynaklar

1. WHO. ICD-11. 6C46 Disorders due to use of stimulants. 2024.
2. APA. DSM-5-TR. 2022.
3. SAMHSA. TIP 33. 2021.
4. NIDA. Methamphetamine Research Report. 2019.
5. Trivedi M.H. et al. Bupropion and Naltrexone in Methamphetamine Use Disorder. NEJM 2021;384(2):140–153.

6. Rawson R.A. et al. Matrix Model. SAMHSA.

ICD-11 **6C49**	**6C49** **HALÜSİNOJENLERİN KULLANIMI NEDENLİ BOZUKLUKLAR** **Disorders due to use of hallucinogens**
ICD-10 F16	Halüsinojen kullanımına bağlı ruhsal ve davranışsal bozukluklar
DSM-5-TR F16.20	Diğer Halüsinojen Kullanım Bozukluğu, Orta veya Ağır

1. Tanım ve nozoloji

Halüsinojenlerin kullanımı nedenli bozukluklar (ICD-11: 6C49; DSM-5-TR: F16.20 Hallucinogen Use Disorder) — LSD, psilosibin, meskalin, DMT, ayahuasca ve benzer maddelerin kullanımı ile ilişkili bozukluklar. Disosiyatif maddeler — ketamin ve fensiklidin (PCP) — ICD-11'de ayrıca kodlanır (6C4D).

2. Tarihçe

- Hofmann A. (1943) — LSD'nin halüsinojenik etkisinin tesadüfi keşfi.
- 1950–60'lı yıllar — klinik araştırmalar (depresyon, şizofreni).
- 1970 — Controlled Substances Act ABD'de Schedule I.
- 2020+ — psilosibin ve ketamin “psikedelik terapi” araştırma rönesansı.

3. Epidemiyoloji

- Bağımlılık nispeten nadir (diğer maddelerden farklı); tipik kullanım epizodik.
- Hallucinogen Persisting Perception Disorder (HPPD) — flashback-benzeri deneyimler.

4. Etiyoloji ve patogenez

- Serotonerjik (5-HT2A) veya NMDA (ketamin, PCP) reseptörlerine etki.
- Çevre, akran, deneyimleme.

5. Klinik özellikler

- Entoksikasyon — görsel halüsinasyonlar, sinestezi, zaman bozukluğu, depersonalizasyon, derealizasyon, “bad trip” (panik, paranoya).
- Ağır olguda — psikoz, ölümcül kazalar.
- “Persisting Perception Disorder” (HPPD) — kullanım sonrası devam eden görsel fenomenler (flashback).
- Ketamin — dissosiyasyon, “K-hole”; kronik kullanım — mesane sendromu.
- PCP — agresif davranış, analjezi, dezorganize davranış.

6. Tanı

6.1 Birleşik tanı ölçütleri

DSM-5-TR 11 kriter; HPPD ayrı tanı (DSM-5). ICD-11, DSM-5-TR’nin tek ölçeğinden farklı olarak üç ayrı kategori kullanır: zararlı kullanım epizodu, zararlı kullanım örüntüsü ve bağımlılık. ICD-11 süre gerekliliği: zararlı kullanım örüntüsü — epizodik kullanımda en az 12 ay, sürekli kullanımda en az 1 ay; bağımlılık — en az 12 ay ya da sürekli (günlük veya neredeyse günlük) kullanımda en az 3 ay.

6.2 Kaynaklar arasındaki farklar

- NIDA, SAMHSA.

6.3 Tanı algoritması

1. Klinik görüşme.
2. Toksikolojik (LSD standart panellerde yok).
3. Komorbid psikoz, anksiyete, MDD.

6.4 Ayırıcı tanı

Durum	**Ayırt edici**
Şizofreni	Sürekli belirtiler.
Depersonalizasyon-Derealizasyon Bozukluğu (6B66)	Gerçeklik testi korunur.
Nöbet	EEG.

7. Muayene ve değerlendirme

- Toksikoloji.

- Komorbidite ölçekleri.

8. Tedavi

1. Akut intoksikasyon (“bad trip”) — sakin ortam, benzodiazepin (lorazepam); antipsikotik (haloperidol) yalnızca ağır psikotik durumda; dikkatli olun.
2. Bağımlılık nadir; psikososyal müdahale (MI, BDT).
3. HPPD — antipsikotik genellikle etkisiz; klonazepam bazı hastalarda yardımcı; uzun süreli izlem.
4. Psilosibin ve ketamin terapötik araştırmaları (refrakter MDD, TSSB) — araştırma protokollerinde kontrol altında kullanım; standart klinik pratikte henüz onaylanmış protokoller sınırlıdır (FDA esketamin Spravato hariç).

8.1 Tedavi metodolojileri

1. “Bad trip” (kötü deneyim) yönetimi — Sakin ortam, güvence verme, gerektiğinde benzodiazepin.
2. HPPD için klonazepam — Off-label; kanıt temeli küçük.
3. Psikedelik-destekli terapi (Psychedelic-assisted therapy — araştırma aşamasında) — Psilosibin + psikoterapi, ketamin + psikoterapi; klinik araştırma protokollerinde.

8.2 Kaynaklar arasındaki farklar

- NIDA — psikedelik araştırma rönesansı; klinik öneri için henüz erken.

9. Prognoz

- Çoğu kullanıcıda bağımlılık gelişmez.
- Ağır psikotik veya HPPD komplikasyonlu hastalarda kronik seyir.

10. Mit ve yanlış inançlar

Mit 1: “Halüsinojenler bağımlılık yapmaz, tamamen güvenlidir”

Kanıt: Fiziksel bağımlılık nadir, ancak psikolojik bağımlılık ve ağır psikotik epizodlar mümkündür; HPPD uzun vadeli komplikasyon.

Mit 2: “Psilocybin terapisi tüm depresyon için onaylanmıştır”

Kanıt: henüz araştırma aşamasındadır; standart klinik pratiğe tam olarak onaylanmamıştır. FDA “Breakthrough Therapy” statüsünde, ancak geniş öneri henüz erken.

Mit 3: “Ayahuasca dini ritüel için güvenlidir”

Kanıt: Serotonin sendromu (SSRI ile etkileşim), psikotik dekompansasyon vakaları bildirilmiştir.

Mit 4: “Ketamin 'club drug'dur, tıbbi kullanımı yoktur”

Kanıt: Ketamin anestezik olarak on yıllardır kullanılmaktadır; intranazal esketamin (Spravato) FDA 2019 ağır refrakter depresyon için onaylanmıştır.

Mit 5: “LSD ‘flashback’ efsanedir”

Kanıt: HPPD DSM-5 resmi tanı; bazı hastalarda kalıcı görsel bozukluklar.

11. Kaynaklar

1. WHO. ICD-11. 6C49 Disorders due to use of hallucinogens. 2024.
2. APA. DSM-5-TR. 2022.
3. NIDA. Hallucinogens DrugFacts. 2019.
4. Halpern J.H., Lerner A.G., Passie T. A review of Hallucinogen Persisting Perception Disorder (HPPD). Curr Top Behav Neurosci 2018;36:333–360.
5. Carhart-Harris R.L. et al. Trial of psilocybin versus escitalopram for depression. NEJM 2021;384(15):1402–1411.

ICD-11 **6C4A**	**6C4A NİKOTİN KULLANIMI NEDENLİ BOZUKLUKLAR** **Disorders due to use of nicotine**
ICD-10 F17	Tütün kullanımına bağlı ruhsal ve davranışsal bozukluklar
DSM-5-TR F17.200	Tütün Kullanım Bozukluğu, Orta derecede / Ağır

1. Tanım ve nozoloji

Nikotin kullanımı nedenli bozukluklar (ICD-11: 6C4A; DSM-5-TR: F17.200 Tobacco Use Disorder) — sigara, tütün ürünleri, e-sigara veya diğer nikotin maddelerinin kontrolünün bozulmuş kullanımı. Dünyada önlenebilir ölümlerin başlıca nedenidir.

2. Tarihçe

- 1964 — Surgeon General Report (ABD) — tütünün hastalık nedeni olarak tanınması.
- DSM-IV — Nicotine Dependence; DSM-5 — Tobacco Use Disorder.
- 2003 — WHO FCTC (Framework Convention on Tobacco Control).
- 2010+ — e-sigara salgını, "EVALI" (e-sigara/vaping ürünü kullanımına bağlı akciğer hasarı).

3. Epidemiyoloji

- Dünya: 1,3 milyar kullanıcı; yıllık 8 milyon+ ölüm (WHO).
- Cinsiyet: erkeklerde yüksek (ancak azalmaktadır); kadınlarda artış gözlenir bazı bölgelerde.
- Komorbidite: MDD, şizofreni (~%60–80 hasta sigara içiyor), anksiyete, diğer madde kullanımı.
- Tütün — kanser, KOAH, kardiyovasküler, inme, perinatal komplikasyonlar.

4. Etiyoloji ve patogenez

- Kalıtım %50.
- Nörobiyolojik — nikotin α4β2 nikotinik asetilkolin reseptörlerine; dopamin ödül artışı.
- Sosyo-kültürel, akran, pazarlama.

5. Klinik özellikler

- Bağımlılık sendromu.
- Kesilme — irritabilite, anksiyete, konsantrasyon güçlüğü, iştah, uyku bozukluğu, depresif duygudurum; 24 saatte başlar, pik 2–3 gün, 2–4 hafta sürer.
- E-sigara — nikotin bağımlılığı + EVALI riski.

6. Tanı

6.1 Birleşik tanı ölçütleri

DSM-5-TR 11 kriter (AUD yapısı). ICD-11, DSM-5-TR'nin tek ölçeğinden farklı olarak üç ayrı kategori kullanır: zararlı kullanım epizodu, zararlı kullanım örüntüsü ve bağımlılık. ICD-11 süre gerekliliği: zararlı kullanım örüntüsü — epizodik

kullanımda en az 12 ay, sürekli kullanımda en az 1 ay; bağımlılık — en az 12 ay ya da sürekli (günlük veya neredeyse günlük) kullanımda en az 3 ay.

6.2 Kaynaklar arasındaki farklar

- USPSTF — tüm yetişkin hastaların tütün kullanımı taranması; sigara içenlere 5A (Ask, Advise, Assess, Assist, Arrange) yaklaşımı.
- NICE NG209 (Tobacco: preventing uptake, promoting quitting and treating dependence, 2021).

6.3 Tanı algoritması

1. Klinik görüşme (5A).
2. Fagerström Nikotin Bağımlılığı Testi (FTND).
3. CO ekspiratuvar izlem (motivasyon).
4. Komorbid kardiyak ve respiratuar değerlendirme.

6.4 Ayırıcı tanı

Çok sayıda tütün ürünü arasında farklılaşma; e-sigara nikotin bağımlılığı çok sayıda kapta sunulabilir.

7. Muayene ve değerlendirme

- FTND.
- CO ekspirator.
- Spirometri (KOAH taraması).

8. Tedavi

8.1 Genel Prensipler (USPSTF · NICE NG209 · APA 2010)

1. 5A modeli (Ask, Advise, Assess, Assist, Arrange).
2. Birinci basamak farmakoterapi:
    - NRT — Nikotin Replasman Tedavisi (yama, çiğneme tableti, pastil, inhaler, sprey) — kombinasyon (uzun + kısa etkili) monoterapiden üstün.
    - Vareniklin (Chantix) — α4β2 parsiyel agonist; en etkili tek ilaç (Cahill K. Cochrane 2013 meta-analiz).
    - Bupropion SR (Zyban) — dopaminerjik ve noradrenerjik etki.
3. Davranış müdahalesi — BDT, MI, telefon “quitline” hizmeti; yoğunluk etkiyi artırır.

4. Kombinasyon — farmakoterapi + davranış terapisi üstündür.
5. E-sigara tütün bırakma aracı olarak tartışmalı — bazı çalışmalarda etkili (Hajek P. NEJM 2019), ancak uzun vadeli güvenliği ve "gateway" riski araştırılıyor; NRT tercih edilir.
6. Komorbidite (MDD, şizofreni) — tütün bırakma psikiyatrik durumu kötüleştirmez, aksine iyileştirir (Taylor G. BMJ 2014 meta-analiz).

8.2 Tedavi metodolojileri

1. 5A Modeli (Ask, Advise, Assess, Assist, Arrange) — Ask (soru), Advise (tavsiye et), Assess (değerlendir), Assist (yardım et), Arrange (izlem düzenle).
2. Nikotin Yerine Koyma Tedavisi Kombinasyonu (NRT — Nicotine Replacement Therapy) — Uzun etkili yama + kısa etkili (çiğneme, lozenge) "rescue".
3. Vareniklin — 1 mg × 2/gün; 12 hafta standart.
4. Bupropion SR — 150 mg × 2/gün; nöbet riski.
5. BDT ve Motivasyonel Görüşme (MI) — Tetikleyicilerin kontrolü, motivasyon artışı.
6. Telefon Destek Hattı (Quitline) — Toplum temelli destek; kanıt temeli geniş.

8.3 Kaynaklar arasındaki farklar

- USPSTF 2021 — tüm sigara içenlere müdahale önerisi.
- NICE NG209 — komorbid psikiyatrik bozukluklarda da aktif müdahale.
- Cahill K. et al. Cochrane 2013 — vareniklin en etkili.

9. Prognoz

- Multimodal müdahale ile 6 aylık abstinans %25–35.
- Bırakma başarılı olursa mortalite ve hastalık riski anlamlı şekilde azalır.

10. Mit ve yanlış inançlar

Mit 1: "Tütün bağımlılık yapmaz, iradeyle bırakılabilir"

Kanıt: nikotin yüksek bağımlılık potansiyeline sahiptir; iradi bırakma başarısızlık oranı yüksek (üç ay sonra ~%5); farmakoterapi etkiyi 2–3 kat artırır.

Mit 2: "Sigara bırakıldığında kilo alımı sağlığa zararlıdır"

Kanıt: ortalama 4–5 kg kilo artışı, ancak tütünü sürdürmenin riski anlamlı yüksektir; kilo yönetilebilir.

Mit 3: "Vareniklin intihar riski yaratır"

Kanıt: ilk FDA uyarısı sonradan EAGLES trial (Anthenelli R.M. Lancet 2016) ile yeniden değerlendirildi — psikiyatrik yan etki oranı plasebodan anlamlı yüksek değil; FDA boxed warning 2016'da kaldırılmıştır.

Mit 4: "Psikiyatrik hasta tütünden vazgeçemez, vazgeçmemelidir"

Kanıt: Taylor BMJ 2014 — sigarayı bırakma psikiyatrik semptomları iyileştirir; şizofreni, MDD hastalarında bırakma etkilidir.

Mit 5: "E-sigara tütünden güvenlidir"

Kanıt: mevcut kanıtlarda e-sigara yanmış tütünden az zararlıdır, ancak "güvenli" değildir; EVALI, kardiyak, respiratuar riskleri; ergenlerde nikotin bağımlılığına gateway.

Mit 6: "Bir kere 'kesip geri getirmek' yasak"

Kanıt: Çoğu sigara içen bırakmak için 6-11 deneme yapar; her nüks geçicidir ve devam eden deneme planı önerilir.

11. Kaynaklar

1. WHO. ICD-11. 6C4A Disorders due to use of nicotine. 2024.
2. APA. DSM-5-TR. 2022.
3. USPSTF. Interventions for tobacco smoking cessation in adults. JAMA 2021;325(3):265–279.
4. NICE NG209. Tobacco. 2021.
5. Cahill K., Stevens S., Perera R., Lancaster T. Pharmacological interventions for smoking cessation: an overview and network meta-analysis. Cochrane Database Syst Rev 2013;(5):CD009329.
6. Anthenelli R.M. et al. Neuropsychiatric safety and efficacy of varenicline, bupropion, and nicotine patch in smokers with and without psychiatric disorders (EAGLES). Lancet 2016;387(10037):2507–2520.
7. Taylor G. ve ark. Change in mental health after smoking cessation: systematic review and meta-analysis. BMJ 2014;348:g1151.
8. Hajek P. et al. A randomized trial of e-cigarettes versus nicotine-replacement therapy. NEJM 2019;380(7):629–637.

ICD-11 **6C50**	**6C50 KUMAR OYNAMA BOZUKLUĞU** **Gambling disorder**
ICD-10 F63.0	Patolojik kumar oynama
DSM-5-TR F63.0	Kumar Oynama Bozukluğu

1. Tanım ve nozoloji

Kumar oynama bozukluğu (ICD-11: 6C50; ICD-10: F63.0; DSM-5-TR: F63.0) — kontrol kaybı, kumarın diğer ilgi alanlarının önüne geçmesi ve olumsuz sonuçlara rağmen sürdürülmesi ile belirli, sürekli ya da yineleyici kumar davranışı paternidir. Önemli işlevsel bozulma yaratır. Oyun oynama bozukluğu ICD-11'de ayrı bir kategoridir — 6C51.

2. Tarihçe

- DSM-IV (1994) — "Pathological Gambling" dürtü kontrol bozuklukları içinde.
- DSM-5 (2013) — "Gambling Disorder" madde kullanımı ve bağımlılık kategorisine taşınmıştır (benzer nörobiyoloji).
- ICD-11 (2019) — davranışsal bağımlılıklar bölümü genişletildi: kumarın (6C50) yanı sıra oyun oynama bozukluğu (6C51) ayrı bir kategori olarak eklendi.

3. Epidemiyoloji

- Gambling Disorder yaşam boyu yaygınlık: %0,2–5,3 (geniş aralık).
- Cinsiyet: kumar erkeklerde yüksek; çevrimiçi kumarda cinsiyet farkı azalır.
- Komorbidite: MDD, anksiyete, diğer madde kullanımı, DEHB, BPD, intihar riski.

4. Etiyoloji ve patogenez

- Kalıtım %50–60.

- Nörobiyolojik — ödül devresinin (dopamin) disregülasyonu, madde kullanım bozukluklarına benzer.
- Kişilik — dürtüsellik, heyecan arayışı.

5. Klinik özellikler

- Sürekli/tekrarlayan kumar davranışı.
- Kontrol itkisi.
- İş, aile, sosyal, akademik bozulma.
- "Chasing losses" (kumarda) — kayıpları geri kazanma girişimleri.
- Yalan, mali bozulma, gizleme davranışı.
- Komorbid MDD ve yüksek intihar riski.

6. Tanı

6.1 Birleşik tanı ölçütleri

Gambling (DSM-5-TR): 9 semptomdan ≥ 4'ü 12 ay içinde:

1. Artan miktarda kumar — tolerans
2. İrritabilite veya anksiyete kumarı azalttığında — yoksunluk;
3. Azaltma girişimleri başarısız;
4. Kumar hakkında meşguliyet;
5. Distress halinde kumar;
6. Kayıp sonrası "chasing";
7. Yalan;
8. İlişki/iş kaybı;
9. Mali kurtarma bağımlılığı.

6.2 Kaynaklar arasındaki farklar

- ICD-11 (6C50) — alt tipler: 6C50.0 ağırlıklı çevrimdışı, 6C50.1 ağırlıklı çevrimiçi, 6C50.Z belirlenmemiş. Tanı için normalde ≥ 12 ay gerekir; tüm tanı ölçütleri karşılanıyor ve belirtiler ağırsa süre kısaltılabilir.
- DSM-5-TR — "Gambling Disorder" (F63.0) ana metinde yer alan tek davranışsal bağımlılıktır; DSM-5 (2013) bunu dürtü kontrol bozukluklarından madde kullanımı ve bağımlılık kategorisine taşımıştır. 6C51'den farklı olarak 6C50 ölçütleri, işlevsel bozulmanın yanı sıra belirgin sıkıntıyı da kabul eder.

6.3 Tanı algoritması

1. Klinik görüşme.
2. SOGS (South Oaks Gambling Screen) veya PGSI (Problem Gambling Severity Index)
3. Komorbid madde, MDD, intihar.
4. Mali durum değerlendirmesi.

6.4 Ayırıcı tanı

Durum	**Ayırt edici**
Manik epizod (kumar disinhibisyonu)	Afektif semptomlar.
OKB (kompulsif kontrol)	Obsesyon temel.
BPD (impulsivite)	Sürekli model tüm alanlara.
Sosyal kumar (sorun yok)	Fonksiyonel bozulma yok.

7. Muayene ve değerlendirme

- Komorbidite ölçekleri.
- C-SSRS intihar.

8. Tedavi

1. BDT — birinci basamak; tetikleyicilerin yönetimi, davranışsal aktivasyon, bilişsel yeniden yapılandırma (“near miss” ve 'gambler's fallacy'). Cowlishaw S. Cochrane 2012 meta-analizi.
2. Naltrekson, nalmefen — kanıt tabanı gelişmekte (Grant J.E. derlemeleri).
3. SSRI — komorbid MDD/anksiyetede.
4. Kendi kendine yardım (Kumarbazlar Anonim, Gam-Anon) — adjuvan.
5. Mali danışmanlık — kumarda kritik.

8.1 Tedavi metodolojileri

1. Kumar için BDT — Bilişsel çarpıtmaların düzeltilmesi, maruz bırakma (tetikleyicilere yanıt azaltma), problem-çözme.
2. Naltrekson off-label — Craving azaltma; 50–150 mg/gün.
3. Kendi kendine yardım grupları (GA) — 12-step model.

9. Prognoz

- BDT ile remisyon %30–50.
- Komorbid MDD kötü prognoz.

10. Mit ve yanlış inançlar

Mit 1: "Kumar bağımlılığı 'karakter' bozukluğudur"

Kanıt: DSM-5, ICD-11 — tıbbi/davranışsal bozukluktur; nörobiyolojik ve genetik yatkınlık.

Mit 2: "Hasta 'büyük kazanç' ile borçtan kurtulur"

Kanıt: "kayıpları kovalama" kumarın tanısal belirtisidir; kayıp paterni istatistiksel olarak mutlaktır.

Mit 3: "Yalnızca mali destek yeterlidir"

Kanıt: bailout'a bağımlılık tanısal bir belirtidir; psikososyal müdahale gereklidir.

Mit 4: "Hasta 'büyüyünce geçer'"

Kanıt: aktif müdahale gereklidir; kronikleşme.

11. Kaynaklar

1. WHO. ICD-11. 6C50 Gambling disorder. 2024.
2. APA. DSM-5-TR. 2022.
3. Cowlishaw S. et al. Psychological therapies for pathological and problem gambling. Cochrane Database Syst Rev 2012;(11):CD008937.
4. Grant J.E. et al. Pharmacotherapy for gambling disorder. Curr Top Behav Neurosci 2016;26:135–149.

ICD-11 **6C51**	**6C51 OYUN OYNAMA BOZUKLUĞU** **Gaming disorder**
ICD-10 —	ICD-10'da karşılığı yoktur
DSM-5-TR —	İnternet Oyun Oynama Bozukluğu (Bölüm III, ileri araştırma için)

1. Tanım ve nozoloji

Oyun oynama bozukluğu (ICD-11 kodu 6C51), World Health Organization tarafından, çevrim içi ya da çevrim dışı dijital oyun veya video oyunu oynama biçimindeki sürekli ya da yineleyici oyun oynama davranışı paterni olarak tanımlanır ve üç temel özellikle kendini gösterir:

- oyun oynama üzerindeki kontrolün bozulması (başlama, sıklık, yoğunluk, süre, sonlandırma, bağlam);
- oyun oynamaya giderek artan öncelik verilmesi, öyle ki oyun diğer yaşam ilgi alanlarının ve günlük etkinliklerin önüne geçer;
- olumsuz sonuçların ortaya çıkmasına rağmen oyun oynamanın sürdürülmesi ya da artırılması.

Davranış paterni; kişisel, ailevi, sosyal, eğitsel, mesleki veya diğer önemli işlevsellik alanlarında belirgin bozulmaya yol açacak ağırlıkta olmalıdır. Dikkat: ICD-11'de 6C51 için bir sıkıntı ölçütü yoktur. İşlevsel bozulma zorunlu ögedir; tanıya alternatif bir giriş yolu olarak "belirgin sıkıntı"nın eklenmesi, kategoriye eşiğini veren özelliği ortadan kaldırırdı. Patern normalde en az 12 aylık bir süre boyunca belirgindir; ancak tüm tanı gereklilikleri karşılanıyorsa ve semptomlar ağırsa gerekli süre kısaltılabilir.

Nozolojik konum

6C51, ICD-11'in "Bağımlılık yapıcı davranışlara bağlı bozukluklar" (6C50–6C5Z) grubunda, 6C50 Kumar oynama bozukluğu ile birlikte yer alır. ICD-11'de kendine ait kategorisi bulunan yalnızca bu iki davranışsal bağımlılık vardır; aday diğer durumlar için 6C5Y (diğer belirtilmiş) ve 6C5Z (belirtilmemiş) artık kodları mevcuttur. ICD-11, 25 Mayıs 2019'da 72. Dünya Sağlık Asamblesi tarafından oybirliğiyle kabul edilmiş ve 1 Ocak 2022'de yürürlüğe girmiştir.

Alt tipler ve dışlamalar

- 6C51.0 — Oyun oynama bozukluğu, ağırlıklı olarak çevrim içi.
- 6C51.1 — Oyun oynama bozukluğu, ağırlıklı olarak çevrim dışı.
- 6C51.Z — Oyun oynama bozukluğu, belirtilmemiş.

6C51 altında listelenen dışlamalar Riskli oyun oynama (QE22), Bipolar tip I bozukluğu (6A60) ve Bipolar tip II bozukluğudur (6A61). Bu nedenle yalnızca bir manik ya da hipomanik epizod içinde ortaya çıkan aşırı oyun oynama 6C51 olarak kodlanmaz.

Eşik altı kategori QE22

ICD-11'in sağlık durumunu etkileyen etkenlere ayrılmış bölümünde yer alan QE22 Riskli oyun oynama; çevrim içi ya da çevrim dışı, kişinin kendisi ya da çevresindekiler için zararlı fiziksel veya ruhsal sağlık sonuçları riskini kayda değer ölçüde artıran, ancak oyun oynama bozukluğunun tanı gerekliliklerini karşılamayan bir oyun oynama paternini belirtir. Tam da mesleki ilgi ve öneri gerektiren bir paternin bir bozukluk tanısına zorlanmak zorunda kalmaması için vardır.

American Psychiatric Association oyun oynamayı resmi bir bozukluk olarak tanımamıştır: internette oyun oynama bozukluğu (IGD) DSM-5-TR'nin III. Bölümünde, "İleri Araştırma Gerektiren Durumlar" içinde kalmaktadır; iki ölçüt seti bu bölümün 6. kısmında tanımlanıp karşılaştırılmaktadır.

2. Tarihçe

Ön tarih: internet bağımlılığı (1990'lar)

Kavramsal öncül, DSM-IV'ün patolojik kumar oynama ölçütlerini internet kullanımına uyarlayan Young tarafından klinik bir antite olarak önerilen "internet bağımlılığı" idi (Young, 1998). 1990'lar ve 2000'ler boyunca oyun oynama esas olarak bu daha geniş internet bağımlılığı çerçevesi içinde incelendi — sonradan başlıca ölçüm hatası kaynaklarından biri olarak tanımlanan ve bugün hâlâ oyun oynama bozukluğuna ilişkin sistematik derlemeleri kirleten bir iç içe geçirme (Kuss ve ark., 2017; Colder Carras ve ark., 2020).

2013 — DSM-5

APA, internette oyun oynama bozukluğunu daha ileri araştırma gerektiren bir durum olarak DSM-5'in III. Bölümüne yerleştirdi ve bunu resmi bir tanı hâline getirmeyi açıkça reddetti. Bu statü 2022'de DSM-5-TR'ye değişmeden aktarıldı.

2014–2017 — WHO danışma toplantıları

WHO; internetin, bilgisayarların, akıllı telefonların ve benzeri cihazların aşırı kullanımının halk sağlığı açısından sonuçları ile davranışsal bağımlılıklar üzerine bir dizi uzman toplantısı düzenledi. ICD-11 metnini biçimlendiren çalışma grubu çıktısı, oyun oynama bozukluğunun bağımlılık yapıcı bir bozukluktan beklenen temel özellikleri taşıdığını ve halihazırda tedaviye başvuran kişiler için bir tanı kategorisinin gerekli olduğunu savundu (Saunders ve ark., 2017).

2016–2018 — bilimsel tartışma

ICD-11 kesinleşmeden önce 26 akademisyen, dahil edilmeye karşı çıkan açık bir tartışma makalesi yayımlayarak araştırma kalitesinin düşüklüğü, madde kullanımı ve kumar ölçütlerinden eleştirisiz ödünç alma, ahlaki panik ve sağlıklı oyuncuların zarar görmesi konusunda uyardı (Aarseth ve ark., 2017). Kısmen örtüşen bir grup, araştırma yapısından resmi bir bozukluğa geçiş için gereken kanıt yükünün karşılanmadığı savıyla bunu izledi (van Rooij ve ark., 2018). Klinisyenler ve halk sağlığı araştırmacıları aynı dergide dahil edilmeyi savunan yanıtlar verdi (Griffiths ve ark., 2017; Rumpf ve ark., 2018). Bu tartışmanın özü 10. kısımda ortaya konmaktadır.

2018–2019 — resmi olarak dahil edilme

6C51'i içeren ICD-11 taslağı Haziran 2018'de yayımlandı; sınıflandırma 25 Mayıs 2019'da 72. Dünya Sağlık Asamblesi tarafından kabul edildi ve 1 Ocak 2022'de yürürlüğe girdi. WHO 2024'te, ICD-11 ruhsal, davranışsal ve nörogelişimsel bozukluklar için Klinik Tanımlamalar ve Tanı Gerekliliklerini (CDDR) — klinisyenlerin bugün MMS kaydının yanı sıra kullandığı işlevsel rehberi — yayımladı.

Politika bağlamı (klinik olmayan kaynaklar)

Aşağıdakiler hükümet ve basın duyurularıdır, klinik kanıt değildir; klinik etkilerine ilişkin yüksek kaliteli bir değerlendirme saptanmamıştır.

- Güney Kore. Kapatma yasası (reşit olmayanlar için gece saatlerinde oyun yasağı) 19 Mayıs 2011'de kabul edildi ve 20 Kasım 2011'de yürürlüğe girdi. Hükümet 25 Ağustos 2021'de yasanın kaldırılacağını duyurdu; ilga aynı yıl içinde yasalaştı ve yasak 1 Ocak 2022'den itibaren sona erdi.
- Çin. Ulusal Basın ve Yayın İdaresinin 30 Ağustos 2021 tarihli bildirimine göre 18 yaş altındaki kullanıcılar çevrim içi oyunları yalnızca cuma günleri, hafta sonları ve resmi tatillerde 20:00 ile 21:00 arasında oynayabilir — sıradan bir haftada yaklaşık üç saat.
- İngiltere ve Galler. NHS National Centre for Gaming Disorders Ekim 2019'da Londra'da açıldı.

3. Epidemiyoloji

Birleştirilmiş yaygınlık

İki büyük meta-analiz, yöntemsel kalite hesaba katıldığında belirgin biçimde düşen, yaklaşık %3'lük küresel bir değerde birleşmektedir.

Kaynak	Temel	Tahmin
Stevens ve ark., 2021	Dünya geneli birleştirilmiş	%3,05 (%95 GA 2,38–3,91)
Stevens ve ark., 2021	Katı örnekleme ölçütlerini karşılayan çalışmalar	%1,96 (%95 GA 0,19–17,12)
Kim ve ark., 2022	61 çalışma, 227.665 katılımcı, 29 ülke	%3,3 (%95 GA 2,6–4,0)
Kim ve ark., 2022	Temsili örneklemli 28 çalışma	%2,4 (%95 GA 1,7–3,2)
Kim ve ark., 2022	Yayın yanlılığı için trim-and-fill düzeltmesinden sonra	%1,4 (%95 GA 0,9–1,9)
Przybylski ve ark., 2017	Dört araştırma, N = 18.932, DSM-5 ölçütleri	%0,3–1,0

Stevens'ın %0,19–17,12'lik güven aralığı nokta tahminiyle birlikte basılmalıdır. Diğer her değerin bir aralık taşıdığı bir paragrafta yalnızca %1,96'yı aktarmak yanlış bir kesinlik izlenimi yaratır — katı örneklemli alt küme küçüktür ve tahmin buna bağlı olarak kararsızdır.

En düşük tahminler, DSM-5 ölçütlerini dört büyük uluslararası kohortta uygulayan Przybylski, Weinstein ve Murayama'dan gelmektedir (örneklemler ikincil kaynaklarda Amerika Birleşik Devletleri, Birleşik Krallık, Kanada ve Almanya'dan alınmış olarak tanımlanmaktadır). Oyun oynayan her üç kişiden ikisinden fazlası hiçbir IGD semptomu bildirmemiştir ve yazarlar IGD ile fiziksel, sosyal ve ruhsal sağlık sonuçları arasındaki bağlantıları karışık bulmuştur.

Cinsiyet dağılımı

Erkek üstünlüğü en tutarlı epidemiyolojik bulgudur: erkeklerde %8,5, kadınlarda %3,5 (Kim ve ark., 2022). Derlemeler, Su ve arkadaşlarının bir meta-analizine dayanarak, erkeklerin kadınlara kıyasla bozulmuş oyun oynama gösterme olasılığının

daha yüksek olduğunu, kadınların ise sorunlu sosyal medya kullanımı gösterme olasılığının daha yüksek olduğunu bildirmektedir (Musetti ve ark., 2025).

Yaş

Yaygınlık ergenlerde ve genç erişkinlerde en yüksektir; Kim ve ark. (2022) çalışmasında örneklemin ortalama yaşı, örneklem büyüklüğü ve çalışma kalitesi gibi, bildirilen yaygınlıkla negatif ilişkiliydi. Gentile ve ark. (2011) tarafından yürütülen ve 3., 4., 7. ve 8. sınıflardaki 3.034 çocuğu iki yıl boyunca izleyen Singapur panel çalışmasında, herhangi bir tek zaman noktasında çocukların %7,6 ila %9,9'u patolojik oyuncu olarak sınıflandırılacaktı (özette yaklaşık %9 olarak özetlenmiştir).

İki pediatrik sentez sıklıkla birlikte aktarılmaktadır, oysa aktarılmamalıdır: Gentile ve ark. (2017) yaşa, ülkeye ve örneklem özelliklerine göre kabaca %1 ila %9'luk bir aralık bildirirken Paulus ve ark. (2018) çocuk ve ergenlerin temsili örneklemlerinde yaklaşık %2, klinik örneklemler dahil tüm örneklemler birleştirildiğinde ise %5,5'lik ortalama bir yaygınlık bildirmektedir.

Heterojenliğin kaynakları

Bildirilen yaygınlık çalışmalar arasında bir büyüklük mertebesi kadar değişmektedir ve baskın neden coğrafi değil yöntemseldir. Stevens ve ark. (2021) çalışmasında tarama aracı seçimi varyansın %77'sini açıklamıştır; ergen örneklemleri, daha düşük kesme puanları ve daha küçük örneklem büyüklüğü ise daha yüksek yaygınlığın anlamlı yordayıcılarıydı. Kim ve ark. (2022) heterojenliği etkileyen düzenleyiciler arasında bölgeyi de saymaktadır; Stevens ve ark. çalışma bölgesini aday bir düzenleyici olarak incelemiş ancak anlamlı yordayıcılar arasında bildirmemiştir. Dolayısıyla her iki meta-analize dayanılarak bölgesel bir fark ileri sürülemez ve bölge; araç, örneklem türü ve çalışma kalitesiyle karışmış durumda kalmaktadır.

Bölgesel veri boşluğu

Bu taramada Azerbaycan'da yürütülmüş, hakemli bir oyun oynama bozukluğu yaygınlık çalışması saptanmamış ve Güney Kafkasya için ICD-11 temelli bir yaygınlık tahmini bulunamamıştır. Herhangi bir yerel değer, ölçülmüş veri olarak değil, yalnızca ekstrapolasyon olarak sunulmalıdır.

4. Etiyoloji ve patogenez

Tek bir nedensel mekanizma ortaya konmuş değildir. Kanıt tabanına kesitsel çalışmalar egemendir; mevcut en güçlü veriler boylamsal kohortlardan ve risk faktörlerine ilişkin meta-analizlerden gelmektedir.

Genetik

ICD-11 oyun oynama bozukluğu için doğrudan kalıtsallık tahminleri mevcut değildir. En yakın kanıt, 5.247 monozigotik ve dizigotik ergen ikizini kapsayan bir Netherlands Twin Register çalışmasıdır; bu çalışmada kompulsif internet kullanımındaki bireysel farklılıkların %48'i genetik etkenlerle açıklanmış, tahminler erkek ve kız çocuklarında özdeş çıkmış, kalan %52 ise paylaşılmayan çevreye atfedilmiştir (Vink ve ark., 2016).

Bu değer oyun oynama bozukluğuna aktarılmamalıdır. Kullanılan araç olan Compulsive Internet Use Scale, kompulsif internet kullanımını tek bir genel yapı olarak ölçen 14 maddelik bir ölçektir — kontrol kaybı, zihinsel meşguliyet, yoksunluk, baş etme ya da duygudurum düzenleme ve çatışma — ve oyuna özgü hiçbir madde içermez. O çalışmada oyun oynamaya harcanan süre ayrıca ölçülmüştür ve %48'lik tahminin elde edildiği fenotip değildir.

Kuramsal model

En yaygın kullanılan bütünleştirici çerçeve I-PACE modelidir (Interaction of Person-Affect-Cognition-Execution); bu model, bağımlılık yapıcı davranışların yatkınlık yaratan kişi değişkenleri, içsel ve dışsal işaretlere verilen duygusal ve bilişsel yanıtlar ile yürütücü ve inhibitör kontrol arasındaki etkileşimlerden doğduğunu, zaman içindeki pekiştirmenin ise davranışı doyum güdümlüden telafi güdümlü ve alışkanlık hâline kaydırdığını öne sürer (Brand ve ark., 2016; Brand ve ark., 2019). Model kuramsal olarak etkilidir, ancak tanısal ya da yordayıcı bir araç olarak geçerliliği gösterilmemiştir ve hiçbir klinik karar buna dayandırılmamalıdır.

Nörobiyoloji

40 işlevsel görüntüleme çalışmasını seed-based d mapping ile birleştiren tüm beyin meta-analizi, internette oyun oynama bozukluğundaki nöral değişikliklerin göreve bağımlı olduğunu bulmuştur (Zheng ve ark., 2019):

Paradigma	Hiperaktivasyon	Hipoaktivasyon
İşaret reaktivitesi	Bilateral prekuneus, bilateral singulat	İnsula; **striatumda fark yok**
Yürütücü kontrol	Sağ superior temporal girus, bilateral prekuneus, bilateral singulat, insula	Sol inferior frontal girus

Paradigma	Hiperaktivasyon	Hipoaktivasyon
Riskli karar verme	Sol striatum, sağ inferior frontal girus, insula	Sol superior frontal girus, sol inferior frontal girus, sağ presantral girus

Burada iki doğruluk noktası önem taşır. Birincisi, işaret reaktivitesi paradigmalarındaki birleştirilmiş null sonuç bir bütün olarak striatuma ilişkindir; bu türden bir tüm beyin analizi özel olarak ventral striatum hakkında bir iddiaya izin vermez. İkincisi, yazarların kendi vardığı sonuç, çalışmanın IGD'de ödül ve yürütücü kontrol devrelerinin kritik rolünü doğruladığı, ancak bunun tüm koşullarda geçerli olmadığıdır — ödül sisteminin katılımının bir çürütülmesi değildir. Klinisyenin buradan çıkarması gereken daha dar ve daha sağlamdır: frontal bulgular tekdüze biçimde "hipofrontal" değildir (riskli karar verme sırasında sağ inferior frontal girus hiperaktifken sol hipoaktifti), bulgular kesitseldir ve hiçbir görüntüleme bulgusunun ve hiçbir biyobelirtecin tanısal değeri yoktur.

Risk ve koruyucu faktörler — kesitsel sentez

Bugüne kadarki en büyük sentez, COVID-19 pandemisinden önce yayımlanmış 253 çalışmadan ve 210.557 katılımcıdan 1.586 etkiyi birleştirmiştir. Ampirik olarak sağlam koruyucu faktörler azdı — benlik saygısı, zekâ, yaşam doyumu ve eğitim — ve hepsinin etki büyüklükleri risk faktörlerininkinden belirgin biçimde küçüktü (Ropovik ve ark., 2023).

Risk ve koruyucu faktörler — boylamsal sentez

37.042 katılımcılı 39 boylamsal çalışmanın meta-analizi klinik açıdan en kullanışlı yapıyı sunmaktadır (Zhuang ve ark., 2023).

Alan	Risk faktörleri	Koruyucu faktörler
Kişi içi	Oyun süresi r = 0,33; yalnızlık r = 0,29; sosyal medya bozukluğu r = 0,24 (%95 GA 0,03–0,43); saldırganlık r = 0,23; anksiyete r = 0,21	Öz-denetim r = −0,27; sorumluluk r = −0,25; uyumluluk r = −0,20; benlik saygısı r = −0,19
Kişiler arası	Sapkın akranlarla ilişki r = 0,20; aile içi istismar r = 0,15	Akran ilişkisi r = −0,23; ebeveyn–çocuk ilişkisi r = −0,15; sosyal destek r = −0,14

Alan	Risk faktörleri	Koruyucu faktörler
Çevresel	—	Okula bağlılık r = −0,18

Kişi içi faktörler, kişiler arası ya da çevresel faktörlere göre belirgin biçimde daha yordayıcıydı. Sosyal medya bozukluğuna ilişkin geniş güven aralığı, bu ilişki klinikte kullanılmadan önce dikkate alınmalıdır.

Nedenselliğin yönü

İki yıllık Singapur panel çalışması, zamansal sıralama hakkında konuşabilen az sayıdaki veri setinden biridir. Daha fazla oyun oynama, daha düşük sosyal yeterlik ve daha yüksek dürtüsellik patolojik oyuncu olma açısından risk faktörü gibi davranırken; depresyon, anksiyete, sosyal fobi ve daha düşük okul başarısı patolojik oyun oynamanın nedenlerinden çok sonuçları gibi davranmıştır (Gentile ve ark., 2011). Yazarların kendi çekinceli fiili — bu değişkenlerin bu rollerde "davranıyor göründüğü" — korunmalıdır.

Dikkat eksikliği/hiperaktivite bozukluğu

Bir sistematik derleme ve meta-analiz, DEHB semptom şiddeti ile oyun oynama bozukluğu arasında orta düzeyde bir ilişki bulmuştur: birleşik DEHB semptomları için r = 0,296, dikkatsizlik için r = 0,306 ve hiperaktivite için r = 0,266 (Koncz ve ark., 2023). Bu, alandaki en tutarlı tek komorbidite ilişkisi ve uygulamada en yüksek getirili tarama hedefidir.

Oyun tasarımı ve monetizasyon

7.422 oyuncuyla yapılan bir ankette ganimet kutularına yapılan harcama, sorunlu kumar şiddetiyle ilişkiliydi ($\eta^2 = 0,054$); bu ilişki, gerçek parayla yapılan diğer oyun içi satın almalara kıyasla ($\eta^2 = 0,004$) bir büyüklük mertebesi daha güçlüydü ve kumar benzeri öge açısından özgüllüğe işaret etmektedir (Zendle ve Cairns, 2018). Tasarım kesitseldir ve yazarlar, ganimet kutularının sorunlu kumara açılan bir kapı gibi mi işlediğini yoksa zaten sorunlu biçimde kumar oynayan kişilere mi daha çok çekici geldiğini ayırt edemeyeceklerini açıkça belirtmektedir.

Rakip psikolojik açıklama

Telafi edici internet kullanımı modeli, aşırı oyun oynamayı birincil bir bağımlılıktan çok, karşılanmamış psikososyal gereksinimlere ve olumsuz yaşam durumlarına verilen bir baş etme yanıtı olarak kavramsallaştırır (Kardefelt-Winther, 2014). Bu açıklama doğrudan bağımlılık modeliyle yarışmaktadır, çözüme kavuşmamıştır ve pratik bir sonucu vardır: oyun oynaması depresif bir epizodla ya da sosyal bir krizle

birlikte artmış bir hastada oyunu yalıtılmış biçimde tedavi etmenin işe yaraması olası değildir.

5. Klinik özellikler

Temel klinik görünüm

Klinik tablo, oynanan saatlerle değil, ICD-11'in üç özelliğiyle tanımlanır.

ICD-11 özelliği	Klinikte nasıl görünür
Bozulmuş kontrol	Amaçlanan saatte durmakta yinelenen başarısızlık; planlanandan uzun süren oturumlar; azaltma girişimlerinin başarısız olması; gecenin içine uzayan "bir maç daha"
Artan öncelik	Oyun; uykunun, öğünlerin, hijyenin, ders çalışmanın, işin, aile yükümlülüklerinin ve daha önce değer verilen hobilerin yerini alır
Olumsuz sonuçlara rağmen sürdürme	Akademik başarısızlık, iş kaybı, aile içi çatışma, mali kayıp ya da belgelenmiş sağlık zararından sonra da devam etme

Eşlik eden özellikler

Oturumlar arasında oyunla zihinsel meşguliyet, irritabilite, oyun engellendiğinde huzursuzluk ya da disfori, oyunun kapsamı hakkında yalan söyleme ve olumsuz duygudurumu hafifletmek için oyun kullanımı DSM-5-TR ölçüt setinde tanımlanmaktadır. ICD-11 tolerans ya da yoksunluğu bilinçli olarak gerekli görmez ve oyun oynamada yoksunluk benzeri fenomenlerin statüsü tartışmalı olmayı sürdürmektedir. Uygulamada bu özellikler tanıyı destekler ancak tek başına taşıyamaz.

İşlevsel sonuçlar

Klinik başvurularda öncü yakınmalar tipik olarak aile tarafından getirilir: okul başarısının düşmesi, okul reddi ya da devamsızlık, gece–gündüz ritminin tersine dönmesi, çevrim dışı akranlardan uzaklaşma ve erişimi sınırlama girişimleri çevresinde tırmanan çatışma. Bozukluğu yoğun hobi kullanımından ayıran şey işlevsel bozulma koşuludur (Billieux ve ark., 2019).

Uyku

Gece oyun oynama, uykuya dalmanın gecikmesi ve uyku süresinin kısalması sık bildirilmektedir. American Academy of Sleep Medicine'ın uzlaşı önerisi, 13–18 yaş arası ergenler için 24 saatte 8 ila 10 saat uykudur (Paruthi ve ark., 2016). Oyun oynamayı uyku bozulmasına bağlayan kanıtlar gözlemseldir, ancak uyku zamanlaması nesnel olarak belgelenebilen ve tedavi boyunca izlenebilen az sayıdaki işlevsel ölçütten biridir.

Fiziksel sağlık

Bildirilen fiziksel korelatlar arasında sırt, boyun ve omuzlarda kas-iskelet ağrısı, el ve başparmakta yinelemeli zorlanma yaralanmaları, baş ağrısı ve baş dönmesinin eşlik ettiği göz yorgunluğu ve hareketsiz yaşam tarzının sonuçları yer almaktadır. Bir derleme yazısı, her on e-spor sporcusundan dördünün ağrı bildirdiğini ve günde beş saatten fazla oyun oynamanın 13–18 yaş arası ergenlerde kas-iskelet semptomlarını artırdığını belirtmektedir (Satish Kumar ve ark., 2023). Aynı derleme, çok az sayıda çalışma bulunduğunu, kanıtların karışık olduğunu, değerlendirme araçlarının geçerliliğinin gösterilmediğini ve ergenlerde hiçbir boylamsal çalışma yapılmadığını belirtmektedir. Bu, zayıf bir kanıt alanıdır ve böyle sunulmalıdır.

Komorbidite

En tutarlı ilişkiyi DEHB göstermektedir ($r \approx 0{,}30$; Koncz ve ark., 2023). Depresyon ve anksiyete sık bildirilmektedir, ancak bu izlenimin dayandığı sentez literatürü değerlendirmeye dayanamamaktadır: oyun oynama bozukluğunu depresyon ya da anksiyete ile birlikte ele alan ve toplam 196 birincil çalışmayı kapsayan yedi sistematik derlemenin yedisinde de seçici sonuç bildirimi kanıtı bulunmuş, yalnızca biri yanlılık riskini değerlendirmiş ve maruziyet tanımları tutarsız olmuştur — dahil edilen bazı çalışmalar oyun oynama bozukluğu yerine internet bağımlılığı ölçümleri kullanmıştır. Hiçbiri güvenilir olarak sınıflandırılmamış ve yazarlar oyun oynama bozukluğuyla ilgili sistematik derlemelerin yöntemsel standartları karşılamadığı sonucuna varmıştır (Colder Carras ve ark., 2020). Bu nedenle komorbidite sık gözlenen ancak kötü nicelenmiş olarak tanımlanmalı; komorbid bir duygudurum ya da anksiyete bozukluğu, oyun oynama bozukluğunun parçası varsayılmak yerine kendi başına değerlendirilip tedavi edilmelidir.

Çevrim içi ve çevrim dışı alt tip

Ağırlıklı olarak çevrim içi biçim (6C51.0) daha sık tanımlanan görünümdür ve çok oyunculu, kalıcı dünyalı ve rekabetçi oyunlarla ilişkilidir. Ağırlıklı olarak çevrim dışı biçim (6C51.1) tanınmaktadır ancak çok daha az çalışılmıştır.

Klinik tablonun parçası olmayanlar

İşlevselliği, uykusu, ilişkileri ve yükümlülükleri sağlam olan bir kişide uzun oyun saatleri oyun oynama bozukluğu oluşturmaz. Yakın tarihli bir genel değerlendirmede aktarılan kişi merkezli bir çalışma, günde dört saatten fazla oynayan ve düşük düzeyde psikolojik uyumsuzluk gösteren bir "tutkulu oyuncu" alt grubu tanımlamıştır (Musetti ve ark., 2025). Yüksek katılım ile patolojik katılım arasındaki ayrım, tanının geçerliliği açısından temeldir (Billieux ve ark., 2019).

6. Tanı

6.1 Birleşik tanı ölçütleri

Aşağıdakilerin tümü bulunmalıdır:

- oyun oynama üzerindeki kontrolün bozulması — başlama, sıklık, yoğunluk, süre, sonlandırma ve bağlam;
- oyun oynamaya giderek artan öncelik verilmesi, öyle ki oyun diğer yaşam ilgi alanlarının ve günlük etkinliklerin önüne geçer;
- olumsuz sonuçların ortaya çıkmasına rağmen oyun oynamanın sürdürülmesi ya da artırılması;
- ve paternin kişisel, ailevi, sosyal, eğitsel, mesleki veya diğer önemli işlevsellik alanlarında belirgin bozulmaya yol açması.

Süre: oyun oynama davranışı paterni ve diğer özellikler normalde en az 12 aylık bir süre boyunca belirgindir; ancak tüm tanı gereklilikleri karşılanıyorsa ve semptomlar ağırsa gerekli süre kısaltılabilir. Alt tipi belirtin: 6C51.0 ağırlıklı olarak çevrim içi, 6C51.1 ağırlıklı olarak çevrim dışı, 6C51.Z belirtilmemiş.

6.2 Bu tanı uygulamada ne kadar güvenilir?

ICD-11 rehberini doğrudan sınayan tek bir saha çalışması vardır. Şanghay ve Hebei'de, 15–18 yaş arası 200 oyuncu (ortalama 16,5; %85,6'sı erkek) yedi psikiyatristten oluşturulan 21 değerlendirici çifti tarafından değerlendirilmiştir. Değerlendiriciler arası uyum, ICD-11 oyun oynama bozukluğu rehberi için $\kappa = 0{,}545$ (%95 GA 0,490–0,600) — yazarların kendi kullandığı Landis ve Koch sınıflamasına göre orta düzey — ve DSM-5 IGD için $\kappa = 0{,}622$ (%95 GA 0,553–0,691) idi. Aynı hastalara uygulanan iki sistem arasındaki uyum $\kappa = 0{,}847$ (%95 GA 0,814–0,880) idi. Klinisyenler 400 değerlendirme setinin %86,0'sında rehberin klinik uygulanabilirliğini oldukça ya da son derece iyi olarak onaylamıştır (Ma ve ark., 2021).

Bu iki kappa değerinin doğrudan karşılaştırılması eşdeğerler arasında değildir ve ICD-11'in daha az güvenilir sistem olduğunun temiz bir gösterimi olarak bildirilmemelidir. ICD-11 değeri üç kategorili bir yargıdan (oyun oynama bozukluğu / riskli oyun oynama / hiçbiri), DSM-5 değeri ise iki kategorili bir yargıdan (IGD var / yok) gelmektedir. Üç kategorili bir kappa, DSM-5'te karşılığı bulunmayan ara riskli oyun oynama kategorisine ilişkin uyuşmazlıklar nedeniyle yapısal olarak cezalandırılır. Bu değerlerin yanına üç kısıtlılık daha eklenmelidir: 200 oyuncunun tümü tek bir mesleki ve teknik eğitim merkezinden taranmıştır; yalnızca yedi değerlendirici vardır; ve WHO saha çalışmalarında kullanılan eş zamanlı ortak değerlendirici tasarımı, bağımsız bir yeniden görüşmeye kıyasla daha yüksek kappa değerleri üretme eğilimindedir, dolayısıyla 0,545 gündelik uygulama için karamsar olmaktan çok iyimser bir tahmindir. Yineleme çalışması yoktur.

Aynı çalışma yaygın bir varsayımı da geçersiz kılmaktadır. Aynı 400 değerlendirme setine uygulandığında ICD-11 ölçütleri, DSM-5 ölçütlerinden (78) biraz *daha fazla* olgu (86) vermiş ve sistemler arasındaki uyum neredeyse kusursuz olmuştur. Bu nedenle çalışmalar arasındaki yaygınlık farkları basitçe bir aracın hangi el kitabını izlediğine bağlanamaz; aracın kendisi, kesme puanı ve örneklem çok daha fazla önem taşır (bkz. 3. kısım).

6.3 12 aylık koşul neden keyfi değildir

Oyun oynama bozukluğunda olgu olma durumu zaman içinde belirgin biçimde kararsızdır. 50 boylamsal çalışmanın meta-analizi, bir yılda yaklaşık %43 ila %45, iki yılda ise %34 ila %38'lik kategorik kararlılık bulmuş (Sun ve ark., 2025); bir yıllık boylamsal bir çalışma ise tanı eşiğinin her iki yönde de önemli ölçüde aşıldığını göstermiştir (Hong ve ark., 2023). Tek bir değerlendirmede eşiği aşan kişilerin büyük bir bölümü, hiçbir tedavi almadan bir yıl sonra eşiğin üzerinde olmayacaktır. 12 aylık koşul, geçici bir dönemin — bir sınav dönemi, kaybedilen bir iş, bir yas, sınırsız bağlantılı bir yaz tatili — psikiyatrik bir tanıya dönüştürülmesini engelleyen şeydir. İzin verilen kısaltma yalnızca her tanı gerekliliği halihazırda karşılandığında ve semptomlar ağır olduğunda geçerlidir; izlenime dayanarak erken tanı koymak için bir ruhsat değildir.

6.4 Normalle sınır

Beceri geliştirme, rekabet ya da eğlence amacıyla yürütülen yoğun oyun oynama, kontrolün bozulması ve işlevsel bozulma yokluğunda bir bozukluk değildir. Ölçütlerde bir süre eşiği yoktur; oynanan saatler tanısal değildir. WHO kamuya yönelik rehberliğinde, oyun oynama bozukluğunun dijital ya da video oyunu oynayan kişilerin yalnızca küçük bir bölümünü etkilediğini belirtmektedir. Bu, yanlış pozitif tanıya karşı başlıca güvencedir (Billieux ve ark., 2019).

6.5 Tanı algoritması

- 1. Adım. Bir oyun oynama paterninin varlığını saptayın ve niteleyin: oyunlar, platform, çevrim içi ya da çevrim dışı, oturum yapısı, ganimet kutuları dahil monetizasyona maruziyet.
- 2. Adım. Üç temel bileşenin her birini, kişinin kendini etiketlemesine değil somut davranışsal örneklere dayanarak ayrı ayrı değerlendirin.
- 3. Adım. İşlevsel bozulmayı nesnel olarak belgeleyin — okul ya da iş kayıtları, uyku, aile bildirimi, önceki etkinliklerin kaybı. Bozulma yoksa bunun yerine QE22 Riskli oyun oynamayı düşünün.
- 4. Adım. 12 aylık zaman çerçevesini saptayın ya da bunu kısaltmaya yetecek ağırlığı belgeleyin.
- 5. Adım. Davranışın tek bağlamı olarak manik ya da hipomanik epizodu (6A60, 6A61) dışlayın.
- 6. Adım. Komorbidite açısından sistematik olarak tarayın: önce DEHB, ardından depresif bozukluklar, anksiyete ve sosyal anksiyete, madde kullanımı ve uyku bozuklukları.
- 7. Adım. Geçerliliği gösterilmiş bir aracı (GDT, ACSID-11, IGDT-10, IGDS9-SF) yalnızca yardımcı olarak kullanın. Hiçbir araç tek başına tanısal değildir.

6.6 ICD-11 ile DSM-5-TR karşılaştırması

	ICD-11 6C51 Oyun oynama bozukluğu	**DSM-5-TR İnternette oyun oynama bozukluğu**
Statü	Resmi tanı	III. Bölüm, İleri Araştırma Gerektiren Durumlar
Yapı	Üçü de zorunlu olan üç bileşen	Önerilen dokuz ölçüt; beşi ya da daha fazlası gerekli
İşlevsel bozulma	Zorunlu, ayrı bir gereklilik	Tanı girişinde yer alır (klinik açıdan belirgin bozulma ya da sıkıntı); ayrı bir ek ölçüt değildir
Tolerans ve yoksunluk	Yer almaz	Dokuz ölçüt arasında yer alır
Zaman çerçevesi	Normalde en az 12 ay; ağır olguda kısaltılabilir	12 aylık bir dönem içinde

	ICD-11 6C51 Oyun oynama bozukluğu	**DSM-5-TR İnternette oyun oynama bozukluğu**
Kapsam	Çevrim içi ya da çevrim dışı; alt tipler kodlanır	Çevrim içi oyunlar çerçevesinde kurgulanmıştır
Eşik altı kod	QE22 Riskli oyun oynama	Yok

ICD-11'in işlevsel bozulmaya verdiği daha büyük ağırlık, genellikle ona daha yüksek bir tanı eşiği kazandırdığı biçiminde okunmaktadır (Musetti ve ark., 2025).

6.7 Bir yıl içinde tanısal kararlılık

279 katılımcıyla — sorunlu oyun oynayan 120 hasta ve genel popülasyondan 159 oyuncu — yürütülen bir yıllık boylamsal çalışmada katılımcıların %34,7'sinde DSM-5 IGD tanısında değişiklik olurken ICD-11 oyun oynama bozukluğu olgularının sayısı %60,4'e yükselmiştir (Hong ve ark., 2023). Bu iki değer farklı niceliklerdir ve aynıymış gibi birbirinin karşısına konmamalıdır: %34,7 bir tanı değişikliği oranıdır, %60,4 ise oyun oynama bozukluğu olgu yükünün yükseldiği düzeydir. Yazarlar, yıl boyunca IGD ve GD tanı değişikliği miktarları arasında anlamlı fark bulunmadığını açıkça belirtmektedir; yorumsal sonuçları da ihtiyatlı olanıdır — bir oyun oynama bozukluğu tanısının bir IGD tanısına göre değişmeye *daha yatkın olabileceği*. Her ikisi için de en yüksek odds oranını DEHB taşımaktaydı; oyun oynama bozukluğu için bildirilen nokta tahmini 10^6 mertebesinde olup buna karşılık gelen çok geniş bir güven aralığı taşımaktadır, bir etki büyüklüğü olarak yorumlanamaz ve neredeyse kesin biçimde modeldeki yarı-tam ayrışmayı yansıtmaktadır.

Klinik sonuç doğrudandır: tek bir kesitsel değerlendirme o andaki tanıyı koyar, prognozu değil; yeniden değerlendirme ise isteğe bağlı bir ek değil, tedavi yönetiminin parçasıdır.

6.8 Ayırıcı tanı

Kod	Durum	Ayırt edici nokta
QE22	Riskli oyun oynama	Zarar riskini kayda değer ölçüde artıran, ancak 6C51 gerekliliklerini karşılamayan oyun oynama — tipik olarak kontrolün bozulması ya da belirgin işlevsel bozulma bulunmadığı için. Patern öneri gerektirdiğinde ancak bozukluk tanısı gerektirmediğinde bu kodu kullanın.
6C50	Kumar oynama bozukluğu	Merkezî davranış, sonucu belirsiz olaylara para ya da değerli şeyler yatırmaktır. Sınır, kumar benzeri oyun içi monetizasyonla bulanıklaşır; her iki davranışı da değerlendirin ve ölçütler karşılandığında her ikisini de kodlayın.
6A60 / 6A61	Bipolar tip I / tip II bozukluğu	Resmi ICD-11 dışlamaları. Yalnızca bir manik ya da hipomanik epizod içinde ortaya çıkan aşırı oyun oynama, duygudurum epizodunun bir semptomudur.

Kod	Durum	Ayırt edici nokta
6A05	Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu	En güçlü ve en tutarlı komorbidite. Dağınık, kötü düzenlenmiş oyun oynamanın eşlik ettiği birincil DEHB'yi bağımsız bir oyun oynama bozukluğundan ayırın; ikisi sıklıkla bir arada bulunur ve ölçütler karşılandığında her ikisi de kodlanmalıdır.
6A70 / 6A71 / 6A72	Depresif bozukluklar	Ağırlıklı olarak depresif duygudurumdan kaçmak ya da onu hafifletmek için kullanılan oyun oynama ikincil bir fenomen olabilir. Zamansal sıralamayı ve duygudurum bozukluğu tedavi edildiğinde oyunla ilişkili bozulmanın sürüp sürmediğini değerlendirin.
6B00 / 6B04	Yaygın anksiyete bozukluğu / Sosyal anksiyete bozukluğu	Sosyal anksiyetede kaçınmayı olumsuz değerlendirilme korkusu yönlendirir; oyun oynama bozukluğunda ise itici güç, oyun üzerindeki kontrolün bozulması ve oyuna öncelik verilmesidir.

Kod	Durum	Ayırt edici nokta
6A02	Otizm spektrum bozukluğu	Yoğun ve sınırlı ilgi, bağımlılık sürecinden çok kısıtlı ilgi alanını yansıtıyor olabilir. Uzun süredir var olan, tırmanmayan ve işlevsel bozulma yaratmayan özel bir ilgi 6C51 değildir.
6C40–6C4G	Madde kullanımına bağlı bozukluklar	Oyun oynama paterninin madde kullanımından ya da entoksikasyondan bağımsız olarak sürüp sürmediğini değerlendirin.
6A20	Şizofreni	Uzamış, yalnız başına dalıp gitme; negatif semptomlar, sosyal geri çekilme ya da oyun içeriğine ilişkin hezeyanlı meşguliyet bağlamında ortaya çıkabilir.
6B20	Obsesif-kompulsif bozukluk	İstenmeden gelen düşüncelerin ve anksiyetenin azaltılmasının yönlendirdiği ritüelleşmiş oyun içi davranış, oyun oynama bozukluğunun önce doyum sonra alışkanlık paterninden farklı olarak baştan itibaren ego-distoniktir.

Kod	Durum	Ayırt edici nokta
6C5Y / 6C5Z	Bağımlılık yapıcı davranışlara bağlı diğer belirtilmiş / belirtilmemiş bozukluklar	Ne oyun ne de kumar tanımını karşılayan, başka çevrim içi etkinlikler — sosyal ağlar, satın alma-alışveriş, pornografi kullanımı — çevresinde odaklanan bağımlılık yapıcı davranış paternleri için.
7A00–7A0Z	Uykusuzluk bozuklukları	Uyku bozulmasının oyun oynama paterninin bir sonucu mu yoksa bağımsız bir uyku–uyanıklık bozukluğu mu olduğunu belirleyin.

Bir ayırıcı tanı sorusunun yerleşik bir yanıtı yoktur: bir duygudurum ya da dikkat bozukluğuyla birlikte ortaya çıkıp onunla birlikte geçen oyun oynamanın birincil bir durum olup olmadığı. Bu, kabul görmüş bir araştırma önceliği olmayı sürdürmektedir (Musetti ve ark., 2025) ve tek tek hastalarda pragmatik biçimde yanıtlanır — komorbid bozukluk düzgün biçimde tedavi edilerek ve oyunla ilişkili bozulmanın onunla birlikte düzelip düzelmediği gözlenerek.

7. Muayene ve değerlendirme

Genel ilke

Oyun oynama bozukluğuna tanı koyabilecek hiçbir biyolojik test ve hiçbir görüntüleme bulgusu yoktur; tanısal bir biyobelirteç ortaya konmamıştır. Tanı klinik görüşmeye dayanır; psikometrik araçlar yalnızca tarama ve şiddet araçlarıdır ve hiçbiri tek başına tanı koymak ya da tanıyı dışlamak için kullanılmamalıdır.

Ölçüm araçları

Araç	Çerçeve	Yapı ve puanlama	Geçerlilik ve kesme puanı
Gaming Disorder Test (GDT) Pontes ve ark., 2021	ICD-11	4 madde, 5'li Likert, toplam 4–20; yüksek puan = daha ağır	Çevrim içi olarak toplanan 236 Çinli ve 324 Britanyalı oyuncuda geliştirildi. İç tutarlılık, 14 dilde 17 çalışmayı kapsayan 2024 tarihli bir güvenirlik genellemesi meta-analiziyle desteklenmiştir (birleştirilmiş α = 0,86; %95 GA 0,83 –0,89). Evrensel olarak geçerliliği gösterilmiş tek bir tanısal kesme puanı yoktur.

Araç	Çerçeve	Yapı ve puanlama	Geçerlilik ve kesme puanı
ACSID-11 Müller ve ark., 2022	ICD-11	Oyun oynama, satın alma-alışveriş, pornografi kullanımı, sosyal ağ kullanımı ve çevrim içi kumara özdeş biçimde uygulanan 11 madde	985 etkin internet kullanıcısında (Almanca) geliştirildi. Tay (2023) ve Çinli ergen (2024) geçerlilik çalışmaları oyun oynamayı kapsamaktadır; bugüne kadar yayımlanmış İngilizce geçerlilik çalışması ise oyun oynamayı değil, Tinder ve çevrim içi pornografi kullanımını kapsamaktadır. Boyutsal; tanısal kesme puanı yoktur.
IGDT-10 Király ve ark., 2017	DSM-5	Dokuz ölçütü işlevselleştiren 10 madde; puan aralığı 0–9	4.887 çevrim içi oyuncuda (14–64 yaş, ortalama 22,2, %92,5 erkek) geliştirildi. ≥ 5 kesme puanı olası IGD'yi gösterir. Yedi dil temelli örneklemde (7.193 katılımcı) skalar ölçüm değişmezliği ayrı bir 2019 çalışmasında gösterilmiştir.

Araç	Çerçeve	Yapı ve puanlama	Geçerlilik ve kesme puanı
IGDS9-SF Pontes ve Griffiths, 2015	DSM-5	9 madde, 5'li ölçek; ölçüt temelli yorum (dokuz ölçütten en az beşinin en yüksek sıklıkta onaylanması)	1.397 İngilizce konuşan oyuncuda (%85,1 erkek, ortalama yaş 27) geliştirildi. 15 dil sürümünde 21 çalışmayı kapsayan sistematik derleme tek boyutlu bir yapıyı doğrulamıştır (Poon ve ark., 2021). Kesin olarak geçerliliği gösterilmiş tek bir toplam puan eşiği yoktur.
AICA-S	Klinik (internet ve bilgisayar oyunu bağımlılığı)	Şiddet ölçeği	STICA çok merkezli randomize çalışmasında birincil sonuç ölçütü (tedavi sonunda d = 1,19).

Ölçüm araçlarına ilişkin kritik uyarı

Üç profesyonel değerlendirici tarafından bağımsız olarak puanlanan 417 maddelik bir madde havuzundan oluşan, 29 oyun oynama bozukluğu tarama aracının görünüş geçerliliği değerlendirmesi; kapsam, ifade ve aşırı patolojikleştirme açısından sistematik sorunlar saptamıştır — normal yoğun katılımı yakalayan maddeler (King ve ark., 2020). Bu kuramsal bir kaygı değildir: en büyük yaygınlık meta-analizinde tarama aracı seçimi çalışmalar arası varyansın %77'sini açıklamıştır (Stevens ve ark., 2021). Bir kesme puanının üzerindeki araç puanı, dikkatle görüşme yapmak için bir nedendir; asla bir tanı değildir.

Önerilen değerlendirme paketi

- Üç ICD-11 bileşenine ve belgelenmiş işlevsel bozulmaya yönelik yapılandırılmış klinik görüşme.
- Aileden ya da okuldan alınan yan öykü — reşit olmayanlarda zorunludur.
- Zaman içinde şiddet takibi için ICD-11 ile uyumlu bir araç (GDT ya da ACSID-11).
- Sistematik komorbidite taraması: önce DEHB ($r \approx 0{,}30$), ardından depresif ve anksiyete bozuklukları, madde kullanımı ve sosyal anksiyete.
- AASM'nin ergenler için 8–10 saatlik önerisini referans alan uyku değerlendirmesi.
- Kumar benzeri monetizasyona maruziyetin (ganimet kutuları, oyun içi satın almalar) ve eşlik eden herhangi bir kumar davranışının değerlendirilmesi.
- İzlem için başlangıç işlevsellik ölçütleri: okula ya da işe devam ve başarı, uyku zamanlaması, çevrim dışı sosyal ilişkiler, fiziksel etkinlik.

8. Tedavi

Hiçbir yerde oyun oynama bozukluğu için onaylanmış bir farmakoterapi yoktur. Hiçbir ilaç bu endikasyon için FDA onayı taşımamaktadır ve çalışılmış olan her ajan endikasyon dışı kullanılmıştır. Oyun oynama bozukluğuna ayrılmış bir Cochrane sistematik derlemesi saptanmamıştır; NICE kumarla ilişkili zararlara ilişkin bir kılavuz yayımlamıştır (NG248, 28 Ocak 2025) ancak oyun oynama bozukluğunu kapsayan bir kılavuzu yoktur; oyun oynama bozukluğuna özgü WFSBP, CANMAT, NIMH, SAMHSA ya da VA-DoD klinik rehberliği de saptanmamıştır. Resmi olarak sınıflandırılmış bir bozukluk için bu çarpıcı bir boşluktur ve klinisyenin kılavuzlardan değil birincil çalışmalardan yola çıkarak çalıştığı anlamına gelir.

8.1 Farmakoterapi: gerçekte ne çalışılmıştır

Farmakolojik literatürün tamamı, 724 katılımcıyı bildiren 12 klinik çalışmanın sistematik derlemesinde özetlenmiştir. Derlemenin kısıtlılıkları, ondan neyin çıkarılabileceğini ve neyin çıkarılamayacağını belirlemektedir:

- katılımcıların %98,6'sı erkekti (cinsiyeti bildirilen 694 kişinin 684'ü);
- çalışmaların %100'ü Güney Kore'de yürütülmüştü;
- 12 çalışmanın 8'i açık etiketliydi ve genel olarak yalnızca dört çalışma düşük yanlılık riski taşıyor olarak değerlendirildi.

Tüm çalışmalarda tedavi öncesinden sonrasına IGD semptom azalmaları %15,4 ila %51,4 arasında değişmiştir — tümüyle bupropion çalışmalarının belirlediği bir aralık (Sá ve ark., 2023).

İlaç	Katılımcı payı	Bildirilen semptom azalması
Bupropion (uzatılmış salımlı formlar dahil), 6 makale	%26,9 (n = 195)	%15,4–51,4
SSRI'ler — fluoksetin, essitalopram, paroksetin, 6 makale	%23,3 (n = 169)	%17,6–24,0
Metilfenidat, 2 makale	%14,6 (n = 106)	%23,7–25,7
Atomoksetin, 1 makale	%5,5 (n = 40)	%18,3

Bu değerleri okurken komorbidite merkezî önemdedir. 12 çalışmanın yedisi öncelikle IGD'ye odaklanmış ve 461 katılımcıyı (toplamın %63,6'sı) kapsamıştır; bu yedi çalışmanın beşi aynı zamanda psikiyatrik komorbiditesi olan — en sık DEHB ve majör depresif bozukluk — 298 katılımcıyı, yani birleştirilmiş örneklemin yaklaşık %41'ini almıştır. Başka bir deyişle, gözlenen düzelmenin önemli bir bölümü oyun davranışına değil komorbid bozukluğa ait olabilir.

En bilgilendirici iki tekil çalışma:

- Han ve Renshaw (2012). Majör depresif bozukluğu ve aşırı çevrim içi oyun oynaması olan 50 erkekte on iki haftalık prospektif, randomize, çift kör çalışma (sekiz hafta etkin tedavi, dört hafta izlem). Bupropion ile birlikte internet kullanımı eğitimi, plasebo ile birlikte eğitime kıyasla Young Internet Addiction Scale puanlarını ve ortalama oyun süresini daha fazla azaltmıştır. Klinik açıdan önemli ayrıntı: dört haftalık izlem sırasında çevrim içi oyun oynamadaki azalma sürerken depresif semptomlar yinelemiştir.
- Nam ve ark. (2017). Majör depresif bozukluğu ve aşırı internette oyun oynaması olan hastalarda bupropion ile essitalopramın on iki haftalık çift kör karşılaştırması. Her iki grupta da depresif ve IGD semptomları düzelmiştir, ancak toplam 30 hastayla (kol başına 15) çalışma herhangi bir karşılaştırmalı etkililik iddiasını destekleyemez.

Klinik kural. Oyun oynama bozukluğunda farmakoterapi şu anda oyun davranışının kendisine değil, komorbiditeye — DEHB, depresyon — yöneliktir. Komorbid bozukluğun endikasyonuyla reçete edilmeli, oyunla ilgili sonuç vaat edilmek yerine izlenmelidir.

8.2 Psikoterapi: en iyi desteklenen seçenek bilişsel davranışçı terapidir

Konumu üç sentez ve bir çok merkezli çalışma belirlemektedir.

- Stevens ve ark. (2019). 12 bağımsız BDT çalışmasının meta-analizi. Tedavi sonunda IGD semptomları üzerindeki tedavi öncesi–sonrası etki g = 0,92 (%95 GA 0,50–1,34); depresyon g = 0,80 (0,21–1,38); anksiyete g = 0,55 (0,17–0,93) idi. Bunlar tedavi öncesi–sonrası etkilerdir, kontrollü gruplar arası karşılaştırmalar değildir; ve bu ayrım önemlidir, çünkü alanın manşet değeri budur. Uygulamayı belirleyen bulgu bir sonrakidir: izlemde tedavi kazanımları dört sonucun tümünde — yalnızca depresyon ve anksiyete değil, IGD semptomları dahil — anlamlı değildi. BDT'den elde edilen kazanımlar kısa vadede gösterilmiştir; kalıcı oldukları gösterilmemiştir.
- Wölfling ve ark. (2019) — STICA çalışması. En yüksek kaliteli randomize kanıt: Almanya ve Avusturya'da dört ayaktan tedavi kliniğinde yürütülen çok merkezli bir randomize kontrollü çalışma; 143 erkek, el kitabına dayalı kısa süreli BDT'ye (n = 72) ya da bekleme listesi kontrol grubuna (n = 71) randomize edilmiştir. Remisyon tedavi grubunun %69,4'ünde, kontrol grubunun ise %23,9'unda gerçekleşmiştir (odds oranı 10,10; %95 GA 3,69–27,65; başlangıç şiddeti, komorbidite, merkez ve yaşa göre düzeltilmiş). Tedavi sonundaki etki büyüklükleri: d = 1,19 (AICA-S), d = 0,88 (hafta içi çevrim içi süre), d = 0,64 (psikososyal işlevsellik), d = 0,67 (depresyon). Doz, haftalık 15 grup seansı ile iki haftada bir yapılan en fazla sekiz bireysel seanstı — kabaca dört ay içinde yaklaşık 23 seansa kadar; bu sonucu yineleyecek bir hizmetin kaynak ayırması gereken miktar budur. Kısıtlılıklar: yalnızca erkeklerden oluşan örneklem ve dahil etmenin kesin olarak ICD-11 oyun oynama bozukluğuna değil, birincil tanı olarak internet bağımlılığına dayandırılmış olması.
- Ock ve ark. (2025). Farmakolojik olmayan müdahalelere ilişkin 18 randomize kontrollü çalışmanın (1.950 katılımcı) meta-analizi: birleştirilmiş g = −0,82 (%95 GA −1,23 ila −0,52; I^2 = %90,36). En büyük etkiyi, başlıca BDT olmak üzere psikoterapi göstermiştir (10 çalışma, 1.036 katılımcı; g = −1,34); davranışsal müdahaleler g = −0,38; önlemeye odaklı çalışmalar g = −0,33, tedaviye yönelik çalışmalar g = −1,13; erişkinler ergenlerden daha fazla düzelmiştir (g = −1,14'e karşı −0,45). Yayın yanlılığı istatistiksel olarak doğrulanmıştır (Begg p = 0,043; Egger p = 0,002). Bir uyarı işareti daha: düşük yanlılık riski taşıyor olarak değerlendirilen dört çalışma tümünün en büyük etkisini üretmiştir (g = −4,08); bu, büyük bir gerçek etkiye değil kararsız bir kanıt tabanına işaret eden, akla yatkın olmayan bir tahmindir.
- Danielsen ve ark. (2024). En muhafazakâr sentez — 38 çalışma, 76 etki büyüklüğü, 9.524 katılımcı — orta düzeyde bir özet tahmin vermiştir; yazarlar bulguya duyulan güvenin küçük çalışma etkileri, olası yayın yanlılığı, sınırlı çalışma havuzu ve standartlaşma eksikliği nedeniyle zedelendiğini belirtmektedir.

8.3 Kısa süreli oyundan uzak durma

IGD açısından taramada 9'u pozitif çıkan 24 erişkin oyuncuda uygulanan gönüllü 84 saatlik uzak durma protokolü; tam uyum ve hiç kayıp olmaksızın oyun saatlerini, uyumsuz oyun bilişlerini ve IGD semptomlarını azaltmıştır; 28. günde IGD grubunun %75'i IGD semptomlarında klinik açıdan anlamlı düzelme, %63'ü ise uyumsuz bilişlerde güvenilir düzelme göstermiştir (King ve ark., 2017). Bu küçük bir pilot çalışmadır. Tam bırakma ile kontrollü kullanım hedefleri yeterli güce sahip bir çalışmada hiç karşılaştırılmamıştır ve tedavi hedefi dayatılmak yerine bireyselleştirilmelidir.

8.4 Aile ve gelişimsel müdahaleler

PIPATIC programı — 12–18 yaş arası ergenler için psikoeğitim ve motivasyon, IGD'ye uyarlanmış olağan bağımlılık tedavisi, kişi içi, kişiler arası, aile ve yeni yaşam tarzı modüllerinden oluşan, altı ay boyunca yaklaşık 45 dakikalık 22 seansta uygulanan, el kitabına dayalı altı modüllü bireyselleştirilmiş bir psikoterapi — iki kamu ruh sağlığı merkezinde standart BDT ile karşılaştırılmıştır. Her iki grupta da IGD semptomlarında anlamlı azalma görülmüştür (Torres-Rodríguez ve ark., 2018). Belirleyici kısıtlılık örneklemdir: iki kolda toplam 31 ergen.

Aile, ebeveyn aracılığı, okula bağlılık ve yaşam tarzı önlemleri yaygın biçimde önerilmektedir ve boylamsal koruyucu faktör verileriyle uyumludur — akran ilişkisi kalitesi $r = -0{,}23$, okula bağlılık $r = -0{,}18$, ebeveyn–çocuk ilişkisi $r = -0{,}15$, sosyal destek $r = -0{,}14$ (Zhuang ve ark., 2023) — ancak randomize çalışmalarda tek başına müdahale olarak sınanmamışlardır. Reşit olmayanlara yönelik yasak saatleri ve haftalık süre sınırları gibi ulusal düzenleyici önlemler birçok ülkede mevcuttur; bunların klinik sonuçlar üzerindeki etkisine ilişkin yüksek kaliteli bir değerlendirme saptanmamıştır ve ganimet kutuları ile mikro ödemelerin düzenlenmesi açık bir politika sorusu olmayı sürdürmektedir (Musetti ve ark., 2025).

8.5 Kanıt düzeylerinin özeti

Müdahale	Düzey	Dayanak ve temel kısıtlılık
BDT, bireysel ve grup (STICA dozu: 15 grup + en fazla 8 bireysel seans)	ORTA	Çok sayıda randomize kontrollü çalışma ile bir çok merkezli randomize kontrollü çalışma; yüksek heterojenlik ve doğrulanmış yayın yanlılığı; izlemde kazanımlar anlamlı değil
Kısa süreli yapılandırılmış uzak durma	DÜŞÜK	Tek pilot çalışma, 24 katılımcı
Aile bütünleşik ergen programları	DÜŞÜK	Küçük kontrollü çalışma, toplam 31 ergen
Komorbid DEHB ya da depresyon için farmakoterapi	DÜŞÜK	12 çalışma, 724 katılımcı, %98,6 erkek, tümü Güney Kore'de, 12'sinin 8'i açık etiketli
Doğrudan oyun oynama bozukluğunu hedefleyen farmakoterapi	YETERSİZ	Onaylı ajan yok; komorbiditesi olmayan, ICD-11 ile tanı konmuş bir örneklemde yeterli güce sahip plasebo kontrollü çalışma yok
Ebeveyn, okul ve çevresel önlemler	DOLAYLI	Boylamsal risk faktörü verileriyle desteklenmekte, çalışmalarla değil
Ulusal düzenleyici kısıtlamalar	DEĞERLENDİRİLMEMİŞ	Klinik sonuçlara ilişkin yüksek kaliteli bir değerlendirme saptanmadı

9. Prognoz

Oyun oynama bozukluğuna ilişkin prognostik ifadeler bir ila iki yıllık bir ufukla sınırlandırılmalıdır. Bunun ötesinde hiçbir şey bilinmemektedir: beş ila on yıla

uzanan bir izlem çalışması saptanmamıştır, ergenlik başlangıçlı oyun oynama bozukluğunun erişkinlik sonuçlarına ilişkin veri yoktur ve mortalite verisi yoktur.

Doğal seyir

Oyun oynama bozukluğu tekdüze biçimde kronik bir durum değildir. 50 boylamsal çalışmanın meta-analizi, bir yıllık izlemde yaklaşık %43 ila %45, iki yılda ise %34 ila %38'lik kategorik kararlılık bulmuştur — başlangıçta eşiği karşılayanların üçte biri ile yarısı arasındaki bir bölümü izlemde de eşiği karşılamış, geri kalanı karşılamamıştır. Boyutsal semptom şiddeti farklı davranmıştır: başlangıçtan izleme korelasyonlar pozitif ve istatistiksel olarak anlamlıydı; bu, kategorik durum değişse bile şiddette orta ila yüksek bir sürekliliğe işaret etmektedir. Bu düzeydeki kararlılık, kişilik bozukluğu ve kumar oynama bozukluğunkine benzer, şizofreni ya da bipolar bozukluğunkinden ise düşüktür (Sun ve ark., 2025). Bu değerlerin yanına iki çekince eklenmelidir: birleştirilmiş örneklemler ağırlıklı olarak ergenlerden oluşmaktaydı ve bunlar tedavi edilmemiş doğal seyre ilişkin verilerdir.

279 katılımcılı bir yıllık boylamsal çalışma da aynı yöne işaret etmektedir: yıl boyunca katılımcıların %34,7'sinde DSM-5 IGD tanısında değişiklik olurken ICD-11 oyun oynama bozukluğu olgularının sayısı %60,4'e yükselmiş, iki sistemdeki tanı değişikliği miktarları arasında anlamlı fark bulunmamıştır (Hong ve ark., 2023).

Yordayıcılar

Patolojik oyun oynamanın gelişmesi açısından prospektif risk faktörleri daha fazla oyun oynama, daha düşük sosyal yeterlik ve daha yüksek dürtüselliktir (Gentile ve ark., 2011). Daha yüksek semptom seyirlerinin meta-analitik boylamsal yordayıcıları oyun süresi ($r = 0,33$), yalnızlık ($r = 0,29$), eşlik eden sosyal medya bozukluğu ($r = 0,24$), saldırganlık ($r = 0,23$) ve anksiyetedir ($r = 0,21$); koruyucu yordayıcılar ise öz-denetim ($r = −0,27$), sorumluluk ($r = −0,25$), akran ilişkisi kalitesi ($r = −0,23$), benlik saygısı ($r = −0,19$) ve okula bağlılıktır ($r = −0,18$) (Zhuang ve ark., 2023). Bir yıllık çalışmada tanı değişikliği için en yüksek odds oranını DEHB taşımaktaydı (Hong ve ark., 2023).

Başarılı tedaviden sonra nüksün yordayıcıları ortaya konmamıştır. Geçerliliği gösterilmiş bir nüks yordayıcısı yoktur; bu da remisyondan sonraki izlemin yüksek riskli bir alt gruba yönlendirilemeyeceği ve rutin olarak sunulması gerektiği anlamına gelir.

Bozukluğa atfedilebilen sonuçlar

İki yıllık Singapur panelinde depresyon, anksiyete, sosyal fobi ve daha düşük okul başarısı, patolojik oyun oynamanın nedenlerinden çok sonuçları gibi davranmıştır.

Patolojik oyuncu olmaktan çıkan gençler, patolojik oyuncu olarak kalanlara kıyasla daha düşük depresyon, anksiyete ve sosyal fobi düzeyleriyle sonlanmıştır (Gentile ve ark., 2011). Bu, belgelenmiş bir kişi içi düzelme değil, gruplar arası bir karşılaştırmadır ve okul başarısı, bırakanlarla bırakmayanlar arasında farklılık gösterdiği bildirilen değişkenler arasında yer almamaktadır. Yine de bu, durumun yalnızca sıkıntıyla birlikte bulunmaktan öte prospektif bir zarar taşıdığına ilişkin mevcut en güçlü kanıt olmayı sürdürmektedir.

Tedavi edilenlerde prognoz

STICA çok merkezli çalışmasında remisyon, tedavi edilen erkeklerin %69,4'ünde, bekleme listesi kontrollerinin ise %23,9'unda gerçekleşmiştir (Wölfling ve ark., 2019). Farmakolojik olmayan müdahalelerin meta-analizi, erişkinlerin ergenlerden belirgin biçimde daha fazla düzeldiğini bulmuştur ($g = -1{,}14$'e karşı $-0{,}45$); bu yaş eğimi, daha genç hastalarda prognostik beklentileri ölçülü tutmalıdır (Ock ve ark., 2025). Buna karşılık BDT meta-analizi, izlemde tedavi kazanımlarının dört sonucun tümünde anlamlı olmadığını bulmuştur (Stevens ve ark., 2019): kısa vadeli yanıt iyi belgelenmiştir, kalıcılık değildir.

Prognostik kanıtta kim eksik

Kadınlar ve kızlar tedavi literatüründe fiilen temsil edilmemektedir. Tek çok merkezli randomize çalışmaya yalnızca erkekler alınmış, farmakolojik literatürün tamamındaki katılımcıların %98,6'sı erkek olmuştur. Yayımlanmış kanıtlardan kadın hastalarda tedavi yanıtına ya da prognoza ilişkin hiçbir ifade türetilemez; bu, erkek örneklemlerden elde edilen değerlerin ardına gizlenmek yerine kadın hastalara ve ailelerine söylenmelidir.

10. Mit ve yanlış inançlar

Gündelik yanlış inançlar

Mit 1: "Çok oynayan herkes bağımlıdır"

Çürütülmüştür. ICD-11 hiçbir süre eşiği içermez; tanı, kontrolün bozulmasını, diğer yaşam ilgi alanlarının yerinden edilmesini, zarara rağmen sürdürmeyi *ve* işlevsel bozulmayı gerektirir. WHO, oyun oynama bozukluğunun dijital ya da video oyunu oynayan kişilerin yalnızca küçük bir bölümünü etkilediğini belirtmektedir. Yakın tarihli bir genel değerlendirmede aktarılan kişi merkezli bir çalışma, günde dört saatten fazla oynayan ve düşük düzeyde psikolojik uyumsuzluk gösteren bir "tutkulu oyuncular" alt grubu tanımlamıştır (Musetti ve ark., 2025; Billieux ve ark., 2019).

Mit 2: "Oyun oynama bozukluğu oyuncuların büyük bir bölümünü etkiler"

Üst uçta çürütülmüştür. En iyi kalitedeki tahminler temsili örneklemlerde %2,4 ve yayın yanlılığı düzeltmesinden sonra %1,4 (Kim ve ark., 2022); katı örneklemli alt kümede %1,96 (%95 GA 0,19–17,12) (Stevens ve ark., 2021); ve dört büyük uluslararası örneklemde DSM-5 ölçütleriyle %0,3 ila %1,0'dır (Przybylski ve ark., 2017).

Mit 3: "Bozukluğu günde sabit bir saat sayısı tanımlar"

Çürütülmüştür. ICD-11 durumu kontrol, öncelik, zarara rağmen sürdürme ve işlevsel bozulma ile tanımlar. Süre prospektif bir risk faktörüdür ($r = 0,33$; Zhuang ve ark., 2023) ancak bir ölçüt değildir; ne gerekli ne de yeterlidir.

Mit 4: "Video oyunları şiddete yol açar"

Nedensel bir iddia olarak çürütülmüştür. American Psychological Association'ın Şubat 2020 tarihli karar revizyonu, şiddet içeren video oyunları ile şiddet davranışı arasında nedensel bir bağı destekleyecek yeterli bilimsel kanıt bulunmadığını belirtmekte ve kitlesel silahlı saldırılar dahil olmak üzere şiddetin video oyunu kullanımına atfedilmesine karşı açıkça uyarmaktadır. APA'nın 2015 görev gücü raporunun dayandığı verilerin yeniden analizi; saldırgan ve prososyal davranışla ihmal edilebilir ilişkiler, saldırgan duygulanım ve bilişlerle küçük ilişkiler ve duyarsızlaşmayla daha güçlü ilişkiler bulmuştur; etki büyüklükleri, özellikle deneysel çalışmalarda, en iyi olmayan uygulamalar ve araştırmacı beklenti etkileriyle yükselmiş görünmektedir (Ferguson ve ark., 2020). Duyarsızlaşma bulgusu genel savın tersine işlemektedir ve bu nedenle burada bildirilmektedir. Şiddet ile oyun oynama bozukluğu ayrı sorulardır ve birleştirilmemelidir.

Mit 5: "Oyun oynama bozukluğu, depresyonun ya da DEHB'nin bir semptomundan başka bir şey değildir"

Kısmen doğru ve gerçekten tartışmalı. Komorbidite yüksektir ve en tutarlı ilişkiyi DEHB göstermektedir ($r \approx 0,30$; Koncz ve ark., 2023); eleştirmenler bozulmuş oyun oynamanın büyük ölçüde duygudurum ve dikkat sorunlarına ikincil olduğunu savunmaktadır (van Rooij ve ark., 2018). Buna karşılık iki yıllık Singapur paneli, depresyon, anksiyete ve sosyal fobinin patolojik oyun oynamanın nedenlerinden çok sonuçları gibi davrandığını bulmuştur (Gentile ve ark., 2011). Her iki okuma da sunulmalıdır; soru çözülmüş değildir.

Mit 6: "Tüm oyunlardan tümüyle uzak durmak tek doğru tedavi hedefidir"

Kanıtlanmamıştır. Kısa süreli gönüllü uzak durmanın yalnızca pilot düzeyde desteği vardır (King ve ark., 2017) ve yeterli güce sahip hiçbir çalışma tam bırakmayı

kontrollü kullanım hedefleriyle karşılaştırmamıştır. Tedavi hedefi bireyselleştirilmelidir.

Mit 7: "Oyun oynama bozukluğunu iyileştiren bir ilaç vardır"

Çürütülmüştür. Hiçbir ajan bu endikasyon için düzenleyici onay taşımamaktadır; farmakolojik literatürün tamamı 12 çalışma ve 724 katılımcıdan oluşmakta, katılımcıların %98,6'sı erkek olup çalışmaların tümü Güney Kore'de yürütülmüş ve 12'sinin 8'i açık etiketli olmuştur (Sá ve ark., 2023). İlaçlar komorbid DEHB ya da depresyon için endikasyon dışı kullanılmaktadır.

Mit 8: "Ganimet kutuları ve oyun içi satın almalar zararsız eğlencedir"

Desteklenmemektedir. 7.422 oyuncuda ganimet kutusu harcaması sorunlu kumar şiddetiyle ilişkiliydi ($\eta^2 = 0,054$); bu etki diğer oyun içi satın almalardakinden bir büyüklük mertebesi daha büyüktü (Zendle ve Cairns, 2018). Kanıtlar kesitseldir ve her iki yönde de nedensellik kurmaz, ancak ilişki her değerlendirmede bunu sormayı gerektirecek kadar sağlamdır.

Mit 9: "Oyun oynama bozukluğu bir Asya sorunudur"

Abartılıdır. Doğu ve Güneydoğu Asya örneklemlerinden gelen yaygınlık tahminleri daha yüksek olma eğilimindedir, ancak en büyük meta-analizde tarama aracı çalışmalar arası varyansın %77'sini açıklamış ve bölge, bildirilen anlamlı yordayıcılar arasında yer almamıştır (Stevens ve ark., 2021); Kim ve ark. (2022) bölgeyi birkaç düzenleyiciden biri olarak saymaktadır. Bölge; araç, örneklem türü ve çalışma kalitesiyle karışmıştır ve dünyanın her yerinden olgu bildirilmektedir.

Mit 10: "Oyun oynama ve depresyon literatürü sağlamdır"

Çürütülmüştür. Oyun oynama bozukluğunu depresyon ya da anksiyete ile birlikte ele alan ve 196 birincil çalışmayı kapsayan yedi sistematik derlemenin değerlendirilmesi; yedisinde de seçici sonuç bildirimi, yalnızca birinde yanlılık riski değerlendirmesi ve tutarsız maruziyet tanımları bulmuştur; hiçbiri güvenilir olarak sınıflandırılmamıştır (Colder Carras ve ark., 2020).

Kategorinin kendisine ilişkin bilimsel tartışma

6C51, ICD-11'in bağımlılık yapıcı davranışlar grubundaki en tartışmalı tanıdır. Tartışma akademiktir, ticari değildir; ve buna ilişkin yaygın açıklamaların ikisi de — bir yanda sektör lobiciliği, diğer yanda saf ahlaki panik — yanlıştır.

Dahil edilmeye karşı sav. 2017'de 26 akademisyen, WHO önerisine karşı çıkan açık bir tartışma makalesi yayımladı (Aarseth ve ark., 2017). Savları şunlardı:

araştırma tabanının kalitesi düşüktü; işlevselleştirme, madde kullanımı ve kumar ölçütlerinden eleştirisiz ödünç alınmıştı; tanı, normal, sağlıklı, yoğun oyunu patolojikleştirme riski taşıyordu; ve resmileştirme ahlaki paniği körükleyebilir, geniş bir eğlence amaçlı nüfusu damgalayabilir ve çocukların gereksiz tedavisine yol açabilirdi. Kısmen örtüşen bir grup daha sonra, tanıların kötüye kullanılabilmesi nedeniyle bir araştırma yapısından resmi bir bozukluğa geçmek için gereken kanıt yükünün çok yüksek olduğunu ve WHO'nun resmileştirmeyi ertelemesi gerektiğini savundu (van Rooij ve ark., 2018).

Dahil edilme lehine sav. WHO uzman danışma çıktısı, oyun oynama bozukluğunun bağımlılık yapıcı bir bozukluğun temel özelliklerini taşıdığını ve halihazırda tedaviye başvuran kişiler için bir kategorinin gerekli olduğunu savundu (Saunders ve ark., 2017). Rumpf ve arkadaşları klinik ve halk sağlığı açısından yanıt verdi: bu hastalar için tedavi hizmetleri birçok ülkede zaten mevcuttu; bir kategori olmadan hastalar güvenilir biçimde tanımlanamaz, hizmetler planlanamaz ya da finanse edilemez ve araştırmalar standartlaştırılamazdı; aşırı tanı riski ise ICD-11'in katı işlevsel bozulma koşuluyla hafifletilmektedir (Rumpf ve ark., 2018). Griffiths ve arkadaşları, sorunlu oyun oynamanın gösterilebilir biçimde var olduğunu ve bozulmuş oyun oynama oluşturduğunu savundu (Griffiths ve ark., 2017).

WHO'nun konumu. WHO kategoriyi korudu, dahil edilmeyi dünyanın birçok yerinde özdeş klinik görünümler için tedavi programlarının bağımsız olarak gelişmesinin ardından atılmış bir adım olarak çerçeveledi ve kamuya yönelik rehberliğinde oyun oynama bozukluğunun oyun oynayan kişilerin yalnızca küçük bir bölümünü etkilediğini vurguladı — aşırı patolojikleştirme itirazını etkisizleştirmeye yönelik açık bir girişim.

Sektörün konumu. Yaygın bir varsayımın tersine, video oyunu sektörü tanıya karşı çıktı. Entertainment Software Association bağımlılık çerçevesini kamuya açık biçimde reddetti ve WHO'yu yön değiştirmeye çağırdı; benzer kaygılar European Games Developer Federation tarafından da dile getirildi (Musetti ve ark., 2025'te aktarılmaktadır). Tanı sektör lobiciliğine atfedilemez ve ahlaki panik itirazı sektörden değil akademinin içinden gelmiştir.

Gerçekten çözülmemiş olanlar. Üç şey; her biri klinisyenin hastaya ne söyleyeceğini değiştirir. ICD-11 rehberinin değerlendiriciler arası güvenirliği bir kez, tek bir ülkede, okul temelli tek bir örneklemde sınanmış ve orta düzeyde çıkmıştır (κ = 0,545). Kategorik olgu olma durumu her iki tanı sisteminde de tek bir yıl içinde kararsızdır. Ve en sık görülen komorbiditelere ilişkin sentez literatürü kabul görmüş yöntemsel standartları karşılamamaktadır. Bunların hiçbiri tanıyı kullanılamaz kılmaz; ancak hepsi birlikte, kendinden emin bir prognozu haksız kılar.

11. Kaynaklar

1. World Health Organization. ICD-11 for Mortality and Morbidity Statistics: 6C51 Gaming disorder. Geneva: WHO; 2019 (2025-01 release).
2. World Health Organization. ICD-11 for Mortality and Morbidity Statistics: QE22 Hazardous gaming. Geneva: WHO; 2019 (2025-01 release).
3. World Health Organization. Clinical Descriptions and Diagnostic Requirements for ICD-11 Mental, Behavioural and Neurodevelopmental Disorders (CDDR). Geneva: WHO; 2024.
4. World Health Organization. Addictive behaviours: Gaming disorder — Questions and answers. Geneva: WHO.
5. American Psychiatric Association. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fifth Edition, Text Revision (DSM-5-TR). Washington, DC: American Psychiatric Association Publishing; 2022. (Internet gaming disorder — Section III, Conditions for Further Study.)
6. American Psychological Association. APA Resolution on Violent Video Games: February 2020 Revision. Washington, DC: APA; 2020.
7. American Psychological Association. APA reaffirms position on violent video games and violent behavior [press release]. 3 March 2020.
8. National Institute for Health and Care Excellence. Gambling-related harms: identification, assessment and management. NICE guideline NG248. London: NICE; 28 January 2025. (Cited for contrast: no NICE guideline exists for gaming disorder.)
9. Aarseth E, Bean AM, Boonen H, Colder Carras M, Coulson M, Das D, et al. Scholars' open debate paper on the World Health Organization ICD-11 Gaming Disorder proposal. J Behav Addict. 2017;6(3):267–270. doi:10.1556/2006.5.2016.088
10. Billieux J, Flayelle M, Rumpf HJ, Stein DJ. High involvement versus pathological involvement in video games: a crucial distinction for ensuring the validity and utility of gaming disorder. Curr Addict Rep. 2019;6(3):323–330. doi:10.1007/s40429-019-00259-x
11. Brand M, Young KS, Laier C, Wölfling K, Potenza MN. Integrating psychological and neurobiological considerations regarding the development and maintenance of specific Internet-use disorders: an Interaction of Person-Affect-Cognition-Execution (I-PACE) model. Neurosci Biobehav Rev. 2016;71:252–266. doi:10.1016/j.neubiorev.2016.08.033
12. Brand M, Wegmann E, Stark R, Müller A, Wölfling K, Robbins TW, Potenza MN. The Interaction of Person-Affect-Cognition-Execution (I-PACE) model for addictive behaviors: update, generalization to addictive behaviors beyond internet-use disorders, and specification of the process

character of addictive behaviors. Neurosci Biobehav Rev. 2019;104:1–10. doi:10.1016/j.neubiorev.2019.06.032

13. Colder Carras M, Shi J, Hard G, Saldanha IJ. Evaluating the quality of evidence for gaming disorder: a summary of systematic reviews of associations between gaming disorder and depression or anxiety. PLoS One. 2020;15(10):e0240032. doi:10.1371/journal.pone.0240032
14. Danielsen PA, Mentzoni RA, Låg T. Treatment effects of therapeutic interventions for gaming disorder: a systematic review and meta-analysis. Addict Behav. 2024;149:107887. doi:10.1016/j.addbeh.2023.107887 (PMID 37826910)
15. Ferguson CJ, Copenhaver A, Markey P. Reexamining the findings of the American Psychological Association's 2015 task force on violent media: a meta-analysis. Perspect Psychol Sci. 2020;15(6):1423–1443. doi:10.1177/1745691620927666
16. Gentile DA, Choo H, Liau A, Sim T, Li D, Fung D, Khoo A. Pathological video game use among youths: a two-year longitudinal study. Pediatrics. 2011;127(2):e319–e329. doi:10.1542/peds.2010-1353
17. Gentile DA, Bailey K, Bavelier D, Brockmyer JF, Cash H, Coyne SM, et al. Internet gaming disorder in children and adolescents. Pediatrics. 2017;140(Suppl 2):S81–S85. doi:10.1542/peds.2016-1758H
18. Griffiths MD, Kuss DJ, Lopez-Fernandez O, Pontes HM. Problematic gaming exists and is an example of disordered gaming. J Behav Addict. 2017;6(3):296–301. doi:10.1556/2006.6.2017.037
19. Han DH, Renshaw PF. Bupropion in the treatment of problematic online game play in patients with major depressive disorder. J Psychopharmacol. 2012;26(5):689–696. doi:10.1177/0269881111400647 (PMID 21447539)
20. Hong YN, Hwang H, Starcevic V, Choi TY, Kim TH, Han DH. Which is more stable and specific: DSM-5 internet gaming disorder or ICD-11 gaming disorder? A longitudinal study. Psychiatry Clin Neurosci. 2023;77(4):213–222. doi:10.1111/pcn.13522 (PMID 36562926)
21. Kardefelt-Winther D. A conceptual and methodological critique of internet addiction research: towards a model of compensatory internet use. Comput Human Behav. 2014;31:351–354. doi:10.1016/j.chb.2013.10.059
22. Kim HS, Son G, Roh EB, Ahn WY, Kim J, Shin SH, Chey J, Choi KH. Prevalence of gaming disorder: a meta-analysis. Addict Behav. 2022;126:107183. doi:10.1016/j.addbeh.2021.107183 (PMID 34864436)
23. King DL, Billieux J, Carragher N, Delfabbro PH. Face validity evaluation of screening tools for gaming disorder: scope, language, and overpathologizing

issues. J Behav Addict. 2020;9(1):1–13. doi:10.1556/2006.2020.00001 (PMID 32359228)

24. King DL, Kaptsis D, Delfabbro PH, Gradisar M. Effectiveness of brief abstinence for modifying problematic internet gaming cognitions and behaviors. J Clin Psychol. 2017;73(12):1573–1585. doi:10.1002/jclp.22460 (PMID 28152189)
25. Király O, Sleczka P, Pontes HM, Urbán R, Griffiths MD, Demetrovics Z. Validation of the Ten-Item Internet Gaming Disorder Test (IGDT-10) and evaluation of the nine DSM-5 Internet Gaming Disorder criteria. Addict Behav. 2017;64:253–260. doi:10.1016/j.addbeh.2015.11.005
26. Király O, Bőthe B, et al. Ten-Item Internet Gaming Disorder Test (IGDT-10): measurement invariance and cross-cultural validation across seven language-based samples. Psychol Addict Behav. 2019;33(1):91–103. doi:10.1037/adb0000433
27. Koncz P, Demetrovics Z, Takacs ZK, Griffiths MD, Nagy T, Király O. The emerging evidence on the association between symptoms of ADHD and gaming disorder: a systematic review and meta-analysis. Clin Psychol Rev. 2023;106:102343. doi:10.1016/j.cpr.2023.102343 (PMID 37883910)
28. Kuss DJ, Griffiths MD, Pontes HM. Chaos and confusion in DSM-5 diagnosis of Internet Gaming Disorder. J Behav Addict. 2017;6(2):103–109. doi:10.1556/2006.5.2016.062
29. Ma C, Wang Z, Li C, Lu J, Long J, Li R, Wu Q, Jiang H, Du J, Li R, Wang P, Ma L, Li H, Hui S, Zhao W, Zhong N, Zhao M. The clinical consistency and utility of ICD-11 diagnostic guidelines for gaming disorder: a field study among the Chinese population. Front Psychiatry. 2021;12:781992. doi:10.3389/fpsyt.2021.781992 (PMID 35002801; 781992 is the article number)
30. Müller SM, Wegmann E, Oelker A, Stark R, Müller A, Montag C, Wölfling K, Rumpf HJ, Brand M. Assessment of Criteria for Specific Internet-use Disorders (ACSID-11): introduction of a new screening instrument capturing ICD-11 criteria for gaming disorder and other potential Internet-use disorders. J Behav Addict. 2022;11(2):427–450. doi:10.1556/2006.2022.00013
31. Musetti A, Floros G, Chiappedi M, Stavropoulos V. Gaming disorder in the ICD-11: the state of the game. BMC Psychiatry. 2025;25(1):1114. doi:10.1186/s12888-025-07576-8 (PMID 41272537; 1114 is the article number)
32. Nam B, Bae S, Kim SM, Hong JS, Han DH. Comparing the effects of bupropion and escitalopram on excessive internet game play in patients with

major depressive disorder. Clin Psychopharmacol Neurosci. 2017;15(4):361–368. doi:10.9758/cpn.2017.15.4.361 (PMID 29073748)

33. Ock CM, Lee HS, Chae J, Kim H. Effectiveness of non-pharmacological interventions on gaming disorder: a systematic review and meta-analysis. Psychiatry Investig. 2025;22(5):490–503. doi:10.30773/pi.2024.0358
34. Paruthi S, Brooks LJ, D'Ambrosio C, Hall WA, Kotagal S, Lloyd RM, et al. Recommended amount of sleep for pediatric populations: a consensus statement of the American Academy of Sleep Medicine. J Clin Sleep Med. 2016;12(6):785–786. doi:10.5664/jcsm.5866
35. Paulus FW, Ohmann S, von Gontard A, Popow C. Internet gaming disorder in children and adolescents: a systematic review. Dev Med Child Neurol. 2018;60(7):645–659. doi:10.1111/dmcn.13754
36. Pontes HM, Griffiths MD. Measuring DSM-5 Internet gaming disorder: development and validation of a short psychometric scale. Comput Human Behav. 2015;45:137–143. doi:10.1016/j.chb.2014.12.006
37. Pontes HM, Schivinski B, Sindermann C, Li M, Becker B, Zhou M, Montag C. Measurement and conceptualization of Gaming Disorder according to the World Health Organization framework: the development of the Gaming Disorder Test. Int J Ment Health Addict. 2021;19(2):508–528. doi:10.1007/s11469-019-00088-z
38. Poon LYJ, Tsang HWH, Chan TYJ, Man SWT, Ng LY, Wong YLE, Lin CY, Chien CW, Griffiths MD, Pontes HM, Pakpour AH. Psychometric properties of the Internet Gaming Disorder Scale-Short-Form (IGDS9-SF): systematic review. J Med Internet Res. 2021;23(10):e26821. doi:10.2196/26821 (e26821 is the article number)
39. Przybylski AK, Weinstein N, Murayama K. Internet gaming disorder: investigating the clinical relevance of a new phenomenon. Am J Psychiatry. 2017;174(3):230–236. doi:10.1176/appi.ajp.2016.16020224
40. Jahrami H., Husain W., Lin C.-Y. et al. Reliability generalization meta-analysis and psychometric review of the Gaming Disorder Test (GDT): evaluating internal consistency. Addict Behav Rep 2024;20:100563.
41. Ropovik I, Martončik M, Babinčák P, Baník G, Vargová L, Adamkovič M. Risk and protective factors for (internet) gaming disorder: a meta-analysis of pre-COVID studies. Addict Behav. 2023;139:107590. doi:10.1016/j.addbeh.2022.107590 (107590 is the article number)
42. Rumpf HJ, Achab S, Billieux J, Bowden-Jones H, Carragher N, Demetrovics Z, et al. Including gaming disorder in the ICD-11: the need to do so from a clinical and public health perspective. J Behav Addict. 2018;7(3):556–561. doi:10.1556/2006.7.2018.59

43. Sá RRC, Coelho S, Parmar PK, Johnstone S, Kim HS, Tavares H. A systematic review of pharmacological treatments for Internet Gaming Disorder. Psychiatry Investig. 2023;20(8):696–706. doi:10.30773/pi.2022.0297 (PMID 37559452)
44. Satish Kumar CR, Sharma MK, Amudhan S, Arya S, Mahapatra S, Anand N, et al. Digital gaming, musculoskeletal, and related health hazards among adolescents and young adults. Indian J Psychiatry. 2023;65(6):698–700. doi:10.4103/indianjpsychiatry.indianjpsychiatry_818_22
45. Saunders JB, Hao W, Long J, King DL, Mann K, Fauth-Bühler M, et al. Gaming disorder: its delineation as an important condition for diagnosis, management, and prevention. J Behav Addict. 2017;6(3):271–279. doi:10.1556/2006.6.2017.039
46. Stevens MW, Dorstyn D, Delfabbro PH, King DL. Global prevalence of gaming disorder: a systematic review and meta-analysis. Aust N Z J Psychiatry. 2021;55(6):553–568. doi:10.1177/0004867420962851
47. Stevens MW, Dorstyn D, Delfabbro PH, King DL. Corrigendum to: Global prevalence of gaming disorder: a systematic review and meta-analysis. Aust N Z J Psychiatry. 2023;57(6):928. doi:10.1177/00048674221137011 (PMID 36433839)
48. Stevens MWR, King DL, Dorstyn D, Delfabbro PH. Cognitive-behavioral therapy for Internet gaming disorder: a systematic review and meta-analysis. Clin Psychol Psychother. 2019;26(2):191–203. doi:10.1002/cpp.2341
49. Sun AP, Ho CH, Kuss DJ, Cross CL. The temporal stability of problematic gaming and gaming disorder: a systematic review and meta-analysis. Addict Behav Rep. 2025;21:100592. doi:10.1016/j.abrep.2025.100592 (PMID 40125549; 100592 is the article number)
50. Torres-Rodríguez A, Griffiths MD, Carbonell X, Oberst U. Treatment efficacy of a specialized psychotherapy program for Internet Gaming Disorder. J Behav Addict. 2018;7(4):939–952. doi:10.1556/2006.7.2018.111 (PMID 30427213)
51. van Rooij AJ, Ferguson CJ, Colder Carras M, Kardefelt-Winther D, Shi J, Aarseth E, et al. A weak scientific basis for gaming disorder: let us err on the side of caution. J Behav Addict. 2018;7(1):1–9. doi:10.1556/2006.7.2018.19
52. Vink JM, van Beijsterveldt TCEM, Huppertz C, Bartels M, Boomsma DI. Heritability of compulsive Internet use in adolescents. Addict Biol. 2016;21(2):460–468. doi:10.1111/adb.12218
53. Wölfling K, Müller KW, Dreier M, Ruckes C, Deuster O, Batra A, et al. Efficacy of short-term treatment of internet and computer game addiction: a randomized clinical trial. JAMA Psychiatry. 2019;76(10):1018–1025. doi:10.1001/jamapsychiatry.2019.1676 (PMID 31290948)

54. Young KS. Internet addiction: the emergence of a new clinical disorder. CyberPsychology and Behavior. 1998;1(3):237–244. doi:10.1089/cpb.1998.1.237
55. Zendle D, Cairns P. Video game loot boxes are linked to problem gambling: results of a large-scale survey. PLoS One. 2018;13(11):e0206767. doi:10.1371/journal.pone.0206767
56. Zheng H, Hu Y, Wang Z, Wang M, Du X, Dong G. Meta-analyses of the functional neural alterations in subjects with Internet gaming disorder: similarities and differences across different paradigms. Prog Neuropsychopharmacol Biol Psychiatry. 2019;94:109656. doi:10.1016/j.pnpbp.2019.109656 (PMID 31145927)
57. Zhuang X, Zhang Y, Tang X, Ng TK, Lin J, Yang X. Longitudinal modifiable risk and protective factors of internet gaming disorder: a systematic review and meta-analysis. J Behav Addict. 2023;12(2):375–392. doi:10.1556/2006.2023.00017

6C70–6C7Z DÜRTÜ KONTROLÜ

Impulse control disorders

ICD-11 **6C70**	**6C70 PİROMANİ** **Pyromania**
ICD-10 F63.1	Patolojik yangın-çıkartma [piromani]
DSM-5-TR F63.1	Piromani

1. Tanım ve nozoloji

Piromani (ICD-11: 6C70; DSM-5-TR: F63.1) — kasıtlı, amaçlı yangın çıkarma davranışı; eylem öncesi gerginlik veya duygusal uyarılma, eylem sonrası rahatlama veya zevk. Maddi kazanç, intikam veya ideolojik amaç olmaksızın; nadir dürtü kontrol bozukluğudur.

2. Tarihçe

- 1830'larda Marc — “monomanie incendiaire”.
- DSM-III (1980) — dürtü kontrol bozuklukları içinde.
- ICD-11 (2019) — dürtü kontrol bozuklukları kategorisinde.

3. Epidemiyoloji

- Nadir — yangın çıkarma olaylarının yalnızca ~%3–10'u piromani kriterlerini karşılar (çoğu yangın çıkarmanın mali, intikam veya başka motivasyonu).
- Cinsiyet: erkeklerde yüksek.
- Başlangıç: ergenlik.
- Komorbidite: davranım bozukluğu, ASKB, İD, DEHB, diğer madde kullanımı.

4. Etiyoloji ve patogenez

- Çok sayıda faktör — nörobiyolojik dürtü kontrolü, bilişsel defisit, aile disfonksiyonu.

- Komorbid bozukluklar tipik.

5. Klinik özellikler

- Tekrarlayan kasıtlı yangın çıkarma.
- Eylemden önce gerginlik/duygusal heyecan.
- Yangına ve araçlarına (alev, alet) hayranlık.
- Eylemden sonra zevk, rahatlama.
- Mali kazanç, intikam, ideolojik amaç veya psikotik zorlama (sanrı) yok.

6. Tanı

6.1 Birleşik tanı ölçütleri

A. Birden fazla kasten yangın çıkarma.

B. Eylemden önce gerginlik veya duygusal heyecan.

C. Ateşe ve bağlamına (nesneler, araçlar) hayranlık.

D. Eylemin icrası, gözlemi, sonucu zevk verir.

E. Yangın mali, intikam, ideolojik, sosyo-politik veya psikotik motivasyonla değil.

F. Davranış bozukluğu, manik epizod, ASPD ile daha iyi açıklanmaz.

6.2 Kaynaklar arasındaki farklar

- DSM-5-TR / ICD-11 — aynı.
- Klinik pratikte nadir; çoğu kundakçılık motivasyon temelli.

6.3 Tanı algoritması

1. Klinik görüşme + aile/tanık bilgisi.
2. Motivasyon öyküsü — piromani kriterlerine uygunluk.
3. Komorbidite (ASPD, davranış bozukluğu, manik, psikoz, İD, DEHB).
4. Hukuki bağlam — adli psikiyatri konsültasyonu.

6.4 Ayırıcı tanı

Durum	Ayırt edici
Davranış Bozukluğu (6C91)	Çok sayıda antisosyal davranış.

Durum	Ayırt edici
ASPD (Antisosyal kişilik)	Sürekli antisosyal model.
Manik epizod	Afektif epizodla ilişkili.
Psikotik motivasyon	Sanrı (örn. "sesler"); şizofreni, sanrı bozukluğu.
İntikam / mali / ideolojik	Klinik tanı değil — adli konu.

7. Muayene ve değerlendirme

- Psikiyatrik görüşme.
- Zekâ değerlendirmesi.
- Dürtüsellik ölçekleri (Barratt Dürtüsellik Ölçeği).
- Adli bağlamda yapılandırılmış risk değerlendirmesi (HCR-20, VRAG).

8. Tedavi

1. Kanıt temeli sınırlıdır (nadir bozukluk).
2. BDT — dürtü kontrolü, tetikleyicilerin yönetimi, maruz bırakma alternatif davranışa.
3. Komorbid bozuklukların tedavisi (ASPD'de terapötik sınırlama, İD'de davranış müdahalesi, DEHB'de stimülan).
4. SSRI — dürtü kontrolü için endikasyon dışı.
5. Hukuki-psikiyatrik koordinasyon (hastaneye yatış, mahkeme kararı).

8.1 Tedavi metodolojileri

1. Dürtü kontrolü için BDT — Tetikleyici tanımlama, davranış değiştirme.
2. Komorbidite tedavisi — Davranış bozukluğu, İD, DEHB için spesifik müdahale.
3. Adli risk değerlendirmesi — HCR-20, VRAG.

9. Prognoz

- Kanıt temeli sınırlıdır; komorbid bozukluk ve psikososyal destek prognozu belirler.

10. Mit ve yanlış inançlar

Mit 1: "Tüm kundakçılar piromanidir"

Kanıt: Çoğu kundakçılık motivasyon temellidir (mali, intikam) — piromani yok; ~%3-10 klinik tanıya uyar.

Mit 2: "Pyromani sadece çocuk fenomenidir"

Kanıt: başlangıç genellikle ergenlikte, ancak yetişkinlikte de devam edebilir.

Mit 3: "Spesifik etkili farmakoterapi vardır"

Kanıt: FDA onayı yoktur; SSRI off-label, kanıt temeli sınırlı.

Mit 4: "Hukuki ceza tek başına yeterlidir"

Kanıt: klinik müdahale ve komorbidite tedavisi nüks riskini azaltır.

11. Kaynaklar

1. WHO. ICD-11. 6C70 Pyromania. 2024.
2. APA. DSM-5-TR. 2022.
3. Burton P.R., McNiel D.E., Binder R.L. Firesetting, arson, pyromania, and the forensic mental health expert. J Am Acad Psychiatry Law 2012;40(3):355–365.

ICD-11 **6C71**	**6C71 KLEPTOMANİ** **Kleptomania**
ICD-10 F63.2	Patolojik çalma [kleptomani]
DSM-5-TR F63.2	Kleptomani

1. Tanım ve nozoloji

Kleptomani (ICD-11: 6C71; DSM-5-TR: F63.2) — kişisel kullanım veya maddi değeri için gerekli olmayan eşyaların çalınması için tekrarlayan, direnilemeyen dürtü; eylem öncesi gerginlik, eylem sonrası rahatlama veya zevk.

2. Tarihçe

- Esquirol (1838) — “kleptomanie”.
- DSM-III — dürtü kontrol bozuklukları.
- ICD-11 — dürtü kontrol bozuklukları.

3. Epidemiyoloji

- Mağaza hırsızlığı olaylarının yalnızca ~%5'i kleptomaniye uygundur (çoğu hırsızlık motivasyon-temelli).
- Cinsiyet: kadınlarda yüksek (klinik popülasyonlarda).
- Komorbidite: duygudurum bozuklukları serilere göre %45–100, MDD ~%65'e kadar; anksiyete, OKB, yeme bozuklukları, madde kullanımı.

4. Etiyoloji ve patogenez

- Serotonin ve opioid sistem disregülasyonu hipotezi (Grant J.E.).
- Komorbid afektif ve dürtüsellik bozuklukları.

5. Klinik özellikler

- Çalma eylemine direnç göstermede başarısızlık — kişisel veya mali değer için gerekli olmayan eşya.
- Eylemden önce gerginlik artışı.
- Eylemden sonra rahatlama, zevk.
- Çalma öfke, intikam veya psikotik motivasyonla değil.
- Nesneler tipik olarak sonradan atılır, başkasına verilir, saklanır; bazen gizlice geri konur.

6. Tanı

6.1 Birleşik tanı ölçütleri

A. Kişisel veya maddi değeri için gerekli olmayan eşyaları çalmaya yönelik tekrarlayan dürtüye karşı koyamama.

B. Eylemden önce gerginlik.

C. Eylemden sonra rahatlama, zevk.

D. Çalma öfke, intikam, sanrı veya halüsinasyon motivasyonuyla değil.

E. Davranış bozukluğu, manik epizod, ASPD ile daha iyi açıklanmaz.

6.2 Kaynaklar arasındaki farklar

DSM-5-TR / ICD-11 — aynı kriterler.

6.3 Tanı algoritması

1. Klinik görüşme.
2. K-SAS (Kleptomani Semptom Değerlendirme Ölçeği) — Grant J.E.
3. Komorbid MDD, anksiyete, OKB, yeme bozuklukları.

6.4 Ayırıcı tanı

Durum	**Ayırt edici**
Adi hırsızlık	Motivasyon — kazanç, ihtiyaç.
ASPD	Sürekli antisosyal model.
Manik epizod	Afektif kontekst.
Davranış Bozukluğu (6C91)	Çok sayıda antisosyal davranış.
Demans	Bilişsel gerileme.

7. Muayene ve değerlendirme

- K-SAS.
- Komorbidite ölçekleri.

8. Tedavi

1. Naltrekson — Grant J.E. et al. Biol Psychiatry 2009 RKÇ — kleptomanide etkili (50–150 mg/gün).
2. BDT — bilişsel yeniden yapılandırma, davranışsal aktivasyon, maruz bırakma ve ritüel önleme.
3. SSRI — komorbid MDB için.
4. Multidisipliner yaklaşım — hukuki bağlam.

8.1 Tedavi metodolojileri

1. Naltrekson — Opioid antagonisti; kleptomanide dürtüyü azaltır.
2. Dürtü kontrolü için BDT — Tetikleyicilerin kontrolü.
3. Kleptomani Semptom Değerlendirme Ölçeği (K-SAS — Kleptomania Symptom Assessment Scale) — Şiddet skalası.

8.2 Kaynaklar arasındaki farklar

- Grant J.E. — naltrekson kanıt temeli.

9. Prognoz

- Naltrekson ve BDT ile anlamlı iyileşme.
- Komorbid MDD kötü prognoz.

10. Mit ve yanlış inançlar

Mit 1: "Tüm tekrarlayan hırsızlık kleptomanidir"

Kanıt: Çoğu hırsızlık motivasyon temellidir; kleptomani nadirdir.

Mit 2: "Hasta 'iradi olarak' durdurabilir"

Kanıt: dürtü kontrol bozukluğudur — direnç gösterme başarısızlığı klinik tanısal özellik.

Mit 3: "Hukuki ceza tek başına yeterlidir"

Kanıt: klinik müdahale ve komorbidite tedavisi nüks riskini azaltır.

Mit 4: "Spesifik tedavi yoktur"

Kanıt: naltrekson kanıt temeli (Grant 2009 RKÇ); BDT etkilidir.

11. Kaynaklar

1. WHO. ICD-11. 6C71 Kleptomania. 2024.
2. APA. DSM-5-TR. 2022.
3. Grant J.E. et al. A double-blind, placebo-controlled study of the opiate antagonist naltrexone in the treatment of kleptomania. Biol Psychiatry 2009;65(7):600–606.

ICD-11 **6C72**	**6C72 KOMPULSİF CİNSEL DAVRANIŞ BOZUKLUĞU** **Compulsive sexual behaviour disorder**
ICD-10 F52.7	Aşırı seksüel istek
DSM-5-TR —	DSM-5-TR'de karşılığı yoktur

1. Tanım ve nozoloji

Kompulsif Cinsel Davranış Bozukluğu (ICD-11: 6C72 Compulsive Sexual Behaviour Disorder) — yoğun, tekrarlayan cinsel dürtüleri ve davranışları kontrol etmede sürekli başarısızlık paterni; belirgin sıkıntı veya işlevsel bozulmaya yol açar. ICD-11'de dürtü kontrol bozuklukları kategorisine dahil edilmiştir.

DSM-5-TR'de ayrı bir tanı yoktur ("Hypersexual Disorder" DSM-5'e dahil edilmemiştir). "Sex addiction" terimi bilimsel topluluk tarafından tartışmalıdır.

2. Tarihçe

- Krafft-Ebing (1886) — "hyperaesthesia sexualis".
- 1980-90'lar — "sexual addiction" konsepti (Carnes P.) popülerleşti, ancak bilimsel topluluk tarafından tartışmalı kaldı.
- DSM-5 (2013) — "Hypersexual Disorder" dahil edilmedi.
- ICD-11 (2019) — Kompulsif Cinsel Davranış Bozukluğu (dürtü kontrolü, bağımlılık DEĞİL) resmi kategori olarak eklendi.

3. Epidemiyoloji

- Yaygınlık: %1–6 (geniş aralık, ölçüm araçlarına bağlı).
- Cinsiyet: erkeklerde yüksek (klinik popülasyonlarda 5:1).
- Komorbidite: MDD, anksiyete, BPD, madde kullanımı, OKB, DEHB.

4. Etiyoloji ve patogenez

- Çok sayıda faktör — dürtüsellik, kompulsivite, bilişsel-duygusal disregülasyon, travma.
- Nörobiyolojik benzerlikler madde kullanım bozuklukları ve OKB ile.
- Sosyo-kültürel — internet pornografisi erişilebilirliği.

5. Klinik özellikler

- Cinsel fantezilere, dürtülere, davranışlara aşırı zaman harcama.
- Olumsuz sonuçlara rağmen davranışı azaltma girişimlerinin başarısızlığı.
- Distressi azaltma veya duygusal kabul için cinsel davranış kullanımı.
- Cinsel davranış kontrol bozukluğu ile belirgin işlevsel bozulma (ilişkiler, iş, sağlık, hukuki).
- Tipik formlar — kompulsif mastürbasyon, çok sayıda cinsel partner, ticari cinsel hizmetlere müşteri olma, sorunlu pornografi kullanımı.

6. Tanı

6.1 Birleşik tanı ölçütleri (ICD-11)

A. Yoğun cinsel dürtüleri ve davranışları kontrol etmede sürekli başarısızlık paterni.

B. Aşağıdakilerden ≥ 1:

1. Tekrarlayan cinsel aktivite bireyin hayatının diğer alanlarının (sağlık, ilişkiler, sorumluluk) zayıflamasına yol açar;
2. Hasta kontrolü ele geçirmek için tekrarlayan ve önemli girişimlerde bulunmuştur — başarısız olmuştur.
3. Davranış olumsuz sonuçlara rağmen devam eder;
4. Davranış klinik olarak anlamlı zevk yaratmasa bile devam eder.

C. Süre ≥ 6 ay.

D. Önemli distress veya fonksiyonel bozulma.

E. Yalnızca ahlaki-dini yargı ve onaylamamaya bağlı sıkıntı ölçütü karşılamaz; işlevsel bozulma ya da bu yargıdan bağımsız bir sıkıntı gerekir.

6.2 Kaynaklar arasındaki farklar

- ICD-11: dürtü kontrol bozuklukları; “sex addiction” terimi kullanılmaz.
- DSM-5-TR: ayrı bir tanı yoktur; klinik pratikte “Other Specified Disruptive, Impulse-Control, and Conduct Disorder” içinde yer alır.

- Manevi-dini sıkıntı temelinde tanı konulmamalıdır.

6.3 Tanı algoritması

1. Klinik görüşme.
2. Ölçek — CSBI (Compulsive Sexual Behavior Inventory).
3. Komorbidite (MDD, anksiyete, BPD, madde, OKB).
4. Cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlar (STI) taraması.
5. Hukuki ve ilişki sonuçları.

6.4 Ayırıcı tanı

Durum	**Ayırt edici**
Manik epizod (hiperseksüalite)	Afektif kontekst.
BPD (impulsivite)	Sürekli model tüm alanlara.
OKB (cinsel obsesyonlar)	Ego-distonik obsesyon; ritüel.
Parafilik bozukluk (6D3x)	Spesifik atipik cinsel nesne.
Yüksek cinsel ilgi (normal varyant)	Fonksiyonel bozulma yok.
Yalnızca ahlaki-dini onaylamama	Klinik tanı temeli değil.

7. Muayene ve değerlendirme

- CSBI.
- Komorbidite ölçekleri.
- STI taraması.

8. Tedavi

1. Psikoterapi birinci sıra — BDT, ACT, mindfulness temelli yaklaşım. Kanıt temeli gelişmekte.
2. Naltrekson off-label — opioid antagonisti; bazı çalışmalarda hafif etki.
3. SSRI — komorbid MDB/anksiyetede.
4. Grup desteği (S-Anon, SAA) — adjuvan.
5. İlişki/çift terapisi — komorbid bağlamda.
6. Spesifik FDA onaylı farmakoterapi yoktur.

8.1 Tedavi metodolojileri

1. BDT ve Kabul-Kararlılık Terapisi (ACT) — Tetikleyicilerin kontrolü, değer-temelli davranış.
2. Naltrekson off-label — Craving azaltma.
3. Kompulsif Cinsel Davranış Envanteri (CSBI — Compulsive Sexual Behavior Inventory) — Şiddet skalası.
4. Self-help (SAA, SLAA) — 12-step temelli; kanıt temeli sınırlı.

8.2 Kaynaklar arasındaki farklar

- WHO — ICD-11 resmi kategori.
- APA — DSM-5-TR'de ayrı tanı yok; tartışmalı alan.

9. Prognoz

- BDT ve ACT ile anlamlı iyileşme.
- Komorbidite tedavisi önemli.

10. Mit ve yanlış inançlar

Mit 1: “Seks bağımlılığı madde bağımlılığı gibi bir tanıdır”

Kanıt: ICD-11 — dürtü kontrol bozukluğu; “bağımlılık” konsepti tartışmalı, DSM-5'te kabul edilmemiş.

Mit 2: “Yüksek cinsel ilgi seks bağımlılığı belirtisidir”

Kanıt: Klinik tanı işlevsel bozulma ve kontrol başarısızlığı gerektirir; sadece yüksek cinsel aktivite hastalık değildir.

Mit 3: “Manevi-dini normun ihlali tanı için temeldir”

Kanıt: ICD-11 — dini-manevi açıklama yeterli değil; işlevsel bozulma ya da belirgin sıkıntı gereklidir.

Mit 4: “Pornografi kullanımı her zaman bir hastalıktır”

Kanıt: normal kullanım ve kompulsif kullanım farklıdır; kontrol bozukluğu ve fonksiyonel yük tanısaldır.

Mit 5: “Kimyasal kastrasyon (testosteron supresyonu) standart tedavidir”

Kanıt: bu yaklaşım yalnızca şiddetli parafilik bozukluklarda (örn. pedofilik aktif risk) WFSBP kılavuzuna göre; genel kompulsif cinsel davranış için önerilmez.

11. Kaynaklar

1. WHO. ICD-11. 6C72 Compulsive sexual behaviour disorder. 2024.
2. APA. DSM-5-TR. 2022.
3. Kraus S.W. et al. Compulsive sexual behaviour disorder in the ICD-11. World Psychiatry 2018;17(1):109–110.
4. Grubbs J.B., Hoagland K.C., Lee B.N. et al. Sexual addiction 25 years on. Clin Psychol Rev 2020;82:101925.

ICD-11 **6C73**	**6C73 ARALIKLI PATLAYICI BOZUKLUK (IED)** **Intermittent explosive disorder**
ICD-10 F63.8	Alışkanlık ve impuls bozuklukları, diğer
DSM-5-TR F63.81	Aralıklı Patlayıcı Bozukluk

1. Tanım ve nozoloji

Aralıklı Patlayıcı Bozukluk (IED; ICD-11: 6C73 Intermittent Explosive Disorder; DSM-5-TR: F63.81) — tekrarlayan, kontrol dışı sözel veya fiziksel saldırganlık patlamaları; tetikleyici provokasyonla orantısız derecede yoğun. Eylem sonrası pişmanlık veya utanç.

2. Tarihçe

- DSM-III (1980) — IED resmi tanısı.
- DSM-5 (2013) — kriterler netleştirilmiştir.
- ICD-11 (2019) — dürtü kontrol bozuklukları içinde.

3. Epidemiyoloji

- Yaşam boyu yaygınlık: %4–7 (Kessler R.C. ve ark. Arch Gen Psychiatry 2006).
- Cinsiyet: erkeklerde yüksek.
- Başlangıç: orta ergenlik.

- Komorbidite: MDD ~%70, anksiyete, madde kullanımı, BPD, ASPD.

4. Etiyoloji ve patogenez

- Kalıtım %40.
- Serotonin disregülasyonu — SSRI etkisi.
- Travma ve istismar öyküsü.
- Korteks-amigdala düzenlemesinin bozulması.

5. Klinik özellikler

- Tekrarlayan saldırganlık patlamaları — sözel (bağırma, tehdit) veya fiziksel (eşya hasarı, başkalarına zarar).
- Patlama kontrol dışı — hasta tutmada başarısız.
- Tetikleyici minimal veya hafif.
- Eylemden sonra pişmanlık, utanç, suçluluk.
- İlişki, iş, hukuki sonuçlar.

6. Tanı

6.1 Birleşik tanı ölçütleri

A. Aşağıdakilerden biri:

1. Sözel veya fiziksel saldırganlık patlamaları, yıkıcı hasar olmadan, haftada ≥ 2 kez, ≥ 3 ay;
2. Üç veya daha fazla yıkıcı/zarar verici patlama 12 ay içinde.

B. Agresyon tetikleyiciye uygun olmayan derecede

C. Dürtüsel (planlı değil) ve belirli bir amaç için değil.

D. Önemli sıkıntı veya işlevsel bozulma.

E. Kronolojik yaş ≥ 6 yaş.

F. Başka bir ruhsal bozuklukla (manik, ASPD, BPD, davranış bozukluğu) daha iyi açıklanmaz; madde etkisi dışlanır.

6.2 Kaynaklar arasındaki farklar

- DSM-5-TR — kriter A1 (hafif) ve A2 (yıkıcı) ayrı ayrı.

- ICD-11 — ne sıklık ne yaş ölçütü vardır: DSM-5-TR A1/A2 ayrımını, haftada iki kez üç ay ya da 12 ayda üç yıkıcı epizodu ve ≥6 yaşı ister; ICD-11 bunların hiçbirini koymaz.

6.3 Tanı algoritması

1. Klinik görüşme + aile bilgisi.
2. Ölçek — OAS (Overt Aggression Scale), BPAQ (Buss-Perry Aggression Questionnaire).
3. Komorbidite ve tıbbi nedenlerin dışlanması (frontal lob hasarı, epilepsi, hipoglisemi).
4. Toksikoloji.

6.4 Ayırıcı tanı

Durum	**Ayırt edici**
ASPD (Antisosial)	Planlı saldırganlık, pişmanlık yok.
BPD	Duygusal değişkenlik ve ilişkiler temel.
Manik epizod	Afektif epizod bağlamında.
Davranış Bozukluğu (6C91)	Çok sayıda antisosyal davranış.
ODD (6C90)	Sürekli karşıt gelme, saldırganlık bileşeni var, ancak patlama esas değil.
Frontal lob patolojisi	Nöroloji.
Madde indüksiyonlu agresyon	Toksikoloji.

7. Muayene ve değerlendirme

- OAS, BPAQ.
- Tıbbi ve nörolojik.
- Toksikoloji.
- Komorbidite ölçekleri.

8. Tedavi

1. Fluoksetin (SSRI) — Coccaro E.F. ve ark. J Clin Psychiatry 2009 RKÇ — IED'de en kanıta dayalı farmakoterapi; 20–60 mg/gün.
2. BDT — öfke yönetimi, bilişsel yeniden yapılandırma, davranışsal aktivasyon, gevşeme. McCloskey M.S. ve ark. J Consult Clin Psychol 2008.

3. Duygudurum dengeleyicileri — valproat, lityum (off-label refrakter durumda).
4. Komorbid bozukluk tedavisi.
5. Hukuki koordinasyon gerektiğinde.

8.1 Tedavi metodolojileri

1. Fluoksetin — SSRI; IED'de Coccaro RKÇ kanıt temeli.
2. Öfke kontrolü için BDT — Tetikleyici tanımlama, bilişsel yeniden yapılandırma, mola, gevşeme, problem çözme.
3. Açık Saldırganlık Ölçeği (OAS — Overt Aggression Scale) — Saldırganlık şiddet ölçeği.

8.2 Kaynaklar arasındaki farklar

- Coccaro J Clin Psychiatry 2009 — fluoksetin kanıtlanmış.
- McCloskey 2008 — BDT etkililik.

9. Prognoz

- Fluoksetin ve BDT ile anlamlı iyileşme.
- Komorbid ASPD, madde kullanımı kötü prognoz.

10. Mit ve yanlış inançlar

Mit 1: “IED — sıradan 'öfke patlaması'dır”

Kanıt: klinik tanı sıklık ve işlevsel bozulma temelinde.

Mit 2: “Hasta ‘iradi olarak’ durdurabilir”

Kanıt: dürtü kontrol bozukluğudur — kontrol başarısızlığı klinik özellik; kanıta dayalı tedavi (fluoksetin, BDT) gerekir.

Mit 3: “Benzodiazepin saldırganlığı sakinleştirir”

Kanıt: benzodiazepin paradoksal disinhibisyona yol açar; IED'de kontrendike veya dikkatle.

Mit 4: “Yalnızca hukuki ceza etkilidir”

Kanıt: hukuki ceza tek başına etkisiz; klinik tedavi gereklidir.

Mit 5: “Antipsikotik birinci sıra”

Kanıt: SSRI birinci basamak; antipsikotik refrakter vakada kullanılır.

11. Kaynaklar

1. WHO. ICD-11. 6C73 Intermittent explosive disorder. 2024.
2. APA. DSM-5-TR. 2022.
3. Coccaro E.F. ve ark. A double-blind, randomized, placebo-controlled trial of fluoxetine in patients with intermittent explosive disorder. J Clin Psychiatry 2009;70(5):653–662.
4. McCloskey M.S. et al. Cognitive-behavioral therapy for intermittent explosive disorder. J Consult Clin Psychol 2008;76(5):876–886.
5. Kessler R.C. et al. The prevalence and correlates of DSM-IV intermittent explosive disorder. Arch Gen Psychiatry 2006;63(6):669–678.

6C90–6C9Z BOZUCU DAVRANIŞ

Disruptive behaviour or dissocial disorders

ICD-11 **6C91**	**6C91 TOPLUM KARŞITI DAVRANIM BOZUKLUĞU** **Conduct-dissocial disorder**
ICD-10 F91	Davranım bozuklukları
DSM-5-TR F91.1	Davranım Bozukluğu, Çocuklukta başlayan tür

1. Tanım ve nozoloji

Toplum karşıtı davranım bozukluğu (ICD-11: 6C91 Conduct-Dissocial Disorder; DSM-5-TR: F91.1 Conduct Disorder) — başkalarının haklarına veya yaşa uygun sosyal normlara sürekli ve tekrarlayan müdahale paterni. Tipik olarak çocukluk/ergenlikte başlar; yetişkinlikte ASPD'ye dönüşebilir.

2. Tarihçe

- DSM-III (1980) — resmi tanı.
- DSM-5 (2013) — “limited prosocial emotions” niteleyicisi (psikopatik özelliklerin çocukluk belirteci).
- NICE CG158 (2017) — çocuk ve ergen antisosyal davranışı.

3. Epidemiyoloji

- Yaygınlık: 12 aylık yaygınlık %2–10, medyan %4; erkeklerde kızlardan daha yüksek (DSM-5-TR).
- Cinsiyet: erkeklerde 3 kat yüksek.
- Başlangıç — çocukluk (10 yaşa kadar, kötü prognoz) veya ergenlik (10+ yaş, iyi prognoz).
- Komorbidite: DEHB %50, ODD, MDD, anksiyete, madde kullanımı, öğrenme bozuklukları.

4. Etiyoloji ve patogenez

- Kalıtım %40–60.
- Nörobiyolojik — amigdala, prefrontal disregülasyonu, düşük sempatik arousal.
- Çevre — çocukluk travması, katı ebeveyn tutumu, aile işlev bozukluğu, akran.
- Prenatal — tütün, alkol.

5. Klinik özellikler

DSM-5-TR 15 semptom 4 kategoride (≥ 3 semptom 12 ay)

- Agresyon — insanlara/hayvana tehdit, saldırı, silah kullanımı, fiziksel şiddet, cinsel şiddet.
- Nesne hasarı: kasten yangın çıkarma, başka eşyaların zarar görmesi.
- Aldatma/hırsızlık: Eve girme, yalan, hırsızlık.
- Ciddi kural ihlali: Geç gelme, evden kaçma, okula gitmeme (truancy).

"Limited prosocial emotions" niteleyicisi (psikopatik özellikler)

- Empati veya pişmanlık yokluğu;
- Performans hakkında yetersizlik;
- Afektif küntlük (duygusuzluk);
- Yüzeysel affekt.

6. Tanı

6.1 Birleşik tanı ölçütleri

DSM-5-TR kriterleri (15'ten ≥ 3 semptom 12 ay; en az 1 semptom son 6 ay). Şiddet: hafif, orta, ağır.

Başlangıç: çocukluk tipi (≥ 1 semptom 10 yaşa kadar), ergenlik tipi.

6.2 Kaynaklar arasındaki farklar

- DSM-5-TR — "limited prosocial emotions" niteleyicisi.
- ICD-11 — "Conduct-Dissocial Disorder"; çocuk, ergen, yetişkin paternlerine göre.
- NICE CG158 — çocuk ve ergenlerde tanı ve müdahale.

6.3 Tanı algoritması

1. Klinik görüşme + ebeveyn, öğretmen.
2. Yapılandırılmış görüşme (K-SADS).
3. CBCL (Child Behavior Checklist), TRF (Teacher Report Form).
4. ICU (Inventory of Callous-Unemotional Traits) — psikopatik özellikler için.
5. Komorbidite (DEHB, MDD, madde, öğrenme).

6.4 Ayırıcı tanı

Durum	Ayırt edici
ODD (6C90)	Hafif, ciddi hukuk ihlali yok.
DEHB (6A05)	Dürtüsellik ve dikkat; komorbid sık.
IED (6C73)	Patlama esas; sürekli antisosyal model yok.
Manik epizod	Afektif kontekst.
RAD/DSED (6B44/6B45)	Bağlanma bozukluğu çocukluktan.
Madde indüksiyonlu	Toksikoloji.

7. Muayene ve değerlendirme

- CBCL, TRF, ICU.
- Komorbidite taraması.
- Zekâ ve akademik değerlendirme.

8. Tedavi

8.1 Genel Prensipler (NICE CG158 · AACAP)

1. Ebeveyn eğitimi (parent training programs) birinci basamak 3–11 yaş için:
    - Incredible Years (Webster-Stratton);
    - PCIT (Parent-Child Interaction Therapy);
    - Triple P.
2. Ergenler için:
    - MST — Multisystemic Therapy (Henggeler S.W.) — aile, akran, okul, toplumu kapsayan;
    - FFT — Functional Family Therapy;

- MTFC — Multidimensional Treatment Foster Care.

3. Komorbid DEHB — stimülan (saldırganlığı da azaltır).
4. Antipsikotik (risperidon) — şiddetli agresyonda off-label, dikkatle; FDA onayı yok (çocuk agresyonu için spesifik).
5. "Scared Straight" ve benzeri programlar kontrendikedir — Cochrane (Petrosino A. 2013) — bu programlar antisosyal davranışı artırır.
6. Boot camp tipi "tough love" programları — kanıt yok, zararlıdır.

8.2 Tedavi metodolojileri

1. "Incredible Years" programı — Webster-Stratton — 3–8 yaşlı çocukların ebeveynleri için grup programı; 14–22 seans.
2. Ebeveyn-Çocuk Etkileşim Terapisi (PCIT — Parent-Child Interaction Therapy) — 4–7 yaş; ÇYE + EYE.
3. Çok Sistemli Terapi (MST — Multisystemic Therapy) — Ergenler için ev temelli multisistem müdahalesi; kanıt temeli ağır davranış bozukluğu için güçlü.
4. İşlevsel Aile Terapisi (FFT — Functional Family Therapy) — Aile temelli, 8–30 seans.
5. Çok Boyutlu Tedavi Koruyucu Bakımı (MTFC — Multidimensional Treatment Foster Care) — Yapılandırılmış koruyucu aile programı; ağır vakada.

8.3 Kaynaklar arasındaki farklar

- NICE CG158 (2017).
- AACAP Practice Parameter (Steiner H. 2007).
- Cochrane (Petrosino 2013) — Scared Straight kontrprodüktiftir.

9. Prognoz

- Çocukluk tipi ve psikopatik özelliklerle — yetişkinlikte ASPD ~%40–50 riski.
- Gençlik tipi iyi prognoz.
- Erken ebeveyn eğitimi ve multisistem müdahalesi sonuçları anlamlı şekilde iyileştirir.

10. Mit ve yanlış inançlar

Mit 1: “Sert ceza/disiplin en etkili müdahaledir”

Kanıt: katı ceza antisosyal davranışı pekiştirir; pozitif aile eğitimi kanıtlanmıştır.

Mit 2: “‘Scared Straight’ programları gençleri ‘düzeltir’”

Kanıt: Petrosino A. Cochrane 2013 — Scared Straight antisosyal davranışı artırır (OR 1,68; %95 GA 1,20–2,36); kontrendike; medyada bazen “etkili” olarak sunulur, ancak meta-analiz olumsuz.

Mit 3: “Davranış bozukluğu mutlaka ASPD'ye dönüşür”

Kanıt: ~%50 vakanın ergenlik tipi remisyona girer; çocukluk tipi ve psikopatik özelliklerle kötü prognoz.

Mit 4: “Stimülan agresyonu artırır”

Kanıt: komorbid DEHB'de stimülan saldırganlığı azaltır; davranış ve yan etki izlemiyle kullanılır.

Mit 5: “Boot camp veya askeri ortam ağır CD'yi iyileştirir”

Kanıt: kanıt yok; bazı araştırmalarda tersine etkinlik.

Mit 6: “Antipsikotik standart birinci sıra”

Kanıt: ebeveyn eğitimi ve psikososyal yaklaşımlar birinci sıra; risperidon ağır refrakter durumda off-label.

11. Kaynaklar

1. WHO. ICD-11. 6C91 Conduct-dissocial disorder. 2024.
2. APA. DSM-5-TR. 2022.
3. NICE CG158. Antisocial behaviour and conduct disorders in children and young people: recognition and management. 2017.
4. Steiner H., Remsing L. AACAP Practice Parameter for the Assessment and Treatment of Conduct Disorder. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry 2007;46(1):126–141.
5. Petrosino A. et al. “Scared Straight” and other juvenile awareness programs for preventing juvenile delinquency. Cochrane Database Syst Rev 2013; (4):CD002796.
6. Henggeler S.W. Multisystemic Therapy. Guilford Press; 1998.

7. Sanders M.R. Development, evaluation, and multinational dissemination of the Triple P-Positive Parenting Program. Annu Rev Clin Psychol 2012;8:345 –379.

ICD-11 **6C90**	**6C90 KARŞIT OLMA-KARŞI GELME BOZUKLUĞU (ODD)** **Oppositional defiant disorder**
ICD-10 F91.3	Karşı koyma bozukluğu
DSM-5-TR F91.3	Karşıt Olma, Karşı Gelme Bozukluğu

1. Tanım ve nozoloji

Karşıt olma karşı gelme bozukluğu (ODD; ICD-11: 6C90 Oppositional Defiant Disorder; DSM-5-TR: F91.3) — öfkeli/iritabl duygudurum, kavgacı/inatçı davranış veya intikamcı davranış paterni. Davranış bozukluğundan (CD) farklı olarak, başkalarının temel haklarına müdahale yoktur.

2. Tarihçe

- DSM-III (1980) — resmi tanı.
- DSM-5 (2013) — duygusal bileşen (öfkeli/iritabl) ayrıca vurgulanır.

3. Epidemiyoloji

- Yaygınlık: Okul öncesi ve okul çağı çocuklarında %1–11 (ortalama %3,3) (DSM-5-TR).
- Cinsiyet: prebubertat erkek çocuklarda yüksek; postpubertat fark azalır.
- Komorbidite: DEHB ~%40–60, MDD, anksiyete, CD'ye geçiş %30'unda (çocukluk tipi ağır vakada).

4. Etiyoloji ve patogenez

- Kalıtım %50.
- Çevre — katı ebeveyn tutumu, aile işlev bozukluğu.
- Nörobiyolojik — afektif düzenleme, frontal-amigdala devresi.

- Temperamental faktörler (irritabilite).

5. Klinik özellikler

8 semptom 3 kategoride (≥ 4 semptom 6 ay)

- Öfkeli/irritabl duygudurum: tez öfkelenme; tez irritabl; tez öfkeli, memnuniyetsiz.
- Kavgacı/inatçı davranış: yetişkinlerle tartışma; kurallara uymama; başkalarını kasten kızdırma; başkalarını suçlama.
- İntikamcı davranış: Son 6 ayda en az 2 kez.

6. Tanı

6.1 Birleşik tanı ölçütleri

DSM-5-TR — 8'den ≥ 4 semptom 6 ay; en az bir bağlamda (ev, okul, akran); en az bir diğer bağlamda farklı bir kişiyle.

Yaş niteleyicisi: 5 yaşa kadar semptomlar çoğu günde 6 ay; 5+ yaş — haftada ≥ 1 kez 6 ay.

6.2 Kaynaklar arasındaki farklar

- DSM-5-TR — şiddet (hafif, orta, ağır) bağlam sayısına göre.
- NICE CG158 — çocuk antisosyal davranışı için rehberlik.

6.3 Tanı algoritması

1. Klinik görüşme + ebeveyn, öğretmen.
2. CBCL, TRF, ECBI (Eyberg Child Behavior Inventory).
3. Komorbid DEHB taraması.
4. Disruptive Mood Dysregulation Disorder (DMDD) ve depresif bozukluk farkı.

6.4 Ayırıcı tanı

Durum	Ayırt edici
CD (6C91)	Ciddi hukuk ihlali
DEHB	Dikkat/dürtüsellik; komorbidite sık.

Durum	Ayırt edici
DMDD (DSM-5)	Sürekli irritabilite + şiddetli öfke patlamaları, ≥ 12 ay (art arda ≥ 3 ay semptomsuz dönem olmadan); ODD ölçütleri de karşılanıyorsa yalnızca DMDD tanısı konur.
Anksiyete bozukluğu	Anksiyete komponenti dominant.
Entelektüel yetersizlik	Bilişsel defisit bağlamında davranış bozukluğu.
Yaşa uygun "çocuk direnci"	Fonksiyonel bozulma yoktur.

7. Muayene ve değerlendirme

- ECBI, CBCL.
- Komorbid DEHB, anksiyete, MDD.

8. Tedavi

1. Ebeveyn eğitimi birinci basamak:
    - PCIT — 2–7 yaş
    - Incredible Years — 3-8 yaş;
    - Ebeveyn Yönetimi Eğitimi (Barkley) — 6+ yaş;
    - Triple P.
2. Komorbid DEHB — stimülan.
3. SSRI — komorbid anksiyete/depresyon.
4. Okul temelli müdahale.
5. Çocuk istismarı veya aile içi şiddet şüphesi — çocuk koruma ve sosyal hizmet koordinasyonu.

8.1 Tedavi metodolojileri

1. Ebeveyn-Çocuk Etkileşim Terapisi (PCIT) — Gerçek zamanlı terapist koçluğu.
2. "Incredible Years" programı — Grup formatı.
3. Triple P — Pozitif Ebeveynlik Programı (Positive Parenting Program) — 5 aşamalı sistem.

4. Ebeveyn Yönetim Eğitimi (Parent Management Training) — Barkley (Barkley) — Davranış ilkeleri temelli eğitim.
5. Eyberg Çocuk Davranış Anketi (ECBI — Eyberg Child Behavior Inventory) — Ebeveyn derecelendirmeli davranış skalası.

8.2 Kaynaklar arasındaki farklar

- NICE CG158.
- AACAP — ebeveyn eğitimi.

9. Prognoz

- Erken ebeveyn eğitimi ile çoğu hasta iyileşir.
- Komorbid DEHB, ağır varyant — CD/ASPD riski.

10. Mit ve yanlış inançlar

Mit 1: “ODD normal ‘inatçı çocuk’ davranışıdır”

Kanıt: Klinik tanı işlevsel bozulma ve sıklık temelinde; normal yaş varyantından farklıdır.

Mit 2: “Sert disiplin ODD'yi düzeltir”

Kanıt: katı ceza semptomları pekiştirir; pozitif aile eğitimi kanıtlanmıştır.

Mit 3: “Antipsikotik birinci basamaktır”

Kanıt: ebeveyn eğitimi birinci sıra; antipsikotik refrakter durumda nadir.

Mit 4: “ODD her zaman CD'ye dönüşür”

Kanıt: %30'unda DB'ye geçiş; çocukluk tipi ve komorbidite ile risk yüksek; çoğunluk DB'ye dönüşmez.

Mit 5: “Yalnızca çocuk tedavi edilmelidir, aile değil”

Kanıt: ebeveyn eğitimi merkezi bileşendir; çocuk tek başına psikoterapi az etkilidir.

11. Kaynaklar

1. WHO. ICD-11. 6C90 Oppositional defiant disorder. 2024.
2. APA. DSM-5-TR. 2022.
3. NICE CG158. 2017.
4. AACAP Practice Parameter (Steiner 2007).

5. Eyberg S.M. et al. Evidence-based psychosocial treatments for children and adolescents with disruptive behavior. J Clin Child Adolesc Psychol 2008;37(1):215–237.
6. Sanders M.R. Development, evaluation, and multinational dissemination of the Triple P-Positive Parenting Program. Annu Rev Clin Psychol 2012;8:345 –379.

6D10–6D1Z KİŞİLİK BOZUKLUKLARI

Personality disorders and related traits

ICD-11 **6D10**	**6D10 KİŞİLİK BOZUKLUĞU** **Personality disorder**
ICD-10 F60.9	Kişilik bozuklukları, tanımlanmamış
DSM-5-TR F60.9	Belirlenmemiş Kişilik Bozukluğu

1. Tanım ve nozoloji

Kişilik Bozukluğu (ICD-11: 6D10 Personality Disorder; DSM-5-TR: F60.9; 10 kategori) — kişisel ve sosyal işlevsellikte sürekli ve yaygın model; kendine ve başkalarına dair düşünce, duygu ve davranışlarda. ICD-11 temel olarak tek kategori + şiddet dereceleri + özellik alanları modeline geçmiştir; klasik 10 ayrı kişilik bozukluğu (paranoid, schizoid, BPD, ASPD vb.) kategorik tanı olarak iptal edilmiştir.

2. Tarihçe

- DSM-III (1980) — kategorik 11 kişilik bozukluğu (Cluster A, B, C).
- DSM-IV (1994), DSM-5-TR (2022) — aynı kategorik model korunur; ancak DSM-5 Section III araştırma kategorisinde alternatif "dimensional" model.
- ICD-11 (2019) — radikal değişiklik: Kategorik 10 bozukluk kaldırılmış, tek Kişilik Bozukluğu (hafif, orta, ağır + Personality Difficulty) + 5 özellik alanı değerlendirmesi.

3. Epidemiyoloji

- Yaşam boyu yaygınlık: ~%9 (Lenzenweger M.F. ve ark. Biol Psychiatry 2007); BPD ~%1,4, ASPD ~%1, şizoid %3.
- Cinsiyet: BPD kadınlarda klinik popülasyonlarda; ASPD erkeklerde yüksek.
- Başlangıç: ergenlik ve erken yetişkinlik.

- Mortalite: BPD'de intihar %8–10 ömür boyu; ASPD'de şiddetli ölüm.
- Komorbidite: MDD, anksiyete, madde kullanımı, yeme bozuklukları.

4. Etiyoloji ve patogenez

- Kalıtım %40–60.
- Erken travma, çocukluk istismarı (özellikle BPD).
- Düzensiz bağlanma.
- Nörobiyolojik — frontal-limbik düzenleme, serotonerjik disregülasyon.

5. Klinik özellikler

5.1 ICD-11 5 özellik alanı

- Olumsuz duygulanım — anksiyete, depresyon, değişkenlik.
- Çekingenlik — sosyal ve duygusal uzaklık.
- Dissosyallik — empati yokluğu, benmerkezcilik.
- Dezinhibisyon — dürtüsellik, sorumsuzluk.
- Anankastik — mükemmeliyetçilik, kontrol, katı kurallar.

"Borderline model" — ICD-11'de ayrı bir niteleyici (BPD'ye karşılık gelen, kategorik 10 ayrı tanı yerine).

5.2 DSM-5-TR 10 kategorik bozukluk (kısa)

- Cluster A (garip/eksantrik): Paranoid, Şizoid, Şizotipal.
- Cluster B (dramatik/erratik): Antisocial (ASPD), Borderline (BPD), Histrionic, Narcissistic.
- Küme C (kaygılı/korkulu): Avoidant, Dependent, Obsessive-Compulsive (OCPD).

6. Tanı

6.1 Birleşik tanı ölçütleri (ICD-11)

A. Sürekli ve yaygın kişilik işlev bozukluğu — kendilikle ilgili (kimlik, öz-değer, öz-yönetim) veya kişilerarası (ilişkiler, empati, yakınlık, sorumluluk) işlevde.

B. Süre — uzun süreli (yıllar).

C. Gelişim yaşı, kültürel norm, aile durumu ile uyumsuz.

D. Şiddet: Kişilik Güçlüğü (subklinik), Hafif KB, Orta KB, Ağır KB.

E. Özellik alanı niteleyicileri (yukarıda).

6.2 Kaynaklar arasındaki farklar

- ICD-11: Kategorik sisteme radikal değişiklik; klinik pratikte öğretim gerektirir.
- DSM-5-TR: 10 kategorik tanı korunur; Section III alternatif model.
- NICE CG78 (BPD), CG77 (ASPD): BPD ve ASPD için ayrı klinik kılavuzlar.

6.3 Tanı algoritması

1. Klinik görüşme + uzun geçmiş.
2. SCID-5-PD (DSM kategorik) veya ICD-11 PD değerlendirmesi.
3. Kişilik ölçekleri — PID-5 (DSM-5 boyutsal), MMPI-2-RF.
4. Komorbidite (MDD, madde, travma).
5. İntihar ve şiddet riski.

6.4 Ayırıcı tanı

Durum	**Ayırt edici**
Afektif epizod bağlamında değişiklik	Epizodik gidiş; kişilik süreklidir.
Madde indüksiyonlu	Madde anamnezi.
TSSB / kompleks TSSB	Travma bağlamında; klinik örtüşme BPD'de.
Bipolar	Afektif epizodlar.
Tıbbi durum (frontal lob, demans)	Nöroloji.

7. Muayene ve değerlendirme

- SCID-5-PD, PID-5.
- MMPI-2-RF, MCMI-IV.
- Komorbidite ve intihar.

8. Tedavi

8.1 Genel Prensipler (NICE CG78 (BPD), CG77 (ASPD); APA 2024 (BPD, 2. baskı))

1. Psikoterapi birinci sıra — kişilik bozukluklarında altın standart.
2. BPD için kanıta dayalı yaklaşımlar (5):
    - DBT (Dialectical Behavior Therapy, Linehan M.) — duygusal düzenleme, distress toleransı, sosyal beceriler, mindfulness; standart 12 ay;
    - MBT (Mentalization-Based Treatment, Bateman A., Fonagy P.);
    - Schema Therapy (Young J.);
    - TFP (Transference-Focused Psychotherapy, Kernberg O.);
    - STEPPS (Systems Training for Emotional Predictability and Problem Solving).
3. ASPD için — terapötik sınırlama; yapılandırılmış, motive hastada BDT.
4. Farmakoterapi — kişilik bozukluğunun kendisi için spesifik onay yok; komorbid semptomlar (dürtüsellik, depresyon, anksiyete, psikoz-benzeri) için — SSRI, duygudurum düzenleyicileri, atipik antipsikotik düşük dozda.
5. Kriz yönetimi — DBT becerileri, kısa süreli yatış.
6. Uzun süreli tedavi (yıllar).

8.2 Tedavi metodolojileri

1. Diyalektik Davranış Terapisi (DBT — Dialectical Behavior Therapy) — Linehan (Linehan M.) — 4 modül (farkındalık, sıkıntıya dayanma, duygusal düzenleme, sosyal beceriler); bireysel + grup + telefon koçluğu + terapist konsültasyonu. 12 ay standart. Kanıt: Linehan M.M. JAMA Psychiatry 2015.
2. Mentalizasyon-Temelli Terapi (MBT — Mentalization-Based Therapy) — Bateman (Bateman A.), Fonagy (Fonagy P.) — Mentalizasyon — kendinin ve başkalarının zihinsel durumlarının tanınması; psikodinamik köke dayalı. Bateman A. Am J Psychiatry 2009.
3. Şema Terapisi (Schema Therapy) — Young J — Erken maladaptif şemaların yeniden yapılandırılması; uzun süreli psikoterapi.
4. Aktarım-Odaklı Psikoterapi (TFP — Transference-Focused Psychotherapy) — Kernberg (Kernberg O.) — Aktarım bağlamında ilkel savunma mekanizmalarının işlenmesi.
5. STEPPS — 20 haftalık grup; BPD hastasının sosyal sisteminin de katılımı.

6. Kişilik Bozuklukları için Yapılandırılmış Klinik Görüşme (SCID-5-PD) — DSM-5 kategorik tanı.

8.3 Kaynaklar arasındaki farklar

- NICE CG78 (BPD, 2009) — DBT, MBT ve benzer yapılandırılmış yaklaşımlar; farmakoterapi BPD'nin kendisi için rutin olarak önerilmez.
- NICE CG77 (ASPD, 2009).
- APA Practice Guideline for the Treatment of Patients With Borderline Personality Disorder, 2. baskı (2024) — 2001 baskısının yerini aldı.

9. Prognoz

- BPD — 10 yıllık izlemde %50+ remisyon (Zanarini M.C. derlemeleri).
- ASPD — en kötü prognoz; ancak yaşla saldırganlık azalır.
- Tedavi prognozu anlamlı şekilde iyileştirir.

10. Mit ve yanlış inançlar

Mit 1: “Kişilik bozuklukları tedavi edilmez”

Kanıt: DBT, MBT, Şema, TFP — kanıta dayalı yaklaşımlar; çoğu hasta önemli ölçüde iyileşir; karamsar prognostik tutum eskimiştir.

Mit 2: “BPD hastaları manipülatiftir, katı sınır gerektirir”

Kanıt: “manipülatif” terimi damgalayıcı ve yanlıştır; BPD davranışları duygusal düzenleme bozukluğundan kaynaklanır; DBT geçerleme + yapı dengesini önerir.

Mit 3: “Farmakoterapi BPD'yi iyileştirir”

Kanıt: NICE CG78 — farmakoterapi BPD'nin kendisi için rutin olarak önerilmez; psikoterapi birinci basamak.

Mit 4: “ASPD tedavi edilemez”

Kanıt: ağır ASPD'de müdahale sınırlıdır, ancak motive hastada yapılandırılmış tedavi iyileşme sağlayabilir; nihilist tutum kontrendikedir.

Mit 5: “Yaşla kişilik bozukluğu sabitlenir, tedavi gerektirmez”

Kanıt: uzun süreli izlem — BPD remisyon oranı %50+ 10 yılda; tedavi bu süreci hızlandırır.

Mit 6: "Hipnoterapi, ezoterik müdahaleler kişilik bozukluklarını iyileştirir"

Kanıt: kanıt yoktur; kanıtlanmış yapılandırılmış psikoterapi önerilir.

11. Kaynaklar

1. WHO. ICD-11. 6D10 Personality disorder. 2024.
2. APA. DSM-5-TR. 2022.
3. NICE CG78. Borderline personality disorder: recognition and management. 2009.
4. NICE CG77. Antisocial personality disorder: prevention and management. 2009.
5. Linehan M.M. et al. Dialectical behavior therapy for high suicide risk in individuals with borderline personality disorder: a randomized clinical trial and component analysis. JAMA Psychiatry 2015;72(5):475–482.
6. Bateman A., Fonagy P. Randomized controlled trial of outpatient mentalization-based treatment versus structured clinical management for BPD. Am J Psychiatry 2009;166(12):1355–1364.
7. Zanarini M.C. et al. Prediction of the 10-year course of borderline personality disorder. Am J Psychiatry 2006;163(5):827–832.
8. Tyrer P., Reed G.M., Crawford M.J. Classification, assessment, prevalence, and effect of personality disorder. Lancet 2015;385(9969):717–726.
9. Young J.E., Klosko J.S., Weishaar M.E. Schema Therapy: A Practitioner's Guide. New York: Guilford Press, 2003.
10. Yeomans F.E., Clarkin J.F., Kernberg O.F. Transference-Focused Psychotherapy for Borderline Personality Disorder: A Clinical Guide. Washington: American Psychiatric Publishing, 2015.
11. Lenzenweger M.F., Lane M.C., Loranger A.W., Kessler R.C. DSM-IV personality disorders in the National Comorbidity Survey Replication. Biol Psychiatry 2007;62(6):553–564.

ICD-11 **6D11**	**6D11 BELİRGİN KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ VEYA ÖRÜNTÜLERİ** **Prominent personality traits or patterns**
ICD-10 —	ICD-10'da karşılığı yoktur
DSM-5-TR F60.3	Sınırda Kişilik Bozukluğu (yalnızca 6D11.5 sınırda örüntü niteleyicisine karşılık gelir)

1. Tanım ve nozoloji

Belirgin kişilik özellikleri veya örüntüleri (ICD-11: 6D11 Prominent personality traits or patterns) bağımsız bir tanı değil, bir niteleyiciler kümesidir: kişilik bozukluğunun (6D10) ya da kişilik zorluğunun hangi özellik alanlarıyla ortaya çıktığını kaydeder. Şiddet 6D10'da, alanlar ise burada kodlanır; 6D11 tek başına konmaz.

Kişilik zorluğu (Personality difficulty) ICD-11'de bir ruhsal bozukluk değildir — "Sağlık durumunu etkileyen etmenler" bölümünde QE50.7 kodu altında yer alır. Kişilik özellikleri işlevsel zorluk yaratır, ancak 6D10 ölçütlerine ulaşmaz.

2. Tarihçe

- ICD-11 (2019) — 10 kategorik kişilik bozukluğundan vazgeçildi; yerine şiddet derecesi (6D10) ve beş özellik alanı (6D11.0–6D11.4).
- 6D11.5 "sınırda örüntü" ayrıca eklendi — ICD-10'daki sınırda kişilik bozukluğunun (F60.3) devamı; DSM-5-TR'de paralel yalnızca Bölüm III boyutsal modelidir.

3. Epidemiyoloji

Kesin epidemiyolojik veri sınırlıdır; subklinik kişilik özellikleri popülasyonda yaygındır.

4. Etiyoloji ve patogenez

6D10 ile aynı — genetik ve çevre etkileşimi.

5. Klinik özellikler

- 6D11.0 Negatif duygulanım — geniş bir olumsuz duygu yelpazesi: kaygı, sinirlilik, düşük özgüven, duygusal oynaklık.
- 6D11.1 Çekingenlik — sosyal ve duygusal mesafe: kaçınma, kısıtlı duygulanım, yakınlıktan kaçış.
- 6D11.2 Antisosyallik — başkalarının hak ve duygularını hiçe sayma: benmerkezcilik, empati eksikliği, sömürücülük.
- 6D11.3 Disinhibisyon — dürtüsellik, dikkat dağınıklığı, sorumsuzluk, anlık ödüle yönelme.
- 6D11.4 Anankastik — mükemmeliyetçilik, katı kurallar, duygusal ve davranışsal denetim.
- 6D11.5 Sınırda örüntü (borderline pattern) — ilişkilerde, benlik algısında ve duygulanımda dengesizlik, dürtüsellik, terk edilme korkusu, kendine zarar verme ve intihar davranışı.

6. Tanı

6.1 Birleşik tanı ölçütleri

A. Tanı 6D10 (kişilik bozukluğu) veya QE50.7 (kişilik zorluğu) üzerinden konur; 6D11 yalnızca niteleyici olarak eklenir.

B. Klinik olarak anlamlı düzeyde bulunan tüm alanlar kaydedilir — birden fazla olabilir.

C. Sınırda örüntü (6D11.5) herhangi bir alan bileşimine ek olarak kaydedilebilir.

6.2 Kaynaklar arasındaki farklar

ICD-11 — kategori bir tür “kişilik sorunlarına dair klinik dikkat” Z-koduna benzer.

6.3 Tanı algoritması

1. Klinik görüşme.
2. 5 alan değerlendirmesi.
3. Tam PD tanısının dışlanması.

6.4 Ayırıcı tanı

Durum	Ayırt edici
Personality Disorder (6D10)	Önemli fonksiyonel bozulma.
Uyum bozukluğu (6B43)	Stres faktörüne yanıt.
Normal kişilik varyantı	İşlevsel zorluk yok.

7. Muayene ve değerlendirme

Kişilik ölçekleri (PID-5).

8. Tedavi

1. Psikoterapi — kısa-orta süreli; problem odaklı BDT veya destekleyici.
2. Stres yönetimi ve başa çıkma becerileri.
3. Komorbid semptomlar için spesifik müdahale.

8.1 Tedavi metodolojileri

1. DSM-5 için Kişilik Envanteri (PID-5 — Personality Inventory for DSM-5) — Boyutsal kişilik ölçeği.

9. Prognoz

Tedavi ile iyileşme; stabil veya tam PD'ye ilerleme riski.

10. Mit ve yanlış inançlar

Mit 1: “Kişilik Güçlüğü gerçek bir tanı değildir”

Kanıt: ICD-11 resmi koddur; subklinik kişilik sorunlarına klinik dikkat sağlar.

Mit 2: “Kişilik Zorluğu mutlaka PD'ye dönüşür”

Kanıt: bazı hastada gelişme, ancak çoğu stabil veya iyileşir.

Mit 3: “Yalnızca ilaçla tedavi edilmelidir”

Kanıt: psikoterapi birinci sıra; farmakoterapi komorbid semptomlar için.

Mit 4: “Bu kategori yalnız ‘endişeli’ hastaları etiketlemek içindir”

Kanıt: ICD-11 — işlevsel zorluğa klinik yanıt; klinik destek sağlar.

11. Kaynaklar

1. WHO. ICD-11. 6D11 Prominent personality traits or patterns. 2024.
2. WHO. ICD-11. QE50.7 Personality difficulty. 2024.
3. Tyrer P. et al. Lancet 2015;385(9969):717–726.

6D30–6D3Z PARAFİLİK BOZUKLUKLAR

Paraphilic disorders

ICD-11 **6D30**	**6D30 TEŞHİRCİLİK BOZUKLUĞU** **Exhibitionistic disorder**
ICD-10 F65.2	Teşhircilik
DSM-5-TR F65.2	Göstermecilik Bozukluğu

1. Tanım ve nozoloji

Teşhircilik bozukluğu (ICD-11: 6D30 Exhibitionistic Disorder; DSM-5-TR: F65.2) — rızası olmayan kişilerin önünde genital organların açılmasından kalıcı veya yoğun cinsel uyarılma; hasta bu fantezilere, dürtülere veya davranışa yanıt olarak anlamlı sıkıntı veya işlevsel bozulma yaşar, ve/veya gerçek rızası olmayan insanlarda gerçekleştirir.

2. Tarihçe

- Lasègue C. (1877) — “exhibitionnistes” terimi.
- DSM-III (1980) — resmi tanı.
- DSM-5 (2013) — parafili (atipik cinsel ilgi) ile parafilik bozukluk (klinik sıkıntı veya başkalarına zarar) ayrımı.
- WFSBP 2020 (Thibaut F. et al.) — parafilik bozukluklar için uluslararası öneri.

3. Epidemiyoloji

- Yaygınlık: Erkeklerde %2–4; kadınlarda nadir.
- Başlangıç: ergenlik ve erken yetişkinlik.
- Komorbidite: diğer parafili (%50–80 parafilik bozukluk hastasında), ASKB, madde kullanımı, MDD.

4. Etiyoloji ve patogenez

- Çok sayıda faktör — biyolojik, davranışsal koşullanma, psikososyal.
- Komorbid dürtüsellik ve hiperseksüalite.

5. Klinik özellikler

- Rızası olmayan kişilerin önünde genital organların açılması için tekrarlayan ve yoğun cinsel uyarılma.
- Hasta fantezi, dürtü veya davranışı uygular veya sıkıntı yaşar.
- Tipik bağlam — sokak, toplu taşıma.
- Hukuki ve toplumsal sonuçlar (cinsel suç).

6. Tanı

6.1 Birleşik tanı ölçütleri

A. ≥ 6 ay tekrarlayan ve yoğun cinsel uyarılma rızası olmayan kişilerin önünde genital açılmasından.

B. Hasta fantezi/dürtüleri uygulamış veya önemli sıkıntı/işlevsel bozulma yaşar.

6.2 Kaynaklar arasındaki farklar

- DSM-5-TR 6 aylık süre ister; ICD-11'de süre ölçütü yoktur — "sürekli, odaklanmış ve yoğun uyarılma örüntüsü" denir.
- WFSBP 2020 — parafilik bozukluklar için basamaklı terapi.

6.3 Tanı algoritması

1. Klinik görüşme.
2. Komorbidite (ASPD, madde, diğer parafilik).
3. Risk değerlendirmesi (adli bağlam).

6.4 Ayırıcı tanı

Durum	**Ayırt edici**
Hiperseksüalite	Rızası olan partnerler.
Manik epizod	Afektif kontekst.
Demans	Disinhibisyon frontal lob patolojisi.
Madde indüksiyonlu	Toksikoloji.

7. Muayene ve değerlendirme

- Klinik görüşme.
- Risk ölçekleri (Static-99R cinsel tekerrür için).

8. Tedavi

8.1 Genel Prensipler (WFSBP 2020 basamaklı)

1. BDT ve bilişsel-davranışsal müdahale — birinci sıra; nüksün önlenmesi, bilişsel distorsiyon yönetimi.
2. SSRI — yüksek dozda (fluoksetin 40–80 mg); dürtüsellik ve cinsel isteği azaltır.
3. Refrakter durumda / ağır durumda — antiandrojen (CPA siproteron, MPA medroksiprogesteron).
4. En ağır durumda — GnRH agonisti (leuprolid, triptorelin) — kimyasal kastrasyon; sürekli izlem.
5. Hukuki-tıbbi koordinasyon.

8.2 Tedavi metodolojileri

1. BDT (nüksün önlenmesi) — Tetikleyici kontrolü, bilişsel distorsiyon.
2. SSRI Yüksek Doz — Birinci farmakoterapi.
3. Antiandrogen (CPA, MPA) — Refrakter durumda.
4. GnRH Agonist — En ağır durumda.

8.3 Kaynaklar arasındaki farklar

- WFSBP 2020 — basamaklı algoritma.

9. Prognoz

Kanıtlı tedavi ile nüks azalması; komorbid ASPD ve madde kötü prognoz.

10. Mit ve yanlış inançlar

Mit 1: “Ekshibisyonizm zararsızdır”

Kanıt: mağdura psikolojik travma; cinsel suç; daha ağır parafililere gelişme riski.

Mit 2: “Kimyasal kastrasyon birinci sıradır”

Kanıt: WFSBP 2020 basamaklı — BDT ve SSRI önce; GnRH en ağır vakada.

Mit 3: "Tedavi etkisizdir"

Kanıt: BDT ve farmakoterapi nüksü anlamlı şekilde azaltır.

Mit 4: "Yalnızca hukuki ceza gereklidir"

Kanıt: klinik müdahale nüks riskini azaltır.

11. Kaynaklar

1. WHO. ICD-11. 6D30 Exhibitionistic disorder. 2024.
2. APA. DSM-5-TR. 2022.
3. Thibaut F., Cosyns P., Fedoroff J.P. et al.; WFSBP Task Force on Paraphilias. The World Federation of Societies of Biological Psychiatry (WFSBP) 2020 guidelines for the pharmacological treatment of paraphilic disorders. World J Biol Psychiatry 2020;21(6):412–490.

ICD-11 **6D31**	**6D31** **GÖZETLEMECİLİK BOZUKLUĞU** **Voyeuristic disorder**
ICD-10 F65.3	Röntgencilik
DSM-5-TR F65.3	Gözetlemecilik Bozukluğu

1. Tanım ve nozoloji

Gözetlemecilik bozukluğu (ICD-11: 6D31 Voyeuristic Disorder; DSM-5-TR: F65.3) — rızası olmayan kişilere soyunma, çıplak olma, cinsel aktivite sırasında gizlice bakmaktan sürekli ve yoğun cinsel uyarılma; hasta bu fantezilere yanıt olarak distress yaşar veya rızası olmayan insanlarda gerçekleştirir.

2. Tarihçe

Voyörizm klinik literatürde eksibisyonizmle (6D30) paralel olarak tanımlanmıştır.

3. Epidemiyoloji

- Yaygınlık: bozukluğun popülasyon yaygınlığı bilinmemektedir; DSM-5-TR, klinik olmayan örneklemlerdeki voyöristik eylemlere dayanarak olası en yüksek yaşam boyu yaygınlığı erkeklerde ~%12, kadınlarda ~%4 olarak vermektedir (Långström N., Seto M.C. Arch Sex Behav 2006, n=2450). Voyöristik davranışı olanların çoğu bozukluk ölçütlerini karşılamaz.
- Komorbid diğer parafilik bozukluklar.
- İnternet voyeurizmi (gizli kamera, "upskirt") gelişmektedir.

4. Etiyoloji ve patogenez

Parafilik bozukluklar için genel etiyoloji.

5. Klinik özellikler

- Rızası olmayan kişilere soyunmuş veya cinsel aktivite sırasında gizlice bakma.
- Tipik bağlam — pencere, soyunma odaları, kamusal alanlar.
- "Upskirting" — modern formu.
- Hukuki sonuçlar.

6. Tanı

6.1 Birleşik tanı ölçütleri

A. ≥ 6 ay rızası olmayan kişilere bakmaktan tekrarlayan cinsel uyarılma.

B. Hasta fanteziyi uygulamış veya sıkıntı yaşar.

C. Yaş ≥ 18 (DSM-5-TR; ergenlerde normal merak hariç).

6.2 Kaynaklar arasındaki farklar

- DSM-5-TR 6 aylık süre ister; ICD-11'de süre ölçütü yoktur — "sürekli, odaklanmış ve yoğun uyarılma örüntüsü" denir.
- WFSBP 2020.

6.3 Tanı algoritması

1. Klinik görüşme.
2. Komorbidite.
3. Risk değerlendirmesi.

6.4 Ayırıcı tanı

Durum	Ayırt edici
Ergen merakı	Normal gelişimin parçası.
Rızaya dayalı seyircilik (porno)	Rızaya dayalı bağlam.
Manik epizod	Afektif kontekst.

7. Muayene ve değerlendirme

- Klinik görüşme.
- Risk ölçekleri.

8. Tedavi

1. WFSBP 2020 basamaklı algoritma (6D30 ile aynı):
    - BDT nüksün önlenmesi;
    - SSRI yüksek doz;
    - Antiandrojen;
    - GnRH en ağır vakada.
2. Hukuki-tıbbi koordinasyon.

8.1 Tedavi metodolojileri

6D30 ile aynı.

9. Prognoz

Kanıtlı tedavi ile nüks azalması.

10. Mit ve yanlış inançlar

Mit 1: "Röntgencilik zararsızdır, kurban habersiz kalır"

Kanıt: mağdur açık olduğunda travma; rıza ihlali cinsel suç.

Mit 2: "Pornografi kullanımı voyeurizmdir"

Kanıt: rızaya dayalı üretim ve tüketim — voyerizm yok; klinik tanı rızası olmayanlara odaklanır.

Mit 3: "Yalnızca internet voyeurizmi yenidir, klinik önemi yoktur"

Kanıt: "upskirting", gizli kamera — cinsel suç; klinik ve hukuki müdahale gerektirir.

Mit 4: "Tedavi etkisizdir"

Kanıt: BDT ve farmakoterapi etkilidir.

11. Kaynaklar

1. WHO. ICD-11. 6D31 Voyeuristic disorder. 2024.
2. APA. DSM-5-TR. 2022.
3. Thibaut F., Cosyns P., Fedoroff J.P. et al.; WFSBP Task Force on Paraphilias. The World Federation of Societies of Biological Psychiatry (WFSBP) 2020 guidelines for the pharmacological treatment of paraphilic disorders. World J Biol Psychiatry 2020;21(6):412–490.
4. Långström N., Seto M.C. Exhibitionistic and voyeuristic behavior in a Swedish national population survey. Arch Sex Behav 2006;35(4):427–435.

ICD-11 **6D32**	**6D32 PEDOFİLİK BOZUKLUK** **Pedophilic disorder**
ICD-10 F65.4	Pedofili (çocuğa cinsel sevi)
DSM-5-TR F65.4	Pedofili Bozukluğu

1. Tanım ve nozoloji

Pedofilik Bozukluk (ICD-11: 6D32 Pedophilic Disorder; DSM-5-TR: F65.4) — prepubertal çocuklara (tipik < 13 yaş) karşı sürekli ve yoğun cinsel uyarılma ≥ 6 ay; hasta fantazilerine karşılık çocukla cinsel ilişki gerçekleştirmiş ya da önemli distress/fonksiyonel bozukluk yaşar. Hasta en az 16 yaşında ve mağdur en az 5 yaş küçük.

Önemli: "Pedofilik ilgi" (parafili) ve "Pedofilik Bozukluk" (klinik tanı) farklıdır — tanı işlevsel bozulma ve/veya çocuğa zarar gerektirir.

2. Tarihçe

- Krafft-Ebing (1886).
- DSM-III (1980).
- WFSBP 2020 — uluslararası parafilik kılavuzu.

3. Epidemiyoloji

- Yaygınlık — kesin veri elde etmek zordur (damgalanmış kategori); DSM-5-TR erkek nüfusta olası en yüksek oran olarak %3–5 verir; gerçek pedofilik tercih ~%1.
- Cinsiyet: erkeklerde neredeyse her zaman.
- Komorbidite: diğer parafilik, ASKB, MDD, anksiyete, madde kullanımı.

4. Etiyoloji ve patogenez

- Biyolojik — nörogelişimsel anomaliler (Cantor J.M. derlemeleri — IQ, nöroanatomik farklılıklar).
- Çocukluk travması veya cinsel istismar öyküsü (ancak çoğu pedofilik bozukluğu olan kişi kendisi kurban olmamıştır; "istismar edilmiş-istismarcı" tartışmalı bir konsepttir).
- Komorbid dürtüsellik ve hiperseksüalite.

5. Klinik özellikler

- Prepubertal çocuklara karşı sürekli ve yoğun cinsel uyarılma.
- Hasta fanteziyi uygulamış (çocuğa cinsel şiddet) veya sıkıntı/işlevsel bozulma yaşar.
- Alt tipler (DSM-5-TR): yalnızca çocuklara yönelik (exclusive type), hem çocuklara hem yetişkinlere (nonexclusive); erkek/kadın/her ikisi.
- Hukuki sonuçlar (suç).

6. Tanı

6.1 Birleşik tanı ölçütleri

A. ≥ 6 ay prepubertal çocuklara (tipik ≤ 13) karşı tekrarlayan ve yoğun cinsel uyarılma.

B. Hasta fanteziyi gerçekleştirmiş veya belirgin sıkıntı/işlevsel bozulma yaşamaktadır.

C. Hasta ≥ 16 yaş, mağdurdan ≥ 5 yaş büyük.

6.2 Kaynaklar arasındaki farklar

- DSM-5-TR 6 aylık süre ve yaş kuralı (hasta ≥16 yaş ve çocuktan ≥5 yaş büyük) ister; ICD-11'de ne süre ne yaş ölçütü vardır — yalnızca yaşça yakın akranlar arasındaki davranış dışlanır.
- WFSBP 2020.
- Adli psikiyatri bağlamında yapılandırılmış risk değerlendirmesi.

6.3 Tanı algoritması

1. Klinik görüşme (itiraf zor; hasta gizleyebilir).
2. Penil pletismografi — araştırma ve adli bağlam.
3. Adli risk değerlendirmesi (Static-99R, STABLE-2007).
4. Komorbidite.

6.4 Ayırıcı tanı

Durum	**Ayırt edici**
Madde indüksiyonlu disinhibisyon	Toksikoloji.
Demans (frontal)	Bilişsel gerileme, nörolojik.
Entelektüel yetersizlik	Bilişsel defisit bağlamında.
Hiperseksüalite yetişkinlerde	Pedofilik fokus yok.
"Hebephilia" / "ephebophilia"	Pubertat ve post-pubertatlara odak; DSM-5-TR ayrı kategori yok.

7. Muayene ve değerlendirme

- Adli klinik görüşme.
- Static-99R, STABLE-2007.
- Penil pletismografi (araştırma).
- Komorbidite.

8. Tedavi

8.1 Genel Prensipler (WFSBP 2020 basamaklı)

1. BDT ve nüksün önlenmesi — birinci sıra; tetikleyici yönetimi, bilişsel distorsiyon yönetimi, empati gelişimi.
2. SSRI yüksek dozda — birinci farmakoterapi — dürtüselliği ve cinsel ihtiyacı azaltır.
3. Antiandrogen (CPA, MPA) — orta-ağır vakada; libido ve cinsel aktivite azalır.
4. GnRH agonist (leuprolid, triptorelin) — kimyasal kastrasyon; en ağır veya yüksek riskli durumda; sürekli izleme (osteoporoz, metabolik).
5. Adli müdahale ve toplum izlemi paralel.
6. Multidisipliner yaklaşım — psikiyatrist, terapist, sosyal hizmet, hukuki.

8.2 Tedavi metodolojileri

1. BDT ve Nüks Önleme (Relapse Prevention) — Tetikleyici ve bağlam kontrolü; bilişsel distorsiyon; empati eğitimi.
2. SSRI Yüksek Doz — Birinci farmakoterapi.
3. Antiandrogen (CPA, MPA) — Libido azaltma.
4. GnRH Agonist — Kimyasal kastrasyon; sürekli izleme.
5. Static-99R, STABLE-2007 — Adli risk değerlendirmesi.

8.3 Kaynaklar arasındaki farklar

- WFSBP 2020 — Thibaut et al. — basamaklı farmakoterapi.
- STABLE-2007 — dinamik risk faktörleri.

9. Prognoz

- Kanıtlı tedavi ile davranış yönetimi iyileşir.
- Komorbid ASPD ve madde kullanımı — kötü prognoz.
- Sürekli izleme kritik.

10. Mit ve yanlış inançlar

Mit 1: “Pedofilik ilgi her zaman çocuğa şiddet anlamına gelir”

Kanıt: “pedofilik fanteziye sahip olmak” ve “çocuğa şiddet uygulamak” farklıdır; bazı hastalar asla şiddet uygulamaz ve klinik destek arar (“Dunkelfeld” Almanya programı gibi).

Mit 2: “Tüm çocuk cinsel istismarı failleri pedofiliktir”

Kanıt: Çoğu çocuk cinsel istismarı faili pedofilik DEĞİL — durumsal, başka motivasyon. Pedofilik tanı ≥ 6 ay sürekli cinsel uyarılma gerektirir.

Mit 3: “Kimyasal kastrasyon tüm hastalar için zorunlu olmalıdır”

Kanıt: WFSBP 2020 basamaklı yaklaşım — GnRH en ağır vakada; BDT ve SSRI önce. Etik ve hukuki ihtiyat.

Mit 4: “‘Bir kez pedofilik — her zaman pedofilik’”

Kanıt: cinsel ilgi stabil olabilir, ancak davranış kontrolü BDT ve farmakoterapi ile önemli ölçüde iyileşebilir.

Mit 5: “Tedavi etkisizdir”

Kanıt: WFSBP 2020 ve meta-analizler — multimodal müdahale recidivism azaltır.

Mit 6: “Hasta çocukluk travmasının 'kurbanı'dır”

Kanıt: “abused-abuser” konsepti tam olarak desteklenmemektedir; çoğu hasta çocuklukta şiddete maruz kalmamıştır; mağduriyet, suç işlemenin temeli değildir.

11. Kaynaklar

1. WHO. ICD-11. 6D32 Pedophilic disorder. 2024.
2. APA. DSM-5-TR. 2022.
3. Thibaut F., Cosyns P., Fedoroff J.P. et al.; WFSBP Task Force on Paraphilias. The World Federation of Societies of Biological Psychiatry (WFSBP) 2020 guidelines for the pharmacological treatment of paraphilic disorders. World J Biol Psychiatry 2020;21(6):412–490.
4. Cantor J.M. et al. Cerebral white matter deficiencies in pedophilic men. J Psychiatr Res 2008;42(3):167–183.
5. Beier K.M. et al. Encouraging self-identified pedophiles and hebephiles to seek professional help (Prevention Project Dunkelfeld). Child Abuse Negl 2009;33(8):545–549.

ICD-11 **6D33**	**6D33 ZORA DAYALI CİNSEL SADİZM BOZUKLUĞU** **Coercive sexual sadism disorder**
ICD-10 F65.5	Sadomazoşizm
DSM-5-TR F65.52	Cinsel Sadizm Bozukluğu

1. Tanım ve nozoloji

Zora Dayalı Cinsel Sadizm Bozukluğu (ICD-11: 6D33 Coercive Sexual Sadism Disorder; DSM-5-TR: F65.52 Sexual Sadism Disorder) — rızası olmayan kişiye fiziksel veya psikolojik acı vermekten sürekli ve yoğun cinsel uyarılma. Hasta fanteziyi gerçekleştirmiş veya belirgin sıkıntı/işlevsel bozulma yaşamaktadır.

Önemli fark: rızaya dayalı BDSM (Bondage/Discipline, Dominance/Submission, Sadism/Masochism) pratiği — klinik bozukluk değildir; ICD-11 bu farkı vurgular.

2. Tarihçe

- Krafft-Ebing (1886) — sadizm terimi Marquis de Sade'dan.
- DSM-5 (2013) — paraphilia ve paraphilic disorder farkı.
- ICD-11 (2019) — “Coercive” kelimesi rızanın önemini vurgular.
- WFSBP 2020.

3. Epidemiyoloji

- Klinik popülasyonda nadir; adli bağlamda cinsel suç örneklerinde %5–15.
- Neredeyse her zaman erkeklerde.
- Yüksek komorbidite ASPD, diğer parafilik bozukluklar.

4. Etiyoloji ve patogenez

- Biyolojik ve psikososyal faktörler; çocukluk travması, antisosyal özellikler.
- Hiperseksüalite ve dürtüsellik komorbid sık.

5. Klinik özellikler

- Rızası olmayan kurbana acı vermekten cinsel uyarılma.
- Tipik bağlam — adli suç (tecavüz-sadistik).
- Ağır olguda — sadistik cinayetler, ciddi fiziksel yaralanma.
- Adli risk yüksek.

6. Tanı

6.1 Birleşik tanı ölçütleri

A. ≥ 6 ay rızası olmayan kişiye fiziksel veya psikolojik acıdan sürekli ve yoğun cinsel uyarılma.

B. Hasta fanteziyi uygulamış veya önemli sıkıntı yaşar.

6.2 Kaynaklar arasındaki farklar

- DSM-5-TR 6 aylık süre ister; ICD-11'de süre ölçütü yoktur — "sürekli, odaklanmış ve yoğun uyarılma örüntüsü" denir.
- Rızaya dayalı BDSM klinik bozukluk değildir.

6.3 Tanı algoritması

1. Adli klinik görüşme.
2. Risk değerlendirmesi (Static-99R, SVR-20).
3. Komorbid bozukluklar (ASPD, psikopati — PCL-R).

6.4 Ayırıcı tanı

Durum	Ayırt edici
Rızaya dayalı BDSM	Rızaya dayalı bağlam — bozukluk değildir.
ASPD	Cinsel bileşen olmaksızın şiddet.
Psikopati	PCL-R; klinik örtüşme.
Madde indüksiyonlu	Toksikoloji.

7. Muayene ve değerlendirme

- Adli klinik görüşme.
- PCL-R (Psychopathy Checklist), Static-99R, SVR-20.

8. Tedavi

1. WFSBP 2020 basamaklı algoritma:
    - BDT ve nüksün önlenmesi;
    - SSRI yüksek doz;
    - Antiandrojen;
    - GnRH agonisti en ağır vakada.
2. Adli psikiyatri denetimi; hastaneye yatış veya ceza ortamında.
3. Psikopati komorbid hallarda standart psikoterapi az etkilidir.

8.1 Tedavi metodolojileri

1. BDT ve Nüks Önleme (Relapse Prevention) — Sınırlı etkili; psikopati bağlamında sınırlı.
2. SSRI + Antiandrojen + GnRH — WFSBP 2020 basamaklı.
3. PCL-R, Static-99R, SVR-20 — Adli risk değerlendirmesi.

8.2 Kaynaklar arasındaki farklar

- WFSBP 2020 — ağır vakada kombinasyon (BDT + antiandrojen + GnRH).

9. Prognoz

Ağır olguda yüksek nüks riski; multimodal müdahale ve sürekli izlem gereklidir

10. Mit ve yanlış inançlar

Mit 1: “BDSM = sadistik bozukluk”

Kanıt: rızaya dayalı BDSM klinik bozukluk değildir; ICD-11 “coercive” terimi ile kesin olarak ayırt eder. APA ve diğer profesyonel birlikler rızaya dayalı BDSM'i patoloji olarak görmez.

Mit 2: “Sadistik bozukluk tedavi edilemez”

Kanıt: WFSBP 2020 — multimodal müdahale nüks riskini azaltır; psikopati komorbid vakada etki daha az.

Mit 3: “Yalnızca hukuki ceza gerekir”

Kanıt: klinik müdahale yasal denetimle birlikte önerilir.

Mit 4: "Tüm cinsel katiller sadistik bozukluğa sahiptir"

Kanıt: Çoğu cinsel suç ASPD veya başka motivasyonludur; sadistik klinik tanı belirli bir fantezi paterni gerektirir.

11. Kaynaklar

1. WHO. ICD-11. 6D33 Coercive sexual sadism disorder. 2024.
2. APA. DSM-5-TR. 2022.
3. Thibaut F., Cosyns P., Fedoroff J.P. et al.; WFSBP Task Force on Paraphilias. The World Federation of Societies of Biological Psychiatry (WFSBP) 2020 guidelines for the pharmacological treatment of paraphilic disorders. World J Biol Psychiatry 2020;21(6):412–490.
4. Hare R.D. Psychopathy Checklist-Revised (PCL-R). 2nd ed. 2003.

ICD-11 **6D34**	**6D34 SÜRTÜNMECİLİK BOZUKLUĞU** **Frotteuristic disorder**
ICD-10 F65.8	Seksüel tercih bozuklukları, diğer
DSM-5-TR F65.81	Sürtünmecilik Bozukluğu

1. Tanım ve nozoloji

Sürtünmecilik bozukluğu (ICD-11: 6D34 Frotteuristic Disorder; DSM-5-TR: F65.81) — rızası olmayan kişiye dokunma veya kendi cinsel organlarını sürtmekten sürekli ve yoğun cinsel uyarılma. Hasta fanteziyi gerçekleştirmiş veya belirgin sıkıntı/işlevsel bozulma yaşar. Tipik bağlam — kalabalık toplu taşıma ve izdiham.

2. Tarihçe

- "Frotteur" — Fransızca "sürtünen" sözcüğünden.
- DSM-IV (1994) — "Other Specified Paraphilia"; DSM-5 (2013) — ayrı kategori.

3. Epidemiyoloji

- Yaygınlık: Frotöristik davranışlar erişkin erkeklerin %30'una varan oranda görülebilir; parafilik bozukluk ve hiperseksüalite nedeniyle ayaktan başvuran erkeklerin %10–14'ü tanı ölçütlerini karşılar (DSM-5-TR).
- Komorbid diğer parafilik bozukluklar.

4. Etiyoloji ve patogenez

Parafilik genel etiyoloji; komorbid hiperseksüalite ve dürtüsellik.

5. Klinik özellikler

- Sıkışık toplu taşıma yerlerinde (otobüs, metro, kalabalık) rızası olmayan kişiye dokunma.
- Hasta kaçar — mağdur hemen şikayet edemez.
- Hukuki sonuçlar (cinsel taciz, cinsel suç).

6. Tanı

6.1 Birleşik tanı ölçütleri

A. ≥ 6 ay rızası olmayan kişiye dokunma veya sürtünmeden sürekli ve yoğun cinsel uyarılma.

B. Hasta fanteziyi uygulamış veya önemli sıkıntı yaşar.

6.2 Kaynaklar arasındaki farklar

DSM-5-TR / ICD-11 — aynı; WFSBP 2020.

6.3 Tanı algoritması

1. Klinik görüşme.
2. Risk değerlendirmesi.
3. Komorbidite.

6.4 Ayırıcı tanı

Durum	**Ayırt edici**
Rastgele dokunma (sıkışık kalabalıkta)	Rıza sorunu ve fantezi yok.
ASPD	Yaygın antisosyal model.

Durum	Ayırt edici
Manik epizod	Afektif kontekst.

7. Muayene ve değerlendirme

- Adli klinik görüşme.
- Risk ölçekleri.

8. Tedavi

1. WFSBP 2020 basamaklı:
    - BDT ve nüksün önlenmesi;
    - SSRI yüksek doz;
    - Antiandrojen / GnRH ağır durumda.
2. Hukuki-tıbbi koordinasyon.

8.1 Tedavi metodolojileri

1. BDT ve SSRI + WFSBP 2020 protokolü — 6D30/6D31/6D32 ile aynı aşamalı.

9. Prognoz

WFSBP müdahalesi ile nüks azalması.

10. Mit ve yanlış inançlar

Mit 1: "Frotteurizm zararsızdır"

Kanıt: mağdur için travmadır; cinsel suç ve hukuki sonuçlar.

Mit 2: "Sadece bir dürtü — klinik müdahale gerektirmez"

Kanıt: tekrarlayan patern klinik tanı gerektirir.

Mit 3: "Yalnızca hukuki ceza"

Kanıt: klinik müdahale nüksü azaltır.

11. Kaynaklar

1. WHO. ICD-11. 6D34 Frotteuristic disorder. 2024.
2. APA. DSM-5-TR. 2022.

3. Thibaut F., Cosyns P., Fedoroff J.P. et al.; WFSBP Task Force on Paraphilias. The World Federation of Societies of Biological Psychiatry (WFSBP) 2020 guidelines for the pharmacological treatment of paraphilic disorders. World J Biol Psychiatry 2020;21(6):412–490.

6D50–6D5Z FAKTİTİYÖZ BOZUKLUKLAR

Factitious disorders

ICD-11 **6D50**	**6D50 KENDİNE YÖNELİK FAKTİTİYÖZ BOZUKLUK** **Factitious disorder imposed on self**
ICD-10 F68.1	Yeteneksizliklerin Veya Semptomların İstemli Olarak Üretimi Veya Taklidi Fiziksel Veya Psikolojik Sahte Bozukluk
DSM-5-TR F68.10	Kendine Uygulanan Yapay Bozukluk

1. Tanım ve nozoloji

Kendine uygulanan faktitiyöz bozukluk (ICD-11: 6D50; DSM-5-TR: F68.10 Kendine Yönelik Yapay Bozukluk) — hastanın kendisinde fiziksel veya psikolojik semptomları veya yaralanmayı kasıtlı olarak yaratması, bu semptomları başkalarına sunması; belirgin maddi kazanç yoktur (bu yönüyle malingering'den farklıdır). Hastanın temel motivasyonu tıbbi rol veya hasta olarak kabul edilmektir.

2. Tarihçe

- Asher R. (1951) — “Munchausen sendromu” terimi (Baron Munchausen'in fantastik hikayelerinden)
- DSM-III (1980) — Factitious Disorder resmi tanı olarak belirlendi.
- DSM-5 (2013) — “Imposed on Self” ve “Imposed on Another” alt tipleri.
- Eisendrath S.J. derlemeleri — tanı ve klinik yaklaşım.

3. Epidemiyoloji

- Klinik popülasyonda nadir (%1–2 hastane yatışı); klinik yaklaşımda az tespit.

- Cinsiyet: kadınlarda nispeten yüksek (tıbbi meslek geçmişinde).
- Komorbidite: BPD, depresif bozukluklar, travma anamnezi.

4. Etiyoloji ve patogenez

- Psikolojik — tıbbi rolde derin duygusal ihtiyaç; çocukluk travması, ihmal.
- Tıbbi sisteme yakınlık (sağlık profesyoneli olmak).
- BPD komorbid sık.

5. Klinik özellikler

- Çok sayıda tıbbi başvuru ve tetkik; çok sayıda klinik ziyareti ("hospital shopping").
- Çok sayıda cerrahi prosedür.
- Semptom veya yaralanmanın kasıtlı oluşturulması (kan dökme, enfeksiyon yaratma, ilaçla zehirlenme, somatik şikayet uydurma).
- Klinik prezentasyon "imkansız" veya atipik; laboratuvar sonuçları hastanın anlattıklarıyla çelişiyor.
- Hasta görüşmede yalan söyleyebilir; tıbbi öykü güvenilir değil.
- Açık maddi kazanç yok (sigorta, mahkeme, iş).

6. Tanı

6.1 Birleşik tanı ölçütleri

A. Kendinde fiziksel veya psikolojik semptom ya da yaralanmanın kasıtlı olarak oluşturulması (indüklenmiş veya uydurulmuş).

B. Hasta kendini hasta, yaralı gibi sunar.

C. Aldatma davranışı belirgin maddi kazanç yok.

D. Davranış başka bir ruhsal bozukluk (sanrısal bozukluk, diğer psikotik) ile daha iyi açıklanmaz.

6.2 Kaynaklar arasındaki farklar

- DSM-5-TR / ICD-11 — aynı.
- Tanı zordur — kanıt gerektirir (sigorta belgeleri, başka klinikten bilgi, video).

6.3 Tanı algoritması

1. Klinik şüphe — atipik klinik görünümler, çoklu klinik, "imkansız" semptom.
2. Başka kliniklerden tıbbi öykü elde etme (hastanın rızası ile).
3. Sigorta ve eczacılık kayıtları.
4. Gözlem — laboratuvar örneklerinin oluşturulma yolu.
5. Komorbid BPD, MDD, travma anamnezi.
6. Hukuki ve etik koordinasyon.

6.4 Ayırıcı tanı

Durum	**Ayırt edici**
Gerçek tıbbi hastalık	Klinik doğrulama; ancak faktisiyöz komorbid olabilir (kompleks vakalar).
Somatik Belirti Bozukluğu (6C20)	Bilinçli yalan yok; hasta semptomları gerçek hissediyor
Konversion (6B60)	Bilinçli değil; sinir sisteminin fonksiyonel bozukluğu
Malingering	Açık maddi/hukuki kazanç (sigorta, mahkeme).
Sanrı bozukluğu — somatik	İçgörü yok.

7. Muayene ve değerlendirme

- Tıbbi öykü (diğer kliniklerden).
- Sigorta kayıtları.
- Psikiyatrik görüşme komorbid bozukluklar için.

8. Tedavi

1. Konfrontasyon dışı yaklaşım ("non-confrontational approach" — Eisendrath) — tanı hastaya ceza yerine bakım çerçevesinde açıklanır; "sıkıntınız gerçektir, başka yolla yardım edebiliriz".
2. Tek hekim modeli — tüm şikayetler o hekim aracılığıyla.
3. İnvaziv prosedürlerin ve gereksiz tetkiklerin sınırlandırılması.
4. Psikoterapi — destekleyici, BDT; uzun süreli izlem.
5. Komorbid BPD, MDD, travma tedavisi.

6. Konfrontasyon aniden hastayı “kavurur”; yumuşak ve ilgi bağlamında daha iyi.

8.1 Tedavi metodolojileri

1. Destekleyici Psikoterapi — Hastanın duygusal ihtiyaçlarına özen.
2. Multidisipliner Yaklaşım — Tıbbi ve psikiyatrik birlikte.

8.2 Kaynaklar arasındaki farklar

- Eisendrath S.J. — konfrontasyon dışı yaklaşım ve terapötik ittifak.
- APA Textbook of Consultation-Liaison Psychiatry (Levenson).

9. Prognoz

- Kronik seyir; “hospital shopping” devam ediyor.
- Uzun süreli terapötik ittifak ve komorbidite tedavisi prognozu iyileştirir.

10. Mit ve yanlış inançlar

Mit 1: “Hasta 'yalancı'dır, yasal ceza gerektirir”

Kanıt: Faktisiyöz bozukluk psikiyatrik bir bozukluktur — duygusal ihtiyaca yanıt; konfrontasyon dışı yaklaşım ve psikoterapi önerilir.

Mit 2: “Doğrudan ‘yalan söylüyorsun’ denmesi hastayı ‘düzeltir’”

Kanıt: katı konfrontasyon hastayı “yakar” ve başka bir kliniğe geçer; yumuşak yaklaşım terapötik ilişki kurar.

Mit 3: “Faktisiyöz bozukluk = somatik semptom bozukluğu”

Kanıt: Faktisiyöz bilinçli yalan; somatik semptom — hastanın gerçek hissi.

Mit 4: “Başlanan invaziv işlemler sonuna kadar sürdürülmelidir”

Kanıt: gereksiz invaziv prosedürler zararlıdır; tanı konulduktan sonra sınırlandırılmalıdır.

Mit 5: “Faktisiyöz bozukluk tedavi edilemez”

Kanıt: kanıt temeli kısıtlıdır, ancak uzun süreli terapötik ilişki ve multidisipliner bakım ile iyileşme mümkündür.

11. Kaynaklar

1. WHO. ICD-11. 6D50 Factitious disorder imposed on self. 2024.
2. APA. DSM-5-TR. 2022.
3. Eisendrath S.J. Factitious physical disorders: treatment without confrontation. Psychosomatics 1989;30(4):383–387.
4. Levenson J.L. (ed.). APA Publishing Textbook of Psychosomatic Medicine and Consultation-Liaison Psychiatry. 3rd ed. 2018.
5. Asher R. Munchausen's syndrome. Lancet 1951;1(6650):339–341.

ICD-11 **6D51**	**6D51 BAŞKASINA YÖNELİK FAKTİTİYÖZ BOZUKLUK** **Factitious disorder imposed on another**
ICD-10 F68.1	Yeteneksizliklerin Veya Semptomların İstemli Olarak Üretimi Veya Taklidi Fiziksel Veya Psikolojik Sahte Bozukluk
DSM-5-TR F68.A	Başkasına Uygulanan Yapay Bozukluk

1. Tanım ve nozoloji

Başkasına uygulanan faktitiyöz bozukluk (ICD-11: 6D51 Factitious Disorder Imposed on Another; DSM-5-TR: F68.10) — hastanın başka bir kişide (tipik olarak kendi çocuğunda, yaşlı veya engelli bakım alanında) fiziksel veya psikolojik semptom yaratması veya taklit etmesi; o kişiyi kurban olarak hastaneye getirir. Önceleri “Munchausen by proxy” (Meadow R. 1977) olarak adlandırılırdı.

Tanı hastaya konur, kurbana değil. Bu bozukluk aynı zamanda çocuk istismarıdır — çocuk koruma ve hukuki müdahale zorunludur.

2. Tarihçe

- Meadow R. (1977) — “Munchausen syndrome by proxy” Lancet.
- DSM-IV (1994) — araştırma kategorisinde.
- DSM-5 (2013) — resmi tanı.

- APSAC, AAP — çocuk koruma protokolleri.

3. Epidemiyoloji

- Nadir — yıllık insidans ~2/100 000 çocuk (Sheridan M.S. Child Abuse Negl 2003 derlemesi); az bildirim.
- Tipik fail — biyolojik anne (>%90); mağdur — çocuk (tipik < 5 yaş).
- Mağdurların mortalitesi %6–9 (Sheridan); morbidite yüksek.

4. Etiyoloji ve patogenez

- Olgunun psikolojik ihtiyaçları — tıbbi rolde dikkat, ilişkiler, "kahraman" imajı.
- Tıbbi meslek geçmişinde yoğunluk.
- Olgunun öyküsünde travma veya ihmal.

5. Klinik özellikler

- Çocuğun semptomları yalnızca annesinin yanında ortaya çıkar; yatağa yatırıldığında ve anne ayrı olduğunda iyileşir.
- Çok sayıda klinik, atipik semptomlar, "imkansız" tıbbi öykü.
- Anne — tıbbi profesyonel veya tıbbi bilgi açısından zengin.
- Anne aşırı nazik ve "ideal bakıcı" görünür.
- Tipik indüksiyon yöntemleri: ilaçla zehirlenme, gıda veya hava yolunun mekanik tıkanması, kan toplama, enfeksiyon oluşturma.
- Mağdur çocukta açıklanamayan tekrarlayan nöbetler, apne, hipoglisemi, enfeksiyon, cilt yaralanması.

6. Tanı

6.1 Birleşik tanı ölçütleri

A. Hastanın başkasında (mağdur) fiziksel veya psikolojik belirti ya da yaralanmanın kasıtlı olarak yaratılması.

B. Hasta mağduru hasta, yaralı gibi başkalarına sunar.

C. Aldatma davranışı belirgin maddi kazanç yok.

D. Davranış başka bir ruhsal bozukluk ile daha iyi açıklanmaz.

Tanı faile konur, kurbana değil.

6.2 Kaynaklar arasındaki farklar

- DSM-5-TR / ICD-11 — aynı.
- APSAC, AAP — çocuk koruma protokolleri; bu klinik durum aynı zamanda çocuk istismarı kategorisidir.

6.3 Tanı algoritması

1. Klinik şüphe — atipik semptom paterni, anneye bağlı.
2. Pediatrist, psikiyatrist, sosyal hizmet uzmanı multidisipliner ekip.
3. Tıbbi belgelerin diğer kliniklerden elde edilmesi.
4. Ayırma testi — annenin kurbandan ayrı olduğunda semptomların izlenmesi.
5. Video izleme (çocuk koruma ve hukuki müdahale altında).
6. Toksikolojik ve biyokimyasal testler (oluşturma kanıtı).
7. Çocuk koruma başvurusu ve hukuki koordinasyon zorunludur.

6.4 Ayırıcı tanı

Durum	**Ayırt edici**
Gerçek tıbbi hastalık	Tıbbi kanıt.
Aşırı kaygılı ebeveyn	Kasıtlı indüksiyon yok; tıbbi şüpheleri ifade eder, ancak yaratmaz.
Gerçek çocuk istismarı (başka form)	Fiziksel istismar, cinsel istismar, ihmal — farklı motivasyon.
Faktisiyöz kendine (6D50)	Mağdurun kendisidir.

7. Muayene ve değerlendirme

- Pediatrik klinik değerlendirme.
- Tıbbi öykü grup ile.
- Sosyal hizmet ve çocuk koruma başvurusu.
- Hukuki koordinasyon.

8. Tedavi

1. Mağdurun güvenliği birinci öncelik — çocuğun ayrılması (anne veya bakıcıdan).
2. Çocuk koruma başvurusu — hukuki protokoller.
3. Hastanın (failin) psikiyatrik tedavisi:

- Psikoterapi (uzun süreli);
- Komorbid bozukluklar (BPD, MDD, travma);
- Tıbbi meslek geçmişinde — meslek yasağı değerlendirilebilir.

4. Aile müdahalesi ve kardeşlerin koruma değerlendirmesi.
5. Mağdur çocuğun psikoterapisi — travma müdahalesi.

8.1 Tedavi metodolojileri

1. Çocuk Koruma Başvurusu — Şüphe durumunda mutlaka; APSAC, AAP protokolleri.
2. Multidisipliner Grup — Pediatrist + psikiyatrist + sosyal hizmet uzmanı + adli uzman.
3. Ayırma Testi (Separation Test) — Anne kurbandan ayrılır; semptomlar izlenir.
4. Video İzlem — Yasal ve etik denetim altında.

8.2 Kaynaklar arasındaki farklar

- APSAC — çocuk koruma protokolleri.
- AAP — pediatr rolü.
- Hukuki sistemin koordinasyonu zorunludur.

9. Prognoz

- Mağdur için — müdahalesiz yüksek mortalite (%6–9) ve morbidite.
- Olgu için — psikoterapi ile iyileşme; uzun süreli izlem.

10. Mit ve yanlış inançlar

Mit 1: "Anne gerçekten ilgili, tanı yanlış"

Kanıt: klinik özellikler (anneye bağlı semptomlar, atipik tıbbi öykü) ciddi kanıt gerektirir; klinik şüphe çocuk korumaya başvurmak için yeterlidir.

Mit 2: "Bu durum psikiyatrik bir sorun değil, sadece çocuk istismarıdır"

Kanıt: her iki yaklaşım da önemlidir — çocuk koruma + failin psikiyatrik tedavisi.

Mit 3: "Failin tedavisi mağdura bakımın durdurulmasını geciktirir"

Kanıt: mağdurun güvenliği birinci öncelik; psikiyatrik tedavi ayrıca sürdürülür.

Mit 4: “Yalnızca annede meydana gelir”

Kanıt: Çoğu vakada anne, ancak çocuğa bakan diğer kişiler — babalar, bakıcılar, sağlık çalışanları — da fail olabilir.

Mit 5: “Konfrontasyon hastayı ‘tedavi eder’”

Kanıt: konfrontasyon başka bir kliniğe geçişe neden olabilir; hasta devam eder; çocuk koruma ve adli koordinasyon zorunludur.

11. Kaynaklar

1. WHO. ICD-11. 6D51 Factitious disorder imposed on another. 2024.
2. APA. DSM-5-TR. 2022.
3. Meadow R. Munchausen syndrome by proxy. The hinterland of child abuse. Lancet 1977;2(8033):343–345.
4. Sheridan M.S. The deceit continues: an updated literature review of Munchausen Syndrome by Proxy. Child Abuse Negl 2003;27(4):431–451.
5. APSAC Task Force. Munchausen by Proxy: Identification, Intervention, and Case Management. 2018.

6D70–6D8Z NÖROKOGNİTİF (DEMANS)

Neurocognitive disorders

ICD-11 **6D70**	**6D70 DELİRYUM** **Delirium**
ICD-10 F05	Deliryum, alkol ve diğer psikoaktif maddelere bağlı olmayan
DSM-5-TR F05	Deliryum

1. Tanım ve nozoloji

Deliryum (ICD-11: 6D70; DSM-5-TR: F05) — akut, dalgalı dikkat ve bilinç bozukluğu, kognitif defisit (bellek, oryantasyon, dil, görsel-uzamsal) ve algı bozuklukları (illüzyon, halüsinasyonlar) ile karakterize nöropsikiyatrik sendrom. Tipik bir tıbbi nedene (enfeksiyon, ilaç, metabolik, nörolojik) yanıt olarak gelişir.

Tıbbi acil durumdur — hastaneye yatırılmış yaşlı hastalarda mortalite %25–33.

2. Tarihçe

- Hipokrat “phrenitis” — deliryumun klasik tanımı.
- Lipowski Z.J. (1980-90'lar) — modern kavramsallaştırma.
- CAM (Confusion Assessment Method, Inouye S.K. 1990) — altın standart tarama.

3. Epidemiyoloji

- Hastaneye yatırılmış yaşlılarda yaygınlık %15–30; YBÜ'de %50–80; cerrahi sonrası %15–50.
- Komorbidite: demans (demans zemininde gelişen deliryum), enfeksiyon, polifarmasi.
- Mortalite ve morbidite yüksek; uzun süreli bilişsel düşüş riski.

4. Etiyoloji ve patogenez

- Çok sayıda faktör:
    - Enfeksiyonlar — sepsis, pnömoni, İYE;
    - İlaç — antikolinerjik, opioid, benzodiazepin, steroidler;
    - Madde kesilmesi (alkol, benzodiazepin);
    - Metabolik — elektrolit, glukoz, amonyak, üremi;
    - Hipoksi, hipoperfüzyon;
    - Nörolojik — nöbet, inme, beyin tümörü, ensefalit;
    - Ağrı, konstipasyon, idrar tutulması
    - Çevre — duyusal yoksunluk, uyku bozukluğu (özellikle YBÜ).

5. Klinik özellikler

Üç motorik alt tip

- Hiperaktif — ajitasyon, halüsinasyon — tanıyı kolaylaştırır.
- Hipoaktif — sedasyon, geri çekilme — tanısı sıklıkla konulamaz, depresyona benzer;
- Karışık — dalgalanma.

Klinik belirtiler

- Akut başlangıç (saatler-günler) ve dalgalanma.
- Dikkat bozukluğu.
- Bilişsel defisitler — bellek, oryantasyon (zaman, yer, kişi).
- Algı bozuklukları — vizüel halüsinasyonlar tipik.
- Uyku-uyanıklık siklusunun bozulması.
- Sundowning — akşam saatlerinde kötüleşme.

6. Tanı

6.1 Birleşik tanı ölçütleri

A. Dikkat bozukluğu (yönlendirme, sürdürme, kaydırma) ve bilinç bozukluğu.

B. Bozulma kısa sürede (saatler-günler) gelişir; ilk göstergelerden değişir; gün içinde dalgalanma.

C. Ek kognitif bozulma (bellek, oryantasyon, dil, görsel-uzamsal, algı).

D. Demans veya başka bir nörokognitif bozuklukla tam olarak açıklanamaz.

E. Kanıt — öykü, muayene, laboratuvar gösterir ki bozukluk doğrudan tıbbi durum, madde intoksikasyonu/kesilmesi veya çoklu etiyoloji sonucudur.

6.2 Kaynaklar arasındaki farklar

- DSM-5-TR / ICD-11 — aynı.
- NICE CG103 — Deliryum: önleme, tanı, yönetim (2010, 2019 güncellemesi).

6.3 Tanı algoritması

1. CAM (Confusion Assessment Method) — altın standart tarama.
2. CAM-ICU — yoğun bakım için.
3. Tıbbi neden arayışı: tam kan, elektrolitler (Na, K, Ca, Mg, P), glukoz, karaciğer, böbrek, TSH, B12, troponin, EKG, idrar analizi ve kültürü, kan kültürü, akciğer grafisi, beyin MR/BT, EEG (nöbet şüphesi), lomber ponksiyon (ensefalit/meninjit).
4. İlaç listesinin gözden geçirilmesi — antikolinerjik, opioid, benzodiazepin (Beers Kriterleri).
5. Toksikoloji.
6. Komorbid demans değerlendirmesi (ilk belirtiler).

6.4 Ayırıcı tanı

Durum	**Ayırt edici**
Demans (6D8x)	Kademeli başlangıç; dikkat nispeten korunur.
Depresyon (psikomotor yavaşlama hipoaktif olarak)	Afektif semptomlar dominant; dikkat nispeten korunur.
Psikotik epizod	Dikkat sürdürülür; başlangıç farklı.
Non-convulsive status epilepticus	EEG.
Wernicke ensefalopatisi	Tiamin testi; klasik triadı (oftalmopleji, ataksi, konfüzyon)

7. Muayene ve değerlendirme

- CAM, CAM-ICU.
- MMSE veya MoCA (başlangıç göstergeleri bilişsel işlev).

- Yukarıdaki tıbbi panelden.
- EEG — non-konvülsif status istisnası.

8. Tedavi

8.1 Genel Prensipler (NICE CG103)

1. Etiyolojik tedavi birinci öncelik — enfeksiyon, metabolik, ilaç, hastaneye yatış bağlamının düzeltilmesi.
2. Çevre modifikasyonu — duyusal (gözlük, işitme cihazı), gündüz ışığı, gece karanlığı, sessiz ortam, yakınların yanında olması.
3. Yatak bakımı — hidrasyon, beslenme, idrar ve defekasyon, hareket.
4. Antipsikotik (haloperidol 0,25–2 mg, ketiapin, risperidon) — yalnızca şiddetli ajitasyon veya hastanın kendisine/başkasına tehlike oluşturması durumunda, kısa süreli, düşük doz. NICE CG103 — antipsikotik rutin olarak önerilmez; kanıt temeli sınırlıdır (Burry L. Cochrane 2018).
5. Benzodiazepin — yalnızca alkol veya benzodiazepin kesilme deliryumunda; diğer durumlarda kontrendikedir (deliryumu güçlendirir).
6. Profilaksi — ABCDEF bundle ICU'da (Awakening, Breathing, Coordination, Delirium monitoring, Early mobility, Family).

8.2 Tedavi metodolojileri

1. Konfüzyon Değerlendirme Metodu (CAM — Confusion Assessment Method) — Inouye (Inouye S.K.) — 4 temel özellik: akut başlangıç/dalgalanma + dikkat eksikliği + dağınık düşünce veya bilinç değişikliği.
2. CAM-ICU — Yoğun bakım için adapte edilmiş; ventilatördeki hastalarda.
3. Hastane Yaşlı Hayat Programı (HELP — Hospital Elder Life Program) — Inouye (Inouye S.K.) — Çok bileşenli deliryum profilaksisi programı; kanıt temeli güçlü.

8.3 Kaynaklar arasındaki farklar

- NICE CG103 — etyolojik ve çevresel yaklaşım birinci basamak; antipsikotik sınırlı.
- SCCM PADIS Guidelines (YBÜ için, 2018).
- Burry L. Cochrane 2018 — antipsikotik deliryum süresini veya mortaliteyi azaltmaz.

9. Prognoz

- Hastane mortalitesi %25–33.
- Sağ kalanlarda — işlevsel düşüş, uzun süreli bilişsel bozulma, demans riski artmış.
- Erken etiyolojik müdahale prognozu iyileştirir.

10. Mit ve yanlış inançlar

Mit 1: "Deliryum 'yaşlı insan için normaldir'"

Kanıt: deliryum klinik acil durumdur, mortalite yüksek; aktif müdahale gerektirir.

Mit 2: "Antipsikotik deliryum tedavisidir"

Kanıt: NICE CG103, Burry Cochrane 2018 — antipsikotik deliryum süresini, mortaliteyi azaltmaz; yalnızca şiddetli ajitasyon için.

Mit 3: "Benzodiazepin yaşlı ajite hasta için güvenlidir"

Kanıt: benzodiazepin deliryumu güçlendirir; yalnızca alkol/bz yoksunluğu durumunda.

Mit 4: "Hipoaktif deliryum 'iyidir', müdahale gerektirmez"

Kanıt: hipoaktif deliryum daha kötü mortalite ile ilişkili; az tespit edilme sorunu.

Mit 5: "Hastanın uyuması deliryum için en iyisidir"

Kanıt: Gündüz aktivite, yakınların yanında olması, duyusal stimülasyon önerilir; HELP programı kanıtlı.

11. Kaynaklar

1. WHO. ICD-11. 6D70 Delirium. 2024.
2. APA. DSM-5-TR. 2022.
3. NICE CG103. Delirium: prevention, diagnosis and management. 2010, 2019 update.
4. Inouye S.K. ve ark. Clarifying confusion: the confusion assessment method. Ann Intern Med 1990;113(12):941–948.
5. Burry L. et al. Antipsychotics for treatment of delirium in hospitalised non-ICU patients. Cochrane Database Syst Rev 2018;(6):CD005594.
6. Devlin J.W. et al. SCCM PADIS Guidelines. Crit Care Med 2018;46(9):e825–e873.

ICD-11 **6D71**	**6D71 HAFİF NÖROBİLİŞSEL BOZUKLUK (MCI)** **Mild neurocognitive disorder**
ICD-10 F06.7	Hafif bilişsel bozukluk
DSM-5-TR G31.84	Ağır Olmayan Nörobilişsel Bozukluk

1. Tanım ve nozoloji

Hafif nörobilişsel bozukluk (ICD-11: 6D71 Mild Neurocognitive Disorder; DSM-5-TR: G31.84) — bir veya birkaç bilişsel alanda (bellek, karmaşık dikkat, yürütücü işlev, dil, görsel-uzamsal, sosyal biliş) hafif düşüş; Günlük aktivite sürdürülür (kompanzasyon gerekli olsa da). Tipik adı — "Mild Cognitive Impairment" (MCI).

2. Tarihçe

- Petersen R.C. (1999) — MCI klinik kavramsallaştırması.
- DSM-5 (2013) — Major (demans) ve Mild Neurocognitive Disorders kategorileri.
- AAN (2018) — Practice Guideline for MCI (Petersen).

3. Epidemiyoloji

- 65+ yaşta yaygınlık %10–20.
- Yıllık %10–15 MCI Alzheimer demansına dönüşür.
- Risk faktörleri: yaş, ApoE4, kardiyovasküler.

4. Etiyoloji ve patogenez

- Alzheimer prodromal (amnestik MCI);
- Vasküler;
- Lewy cisimcikleri prodromal;
- Frontotemporal;
- Tıbbi (depresyon, tiroid, B12, ilaç etkileri)

5. Klinik özellikler

- Hasta veya yakını bilişsel düşüşten şikayet eder.
- Standardize edilmiş testlerde hafif defisit (tipik -1 ila -2 SD).
- Günlük aktivite korunur (karmaşık aktivitelerde minimal kompanzasyon).
- Alt tipler: amnestik (bellek dominant — Alzheimer riski yüksek), non-amnestik (yürütücü veya başka alan).

6. Tanı

6.1 Birleşik tanı ölçütleri

A. Bir veya daha fazla bilişsel alanda hafif düşüş (hasta, bilgi veren veya klinisyen tarafından belirtilen ve standartlaştırılmış nöropsikolojik test).

B. Günlük aktivite korunur.

C. Deliryum ile daha iyi açıklanmaz.

D. Başka bir psikiyatrik bozukluk (MDD) ile daha iyi açıklanmaz.

6.2 Kaynaklar arasındaki farklar

- DSM-5-TR — Major ve Mild ayrımı.
- AAN 2018 — etiyolojik araştırma (Alzheimer, vasküler) ve biyobelirteçler gelişme aşamasında.

6.3 Tanı algoritması

1. Klinik görüşme + informant.
2. MoCA (Montreal Cognitive Assessment), MMSE.
3. Nöropsikolojik test.
4. Laboratuvar — B12, folat, TSH, karaciğer, böbrek, glukoz, HIV/sifiliz.
5. Beyin MRG — vasküler, atrofi, diğer patoloji.
6. Biyobelirteçler (klinik şüphede) — BOS amiloid-β/tau, PET görüntüleme (Alzheimer prodromu).
7. Depresyon taraması (GDS, PHQ-9).

6.4 Ayırıcı tanı

Durum	**Ayırt edici**
Demans (Major NCD)	Günlük aktivite belirgin şekilde bozulmuş.

Durum	Ayırt edici
Normal yaşa bağlı kognitif değişiklik	Test edilirken normal performans.
Depresyon (psödodemans)	Afektif semptomlar dominant; antidepresanla düzelir.
Delirium (6D70)	Akut başlangıç, dikkat dalgalanması.
B12 veya tiroid eksikliği	Laboratuvar; düzeltme ile iyileşme.

7. Muayene ve değerlendirme

- MoCA (≤ 25 patolojik) — MCI için doğrulanmış tarama; MMSE'nin MCI için belirlenmiş bir kesme noktası yoktur ve hafif bozukluğa duyarlılığı düşüktür.
- Nöropsikolojik batarya (bellek, yürütücü, dil, görsel-uzamsal).
- Laboratuvar paneli.
- MRG (rutin), biyobelirteçler (seçici).

8. Tedavi

1. Etyolojik tedavi — değiştirilebilir faktörler (kardiyovasküler risk, B12, tiroid, depresyon, ilaç).
2. Yaşam tarzı — fiziksel aktivite (aerobik), Akdeniz diyeti, bilişsel uyarım, sosyal bağlantılar (FINGER trial Lancet 2015 — multimodal yaklaşım etkili).
3. Farmakoterapi MCI için spesifik onay yoktur. Donepezil ve diğer AChEI — kanıt temeli sınırlıdır; rutin önerilmez.
4. Lekanemab, Donanemab — yeni anti-amiloid antikorlar; FDA onayı (lekanemab 2023, donanemab 2024) Alzheimer prodrom ve hafif demans için; klinik etki orta düzeyde, infüzyon reaksiyonları ve ARIA (Amyloid-Related Imaging Abnormalities) riskli.
5. Komorbid depresyon, anksiyete tedavisi (SSRI).
6. Demansa geçiş riskinin izlenmesi.

8.1 Tedavi metodolojileri

1. Montreal Bilişsel Değerlendirme (MoCA — Montreal Cognitive Assessment) — Nasreddine (Nasreddine Z.S.) — 30 madde; MCI taraması (kesme noktası 26).

2. FINGER Çok Modlu Müdahalesi (FINGER — Finnish Geriatric Intervention Study) — Diyet + egzersiz + bilişsel eğitim + vasküler risk yönetimi.
3. Lekanemab, Donanemab — Anti-amiloid antikorlar; FDA onayı; ARIA izlemi (MRG).

8.2 Kaynaklar arasındaki farklar

- AAN 2018 — modifiye edilebilir faktörler ve yaşam tarzı.
- FINGER trial (Ngandu Lancet 2015) — multimodal müdahale.
- Lekanemab — CLARITY-AD (van Dyck NEJM 2023); donanemab — TRAILBLAZER-ALZ 2 (Sims JAMA 2023).

9. Prognoz

- Stabil %30, demansa geçiş %10–15/yıl, geri dönüş %15–20.
- Amnestik MCI Alzheimer prodromu — yüksek konversiyon.

10. Mit ve yanlış inançlar

Mit 1: “MCI mutlaka demansa dönüşür”

Kanıt: yıllık %10–15 geçer; bir kısmı stabil kalır veya iyileşir.

Mit 2: “B vitamini ve ginkgo MCI'yı iyileştirir”

Kanıt: B vitaminleri yalnız eksiklikte; ginkgo Cochrane (Birks 2009) — etki kanıtı zayıf.

Mit 3: “AChEI standart MCI tedavisidir”

Kanıt: AAN 2018 — kanıt bazası kafi değil; rutin önerilmez.

Mit 4: “Lekanemab MCI/Alzheimer'ı iyileştirir”

Kanıt: klinik düşüş hızını ~%25 azaltır; ARIA ve infüzyon reaksiyonları; “tedavi” değildir.

Mit 5: “Bilişsel düşüş yaşla kaçınılmazdır”

Kanıt: Kardiyovasküler risk, fiziksel aktivite, sosyal bağlantılar değiştirilebilir faktörlerdir.

11. Kaynaklar

1. WHO. ICD-11. 6D71 Mild neurocognitive disorder. 2024.
2. APA. DSM-5-TR. 2022.
3. Petersen R.C. et al. Practice guideline update summary: Mild cognitive impairment. Neurology 2018;90(3):126–135.
4. Ngandu T. et al. A 2-year multidomain intervention of diet, exercise, cognitive training, and vascular risk monitoring (FINGER): a randomised controlled trial. Lancet 2015;385(9984):2255–2263.
5. van Dyck C.H. et al. Lecanemab in Early Alzheimer's Disease. NEJM 2023;388(1):9–21.
6. Nasreddine Z.S., Phillips N.A., Bédirian V. et al. The Montreal Cognitive Assessment, MoCA: a brief screening tool for mild cognitive impairment. J Am Geriatr Soc 2005;53(4):695–699.
7. Birks J., Grimley Evans J. Ginkgo biloba for cognitive impairment and dementia. Cochrane Database Syst Rev 2009;(1):CD003120.

ICD-11 **6D72**	**6D72 AMNESTİK BOZUKLUK** **Amnestic disorder**
ICD-10 F04	Organik amnezik sendrom, alkol ve diğer psikoaktif maddelerin sebep olmadığı
DSM-5-TR F02.8x	Başka Bir Tıbbi Duruma Bağlı Ağır Nörobilişsel Bozukluk (amnestik görünüm)

1. Tanım ve nozoloji

Amnestik Bozukluk (ICD-11: 6D72 Amnestic Disorder; DSM-5-TR: F04 ve benzeri) — yeni bilgiyi öğrenme ve geri çağırmada belirgin bozulma; diğer bilişsel alanlar görece korunur. Tıbbi durum (Wernicke-Korsakoff, beyin hasarı, ensefalit, anoksi), madde etkisi veya başka nedenlerle.

2. Tarihçe

- Korsakoff S. (1887) — alkol-ilişkili amnezi tanımı.

- Scoville W.B., Milner B. (1957) — H.M. vakası (bilateral medial temporal rezeksiyon sonrası amnezi).

3. Epidemiyoloji

- Korsakoff sendromu — kronik ağır alkol kullanıcılarının %12–25'inde.
- Travmatik beyin hasarı sonrası amnezi — TBH hastalarının %30–50'sinde.
- Transient global amnesia (TGA) — 65+ yaşta yaygınlık 5–25/100 000/yıl.

4. Etiyoloji ve patogenez

- Wernicke-Korsakoff — tiamin (B1) eksikliği (alkol, malnutrisyon).
- Travmatik beyin hasarı (TBH).
- Hipoksi/anoksi — kardiyak arrest, karbon monoksit.
- Herpes simpleks ensefaliti.
- Otoimmün ensefalit (anti-NMDA, anti-LGI1).
- Transient global amnesia (TGA) — vasküler şüphesi.
- Madde (alkol blackout, benzodiazepin).
- İnme (özellikle bilateral talamik veya hipokampal).

5. Klinik özellikler

- Anterograd amnezi — yeni bilginin öğrenilmesinde bozulma (temel özellik).
- Retrograd amnezi — geçmiş bellek (yaralanma öncesi için; "Ribot yasası" — yeni anılar daha önce kaybedilir).
- Konfabulasyon — Korsakoff sendromunda — hasta boş hafıza alanlarını uydurmalarla doldurur.
- Başka bilişsel alanlar nispeten korunur (zeka, dil, görsel-uzamsal).

6. Tanı

6.1 Birleşik tanı ölçütleri

A. Yeni bilginin öğrenme bozukluğu veya önceden öğrenilen bilginin geri çağırma bozukluğu.

B. Bellek bozukluğu önemli işlevsel bozulma yaratır.

C. Yalnızca deliryum veya başka NCD bağlamında ortaya çıkmaz.

D. Kanıt — öykü, muayene, laboratuvar gösterir ki bellek bozukluğu spesifik nedene (tıbbi durum, madde) bağlıdır.

6.2 Kaynaklar arasındaki farklar

- DSM-5-TR — Major ve Mild NCD yapısına entegrasyon; amnestik alt tip.
- ICD-11 — ayrı kategori.

6.3 Tanı algoritması

1. Klinik görüşme + informant.
2. Nöropsikolojik test — bellek (WMS-IV, RAVLT, Wechsler Logical Memory).
3. Beyin MRG — bilateral hipokampal, medial temporal, talamik patoloji.
4. Tiamin (B1) düzeyi veya ampirik tiamin (Korsakoff şüphesi)
5. Toksikoloji.
6. Otoimmün ensefalit panel (atipik durumda).
7. EEG.

6.4 Ayırıcı tanı

Durum	**Ayırt edici**
Alzheimer demansı	Çok sayıda bilişsel alan, kademeli başlangıç.
Delirium (6D70)	Dikkat dalgalanması.
Disosiyatif amnezi (6B61)	Travma bağlamında; seçici geçmiş bellek; tıbbi neden yok.
Yapay bozukluk / temaruz	Atipik model, ikincil kazanç.
TGA	Akut, 24 saatten az; tam iyileşme.

7. Muayene ve değerlendirme

- WMS-IV (Wechsler Memory Scale), RAVLT.
- Beyin MRG.
- Tiamin, B12.
- Toksikoloji.

8. Tedavi

1. Etiyolojik — tiamin (Wernicke-Korsakoff — 500 mg IV × 3 kez/gün × 3 gün, sonra 250 mg IM/günde × 3–5 gün; uzun süreli oral tiamin alkol kesilmesinde).
2. Otoimmün ensefalit — immünoterapi (steroidler, IVIG, plazmaferez, rituksimab).
3. Herpes ensefalit — asiklovir.
4. Telafi edici stratejiler (harici bellek yardımcıları, günlük yapılandırma).
5. Madde kullanımı (alkol) tedavisi.
6. Rehabilitasyon — bilişsel rehabilitasyon (Wilson B.A.).

8.1 Tedavi metodolojileri

1. Wernicke-Korsakoff Profilaksisi ve Tedavisi — Tiamin IV/IM yüksek dozda; glukozdan ÖNCE uygulama kritik (glukoz tiamin eksikliğinde Wernicke'yi güçlendirir).
2. Bilişsel Rehabilitasyon (Cognitive Rehabilitation) — Wilson (Wilson B.A.) — Harici bellek yardımcıları (günlük, telefon hatırlatıcıları), strateji öğretimi.
3. İmmünoterapi (Otoimmün Ensefalit) — Graus 2016 protokolü.

8.2 Kaynaklar arasındaki farklar

- Wernicke-Korsakoff — Royal College of Physicians thiamine protocol.
- Graus F. ve ark. Lancet Neurol 2016 — otoimmün ensefalit.

9. Prognoz

- TGA — tam iyileşme.
- Korsakoff — kalıcı defisit tipik; tiamin ile Wernicke akut müdahalesi kritik.
- TBİ — rehabilitasyonla kısmi iyileşme.

10. Mit ve yanlış inançlar

Mit 1: “Amnezi hipnoz ile ‘geri getirilebilir’”

Kanıt: hipnoz false memory yaratır; organik amnezide etkisizdir.

Mit 2: “Oral tiamin Wernicke'de yeterlidir”

Kanıt: oral absorbsiyon yeterli değil; IV/IM yüksek doz gerekir.

Mit 3: "Glukoz ile Wernicke 'iyileştirilir'"

Kanıt: glukoz tiamin eksikliğinde Wernicke ensefalopatisini tetikler ve şiddetlendirir; tiamin önceden uygulanır.

Mit 4: "Tüm amneziler geçicidir"

Kanıt: Korsakoff, TBİ-temelli amnezi tipik kronik; rehabilitasyon iyileşme sağlar, ancak tam düzelme az.

Mit 5: "Konfabülasyon yalandır"

Kanıt: konfabulasyon Korsakoff sendromunda nörobiyolojik bir fenomendir, bilinçli yalan değildir.

11. Kaynaklar

1. WHO. ICD-11. 6D72 Amnestic disorder. 2024.
2. APA. DSM-5-TR. 2022.
3. Royal College of Physicians. Wernicke's encephalopathy and Korsakoff's syndrome. 2014.
4. Graus F. ve ark. A clinical approach to diagnosis of autoimmune encephalitis. Lancet Neurol 2016;15(4):391–404.
5. Wilson B.A. Neuropsychological Rehabilitation. Wiley; 2009.

ICD-11 **6D80**	**6D80 ALZHEİMER HASTALIĞI NEDENLİ DEMANS** **Dementia due to Alzheimer disease**
ICD-10 F00	Bunama, Alzheimer hastalığında
DSM-5-TR G30.9 + F02.8x	Alzheimer Hastalığına Bağlı Yeğin Nörobilişsel Bozukluk

1. Tanım ve nozoloji

Alzheimer hastalığı nedenli demans (ICD-11: 6D80; DSM-5-TR: G30.9 + F02.8x Alzheimer Hastalığına Bağlı Major Nörokognitif Bozukluk) — kademeli ve sürekli kognitif düşüş, başlangıçta epizodik bellek, sonra çok sayıda kognitif alan ve günlük işlevde belirgin bozulma. Demansların en sık nedeni (%60–70).

2. Tarihçe

- Alzheimer A. (1906) — ilk klinik ve patohistolojik tanımlama.
- Amiloid hipotezi (Hardy J., Higgins G.A. Science 1992).
- NICE NG97 (2018) — demans klinik kılavuzu.
- FDA — aducanumab (2021, tartışmalı), lekanemab (2023), donanemab (2024) — anti-amiloid antikorlar.

3. Epidemiyoloji

- Dünyada 55 milyon+ demans hastası (WHO 2023); %60–70 Alzheimer.
- Yaygınlık yaşa göre: 65 yaş %5, 80+ yaş %25+.
- Cinsiyet: kadınlarda yüksek (beklenen yaşam süresi ile ilişkili).
- Komorbidite: kardiyovasküler, depresyon, anksiyete, BPSD (davranışsal ve psikolojik demans belirtileri).

4. Etiyoloji ve patogenez

- Ailesel Alzheimer (%1): APP, PSEN1, PSEN2 mutasyonları (erken başlangıçlı, dominant).
- Sporadik (%99) — multipl genler (ApoE4 en güçlü risk; LOAD GWAS lokusları).
- Modifiye edilebilir faktörler (Lancet Commission 2024) — yaş, ApoE4 yanında: düşük eğitim, işitme kaybı, hipertansiyon, obezite, sigara, depresyon, fiziksel pasiflik, sosyal izolasyon, diyabet, hava kirliliği, alkol, TBI, görme kaybı, yüksek LDL.
- Patogenez — amiloid-β plakları + tau nörofibriler yumakları + nöroinflamasyon.

5. Klinik özellikler

- Tipik başlangıç — epizodik bellek düşüşü (yeni bilgi depolama güçlüğü).
- Aşamalar:
    - Erken — bellek, anomi, oryantasyon güçlüğü;
    - Orta — görsel-uzamsal, yürütücü işlev, günlük aktivite destekle;
    - Geç — konuşma ileri derecede sınırlı, yakınlarını tanıyamama, hareket kısıtlılığı, beslenme ve yutma güçlüğü.
- BPSD — ajitasyon, agresyon, sanrılar (özellikle çalıntı), halüsinasyonlar, depresyon, anksiyete, uyku bozukluğu, sundowning.

- Atipik formlar: posterior kortikal atrofi (görsel-uzamsal dominant), logopenik primer progresif afazi (dil dominant).

6. Tanı

6.1 Birleşik tanı ölçütleri

A. Major NCD kriterleri (≥ 1 kognitif alanda belirgin düşüş + günlük işlev bozukluğu).

B. Klinik karakteristik Alzheimer ile uyumlu (kademeli, sürekli düşüş, bellek temel).

C. Probable AD — genetik mutasyon ve/veya 3 element (bellek + 1+ bilişsel alan, sürekli düşüş, başka neden yok).

D. Possible AD — kriterler tam karşılamıyor, ancak atipik klinik veya komorbidite.

6.2 Kaynaklar arasındaki farklar

- NIA-AA Research Framework (Jack C.R. 2018) — biyobelirteç temelli tanı (ATN — amiloid, tau, nörodejenerasyon).
- NICE NG97 — klinik tanıya dayalı; biyobelirteçler seçici.
- AAN — diagnostik araçlar.

6.3 Tanı algoritması

1. Klinik görüşme + informant.
2. MoCA, MMSE, ACE-III.
3. Nöropsikolojik battery.
4. Laboratuvar — B12, folat, TSH, karaciğer, böbrek, glukoz, HIV/sifiliz (tıbbi neden dışlaması).
5. Beyin MRG (atrofi, vasküler değişiklikler, diğer patoloji).
6. Biyobelirteçler (seçici, klinik şüphede):
    - CSF amiloid-β42 (düşük), tau (yüksek);
    - Amyloid PET, tau PET;
    - Kan biyobelirteçleri (p-tau217, GFAP) — yeni gelişmekte.
7. Komorbid depresyon taraması (GDS).

6.4 Ayırıcı tanı

Durum	Ayırt edici
Vasküler demans (6D81)	Basamaklı (stepwise) bilişsel düşüş, fokal nörolojik bulgular, vasküler MRG.
Lewy cisimcikleri (6D82)	Görsel halüsinasyonlar, parkinsonizm, REM uyku davranış bozukluğu.
Frontotemporal (6D83)	Kişilik/davranış veya dil baskın; daha erken başlangıç.
Delirium (6D70)	Akut, dalgalanan dikkat.
Depresif psödodemans	Afektif, antidepresanla düzelme.
Normal basınçlı hidrosefali (NPH)	Klasik triad (yürüyüş bozukluğu, üriner inkontinans, kognitif gerileme).
Tibbi (B12, tireoid, neyrosifilis, HIV)	Laboratuvar.

7. Muayene ve değerlendirme

- MoCA, MMSE, ACE-III, nöropsikolojik.
- Laboratuvar paneli.
- MRG, biyobelirteçler.
- BPSD ölçekleri (NPI — Neuropsychiatric Inventory).

8. Tedavi

8.1 Genel Prensipler (NICE NG97 · AAN · APA)

1. AChEI (donepezil, galantamin, rivastigmin) — hafif-orta Alzheimer için; bilişsel düşüşü mütevazı şekilde yavaşlatır. Donepezil 5–10 mg (sonra 23 mg), rivastigmin bandı.
2. Memantin (NMDA antagonisti) — orta-ağır Alzheimer için; AChEI ile kombinasyon.
3. Anti-amiloid antikorlar (lekanemab, donanemab) — erken semptomatik AD için FDA onayı (lekanemab 2023, donanemab 2024); klinik düşüş hızını ~%25 azaltır; ARIA (Amyloid-Related Imaging Abnormalities — ödem, mikro beyin kanaması) riski yüksek (özellikle ApoE4 homozigotlarda); MRG takibi önemli; infüzyon. Klinik fayda tartışmalıdır.
4. BPSD yönetimi:

- Birinci sıra — farmakolojik olmayan (çevre, sosyal destek, fiziksel aktivite, müzik terapisi);
- Refrakter durumda — atipik antipsikotik (risperidon, ketiapin) düşük dozda, kısa süreli; FDA black box — yaşlı demans hastalarında antipsikotik mortaliteyi (stroke, kardiyovasküler) artırır.
- SSRI — komorbid depresyon/anksiyete;
- Trazodon — uyku bozukluğu;
- Benzodiazepin — kontrendikedir (düşme, kognitif bozulma).

5. Bakıcı desteği ve psikoeğitim — kritik bileşen.
6. Yaşam tarzı — fiziksel aktivite, bilişsel uyarım, sosyal bağlantılar.
7. İleri yönergeler (advance directives) — bakım ve karar verme planlaması.

8.2 Tedavi metodolojileri

1. Asetilkolinesteraz İnhibitörleri (AChEI — Acetylcholinesterase Inhibitors) — Donepezil, Galantamin, Rivastigmin — Asetilkolinesterazı inhibe eder; sinaptik asetilkolin artışı. NICE NG97.
2. Memantin — NMDA antagonisti; eksitotoksisiteyi azaltır.
3. Lekanemab, Donanemab — Anti-amiloid monoklonal antikorlar; erken AD için; ARIA izlemi.
4. BPSD için Non-Farmakolojik — Validation therapy, müzik terapisi, reminiscence therapy, ABC analizi.
5. FINGER Çok Modlu Müdahalesi (FINGER — Finnish Geriatric Intervention Study) — Profilaksi için.
6. Bakıcı Desteği (Carer Support) — Psikoeğitim, soluklanma, hukuki-mali planlama.

8.3 Kaynaklar arasındaki farklar

- NICE NG97 (2018) — AChEI hafif-orta; memantin orta-ağır; kombinasyon seçici.
- Livingston G. ve ark. Lancet Komisyonu 2024 — 14 değiştirilebilir risk faktörü.
- FDA Lekanemab 2023, Donanemab 2024 — erken AD için; ARIA izlemi.
- APA — yaşlılarda antipsikotik kullanım kuralları.

9. Prognoz

- Tanı sonrası ortalama beklenen yaşam süresi 8–10 yıl.

- Hızlı gidiş, aile öyküsü, ApoE4 ile değişir.
- Komorbid kardiyovaskulyar mortalite.

10. Mit ve yanlış inançlar

Mit 1: “Alzheimer normal yaşlanmadır”

Kanıt: Alzheimer bir hastalıktır; normal yaşlanma bilişsel düşüş olmadan geçebilir; demans vakalarının %45'e kadarı modifiye edilebilir faktörlerle ilişkilidir (Lancet Commission 2024).

Mit 2: “Demans kaçınılmazdır, profilaksi mümkün değildir”

Kanıt: Lancet Commission 2024 — modifiye edilebilir faktörlerin yönetimi potansiyel demans vakalarının %45'ine kadarını geciktirebilir.

Mit 3: “Lekanemab Alzheimer'ı iyileştirir”

Kanıt: klinik düşüş hızını ~%25 azaltır (hafif etki); ARIA ve infüzyon riskleri anlamlıdır; “tedavi” değildir.

Mit 4: “Antipsikotik yaşlı demans hastaları için güvenlidir”

Kanıt: FDA black box — antipsikotik yaşlı demans hastalarında mortaliteyi artırır (stroke, kardiyovasküler); yalnızca şiddetli ajitasyon/psikoz için, kısa süreli.

Mit 5: “Ginkgo biloba demans profilaksisidir”

Kanıt: Cochrane (Birks J. 2009) — ginkgo demans için kanıtlanmış etki göstermez.

Mit 6: “Hindistan cevizi yağı (coconut oil) Alzheimer'ı iyileştirir”

Kanıt: klinik kanıt yoktur; popüler medyada propagandadır, klinik öneri değildir.

Mit 7: “Hastaya demans tanısını söylemek gerekmez”

Kanıt: NICE — hasta tanı hakkına sahiptir; erken karar verme, ileri yönergeler önemlidir.

11. Kaynaklar

1. WHO. ICD-11. 6D80 Dementia due to Alzheimer disease. 2024.
2. APA. DSM-5-TR. 2022.
3. NICE NG97. Dementia: assessment, management and support. 2018.
4. Livingston G. et al. Dementia prevention, intervention, and care: 2024 report of the Lancet standing Commission. Lancet 2024;404(10452):572–628.

5. Jack C.R. ve ark. NIA-AA Research Framework: Toward a biological definition of Alzheimer's disease. Alzheimer's Dement 2018;14(4):535–562.
6. van Dyck C.H. et al. Lecanemab in Early Alzheimer's Disease. NEJM 2023;388(1):9–21.
7. Sims J.R. et al. Donanemab in Early Symptomatic Alzheimer Disease (TRAILBLAZER-ALZ 2). JAMA 2023;330(6):512–527.
8. FDA Black Box Warning — antipsychotics in elderly with dementia. 2005.
9. Birks J. Ginkgo biloba for cognitive impairment and dementia. Cochrane Database Syst Rev 2009;(1):CD003120.

ICD-11 **6D81**	**6D81** **SEREBROVASKÜLER HASTALIK NEDENLİ DEMANS** **Dementia due to cerebrovascular disease**
ICD-10 F01	Vasküler bunama
DSM-5-TR F01.5x	Ağır Vasküler Nörobilişsel Bozukluk

1. Tanım ve nozoloji

Serebrovasküler hastalık nedenli demans (ICD-11: 6D81; DSM-5-TR: F01.5x ve benzeri) — beyin damar hastalığı (inme, küçük damar bozukluğu, hipoperfüzyon) sonucu gelişen kognitif düşüş ve günlük işlev bozukluğu. Demans nedenleri arasında ikinci sıradadır (~%15–20).

2. Tarihçe

- Binswanger O. (1894) — subkortikal vasküler demansın klasik tanımı.
- NINDS-AIREN (1993) — uluslararası tanı kriterleri.
- VASCOG (2014) — güncellenmiş konsensus (Vasküler Bilişsel Bozukluklar).

3. Epidemiyoloji

- Demans vakalarının %15–20'si; çoğu vakada Alzheimer ile karışık.
- Yaşa göre yaygınlık artar.
- Risk faktörleri: hipertansiyon, diyabet, hiperlipidemi, atriyal fibrilasyon, sigara, inme öyküsü.

4. Etiyoloji ve patogenez

- Büyük damar inmesi (multi-infarkt demans).
- Küçük damar hastalığı (subkortikal lökoaraiyozis, laküner enfarktlar — Binswanger).
- Strategik infarkt (talamik, hippokampal).
- Hipoperfüzyon (sistemik hipotansiyon, kardiyak arest).
- CADASIL (autosomal dominant subkortikal demans, NOTCH3).

5. Klinik özellikler

- “Stepwise” iniş (Alzheimer'ın kademeli inişinden farklı olarak).
- Yürütücü işlev, işlem hızı, dikkat baskın — bellek nispeten az bozulur (Alzheimer'dan farklı).
- Fokal nörolojik bulgular — hemiparezi, dizartri, ekstrapiramidal, görsel alan defekti.
- Duygudurum bozuklukları (vasküler depresyon), apati, abuli sıkça.
- Postür bozuklukları (yürüyüş, denge).

6. Tanı

6.1 Birleşik tanı ölçütleri (NINDS-AIREN, VASCOG)

A. Major NCD kriterlerine ulaşma.

B. Klinik özellikler vasküler etiyoloji ile uyumlu: ya (1) basamaklı düşüş + inme öyküsü veya (2) yürütücü işlev ve işlem hızı dominant.

C. Beyin görüntülemesinde vasküler patoloji kanıtı — enfarktlar, lökoaraiyozis, mikrokanama.

D. Bilişsel gerileme ile vasküler olay arasında zamansal bağlantı (Probable VaD).

6.2 Kaynaklar arasındaki farklar

- VASCOG 2014 (Sachdev P. et al. Alzheimer Dis Assoc Disord) — Vasküler Bilişsel Bozukluk şemsiye terimi.
- NICE NG97 — vasküler risk faktörü yönetimi.

6.3 Tanı algoritması

1. Klinik görüşme + informant.
2. MoCA (yürütücü işlev alt ölçeklerine dikkat).
3. Nörolojik muayene — fokal bulgular.
4. Beyin MRG (FLAIR — lökoaraiyozis, DWI — akut enfarktlar, T2/SWI — mikrokanama).
5. Kardiyovasküler değerlendirme — kan basıncı, EKG (atriyal fibrilasyon), Holter, karotis USG, eko.
6. Laboratuvar — HbA1c, lipid, koagülasyon, hiperhomosisteinemi.

6.4 Ayırıcı tanı

Durum	Ayırt edici
Alzheimer (6D80)	Kademeli, bellek dominant.
Karışık demans (Alzheimer + VaD)	Çoğu durumda; klinik birlikte.
Lewy cisimcikleri (6D82)	Görsel halüsinasyonlar, parkinsonizm.
Frontotemporal (6D83)	Kişilik/davranış baskın.
Normal basınçlı hidrosefali	Triad (yürüyüş bozukluğu, üriner inkontinans, kognitif gerileme).
Depresif psödodemans	Afektif, antidepresanla düzelme.

7. Muayene ve değerlendirme

- MoCA, nöropsikolojik.
- MRT, kardiyovaskulyar.
- Laboratuvar paneli.

8. Tedavi

1. Vasküler risk faktörü yönetimi — birinci basamak:
    - Hipertansiyon (hedef SBP < 140, bazen < 130);

- Diyabet HbA1c yönetimi;
- Statin (lipid);
- Antiplatelet (aspirin) veya antikoagülan (atriyal fibrilasyon — DOAK);
- Sigara bırakma;
- Fiziksel aktivite, diyet.

2. AChEI ve memantin — VaD için kanıt temeli sınırlıdır, ancak karışık demansta etkili olabilir; NICE NG97 — karışık durumda değerlendirilir.
3. BPSD yönetimi — non-farmakolojik birinci; antipsikotik sınırlı (Alzheimer için aynı FDA black box).
4. Depresyon (vasküler depresyon) — SSRI.
5. Rehabilitasyon inme sonrası — fizyo, uğraşı, dil terapisi.

8.1 Tedavi metodolojileri

1. Vasküler Risk Yönetimi — Hipertansiyon, diyabet, lipid, atriyal fibrilasyon, sigara.
2. AChEI/Memantin Karışık Demansta — Donepezil, rivastigmin off-label saf VaD'da; karışık durumda düşünülebilir.
3. İnme Rehabilitasyonu (Stroke Rehabilitation) — Multidisipliner.

8.2 Kaynaklar arasındaki farklar

- NICE NG97 — vasküler risk yönetimi.
- AHA/ASA inme profilaksisi.

9. Prognoz

- Risk faktörü yönetimi düşüş hızını azaltır.
- İnme öyküsü ve komorbidite prognozu belirler.

10. Mit ve yanlış inançlar

Mit 1: “Vasküler Demans Alzheimer'dan tamamen farklıdır”

Kanıt: Çoğu demans vakasında karışık patoloji (Alzheimer + VaD); klinik ayırım bazen zordur.

Mit 2: “VaD için spesifik tedavi yoktur”

Kanıt: vasküler risk faktörü yönetimi — birinci sıra ve güçlü müdahaledir; profilaksi özellikle güçlü.

Mit 3: "Aspirin demans profilaksisi içindir"

Kanıt: ASPREE trial (McNeil J.J. NEJM 2018) — aspirinin birincil profilaksi (primary prophylaxis) olarak demans profilaksisinde kanıt göstermemiştir; yalnızca spesifik stroke profilaksi endikasyonlarında.

Mit 4: "Vitaminler ve homosistein vasküler demans profilaksisidir"

Kanıt: homosistein azaltıcı vitaminlerin kognitif profilaksisi kanıtı zayıf.

Mit 5: "Stepwise iniş VaD tanısı için zorunludur"

Kanıt: Küçük damar VaD'da kademeli düşüş tipiktir; stepwise yalnızca multi-infarkt formda.

11. Kaynaklar

1. WHO. ICD-11. 6D81 Vascular dementia. 2024.
2. APA. DSM-5-TR. 2022.
3. NICE NG97. 2018.
4. Sachdev P. et al. Diagnostic criteria for vascular cognitive disorders: a VASCOG statement. Alzheimer Dis Assoc Disord 2014;28(3):206–218.
5. McNeil J.J. et al. Effect of Aspirin on Disability-free Survival in the Healthy Elderly (ASPREE). NEJM 2018;379(16):1499–1508.
6. Livingston G. et al. Lancet Commission 2024.

ICD-11 **6D82**	**6D82 LEWY CİSİMCİĞİ HASTALIĞI NEDENLİ DEMANS (DLB)** **Dementia due to Lewy body disease**
ICD-10 F02.8	Bunama, diğer tanımlanmış, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda
DSM-5-TR G31.83 + F02.8x	Lewy Cisimciği Olan Yeğin Nörobilişsel Bozukluk

1. Tanım ve nozoloji

Lewy cisimciği hastalığı nedenli demans (DLB; ICD-11: 6D82; DSM-5-TR: G31.83 + F02.8x) — α-sinüklein patolojisi sonucu gelişen demans; klasik üçlü — bilişsel dalgalanma, görsel halüsinasyonlar, parkinsonizm. Demansların %5-15'i.

Parkinson hastalığı demansı (PDD) — aynı patoloji, ancak demans parkinsonizmden en az 1 yıl sonra gelişir; DLB ve PDD klinik spektrum.

2. Tarihçe

- Lewy F. (1912) — Parkinson hastalığında Lewy cisimciklerinin tanımı.
- McKeith I. (1996, 2017 güncellemesi) — DLB konsensus kriterleri.

3. Epidemiyoloji

- Demans vakalarının %5–15'i; erkeklerde nispeten yüksek.
- Yaş 65+ yaygınlık artar.
- Komorbidite: depresyon, sanrılar, REM uykusu davranış bozukluğu.

4. Etiyoloji ve patogenez

- α-Sinüklein agregasyonu — Lewy cisimcikleri kortikal ve substantia nigra'da.
- SNCA, LRRK2, GBA genleri risk.

5. Klinik özellikler

Dört temel klinik özellik (McKeith 2017)

- Bilişsel dalgalanma — dikkat ve uyanıklıkta belirgin değişkenlik (saatler-günler).
- Yinelenen görsel halüsinasyonlar — tam oluşmuş, ayrıntılı (insan, hayvan imgeleri); hasta bunlara nispeten toleranslı olabilir.
- REM uykusu davranış bozukluğu (RBD) — bilişsel düşüşten yıllar önce başlayabilir.
- Parkinsonizm — bradikinezi, istirahat tremoru veya rijidite kardinal bulgularından biri ya da daha fazlası (tremor Parkinson hastalığındakinden tipik olarak daha hafiftir).

İndikatif biyobelirteçler

- DAT-SPECT/PET (123I-FP-CIT) — bazal ganglionlarda presinaptik dopamin taşıyıcı tutulumunda azalma.
- 123I-MIBG miyokard sintigrafisi — patolojik (düşük) tutulum.
- Polisomnografi — atonisiz REM uykusunun doğrulanması.

Destekleyici klinik özellikler

- Antipsikotiklere ağır duyarlılık — nöroleptik malign sendrom benzeri reaksiyon (tanı algoritmasına dahil değildir).
- Postural instabilite, yinelenen düşmeler, senkop, ağır otonom disfonksiyon, hipersomni, hiposmi, sistematize sanrılar, apati, anksiyete, depresyon.

6. Tanı

6.1 Birleşik tanı ölçütleri (McKeith 2017)

Probable DLB: 2+ temel klinik özellik (indikatif biyobelirteçten bağımsız olarak), veya 1 temel özellik + 1 ya da daha fazla indikatif biyobelirteç. Yalnızca biyobelirteçlere dayanarak konulamaz.

Possible DLB: indikatif biyobelirteç olmaksızın yalnızca 1 temel klinik özellik; veya temel klinik özellik olmaksızın 1 ya da daha fazla indikatif biyobelirteç.

6.2 Kaynaklar arasındaki farklar

- McKeith I. et al. Neurology 2017 — tanısal konsensus.
- DAT-SPECT veya 123I-MIBG kardiyak sintigrafi — indikatif biyobelirteçlerdir (destekleyici değil).

6.3 Tanı algoritması

1. Klinik görüşme + informant (özellikle RBD).
2. MoCA, MMSE, nöropsikolojik (görsel-mekansal ve yürütücü işlev dominant).
3. Nörolojik muayene.
4. Beyin MRG (Alzheimer'a kıyasla daha az hipokampal atrofi).
5. DAT-SPECT (endike olduğunda).
6. Polisomnografi — RBD doğrulaması.

6.4 Ayırıcı tanı

Durum	Ayırt edici
Alzheimer (6D80)	Bellek dominant, görsel halüsinasyon az.
Parkinson hastalığı demansı (PDD)	Demans, parkinsonizmden ≥ 1 yıl sonra (1 yıl kuralı).
Vasküler (6D81)	İnme öyküsü, MRG.
Delirium (6D70)	Akut başlangıç; dalgalanma benzerdir.
Şizofreni geç başlangıçlı	Demans yok.

7. Muayene ve değerlendirme

- MoCA, nöropsikolojik.
- Polisomnografi (RBD).
- DAT-SPECT.
- Beyin MRG.

8. Tedavi

1. AChEI (rivastigmin, donepezil) — DLB'de özellikle etkili (kortikal asetilkolin azalması Alzheimer'dan daha güçlüdür); rivastigmin McKeith I. Lancet 2000 RKÇ.
2. Memantin — orta-ağır vakada.
3. Parkinsonizm — levodopa dikkatle; psikotik semptomları şiddetlendirebilir.
4. Görsel halüsinasyonlar için: farmakolojik olmayan birinci. Refrakter olguda ketiapin veya klozapin düşük dozda; tipik antipsikotikler (haloperidol) ve risperidon kontrendike — ağır nöroleptik duyarlılık reaksiyonu.
5. RBD — melatonin (3–12 mg gece) veya klonazepam (düşük doz).
6. BPSD farmakolojik olmayan birinci.
7. FDA antipsikotik black box yaşlı demans hastalarında.

8.1 Tedavi metodolojileri

1. Rivastigmin AChEI — DLB'de özellikle etkili; bant ve oral.
2. Ketiapin/Klozapin (refrakter psikoz) — Düşük doz; klozapin en güvenli ancak izlem gerektirir.
3. Melatonin RBD için — 3–12 mg gece.

4. DAT-SPECT — İndikatif tanısal biyobelirteç.

8.2 Kaynaklar arasındaki farklar

- McKeith I. Lancet 2000 — rivastigmin DLB'de.
- NICE NG97 — DLB için rivastigmin veya donepezil.
- Antipsikotik duyarlılığı — McKeith I. derlemeleri.

9. Prognoz

- Ortalama beklenen yaşam süresi tanıdan 5–8 yıl; Alzheimer'dan bazen daha kısa.
- Antipsikotik reaksiyonu kritik komplikasyon.

10. Mit ve yanlış inançlar

Mit 1: "DLB yalnızca Alzheimer'in alt tipidir"

Kanıt: ayrı bir patolojik ve klinik birimdir; α-sinüklein vs amiloid-β/tau; antipsikotik duyarlılığı kritik farktır.

Mit 2: "Haloperidol DLB'de güvenlidir"

Kanıt: Haloperidol ve risperidon kontrendikedir — nöroleptik malign sendrom-benzeri reaksiyon, mortalite riski yüksek.

Mit 3: "Görsel halüsinasyonlar her zaman tedavi gerektirir"

Kanıt: bazı hasta halüsinasyona toleranslıdır; distress yaratmıyorsa farklı yaklaşım.

Mit 4: "Levodopa DLB'de parkinsonizmi tamamen iyileştirir"

Kanıt: levodopa yanıtı Parkinson hastalığından az; psikotik semptomları güçlendirebilir; denge gereklidir.

Mit 5: "RBD önemsiz bir semptomdur"

Kanıt: RBD α-sinüklein hastalığının (DLB, Parkinson, MSA) prodromudur — gelecekte gelişim %80+ 10-15 yılda.

11. Kaynaklar

1. WHO. ICD-11. 6D82 Dementia due to Lewy body disease. 2024.
2. APA. DSM-5-TR. 2022.

3. McKeith I.G. et al. Diagnosis and management of dementia with Lewy bodies: Fourth consensus report. Neurology 2017;89(1):88–100.
4. McKeith I. et al. Efficacy of rivastigmine in dementia with Lewy bodies: a randomised, double-blind, placebo-controlled international study. Lancet 2000;356(9247):2031–2036.
5. NICE NG97. 2018.

ICD-11 **6D83**	**6D83** **FRONTOTEMPORAL DEMANS (FTD)** **Frontotemporal dementia**
ICD-10 F02.0	Bunama, Pick hastalığında
DSM-5-TR G31.09 + F02.8x	Frontotemporal Lob Yozlaşmasına Bağlı Yeğin Nörobilişsel Bozukluk

1. Tanım ve nozoloji

Frontotemporal Demans (FTD; ICD-11: 6D83; DSM-5-TR: G31.09 + F02.8x) — frontal ve/veya temporal lobların atrofisi sonucu gelişen demans; tipik 45–65 yaş arası başlangıç (erken başlayan demansların en sık görüleni). Üç klinik varyant: bvFTD (davranış varyantı) ve iki PPA formu (Primer Progresif Afazi — semantik ve non-fluent).

2. Tarihçe

- Pick A. (1892) — “Pick hastalığı” — frontotemporal atrofi tanımı.
- Neary D. et al. (1998) — FTD klinik konsensus kriterleri.
- Rascovsky K. ve ark. (2011) — bvFTD güncellenmiş kriterler.

3. Epidemiyoloji

- 65 yaşa kadar demans vakalarının %5–10'u; 65 yaş sonrası Alzheimer dominant.
- Cinsiyet: eşit.
- Aile öyküsü %40’tan fazla.

- Komorbidite: ALS (Amyotrofik Lateral Skleroz) — FTD-ALS spektrumu (C9orf72 mutasyonu).

4. Etiyoloji ve patogenez

- Genetik (%40) — C9orf72 (en sık), MAPT, GRN mutasyonları.
- Patolojik — tau (Pick cisimciği, MAPT), TDP-43 (TDP-43A, B, C, D, GRN, C9orf72), FUS proteinleri.

5. Klinik özellikler

bvFTD (Davranış Varyantı, ~%60 FTD)

- Erken kişilik değişikliği — apati, dezhibisyon, sosyal uygun olmayan davranış, empati kaybı.
- Tipik davranış (ritüalistik).
- Hiperoral davranış (beslenme değişikliği, "sweet tooth").
- Yürütücü işlev önemli ölçüde bozulur; bellek ve görsel-uzamsal başlangıçta nispeten korunur.

PPA — Primary Progressive Aphasia

- Non-fluent variant (nfvPPA) — dilbilgisi güçlüğü, yavaş konuşma, apraksi of speech.
- Semantic variant (svPPA) — sözcük anlamı kaybı, agnozi; akıcı ancak boş konuşma.
- Logopenik — Alzheimer ile ilişkili, ayrı.

6. Tanı

6.1 Birleşik tanı ölçütleri (Rascovsky 2011 bvFTD; Gorno-Tempini 2011 PPA)

bvFTD (Probable): 6 davranış semptomundan ≥ 3 (dezhibisyon, apati, empati kaybı, stereotipik, hiperoral, yürütücü) + işlevsel bozulma + nörogörüntüleme desteği.

PPA: dil temel defisit; klinik ve nörogörüntüleme temelinde alt-varyant.

6.2 Kaynaklar arasındaki farklar

- Rascovsky K. ve ark. Brain 2011 — bvFTD.
- Gorno-Tempini M.L. ve ark. Neurology 2011 — PPA.

6.3 Tanı algoritması

1. Klinik görüşme + bilgi veren (davranış değişikliği).
2. Nöropsikolojik batarya (yürütücü işlev, dil).
3. Beyin MRG — frontal ve/veya temporal atrofi.
4. FDG-PET — hipometabolizma.
5. Genetik test (aile öyküsü).
6. ALS taraması (klinik veya elektromiyografi).

6.4 Ayırıcı tanı

Durum	**Ayırt edici**
Alzheimer (6D80)	Bellek dominant, geç başlangıç.
Şizofreni geç başlangıçlı	Atrofi yok.
Mania, depresyon	Afektif epizodlar.
Bipolar bozukluk	Afektif siklik.
Kişilik bozukluğu	Sürekli, uzun süreli; FTD'de değişiklik yenidir.
Beyin tümörü	MRT.

7. Muayene ve değerlendirme

- FAB (Frontal Assessment Battery), nöropsikolojik.
- MRT, FDG-PET.
- Genetik test.
- ALS taraması.

8. Tedavi

1. Spesifik hastalık-modifikatör ilacı yoktur — patohistolojik sürece yönelik tedavi henüz onaylanmamıştır (klinik çalışmalar devam etmektedir).
2. AChEI — FTD'de etkisiz veya zararlıdır (davranışı kötüleştirebilir); Alzheimer'dan farklı.
3. SSRI — bvFTD'de davranış semptomları (dezhibisyon, kompulsivite, depresyon) için; bazı kanıt.
4. Trazodon — ajitasyon için; Lebert F. et al. çalışmaları.

5. Atipik antipsikotik — yalnız ağır davranış bozukluğunda, kısa süreli, FDA black box kuralı.
6. Bakıcı desteği ve psikoeğitim kritik (davranışsal belirtiler aile için zordur).
7. Nutrisyonel destek (hiperoral davranışta kontrol).
8. Hukuki-mali planlama.

8.1 Tedavi metodolojileri

1. SSRI bvFTD için — Sitalopram, sertralin — davranışsal semptomlar.
2. Trazodon — Ajitasyon, uyku.
3. Farmakolojik Olmayan — Çevre modifikasyonu, yapı, bakıcı eğitimi.
4. Konuşma-Dil Terapisi (SLT — Speech-Language Therapy) — PPA için; kompansatuar stratejiler.
5. Genetik Konsültasyon — Aile üyeleri için.

8.2 Kaynaklar arasındaki farklar

- NICE NG97 — FTD için AChEI önermez.
- Lebert F. et al. Dement Geriatr Cogn Disord 2004 — trazodon.

9. Prognoz

- Tanı sonrası ortalama beklenen yaşam süresi 6–11 yıl; FTD-ALS daha kısa (3 yıl).
- Bazı mutasyonlarda hızlı düşüş.

10. Mit ve yanlış inançlar

Mit 1: “FTD Alzheimer'in alt tipidir”

Kanıt: ayrı bir patolojik ve klinik birimdir; tau, TDP-43, FUS patolojileri; AChEI etkisizdir.

Mit 2: “AChEI tüm demanslarda kullanılabilir”

Kanıt: FTD'de AChEI etkisiz veya zararlı; NICE NG97 önermiyor.

Mit 3: “Davranış değişikliği yalnızca psikiyatrik sorundur”

Kanıt: erken başlayan davranış değişikliği (45–65 yaş) FTD için şüphe uyandırmalıdır; nörogörüntüleme önemli.

Mit 4: “Aile öyküsü yoksa FTD genetik değildir”

Kanıt: %40 vakada aile öyküsü; sporadik de mümkün; C9orf72 ekspansiyonu gizli olabilir.

Mit 5: “FTD hastasının davranışı iradidir”

Kanıt: davranış değişikliği nörobiyolojik — frontal lob disfonksiyonu; iradi kontrol bozulmuş.

11. Kaynaklar

1. WHO. ICD-11. 6D83 Dementia due to frontotemporal lobar degeneration. 2024.
2. APA. DSM-5-TR. 2022.
3. Rascovsky K. ve ark. Sensitivity of revised diagnostic criteria for the behavioural variant of frontotemporal dementia. Brain 2011;134(Pt 9):2456–2477.
4. Gorno-Tempini M.L. et al. Classification of primary progressive aphasia and its variants. Neurology 2011;76(11):1006–1014.
5. NICE NG97. 2018.
6. Lebert F. et al. Frontotemporal dementia: a randomised, controlled trial with trazodone. Dement Geriatr Cogn Disord 2004;17(4):355–359.

6E20–6E2Z PERİNATAL BOZUKLUKLAR

Mental or behavioural disorders associated with pregnancy, childbirth or the puerperium

ICD-11 **6E20**	**6E20 GEBELİK, DOĞUM VEYA LOHUSALIK İLE İLİŞKİLİ RUHSAL VEYA DAVRANIŞSAL BOZUKLUKLAR, PSİKOTİK BELİRTİSİZ** **Mental or behavioural disorders associated with pregnancy, childbirth or the puerperium, without psychotic symptoms**
ICD-10 F53.0	Puerperium İle İlişkili Hafif Mental Ve Davranışsal Bozukluklar, Başka Yerde Sınıflanmamış
DSM-5-TR —	"Peripartum başlangıçlı" belirleyicisi (DSM-5-TR'de ayrı kategori yoktur)

1. Tanım ve nozoloji

Postnatal Depresyon (ICD-11: 6E20 Mental and Behavioural Disorders Associated with Pregnancy, Childbirth or the Puerperium; DSM-5-TR: F32.x / F33.x Major Depressive Disorder with peripartum onset specifier) — doğumdan sonra (tipik ilk 6 ay; bazı kılavuzlarda 1 yıl) gelişen major depresif epizod. Kadınların %10–15'ini etkiler.

2. Tarihçe

- Marcé L.V. (1858) — postpartum psikoz ve depresyonun ilk klinik tanımı.
- EPDS — Cox J.L. ve ark. (1987) — Edinburgh Postnatal Depression Scale.
- NICE CG192 (2014, 2018) — antenatal ve postnatal ruh sağlığı.

- FDA — brexanolone (2019), zuranolone (2023) — postpartum depresyon için ilk özel onaylı preparatlar.

3. Epidemiyoloji

- Yaygınlık: %10–15 (yüksek gelirli ülkeler), %20–30 (düşük ve orta gelirli ülkelerde).
- "Baby blues" — daha hafif, kısa süreli (1–2 hafta) — kadınların %50–80'inde; klinik müdahale gerektirmez.
- Komorbidite: anksiyete, OKB, panik.
- Risk faktörleri: önceki depresyon, aile öyküsü, gebelikte depresyon, partner desteği yokluğu, sosyo-ekonomik stres.

4. Etiyoloji ve patogenez

- Hormonal — östrojen ve progesteronun doğum sonrası ani düşüşü; allopregnanolon disregülasyonu.
- Uyku bozukluğu yenidoğan bakımı ile.
- Psikososyal stres, ilişkiler, sosyal destek.
- Genetik ve önceki afektif bozukluk öyküsü.

5. Klinik özellikler

- Major depresif epizod semptomları (uyku bozukluğu, iştahsızlık, anhedoni, değersizlik, intihar düşünceleri).
- Spesifik özellikler: bebeğe karşı afektif mesafe, çocuk bağlanmasında zorluk, anne rolünün üstesinden gelemeyeceğine inanç, bebeğe zarar verme hakkında intrusif düşünceler (ego-distonik — OKB benzeri; postnatal psikozdan farklı).
- İntihar riski ve nadiren infanticide (postnatal psikozda daha yüksek).

6. Tanı

6.1 Birleşik tanı ölçütleri

Major depresif epizod kriterleri (DSM-5-TR 5+ semptom 2 hafta; ICD-11) + peripartum başlangıç belirleyicisi (DSM-5-TR — gebelik veya doğumdan 4 hafta içinde; ICD-11 — daha geniş, 6 ay-1 yıla kadar).

6.2 Kaynaklar arasındaki farklar

- NICE CG192 (2014, 2018) — tanı ve tedavi.

- ACOG Committee Opinion 757 (2018) — perinatal depresyon taraması.
- USPSTF — gebe ve postpartum kadınlarda tarama.

6.3 Tanı algoritması

1. EPDS (Edinburgh Postnatal Depression Scale, 10 madde) — altın standart tarama; cut-off ≥ 10 — olası depresyon (duyarlı tarama eşiği), ≥ 13 — muhtemel major depresyon.
2. Klinik görüşme (hastaneye yatış ve intihar riski değerlendirmesi).
3. Postnatal psikoz farkı — psikotik semptomlar varsa acil hastaneye yatış.
4. Tıbbi değerlendirme — tiroid (postpartum tiroidit), anemi.
5. Komorbid anksiyete, OKB taraması.

6.4 Ayırıcı tanı

Durum	Ayırt edici
"Baby blues"	≤ 2 hafta, hafif, klinik müdahale gerektirmez.
Postnatal psikoz (6E21)	Psikotik semptomlar; acil hospitalizasyon.
Bipolar depresif epizod	Manik/hipomanik epizod öyküsü.
Postpartum tireoidit	TSH.
Anemi	Hemoglobin.
Postnatal OKB	Ego-distonik intruzivler ile bebeğe zarar; postnatal depresyon komorbid.

7. Muayene ve değerlendirme

- EPDS, PHQ-9.
- C-SSRS — intihar ve bebeğe zarar riski.
- TSH, hemoglobin.

8. Tedavi

8.1 Genel Prensipler (NICE CG192 · ACOG · APA)

1. Hafif-orta: psikoterapi birinci sıra — BDT, İPT (özellikle perinatal bağlama uyarlanmış).

2. Orta-ağır: psikoterapi + SSRI. Emzirme bağlamında:
    - Sertralin (en az süte geçen) ve paroksetin — birinci basamak;
    - Fluoksetin — uzun yarılanma ömrü, dikkatle;
    - Sitalopram, essitalopram — uygun.
3. Refrakter ağır PPD
    - Brexanolone (Zulresso) — IV 60 saat infüzyon; FDA 2019 onayı; REMS programı altında klinikte denetim; hızlı etki.
    - Zuranolone (Zurzuvae) — oral 14 gün; FDA 2023 onayı; daha uygun.
4. EKT — psikotik depresyon, ağır intihar riski, besin alımı bozukluğu, gebelikte de güvenli.
5. Aile desteği, akran desteği (örn. PND yardım hattı).
6. Sosyal hizmet ve anne-çocuk bağlanma desteği.
7. Uyku hijyeni ve aile üyelerinin gece bakımına dahil edilmesi.

8.2 Tedavi metodolojileri

1. Perinatal Kişilerarası Terapi (IPT) — Stuart (Stuart S.), Robertson (Robertson M.) — Anne rolü geçişleri, partner ilişkileri, sosyal destek sistemi.
2. BDT Perinatal Uyarlanmış — Bilişsel bozukluklar, davranış aktivasyonu.
3. Brexanolone (Zulresso) — IV 60 saat; REMS programı; klinikte denetim.
4. Edinburgh Postnatal Depresyon Ölçeği (EPDS — Edinburgh Postnatal Depression Scale) — 10 maddelik öz değerlendirme.
5. EKT — Gebelikte ve emzirmede güvenli; ağır refrakter durumda.

8.3 Kaynaklar arasındaki farklar

- NICE CG192 — sertralin ve paroksetin emzirmede birinci basamak.
- Louik C. et al. NEJM 2007 · Huybrechts K.F. et al. NEJM 2014 — SSRI gebelikte kardiyak malformasyonlar (paroksetin dikkatle).
- Meltzer-Brody S. et al. Lancet 2018 — breksanolone RCT.

9. Prognoz

- Yeterli tedavi ile %70-80 remisyon.
- Sonraki gebeliklerde nüks riski (~%25).
- Tedavisiz kronikleşme ve komorbidite.

10. Mit ve yanlış inançlar

Mit 1: “PPD normal 'baby blues'dur, geçicidir”

Kanıt: baby blues ≤ 2 hafta, hafif form; PPD — klinik depresif epizod, müdahale gerektirir; uzun sürebilir.

Mit 2: “Antidepresan emzirmede tehlikelidir”

Kanıt: Sertralin ve paroksetin emzirmede kabul edilebilirdir; süte geçiş minimaldir; klinik danışmanlık.

Mit 3: “Anne zayıftır, ‘kendini düzeltmelidir’”

Kanıt: PPD klinik bir durumdur; intihar ve bebek öldürme riski mevcuttur; müdahale gerektirir.

Mit 4: “Brexanolone PPD'yi iyileştirir”

Kanıt: hızlı etki gösterir, ancak maliyet ve klinikte kontrol gereği önemlidir; standart yaklaşım SSRI + psikoterapi.

Mit 5: “PPD bebeği etkilemez”

Kanıt: PPD anne-bebek bağlanması, çocuğun bilişsel ve duygusal gelişimini etkiler; erken müdahale önemlidir.

Mit 6: “İntrüzif düşünceler (bebeğe zarar) her zaman psikoz belirtisidir”

Kanıt: postnatal OKB'de intrusif düşünceler ego-distoniktir (hasta acı çeker, kaçınma davranışı); postnatal psikozda ego-sintonik ve davranışa geçebilir — farklı müdahale.

11. Kaynaklar

1. WHO. ICD-11. 6E20 Mental and behavioural disorders associated with pregnancy, childbirth and the puerperium. 2024.
2. APA. DSM-5-TR. 2022.
3. NICE CG192. Antenatal and postnatal mental health. 2014, 2018 update.
4. ACOG Committee Opinion No. 757: Screening for Perinatal Depression. 2018.
5. Cox J.L., Holden J.M., Sagovsky R. Detection of postnatal depression. Development of the 10-item Edinburgh Postnatal Depression Scale. Br J Psychiatry 1987;150:782–786.
6. Meltzer-Brody S. et al. Brexanolone injection in post-partum depression. Lancet 2018;392(10152):1058–1070.

7. Deligiannidis K.M. et al. Effect of zuranolone vs placebo in postpartum depression. JAMA Psychiatry 2021;78(9):951–959.
8. Louik C., Lin A.E., Werler M.M., Hernández-Díaz S., Mitchell A.A. First-trimester use of selective serotonin-reuptake inhibitors and the risk of birth defects. N Engl J Med 2007;356(26):2675–2683.
9. Huybrechts K.F., Palmsten K., Avorn J. et al. Antidepressant use in pregnancy and the risk of cardiac defects. N Engl J Med 2014;370(25):2397 –2407.
10. Stuart S., Robertson M. Interpersonal Psychotherapy: A Clinician's Guide. 2nd ed. London: Hodder Arnold, 2012.

ICD-11 **6E21**	**6E21 GEBELİK, DOĞUM VEYA LOHUSALIK İLE İLİŞKİLİ RUHSAL VE DAVRANIŞSAL BOZUKLUKLAR, PSİKOTİK BELİRTİLİ** **Mental or behavioural disorders associated with pregnancy, childbirth or the puerperium, with psychotic symptoms**
ICD-10 F53.1	Puerperiumla ilişkili şiddetli mental ve davranışsal bozukluklar, başka yerde sınıflanmamış
DSM-5-TR F23	Kısa Psikotik Bozukluk, Peripartum Başlangıçlı

1. Tanım ve nozoloji

Postnatal Psikoz (PPP; ICD-11: 6E21; DSM-5-TR: peripartum onset specifier ile Brief Psychotic Disorder veya Bipolar I) — doğum sonrası (tipik ilk 2 hafta) akut başlangıçlı psikotik epizod; halüsinasyonlar, sanrılar, bilişsel dezorganizasyon, duygudurum değişkenliği. Tıbbi acil durumdur — infanticide (~%4) ve anne intihar riski yüksek.

2. Tarihçe

- Marcé L.V. (1858) — postpartum psikoz klasik tanımı.
- Bergink V. et al. (2015) — 4 basamaklı tedavi algoritması.
- NICE CG192 — peripartum psikiyatrik durumlar.

3. Epidemiyoloji

- İnsidans: 1–2/1000 doğum.
- Bipolar bozukluk öyküsü olan kadınlarda %25–50; önceki PPP öyküsünde %30.
- Komorbidite: çoğu vakada bipolar temel.
- Mortalite: infanticide %4, intihar %5'e kadar (tedavisiz).

4. Etiyoloji ve patogenez

- Hormonal — doğum sonrası östrojen ve progesteronun ani düşüşü.
- Uyku yoksunluğu.
- Bipolar bozukluk yatkınlığı (çoğu PPP — bipolar epizod tezahürü).
- Aile öyküsü.

5. Klinik özellikler

- Hızlı başlangıç (24–72 saat, tipik ilk 2 hafta).
- Polimorf psikotik semptomlar — sanrılar (özellikle bebek hakkında — bebeğin "şeytan" veya "talep edilmiş" olması; anne "kurtarmalı"), halüsinasyonlar.
- Duygudurum değişkenliği — manik veya depresif bileşenler.
- Bilişsel dezorganizasyon, karışıklık.
- Uyku bozukluğu ağır.
- Davranış — tuhaf, aşırı, bebek bakımında bozulma.
- Yüksek risk: anne intiharı, bebeğe zarar (infantisit).

6. Tanı

6.1 Birleşik tanı ölçütleri

Klinik tanı: doğum sonrası akut başlangıçlı psikotik epizod; bipolar manik veya akut psikotik kategorisinde kodlanır + peripartum başlangıç belirteci.

6.2 Kaynaklar arasındaki farklar

- NICE CG192 — acil tıbbi durum.
- RCPsych (Royal College of Psychiatrists) — perinatal psikiyatrik hizmet standartları.

6.3 Tanı algoritması

1. Klinik görüşme — hızlı başlangıç, semptom doğası.
2. Tıbbi değerlendirme — postpartum tıbbi (tiroidit, enfeksiyon, ensefalopati, eklampsi, B12 eksikliği) dışlama.
3. Laboratuvar — TSH, tam kan, elektrolitler, karaciğer, böbrek, amonyak, glukoz, enfeksiyon belirteçleri.
4. Beyin MRG ve EEG — atipik prezentasyon veya nörolojik belirtiler varsa (otoimmün ensefalit — anti-NMDA-R özellikle!).
5. Toksikoloji.
6. İntihar ve infanticide riski değerlendirmesi (C-SSRS, bebek güvenliği).

6.4 Ayırıcı tanı

Durum	**Ayırt edici**
Postnatal depresyon (6E20)	Psikotik semptom yoktur.
Postnatal OKB	Ego-distonik intruzivler; içgörü korunur.
Delirium (6D70)	Dikkat dalgalanması; tıbbi neden (enfeksiyon).
Anti-NMDA-R ensefalit	Atipik psikoz + motor semptomlar + nöbetler; BOS antikorlar; klasik sunum genç kadında!
Eklampsi/HELLP	Hipertansiyon, proteinüri, trombositopeni.
Sheehan sendromu	Hipopituitarizm (post-hemoraji).

7. Muayene ve değerlendirme

- Klinik psikiyatrik ve nörolojik.
- Yukarıdaki tıbbi panel.
- Anti-NMDA-R antikorları (BOS) — atipik durumda.
- C-SSRS, bebek güvenliği.

8. Tedavi

8.1 Genel Prensipler (NICE CG192 · Bergink 2015)

1. Acil hastane yatışı zorunludur — anne ve bebek için; mümkünse Mother-Baby Unit (anne-bebek ortak yatış hizmeti).
2. Bergink 4 basamaklı algoritma (Am J Psychiatry 2015):
    - Basamak 1: Benzodiazepin (lorazepam) akut stabilizasyon;
    - Basamak 2: Atipik antipsikotik (olanzapin, ketiapin, risperidon);
    - Basamak 3: Lityum ekle;
    - Basamak 4: EKT refrakter veya katatonik özelliklerde.
3. Bipolar çoğunlukla — lityum birinci basamak. Valproat doğurganlık çağındaki kadınlarda kontrendikedir ve yalnızca Gebelik Önleme Programı koşulları karşılandığında kullanılabilir (EMA/MHRA 2018); bipolar bozuklukta gebelikte mutlak kontrendikedir.
4. Emzirme kararı — lityum emzirmede nispi kontrendikedir (süte geçer); olanzapin ve ketiapin nispeten güvenli; hasta ve aile ile tartışma.
5. Sonraki gebeliklerde nüks riski yüksek (~%30–40) — profilaktik lityum peri-postpartum döneminde düşünülür.
6. EKT — gebelikte ve postpartum dönemde güvenli; hızlı etki.
7. Multidisipliner koordinasyon — psikiyatrist, kadın doğum uzmanı, pediatrist, sosyal hizmet uzmanı.

8.2 Tedavi metodolojileri

1. Bergink 4-Basamaklı Algoritması (Bergink) — Benzodiazepin → antipsikotik → lityum → EKT.
2. Anne-Bebek Ünitesi (MBU — Mother-Baby Unit) — Anne ve bebeğin birlikte hastaneye yatırılması; bağlanmayı koruma ve güvenlik.
3. EKT Postpartum — Gebelikte ve emzirmede güvenli; hızlı etki; katatonik özelliklerde birinci sıra.
4. Profilaktik Lityum Sonraki Gebeliklerde — Bergink V. et al. Am J Psychiatry 2012 — peri-postpartum döneminde nüks profilaksisi.

8.3 Kaynaklar arasındaki farklar

- NICE CG192 — Mother-Baby Unit önerisi.
- Bergink V. et al. Am J Psychiatry 2015 — 4 basamaklı algoritma kanıt temeli.

9. Prognoz

- Yeterli tedavi ile çoğu hastada tam iyileşme.
- Sonraki gebeliklerde nüks yüksek (~%30–40).
- Uzun süreli bipolar yönetimi önemlidir.

10. Mit ve yanlış inançlar

Mit 1: "PPP 'anne duygularının' güçlü bir ifadesidir"

Kanıt: klinik psikotik durum; bebek öldürme ve intihar riski yüksek; acil müdahale.

Mit 2: "Evde takip etmek yeterlidir"

Kanıt: NICE CG192 — hastaneye yatış zorunlu; MBU tercih edilir.

Mit 3: "Emzirme için antipsikotik ve lityum yasaktır"

Kanıt: olanzapin ve ketiapin emzirmede nispeten güvenli; lityum süte geçer, ancak çocuk izlemi ile önerilebilir; bireysel denge.

Mit 4: "Sonraki gebelikte tekrarlamayacak"

Kanıt: önceki PPP öyküsünde nüks ~%30–40 (profilaksisiz %44'e kadar); profilaktik plan önemlidir.

Mit 5: "Anti-NMDA-R ensefalit nadirdir, araştırmaya gerek yok"

Kanıt: Genç kadında atipik psikoz + motor semptomlar + nöbetler Anti-NMDA-R ensefalit klasik prezentasyonudur; antikor testi hayat kurtarır.

11. Kaynaklar

1. WHO. ICD-11. 6E21 Puerperal psychosis. 2024.
2. APA. DSM-5-TR. 2022.
3. NICE CG192. 2014/2018.
4. Bergink V. et al. Treatment of psychosis and mania in the postpartum period. Am J Psychiatry 2015;172(2):115–123.
5. Bergink V. et al. Prevention of postpartum psychosis and mania in women at high risk. Am J Psychiatry 2012;169(6):609–615.
6. Graus F. et al. Lancet Neurol 2016 (autoimmune encephalitis).

6E40 PSİKOSOMATİK FAKTÖRLER

Psychological or behavioural factors affecting disorders classified elsewhere

ICD-11 **6E40**	**6E40 BAŞKA YERDE SINIFLANDIRILMIŞ BOZUKLUKLARI VEYA HASTALIKLARI ETKİLEYEN PSİKOLOJİK VEYA DAVRANIŞSAL ETMENLER** **Psychological or behavioural factors affecting disorders or diseases classified elsewhere**
ICD-10 F54	Psikolojik Ve Davranışsal Faktörler, Başka Yerde Sınıflanmış Hastalık Veya Bozukluklarla İlişkili
DSM-5-TR F54	Diğer Sağlık Durumlarını Etkileyen Ruhsal Etkenler

1. Tanım ve nozoloji

ICD-11: 6E40 Başka yerde sınıflandırılan hastalıkları veya bozuklukları etkileyen psikolojik veya davranışsal faktörler; DSM-5-TR: F54 Diğer Tıbbi Durumları Etkileyen Psikolojik Faktörler — somatik hastalığın gidişatına müdahale eden psikolojik faktörler (depresyon, anksiyete, ilaca uyum, stres, hastalık hakkındaki inançlar).

Faktisiyöz bozukluktan (6D50) ve somatik semptom bozukluğundan (6C20) farklıdır — burada doğrulanmış tıbbi hastalık vardır, ancak psikolojik faktörler gidişatı etkiler.

2. Tarihçe

- Alexander F. (1950) — “psikosomatik tıp” kavramsallaştırması.

- Engel G.L. (1977) — “biyopsikososyal model”.
- Levenson J.L. (2018) — APA Textbook of Psychosomatic Medicine.

3. Epidemiyoloji

- Evrensel — tüm kronik somatik hastalıklarda psikolojik faktörler etki gösterir.
- Kardiyovasküler hastalıkta depresyon — %20–40; diyabet — %25; kanser — %15–25.
- Konsültasyon-liyezon psikiyatri hizmet kullanımı yaygın.

4. Etiyoloji ve patogenez

Biyopsikososyal etkileşim — biyolojik predispozisyon + psikolojik faktörler + sosyal bağlam.

5. Klinik özellikler

- Komorbid depresyon/anksiyete hastalığı etkiler (örn. miyokard enfarktüsü sonrası mortalite artışı).
- İlaca uyum bozukluğu (uyum/riayet).
- Hastalık hakkında yanlış inançlar.
- Stres ile hastalık gidişinin kötüleşmesi.
- Davranışsal faktörler (sigara, alkol, diyet, fiziksel pasiflik).

6. Tanı

6.1 Birleşik tanı ölçütleri

A. Kanıtlanmış tıbbi hastalık mevcuttur.

B. Psikolojik veya davranışsal faktörler hastalığın gidişatına müdahale eder:

1. Tedavi yanıtını azaltır;
2. Sağlık riskini artırır;
3. Patofizyolojik süreci kötüleştirir;
4. Tıbbi müdahaleye ihtiyacı değiştirir.

C. Faktisiyöz, somatik semptom, başka bir ruhsal bozuklukla daha iyi açıklanmaz.

6.2 Kaynaklar arasındaki farklar

- DSM-5-TR / ICD-11 — aynı.

- Konsültasyon-liyezon psikiyatrisi modeli.

6.3 Tanı algoritması

1. Tıbbi hastalığın değerlendirilmesi.
2. Psikolojik faktörlerin tanımlanması — depresyon (PHQ-9), anksiyete (GAD-7), ilaca uyum (Morisky).
3. Davranışsal faktörler — sigara, alkol, diyet, fiziksel aktivite.
4. Komorbid psikiyatrik bozukluk taraması.

6.4 Ayırıcı tanı

Durum	**Ayırt edici**
Somatik Belirti Bozukluğu (6C20)	Somatik şikayet dominant.
Yapay bozukluk (6D50)	Bilinçli yalan
MDD komorbid hastalığa	Afektif semptomlar bağımsız kriterleri karşılar — ayrı tanı.

7. Muayene ve değerlendirme

- PHQ-9, GAD-7, Morisky.
- Hastalık-spesifik ölçekler (DDS — Diabetes Distress Scale, Beck-cardiac).

8. Tedavi

1. Entegre multidisipliner yaklaşım — somatik uzman + psikiyatrist + psikolog.
2. Hastalık-spesifik psikososyal müdahale:
    - Kardiyak BDT (post-MI depresyon);
    - Diyabet Öz-Yönetim Eğitimi (DSME)
    - Onkolojik distress izlemi;
    - Kronik ağrı BDT ve ACT.
3. Antidepresan — hastalık-spesifik yan etki profili:
    - Kardiyak — sertralin, essitalopram;
    - Onkolojik — mirtazapin (uyku, iştah faydası);
    - Kronik ağrı — duloksetin, amitriptilin.
4. Motivasyonel görüşme — davranış değişikliği (sigara, fiziksel aktivite).

8.1 Tedavi metodolojileri

1. Konsültasyon-Liyezon Psikiyatrisi — tıbbi-cerrahi servislerde entegre hizmet.
2. Kardiyak BDT — Post-MI depresyon yönetimi.
3. Diyabetin Öz-Yönetim Eğitimi (DSME — Diabetes Self-Management Education) — Diyabet öz-yönetim eğitimi.
4. Kronik ağrı için BDT ve ACT — Williams Cochrane 2020.

8.2 Kaynaklar arasındaki farklar

- NICE CG91 — kardiyak hastalarda depresyonda BDT.
- Levenson J.L. APA Textbook of Psychosomatic Medicine 2018.

9. Prognoz

Entegre yaklaşımla hem somatik hem psikolojik sonuçlar iyileşir.

10. Mit ve yanlış inançlar

Mit 1: "Hastalık tamamen psikolojik kökenlidir"

Kanıt: "biyopsikososyal" model — psikolojik faktörler etki eder, ancak somatik hastalığı tek başına yaratmaz.

Mit 2: "Psikiyatrist hastalıktan 'kaçar'"

Kanıt: entegre yaklaşım — somatik ve psikiyatrik müdahale paralel.

Mit 3: "Alternatif tıp (yoga, mindfulness) somatik hastalığı iyileştirir"

Kanıt: komplementer müdahaleler adjunkt olarak; standart somatik tedavinin yerini almaz (onkoloji, kardiyak).

Mit 4: "Hastaya 'stres nedeniyle hastalandın' demek terapötiktir"

Kanıt: bu yaklaşım suçlayıcıdır ve terapötik ilişkiyi bozar.

11. Kaynaklar

1. WHO. ICD-11. 6E40 Psychological or behavioural factors affecting disorders or diseases classified elsewhere. 2024.
2. APA. DSM-5-TR. 2022.
3. Levenson J.L. (ed.). APA Publishing Textbook of Psychosomatic Medicine and Consultation-Liaison Psychiatry. 3rd ed. 2018.

4. NICE NG185. Acute coronary syndromes. 2020.
5. Whooley M.A., Wong J.M. Depression and cardiovascular disorders. Annu Rev Clin Psychol 2013;9:327–354.

6E60–6E6Z İKİNCİL PSİKİYATRİ

Secondary mental or behavioural syndromes

ICD-11 **6E61**	**6E61 SEKONDER PSİKOTİK SENDROM** **Secondary psychotic syndrome**
ICD-10 F06.2	Organik delüzyonel [şizofreni-benzeri] bozukluklar
DSM-5-TR F06.2	Başka Bir Sağlık Durumuna Bağlı Psikoz Bozukluğu, Sanrılarla

1. Tanım ve nozoloji

Sekonder Psikotik Sendrom (ICD-11: 6E61 Secondary Psychotic Syndrome; DSM-5-TR: F06.2/F06.0 Başka Bir Tıbbi Duruma Bağlı Psikotik Bozukluk) — başka bir tıbbi durum (otoimmün, enfeksiyöz, endokrin, metabolik, nörolojik) veya madde bağlamında gelişen psikotik epizod. Birinci basamak müdahale — temel etyolojiye yönelik tedavi.

2. Tarihçe

- "Semptomatik psikoz" terimi 20. yüzyılda oluşmuştur.
- Dalmau J. (2007) — anti-NMDA-R ensefalit keşfi; otoimmün psikoz devrimi.
- Graus F. ve ark. (2016) — otoimmün ensefalit klinik kılavuzu.

3. Epidemiyoloji

- Tüm ilk-epizod psikoz vakalarının %3–8'i sekonder etyolojilidir.
- Anti-NMDA-R ensefaliti — genç kadınlarda nadir, ancak geri dönüşümlü psikoz; teratom ile paraneoplastik.
- Hashimoto ensefalopatisi, lupus ensefalopatisi.

4. Etiyoloji ve patogenez

- Otoimmün: anti-NMDA-R, anti-LGI1, anti-CASPR2 ensefalit; Hashimoto (TPO antikorları); lupus (NPSLE).
- Enfeksiyöz: HIV, sifilis, herpes ensefaliti, COVID-19.
- Endokrin: hiper/hipotiroit, kortizol bozuklukları (Cushing, Addison), paratiroit bozuklukları (hiperkalsemi).
- Metabolik: üremi, hepatik ensefalopati, hiponatremi, hipo/hiperglisemi, B12 eksikliği, Wilson hastalığı.
- Nöroloji: beyin tümörü, inme, epilepsi (postiktal), demans.
- Madde indüksiyonlu: amfetamin, kokain, kannabis, halüsinojen, alkol yoksunluğu, steroidler.
- Paraneoplastik: over teratomu (anti-NMDA-R), küçük hücreli akciğer kanseri.

5. Klinik özellikler

- Psikotik semptomlar (sanrı, halüsinasyon, dezorganize davranış).
- Atipik özellikler (otoimmün ensefalite karakteristik):
    - Hızlı başlangıç;
    - Hareket semptomları (katatonik, distoniler, orofasiyal diskinezi);
    - Otonom bozukluk (hipertansiyon, taşikardi, hipertermi);
    - Nöbetler;
    - Bilinç bozukluğu.
- Klasik psikoz (şizofreni) ile karşılaştırıldığında — atipik prezentasyon şüphe uyandırır.

6. Tanı

6.1 Birleşik tanı ölçütleri

A. Psikotik semptomlar.

B. Tıbbi durum (otoimmün, enfeksiyöz, endokrin, metabolik, nörolojik) veya madde etkisi kanıtı.

C. Psikoz deliryum bağlamında ortaya çıkmaz (ancak deliryum ile örtüşebilir).

D. Başka bir primer psikotik bozuklukla daha iyi açıklanmaz.

6.2 Kaynaklar arasındaki farklar

- Graus F. ve ark. Lancet Neurol 2016 — otoimmün ensefalit klinik yaklaşımı.
- ICD-11 — maddeye bağlı psikoz buraya AİT DEĞİLDİR: madde bölümünde yer alır (6C40.6 alkol, 6C41.6 kannabis vb.). 6E61 yalnızca ruhsal bozukluklar bölümü dışındaki sağlık durumları içindir ve altta yatan hastalığın tanısıyla birlikte konur.

6.3 Tanı algoritması

1. Klinik şüphe — yeni psikoz, özellikle atipik özellikler veya genç kadın.
2. Tıbbi değerlendirme:
    - Tam kan sayımı, karaciğer/böbrek, elektrolitler (Na, Ca), glukoz, amonyak;
    - TSH, TPO antikorları (Hashimoto);
    - Kortizol seviyesi (Cushing/Addison);
    - HIV, sifiliz;
    - ANA, lupus paneli;
    - B12, folat, seruloplazmin (Wilson);
    - Toksikoloji tarama.
3. Beyin MRG.
4. EEG — non-konvülsif status, ensefalit.
5. Lomber ponksiyon — pleositoz, antikor paneli (anti-NMDA-R, anti-LGI1, anti-CASPR2, paraneoplastik).
6. Tümör taraması (paraneoplastik antikor pozitifliğinde — over USG, pelvik MR, toraks BT).

6.4 Ayırıcı tanı

Durum	**Ayırt edici**
Şizofreni (6A20)	Tıbbi neden yok; tipik klinik gidiş.
Akut ve geçici psikotik (6A23)	İkincil nedenler dışlanır.
Delirium (6D70)	Dikkat dalgalanması; psikoz deliryum bağlamında.
Madde indüksiyonlu psikoz	Madde tespiti ve zaman bağlantısı.
Psikotik özelliklerle birlikte demans	Bilişsel gerileme.

7. Muayene ve değerlendirme

- Yukarıdaki laboratuvar paneli.
- MRT, EEG.
- CSF antikor paneli.
- Tümör taraması.

8. Tedavi

1. Etiyolojik tedavi birinci sıra:
    - Otoimmün ensefalit — IV metilprednizolon 1 g × 5 gün → IVIG ve/veya plazmaferez; ikinci basamak rituksimab, siklofosfamid;
    - Paraneoplastik — tümörün tedavisi (over teratomu cerrahi);
    - Endokrin — tiroid, kortizol, kalsiyum düzeltmesi;
    - Enfeksiyöz — antibiyotik, antiviral;
    - Metabolik — bozukluğun düzeltilmesi;
    - İlaç indüksiyonlu — şüpheli preparatın kesilmesi.
2. Semptomatik psikiyatrik müdahale — etiyolojik tedavi sonuç verene kadar:
    - Atipik antipsikotik (ketiapin, olanzapin) — dikkatle;
    - Otoimmün ensefalit durumunda — tipik antipsikotik (haloperidol) kontrendike — NMS riski ve hastalığın güçlendirilmesi;
    - Benzodiazepin (lorazepam) — akut ajitasyon.
3. EKT — refrakter katatonik veya otoimmün ensefalite alternatif.

8.1 Tedavi metodolojileri

1. İmmünoterapi (Otoimmün Ensefalit) — IV steroidler → IVIG → plazmaferez → rituksimab/siklofosfamid.
2. Tümör Tedavisi (Paraneoplastik) — Cerrahi veya onkolojik tedavi.
3. Atipik Antipsikotik Semptomatik — Etiyolojik tedavi sonuç verene kadar; ketiapin, olanzapin üstün.
4. EKT Refrakter durumda — Katatonik veya immünoterapiye yanıtsız otoimmün ensefalitte etkili.

8.2 Kaynaklar arasındaki farklar

- Graus F. ve ark. Lancet Neurol 2016 — otoimmün ensefalit protokolleri.
- APA Textbook of Consultation-Liaison Psychiatry (Levenson).

9. Prognoz

- Etiyolojik tedaviye yanıt verir çoğu vakada; geri döndürülebilir durum.
- Anti-NMDA-R ensefaliti — %75 iyi düzelme erken immünoterapi ile.

10. Mit ve yanlış inançlar

Mit 1: "İlk-epizod psikoz her zaman şizofrenidir"

Kanıt: %3–8 ikincil etiyolojili; atipik özellikler dikkat gerektirir; tıbbi değerlendirme ilk epizod psikozda zorunludur.

Mit 2: "Tipik antipsikotik (haloperidol) her psikotik epizod için güvenlidir"

Kanıt: otoimmün ensefalit şüphesinde haloperidol ve benzeri I. kuşak antipsikotikler yasaktır — NMS riski, hastalığın güçlendirilmesi.

Mit 3: "Anti-NMDA-R ensefalit nadirdir, araştırmaya değmez"

Kanıt: Genç kadında atipik psikoz + motor semptomlar + nöbetler Anti-NMDA-R klasik prezentasyonudur; antikor testi hayat kurtarır; geri dönüşümlü durum.

Mit 4: "Tıbbi neden bulunamazsa, psikiyatrik tanı konur — daha fazla aramak gerekmez"

Kanıt: atipik klinik tablo genişletilmiş araştırma gerektirir (BOS, MRG, paraneoplastik panel).

Mit 5: "İmmünoterapi psikiyatrik durum için uygun değildir"

Kanıt: otoimmün ensefalit kanıtı varsa immünoterapi birinci sıradır; standart antipsikotikler etkisizdir.

11. Kaynaklar

1. WHO. ICD-11. 6E61 Secondary psychotic syndrome. 2024.
2. APA. DSM-5-TR. 2022.
3. Graus F. et al. A clinical approach to diagnosis of autoimmune encephalitis. Lancet Neurol 2016;15(4):391–404.
4. Dalmau J. et al. Anti-NMDA-receptor encephalitis: case series and analysis of the effects of antibodies. Lancet Neurol 2008;7(12):1091–1098.
5. Levenson J.L. (ed.). APA Publishing Textbook of Psychosomatic Medicine and Consultation-Liaison Psychiatry. 3rd ed. 2018.

ICD-11 **6E62**	**6E62 SEKONDER DUYGUDURUM SENDROMU** **Secondary mood syndrome**
ICD-10 F06.3	Organik duygu [affektivite] bozuklukları
DSM-5-TR F06.3x	Başka Bir Sağlık Durumuna Bağlı Depresyon Bozukluğu

1. Tanım ve nozoloji

Sekonder Duygudurum Sendromu (ICD-11: 6E62 Secondary Mood Syndrome; DSM-5-TR: F06.3x Başka Bir Tıbbi Duruma Bağlı Duygudurum Bozukluğu) — depresif, manik veya karışık duygudurum epizodları başka bir tıbbi durum, madde veya ilaç etkisi bağlamında.

2. Tarihçe

"Organik afektif bozukluk" terimi XX. yüzyıl; biyopsikososyal model klinik pratikte.

3. Epidemiyoloji

- Kronik tıbbi hastalıklarda depresif semptomlar geniş; bir kısmı klinik depresif epizoda ulaşır.
- Steroid kaynaklı duygudurum bozuklukları — yüksek doz prednizolonda %5 –18 mani/hipomani, depresyon.
- İnterferon kaynaklı depresyon — HCV tedavisinde %20–40.
- İnme sonrası depresyon — %30.

4. Etiyoloji ve patogenez

- Endokrin — hipotiroid (depresyon), hipertiroid (mani-benzeri), Cushing, Addison.
- Nörolojik — inme (sol frontal — depresyon, sağ — mani), Parkinson, MS, beyin tümörü, demans, TBI.
- Madde/ilaç — steroidler, interferon, dopamin agonistleri, izotretinoin, β-bloker, antikonvülzan.

- Metabolik — üremi, B12, folat.
- Enfeksiyöz — HIV, sifiliz, COVID.
- Otoimmün — lupus, Hashimoto.
- Onkolojik — pankreas kanseri (klasik depresif prezentasyon), paraneoplastik.

5. Klinik özellikler

- Depresif, manik, karışık, hipomanik epizod semptomları.
- Tıbbi durum veya madde ile zamansal ilişki.
- Klasik afektif bozukluk için karakteristik olmayan özellikler (geç başlangıç, atipik prezentasyon).

6. Tanı

6.1 Birleşik tanı ölçütleri

A. Sürekli duygudurum bozukluğu (depresif, manik veya karma).

B. Tıbbi durum veya madde etkisi kanıtı.

C. Birincil duygudurum bozukluğu ile daha iyi açıklanmaz.

D. Deliryum bağlamında ortaya çıkmaz.

6.2 Kaynaklar arasındaki farklar

- ICD-11 — maddeye bağlı duygudurum bozukluğu buraya AİT DEĞİLDİR: madde bölümünde yer alır. 6E62 yalnızca ruhsal bozukluklar bölümü dışındaki sağlık durumları içindir ve altta yatan hastalığın tanısıyla birlikte konur.
- Konsültasyon-liyezon protokollar.

6.3 Tanı algoritması

1. Klinik görüşme + tıbbi geçmiş.
2. Tıbbi ve laboratuvar değerlendirme (TSH, B12, kortizol, böbrek, karaciğer).
3. İlaç listesinin gözden geçirilmesi.
4. Beyin görüntülemesi (inme, MS, tümör).
5. Toksikoloji.
6. Komorbid bozukluklar.

6.4 Ayırıcı tanı

Durum	Ayırt edici
MDD birinci (6A70/6A71)	Tıbbi neden yok.
Bipolar birinci	Afektif epizod öyküsü tıbbi neden olmaksızın.
Uyum bozukluğu (6B43)	Stres faktörüne yanıt.
Delirium (6D70)	Dikkat dalgalanması.

7. Muayene ve değerlendirme

- PHQ-9, MADRS, YMRS.
- Laboratuvar: TSH, B12, kortizol, ANA, böbrek, karaciğer.
- MRT atipik durumda.
- C-SSRS.

8. Tedavi

1. Etiyolojik tedavi — tıbbi durum veya ilaç düzeltmesi.
2. Semptomatik psikiyatrik tedavi:
    - Depresif — SSRI (hastalığa özgü seçim; kardiyak — sertralin, essitalopram; onkolojik — mirtazapin);
    - Manik — antipsikotik (ketiapin, olanzapin); steroid indüksiyonlu manik durumda steroidin azaltılması veya antipsikotik;
    - Karışık veya refrakter — EKT.
3. Multidisipliner koordinasyon.

8.1 Tedavi metodolojileri

1. SSRI Hastalığa Özgü — Kardiyak, onkolojik, nörolojik bağlama uygun seçim.
2. EKT — Refrakter ve ağır durumda.

9. Prognoz

Etiyolojik müdahale ile çoğu remisyon.

10. Mit ve yanlış inançlar

Mit 1: “Tıbbi hastalığı olan hasta için depresyon 'normal'dir”

Kanıt: Klinik depresyon tıbbi durumun gidişatını kötüleştirir; aktif müdahale gerektirir.

Mit 2: “Steroid kaynaklı mani kendi kendine geçer”

Kanıt: dozun azaltılması ve/veya antipsikotik eklenmesi gerekir.

Mit 3: “Antidepresan hipotiroidide birinci basamaktır”

Kanıt: tiroid düzeltmesi birinci; antidepresan kalan semptomlar için.

Mit 4: “İnterferon depresyonu nadirdir”

Kanıt: HCV interferon tedavisinde %20–40 — aktif izlem gereklidir.

11. Kaynaklar

1. WHO. ICD-11. 6E62 Secondary mood syndrome. 2024.
2. APA. DSM-5-TR. 2022.
3. Levenson J.L. (ed.). APA Publishing Textbook of Psychosomatic Medicine and Consultation-Liaison Psychiatry. 3rd ed. 2018.
4. Robinson R.G., Jorge R.E. Post-stroke depression: a review. Am J Psychiatry 2016;173(3):221–231.

ICD-11 **6E63**	**6E63 SEKONDER ANKSİYETE SENDROMU** **Secondary anxiety syndrome**
ICD-10 F06.4	Organik anksiyete bozuklukları
DSM-5-TR F06.4	Başka Bir Sağlık Durumuna Bağlı Kaygı Bozukluğu

1. Tanım ve nozoloji

Sekonder Anksiyete Sendromu (ICD-11: 6E63 Secondary Anxiety Syndrome; DSM-5-TR: F06.4 Başka Bir Tıbbi Duruma Bağlı Anksiyete Bozukluğu) — kaygı,

panik veya obsesif-benzeri semptomlar başka bir tıbbi durum veya madde etkisi bağlamında.

2. Tarihçe

Konsültasyon-liyezon psikiyatri gelişimi; DSM-III'ten itibaren resmi kategori.

3. Epidemiyoloji

- Kronik tıbbi hastalıklarda anksiyete sıklığı yüksektir (kardiyak, KOAH, endokrin).
- Hipertiroidizmde %60–70 anksiyete belirtisi.
- Kafein, stimülan kaynaklı anksiyete.

4. Etiyoloji ve patogenez

- Endokrin — hipertiroid, feokromositoma, hipoglisemi.
- Kardiyak — aritmi, miyokard enfarktüsü, mitral valf prolapsusu.
- Respiratuar — KOAH, astım, pulmoner emboli.
- Nörolojik — TBI, Parkinson, MS.
- Madde/ilaç — kafein, stimülan, kortikosteroid, β-bloker (paradoksal), benzodiazepin/alkol kesilmesi.
- Vestibular bozukluklar.

5. Klinik özellikler

- YAB, panik atak, OKB-benzeri semptomlar tıbbi durum bağlamında.
- Atipik özellikler (geç başlangıç, fokal semptom).

6. Tanı

Tıbbi durum kanıtı + anksiyete belirtileri + zamansal ilişki.

6.1 Kaynaklar arasındaki farklar

DSM-5-TR / ICD-11 — aynı.

6.2 Tanı algoritması

1. Klinik görüşme.
2. Tıbbi değerlendirme — TSH, glukoz, kardiyak, vestibüler.
3. İlaç ve kafein anamnezi.

4. Toksikoloji.

6.3 Ayırıcı tanı

- Birincil anksiyete bozuklukları (6B0x);
- Deliryum;
- Uyum bozukluğu.

7. Muayene ve değerlendirme

- GAD-7, HAM-A.
- TSH, glukoz, EKG.
- Toksikoloji.

8. Tedavi

1. Etiyolojik tedavi.
2. Semptomatik — SSRI rezidüel anksiyete için; benzodiazepin kısa süreli akut durumda.
3. Kafein kısıtlaması.

8.1 Tedavi metodolojileri

1. Etiyolojik Müdahale — Tıbbi durum düzeltmesi.
2. SSRI Kalan Anksiyete İçin — Tıbbi durum düzeltmesinden sonra kalan semptomlar için.

9. Prognoz

Etiyolojik müdahale ile anlamlı iyileşme.

10. Mit ve yanlış inançlar

Mit 1: “Tıbbi hastalığı olan hastanın kaygısı 'normal'dir”

Kanıt: klinik sıkıntı tıbbi durumun seyrini kötüleştirir; müdahale gerektirir.

Mit 2: “Hipertiroidizmde anksiyolitik birinci sıradır”

Kanıt: tiroid düzeltmesi birinci; β-bloker (propranolol) semptomatik adjunkt.

Mit 3: “Kafein güvenlidir”

Kanıt: yüksek doz panik, anksiyete, taşikardi yaratır; sınırlama önerilir.

11. Kaynaklar

1. WHO. ICD-11. 6E63 Secondary anxiety syndrome. 2024.
2. APA. DSM-5-TR. 2022.
3. Levenson J.L. (ed.). APA Publishing Textbook of Psychosomatic Medicine and Consultation-Liaison Psychiatry. 3rd ed. 2018.

7A00–7A8Z UYKU BOZUKLUKLARI

Sleep-wake disorders

ICD-11 **7A00**	**7A00 KRONİK İNSOMNİA** **Chronic insomnia**
ICD-10 F51.0	Organik olmayan insomnia
DSM-5-TR F51.01	Uykusuzluk Bozukluğu

1. Tanım ve nozoloji

Kronik insomnia (ICD-11: 7A00; DSM-5-TR: F51.01 Insomnia Disorder) — uykuya dalmada güçlük, uykuyu sürdürememe ve/veya erken uyanma; gündüz işlevsel bozulma. Süre ≥ 3 ay, haftada ≥ 3 kez.

2. Tarihçe

- DSM-IV — “Primary Insomnia”; DSM-5 (2013) — “Insomnia Disorder” — primary/secondary farkı kaldırılmış.
- AASM (American Academy of Sleep Medicine) — Clinical Practice Guidelines (2021 CBT-I, 2017 pharmacological).
- European Insomnia Guideline (Riemann D. 2023).
- NICE TA922 (2023).

3. Epidemiyoloji

- Yaşam boyu yaygınlık: Kronik insomnia %10–15; insomnia semptomları %30–35.
- Cinsiyet: kadınlarda 1,5 kat yüksek.
- Yaşla artar.
- Komorbidite: MDD ~%50, anksiyete, ağrı, KOAH, sirkadiyen bozukluklar.

4. Etiyoloji ve patogenez

- Spielman 3P modeli — Predisposing (yatkınlık), Precipitating (tetikleyici), Perpetuating (sürdürücü).
- Hiperuyarılma hipotezi — fizyolojik ve bilişsel uyarılma.
- Davranışsal faktörler — düzensiz program, kafein, alkol, ekran kullanımı, yatak odasında uyku dışı aktivite.

5. Klinik özellikler

- Uyuma güçlüğü (uykuya dalma), sürdürememe (maintenance), erken uyanma (early morning).
- Gündüz semptomları: yorgunluk, irritabilite, konsantrasyon, iş/akademik bozulma, somatik (baş ağrısı, GI).
- Performansa etki, kaza riski.

6. Tanı

6.1 Birleşik tanı ölçütleri

A. Uyku güçlüğü (başlama, sürdürme veya erken uyanma).

B. Yeterli uyku imkanlarına rağmen.

C. Gündüz işlevsel bozulma.

D. Süre ≥ 3 ay, haftada ≥ 3 kez.

E. Başka bir uyku bozukluğu, madde, tıbbi durumla tam olarak açıklanmaz.

6.2 Kaynaklar arasındaki farklar

- AASM — CBT-I birinci basamak.
- NICE TA922 (2023) — daridoreksant yalnızca CBT-I denenip işe yaramadıysa ya da erişilebilir değilse; yani CBT-I birinci basamaktır.

6.3 Tanı algoritması

1. Klinik görüşme + uyku günlüğü 1–2 hafta.
2. ISI (Uyku Bozukluğu Şiddet İndeksi), PSQI.
3. Ayırıcı tanı — obstrüktif uyku apnesi (STOP-BANG), huzursuz bacaklar, sirkadiyen.
4. Komorbidite (MDD, anksiyete).

5. Polisomnografi yalnızca atipik durumda veya başka bir uyku bozukluğu şüphesi varsa.

6.4 Ayırıcı tanı

Durum	Ayırt edici
Obstrüktif uyku apnesi (7A41)	Horlama, gündüz uykululuğu; polisomnografi.
Sirkadian bozukluklar (7A60)	Uyku programının kayması.
Restless Legs Sendromu	Akathisia-benzer bacak huzursuzluğu.
MDD ile insomnia	Afektif semptomlar dominant.
Hipertiroid	TSH.

7. Muayene ve değerlendirme

- İSİ, PSQI.
- Uyku günlüğü.
- STOP-BANG (OSA), Epworth Sleepiness Scale.
- TSH, ferritin.

8. Tedavi

8.1 Genel prensipler (AASM 2021 · European Insomnia Guideline 2023 · NICE TA922 2023)

1. CBT-I (Cognitive Behavioral Therapy for Insomnia) — birinci basamak — kronik insomnide altın standart; farmakoterapiden üstün uzun dönem etkinlikte (Mitchell M.D. BMC Fam Pract 2012 meta-analizi). 5 temel bileşen:
    - Stimülasyon kontrolü (Bootzin) — yatak yalnızca uyku için;
    - Uyku kısıtlaması (Spielman) — yatakta kalma süresinin uyku süresine eşit olarak sınırlandırılması;
    - Bilişsel terapi — uyku hakkında felaket düşünceleri;
    - Uyku hijyeni;
    - Rahatlama eğitimi.
2. Dijital CBT-I (Sleepio, SHUTi) — NICE HTG624 (2022): birinci basamakta uyku hijyeni ya da uyku ilacı önerilecek kişiler için maliyet

tasarrufu sağlayan seçenek; yüz yüze CBT-I ile doğrudan karşılaştırma kanıtlanmamıştır.

3. Farmakoterapi — kısa süreli (2–4 hafta), BDT-İ yanıt vermediğinde veya ulaşılabilir olmadığında:
    - Z-ilaçları (zolpidem, zopiklon, eszopiklon);
    - Benzodiazepin (temazepam) — tolerans, bağımlılık riski;
    - Daha yeni — suvoreksant, lemboreksant (oreksin antagonistleri) — daha az bağımlılık;
    - Doksepin düşük dozda (3–6 mg);
    - Melatonin — sirkadiyen bileşende veya yaşlılarda; ramelteon (melatonin agonisti).
4. Yaşlılarda — Beers Kriterleri; benzodiazepin ve antihistaminik (difenhidramin) kaçınma.
5. Komorbid depresyon — sedatif antidepresan (mirtazapin, trazodon) — uzun süreli kullanım için yan etkiler dikkate alınmalıdır.

8.2 Tedavi metodolojileri

1. Uykusuzluk için BDT (CBT-I — Cognitive Behavioral Therapy for Insomnia), 5 bileşen — Uyaran kontrolü, uyku kısıtlaması, bilişsel terapi, uyku hijyeni, gevşeme.
2. Dijital CBT-I (Digital) — Sleepio, SHUTi — internet tabanlı.
3. Oreksin Antagonistleri — Suvoreksant, lemboreksant — daha az bağımlılık potansiyeli.
4. Uykusuzluk Şiddet İndeksi (ISI — Insomnia Severity Index) — 7 maddelik tarama.
5. Uyku Günlüğü — 1–2 hafta başlangıç göstergeleri.

8.3 Kaynaklar arasındaki farklar

- AASM Clinical Practice Guideline for Behavioral and Psychological Treatments (Edinger J.D. 2021).
- European Insomnia Guideline (Riemann D. J Sleep Res 2023).
- NICE TA922 (2023) — ilaca geçmeden önce CBT-I denenmelidir.

9. Prognoz

- CBT-I'ye yanıt %70–80, remisyon ~%40; etki uzun süre korunur.
- Tedavisiz kronik gidiş ve komorbidite (MDD, anksiyete).

10. Mit ve yanlış inançlar

Mit 1: “Uyku ilaçları insomnia'nın ana tedavisidir”

Kanıt: AASM 2021 — CBT-I birinci basamak; farmakoterapi kısa süreli adjuvan; uzun süreli kullanım tolerans, bağımlılık.

Mit 2: “Alkol uykuya yardımcı olur”

Kanıt: alkol REM'i azaltır, gece yarısı uyanmaya neden olur, kronik insomniye yol açar.

Mit 3: “Antihistaminik (difenhidramin) yaşlılarda güvenlidir”

Kanıt: Beers Criteria — antihistaminik yaşlılarda antikolinerjik yan etki (düşme, kognitif gerileme); kaçınma.

Mit 4: “Valeriana, kava insomnia için güvenli alternatiftir”

Kanıt: valerian — Leach M.J., Page A.T. Sleep Med Rev 2015;24:1–12 — etki kanıtı yetersiz; kava hepatotoksik.

Mit 5: “8 saat uyku herkes için gereklidir”

Kanıt: Bireysel ihtiyaç 6–9 saat; önemlisi gündüz fonksiyonu.

Mit 6: “Yatakta uyanmak zararlıdır”

Kanıt: kısa uyanmalar normaldir; stimülasyon kontrolü — 20 dk uyuyamıyorsan kalkman önerilir.

11. Kaynaklar

1. WHO. ICD-11. 7A00 Insomnia disorders. 2024.
2. APA. DSM-5-TR. 2022.
3. Edinger J.D. ve ark. Behavioral and psychological treatments for chronic insomnia disorder in adults: an AASM clinical practice guideline. J Clin Sleep Med 2021;17(2):255–262.
4. Riemann D. et al. The European Insomnia Guideline 2023. J Sleep Res 2023;32(6):e14035.
5. Mitchell M.D. et al. Comparative effectiveness of cognitive behavioral therapy for insomnia: a systematic review. BMC Fam Pract 2012;13:40.
6. Buysse D.J. et al. Efficacy of brief behavioral treatment for chronic insomnia in older adults. Arch Intern Med 2011;171(10):887–895.

7. National Institute for Health and Care Excellence. Sleepio to treat insomnia and insomnia symptoms. HealthTech guidance HTG624. London: NICE; 2022.
8. National Institute for Health and Care Excellence. Daridorexant for treating long-term insomnia. Technology appraisal guidance TA922. London: NICE; 18 October 2023.

ICD-11 **7A41**	**7A41 OBSTRÜKTİF UYKU APNESİ (OSA)** **Obstructive sleep apnoea**
ICD-10 G47.3	Uyku apnesi
DSM-5-TR G47.33	Tıkayıcı Uyku Apnesi Hipopnesi

1. Tanım ve nozoloji

Obstrüktif Uyku Apnesi (OSA; ICD-11: 7A41; DSM-5-TR: G47.33) — uyku sırasında tekrarlayan üst hava yolunun tam (apne) veya kısmi (hipopne) tıkanması; gündüz uykululuğu, bilişsel bozulma, kardiyovasküler mortalite artışı.

2. Tarihçe

- Gastaut H. (1965) — OSA klasik tanımı.
- Sullivan C.E. (1981) — CPAP'ı icat etmiştir.
- AASM Practice Parameters (güncelleme).

3. Epidemiyoloji

- Yetişkin popülasyonda: erkeklerde ~%13, kadınlarda ~%6 (orta-ağır OSA).
- Yaşla, BMI ile artar.
- Komorbidite: hipertansiyon (%50), kardiyovasküler, inme, atrial fibrilasyon, diabet.

4. Etiyoloji ve patogenez

- Anatomik — üst hava yolunda yağ dokusu, küçük mandibula, büyümüş tonsil/adenoidler.

- Genetik ve aile öyküsü.
- Postür — supin pozisyonda kötüleşir.
- Alkol, sedatif — kötüleştirir.

5. Klinik özellikler

- Yüksek horlama, gözlenen apne, boğulma hissi ile uyanma.
- Gündüz uykululuk hali (araç kullanırken tehlikeli), yorgunluk.
- Sabah baş ağrısı, ağız kuruluğu.
- Konsantrasyon, hafıza sorunları.
- Cinsel disfonksiyon, depresif semptomlar.

6. Tanı

6.1 Birleşik tanı ölçütleri

Polisomnografi (PSG) — AHI (Apne-Hipopne İndeksi) ≥ 5/saat + semptomlar; AHI ≥ 15 semptomdan bağımsız.

6.2 Kaynaklar arasındaki farklar

- AASM Clinical Practice Guideline for Diagnostic Testing (2017).
- Home Sleep Apnea Test (HSAT) — orta-ağır OSA-da uygun.

6.3 Tanı algoritması

1. STOP-BANG taraması (Snoring, Tiredness, Observed apnea, BP, BMI, Age, Neck, Gender).
2. Epworth Sleepiness Scale.
3. Polisomnografi veya HSAT.
4. Kardiyovasküler değerlendirme.

6.4 Ayırıcı tanı

Durum	Ayırt edici
İnsomni (7A00)	Uyuma ve sürdürme sorunları; horlama yok.
Santral uyku apnesi	Solunum eforu yoktur.
Narkolepsi (7A20)	Katapleksi, MSLT.

Durum	Ayırt edici
RLS	Bacak huzursuzluğu.

7. Muayene ve değerlendirme

- STOP-BANG, Epworth.
- PSG veya HSAT.
- BMI, boyun ölçüsü.

8. Tedavi

1. CPAP — Sürekli Pozitif Havayolu Basıncı ilk sıra orta-ağır OSA için; AHI anlamlı azaltır; kardiyovasküler mortalite üzerindeki etkisi randomize çalışmalarda (SAVE, NEJM 2016) doğrulanmamıştır.
2. BiPAP — refrakter durumda veya CPAP yanıtsız.
3. Kilo verme — hafif OSA'da; bariatrik cerrahi ağır obezitede.
4. Mandibular advancement device (MAD) — hafif-orta OSA, CPAP yanıtsız.
5. Postural terapi — supin-avoidant.
6. Cerrahi (UPPP, hipoglossal stimülasyon — Inspire) — seçici vakalarda.
7. Alkol ve sedatiften yoksunluk.

8.1 Tedavi metodolojileri

1. CPAP — Birinci sıra; uyum temel sorun.
2. Alt Çene İlerletme Cihazı (MAD — Mandibular Advancement Device) — Hafif-orta OSA; CPAP yanıtsızlığında.
3. Hipoglossal Stimülasyon (Inspire) — Yeni cerrahi seçenek; seçilmiş vakada.
4. STOP-BANG, Epworth, PSG — Tarama ve tanı.

8.2 Kaynaklar arasındaki farklar

- AASM CPAP standardı, MAD seçici.
- NICE NG202 (OSA-COPD-overlap).

9. Prognoz

- CPAP semptomları ve AHI'yi güvenilir şekilde azaltır, yaşam kalitesini artırır; kardiyovasküler mortalite üzerindeki etkisi kanıtlanmamıştır (gözlemsel çalışmalar — Marin 2005 — azalmış mortalite ile ilişkilendirmiş

olsa da, randomize çalışmalar — SAVE, NEJM 2016 — bunu doğrulamamıştır, muhtemelen çalışmalardaki düşük uyum nedeniyle).

- Tedavisiz — inme, atriyal fibrilasyon, diyabet mortalite artışı.

10. Mit ve yanlış inançlar

Mit 1: "OSA sadece obez kişilerde görülür"

Kanıt: normal kilolu hastalarda da mümkündür (anatomik faktörler).

Mit 2: "Horlama OSA'nın ana belirtisidir, daha fazlası gerekmez"

Kanıt: horlama tek kanıt değildir; AHI ölçümü gereklidir; OSA tedavisiz mortalite ve morbidite yüksek.

Mit 3: "CPAP yalnızca semptomları azaltır, mortaliteyi etkilemez"

Kanıt: Gerçek daha nüanslı. Gözlemsel veriler (Marin, Lancet 2005) CPAP'ı azalmış mortalite ile ilişkilendirmiştir, ancak sonraki randomize çalışmalar (SAVE, NEJM 2016) kardiyovasküler mortalite azalmasını doğrulamamıştır — muhtemelen çalışmalardaki düşük uyum nedeniyle (ortalama ~3,3 saat/gece, önerilen ~4 saate karşı). CPAP semptomları ve AHI'yi güvenilir şekilde azaltır, yaşam kalitesini artırır; mortalite üzerindeki etkisi kanıtlanmamış durumdadır.

Mit 4: "Santral uyku apnesi ve OSA aynı şekilde tedavi edilir"

Kanıt: Farklı müdahale (ASV — Adaptive Servo-Ventilation santral apnede); farklılaşma kritiktir.

11. Kaynaklar

1. WHO. ICD-11. 7A41 Obstructive sleep apnoea. 2024.
2. APA. DSM-5-TR. 2022.
3. Kapur V.K. et al. AASM Clinical Practice Guideline for Diagnostic Testing for Adult OSA. J Clin Sleep Med 2017;13(3):479–504.
4. Marin J.M. et al. Long-term cardiovascular outcomes in men with OSA-hypopnoea with or without treatment with CPAP. Lancet 2005;365(9464):1046–1053.

	7A60–7A65 SİRKADİYEN RİTM UYKU-UYANIKLIK BOZUKLUKLARI
ICD-11 **7A60–7A65**	**Circadian rhythm sleep-wake disorders**
ICD-10 F51.2	Uyku-uyanıklık ritminin organik olmayan bozukluğu
DSM-5-TR G47.21	Yirmi Dört Saatlik Düzenle İlgili Uyku-Uyanıklık Bozuklukları, Gecikmeli uyku evresi türü

1. Tanım ve nozoloji

Sirkadiyen Ritim Uyku-Uyanıklık Bozuklukları (ICD-11: 7A60–7A65; DSM-5-TR: G47.21) — iç sirkadiyen ritim ile dış sosyal ve ışık çizelgesi arasında uyumsuzluk; sonuçta insomnia ve/veya uykululuk hali.

Alt tipler: Delayed Sleep-Wake Phase Disorder (DSWPD), Advanced Sleep-Wake Phase Disorder, Irregular Sleep-Wake Rhythm, Non-24-hour Sleep-Wake (körlerde), Shift Work Disorder, Jet Lag Disorder.

2. Tarihçe

- 1960'larda Aschoff J. — sirkadiyen biyoloji temelleri.
- AASM (2015) — sirkadiyen ritim bozuklukları için klinik uygulama kılavuzu.

3. Epidemiyoloji

- DSWPD — ergenlerde ve genç yetişkinlerde %7–16.
- Shift Work Disorder — vardiyalı çalışanların %10–30'u.
- Komorbidite: MDD, anksiyete, bipolar, kardiyovasküler.

4. Etiyoloji ve patogenez

- Endojen sirkadiyen ritim bozukluğu (clock gen mutasyonları nadiren — Familial Advanced Sleep Phase).

- Çevre — ışık maruziyeti, sosyal takvim.
- Ergenlerde DSPD — pubertal hormonal değişiklikler.

5. Klinik özellikler

- DSWPD — uyku ve uyanma zamanının geç olması; okul/iş ile uyumsuzluk; "night owl" modeli.
- Advanced — uyku ve uyanma zamanının erken olması; yaşlılarda.
- Irregular — uyku epizodları gün içine yayılmış; demans, İD'de.
- Non-24-hour — kör insanlarda; sirkadiyen ritim dış ışık sinyaline uyum sağlamaz.
- Shift Work — vardiyalı çalışma; insomnia + gündüz uykululuğu.
- Jet Lag — geçici, hızlı zaman dilimi değişikliği.

6. Tanı

6.1 Birleşik tanı ölçütleri

A. Uyku-uyanıklık çizelgesi ile iç sirkadiyen ritim arasında uyumsuzluk.

B. İnsomni, uykululuk veya her ikisi.

C. Süre ≥ 3 ay (jet lag ve vardiyalı çalışma hariç).

D. Fonksiyonel bozulma.

6.2 Kaynaklar arasındaki farklar

- AASM 2015 Clinical Practice Guideline.

6.3 Tanı algoritması

1. Klinik görüşme + uyku günlüğü 1–2 hafta.
2. Aktigrafi 2 hafta.
3. Dim Light Melatonin Onset (DLMO) — araştırma bağlamında.
4. Komorbid uyku bozukluklarının dışlanması.

6.4 Ayırıcı tanı

İnsomni, OSA, depresif bozukluk, narkolepsi.

7. Muayene ve değerlendirme

- Uyku günlüğü, aktigrafi.

- Munich Chronotype Questionnaire.

8. Tedavi

1. Parlak ışık terapisi (bright light) — DSWPD'de sabah; Advanced'da akşam.
2. Eksogen melatonin — fizyolojik düşük doz (0,3–5 mg); DSWPD'de akşam (zaman kritik); jet lag'da.
3. Kronoterapi — uyku zamanının kademeli olarak kaydırılması.
4. Uyku hijyeni ve davranış müdahalesi.
5. Shift work — stratejik dinlenme, karanlık oda, kafein zamanlaması.
6. Non-24-hour kör hastalarda — tasimelteon (Hetlioz, FDA onaylı).

8.1 Tedavi metodolojileri

1. Parlak Işık Terapisi (Bright Light Therapy) — 10 000 lüks × 30–60 dk; zamanlama sirkadiyen kaymaya göre ayarlanır.
2. Melatonin (Sirkadian) — Düşük doz; zaman kritik.
3. Aktigrafi (Actigraphy) — 2 hafta.
4. Tasimelteon — Non-24-hour için FDA onayı.

9. Prognoz

Müdahale ile çoğu hasta iyileşir; kronik formda sürekli strateji gereklidir.

10. Mit ve yanlış inançlar

Mit 1: “Ergen ‘tembeldir’, erken kalkabilir”

Kanıt: DSWPD pubertal dönemde sirkadiyen gecikmenin nörobiyolojik temelidir.

Mit 2: “Melatonin uyku ilacıdır”

Kanıt: melatonin sirkadiyen fazı düzenler, hipnotik etki minimaldir; zaman seçimi kritik.

Mit 3: “Vardiyalı çalışma insomnisinin tedavisi yoktur”

Kanıt: strategik dinlenme, ışık terapisi, melatonin, kafein zaman seçimi iyileştirir.

Mit 4: “Jet lag kendi kendine geçer”

Kanıt: 1 saat kaydırma için yaklaşık 1 gün; hızlandırma ışık + melatonin ile.

11. Kaynaklar

1. WHO. ICD-11. 7A60–7A65 Circadian rhythm sleep-wake disorders. 2024.
2. APA. DSM-5-TR. 2022.
3. Auger R.R. et al. AASM Clinical Practice Guideline for the Treatment of Intrinsic Circadian Rhythm Sleep-Wake Disorders. J Clin Sleep Med 2015;11(10):1199–1236.

ICD-11 **7A21–7A26**	**7A21–7A26 HİPERSOMNİ** **Hypersomnolence disorders**
ICD-10 F51.1	Organik olmayan hipersomnia
DSM-5-TR F51.11	Hipersomnolans Bozukluğu

1. Tanım ve nozoloji

Hipersomni (ICD-11: 7A21–7A26; DSM-5-TR: F51.11 Hypersomnolence Disorder) — gündüz aşırı uykululuk hali veya uyku epizodları (≥ 7 saat gece uykusundan sonra); işlevsel bozulma. İdiyopatik hipersomni, narkolepsi, diğer uyku bozuklukları bağlamında.

2. Tarihçe

1970–80'lerde narkolepsi ile diferansiyasyon gelişti; AASM klinik kılavuzları.

3. Epidemiyoloji

- İdiyopatik hipersomni: ~50/100 000.
- Kleine-Levin sendromu — nadir (~1/1 milyon); tekrarlayan hipersomni epizodları + iştah/cinsel bozukluk.
- Komorbidite: depresif semptomlar, OSA, narkolepsi.

4. Etiyoloji ve patogenez

- Bilinmeyen (idiyopatik) — nörobiyolojik disregülasyon hipotezi.
- GABA-erjik sistemin disregülasyonu (idiyopatik).
- İkincil — Kleine-Levin (otoimmün şüphesi), TBI sonrası, MS, depresif bozukluk.

5. Klinik özellikler

- Sürekli gündüz uykululuğu (Excessive Daytime Sleepiness, EDS).
- Uzun gece uykusu (≥ 9 saat) yeterli gelmez.
- "Uyku sarhoşluğu" — uyandıktan sonra konfüzyon, dezoryantasyon.
- Gündüz uykuları uzun ve dinlendirici değil (narkolepsiden farklı — kısa ve dinlendirici).
- Kleine-Levin — 1–2 haftalık hipersomni epizodları + hiperfaji + dezinhibe davranış.

6. Tanı

6.1 Birleşik tanı ölçütleri

A. Yeterli uykudan (≥ 7 saat) sonra aşırı uykululuk veya uzun uyku.

B. Sıklık ve süre — haftada ≥ 3 kez, ≥ 3 ay

C. Önemli sıkıntı veya işlevsel bozulma.

D. Başka bir uyku bozukluğu, madde, tıbbi durumla tam olarak açıklanmaz.

6.2 Kaynaklar arasındaki farklar

- AASM Practice Parameters — tanısal PSG ve MSLT (Multiple Sleep Latency Test).
- İdiyopatik hipersomni — MSLT'de ortalama uyku latansı ≤ 8 dk; SOREMP ≤ 1 (narkolepsiden farklı).

6.3 Tanı algoritması

1. Klinik görüşme ve uyku günlüğü.
2. Epworth Sleepiness Scale.
3. PSG + MSLT (narkolepsi dışlaması).
4. Tıbbi değerlendirme — tiroid, anemi, depresif, OSA.

6.4 Ayırıcı tanı

Durum	**Ayırt edici**
Narkolepsi (7A20)	Katapleksi, SOREMP ≥ 2.
OSA (7A41)	Horlama, AHI ↑.
Depresif bozukluk	Afektif semptomlar.

Durum	Ayırt edici
İnsomni (7A00)	Yetersiz uyku.
Kleine-Levin sendromu	Epizodik 1–2 haftalık hipersomni + iştah.

7. Muayene ve değerlendirme

- Epworth, PSG + MSLT.
- Tıbbi laboratuvar.

8. Tedavi

1. Modafinil, armodafinil — birinci basamak.
2. Uyarıcılar (metilfenidat, amfetamin) — refrakter.
3. Düşük sodyumlu oksibat (Xywav, FDA 2021) — idiyopatik hipersomnide onaylı tek ilaç.
4. Pitolisant (FDA 2019) — narkolepside; solriamfetol (FDA 2019) — narkolepsi ve obstrüktif uyku apnesinde onaylıdır; idiyopatik hipersomnide her ikisi de off-label.
5. Uyku hijyeni ve davranış müdahalesi (planlanmış gündüz uykuları).
6. Kleine-Levin — destekleyici; epizodlar arası asemptomatik.

8.1 Tedavi metodolojileri

1. Modafinil/Armodafinil — uyanıklığı artıran ilaçlar; birinci basamak; baş ağrısı, anksiyete yan etki.
2. Çoklu Uyku Latansı Testi (MSLT — Multiple Sleep Latency Test) — 5 uyku denemesi 2 saat arayla; uyku latansı ölçümü.
3. Pitolisant ve Solriamfetol — Yeni ilaçlar; refrakter vakada.

8.2 Kaynaklar arasındaki farklar

- AASM Treatment Guidelines (Maski K. et al. 2021).

9. Prognoz

Kronik; farmakoterapi ile fonksiyonel iyileşme.

10. Mit ve yanlış inançlar

Mit 1: “Gündüz uykululuğu 'tembellik'tir”

Kanıt: klinik durum; mortalite ve kaza riskinde artış.

Mit 2: “Kafein hipersomni için yeterlidir”

Kanıt: Kafein adjunkt; modafinil veya stimülan gereklidir.

Mit 3: “Hipersomni yalnızca depresyon belirtisidir”

Kanıt: idiyopatik hipersomni ayrı bir bozukluktur; MSLT ayırt eder.

11. Kaynaklar

1. WHO. ICD-11. 7A21–7A26 Hypersomnolence disorders. 2024.
2. APA. DSM-5-TR. 2022.
3. Maski K. et al. Treatment of central disorders of hypersomnolence: AASM Clinical Practice Guideline. J Clin Sleep Med 2021;17(9):1881–1893.

ICD-11 **7A20**	**7A20 NARKOLEPSİ** **Narcolepsy**
ICD-10 G47.4	Narkolepsi ve kataplexi
DSM-5-TR G47.4xx	Narkolepsi

1. Tanım ve nozoloji

Narkolepsi (ICD-11: 7A20; DSM-5-TR: G47.4xx) — gündüz karşı konulamaz uyku epizodları; iki tip: Tip 1 (kataplexi ile, oreksin-A/hipokretin defisiti) ve Tip 2 (kataplexi olmadan).

2. Tarihçe

- Gélineau J.B. (1880) — narkolepsi terimi.
- Mignot E. et al. (2000) — oreksin/hipokretin sisteminin keşfi narkolepsi etiyolojisinde.

3. Epidemiyoloji

- Yaygınlık: 25–50/100 000.
- Başlangıç: 10–25 yaş (bimodal).
- Komorbidite: OSA, depresif semptomlar, OKB.

4. Etiyoloji ve patogenez

- Tip 1 — oreksin-A nöronlarının autoimmune hasarı (CSF oreksin < 110 pg/ml); HLA-DQB1*06:02 kuvvetli ilişki.
- H1N1 aşısı (Pandemrix, 2009) — İskandinav ülkelerinde narkolepsi tip 1 insidans artışı (Miller E. BMJ 2013).
- Tip 2 — etiyoloji tam olarak bilinmiyor.

5. Klinik özellikler

Klasik tetrada

- Gündüz aşırı uykululuk hali (EDS) — kaçınılmaz uyku atakları.
- Katapleksi (Tip 1) — ani kısmi veya tam kas tonusu kaybı emosyonel tetikleyici ile (gülmek, sinirlenmek); bilinç korunur.
- Uyku paralizisi — uykuya dalma veya uyanma geçişinde hareket edememe.
- Hipnagojik/hipnopompik halüsinasyonlar — uyku geçişinde görsel/işitsel halüsinasyonlar.

Tamamlanmış tetrad nadir; EDS ana özellik.

6. Tanı

6.1 Birleşik tanı ölçütleri

A. EDS ≥ 3 ay.

B. MSLT — ortalama uyku latansı ≤ 8 dak + ≥ 2 SOREMP (Uyku Başlangıç REM Periyodu); ya da CSF oreksin-A < 110 pg/ml.

C. Tip 1 — katapleksi + oreksin defisiti; Tip 2 — katapleksi yok, oreksin normal.

6.2 Kaynaklar arasındaki farklar

- ICSD-3 (International Classification of Sleep Disorders) — AASM.
- HLA tiplendirmesi ve BOS oreksin — atipik durumda.

6.3 Tanı algoritması

1. Klinik görüşme.
2. PSG (gece) + MSLT (gündüz) — altın standarttır.
3. CSF oreksin — seçici.
4. HLA-DQB1*06:02 — destekleyici.

6.4 Ayırıcı tanı

Durum	Ayırt edici
İdiyopatik hipersomni (7A21)	SOREMP < 2.
OSA (7A41)	AHI yüksek.
Nöbet	Bilinç kaybı; EEG
Sinkop	Kardiyovasküler neden.
Fonksiyonel/psikojen	Tipik klinik model ve PSG/MSLT sonuçlarıyla uyumsuzluk.

7. Muayene ve değerlendirme

- Epworth.
- PSG + MSLT.
- CSF oreksin, HLA-DQB1*06:02.

8. Tedavi

1. EDS: modafinil, armodafinil, solriamfetol, pitolisant; stimülanlar (metilfenidat, amfetamin) refrakter durumda.
2. Katapleksi: Sodyum oksibat (Xyrem) — altın standart; yeni — kalsiyum/magnezyum/potasyum/sodyum oksibat (Xywav, FDA 2020, düşük sodyum); SSRI/SNRI (venlafaksin, fluoksetin); pitolisant.
3. Davranış — planlı gündüz uykuları (15–20 dk).
4. Sürücülük kısıtlaması EDS varsa.

8.1 Tedavi metodolojileri

1. Sodyum Oksibat (Xyrem/Xywav) — GHB; gece 2 dozda; katapleksi ve EDS üzerine etki.
2. Modafinil/Armodafinil — EDS için birinci sıra.
3. Pitolisant — H3 reseptör antagonisti; EDS ve katapleksi.

4. SSRI/SNRI Katapleksi için — Venlafaksin, fluoksetin off-label.
5. MSLT — SOREMP ≥ 2 tanısal.

8.2 Kaynaklar arasındaki farklar

- AASM Treatment Guidelines (Maski 2021).
- FDA onayları — pitolisant 2019, solriamfetol 2019, Xywav 2020.

9. Prognoz

- Kronik; farmakoterapi ile fonksiyonel iyileşme.
- Komorbidite (MDD, OSA) müdahalesi önemlidir.

10. Mit ve yanlış inançlar

Mit 1: "Narkolepsi tek başına EDS'dir"

Kanıt: tetrad (EDS + katapleksi + paralizi + halüsinasyon); MSLT'de SOREMP ayırt edici.

Mit 2: "Katapleksi nöbettir"

Kanıt: Bilinç korunur; EEG epileptik aktivite yok; duygusal tetikleyici.

Mit 3: "H1N1 aşısı narkolepsi yaratır — aşılardan kaçınmak gerek"

Kanıt: Spesifik Pandemrix (2009 İskandinavya) ile risk gösterilmiştir; diğer aşılar güvenlidir; genel aşıdan kaçınma önerilmez.

Mit 4: "Hasta araba kullanabilir"

Kanıt: EDS'li narkoleptik hastada sürücülük kısıtlanmalıdır.

11. Kaynaklar

1. WHO. ICD-11. 7A20 Narcolepsy. 2024.
2. APA. DSM-5-TR. 2022.
3. Maski K. et al. AASM CPG. J Clin Sleep Med 2021;17(9):1881–1893.
4. Miller E. et al. Risk of narcolepsy in children and young people receiving AS03 adjuvanted pandemic A/H1N1 2009 influenza vaccine. BMJ 2013;346:f794.
5. Mignot E. et al. The role of cerebrospinal fluid hypocretin measurement in the diagnosis of narcolepsy. Arch Neurol 2002;59(10):1553–1562.

HA00–HA0Z CİNSEL SAĞLIK

Conditions related to sexual health

ICD-11 **HA01.1**	**HA01.1 ERKEK EREKSİYON BOZUKLUĞU (ED)** **Male erectile dysfunction**
ICD-10 F52.2	Psikojenik impotans
DSM-5-TR F52.21	Sertleşme Bozukluğu

1. Tanım ve nozoloji

Erkek ereksiyon bozukluğu (ED; ICD-11: HA01.1 Erektil Disfonksiyon; DSM-5-TR: F52.21) — cinsel ilişki için yeterli ereksiyon elde etme veya sürdürmede sürekli zorluk. Süre ≥ 6 ay, çoğu girişimde.

2. Tarihçe

- 1998 — sildenafil (Viagra) FDA onayı — ED tedavisinde devrim.
- AUA (American Urological Association) Guideline (Burnett 2018, 2024 güncellemesi).
- EAU (European Association of Urology) Guidelines.

3. Epidemiyoloji

- 40 yaşında %5–10, 70 yaşında %50+.
- Risk faktörleri: diyabet, kardiyovasküler hastalık (ED kardiyovasküler erken belirteç), hipertansiyon, hiperlipidemi, sigara, obezite, depresyon, antidepresanlar.

4. Etiyoloji ve patogenez

- Organik (~%70) — vasküler, nörojenik, endokrin (hipogonadizm), ilaca bağlı.

- Psikojen (~%10) — performans kaygısı, ilişki sorunları, depresyon.
- Karışık (~%20).
- Princeton III Consensus (Nehra 2012) — ED kardiyovasküler erken marker, kardiyak risk değerlendirmesi önemli.

5. Klinik özellikler

- Ereksiyon elde etme veya sürdürmede zorluk.
- Sabah veya gece ereksiyonlarının olup olmaması (psikojen vs organik diferansiyasyonda).
- İlişki ve duygusal yük.

6. Tanı

6.1 Birleşik tanı ölçütleri (AUA 2018 · EAU)

A. Ereksiyon elde etme ve/veya sürdürmede sürekli zorluk.

B. Süre ≥ 6 ay, çoğu girişimde.

C. Distress veya ilişki bozulması.

6.2 Kaynaklar arasındaki farklar

- AUA 2018/2024 ve EAU — basamaklı yaklaşım.

6.3 Tanı algoritması

1. Klinik görüşme (cinsel ve tıbbi anamnez, ilişkiler).
2. IIEF (International Index of Erectile Function) / SHIM.
3. Laboratuvar — sabah testosteronu, glukoz, HbA1c, lipid, prolaktin, tiroid.
4. Kardiyovasküler değerlendirme.
5. Penil USG (vasküler şüphesi) — seçici.

6.4 Ayırıcı tanı

Durum	**Ayırt edici**
Hipogonadizm	Testosteron düşük + semptomlar.
Erken boşalma (HA03)	Ejakülasyon süresi.
HSDD	İstek azalması baskın.
Peyronie hastalığı	Penil eğrilik ve ağrı.

7. Muayene ve değerlendirme

- IIEF.
- Tıbbi ve laboratuvar (yukarıda).
- Kardiyak değerlendirme (gerektiğinde EKG, stres testi).

8. Tedavi

8.1 Genel prensipler (AUA 2018/2024 · EAU basamaklı)

1. 1. sıra:
    - Yaşam tarzı — sigarayı bırakma, kilo, fiziksel aktivite, kardiyovasküler yönetim;
    - PDE5 inhibitörleri — sildenafil (25–100 mg), tadalafil (5–20 mg gerektiğinde veya 2,5–5 mg günlük), vardenafil, avanafil; nitratla mutlak kontrendikedir; α-blokerle dikkatli olunmalı.
2. 1. sıra (hipogonadizmde): testosteron replasman tedavisi (TRT) — yalnızca doğrulanmış hipogonadizmde (≥ 2 sabah ölçümü düşük + semptomlar); PSA ve hematokrit izlemi.
3. 2. sıra:
    - İntrakavernozal alprostadil (PGE1);
    - İntraüretral alprostadil (MUSE);
    - Vakuum erektil cihaz.
4. 3. sıra: penil protez (yarı rijit veya şişirilebilir); yüksek memnuniyet.
5. Psikoterapi — performans kaygısında; çift terapisi.
6. Antidepresan indüklü ED — bupropion, mirtazapin, vortioksetin alternatif; sildenafil adjunkt (Nurnberg JAMA 2003).

8.2 Tedavi metodolojileri

1. PDE5 İnhibitörleri — Fosfodiesteraz 5 inhibitörü; nitratla mutlak kontrendikedir.
2. İntrakavernozal Alprostadil — PGE1; PDE5 yanıtsızlığında.
3. Vakum Cihazı (Vacuum Device) — Non-invaziv; antikoagülan ile kullanılabilir.
4. Penil Protez (Penile Prosthesis) — Refrakter ED; yüksek memnuniyet.
5. Uluslararası Erektil Fonksiyon İndeksi (IIEF — International Index of Erectile Function) — Şiddet skalası.

8.3 Kaynaklar arasındaki farklar

- Burnett A.L. et al. AUA Guideline. J Urol 2018, 2024 güncellemesi.
- Salonia A. et al. EAU Guidelines 2023.

9. Prognoz

PDE5 ile %70 etkinlik; refrakter durumda 2–3. sıra; kardiyovasküler risk yönetimi mortaliteyi azaltır.

10. Mit ve yanlış inançlar

Mit 1: "ED yaşlanmanın normal bir parçasıdır, tedavi gerektirmez"

Kanıt: ED kardiyovasküler erken belirteç; aktif müdahale önemlidir.

Mit 2: "Reçetesiz 'doğal' güç artırıcılar güvenlidir"

Kanıt: FDA uyarıları — birçok "doğal" preparatta beyan edilmemiş sildenafil/tadalafil — nitratla etkileşim, ölüm riski.

Mit 3: "Testosteron replasman tedavisi her ED hastası için gereklidir"

Kanıt: AUA — yalnızca doğrulanmış hipogonadizmde; rutin TRT önerilmez.

Mit 4: "Şok dalga terapisi (Li-ESWT) standart tedavidir"

Kanıt: AUA 2024 — araştırma aşamasında; standart birinci sıra değil.

Mit 5: "Yohimbin etkili doğal bir alternatiftir"

Kanıt: Ernst E., Pittler M.H. J Urol 1998;159(2):433–436 — küçük etki, anksiyete ve hipertansiyon yan etkileri; PDE5 üstün.

11. Kaynaklar

1. WHO. ICD-11. HA01.1 Male erectile dysfunction. 2024.
2. APA. DSM-5-TR. 2022.
3. Burnett A.L. et al. Erectile Dysfunction: AUA Guideline. J Urol 2018;200(3):633–641.
4. Salonia A. et al. EAU Guidelines on Sexual and Reproductive Health 2023.
5. Nehra A. et al. The Princeton III Consensus recommendations for the management of erectile dysfunction and cardiovascular disease. Mayo Clin Proc 2012;87(8):766–778.

6. Yuan J. et al. Comparative effectiveness and safety of oral phosphodiesterase type 5 inhibitors for erectile dysfunction: a systematic review and network meta-analysis. Eur Urol 2013;63(5):902–912.

ICD-11 **HA03.0**	**HA03.0 ERKEK ERKEN EJEKÜLASYONU (PE)** **Male early ejaculation**
ICD-10 F52.4	Prematür ejekülasyon
DSM-5-TR F52.4	Erken Boşalma

1. Tanım ve nozoloji

Erkek erken ejekülasyonu (PE; ICD-11: HA03.0 Erken boşalma; DSM-5-TR: F52.4) — boşalmanın istenmeden kısa sürede, çoğunlukla penetrasyondan önce veya ~1 dk içinde gerçekleşmesi; kontrol kaybı ve sıkıntı.

Alt tipler: Lifelong (primary) — başlangıçtan; Acquired (secondary) — sonradan gelişmiş; Variable ve Subjective — ISSM sınıflaması.

2. Tarihçe

- Semans J.H. (1956) — “start-stop” tekniği.
- Masters & Johnson (1970) — “squeeze” (sıkma) davranış yöntemi.
- ISSM (2014) — Althof S.E. uluslararası tanı ve tedavi kılavuzu.
- 2009 — dapoksetin AB'de PE için ilk onaylanan ilaç.

3. Epidemiyoloji

- Erkeklerde yaygınlık %20–30 (kendi bildirimi); strikt ISSM kriterleri ile %4–5.
- Yaşa bağlı değişkenlik az; tüm yaş gruplarında.
- Komorbidite: ED, anksiyete, depresyon, ilişki gerginliği.

4. Etiyoloji ve patogenez

- Nörobiyolojik — serotonerjik (5-HT2C, 5-HT1A dengesi); genetik bileşen (yaşam boyu).

- Psikolojik — performans kaygısı, erken cinsel deneyim, ilişki sorunları.
- Acquired — ED, prostatit, hipertiroidi, madde kullanımı.

5. Klinik özellikler

- İntravajinal ejakülasyon gecikme süresi (IELT) kısa (yaşam boyu ~1 dk; edinilmiş ≤ 3 dk).
- Kontrol kaybı.
- Distress, kaçınma, ilişki gerginliği.

6. Tanı

6.1 Birleşik tanı ölçütleri (ISSM 2014 · DSM-5-TR)

A. Ejakülasyon her zaman veya neredeyse her zaman penetrasyondan önce veya ~1 dk içinde (lifelong) veya gecikme süresinin ≤ 3 dk'ya kadar klinik olarak anlamlı azalması (acquired).

B. Tüm veya neredeyse tüm penetrasyonlarda geciktirememe.

C. Olumsuz kişisel sonuçlar — sıkıntı, kaçınma

6.2 Kaynaklar arasındaki farklar

- ISSM (Althof S.E. et al. J Sex Med 2014).
- AUA ve EAU kılavuzları.

6.3 Tanı algoritması

1. Klinik görüşme (cinsel öykü, IELT, kontrol, sıkıntı).
2. PEDT (Premature Ejaculation Diagnostic Tool) — 5 madde.
3. Komorbid ED değerlendirmesi (IIEF).
4. Endokrin ve ürolojik (edinilmiş form).

6.4 Ayırıcı tanı

Durum	Ayırt edici
ED (HA01)	Ereksiyon sürdürmede zorluk.
Variable PE	Klinik bir bütün değil — normal varyasyon.
Subjective PE	IELT normal, ancak algı bozukluğu.

Durum	Ayırt edici
Prostatit	Pelvik ağrı; edinilmiş PE.

7. Muayene ve değerlendirme

- PEDT, IIEF.
- IELT (kronometre — önerildiğinde).
- Endokrin ve ürolojik (edinilmiş şüphesi).

8. Tedavi

8.1 Genel prensipler (ISSM 2014 · AUA · EAU)

1. Davranışsal yöntemler (1. basamak veya kombinasyon):
    - Start-stop (Semans);
    - Squeeze — sıkma (Masters & Johnson);
    - Pelvik taban egzersizleri (Pastore A. RCT 2014).
2. Dapoksetin — kısa etkili SSRI; 30–60 mg cinsel ilişkiden 1–3 saat önce; AB ve birçok ülkede PE için onaylı; ABD FDA'da PE için onaylanmamıştır.
3. SSRI endikasyon dışı günlük — paroksetin (10–40 mg) en yüksek etkinlik (Waldinger meta-analizi); sertralin, fluoksetin, sitalopram alternatif; cinsel yan etkiler mümkün.
4. Topik anestezikler — lidokain/prilokain (EMLA, TEMPE/Fortacin sprey) penetrasyondan 5–10 dk önce; partnere geçişten korunma (kondom veya silme).
5. Tramadol — seçici vakalarda (bağımlılık riski dikkate alınmalı).
6. PDE5 inhibitörü — yalnızca komorbid ED ile.
7. Çift terapisi ve BDT — performans kaygısında.

8.2 Tedavi metodolojileri

1. Dapoksetin — Kısa etkili SSRI; gerektiğinde; AB onayı.
2. Topik Anestetik — Lidokain/prilokain (EMLA, Fortacin); 5–10 dk önce.
3. SSRI Günlük (off-label) — Paroksetin en yüksek etkinlik.
4. Start-Stop ve Sıkma (Squeeze) teknikleri — Davranışsal yöntemler; tek başına veya kombinasyon.
5. Pelvik Taban Egzersizleri (Pelvic Floor Exercises) — Pastore RKÇ — IELT artışı.

8.3 Kaynaklar arasındaki farklar

- Althof S.E. et al. ISSM Guideline. J Sex Med 2014.
- Waldinger M.D. et al. SSRI meta-analizi.

9. Prognoz

Dapoksetin ve SSRI ile IELT 2–4 kat artar; davranış kombinasyonu uzun vadeli etkiyi destekler.

10. Mit ve yanlış inançlar

Mit 1: "PE sadece psikolojik bir sorundur"

Kanıt: yaşam boyu PE serotonerjik nörobiyoloji ile ilişkilidir; dapoksetin ve SSRI etkisi bunu doğrular.

Mit 2: "Dapoksetin ABD'de FDA tarafından onaylanmıştır"

Kanıt: dapoksetin ABD FDA'da PE için onaylanmamıştır; AB ve birçok ülkede onaylı; ABD'de off-label günlük SSRI ile tedavi edilir.

Mit 3: "Topik anestezik güvenli ve partnere etkisizdir"

Kanıt: kondom veya silme partnere geçişten korunma için önemlidir; aksi halde partner duyum azalması yaşayabilir.

Mit 4: "Reçetesiz 'PE güçlendiricileri' güvenlidir"

Kanıt: FDA uyarıları — birçok "doğal" preparatta beyan edilmemiş SSRI veya anestetik bileşenler.

Mit 5: "Davranış terapisi yalnızca eski yöntemdir"

Kanıt: ISSM start-stop, squeeze ve pelvik taban egzersizlerini önerir; farmakoterapi ile kombinasyonda etkinlik artar.

11. Kaynaklar

1. WHO. ICD-11. HA03.0 Male early ejaculation. 2024.
2. APA. DSM-5-TR. 2022.
3. Althof S.E. et al. An update of the International Society of Sexual Medicine's guidelines for the diagnosis and treatment of premature ejaculation. J Sex Med 2014;11(6):1392–1422.

4. Waldinger M.D. et al. Relevance of methodological design for the interpretation of efficacy of drug treatment of PE: a systematic review and meta-analysis. Int J Impot Res 2004;16(4):369–381.
5. Pastore A.L. et al. Pelvic floor muscle rehabilitation for patients with lifelong premature ejaculation: a novel therapeutic approach. Ther Adv Urol 2014;6(3):83–88.

ICD-11 **HA00**	**HA00 HİPOAKTİF CİNSEL İSTEK BOZUKLUĞU (HSDD)** **Hypoactive sexual desire dysfunction**
ICD-10 F52.0	Seksüel isteğini kaybolması ya da yokluğu
DSM-5-TR F52.0 / F52.22	Erkekte Azalmış Cinsel İstek Bozukluğu / Kadında Cinsel İlgi-Uyarılma Bozukluğu

1. Tanım ve nozoloji

Hipoaktif Cinsel İstek Bozukluğu (HSDD; ICD-11: HA00 Hipoaktif cinsel istek bozukluğu; DSM-5-TR kadınlarda Female Sexual Interest/Arousal Disorder F52.22, erkeklerde Male Hypoactive Sexual Desire Disorder F52.0) — cinsel fantezi ve ilişkiye isteğin sürekli azalması veya yokluğu; sıkıntı ile.

Süre ≥ 6 ay; durumsal veya yaygın; yaşam boyu veya edinilmiş.

2. Tarihçe

- Kaplan H.S. (1977) — istek fazının cinsel yanıt modeline dahil edilmesi.
- Basson R. (2000) — kadınlarda döngüsel (circular) istek-uyarılma modeli.
- 2015 — flibanserin FDA onayı; 2019 — bremelanotid FDA onayı.
- ISSWSH (International Society for the Study of Women's Sexual Health) Process of Care 2018 (Clayton A.H.).

3. Epidemiyoloji

- Kadınlarda %8–10 distressle (HSDD); erkeklerde %14–17.
- Yaşa bağlı artış; perimenopoz risk dönemi.

- Komorbidite: depresyon, antidepresan kullanımı (SSRI), ilişki sorunları.

4. Etiyoloji ve patogenez

- Biyolojik — hormonal (testosteron, östrojen), ilaca bağlı (SSRI, OK, antihipertansif), kronik hastalıklar.
- Psikolojik — depresyon, anksiyete, beden imajı, travma öyküsü.
- İlişki — çatışma, partner cinsel işlev bozukluğu.
- Sosyo-kültürel — yasak, bilgisizlik.

5. Klinik özellikler

- Spontan cinsel fantezi ve düşüncelerin azalması veya yokluğu.
- Başlatıcı olmama ve partnerin girişimine yanıt vermeme.
- Distress (kritik kriter — sadece düşük istek yeterli değil).

6. Tanı

6.1 Birleşik tanı ölçütleri (DSM-5-TR · ISSWSH)

A. Cinsel fantezi ve isteğin sürekli azalması veya yokluğu.

B. Süre ≥ 6 ay.

C. Klinik anlamlı sıkıntı.

D. Başka bir ruhsal bozukluk, ilaç veya tıbbi durumla daha iyi açıklanmaz.

6.2 Kaynaklar arasındaki farklar

- ISSWSH Process of Care (Clayton A.H. et al. Mayo Clin Proc 2018).
- DSM-5-TR kadınlarda istek ve uyarılma birleştirilmiştir (FSIAD).

6.3 Tanı algoritması

1. Klinik görüşme (cinsel ve ilişki öyküsü).
2. DSDS (Decreased Sexual Desire Screener) — kadınlarda 5 maddelik.
3. Hormonal değerlendirme (erkeklerde sabah testosteron; kadınlarda endike olduğunda).
4. İlaç ve komorbidite analizi.
5. Depresyon, anksiyete taraması.

6.4 Ayırıcı tanı

Durum	Ayırt edici
Hipogonadizm	Testosteron düşük + semptomlar.
Depresif bozukluk	Anhedoni, duygudurum bozukluğu.
SSRI indüklü	İlaca bağlı zaman.
Anorgazmi (HA02)	Orgazm bozukluğu dominant.
İlişki sorunu	Situativ.

7. Muayene ve değerlendirme

- DSDS, FSFI, IIEF.
- Hormonal panel.
- Depresyon/anksiyete ölçekleri.

8. Tedavi

8.1 Genel prensipler (ISSWSH 2018)

1. Biyolojik-psikolojik-sosyal yaklaşım — etiyolojiye göre multimodal.
2. Psikoterapi ve çift terapisi — BDT, mindfulness, sensate focus (Masters & Johnson).
3. İlaç değişikliği — SSRI kaynaklı durumda bupropion, mirtazapin, vortioksetin alternatif.
4. Kadınlarda farmakoterapi (premenopozal HSDD):
    - Flibanserin (100 mg gece) — FDA 2015 onayı; alkolle birlikte ağır hipotansiyon ve senkop riski (FDA 2019'da kara kutu uyarısını yumuşattı: 1–2 standart içkiden sonra en az 2 saat bekle, 3 ve üzeri içkide o akşamki dozu atla);
    - Bremelanotid (1,75 mg s/c gerektiğinde) — FDA 2019 onayı; melanokortin agonisti.
5. Kadınlarda postmenopozal: transdermal testosteron düşük dozda (off-label, uluslararası konsensus Davis S.R. 2019) — dikkatli izlem.
6. Erkeklerde: hipogonadizm doğrulanmış durumda TRT (≥ 2 sabah ölçümü düşük + semptomlar).
7. İlişki ve iletişim çalışması kritiktir.

8.2 Tedavi metodolojileri

1. Flibanserin — Serotonin 1A agonisti / 2A antagonisti; günlük gece dozu; premenopozal kadınlarda.
2. Bremelanotid — Melanokortin agonisti; s/c gerektiğinde.
3. Testosteron Kadınlarda (off-label) — Postmenopozal; düşük doz; izlem.
4. BDT ve Mindfulness (Farkındalık) — Brotto L.A. araştırmaları — kadın cinsel işlev bozukluğunda etkili.
5. Duygu Odağı (Sensate Focus) — Çift terapisi tekniği.

8.3 Kaynaklar arasındaki farklar

- Clayton A.H. et al. ISSWSH Process of Care. Mayo Clin Proc 2018.
- Davis S.R. et al. Global Consensus Position Statement on Testosterone Therapy for Women. J Clin Endocrinol Metab 2019.

9. Prognoz

Multimodal yaklaşımla çoğu hasta iyileşir; kronik formda sürekli strateji gereklidir.

10. Mit ve yanlış inançlar

Mit 1: “Düşük istek her zaman bir bozukluktur”

Kanıt: distress kritik ölçüt; distressiz düşük istek normal varyasyon — patolojik değil.

Mit 2: “Testosteron tüm kadınlar için istek artırıcıdır”

Kanıt: Davis 2019 konsensus — yalnızca postmenopozal HSDD'de düşük doz off-label; genel zamanlama resmi öneri değil.

Mit 3: “Flibanserin 'kadın Viagrası'dır”

Kanıt: mekanizması tamamen farklı (serotonerjik, SSS); günlük kullanım; etki mütevazı (sildenafil ile karşılaştırma yanlış).

Mit 4: “İstek işlev bozukluğu yalnızca psikolojik nedenledir”

Kanıt: SSRI, OK, antihipertansifler ve hormonal değişiklikler güçlü etki gösterir; biyolojik araştırma önemli.

Mit 5: "Reçetesiz 'afrodizyaklar' etkilidir"

Kanıt: Cochrane ve sistematik derlemeler — küçük veya yok etki; FDA uyarıları gizli bileşen.

11. Kaynaklar

1. WHO. ICD-11. HA00 Hypoactive sexual desire dysfunction. 2024.
2. APA. DSM-5-TR. 2022.
3. Clayton A.H. ve ark. The International Society for the Study of Women's Sexual Health Process of Care for Management of HSDD in Women. Mayo Clin Proc 2018;93(4):467–487.
4. Davis S.R. et al. Global Consensus Position Statement on the Use of Testosterone Therapy for Women. J Clin Endocrinol Metab 2019;104(10):4660–4666.
5. Basson R. The female sexual response: a different model. J Sex Marital Ther 2000;26(1):51–65.
6. Brotto L.A. Better Sex Through Mindfulness: How Women Can Cultivate Desire. Vancouver: Greystone Books, 2018.

ICD-11 **HA02.0**	**HA02.0 ANORGAZMİ** **Anorgasmia**
ICD-10 F52.3	Orgazm disfonksiyonu
DSM-5-TR F52.31 / F52.32	Kadında Orgazm Bozukluğu / Geciken Boşalma

1. Tanım ve nozoloji

Anorgazmi (ICD-11: HA02.0 Anorgasmia; DSM-5-TR kadınlarda Female Orgasmic Disorder F52.31; erkeklerde Delayed Ejaculation F52.32) — yeterli cinsel uyarılmadan sonra orgazma ulaşmada sürekli zorluk, gecikme veya yokluk; veya orgazm yoğunluğunda azalma.

Süre ≥ 6 ay; durumsal veya yaygın; yaşam boyu veya edinilmiş.

2. Tarihçe

- Masters & Johnson (1970) — orgazm fazı bozukluğunun klasik tanımı.

- ISSWSH ve ISSM kılavuzları.

3. Epidemiyoloji

- Kadınlarda %5–10 klinik anlamlı anorgazmi; erkeklerde gecikmiş ejakülasyon %1–4.
- Antidepresan (SSRI) kullanımında %30–70 cinsel yan etki.

4. Etiyoloji ve patogenez

- İlaca bağlı (SSRI, antipsikotik, opioid).
- Nörolojik (pelvik cerrahi, MS, diyabetik nöropati).
- Endokrin (hipotireoz, hiperprolaktinemi).
- Psikolojik — anksiyete, travma, bilgi eksikliği.
- Yaş ve hormonal değişiklikler.

5. Klinik özellikler

- Orgazma ulaşma güçlüğü veya yokluğu.
- Orgazm yoğunluğunun azalması.
- Distress, kaçınma.

6. Tanı

6.1 Birleşik tanı ölçütleri (DSM-5-TR)

A. Yeterli cinsel uyarılmadan sonra orgazm gecikmesi, yokluğu veya yoğunluğunun azalması — tüm veya neredeyse tüm durumlarda (%75–100).

B. Süre ≥ 6 ay.

C. Distress.

6.2 Kaynaklar arasındaki farklar

- ISSM Delayed Ejaculation Guideline.
- ISSWSH kadınlarda orgazm disfonksiyonu.

6.3 Tanı algoritması

1. Klinik görüşme (cinsel öykü, mastürbasyonda orgazm, partnerle orgazm).
2. FSFI (kadınlarda) / IIEF (erkeklerde).
3. İlaç ve komorbidite analizi.

4. Endokrin (testosteron, prolaktin, tireoid).

6.4 Ayırıcı tanı

Durum	**Ayırt edici**
HSDD (HA00)	İstek azalması baskın.
Retrograd ejakülasyon	Orgazm var, ejakülat mesaneye.
SSRI indüklü	İlaca bağlı zaman.
ED (HA01)	Ereksiyon bozukluğu.

7. Muayene ve değerlendirme

- FSFI, IIEF.
- Hormonal panel.
- Nörolojik ve ürolojik (edinilmiş şüphesi).

8. Tedavi

1. Etiyolojik yaklaşım — ilaç, endokrin, nörolojik nedenlerin yönetimi.
2. SSRI indüklü anorgazmi:
    - İlaç geçişi — bupropion, mirtazapin, vortioksetin alternatif;
    - Doz azaltma; “drug holiday” (SSRI'da dikkatle);
    - Bupropion adjunkt
    - Sildenafil adjunkt kadınlarda SSRI kaynaklı disfonksiyon — Nurnberg JAMA 2008 RKÇ.
3. Psikoterapi ve davranış — orgazm odaklı terapi (Heiman & LoPiccolo); BDT, mindfulness (Brotto L.A.).
4. Kadınlarda yönlendirilmiş mastürbasyon eğitimi — sistematik masturbasyon programı; vibratör.
5. Erkeklerde Gecikmiş Boşalma — psikoterapi, mastürbasyon paterninin modifikasyonu; spesifik FDA onaylı farmakoterapi yoktur.
6. Hormonal terapi yalnızca doğrulanmış eksiklikte.

8.1 Tedavi metodolojileri

1. Bupropion — SSRI kaynaklı anorgazmide ek tedavi veya geçiş.
2. Yönlendirilmiş Mastürbasyon (Directed Masturbation) — Heiman & LoPiccolo programı; kadınlarda primer anorgazmide etkili.

3. Mindfulness-BDT (Mindfulness-CBT) — Brotto araştırmaları; kadın cinsel işlev bozukluğunda.
4. Sildenafil Kadınlarda (off-label) — SSRI kaynaklı işlev bozukluğunda Nurnberg JAMA 2008.

8.2 Kaynaklar arasındaki farklar

- Brotto L.A. mindfulness araştırmaları.

9. Prognoz

Kadınlarda primer anorgazmi için yönlendirilmiş mastürbasyon %60–90 etkinlik; SSRI indüklü vakada ilaç stratejisi iyileşme sağlar.

10. Mit ve yanlış inançlar

Mit 1: "Kadın penetrasyonla orgazma ulaşmalıdır"

Kanıt: Çoğu kadın (~%70) klitoral stimülasyon gerektirir; tek penetrasyonla orgazm normal varyasyondur, anatomik norm değildir.

Mit 2: "Anorgazmi kadında 'soğukluk' belirtisidir"

Kanıt: anorgazmi çoğu zaman bilgi, teknik, anksiyete veya ilaca bağlıdır; karakter özelliği değildir.

Mit 3: "SSRI-indüklü anorgazmi geçicidir, tedavi gerektirmez"

Kanıt: süreklidir; ilaç geçişi veya adjunkt stratejiler etkilidir; devam eden distress klinik olarak anlamlı.

Mit 4: "Reçetesiz 'orgazm güçlendiricileri' etkilidir"

Kanıt: kanıt zayıf; FDA uyarıları gizli bileşen.

Mit 5: "Vibratör kullanımı hastayı partnerle orgazmdan mahrum eder"

Kanıt: Aksine, primer anorgazmi eğitiminde etkilidir; partnerle yakın ilişkiye entegre edilebilir.

11. Kaynaklar

1. WHO. ICD-11. HA02.0 Anorgasmia. 2024.
2. APA. DSM-5-TR. 2022.
3. Nurnberg H.G. et al. Sildenafil treatment of women with antidepressant-associated sexual dysfunction. JAMA 2008;300(4):395–404.

4. Brotto L.A. et al. Psychological and Interpersonal Dimensions of Sexual Function and Dysfunction. J Sex Med 2016;13(4):538–571.
5. Heiman J.R., LoPiccolo J. Becoming Orgasmic. Prentice Hall, 1988.

ICD-11 **HA20**	**HA20 CİNSEL AĞRI-PENETRASYON BOZUKLUĞU (VAGİNİSMUS)** **Sexual pain-penetration disorder**
ICD-10 F52.5	Organik olmayan vajinismus
DSM-5-TR F52.6	Genito-Pelvik Ağrı/Penetrasyon Bozukluğu

1. Tanım ve nozoloji

Cinsel ağrı-penetrasyon bozukluğu (vajinismus; ICD-11: HA20; DSM-5-TR Genito-Pelvik Ağrı/Penetrasyon Bozukluğu F52.6) — penetrasyon girişiminde: (a) zorluk, (b) genital veya pelvik ağrı, (c) ağrı korkusu, (d) pelvik taban kaslarında gerginlik. Klasik vajinismus ve disparoni bu birimde birleştirilmiştir.

Süre ≥ 6 ay; yaşam boyu veya edinilmiş.

2. Tarihçe

- Sims J.M. (1861) — vajinismus tanımı.
- Masters & Johnson (1970) — pelvik taban gerginliği.
- DSM-5 (2013) — vajinismus ve disparoni birleştirilerek GPPPD.
- ISSWSH ve ACOG kılavuzları.

3. Epidemiyoloji

- Kadınlarda %5–17 yaygınlık (klinik ve klinik olmayan örneklemlerde).
- Yaşam boyu vajinismus — genç kadınlarda, ilk penetrasyon denemesinde.
- Acquired — travma, enfeksiyon, atrofik vajinit, cerrahi sonrası.

4. Etiyoloji ve patogenez

- Biyolojik — atrofik vajinit (postmenopozal), vulvodini, endometriozis, enfeksiyon, cerrahi yara.
- Psikolojik — cinsel travma, anksiyete, yasak eğitimi, ağrı korkusu.
- İlişki ve partner faktörleri.

5. Klinik özellikler

- Penetrasyon sırasında pelvik taban kaslarının refleks gerginliği.
- Ağrı (yakıcı, kesici)
- Penetrasyondan kaçınma.
- Jinekolojik muayene de zor veya mümkün değil.

6. Tanı

6.1 Birleşik tanı ölçütleri (DSM-5-TR)

A. Aşağıdakilerden en az biri:

- Penetrasyon güçlüğü;
- Penetrasyon girişiminde veya sırasında vulvovajinal veya pelvik ağrı;
- Penetrasyon beklentisiyle ağrı korkusu;
- Penetrasyon girişiminde pelvik taban kaslarının gerginliği.

B. Süre ≥ 6 ay.

C. Distress.

6.2 Kaynaklar arasındaki farklar

- ISSWSH ve ACOG.

6.3 Tanı algoritması

1. Klinik görüşme (cinsel öykü, ağrı karakteri, travma).
2. Dikkatli jinekolojik muayene — dikkatle, hasta onamı ile.
3. Vulvodini taraması (Q-tip test).
4. Enfeksiyon, atrofik vajinit, endometriozis dışlaması.
5. Pelvik taban değerlendirmesi.

6.4 Ayırıcı tanı

Durum	Ayırt edici
Vulvodini	Lokalize vulva ağrısı, Q-tip pozitif.
Atrofik vajinit	Postmenopozal, östrojen eksikliği.
Endometrioz	Derin disparoni, dismenore.
Enfeksiyon (kandida, vajinoz)	Eksüdasyon, mikrobioloji.

7. Muayene ve değerlendirme

- Jinekolojik muayene.
- Pelvik taban değerlendirmesi.
- FSFI; ağrı skalaları.

8. Tedavi

1. Multidisipliner Yaklaşım — pelvik taban fizyoterapisi + BDT + eğitim.
2. Pelvik Taban Fizyoterapisi — biofeedback, manuel terapi, dilatör terapisi (kademeli boyut artışı).
3. BDT ve maruz bırakma terapisi — ağrı korkusu ve kaçınma; ter Kuile M.M. RKÇ.
4. Duyusal odaklanma ve çift terapisi.
5. Topik anestezik (lidokain) — provoked vulvodynia'da (Goldstein A.T.).
6. Atrofik vajinitte lokal östrojen.
7. Botulinum toxin A — refrakter vajinismusta; kanıt temeli artmaktadır.
8. Antidepresan/antikonvülzan (amitriptilin, gabapentin) — nöropatik komponentte.

8.1 Tedavi metodolojileri

1. Dilatör (genişletici) Terapisi — Kademeli ölçü artışı; gevşeme ile birlikte.
2. Pelvik Taban Fizyoterapisi — Biyofeedback, manuel terapi.
3. BDT/Ekspozisyon — Ağrı korkusu ve kaçınma.
4. Lokal Östrojen — Atrofik vajinitte.
5. Botoks (off-label) — Refrakter vajinismus; seçici.

8.2 Kaynaklar arasındaki farklar

- ter Kuile M.M. et al. CBT vaginismus.

- Goldstein A.T. et al. ISSWSH vulvodini konsensus.

9. Prognoz

Multidisipliner yaklaşımla prognoz iyi (%70–90); refrakter durumda botoks veya derinleştirilmiş psikolojik müdahale.

10. Mit ve yanlış inançlar

Mit 1: "Vajinismus partnere karşı duygusal reddediştir"

Kanıt: reflektor kas gerginliği — bilinçli kontrol dışı; suçlamak zararlıdır.

Mit 2: "Vajinismus tedavi edilemez"

Kanıt: BDT + dilatör + fizyoterapi kombinasyonu %70–90 etkinlik; ter Kuile RKÇ'leri.

Mit 3: "Tedavi penetrasyon sıklığını artırmak için yapılmalıdır"

Kanıt: hedef hastanın distressini azaltmak, kontrol ve seçim hissini geri kazandırmak; performans göstergesi değil.

Mit 4: "Lokal anestezik tüm cinsel ağrılarda etkilidir"

Kanıt: provoke edilmiş vulvodinide etkili; genel vajinismusta kullanım sınırlı — temel sorun kas gerginliğidir.

Mit 5: "Penetrasyon girişimini 'zorunlu egzersiz' yapmak yardımcı olur"

Kanıt: aceleci, ağrılı tekrarlama kaçınmayı ve korkuyu artırır; kademeli, kontrollü maruz bırakma etkilidir.

11. Kaynaklar

1. WHO. ICD-11. HA20 Genito-pelvic pain/penetration disorder. 2024.
2. APA. DSM-5-TR. 2022.
3. Ter Kuile M.M. et al. Therapist-aided exposure for women with lifelong vaginismus: a RCT. J Consult Clin Psychol 2013;81(6):1127–1136.
4. Goldstein A.T. et al. Vulvodynia: Assessment and Treatment. J Sex Med 2016;13(4):572–590.
5. Bergeron S. et al. Genital pain in women and men: It can hurt more than your sex life. Sex Med Rev 2020.

ICD-11 **HA40**	**HA40 CİNSEL İŞLEV BOZUKLUKLARI VE CİNSEL AĞRI BOZUKLUKLARINDA ETİYOLOJİK ETMENLER** **Aetiological considerations in sexual dysfunctions and sexual pain disorders**
ICD-10 F52.8	Organik hastalık veya bozukluğun sebep olmadığı diğer seksüel disfonksiyon
DSM-5-TR —	—

1. Tanım ve nozoloji

Cinsel işlev bozuklukları ve cinsel ağrı bozukluklarında etiyolojik etmenler (ICD-11: HA40) — başka bir fiziksel hastalık, ilaç, madde veya psikiyatrik bozukluk bağlamında ortaya çıkan cinsel işlev bozuklukları (istek, uyarılma, orgazm, ağrı alanlarını kapsayabilir). Spesifik HA01–HA20 kategorilerine uymayan veya birlikte olan durumlar.

Alt tipler (ICD-11): tıbbi durum, yaralanma ya da cerrahi/radyoterapi etkileri (HA40.0); psikolojik veya davranışsal etmenler, ruhsal bozukluklar dâhil (HA40.1); psikoaktif madde veya ilaç kullanımı (HA40.2); bilgi ya da deneyim eksikliği (HA40.3); ilişki etmenleri (HA40.4); kültürel etmenler (HA40.5); diğer belirlenmiş (HA40.Y).

2. Tarihçe

- DSM-5 (2013) — “Substance/Medication-Induced Sexual Dysfunction” resmileştirilmesi.
- 2000'ler — SSRI kaynaklı cinsel işlev bozukluğu geniş şekilde tanımlandı (Montejo A.L. araştırmaları).
- PSSD (Post-SSRI Sexual Dysfunction) — Bahrick A. (2008), EMA 2019 onayı.

3. Epidemiyoloji

- SSRI kullanımında cinsel işlev bozukluğu %30–70.
- Diyabetik erkeklerde ED %35–75.
- Kardiyovasküler hastalıklarda yüksek yaygınlık.
- Antipsikotik (özellikle risperidon, paliperidon) — hiperprolaktinemi sonucu.

4. Etiyoloji ve patogenez

- İlaçlar: SSRI, SNRI, antipsikotik (D2 blokajı, hiperprolaktinemi), antihipertansif (β-bloker, tiazid), opioid, 5α-redüktaz inhibitörleri (finasterid — Post-Finasteride Sendromu şüphesi), antikonvülzan.
- Maddeler: alkol, opioid, kannabis kronik, stimülanlar.
- Tıbbi hastalıklar: diyabet, kardiyovasküler, nörolojik (MS, Parkinson, spinal travma), endokrin (hipogonadizm, hiperprolaktinemi, tiroid), pelvik cerrahi ve radyoterapi, kronik böbrek yetmezliği.
- Ruhsal bozukluklar: depresyon, anksiyete, TSSB, şizofreni.

5. Klinik özellikler

- İstek azalması, uyarılma/ereksiyon bozukluğu, anorgazmi, ağrı — etiyolojiye göre.
- Zaman ilişkisi — ilaç/madde başlangıcı ile.
- PSSD — SSRI kesilmesinden sonra devam eden cinsel işlev bozukluğu, genital uyuşma.

6. Tanı

6.1 Birleşik tanı ölçütleri (DSM-5-TR)

A. Klinik anlamlı cinsel işlev bozukluğu semptomatolojisi.

B. Anamnez, fizik muayene veya laboratuvar sonuçlarından kanıt: semptomlar ilaç, madde veya tıbbi hastalığın doğrudan sonucudur.

C. Distress.

6.2 Kaynaklar arasındaki farklar

- Montejo A.L. et al. — SSRI indüklü disfonksiyon.
- EMA (2019) — PSSD'yi SSRI etiketine dahil etti.

6.3 Tanı algoritması

1. Tam ilaç ve madde öyküsü.
2. Tıbbi ve endokrin değerlendirme (testosteron, prolaktin, glukoz, HbA1c, lipid, tiroid).
3. Cinsel işlev ölçekleri (FSFI, IIEF, ASEX).
4. Ruhsal komorbidite taraması.
5. Pelvik muayene (kadınlarda).

6.4 Ayırıcı tanı

Durum	Ayırt edici
Primary HSDD/ED/Anorgazmi	Tıbbi ve ilaç kanıtı yoktur.
Depresif bozukluk	Anhedoni, duygudurum semptomları dominant.
PSSD	SSRI kesildikten sonra devam eden cinsel işlev bozukluğu.

7. Muayene ve değerlendirme

- Hormonal panel, glukoz, lipid.
- FSFI, IIEF, ASEX (Arizona Sexual Experience Scale).
- Pelvik veya ürolojik muayene endike olduğunda.

8. Tedavi

1. Etiyolojik yaklaşım — birinci sıra:
    - İlaca bağlı — doz azaltma, ilaç geçişi (bupropion, mirtazapin, vortioksetin, aripiprazol — antidepresan veya antipsikotik stratejilerinde);
    - Tıbbi durum yönetimi (diyabet, hipertansiyon, hipogonadizm).
2. Adjünkt farmakoterapi — sildenafil (PDE5) ED'de ve SSRI indüklü kadın disfonksiyonunda (Nurnberg JAMA 2008); bupropion adjünkt.
3. Hiperprolaktinemide — antipsikotik geçiş (aripiprazol, ketiapin) veya doz modifikasyonu; dopamin agonisti yalnızca endokrin yardımıyla.
4. Psikoterapi ve çift terapisi — psikojenik bileşende.
5. Hasta eğitimi ve bilgilendirilmiş onam — antidepresan ve antipsikotik başlamadan önce cinsel yan etkiler hakkında bilgi önemlidir.

6. PSSD — spesifik onaylanmış tedavi yoktur; klinik destek ve izlem; araştırma devam etmektedir.

8.1 Tedavi metodolojileri

1. İlaç Geçişi (Medication Switch) — SSRI → bupropion/mirtazapin/vortioksetin; risperidon → aripiprazol.
2. Sildenafil Adjunkt — SSRI kaynaklı işlev bozukluğu (erkek ve kadın); Nurnberg JAMA RKÇ.
3. Bupropion Adjunkt — İstek ve orgazm bozukluklarında.
4. Antipsikotik Geçişi (aripiprazol) — Hiperprolaktinemi durumunda.
5. Hasta Eğitimi (Patient Education) — Bilgilendirilmiş onam; uzun vadeli riskin tartışılması.

8.2 Kaynaklar arasındaki farklar

- Montejo A.L. et al. — antidepresan cinsel yan etki algoritmaları.
- EMA 2019 — PSSD risk bilgisi.
- NICE ve APA kılavuzları — antidepresan cinsel yan etkilerinin yönetimi.

9. Prognoz

Etiyolojik yönetim ve ilaç değişimi ile çoğu vaka düzelir; PSSD nadiren kalıcı kalabilir.

10. Mit ve yanlış inançlar

Mit 1: “Antidepresan cinsel yan etkileri 'geçici'dir ve müdahale gerektirmez”

Kanıt: Montejo araştırmaları — yan etkiler kalıcıdır (%30–70); aktif yönetim gerektirir.

Mit 2: “PSSD klinik bir birim değildir”

Kanıt: EMA 2019 — PSSD riski SSRI etiketine dahil edildi; klinik olarak tanınmış birimdir.

Mit 3: “Antipsikotik cinsel işlev bozukluğu herkes için aynıdır”

Kanıt: risperidon ve paliperidon yüksek hiperprolaktinemi riski; aripiprazol ve ketiapin daha az; geçiş etkilidir.

Mit 4: "Tıbbi hastalığa bağlı cinsel işlev bozukluğu yalnızca hastalığın sonucudur, müdahale yoktur"

Kanıt: diyabetik ED'de PDE5 etkilidir; kardiyovasküler rehabilitasyonda cinsel işlev iyileşir; aktif müdahale önemlidir.

Mit 5: "Antidepresana başlamadan önce cinsel yan etkileri tartışmaya gerek yok"

Kanıt: informed consent etik ve klinik gerekliliktir; sonradan ortaya çıkan yan etkiler hasta güvensizliği ve tedavi uyumunun azalmasına neden olur.

11. Kaynaklar

1. WHO. ICD-11. HA40 Aetiological considerations in sexual dysfunctions and sexual pain disorders. 2024.
2. APA. DSM-5-TR. 2022.
3. Montejo A.L., Llorca G., Izquierdo J.A., Rico-Villademoros F. Incidence of sexual dysfunction associated with antidepressant agents: a prospective multicenter study of 1022 outpatients. J Clin Psychiatry 2001;62(Suppl 3):10–21.
4. EMA. PRAC recommends new product information warnings on sexual dysfunction after SSRI/SNRI treatment. 2019.
5. Nurnberg H.G. et al. Sildenafil treatment of women with antidepressant-associated sexual dysfunction. JAMA 2008;300(4):395–404.
6. Bahrick A.S. Persistence of sexual dysfunction side effects after discontinuation of antidepressant medications. Open Psychol J 2008;1:42–50.

EKLER

EK A

İZLEM VE MUAYENE STANDARTLARI

Bu ek psikotrop ilaçların kullanımında güvenlik izlemi ve psikiyatri hastalarının tıbbi durumunun izlenmesi için standart protokolleri sunar.

A.1. Antipsikotik terapisinde metabolik izlem

Atipik antipsikotikler – özellikle olanzapin, ketiapin, klozapin – metabolik sendrom riskini artırır (kilo artışı, dislipidemi, insülin direnci, diyabet).

Monitörizasyon tablosu (APA/ADA 2004, ADA/APA/AACE/NAASO uzlaşısı):

Parametre	Başlangıç	4 hafta	8 hafta	12 hafta	Üç aylık	Yıllık
Kişisel/ aile öyküsü	✓					✓
Kilo, bel çevresi	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Arteriyel basınç	✓			✓		✓
Açlık glukozu	✓			✓		✓
Açlık lipid profili	✓			✓		✓ (2 yılda bir)

Eğer anormallik saptanırsa:

- Kilo alımı ≥%7: ilaç değişimine bak (aripiprazol, ziprasidon – metabolik nötr);
- HbA1c ≥%6,5 veya açlık glukozu ≥7: diyabet konsültasyonu;
- LDL ≥3,4 mmol/L: diyet, statin.

Klozapine özgü izlem (agranülositoz nedeniyle):

süre, zaman	sıklık, hızlılık, çabukluk
İlk 6 ay	Haftalık WBC ve mutlak nötrofil (ANC)
7–12 ay	2 haftada bir
12+ ay	Aylık

ANC göstergeleri:

- ≥2,0 × 10^9/L: normal – tedaviye devam et;
- 1,5–2,0: haftalık izlem;
- 1,0–1,5: 2 günde bir izlem, hematolog konsültasyonu;
- <1,0: ilaç durdurulur, hematolog müdahalesi.

Antipsikotiklerde EKG takibi

- QTc uzaması riski: özel ziprasidon, haloperidol IV, ondansetron kombinasyonu;
- Başlangıç EKG Risk faktörleri olan hastalarda (kalp hastalığı, elektrolit bozukluğu, >65 yaş);
- QTc >500 msn ya da bazdan >60 msn artış — İlaç değişikliği;
- Riski artıran ilaçlar: klorpromazin, haloperidol (yüksek), tioridazin.

Hiperprolaktinemi:

- Risperidon, amisulprid, paliperidon — yüksek risk
- Semptomlar: amenore, galaktore, cinsel disfonksiyon, osteoporoz;
- Bazal prolaktin; tekrarlayan semptomla.

A.2. Lityum izlemi

Dar terapötik pencere — seviye 0,6–1,2 mEq/L, >1,5 toksik.

Parametre	Başlangıç	Her 6 ay	Yıllık
Lityum seviyesi	Haftalık 1. ay, sonra her 6 ay	✓	
Kreatinin, eGFR	✓	✓	
TSH	✓	✓	

Parametre	Başlangıç	Her 6 ay	Yıllık
Elektrolitler	✓	✓	
Kalsiyum	✓		✓
EKG	✓ (50+ yaş)		
Gebelik testi	Doğum yaşında kadın		

Lityum intoksikasyonu belirtileri:

- Tremor (daha güçlü);
- Taşikardi;
- İshal, kusma;
- Yavaş, karışık konuşma;
- Ataksi;
- Konvülsiyon – ağır durumlarda.

Durum değişikliğinde seviye kontrol et: dehidratasyon, NSAİİ eklenmesi, ACE inhibitörü eklenmesi, böbrek fonksiyonunda değişiklik.

A.3. Antikonvulsantlar (valproat, karbamazepin, lamotrijin)

Valproat:

Parametre	Başlangıç	Her 6 ay
CBC (trombositopeni)	✓	✓
Karaciğer fonksiyonu (AST, ALT)	✓	✓
Valproat düzeyi		Semptom veya şüphe ile
Pankreatit belirtilerinin izlenmesi		Her ziyaret
Gebelik testi	**KESİNLİKLE doğurgan yaştaki kadında**	**Her çeyrek**

Kritik: valproat doğurganlık çağındaki kadınlarda nöral tüp defekti ve kognitif hasar nedeniyle yalnızca etkili kontrasepsiyon ile, diğer seçenekler önce değerlendirildikten sonra.

Karbamazepin:

- CBC, karaciğer – başlangıç, 1 ay, üç aylık;
- HLA-B*1502 testi Asya kökenli hastalarda (Stevens-Johnson riski);
- Oto-indüksiyon nedeniyle seviye düşüşü ilk 4 haftada – seviye kontrol et.

Lamotrijin:

- Yavaş titrasyon — Stevens-Johnson sendromu riski;
- Başlangıç 25 mg haftada, 4–8 hafta içinde hedef doza;
- Valproat ile birlikte: başlangıç 12,5 mg — valproat lamotrijin metabolizmasını yavaşlatır
- Deri reaksiyonu olursa – hemen durdur.

A.4. SSRI ve SNRI izlemi

- Hiponatremi riski — özellikle yaşlılarda, diüretik kullananlarda
- Bazal Na, 1 ay sonra, sonra semptom ile;
- İntihar eğiliminde artış özellikle 25 yaş altı başlangıçta – ilk 1-2 ay yakın izlem;
- QTc uzanma — essitalopram, sitalopram (yüksek dozlarda);
- Serotonin sendromu (MAOİ veya triptan vb. kombinasyonda) – belirtilerin öğretilmesi.

A.5. Benzodiazepin kullanımı

- Maksimum süre: 2–4 hafta;
- Uzun süreli kullanımda bağımlılık kaçınılmazdır;
- Azaltma şeması (tapering): %25 her 2 haftada, bazen daha yavaş;
- Geri tepki semptomları. (rebound anxiety, uykusuzluk, tremor) normal ve geçicidir.

A.6. Psikoterapi izlemi

Kalite göstergeleri:

- Seansın süresi, sıklığı;
- Hasta semptom ölçekleri (PHQ-9, GAD-7 vb.) her 4–6 haftada;
- İşlevsel göstergeler;
- Terapötik ilişki değerlendirmesi (Working Alliance Inventory);
- Dış hedeflere ulaşma;
- Relaps belirtileri.

Süpervizyon ve meslektaş danışması — karmaşık olgularda ve klinisyenin kendi isteğiyle.

EK C

PSİKİYATRİK ACİL DURUMLAR

Acil durumda zaman yoktur: karar dakikalarla ölçülür ve neredeyse her zaman eksik bilgiyle verilir. Bu ek tam da o dakikalar için yazıldı — ne yapılması gerektiğini hatırlatan kısa listeler, uzun muhakeme değil. Listeler klinik düşünceyi değiştirmez; aceleyle atlanması en kolay adımdan sizi korur.

C.1. Aktif intihar riski

İntihar riskini değerlendirmek bir anket değil, bir konuşmadır. Doğrudan sorun: soru düşünceyi "telkin etmez", çoğu zaman hastaya bunu ilk kez yüksek sesle söyleme imkânı verir. Asıl dinlediğiniz şey, niyetin ne kadar somutlaştığıdır.

Birincil değerlendirme:

- İntihar düşüncesi var mı? Plan? Araç?
- Planın somutluğu: hasta zamanı, yeri ve aracı adlandırıyorsa risk keskin biçimde artar; genel bir "bazen ölmek istiyorum" ifadesi başka bir düzeydir;
- Önceki girişimler — en güçlü prediktör
- Madde intoksikasyonu — inhibisyon azalır;
- Protektiv faktorlar — aile, dini inançlar, gelecek planları.

Yüksek risk belirtileri:

- Belirli plan + araçlara erişilebilirlik;
- Yakın durum değişikliği (kayıp, ağır hastalık);
- Yalnızlık + öfke;
- Psikoz veya ağır depresyon;
- Yeni başlangıç veya derin hipomania (enerji geri gelir + düşük mood kalır);
- Erişkin erkek + engellilik + alkol

Yönetim:

Düşük-orta risk:

- Güvenlik planı — yazılı

- Araçlara erişilebilirliğin azaltılması (silah uzaklaştırılması, ilaç küçük miktarlarda);
- Yakın ayaktan izlem (24-48 saatte yeniden);
- Kriz hattı numarası;
- Aile katılımı (rızayla).

Yüksek risk:

- Hastaneye yatırma (gönüllü veya zorunlu);
- Yakın gözetim – 1:1 eğer çok yüksek;
- İntihar yöntemlerinin ortadan kaldırılması (kesici alet, ip, pencere);
- Kontrollü ilaç alımı.

Zorunlu hastaneye yatış Azerbaycan çerçevesinde:

- "Psikiyatrik yardım hakkında" Azerbaycan Cumhuriyeti kanunu;
- Zorunlu hastaneye yatış için iki psikiyatristin kararı ve hukuki prosedür;
- 72 saat acil gözlem sonrası mahkeme kararı.

C.2. Deliryum tremens ve alkol yoksunluğu

Semptomlar:

- Tremor — eller, sonra genel
- Anksiyete, ajitasyon;
- Halüsinasyon — görsel, dokunsal ("böcekler üzerimde");
- Dezoryantasyon;
- Otonom hiperaktivlik — taşikardi, tansiyon, terleme, ateş
- Nöbetler (~%5–10).

Tedavi (YBÜ veya DYBÜ koşullarında):

- Benzodiazepin — diazepam 10-20 mg IV/IM her 15-20 dk Sedasyon elde edilene kadar; sonra idame rejimi;
- Alternatif: lorazepam (karaciğer disfonksiyonu olanlarda);
- Tiamin 100-300 mg IV — Wernicke ensefalopatisinin önlenmesi. Glukoz vermeden önce.
- Sıvı ve elektrolit restorasyonu;
- Magnezyum sülfatı, potasyum – çoğu zaman düşük;

- Mortalite: tedavi edilmezse %15-20, uygun tedavi ile <%1.

CIWA-Ar skalası – izlemde.

C.3. Serotonin sendromu

Neden: SSRI + MAOİ, SSRI + triptan, SSRI + tramadol, SSRI + linezolid, SSRI + metilen mavisi vb.

Semptomlar:

- Mental değişiklik — ajitasyon, konfüzyon;
- Otonom — taşikardi, hipertansiyon, hipertermi, terleme
- Neyromuskulyar — tremor, hiperrefleksi, klonus (alt ekstremite – özel belirti).

Tedavi:

- Neden olan ilacın hemen kesilmesi;
- Destek – sıvılar, elektrolit, soğutma;
- Şiddetli durumlar Siproheptadin 12 mg başlangıç, 2 mg her saat maksimum 32 mg/gün;
- İnvaziv müdahale (entübasyon) ağır hipertermide.

C.4. Antipsikotik Malign Sendrom (NMS)

Neden: antipsikotikler (özellikle yüksek güçlü, haloperidol), akut başlangıç veya doz artışı.

Semptomlar (4 ana):

1. Kas sertliği (“kurşun boru”);
2. Hipertermi (38–42°C);
3. Otonom değişkenlik (yüksek arteriyel tansiyon, taşikardi, terleme);
4. Mental durum değişikliği (konfüzyon → stupor → koma).

Laboratuvar: CPK akut yüksek (>1000), mioglobinüri, lökositoz, ALT/AST yüksek.

Tedavi (YBÜ):

- Antipsikotiğin hemen kesilmesi

- Soğutma;
- Sıvılar (rabdomiyoliz ve akut böbrek yetmezliği riski);
- Dantrolen 1-2,5 mg/kg IV – kas sertliğini azaltır;
- Bromokriptin 2,5-5 mg her 8 saat – dopamin agonisti;
- EKT yanıtsız durumlarda.

Ölümcüllük: %5-20 yeterli tedavi ile.

C.5. Akut distoni

Neden: antipsikotik başlangıcı, özellikle güçlü D2 antagonistleri.

Semptomlar:

- Akut kas spazmları – boyun (tortikollis), dil, göz (okülojirik kriz), belirli yemek borusu spazmı;
- Hayat tehlikesi – laringeal spazm.

Tedavi:

- Difenhidramin 50 mg IM/IV – 15 dakikada rahatlama;
- Benztropin 1-2 mg IM/IV;
- Antipsikotiğin dozunun azaltılması veya değiştirilmesi
- Profilaktik antikolinerjik riskli hastalarda.

C.6. Akut mani ve psikomotor ajitasyon

Yönetim:

- Oral tercih: haloperidol 2-5 mg + lorazepam 1-2 mg;

- IM endikasyonu: haloperidol 5 mg + lorazepam 2 mg (50/50 enjektör) veya olanzapin IM 10 mg;

- Güvenli ortam — sakin, uyarandan bağımsız
- Verbal de-eskalasyon ilk adım;
- İlaç:
- Gönülsüz hastaneye yatırma Talimatla;
- Fiziksel kısıtlama — yalnızca son çare, yaşam tehlikesi varsa ve kısa süreli.

C.7. Akut psikoz

Yukarıdakine benzer protokol. Diferansiyel: organik nedenler, madde intoksikasyonu, postpartum psikoz, NMS.

C.8. Katatoni

Semptomlar:

- Stupor, mutizm;
- Katalepsi (“mum durumu”);
- Negativizm;
- Manerizmler, stereotipiler;
- Ekolali, ekopraksi.

Birinci basamak tedavi:

- Lorazepam 1-2 mg IV/IM test — 1-2 saat içinde anlamlı yanıt → katatoni tanısı ve tedavi;
- Yanıt alınırsa – 4-24 mg/gün doza çıkarmak;
- Yanıtsız – ECT sıra, çok etkili;
- Antipsikotikten kaçınmak akut fazda – NMS uygulamasını provoke edebilir.

Nedenini ara: organik (ensefalit, epilepsi), duygudurum bozukluğu, şizofreni, otizm, bazı maddeler.

EK D

ASKERİ-TIBBİ UZMANLIK (AZERBAYCAN'DA)

Bu ek Azerbaycan Cumhuriyeti'nde askerlik hizmetine uygunluk değerlendirmesi için psikiyatrik açılardan pratik bir rehber sunmaktadır.

D.1. Yasal dayanak

- "Askerlik çağrısı hakkında" Azərbaycan Respublikası Qanunu
- Askeri-tıbbi ekspertiz hakkında Yönetmelik;
- Savunma Bakanlığının normatif düzenlemeleri;
- Hastalıkların tablosu — yarıya bölünür: hafif/ağır dereceler, A-D gruplarına

D.2. Psikiyatrik değerlendirme yapısı

Temel ekspertiz:

- Şikayetler ve anamnez (hasta ve yakın akrabaları);
- Önceki tıbbi belgeler;
- Klinik görüşme ve mental durum muayenesi;
- Deneysel-Psikolojik İnceleme (EPM) – psikolog tarafından;
- Laboratuvar ve enstrümantal incelemeler gerektiğinde;
- Ayırıcı tanı, tanı ve hastalığın derecesinin değerlendirilmesi;
- Sonuç.

Tipik psikolojik testler (EPM):

- MMPI-2 (Minnesota Multiphasic Personality Inventory-2) – kişilik profili;
- Raven progresif matrisleri — zeka;
- Luriya testleri — hafıza, dikkat
- Wechsler IQ ölçeği (WAIS);
- Rorschach testi — projektif yöntem (güncel güvenilirliği tartışmalıdır);
- Beck, Hamilton ölçekleri — duygudurum

D.3. Psikiyatrik bozukluklar ve askerlik hizmetine uygunluk değerlendirmesi

Gruba göre sınıflandırma (adaptasyon – yerel normatif düzenlemeler esas alınarak):

A grubu – askerliğe tam uygun

Psikiyatrik öykü yok veya hafif geçici sorunlar.

B grubu – sınırlı yararlı

- Hafif kişilik özellikleri (bozukluk eşiğine ulaşmayan);
- Geçici uyum bozuklukları;
- Hafif uyku bozuklukları;
- Remisyon durumunda nevrotik bozukluklar.

V grubu – hizmet sırasında sınırlı

- Kısmi remisyonda orta psikiyatrik bozukluklar;
- Belirli kişilik bozuklukları;
- Geçmiş TSSB, kompanse edilmiş;
- Orta derecede nörokognitif disfonksiyon.

Q grubu – hizmete elverişsiz

- Şizofreni spektrumu;
- Bipolar bozukluk;
- Ağır depresyon
- Aktif TSSB/kompleks TSSB (Karabağ savaşı gazileri – ayrı tedavi programı);
- Madde kullanımı bozuklukları;
- Ağır kişilik bozuklukları;
- Mental gerilik;
- Otizm spektrumunun ağır formları;
- Aktif intihar riski olan bozukluklar;
- Parafilik bozukluklar (şiddetli, aktif).

D.4. Doğum sonrası travma ve gazi değerlendirmesi

Karabakh savaşı gazilerinde:

- Karmaşık TSSB yüksek yaygınlık — travma odaklı müdahale
- Alkol ve madde kullanımı komorbid;
- Depresyon, intihar riski;
- Aile işlev bozukluğu;
- Moral zorlanma — savaş zamanı etik çatışma (öldürme, tanık olma);
- Yanma ve tekrar-travmatizasyon risk faktörleri.

Spesifik rehabilitasyon programları:

- Kanıtlanmış travma terapisi (PE, CPT, EMDR);
- Grup terapisi gazilere;
- Aile terapisi;
- İlaç (SSRI/SNRI);
- Sosyal rehabilitasyon (iş, eğitim).

EK E

İLGİLİ NÖROLOJİK DURUMLAR

Psikiyatri ve nörolojinin kesiştiği alanlarda klinik pratik için önemli olan nörolojik hastalıkların kısa tanımı.

E.1. Epilepsi (G40) ve psikiyatrik belirtiler

Epileptik sendromlar ve psikiyatri:

- İnter-iktal kişilik değişiklikleri (Geschwind sendromu – hiperreligiosite, hipergrafi, "viskozite");

- İnter-iktal psikoz – uzun süreli TLE;

- Post-iktal psikoz – nöbet sonrası 24-72 saat içinde psikotik epizodlar;

- İktal anksiyete ve disosiyatif deneyimler;

- Temporal lob epilepsisi (TLE) — en çok psikiyatrik komorbidite
- Absans epilepsisi — dikkat sorunu, DEHB ile diferansiyel;
- Juvenile miyoklonik epilepsi — yüksek komorbid anksiyete, dürtüsellik

Psikogen (non-epileptik) tutmalar (PNES) – disosiyatif nörolojik semptom bozukluğu (6B64.4):

- Video-EEG — altın standart diferansiyel
- PNES – epilepsi ile sık komorbid, %10-30;
- Tedavi: BDT-PNES, antikonvülzanlardan yavaş kesilme.

Antiepileptiklerin psikiyatrik yan etkileri:

- Levetirasetam: agresyon, irritabilite, depresyon;
- Fenobarbital, primidon: depresyon, kognitif yavaşlama;
- Topiramat: kognitif disfonksiyon, depresyon;
- Lamotrijin: Yine duygudurum stabilize eder.

E.2. Baş ağrısı ve psikiyatrik komorbidite

- Migren — depresyon riski 2-4× yüksek; anksiyete bozuklukları;

- Küme baş ağrısı — depresyon, intihar riski;
- Kronik günlük baş ağrısı — analjezik aşırı kullanımı (MOH) – duygudurum bozukluğu komorbid sık;
- Tekrarlayan gerilim baş ağrısı — yoğun stres, anksiyete ile ilişkili

Yönetim:

- SSRI/SNRI birçok baş ağrısı tipini iyileştirir;
- TCA (amitriptilin) profilaktik migren için tarihsel standart;
- Topiramat, valproat profilaktik;
- BDT kronik baş ağrısında etkilidir;
- Opioidlerden ve aşırı analjezik kullanımından kaçınmak.

E.3. Beyin-damar hastalıkları (inme)

- Post-stroke depresyon: %30-40 ilk yıl;
- Post-stroke mania: nadir, sağ frontal veya talamik lezyonlarda;
- Pseudobulbar affekt (patolojik gülme/ağlama): dekstrometorfan-kinidin kombinasyonu onaylı tedavidir;
- Vasküler kognitif bozukluk/demans: 6D81 altında sınıflandırma;
- Rehabilitasyon: multidisipliner, psikiyatrik destek merkezi rolünde.

E.4. Parkinson hastalığı

- Depresyon: %30-50;
- Anksiyete: %30-40;
- Dopamin agonisti kaynaklı dürtü kontrol bozukluğu: %13-36;
- Parkinsonda psikoz: temel olarak görsel halüsinasyonlar; levodopa-induksiyon;
- Parkinsonda demans: 6D85;
- REM uyku davranış bozukluğu: Parkinson için erken belirteç.

Tedavi özellikleri:

- Antipsikotiklerin Parkinson'da kullanımı ketiapin, klozapin (D2 minimal blokaj);
- Haloperidol, risperidon — motor semptomları kötüleştirir;
- SSRI depresyon için;

- Pimavanserin — ABD'de Parkinson psikozu için onaylı.

E.5. Multipl skleroz (MS)

- Depresyon: %30-50;
- Anksiyete: %30;
- Bipolar benzeri semptomlar: %5-10;
- Pseudobulbar affekt;
- Kognitif disfonksiyon — hastalığın çoğunda
- Uyuşukluk ve yorgunluk — depresyon ile sıkı, diferansiyel zor.

İnterferon-beta tedavisi depresyonu kötüleştirir – aktif izlem.

E.6. Travmatik beyin hasarı (TBH)

- Post-konkussion sendromu: baş ağrısı, baş dönmesi, bellek sorunları, duygudurum değişiklikleri;
- Kronik travma ensefalopatisi (CTE): tekrarlayan yaralanmalar, spor (boks, Amerikan futbolu);
- TSSB + TBZ — çok sık komorbid
- Kişilik değişikliği (6E68) – frontal lezyonlarda.

E.7. Demans (detaylı Bölüm 17'de)

- 6D80 Alzheimer;
- 6D81 Vasküler;
- 6D82 Lewy cisimciği;
- 6D83 Frontotemporal;
- 6D84 Madde-ilişkili;
- 6D85 Parkinson ile;
- 6D86 Demanslarda davranış/psikolojik bozukluklar (BPSD).

E.8. Nöbetler, hareket bozuklukları ve psikiyatri

- Tourette sendromu (8A05.00) — ICD-11'de nörolojik hastalıklar bölümünde, ancak DEHB, OKB ile komorbid çok yüksek;

- Wilson hastalığı — bakır metabolizmasının genetik bozukluğu; psikiyatrik prezentasyon (depresyon, psikoz) sık; testi – seruloplazmin, 24 saatlik idrar bakırı;
- Huntington hastalığı — duygudurum bozuklukları, OKB, psikoz, motor kore

GENEL KAYNAKLAR VE LİTERATÜR

Temel ICD-11 ve DSM-5 kaynakları

1. WHO. ICD-11 Ruhsal, Davranışsal ve Nörogelişimsel Bozukluklar için Klinik Tanımlamalar ve Tanı Kriterleri (CDDR). Cenevre: Dünya Sağlık Örgütü; 2024. ISBN: 9789240077263.
2. APA. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 5th Edition, Text Revision (DSM-5-TR). APA Publishing; 2022.
3. First MB, Reed GM, Hyman SE, Saxena S. ICD-11 Ruhsal ve Davranışsal Bozukluklar için Klinik Tanımlamalar ve Tanı Kılavuzlarının geliştirilmesi. *World Psychiatry*, 2015; 14: 82–90.
4. Reed GM, et al. ICD-11 ruhsal, davranışsal ve nörogelişimsel bozukluklar sınıflandırmasındaki yenilikler ve değişiklikler. *World Psychiatry*, 2019; 18: 3–19.

Klinik psikiyatri ders kitapları

1. Popov Yu.V., Vid V.D. Modern klinik psikiyatri. (Современная клиническая психиатрия) 2. baskı. Sankt-Peterburg: Reç, 2006.
2. Sadock BJ, Sadock VA, Ruiz P. *Kaplan and Sadock's Comprehensive Textbook of Psychiatry.* 11th ed. Wolters Kluwer; 2023.
3. Gelder MG, Andreasen NC, Lopez-Ibor JJ, Geddes JR (eds). *New Oxford Textbook of Psychiatry.* 3rd ed. Oxford UP; 2020.
4. Cowen P, Harrison P, Burns T. *Shorter Oxford Textbook of Psychiatry.* 7th ed. Oxford UP; 2018.

Azerbaycan dilinde kaynaklar

1. Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi “Psikiyatrik hastaların muayene ve tedavi düzeni” ile ilgili normatif belgeler.
2. “Psikiyatrik yardım hakkında” Azerbaycan Cumhuriyeti Kanunu (2001, değişikliklerle).

Pratik klinik kılavuzlar (guidelines)

1. NICE (UK) Klinik Kılavuzlar – psikiyatrik durumlar için: CG31 OKB, CG78 Sınırda KB, CG90 Depresyon, CG113 YAB, CG115 Alkol, CG158 Davranış bozuklukları, NG69 Yeme bozuklukları, NG116 TSSB, CG111 Enürezis.
2. APA Practice Guidelines – şizofreni, BPD, MDD, yeme bozuklukları, Alzheimer.
3. WFSBP Guidelines – bipolar, şizofreni, OKB, TSSB, parafilik bozukluklar.
4. ISTSS (International Society for Traumatic Stress Studies). *PTSD Prevention and Treatment Guidelines.* 3rd ed. 2019.
5. CANMAT/ISBD. Canadian Network for Mood and Anxiety Treatments / International Society for Bipolar Disorders Treatment Guidelines. 2018, 2023.
6. AACAP Practice Parameters – çocuk ve ergen psikiyatrik bozuklukları.

Temel peer-review dergileri

1. *American Journal of Psychiatry* (APA)
2. *World Psychiatry* (WPA)
3. *Lancet Psychiatry*
4. *JAMA Psychiatry*
5. *British Journal of Psychiatry*
6. *Psychological Medicine*
7. *Journal of Clinical Psychiatry*
8. *European Psychiatry*

Onlayn resurslar

1. ICD-11: https://icd.who.int
2. MGH Center for Women's Mental Health: https://womensmentalhealth.org
3. Cochrane Library: psikiyatrik sistematik gözden geçirmeler
4. UpToDate Psychiatry — klinik başvuru kaynağı
5. Psychiatry Online (APA Publishing) — ders kitapları, kılavuzlar
6. Columbia Suicide Severity Rating Scale: https://cssrs.columbia.edu

Bakü, 2026

ragimoff.org

EK B

NÖROGELİŞİMSEL BOZUKLUKLARIN TARAMA ÖLÇEKLERİ

Kullanım kuralları: Bu ölçekler tanısal değil, tarama araçlarıdır. Pozitif sonuç – uzmanlaşmış klinik değerlendirme için endikasyondur, tanı değil. Kesin tanı klinik görüşme, ayrıntılı değerlendirme ve (gerekirse) standartlaştırılmış tanı araçları (ADOS-2, ADI-R, WISC-V vb.) ile konulur.

Lisans statusu (Sorumluluk reddi): Bu ekte tam metinle sunulan ölçekler (M-CHAT-R, AQ-10, ASRS v1.1, SNAP-IV) bilimsel araştırma ve klinik kullanım için geliştiriciler tarafından açıkça sunulmuş araçlardır. Bu kitap tanı testleri koleksiyonu değil, klinik bir kılavuzdur: lisanslı araçlar (WISC-V, ADOS-2, Vineland-3 vb., bkz. B.5) metinde yeniden üretilmemiştir; bunların elde edilmesi ve kullanılması hak sahibinden (Pearson, WPS, MHS vb.) resmi lisans alınmasını ve uzman bir profesyoneli gerektirir.

B.1. M-CHAT-R: Otizm Spektrumu için Düzeltilmiş Tarama Listesi (16–30 aylık çocuklar)

Orijinal yazarlar: Diana L. Robins, Deborah Fein, Marianne Barton, 2009.

Orijinal kaynak: Robins DL, Fein D, Barton M. M-CHAT-R/F. Self-published, 2009; Pediatrics, 2014; 133: 37–45.

Talimat

Bu anket çocuğunuzun günlük davranışı hakkında 20 sorudan oluşmaktadır. Ebeveyn veya birincil bakıcı tarafından doldurulur. Her soruya EVET veya HAYIR olarak yanıt verin — çocuğunuzun genellikle nasıl davrandığına göre. Eğer davranışı bir-iki kez gördüyseniz, ancak genel olarak çocuk böyle yapmıyorsa, HAYIR yanıtlayın.

Sorular

№	Soru	Evet	Hayır
1	Eğer siz odanın diğer tarafındaki bir şeye bakarsanız, çocuğunuz da oraya bakar mı? (Örneğin, uçan uçağa, büyük hayvana veya oyuncağa)		
2	Hiç çocuğunuzun sağır olduğunu düşündünüz mü?		
3	Çocuğunuz hayali oyunlar oynuyor mu? (Örneğin, boş bir fincandan içmek gibi, telefonla konuşmak gibi, bebeğe yemek vermek gibi)		
4	Çocuğunuz eşyalara tırmanmayı seviyor mu? (Örneğin, merdiven, ağaç)		
5	Çocuğunuz avuçlarını, parmaklarını veya vücudunun diğer kısımlarını gözünün önünde alışılmadık hareketlerle yapıyor mu?		

№	Soru	Evet	Hayır
6	Çocuğunuz istediği bir şeyi işaret ediyor mu? (Örneğin, büfeden uzaktaki bir oyuncak için)		
7	Çocuğunuz ilginç bir şeye dikkatinizi çekmek için işaret ediyor mu? (Örneğin, gökyüzündeki uçak veya büyük bir araba)		
8	Çocuğunuz diğer çocuklara ilgi gösteriyor mu? (Örneğin, oyun parkında çocuklara bakar, onlara katılmaya çalışır)		
9	Çocuğunuz size bir şey göstererek veya önünüze koyarak sizinle paylaşıyor mu (bunu yardım için değil, paylaşmak için yapıyor)?		
10	Çocuğunuz adı çağrıldığında cevap veriyor mu?		
11	Çocuğunuza gülümsediğinizde, o da size gülümsüyor mu?		

№	Soru	Evet	Hayır
12	Çocuğunuz günlük seslerden rahatsız oluyor mu? (Örneğin, elektrik süpürgesi, yüksek sesli müzik)		
13	Çocuğunuz yürüyor mu?		
14	Çocuğunuz siz onunla, onun kıyafetini giydirirken veya oynarken gözlerinize bakar mı?		
15	Çocuğunuz sizin yaptıklarınızı taklit ediyor mu? (Örneğin, siz yüzünüze bir hareket yaptığınızda, o da aynı şeyi yapar)		
16	Çocuğunuz bir şey duyduğunda ne olduğunu görmek için size bakar mı?		
17	Çocuğunuz dikkatinizi çekmeye çalışıyor mu? (Örneğin, size bakmak, övgü almak için, “bak” demek)		

№	Soru	Evet	Hayır
18	Çocuğunuz anladığı kelimelere tepki veriyor mu? (Örneğin, "topu ver" veya "kitabı al" dendiğinde)		
19	Eğer bir şey yeni veya garip olursa, çocuğunuz sizin tepkinizi görmek için yüzünüze bakar mı?		
20	Çocuğunuz hareketli oyunları sever mi? (Örneğin, havada zıplamak, dizinize hoplamak)		

Hesaplama

Risk puanı = HAYIR yanıtlarının sayısı, İstisna olarak 2, 5 ve 12. soru için HAYIR – risk belirtisidir (bu üç soruda EVET yanıtı risk sayılır).

Yani:

- 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. sorularda HAYIR yanıtı risk belirtisi olarak kabul edilir.
- 2, 5, 12. sorularda EVET cevabı risk belirtisi olarak kabul edilir.

Sonuçların yorumlanması

Puan	Risk düzeyi	Tavsiye
0–2	Düşük risk	Ek değerlendirme gerekmez (diğer risk faktörleri yoksa); 24 aya kadar yeniden tarama önerilir

Puan	Risk düzeyi	Tavsiye
3–7	Orta risk	**M-CHAT-R/F (Follow-up) gereklidir** — yapılandırılmış takip görüşmesi; sağlık çalışanı tarafından yürütülür
8–20	Yüksek risk	**Acil OSB tanısal değerlendirmesi ve erken müdahale programına yönlendirme gereklidir**

Not: M-CHAT-R – Azerbaycan dilinde çeşitli kliniklerde kullanılır, ancak resmi validasyon Azerbaycan popülasyonunda sınırlıdır. Yukarıdaki çeviri klinik pratik içindir; bilimsel araştırmalarda orijinal resmi çeviri kullanılmalıdır (resmi çeviriler için: https://mchatscreen.com).

B.2. AQ-10: Kısa Otizm Spektrumu Değerlendirmesi (16 yaş+)

Orijinal yazarlar: Carrie Allison, Bonnie Auyeung, Simon Baron-Cohen, 2012.

Orijinal kaynak: Allison C, Auyeung B, Baron-Cohen S. Toward brief "red flags" for autism screening: the short Autism Spectrum Quotient (AQ-10). *J Am Acad Child Adolesc Psychiatry*, 2012; 51: 202–212.

Talimat

Aşağıdaki 10 ifade hakkında ne düşünüyorsunuz? Her ifade için Kesinlikle katılıyorum, Kısmen katılıyorum, Kısmen katılmıyorum, Kesinlikle katılmıyorum varyantlarından birini seçin.

Sorular

№	İfade
1	Sık sık küçük seslere dikkat ederim – başkaları bunları fark etmediğinde

№	İfade
2	Genelde küçük detaylardan çok genel resme daha fazla dikkat ederim
3	Bir sosyal ortamda birkaç kişinin sohbetini takip etmekte zorluk çekerim
4	Sık sık bir konu veya aktivite üzerinde o kadar odaklanırım ki başka şeyleri kaçırırım
5	Bir başkası bir şey söylediğinde ne düşündüğünü veya hissettiğini kolayca anlarım
6	İnsanların niyetlerini okumakta iyiyim
7	Hikaye okurken, karakterlerin ne düşündüğünü anlamakta zorluk çekiyorum
8	Daha önce yaptığım aktiviteler hakkında detaylı bilgi toplamayı severim (örneğin, araba türleri, kuşlar, trenler)
9	Bir insana baktığımda onun ne düşündüğünü veya hissettiğini anlamakta zorluk çekerim
10	Sosyal durumlarda nasıl davranacağımı bilmekte zorluk çekerim

Hesaplama

Soru	**"Tamamen katılıyorum / Kısmen katılıyorum" – 1 puan**	**"Tamamen katılmıyorum / Kısmen katılmıyorum" – 1 puan**
1	✓	
2		✓
3	✓	
4	✓	

Soru	“Tamamen katılıyorum / Kısmen katılıyorum” – 1 puan	“Tamamen katılmıyorum / Kısmen katılmıyorum” – 1 puan
5		✓
6		✓
7	✓	
8	✓	
9	✓	
10	✓	

Toplam puan = 10 üzerinden

Sonuçların yorumlanması

Puan	Tavsiye
0–5	OSB tanısal değerlendirme olasılığı düşüktür
≥6	**Detaylı OSB klinik değerlendirmesi önerilir**

Not: AQ-10 klasik AQ-50'nin kısa versiyonudur. NICE CG142 (UK) tarafından birinci basamak sağlıkta yetişkin OSB taraması için resmi olarak önerilir. Duyarlılık ~%77, özgüllük %36–41. AQ-10 özellikle 'kendi kendine tarama'da geçerli ve klinisyenin ilk görüşmesi ile birlikte kullanılmalıdır.

B.3. ASRS v1.1: Yetişkin DEHB Öz Bildirim Ölçeği

Orijinal yazarlar: WHO, Ronald C. Kessler ve çalışma arkadaşları, Harvard Medical School, 2005.

Orijinal kaynak: Kessler RC, Adler L, Ames M, et al. The World Health Organization Adult ADHD Self-Report Scale (ASRS). *Psychological Medicine*, 2005; 35: 245–256.

Talimat

Bu ölçek yetişkinlerde DEHB semptomlarının taranması içindir. Aşağıdaki 6 soruya – Son 6 ay içinde nasıl hissettiniz – temel alarak yanıt verin. Her soru için Hiçbir zaman, Nadiren, Bazen, Sık sık, Çok sık sık varyantlarından birini seçin.

Bölüm A – Birincil tarama (6 soru)

№	Soru	Hiçbir zaman	Nadiren	Bazen	Sık sık	Çok sık
1	Bir projenin zor kısmı tamamlandıktan sonra son detayları bitirmede ne sıklıkla zorluk çekiyorsunuz?					
2	Organizasyon gerektiren bir iş yaparken işleri sıraya koymakta ne sıklıkta zorluk çekiyorsunuz?					

№	Soru	Hiçbir zaman	Nadiren	Bazen	Sık sık	Çok sık
3	Randevuları veya yükümlülükleri hatırlamada ne sıklıkla sorun yaşıyorsunuz?					
4	Çok düşünce gerektiren bir göreviniz olduğunda, ne sıklıkta başlamaktan kaçınır veya onu ertelersiniz?					
5	Uzun süre oturmak zorunda kaldığınızda ne sıklıkla el ve ayaklarınızı kıpırdatır veya gerersiniz?					

№	Soru	Hiçbir zaman	Nadiren	Bazen	Sık sık	Çok sık
6	'Motorla çalışan' gibi ne kadar sık fazla hareketli ya da bir şey yapma zorunluluğu hissediyorsunuz?					

Hesaplama (Bölüm A için)

Tablodaki kalın hücrelerdeki yanıtlar – pozitif belirtidir.

Soru	Pozitif belirti sayılan yanıtlar
1	**Bazen, Sık sık, Çok sık**
2	**Bazen, Sık sık, Çok sık**
3	**Bazen, Sık sık, Çok sık**
4	**Sık sık, Çok sık sık**
5	**Sık sık, Çok sık sık**
6	**Sık sık, Çok sık sık**

Toplam pozitif belirti sayısı = _____ / 6

Sonuçların yorumlanması

Pozitif belirti sayısı	Yorum
0–3	Semptomlar yetişkin DDB için tipik değil

Pozitif belirti sayısı	Yorum
≥4	**Semptomlar yetişkin DDB için yüksek derecede uygun. Tıbbi değerlendirme önerilir.**

Bölüm B – Genişletilmiş anket (12 ek soru)

Bölüm A pozitif olduğunda, klinik değerlendirme ile birlikte kullanım için Bölüm B soruları (12 ek soru) kullanılır. Bölüm B'nin tam versiyonu geliştiricilerin resmi sitesinden edinilebilir: https://www.hcp.med.harvard.edu/ncs/asrs.php

Not: ASRS v1.1 – DSÖ tarafından geliştirilmiş, dünyada en çok kullanılan yetişkin DEHB tarama ölçeğidir. Dünyaca ünlü Kessler tarafından sonra ASRS-5 (APA, 2013 — DSM-5 kriterlerine göre, 2017) İşlenmiş – daha kısa 5 soruluk versiyon. Her iki versiyon tarama için uygundur, ASRS v1.1 hâlâ yaygın kullanımdadır.

B.4. SNAP-IV: Swanson, Nolan ve Pelham Derecelendirme Ölçeği (çocuk DEHB)

Orijinal yazarlar: James M. Swanson, 1983.

Orijinal kaynak: Swanson JM. School-based assessments and interventions for ADD students. Irvine, CA: KC Publishing, 1992.

Talimat

SNAP-IV – çocuklarda DEHB semptomlarının APA, 1994.">DSM-IV/APA, 2013 — DSM-5 kriterlerine dayalı değerlendirmesidir. Ebeveyn veya öğretmen tarafından doldurulur. Her semptom son 1 ay içinde çocuğunuzda nasıl gözlemleniyor: Hiç (0), Yeterli (1), Çok (2), Çok-çok (3).

Sorular (SNAP-IV kısa versiyon – 26 soru)

Dikkatsizlik alt ölçeği (Maddeler 1–9):

№	**İfade**	**0**	**1**	**2**	**3**
1	Sık sık okul işinde veya diğer faaliyetlerde dikkatsiz hatalar yapar				
2	Sık sık dikkatini görevlerde veya oyunlarda sürdürmekte zorluk çeker				
3	Sık sık doğrudan konuşulduğunda dinlemiyormuş gibi görünür				
4	Sık sık talimatlara uymaz ve okul işini, günlük görevleri bitirmez				
5	Sık sık görevleri ve faaliyetleri organize etmekte zorluk çeker				

№	İfade	0	1	2	3
6	Sık sık sürekli zihinsel çaba gerektiren görevlerden kaçar, sevmez veya isteksizce yerine getirir				
7	Sık sık görevler veya faaliyetler için gerekli eşyaları kaybeder (okul malzemeleri, kalem, kitap)				
8	Sık sık dış uyaranlarla kolayca dikkati dağılır				
9	Sık sık günlük faaliyetlerde unutkandır				

Hiperaktivite-dürtüsellik alt ölçeği (Maddeler 10–18):

№	İfade	0	1	2	3
10	Sık sık el ve ayaklarını kıpırdatır veya oturduğu yerde gerinir				
11	Sık sık odada oturması gereken yerde oturmaz				
12	Sık sık olağandışı durumlarda aşırı koşar veya tırmanır				
13	Sık sık sessiz oynamakta zorluk çeker				
14	'Hareketli' ya da “motorla çalışan” gibi sık davranır				
15	Sık sık aşırı konuşur				

№	İfade	0	1	2	3
16	Sık sık soru bitmeden cevapları ağzından kaçırır				
17	Sık sık kendi sırasını bekleyemez				
18	Sık sık başkalarının faaliyetini keser (sohbete, oyuna)				

Karşıt olma-karşı gelme davranışı alt ölçeği (Maddeler 19–26):

№	İfade	0	1	2	3
19	Sık sık kendini kaybeder				
20	Sık sık yetişkinlerle tartışır				
21	Sık sık yetişkinlerin taleplerine veya kurallara karşı gelir				
22	Sık sık kasten başkalarını rahatsız eder				

№	İfade	0	1	2	3
23	Sık sık kendi hataları veya kötü davranışları için başkalarını suçlar				
24	Sık sık başkaları tarafından kolayca rahatsız edilir				
25	Sık sık sinirlidir ve keskin bir şekilde memnuniyetsizdir				
26	Sık sık kindar veya kinli davranır				

Hesaplama

Her alt ölçeğin ortalaması:

- Dikkatsizlik alt ölçeği (1–9): toplam ÷ 9 = _____
- Hiperaktivite-dürtüsellik alt ölçeği (10–18): toplam ÷ 9 = _____
- Karşıt olma-karşı gelme alt ölçeği (19–26): toplam ÷ 8 = _____

Sonuçların yorumlanması (orta düzeyler)

Subskala	Ebeveyn: olumlu sınır	Öğretmen: pozitif sınır
Dikkatsizlik	≥1,78	≥2,56

Subskala	Ebeveyn: olumlu sınır	Öğretmen: pozitif sınır
Hiperaktivlik-impulsivite	≥1,44	≥1,78
Opozisiyon-etiraz	≥1,88	≥2,00

Bu sınırlar Bussing et al., 2008 verilerine dayanmaktadır ve ABD popülasyonu içindir. Azerbaycan popülasyonunda özel validasyon yapılmamıştır – sonuçlar klinik bağlamda yorumlanmalıdır.

Tanısal yorum

DEHB'nin DSM kriterlerine uygun sunum türü:

- Esas olarak dikkatsiz: Yalnızca dikkatsizlik alt ölçeği pozitif;
- Esas olarak hiperaktif-dürtüsel: Yalnızca hiperaktivite alt ölçeği pozitif;
- Kombine edilmiş: Her iki alt ölçek pozitif.

Karşıt olma-karşı gelme alt ölçeğinde pozitif sonuç komorbid opozisyonel-karşı gelme bozukluğu (ODD, ICD-11 6C90) olasılığını gösterir.

Not: SNAP-IV – araştırma ve klinik kullanım için ücretsiz ulaşılabilir. Tam 90 soruluk versiyon, kısa 26 soruluk versiyon ve öğretmen versiyonları Swanson prof. resmi sitesinden indirilebilir: http://www.shared-care.ca/files/Scoring_for_SNAP_IV_Guide_26-item.pdf

---

B.5. Entelektüel ve uyumsal değerlendirmenin temel araçları (bilgi tablosu)

Aşağıdaki araçlar lisanslı psikolojik araçlardır ve metin içinde tam olarak verilemezler. Bunların elde edilmesi ve kullanımı için klinik psikolog veya nitelikli uzman gereklidir.

B.5.1. Entelektüel değerlendirme

Alet	Yaş grubu	Yayıncı	Tipik süre
WPPSI-IV (Wechsler Preschool and Primary Scale of Intelligence)	2 yaş 6 ay – 7 yaş 7 ay	Pearson	60–90 dk

Alet	Yaş grubu	Yayıncı	Tipik süre
WISC-V (Wechsler Intelligence Scale for Children)	6–16 yaş	Pearson	60–90 dk
WAIS-IV/V (Wechsler Adult Intelligence Scale)	16–90 yaş	Pearson	60–90 dk
Stanford-Binet 5	2 yaş+	Riverside Insights	45–75 dk
Leiter-3 (sözel olmayan)	3–75+ yaş	Stoelting	25–40 dk
Raven's Progressive Matrices	5 yaş+	Pearson	20–40 dk

B.5.2. Uyumsal davranış

Alet	Yaş grubu	Yayıncı	Değerlendirme türü
Vineland-3 (Vineland Adaptive Behavior Scales)	Doğumdan 90+ yaşa	Pearson	Ebeveyn/bakım veren ile yarı yapılandırılmış görüşme
ABAS-3 (Adaptive Behavior Assessment System)	Doğumdan 89 yaşa	WPS	Ebeveyn/öğretmen derecelendirme formu

B.5.3. Otizm tanı araçları

Alet	Yaş grubu	Yayıncı	Tipik süre
ADOS-2 (Autism Diagnostic Observation Schedule)	12 ay – yetkin	WPS	40–60 dk (5 modül)

Alet	Yaş grubu	Yayıncı	Tipik süre
ADI-R (Autism Diagnostic Interview – Revised)	2 yaş – yetişkin	WPS	90–150 dk
CARS-2 (Childhood Autism Rating Scale)	2 yaş+	WPS	15–30 dk
SRS-2 (Social Responsiveness Scale)	2,5–yaş+	WPS	15–20 dk

B.5.4. DEHB ayrıntılı değerlendirme

Alet	Yaş grubu	Yayıncı
Conners-3 (Conners Rating Scales)	6–18 yaş	MHS
Conners CBRS	6–18 yaş	MHS
CAARS (Conners Adult ADHD Rating Scales)	18+ yaş	MHS
BRIEF-2 (Behavior Rating Inventory of Executive Function)	5–18 yaş	PAR
CPT-3 (Conners Continuous Performance Test)	8 yaş+	MHS

Yazarın notu

Ek B'de sunulan tarama ölçekleri (M-CHAT-R, AQ-10, ASRS v1.1, SNAP-IV) klinik işte doğrudan kullanım için hazırdır. Bu ölçeklerin yazarlarına ve kurumlarına – Dünya Sağlık Örgütü'ne, Harvard Tıp Fakültesi'ne, Profesör Simon Baron-Cohen ve çalışma arkadaşlarına, Diana Robins, Deborah Fein, Marianne Barton ve James Swanson'a — modern psikiyatriye büyük katkılarından dolayı teşekkür ederiz.

Lisanslı tanı araçları (ADOS-2, WISC-V, Vineland-3 ve diğerleri) bu kitapta tam olarak yeniden üretilemez. Uygulanmaları özel eğitim ve resmî olarak satın alınmış lisans gerektirir. Klinisyenler bu araçları doğrudan yetkili yayıncılardan (Pearson, WPS, MHS veya kendi ülkesindeki eşdeğer distribütörlerden) edinmelidir.

Çeviri ve yerel validasyon hakkında not. Bu kitapta sunulan Azerice çeviriler klinik kullanım için çalışma versiyonudur. Azerbaycan popülasyonu için henüz formal psikometrik validasyondan geçmemiştir. Bilimsel yayınlar ve validasyon araştırmaları için resmî yayıncılardan onaylı çeviriler edinilmelidir. Azerbaycan popülasyonuna özgü normatif verilerin geliştirilmesi gelecekteki çalışmalar için önemli bir öncelik olmaya devam etmektedir.

SON ÖNERİLER

Klinisyenler için pratik sentez

Kitabın tüm bölümlerinden elde edilen temel klinik dersler:

Tanı her zaman ikinci adımdır, birinci değil

Ruhsal bozukluk tanısı koymadan önce mutlaka:

- Tıbbi nedenleri dışlayın — özellikle yeni başlangıç 40–50 yaş sonrası, akut prezentasyon, atipik profil, somatik semptomlar, hormonal döngü değişiklikleri
- Madde kullanımını kontrol edin — her vakanın %30'unda gizli madde bileşeni;
- Travma anamnezini açıkça sorun — kompleks TSSB ve kişilik bozuklukları sıklıkla travmanın sonucudur, ancak travma öyküsü taranmadan ortaya çıkmaz.

ICD-11 “primary vs secondary” prensibi – klinisyen için ana çerçevedir.

Psikoterapi – birinci seçenek çoğu durumda

ICD-11 döneminin merkezi mesajı: psikoterapi etkinliği kanıtlanmış, farmakoterapiden en az aynı derecede, birçok bozuklukta daha üstün:

- Hafif-orta depresyonda — BDT, İPT SSRI ile eşit;
- Anksiyete bozukluklarında — BDT 1. basamak;
- OKB'de — ERP mutlaka; SSRI ek olarak;
- TSSB'de — TF-CBT, EMDR 1. sıra;
- Kişilik bozukluklarında — DBT, MBT, TFP – farmakoterapiden daha etkili;
- Yeme bozukluklarında — CBT-E, FBT;
- Çocuk davranış bozukluklarında — ebeveyn eğitim programları

Farmakoterapi çoğu durumda adjuvandır — hastanın psikoterapi etkinliğini artırmasına ve korumasına yardımcı olur.

Dozun minimum etkinlik prensibi

- Başlangıç düşük, geç artırılır;
- Kesin minimum etkili doza ulaşan;

- Çok ilaçtan (polifarmasi) kaçının — yaşlılarda, komorbiditede, kişilik bozukluklarında özellikle
- İlacın kesilmesi veya azaltılması da bilgi gerektirir – SSRI'yı aniden kesmemek, benzodiazepinler kademeli azaltılmalı.

Kültür ve bağlamla çalışma

Azerbaycan bağlamında

- Somatik sunum çok yaygındır — birinci basamakta depresyon, anksiyete aktif tarama gerektirir;
- Stigma ve mahremiyet — psikiyatrist ziyareti gizlenir; birinci basamak sağlık veya dahiliye hekimi temelinde çalışma etkilidir;
- Aile sistemi güçlüdür — tedavide aile katılımı büyük bir kaynaktır;
- Din ve kültürel inançlar — dikkate alınmalı, ancak patolojiye dönüştürülmemeli;
- Karabağ Savaşı gazileri — TSSB, cPTSD, travma odaklı müdahale ihtiyacı yüksektir.

Tarama birinci basamak sağlık hizmetinde standart olmalıdır

En temel tarama araçları birinci basamak sağlık hizmetinde rutin olarak uygulanmalıdır:

- PHQ-9 — depresyon (her tıbbi ziyarette);
- GAD-7 — anksiyete
- AUDIT — alkol kullanımı;
- EPDS — perinatal kadınlar;
- C-SSRS — intihar riski.

Azerbaycan diline çevrilmiş ve valide edilmiş araçlara yatırım yapılmalıdır

İntihar riskinin değerlendirilmesi

Her psikiyatrik görüşmede aktif sorgulama:

- Son zamanlarda ölüm veya kendi hayatınıza son vermekle ilgili düşünceleriniz oldu mu?
- Belirli plan, araç?

- Önceki girişimler?

Risk faktörleri:

- Önceki girişimler (en güçlü prediktör);
- Ailede intihar öyküsü;
- Planın ne kadar yakın ve kesin olduğu;
- Araçlara erişilebilirlik;
- Madde kullanımı, depresyon, BPD, psikoz;
- Akut stresör, kayıp.

Müdahale:

- Güvenlik planı;
- Araçlara erişilebilirliğin azaltılması;
- Yakın izlem;
- Hospitalizasyon endikasyonu;
- C-SSRS gibi bir ölçekle yapılandırılmış değerlendirme.

Komorbidite kural, istisna değil

Ruhsal bozukluklarda komorbidite normdur:

- Depresyon + anksiyete — %60 komorbid;
- TSSB + depresyon — %50+;
- Kişilik bozukluğu + depresyon/anksiyete/madde — %80+;
- Otizm + DEHB — %50;
- Yeme bozukluğu + depresyon + travma — tipik üçlü

Tedavi planı tüm komorbiditeleri kapsamalıdır — temel bozukluğun tek başına tedavisi çoğu zaman yeterli değildir

Yaş ve gelişim evresi mutlaka dikkate alınmalıdır

- Çocukta ruhsal bozukluk — ebeveyn ve bağlam önemlidir; ilaçlar az, psikoterapi ve aile odaklı daha fazla
- Ergen — kimlik gelişimi, erken müdahale kritik;
- Yetkin — iş, aile, sosyal işlev;
- Yaşlı — komorbid tıbbi hastalıklar, polifarmasi, kognitif bozukluklar; demans vs depresyon özel dikkat.

Multidisipliner ekip – etkili klinik çalışmanın temelidir

Kompleks hallarda:

- Psikiyatrist;
- Psikolog / psikoterapist;
- Sosyal çalışmacı;
- Tıbbi hekim (komorbiditeler)
- Aile üyeleri (onayla);
- Okul / iş yerindeki kişiler (çocukta).

Azerbaycan'da bu yapının geliştirilmesi – stratejik öncelik

Etik ve hukuki çerçeve

Her klinisyen bilmelidir:

- Gizlilik ve sınırları (başkalarına tehlike, çocuk koruma)
- Bilgilendirilmiş onam;
- Zorunlu hastaneye yatış hukuki çerçevesi;
- Çocuk/yaşlı istismarı bildirimi;
- Adli değerlendirme temelleri;
- Belgelemenin önemi.

Kendi sağlığınıza dikkat

Psikiyatrik iş – duygusal yükü yüksek meslektir. Tükenmişlik (burnout), ikincil travma, empatik yorgunluk klinisyen için gerçek risklerdir.

- Süpervizyon ve kollegial konsültasyon;
- Kişisel psikoterapi;
- Sağlıklı yaşam tarzı;
- Sınırın bilinmesi – tüm hastaları kurtaramazsınız.

Sürekli eğitim ve gelişim.

ICD-11 on yıllar boyunca sabit kalacak, ancak:

- Tedavi standartları her 3–5 yılda güncelleniyor;
- Yeni ilaçlar, yeni psikoterapötik protokoller çıkıyor;

- AACAP, APA, NICE, WFSBP, ISTSS gibi kuruluşların kurallarının düzenli takibi;
- Hakemli dergiler: Lancet Psychiatry, JAMA Psychiatry, American Journal of Psychiatry, World Psychiatry.

Kitabın amacı: Azerbaycan'da psikiyatrik bakımın kalitesine, hastalara ve ailelere, mesleki gelişime katkıda bulunmak. Okuyucu bu kitaptan yararlandığı takdirde amaç gerçekleşmiş sayılacaktır

Sağlıklı tedavi, mesleki yükseliş ve hastalarınıza faydalı olmanızı dilerim.

Kenan Rahimov

Bakü, 2026